

Stres pada hakikatnya merupakan reaksi alamiah tubuh terhadap keadaan yang tidak menyenangkan, sehingga stress dapat dirasakan siapa saja tanpa memperhatikan usia, *gender*, bangsa dan agama. Diantara kelompok yang beresiko menghadapi stress adalah para mahasiswa fakultas kedokteran. Tuntutan dan kewajiban akademik dinilai cukup memberi tekanan-tekanan sehingga dapat memunculkan pengaruh negatif terhadap fungsi psikologis dan fisiologis.

Stres disinyalir terjadi karena terlepasnya individu dari nilai penting dalam hidupnya. Sementara salah satu sumber signifikan atau *valued resources* yang dapat mempertahankan kesehatan psikologis adalah terpenuhinya kesejahteraan spritualitas. Namun demikian penyelesaian masalah mental secara spritualitas itu sendiri harus bersifat holistik yakni mendekati permasalahan kejiwaan dari berbagai cara sehingga tidak terbatas pada spritualitas itu sendiri. Di antara posibilitas tersebut adalah usaha untuk mengatur dan merubah respon diri terhadap berbagai sumber stres yang dikenal dengan istilah regulasi diri.

Melalui penelitian ini, penulis membuktikan bahwa integrasi spritualitas dan regulasi diri yang baik dapat menjadi suatu bentuk koping stres akademik yang efektif. Studi ini juga menyimpulkan bahwa, spritualitas tidak memengaruhi penekanan stres secara langsung, namun harus melalui regulasi diri belajar yang baik. Begitupula, regulasi diri belajar tidak dapat mempengaruhi penekanan stres tanpa spritualitas yang baik.



Penerbit Nusa Litera Inspirasi
Jl. Raya Cirebon - Kuningan
Jl. Pesantren No. 177
Kuningan, Jawa Barat 45556
www.nusaliterainspirasi.com



Dr. Syahidah Rena, M.Ed
Mengatasi Stres Melalui Spritualitas dan Regulasi Diri
(studi pada Mahasiswa Kedokteran di DKI Jakarta)

MENGATASI STRES MELALUI SPIRITUALITAS DAN REGULASI DIRI

(studi pada Mahasiswa Kedokteran di DKI Jakarta)

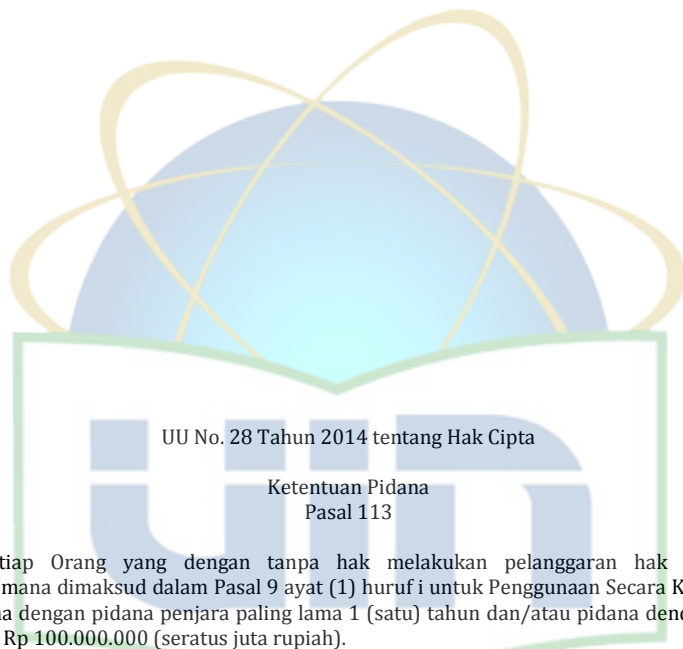
Dr. Syahidah Rena, M.Ed





MENGATASI STRES MELALUI SPIRITUALITAS DAN REGULASI DIRI

(STUDI PADA MAHASISWA KEDOKTERAN DI DKI JAKARTA)



(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Syahidah Rena, M.Ed

**MENGATASI STRES
MELALUI SPIRITUALITAS
DAN REGULASI DIRI**

(STUDI PADA MAHASISWA KEDOKTERAN DI DKI JAKARTA)



NUSA LITERA INSPIRASI
2018



Mengatasi Stres Melalui Spiritualitas dan Regulasi Diri
(Studi pada Mahasiswa Kedokteran di DKI Jakarta)

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Nusa Litera Inspirasi
Cetakan pertama Maret 2018
All Right Reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis: Dr. Syahidah Rena, M.Ed
Perancang sampul: NLI Team
Penata letak: NLI Team

Mengatasi Stres Melalui Spiritualitas dan Regulasi Diri
(Studi pada Mahasiswa Kedokteran di DKI Jakarta)

xviii + 447: 15 cm x 22 cm
ISBN: 978-602-5668-26-5

Penerbit Nusa Litera Inspirasi
Jl. Raya Cirebon - Kuningan
Jl. Pesantren No. 177
Kuningan, Jawa Barat 45556
redaksinu@gmail.com
www.nusaliterainspirasi.com
HP: 0856-9586-9769/0857-1644-6889

Isi di luar tanggungjawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur disampaikan ke hadirat Allah SWT, karena dengan segala rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Mengatasi Stres Melalui Spiritualitas dan Regulasi Diri: Studi pada Mahasiswa Kedokteran di DKI Jakarta”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor Kajian Islam dalam bidang Psikologi Islam pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini terselesaikan dengan dukungan penuh dari suami tercinta Abdurrahman, S.Hum dan doa dari kedua orang tua tercinta bapak H. Muhammad Abdul Kadir dan ibu Hj. Rukiah (Almh) beserta ayah dan ibu mertua bapak. Andis Mahdi (Alm) dan ibu Chadijah. Tak terlupakan ucapan terima kasih atas pengertiannya ananda Raufah Adibah selama penyelesaian studi dan penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada guru penulis: Prof. Dr. Abdul Mujib M.Ag, M.Si dan Prof. Dr. Abuddin Nata, MA selaku promotor yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan kritik serta saran dalam penulisan penelitian ini. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dede Rosyada, serta Prof. Dr. Masykuri Abdillah dan Prof. Dr. Didin Saepudin selaku Direktur dan Ketua Program Doktorat Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan para staf akademik yang telah banyak membantu selama proses pembelajaran penulis tempuh.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., Prof. Dr. Suwito, MA., Prof. Dr. Yunasril Ali, MA., Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, MA., Prof. Dr. Sukron Kamil, MA., Yusuf Rahman, Ph.D, MA, Asep Saepudin Jahar, Ph.D, MA., Fuad Djballi, Ph.D, MA., dan JM. Muslimin, Ph.D, MA., yang telah

banyak membimbing dan memberikan kritik serta saran dalam penulisan penelitian ini yang lebih baik.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap civitas akademik dari UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Trisakti dan Universitas Rumah Sakit Islam (YARSI) yang telah bersedia memberi kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam penyelesaian penelitian ini. Tidak terkecuali ucapan terima kasih kepada para Mahasiswa/i dari Fakultas Kedokteran di tiga Universitas tersebut yang telah bersedia mengisi kuesioner serta berpartisipasi aktif dalam proses wawancara guna memberikan informasi dan pengetahuan yang diperlukan penulis selama melakukan penelitian ini. Demikian juga terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah bersedia menjadi sahabat dalam berbagi kebahagiaan dan kesulitan di masa-masa studi.

Akhir kata, tidak ada kata sempurna dalam setiap langkah dan pemikiran manusia, demikian juga penelitian ini tentunya memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Maka sebagai insan akademik, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi terwujudnya karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

Jakarta, Maret 2018

Dr. Syahidah Rena, M.Ed

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membuktikan adanya hubungan antara spiritualitas dan regulasi diri belajar dalam menekan pengaruh stresor terhadap stres. Lebih jauh, penelitian ini bermaksud menawarkan sebuah model efektif dalam fungsi optimal manusia (*human functioning*) melalui sebuah pandangan holistik, yakni mendekati permasalahan dengan berbagai cara yang mungkin (*possible waysout*). Dimana kemampuan mengatasi stresor akademik tidak hanya dibatasi melalui fungsi pertahanan spiritualitas saja, tetapi juga dengan mengevaluasi sebuah bentuk koping aktif yang salah satu bentuk prakteknya adalah regulasi diri belajar.

Perbincangan akademik terkait peran spiritualitas dan korelasi dengan kesehatan mental dan kesejahteraan diri masih menjadi perdebatan diantara dua kelompok ahli. Kelompok pertama, seperti Albert Ellis (1980), Ronald Siddle (2002), dan Jhon C. Norcross (2010) menyebutkan bahwa spiritualitas dan keyakinan terhadap Tuhan adalah pola pikir yang irasionalistik, bahkan berpotensi terhadap permasalahan psikologis lainnya. Sebaliknya kelompok kedua, seperti Carolyn Aldwin, Crystal Park, Yu-Jin Jeong dan Tiwik Nath (2014) membuktikan bahwa spiritualitas memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan psikologis bagi individu dengan demografis yang berbeda. Adapun penelitian ini selaras dengan pandangan ahli pada kelompok kedua.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*) dengan desain eksplanatori sekuensial (*sequential explanatory design*), yakni penelitian kuantitatif sebagai pendekatan utama dan kualitatif sebagai fasilitator. Sementara subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa kedokteran di beberapa perguruan tinggi terpilih di DKI Jakarta yang telah diperoleh secara *purposive sampling* berdasarkan tahun pendidikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada model analisis kuantitatif yang ditawarkan adalah fit. Spiritualitas secara signifikan berpengaruh dalam menekan stres dengan t-hitung sebesar $(-2.95 > 1.96)$. Begitupula regulasi diri berpengaruh dalam menekan stres dengan t-hitung sebesar $(-3.13 > 1.96)$. Dalam hubungan keseluruhan akhir, regulasi diri belajar didapati memberikan pengaruh signifikan dalam memediasi hubungan negatif antara spiritualitas dan stres.

Sehingga dengan demikian semakin tinggi regulasi diri belajar yang dimiliki mahasiswa maka fungsi spiritualitas sebagai penyanggah kejadian stres (*stress buffer function*) akan semakin tinggi.

Terakhir, melalui analisis kualitatif penelitian ini menegaskan bahwa spiritualitas dan regulasi diri belajar secara efektif terbukti dapat menjadi koping dalam mengatasi stres akademik. Spiritualitas menjadi koping berfokus emosi (*emotion focused coping*) dan regulasi diri secara bersamaan menjadi koping berfokus masalah (*problem focused coping*).



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab - Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	d = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	dhammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...	fathah dan wau	Au	a dan w

Contoh:

حُسَيْن : Ḥusain حَوْل : ḥaul

C. Maddah

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' marbutah (ة)

Transliterasi ta' marbutah ditulis dengan "h" baik dirangkai dengan kata sesudahnya maupun tidak contoh mar'a (مراة) madrasah (مدرسة)

Contoh:

المدينة المنورة : al-Madīnah al-Munawwara

E. Shaddah

Shaddah/tasydīd di transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bersaddah itu.

Contoh:

ربنا : rabbanâ نَزَلَ : nazzal

F. Kata Sandang

Kata sandang "ال" dilambangkan berdasar huruf yang mengikutinya, jika diikuti huruf syamsiyah maka ditulis sesuai huruf yang bersangkutan, dan ditulis "al" jika diikuti dengan huruf qamariyah. Selanjutnya ل ditulis lengkap baik menghadapi al-Qomariyah contoh kata al-Qomar (القمر) maupun al-Syamsiyah seperti kata al-Rajulu (الرجل)

Contoh:

الشمس

: al-Shams

القلم

: al-Qalam

G. Pengecualian Transliterasi

Adalah kata-kata bahasa arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal الله, *asma' al-husnā* dan *ibn*, kecuali menghadirkannya dalam konteks aslinya dan dengan pertimbangan konsistensi dalam penulisan.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii

BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	18
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	21
F. Metodologi Penelitian	27

BAB II	
SPIRITUALITAS DAN REGULASI DIRI BELAJAR: MENGUBAH <i>DISTRESS</i> MENJADI <i>EUSTRESS</i>	49
A. Konseptualisasi Stres sebagai Bentuk Disfungsi Psikofisiologis	50
B. Spiritualitas dan Regulasi Diri Belajar : Mengubah <i>Distress</i> Menjadi <i>Eustress</i>	81
C. Spritualitas dan Regulasi Diri Belajar sebagai Protektor Diri Dari Stres	128

BAB III	
PENGARUH STRESOR, SPRITUALITAS DAN REGULASI DIRI TERHADAP STRES MAHASISWA KEDOKTERAN	137
A. Deskripsi Kampus Partisipan	137
B. Deskripsi Subjek Penelitian	142
C. Analisis Tematik: Kondisi Mahasiswa Kedokteran	145

D. Keterhubungan dengan Tuhan dalam Dominansi Spritualitas	170
E. Pengaruh Mediasi Regulasi Diri Belajar dalam Hubungan Spritualitas dan Stres	200
BAB IV	
SPIRITUALITAS DAN REGULASI DIRI BELAJAR DALAM MEKANISME KOPING STRES	227
A. Mekanisme Kejadian Stres	277
B. Mekanisme Respon Stres	244
C. Efektifitas Spritualitas dalam Pertahan Diri dari Stres Akademik	264
D. Spritualitas dan Regulasi Diri Belajar sebagai Koping Proaktif	307
BAB V	
PENUTUP	325
A. Kesimpulan	325
B. Rekomendasi	327
DAFTAR PUSTAKA	329
GLOSARIUM	371
INDEKS	380
LAMPIRAN	385
BIODATA PENULIS	446

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. :	<i>Blueprint</i> Skala Stresor	29
Tabel 1.2. :	Alternatif Jawaban dan Skor <i>item</i> skala penelitian stresor	32
Tabel 1.3. :	<i>Blueprint</i> Skala Spritualitas	33
Tabel 1.4. :	Alternatif Jawaban dan Skor <i>item</i> skala penelitian spritualitas	34
Tabel 1.5. :	<i>Blueprint</i> Skala Regulasi Diri Belajar	34
Tabel 1.6. :	Alternatif Jawaban dan Skor <i>item</i> Skala Regulasi Diri Belajar	35
Tabel 1.7. :	<i>Blueprint</i> Skala Stres	35
Tabel 1.8. :	Alternatif Jawaban dan Skor <i>item</i> skala stres	36
Tabel 1.9 :	<i>Construct Reliability Variabel-Variabel Manifest</i>	40
Tabel 1.10 :	Hasil Uji Univariat Normalitas	42
Tabel 2.1. :	Stresor Stres Mahasiswa Kedokteran	73
Tabel 2.2. :	Konsep Spritualitas Para Tokok Barat	87
Tabel 2.3. :	Konstruk Spritualitas: Sintesis Barat dan Islam	107
Tabel 2.4 :	Fase Regulasi Diri Belajar pada Studi Islam	124
Tabel 2.5. :	Proposisi Hubungan/Pengaruh Spritualitas dan Regulasi Diri	132
Tabel 3.1 :	Jumlah Partisipan Berdasarkan Universitas	143
Tabel 3.2 :	Jumlah Partisipan Berdasarkan Tahun Pendidikan	144
Tabel 3.3 :	Jumlah Partisipan Berdasarkan <i>Gender</i>	144
Tabel 3.4 :	Jumlah Partisipan Berdasarkan Agama	145
Tabel 3.5 :	Kategorisasi Prevalensi Stres	147
Tabel 3.6 :	Perbandingan Nilai <i>Mean</i> Tahun Pendidikan terhadap Stres	149
Tabel 3.7 :	Perbandingan Nilai <i>Mean</i> Gender terhadap Stres	151
Tabel 3.8 :	Tingkat Stresor berdasarkan <i>Mean Degree</i>	154
Tabel 3.9 :	Perbandingan Nilai <i>Mean</i> Tahun Pendidikan terhadap Stresor	156
Tabel 3.10 :	Perbandingan Nilai <i>Mean</i> Gender terhadap Stresor	157
Tabel 3.11 :	Tingkat Kategorisasi Spritualitas	160
Tabel 3.12 :	Perbandingan Nilai <i>Mean Gender</i> terhadap Spritualitas	161

Tabel 3.13 :	Perbandingan Nilai <i>Mean</i> Tahun Pendidikan terhadap Spritualitas	163
Tabel 3.14 :	Tingkat Kategorisasi Regulasi Diri Belajar	165
Tabel 3.15 :	Perbandingan Nilai <i>Mean</i> Tahun Pendidikan terhadap Regulasi Diri Belajar	167
Tabel 3.16 :	Perbandingan Nilai <i>Mean Gender</i> terhadap Regulasi Diri Belajar	169
Tabel 3.17 :	<i>Convergent Validity</i> Laten Stres	173
Tabel 3.18 :	<i>Goodness of Fit Indices</i> (GOFI) Variabel Stres	174
Tabel 3.19 :	<i>Convergent Validity</i> Laten Stresor	178
Tabel 3.20 :	<i>Goodness of Fit Indices</i> (GOFI) Variabel Stresor	179
Tabel 3.21 :	<i>Convergent Validity</i> Laten Spritualitas	184
Tabel 3.22 :	<i>Goodness of Fit Indices</i> (GOFI) Variabel Spritualitas	185
Tabel 3.23 :	<i>Convergent Validity</i> Laten Regulasi Diri Belajar	195
Tabel 3.24 :	<i>Goodness of Fit Indices</i> (GOFI) Variabel Regulasi Diri Belajar	196
Tabel 3.25 :	<i>Goodness of Fit Indices</i> (GOFI) Uji Model Struktural	201
Tabel 3.26 :	Estimasi Koefisien Model Struktural	203
Tabel 3.27 :	Hasil Uji Signifikansi Hipotesa	224
Tabel 4.1 :	Tipologi Manfaat Interaksi dengan Alam	295
Tabel 4.2 :	Manifestasi Spritualitas: dari <i>Distress</i> Menuju <i>Eustress</i>	304

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 :	Respon Hormonal Pada Stres	77
Gambar 3.1 :	Uji Model Pengukuran Variabel Laten Stres	172
Gambar 3.2 :	Uji Model Pengukuran Variabel Laten Stresor	
Gambar 3.3 :	Uji Model Pengukuran Variabel Laten Spritualitas	184
Gambar 3.4 :	Uji Model Pengukuran Variabel Laten Regulasi Diri Belajar	194
Gambar 3.5 :	Hasil Uji Model Struktural Penelitian (<i>t-value</i>)	202

Gambar 3.6 :	Hasil Uji Model Struktural Penelitian	
--------------	---------------------------------------	--

	(Koefisien Standar)	202
Gambar 4.1 :	Model Pada <i>Resistance</i>	235
Gambar 4.2 :	Titik-titik Beresiko pada Penggunaan Laptop	256

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. :	Model Penelitian	45
Bagan 1.2. :	Dimensi – dimensi Variabel Penelitian	46
Bagan 4.1 :	Hubungan Stresor, Persepsi, dan Respon Stres	229
Bagan 4.2 :	Fase Regulasi Diri Belajar	308





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat memasuki perguruan tinggi seorang mahasiswa dihadapkan pada lingkungan dan proses pendidikan yang berbeda dengan sistem pendidikan satu tingkat di bawahnya yakni sekolah,¹ sehingga dibutuhkan penyesuaian diri untuk hal tersebut. Salah satunya mereka harus siap dengan lingkungan akademik kompetitif yang terjadi dalam proses perkuliahan. Sampai dengan saat ini pendidikan kedokteran menjadi salah satu bidang pendidikan yang sangat menarik (*attractive*) dan menjanjikan di masa depan (*prospective*)². Namun demikian profesi dokter tidaklah mudah. Seiring dengan tuntutan fisik dan mental yang cukup besar dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini.

Ketika baru memasuki pendidikan kedokteran para mahasiswa di bidang ini mempunyai keadaan mental yang sama dengan rekan mahasiswa lain dari akademik keilmuan yang berbeda. Namun dalam proses pendidikan selanjutnya para mahasiswa kedokteran seringkali mengalami penurunan mental. Sebagaimana disebutkan pada hasil sebuah survei atas skala *General Health Questionnaire* yang menyatakan bahwa secara keseluruhan mahasiswa kedokteran mengalami penurunan kesehatan status mental.³

Kajian literasi terkait kesehatan mental ini semakin berkembang. Kesehatan mental bukanlah suatu hal hitam atau putih. Secara

¹Yiqun Gan, Yueqin Hu dan Yiwen Zhang, "Proactive and Preventive Coping in Adjustment to College", *The Psychology Record*, Vol. 60, (2010); 643-658.

²Sudhakara Reddy and others, "Burnout among Dental Faculty and Students in a Dental College", *Indian Journal of Public Health Research & Development*, Vol.5, No. 1, (2014); 64-68.

³Elsbeth Guthrie Stress and others, "Psychological and Burnout in Medical Students; a Five-Year Prospective Longitudinal Study", *J R Soc Med*, (2002); 237-243.

holistik kesehatan mental tidaklah lagi hanya diukur dengan ketiadaan atau keterbebasan individu dari berbagai macam gangguan psikologis. Tetapi lebih dari itu kesehatan mental berkaitan dengan kapasitas dan kualitas dimana individu mampu beradaptasi dengan perubahan, manajemen situasi yang krisis, mendemonstrasikan hubungan yang bermakna dengan individu lainnya dan menikmati hidup.⁴

Profesi dokter yang akan disandang oleh mahasiswa kedokteran setelah menyelesaikan studi ditujukan untuk dapat memberikan pelayanan medis. Dengan demikian mahasiswa kedokteran diharapkan dalam proses pendidikannya dapat tumbuh sebagai pribadi dengan kesehatan mental yang baik. Kondisi ideal yang diharapkan tersebut pada kenyataannya terjadi dengan sebaliknya yakni permasalahan *psychological dysfunction* (disfungsi psikologis)⁵ yang dihadapi para dokter bermula dari masa awal mereka menjalani pendidikan kedokteran.

Disfungsi psikologis yang dihadapi para mahasiswa ini dapat dilihat dengan adanya indikasi seperti rasa kurang bersemangat, kurang konsentrasi, bingung, sulit tidur, cemas, merasa terasing, bereaksi apati, bosan, dan gampang marah bahkan dorongan ingin bunuh diri. Semua kondisi ini mengarah pada keadaan yang kurang menyenangkan yang kemudian dalam keadaan seperti ini seseorang bisa dikatakan mengalami istilah psikologis yang disebut dengan stres.⁶

Pembahasan terkait dengan stres tidak dapat dipisahkan dari konsep kesehatan mental, sebagaimana Notosoedirjo dan Latipun (2005) menjelaskan bahwa kesehatan mental salah satunya dapat

⁴M. Noor Rochman Hadjam dan Wahyu Widhiarso, "Pengujian Model Peranan Kecakapan Hidup terhadap Kesehatan Mental", *Jurnal Psikologi*, Vol. 38, No. 1, (2011); 61-72.

⁵Disfungsi psikologis bermakna *disorder* (gangguan) pada fungsi kejiwaan seseorang. Pada beberapa studi untuk mengukur *psychological dysfunction* (disfungsi psikologis) ini para peneliti menggunakan variabel *depression* (depresi) dan *anxiety* (kecemasan), lih Yu-Wen and others, "Psychological Dysfunction in Southeast Asian Refugees as Mediated by Sense of Coherence", *American Journal of Community Psychology*, Vol. 25, No. 6, (1997); 839-859.

⁶Istilah stres digunakan untuk menunjukkan adanya reaksi fisik dan psikis seseorang terhadap keadaan tertentu yang mengancam. Lih Neil R. Carlson, *Stress Disorder in Foundation of Physiological Psychology 6th Edition*, (US; Pearson, 2005), 502.

didefinisikan dengan ketiadaan sakit akibat sumber stres (stresor).⁷ Dengan demikian dapat dipahami ketika mahasiswa dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan berbagai stresor yang dihadapi maka secara psikologis dapat dikatakan sehat.

Namun demikian stres seolah tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan. Stres dapat dialami oleh siapa saja dalam bentuk, kadar dan tingkat, serta jangka waktu lama atau pendek yang berbeda. Stres memiliki implikasi negatif jika berakumulasi dan berlangsung dalam kehidupan tanpa solusi yang tepat. Sebagaimana stres ini dapat dialami oleh siapa saja maka mahasiswa sebagai insan akademik dalam kegiatannya juga tidak terlepas dari stres. Dari berbagai studi yang telah dilakukan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres pada mahasiswa kedokteran lebih tinggi dibandingkan mahasiswa lainnya.⁸ Penelitian mengenai prevalensi stres pada mahasiswa kedokteran telah banyak dilakukan, seperti di Arab Saudi ditemukan tingkat prevalensi stres mahasiswa kedokteran mencapai 63%. Stres didapati cukup tinggi pada tiga tahun pertama pendidikan dengan data yang menunjukkan mahasiswi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.⁹

Hasil studi ini sejalan dengan beberapa penelitian sejenis yang menunjukkan bahwa stres mengalami penurunan searah dengan bertambahnya masa pendidikan, dalam arti lain mahasiswa semester awal mengalami tingkat stres yang lebih tinggi. Sebagaimana penelitian yang dilakukan di Iran melaporkan tingkat stres mahasiswa kedokteran tahun pertama mencapai 33%, tingkat kedua adalah 26% dan tingkat ketiga mencapai 16%.¹⁰

⁷Moeliono Notosoedirdjo dan Latipun, *Kesehatan Mental; Konsep dan Penerapan*, (Malang; Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 24.

⁸Mohd. Sidik, Sherina Lekhraj, Rampal dan Nadarjan, Kaneson, "Psychological Stress Among Undergraduate Medical Students", *Med J Malaysia*, Vol. 59, No. 2, (2004); 207-211.

⁹Muhammad Hamzah Abdulghani and others, "Stress and Its Effects on Medical Students; A Cross Sectional Study at A College of Medicine in Saudi Arabia", *J Health Popul Nutr*, Vol 5, (2011); 516-522.

¹⁰Marjani and others, "Stress among Medical Students of Gorgan (South East of Caspian Sea) Iran", *Kathamandu University Medical Journal*, Vol. 6, No. 3, (2008); 421-425.

Beberapa penelitian prevalensi stres juga diadakan di kawasan Asia seperti di Malaysia, sebuah studi menyebutkan 78,3% mahasiswa memiliki stres dengan penyebab utama karena beban akademik yang cukup banyak.¹¹ Selanjutnya di Lahore, Pakistan hasil studi ini menunjukkan hubungan signifikan antara tingkat stres dan prestasi akademik pada mahasiswa kedokteran yang kemudian dijelaskan sebanyak 71,6 % mereka mengalami stres sedang.¹² Sementara di Indonesia sendiri sebuah studi menyebutkan bahwa stres yang dialami mahasiswa kedokteran adalah 35% stres ringan, 61% stres sedang dan 4% stres tingkat tinggi.¹³

Perbedaan berbagai hasil penelitian tersebut disebabkan oleh perbedaan faktor penyebab stres yang dihadapi mahasiswa. Selanjutnya penyebab stres ini disebut juga dengan istilah stresor¹⁴. Stres terjadi apabila stresor dirasakan dan dipersepsikan sebagai ancaman sehingga menimbulkan kecemasan, dimana hal ini menjadi awal dari gangguan kesehatan fisik dan psikologis.

Studi mengenai stresor yang dihadapi mahasiswa banyak dilakukan untuk mengetahui faktor yang menjadi sumber stres mereka. Seperti diungkapkan oleh Backovic dkk, bahwa diantara stresor yang dihadapi para mahasiswa ini adalah banyaknya beban akademik, kurangnya waktu luang, tekanan emosional dalam mem-

¹¹Nor Iza A Rahman, and others, "Stress Among Preclinical Medical Students of University Sultan Zainal Abidin", *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, Vol. 3, No. 11, (2013); 076-081.

¹²Nudrat Sohail, "Stress and Academic Performance among Medical Students", *Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan*, Vol. 23, No. 1, (2013); 67-71.

¹³Vilasseni V. Pathmanathan dan M. Surya Husada, "Gambaran Tingkat Stress pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara Semester Ganjil Tahun Akademik 2012/2013", *E Journal FK USU*, Vol. 1, No. 1, (2013); 1- 4.

¹⁴Stresor adalah variabel yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab timbulnya stres. Sumber stres dapat berasal dari dalam tubuh dan luar tubuh. Lih Rasmun, Pengertian Stress, Sumber Stres dan Sifat Stresor. Dalam *Stress, Koping dan Adaptasi edisi ke-1*, (Jakarta: Sagung Seto, 2004), 9.

pertahankan hasil studi dan tuntutan kondisi spesifik prosedural medis saat menghadapi pasien.¹⁵

Selanjutnya penelitian pada Fakultas Kedokteran di Iran dari 440 mahasiswa yang diikutsertakan dalam pengisian kuesionair *Student Stress Scale* didapati bahwasanya sumber stres yang paling tinggi adalah interpersonal “temen baru” (76%), kemudian intrapersonal “tanggung jawab baru” (72,1%) dan “perkuliahan” (65,8%), “perubahan kebiasaan tidur” didapati menjadi stresor yang lebih tinggi pengaruhnya pada mahasiswa tahun pertama dibandingkan tingkatan di atasnya.¹⁶

Sementara hasil studi berbeda menyebutkan bahwa sumber penyebab utama stres mahasiswa kedokteran adalah tinggal di asrama, tingginya harapan orang tua, silabus pendidikan, ujian, sedikitnya waktu dan kurangnya fasilitas hiburan.¹⁷ Dari beberapa stresor yang diungkapkan para peneliti di atas, maka dapat disimpulkan stresor yang dihadapi mahasiswa kedokteran dapat diklasifikasikan kepada dua faktor yakni internal yang berasal dari dalam diri individu sendiri dan faktor eksternal yakni berasal dari luar dirinya. Kemudian dirincikan sebagai berikut; akademik, interpersonal dan intrapersonal, belajar-mengajar, sosial, hasrat dan keinginan, serta kegiatan kelompok.

Stresor yang dihadapi para mahasiswa kedokteran dapat menjadi ancaman kejadian stres bagi mereka, sementara stres dapat mendorong terjadinya perubahan perilaku pada mahasiswa seperti penurunan energi, cenderung mengekspresikan pandangan sinis pada

¹⁵Dusan V. Backovic and others, “Gender Difference in Academic Stress and Burnout Among Medical Students in Final Years of Education”, *Psychiatria Danubina*, Vol. 24, No. 2, (2012); 175-181.

¹⁶Naimah Seyedfatemi, Maryam Tafreshi dan Hamid Hagani, “Experienced Stressors and Coping Strategies among Iranian Nursing Students”, *BMC Nursing*, Vol. 6, No. 11, (2007).

¹⁷Chandrashekhar T Sreeramareddy and others, “Psychological Morbidity, Sources of Stress and Coping Strategies among Undergraduate Medical Students of Nepal”, *BMC Med Educ*, Vol. 2, No. 7 (2007); 6920-6926.

orang lain, perasaan marah, kecewa, frustrasi, bingung dan putus asa serta melemahkan tanggung jawab.¹⁸

Namun demikian sumber resiko stres yang dihadapi memberikan dampak yang berbeda pada setiap individu mahasiswa, artinya stresor tidak memengaruhi setiap orang secara sama. Pengaruh stresor terhadap stres dimediasi oleh karakteristik individu seperti kepribadian, latarbelakang kesehatan, dan *life balancing* (keseimbangan hidup). *Life balancing* sebagaimana didefinisikan oleh WHO meliputi keseimbangan fisik, sosial, intelektual dan spiritual yang kemudian adanya keseimbangan inilah muncul pengertian kesehatan total.

Adapun menurut teori *conservation of resources theory* (CRS) tekanan psikologis seringkali terjadi ketika sumber signifikan hilang.¹⁹ Salah satu sumber signifikan atau *valued resource* yang dapat mempertahankan kesehatan psikologis adalah terpenuhinya kesejahteraan spiritualitas (*spirituality wellness*). Sehingga mengabaikan kebutuhan spiritual dapat memberikan kontribusi ke tingkat stres yang lebih tinggi. Hal ini kemudian ditegaskan juga dengan pandangan Strohl (1998) sebagaimana dikutip oleh Hardiman dan Graets bahwa untuk memfasilitasi sebuah model efektif dalam fungsi optimal manusia (*human functioning*) maka aspek spiritual harus menjadi perhatian.²⁰

Dalam perspektif Islam kecemasan yang merupakan salah satu indikasi stres, menurut al- Ghazali muncul karena permasalahan spiritualitas. Kecemasan merupakan salah satu penyakit hati.²¹ Selanjutnya Şalih ibn ‘Abd Allah menjelaskan bahwa jika ditinjau dari penderitanya kecemasan (*qalaq*) dibagi menjadi dua, yaitu kecemasan

¹⁸Diki Christyanti, dewi Mustami’ah, dan Wiwik Sulistiani, “Hubungan antara Penyesuaian Diri terhadap Tuntutan Akademik dengan Kecenderungan Stress pada Mahasiswa Fakultas kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya”, *Insan*, Vol. 12, No. 03, (2010); 153-159.

¹⁹Debbie Cohen and others, *Factor that Impact on Medical Student Wellbeing – Perspective of Risk*, Cardiff University, (2013); 1-83.

²⁰Piers Hardiman dan Janette Graetz Simmonds, “Spiritual Well-Being, Burnout and Trauma in Counsellors and Psychotherapists”, *Mental Health, Religion, & Culture*, Vol. 16, No.10, (2013); 1044-1055.

²¹Abu Ahmad al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Ma ‘rifah,1997), 315.

masyarakat (*al-qalaq al-ijtimā'iy*) yakni kecemasan yang terjadi karena terjadinya situasi sosial yang mengkhawatirkan orang banyak sehingga mengganggu stabilitas sosial seperti kecemasan akibat bencana alam.

Selanjutnya adalah kecemasan pribadi (*al-qalaq as- Shaḥṣīy*) yakni kecemasan yang dialami pribadi masing-masing individu, seperti kecemasan menghadapi kesulitan ekonomi. Kecemasan pribadi ini muncul karena ada yang bersifat nyata (*al-ḥaṣr al-waqi'iy*) karena adanya objek eksternal yang memengaruhinya dengan bentuk tertentu, seperti ujian. Namun juga ada yang bersifat instingtif/fitrah (*al-ḥaṣr al-'aṣabiy*) yakni bentuk kecemasan yang muncul karena potensi, naluri dan bawaan manusia, seperti kecemasan mengaharapkan kelahiran buah hati. Selanjutnya kecemasan individu ini ada juga yang bersifat perilaku (*al-ḥaṣr al- aḥlāqiy*) yakni kecemasan yang muncul karena perilaku individu itu tersebut, seperti kecemasan yang dirasakan individu setelah dirinya melakukan dosa karena takut diketahui oleh lain.²²

Sementara dalam psikologi modern kecemasan akibat stres merupakan emosi yang dikembangkan secara naluriah sejak manusia itu lahir yang disebut dengan istilah *separation distress* dan *stranger distress*. *Separation distress* muncul karena seorang bayi merasa terpisah atau kehilangan sosok ibu disampingnya, sementara *stranger distress* muncul karena ketidak nyamanan bayi dengan orang yang tidak dikenalnya.²³

Antai-Otong (2001) dalam Othman menjelaskan hubungan antara spiritualitas dan kecemasan sebagai hubungan integral dalam manajemen stres, karena spiritualitas dapat memberikan tujuan, harapan dan makna hidup. Melalui kepercayaan kepada Tuhan, seseorang dapat meminimalisir stres dengan cara meyakini bahwa Tuhan akan

²²Ṣalīḥ ibn 'Abd Allāh, *Naḍrah al- Na'im fi Makārim al- Akhlāq al-Rasūl al- Karīm*, (Jedah: Dar al- Waṣīlah li al- Nasr wa al- Tawzī, 1998), 5338.

²³David H. Barlow, *Anxiety and Its Disorder: The Nature and the Treatment of Anxiety and Panic*, (New York: The Guildford Press, 2002), 39.

selalu ada sebagai tempat kembali dan berbagi atas rasa susah dan sedih yang dihadapi.²⁴

Meyakini Tuhan sebagai tempat kembali selaras dengan ajaran Islam dimana salah satunya ketika nabi Ya'qub merasakan tekanan kesedihan yang sangat mendalam atas kehilangan putra tercintanya Yusuf AS, maka Ia pun berkata sebagaimana hal ini diajarkan kepada kita untuk yakin bahwa Allah akan selalu ada dalam setiap rasa sedih dan susah yang kita hadapi sebagaimana disebutkan dalam surah Yusuf ayat 86:

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

Artinya:

“Dia (Ya'qub) menjawab “sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya”. (Yusuf: 86)

Ayat ini menjelaskan bahwasanya, ketika Nabi Ya'qub kehilangan putranya Yusuf dirinya mengalami kesusahan dan kesedihan yang sangat mendalam, namun demikian Nabi Ya'qub hanya mengadukan hal tersebut kepada Allah. Apa yang dilakukan Nabi Ya'qub dalam kajian psikologi disebut dengan istilah katarsis, yakni pelepasan emosi-emosi yang terpendam.²⁵ Ayat di atas juga menegaskan pengalaman Nabi Ya'qub meskipun dalam keadaan emosional

²⁴Khatijah Othman, “Researching Solution based on Islamic View and Practice in Managing Financial and Work Place Stress”, *International Journal of Academic Research in Business and Social Science*, Vol. 2, No. 8, (2012); 239-252.

²⁵Katarsis diperlukan bagi orang-orang yang menghadapi masalah atau situasi yang sangat berat, menyedihkan, atau menjengkelkan. Dalam konseling psikologis, seorang konselor seringkali hanya berperan sebagai media katarsis atau penampung segala macam keluhan klien yang menumpahkan segala macam perasaan, emosi dan pikiran-pikiran yang menganggunya. Pada umumnya setelah melakukan katarsis, klien akan merasa lebih ringan, meski masalahnya belum terselesaikan. Proses katarsis seringkali diikuti dengan luapan tangisan dan biasanya konselor akan membiarkan klien menangis sampai mereka merasa lega. Lih Rizki Joko Sukmono, *Psikologi Zikir*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 56.

“bersedih atas kehilangan Yusuf” mampu merasakan kehadiran Tuhan dan memunculkan keyakinan dan harapan. Sebagaimana Sabhi (tt) menyebutkan bahwa spiritualitas adalah esensi *ruhiyah* yang dapat merasakan kehadiran Tuhan.²⁶ Hal ini kemudian ditegaskan oleh ‘Uthman al-‘Āmir, bahwa pembentukan spiritualitas menekankan pada penyempurnaan *ruh*, mensucikan jiwa, mencerahkan akal, mengokohkan akhlak dalam rangka membuat ikatan dengan Allah, sehingga manusia dekat dengan-Nya dalam setiap gerak di setiap waktu dan tempat, merasakan keridhaan-Nya.²⁷

Individu yang dapat merasakan kehadiran Tuhan adalah individu yang memiliki keimanan/kepercayaan yang tinggi kepada Allah (*jawwu al-īmān*). Allah berjanji bahwa Allah-lah Tuhan mereka, kemudian ikrar itu tetap dipegang dalam setiap gerak langkahnya, maka Allah akan menghilangkan rasa takut dan kesedihan dari dirinya, sebagai disebutkan dalam al- Qur’ah surah al- Ahqaf ayat 13:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita”. (Al- Ahqaf: 13)

Sejalan dengan surat di atas, Rasulullah juga mengisyaratkan kondisi seorang mukmin, manakala menghadapi sebuah kegagalan atau musibah, sebagaimana termaktub dalam hadits yang artinya sebagai berikut:

Artinya:

“Tidaklah berkumpul harapan dan kekhawatiran dalam hati mumin kecuali Allah Yang Maha Perkasa dan Mulia mem-

²⁶Ghāzī Sabhi, *Al-Qur’ān Manhaj al- Hayah*, (al-Maktabah al-Shāmilah, V.3.28), 446.

²⁷‘Uthman Al- Āmir, *Mas’uliyah al- Muthaqqaf al- Islami Tujah Qadaya al- Irhab*. (al- Maktabah al- Shāmilah. V.3.28), 3.

berinya harapan dan mengamankannya dari kekhawatiran”.
(HR. Tabrani).

Mukmin sejati tidak merasa khawatir dan gentar dalam menghadapi bencana dan cobaan. Bahkan sebaliknya bagi seorang mukmin krisis dan tekanan dapat menguatkan spiritualitasnya. Hal ini selaras dengan pandangan tokoh Barat Leeuwen et al (2008) yang menjelaskan bahwa melalui spiritualitas individu akan berharap dan lebih siap untuk menerima segala situasi dan siap melawan segala situasi.²⁸

Dari pembahasan di atas dapat dianalisis bahwa spiritualitas memberikan pengaruh positif terhadap manajemen stres atau ketika dihubungkan dengan stresor maka spiritualitas dapat berfungsi sebagai *counter* terjadinya stres. Dalam sebuah penelitian psikologi fungsi spiritualitas ini disebut dengan istilah *stress counter balancing effect*.²⁹ Namun demikian mengatasi stres dengan perspektif spiritual bukan bermaksud meniadakan aspek perbuatan lainnya. Spiritual dalam pandangan holistik adalah menuntut kita untuk mendekati permasalahan dengan berbagai cara yang mungkin (*possible*).³⁰ Dengan demikian berbagai stresor yang dihadapi oleh mahasiswa kedokteran sebagaimana diulas di atas tidak dapat begitu saja dipecahkan dengan melihat hubungannya dengan aspek spiritual saja, dibutuhkan langkah-langkah aktif untuk mengatasi berbagai stresor dan memperbaiki akibat-akibat yang akan ditimbulkan dengan tindakan bertahap yang kemudian istilah ini dikenal dengan koping efektif³¹.

²⁸Van Leeuwen and others, “Aspects of Spirituality Concerning Illness”, *Scandinavian Journal of Caring Science*, Vol. 21, (2008); 482-489.

²⁹Gracie H. Boswell, Eva Kahana dan Peggy DA, “Spirituality and Healthy Lifestyle Behaviors; Stress Counter – Balancing Effects on the Well-Being of Older Adults”, *Journal of Religion and Health*, Vol. 45, No. 4, (2006); 587-602.

³⁰Stephen G. Wright, *Burnout- Spiritual Crisis*, diakses dari [http://mindtouch.jankifoundation.org/api/deki/files/112/=Burnout_-_ a_Spiritual_Crisis._Wright%252c_Nursing_Standard_2005.pdf](http://mindtouch.jankifoundation.org/api/deki/files/112/=Burnout_-_a_Spiritual_Crisis._Wright%252c_Nursing_Standard_2005.pdf) pada tanggal 12 Mei 2015 pukul 10.15 WIB

³¹Coping adalah tindakan untuk merubah kognitif dan tingkah laku untuk mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang dinilai membebani seorang individu. Lih Alexander Faisal, Mariangela Gentil Savonia dan

Menurut Lazarus dan Folkman (1984) seseorang yang melakukan strategi untuk mengurangi emosi negatif yang berhubungan dengan stresor disebut juga dengan istilah “*emotion-focused coping*”, adapun seseorang yang melakukan tindakan secara aktif dalam menghadapi stresor disebut juga dengan istilah “*problem-focused coping*”.³² Sehingga demikian regulasi diri dapat menjadi salah satu bentuk *coping* yang efektif yang kemudian terbagi pada dua dimensi yakni *emotional self regulation* (regulasi emosi diri) dan *behavioral self regulation* (regulasi tindakan diri).³³

Berkaitan sedikit dengan konsep regulasi diri, al-Ghazālī pernah mengungkapkan gagasannya tentang *ma‘rifah*.³⁴ Dalam *ma‘rifah* terkandung maksud pengenalan secara langsung terhadap Tuhan dan alam termasuk diri sendiri. Mengenal diri sendiri berarti menghantar bagaimana sampai ke tujuan, hal ini selaras dengan pandangan Zimmerman (1989) yang mengatakan bahwa regulasi diri diperlukan untuk menghantar diri kepada tujuan.³⁵ Sementara Fisher menjelas-

Paulo Rossi Menezes, “Coping Style and Depressive Symptomatology during Pregnancy in a Private Setting Sample”, *The Spanish Journal of Psychology*, Vol. 15, No. 1, (2012); 195-305.

³²Richard S. Lazarus dan Susan Folkman, *Stress, Appraisal and Coping*, (New York; Springer-Verlag, 1984), 34.

³³Regulasi diri adalah usaha individu untuk mengatur atau merubah respon mereka terhadap khususnya (tapi tidak terbatas) pada keadaan tertentu. Regulasi diri bisa mengarah pada tindakan yang disebut dengan *behavioral self regulation* (regulasi diri perilaku) dan satu lagi mengarah pada *emotional self regulated* (regulasi emosi diri) yang bermakna pengaturan terhadap rasa/emosi atau perasaan diri (seperti merubah mood diri) termasuk juga dalam regulasi emosi adalah regulasi fungsi kognitif (seperti menentukan tujuan, dan memfokuskan kesadaran diri). Lih. Carolyn Aldwin, Crystal Park, Yu-Jin Jeong dan Tiwik Nath, “Differing Pathways Between Religiousness, Spirituality, and Health; a Self Regulation Perspective”, *Psychology of Religion and Spirituality*, Vol. 6, No. 1, (2014), 9-21.

³⁴*Ma‘rifah* menurut al-Ghazali adalah mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Sedangkan cara yang dapat ditempuh untuk mencapai *ma‘rifah* adalah dengan penyucian diri (*tazkiyah al-nafs*) dan latihan (*riyadah*).

³⁵Zimmerman menyatakan “*self regulation refers to self-generated thoughts, feelings, and actions that are planned to the attainment of personal goals*”. Barry J. Zimmerman, “A social Cognitive View of Self Regulated

kan bahwa disregulasi psikologis akan menyebabkan guncangan emosi, sehingga untuk menjaga stabilitas emosi diperlukan regulasi psikologis baik melalui regulasi emosi itu sendiri maupun regulasi perilaku.³⁶

Selanjutnya Wibowo (2011) menjabarkan konsep regulasi diri islami adalah terdiri dari: (1) pengarahannya metakognisi sesuai dengan akidah Islam yaitu pemahaman dan kesadaran tentang proses kognitif, merencanakan, mengorganisasi, mengukur diri, dan menginstruksikan diri dalam kerangka keimanan, (2) pengarahannya motivasi yang islami, mencakup semua pemikiran, tindakan atau perilaku dimana seseorang berusaha memengaruhi pilihan, usaha dan ketekunannya dalam rangka beribadah dan bermuamalah yang diwujudkan dalam bentuk dorongan berjuang di jalan Allah (*jihad*) dan dorongan untuk melakukan muamalah atau beramal soleh (*amilus-solihat*); dan (3) pengarahannya perilaku aktif sebagai *abdullah* dan *khalifatullah*.³⁷

Penjabaran di atas mendeskripsikan hubungan antara regulasi diri dengan nilai spiritual. Secara psikologis spiritualitas yakni dengan percaya kepada Tuhan memberikan pengaruh positif terhadap regulasi diri, memunculkan keberanian untuk berkeinginan besar dan keyakinan diri serta kemantapan berusaha dan optimis dalam diri. Dengan hal ini spiritualitas menjadi sumber pengaturan diri.³⁸

Regulasi diri yang didorong oleh nilai spiritualitas yang baik dapat memengaruhi respon diri terhadap stresor yang dihadapi sehingga dapat menjadi stres yang positif yakni dikenal juga dengan istilah *eustress*.³⁹ Sementara Mohd dan Hamdan (2006) menjelaskan

Academic Learning”, *Jurnal of Educational Psychology*, Vol. 81, (1989), 329-339.

³⁶Sebern Fisher, “Arousal and Identity: Thoughtson Neurofeedback in Treatment of Develomental Trauma”, *Biofeedback*, Vol. 38, No. 1, (2010); 6-8.

³⁷Ugung Dwi Ario Wibowo, “Peran Regulasi Diri Islami dan Karakteristik Pekerjaan terhadap Komitmen Organisasional pada Karyawan Organisasi Syariah”, *Jurnal Psikologika*, Vol. 18, No. 1, (2013); 89-97.

³⁸Aftina Nurul Husna, Frieda N.R., Hidayati, dan Jati Ariati. “Regulasi Diri Mahasiswa Berprestasi”, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 13, No. 1, (2014); 50-63.

³⁹Menurut Lazarus sebagaimana yang dikutip oleh Lumongga ada dua bentuk stress yaitu *distress* dan *eustress*, (a) *Distress* (stres negatif)

stres adalah keadaan alamiah dalam kehidupan manusia. Stres dapat memberi pengaruh positif dan negatif tergantung bagaimana seseorang dapat mengontrol, mengatur, dan menangani stres.⁴⁰ Al-Qur'an secara jelas menyebutkan biologis alamiah penciptaan manusia yang kadangkala gelisah dan tertekan yang kemudian dapat mempengaruhi perasaan, mental dan fisik manusia. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

﴿ إِنَّا لَإِنْسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿﴾

Artinya:

“Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan kecemasan (19) apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah (20)” (al-Ma‘arij: 19-20).

Dari dua ayat ini dapat dipahami bahwa Allah menciptakan manusia memiliki rasa gelisah dan berkeluh kesah sebagai reaksi alamiah sensitifitas dan sistem saraf tubuh terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, karena pada dasarnya musibah dan kesusahan bukanlah sesuatu yang diinginkan manusia pada umumnya. Sensitifitas ini menggambarkan respon emosi dan perilaku terhadap pengaruh faktor internal dan eksternal dari lingkungan sekitar.

Menurut Adnan Syarif (2002), manusia menjadi sangat rentan mengalami kecemasan, kekhawatiran bahkan ketakutan, karena hal ini dipengaruhi oleh sistem syarafnya yang sangat peka (*over sensitive*). Dimana pada setiap makhluk hidup terdapat pusat-pusat syaraf organik yang berperan dalam memunculkan ketakutan, kecemasan, rasa marah dan melarikan diri. Hal ini terjadi ketika manusia

yaitu stres yang mengganggu. Individu yang tidak mampu mengatasi keadaan emosinya akan mudah terserang *distress*. *Distress* juga memiliki pengertian stres yang merusak dan merugikan. Ciri-ciri individu yang telah mengalami *distress* yaitu mudah marah, cepat tersinggung, sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, pelupa, pemurung, tidak energik dan cepat bingung. (b) *Eustress*(stres positif) yaitu stres baik atau yang tidak mengganggu dan memberikan perasaan bersemangat. Stres yang bermanfaat dan konstruktif. Lumonga, *Depresi Tinjau Psikologis*, (Jakarta: Kencana, 2009), 17-18.

⁴⁰Taib Dora Mohd dan Abd Kadir Hamdan, *Mengurus Stress*, (Malaysia: PTS Publication Distributor Sdn.Bhd, 2006), 27.

menghadapi keadaan yang membahayakan dan menimbulkan keburukan bagi dirinya. Dalam batas tertentu, secara tidak berlebihan dan memakan waktu lama, hal ini merupakan reaksi alami tubuh.⁴¹ Bahkan kecemasan dan ketakutan alamiah ini tidak hanya dialami manusia biasa, tetapi juga dirasakan oleh para Nabi. Sebagaimana pada situasi tertentu sebagai contoh Nabi Ibrahim dan Musa juga merasakannya. Beberapa ayat al-Qur'an berikut menjelaskan kisahnya, diantaranya:

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ وَدَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾

Artinya:

“Oleh karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut", dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak)”. (Az- Zariyat: 28)

وَأَنَّ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَمُوسَىٰ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ ۚ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾

Artinya:

“Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah Dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. (Kemudian Musa diseru): "Hai Musa datanglah kepada-Ku dan janganlah kamu takut. sesungguhnya kamu Termasuk orang-orang yang aman”. (al-Qashash: 31)

Diantara gejala kesedihan, kecemasan dan ketakutan yang alamiah adalah yang tidak mengakibatkan frustrasi. Keadaan tersebut tidak menghalangi individu tersebut dari bekerja, berpikir dan berperasaan secara wajar. Dengan demikian dalam perspektif Islam terkadang stres merupakan kondisi normal, dengan spirit yang bagus dan regulasi diri justru dapat menjadikan kondisi tubuh semakin baik

⁴¹Adnan Syarif, *Psikologi Qur'ani*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), 90

dan tangguh. Menghubungkan antara spiritualitas dengan regulasi diri merupakan bentuk sanggahan penulis terhadap pandangan Albert Ellis yang mengatakan bahwa spiritualitas dan keyakinan terhadap Tuhan adalah pola pikir yang irasionalistik bahkan berpotensi terhadap permasalahan psikologis lainnya.⁴² Beberapa peneliti lainnya seperti Norcross⁴³ dan Siddle⁴⁴ juga cenderung memaknai spiritualitas sebagai abnormalitas. Menurut mereka pengalaman keyakinan dan kedekatan dengan Tuhan dapat menyebabkan permasalahan psikologis dan sosial seperti fanatisme, symptoms ansietas, halusinasi, dan sebagainya.⁴⁵

Kemampuan regulasi diri menjadi jawaban mengapa statement “spiritualitas adalah bentuk irasionalitas dan abnormalitas” dapat dibantahkan karena beberapa peneliti menyatakan bahwa regulasi diri dilakukan secara sadar (*conscious*) dan proses yang penuh usaha (*effortful process*).⁴⁶ Hal ini dapat dipahami bahwa dalam regulasi diri dibutuhkan kesadaran diri (*self awareness*), sementara kesadaran diri ini lah yang menjadi inti dari spiritualitas. Menurut Ibnu al-Qayyim spiritualitas ini berada di dalam hati yang mana beliau menjelaskan bahwa spiritualitas yang berkedudukan di hati ini berfungsi untuk tidak memberi persetujuan atas pikiran

⁴² Albert Ellis, “Psychotherapy and Atheistic Values; A Reason to AE Bergin’s Psychotherapy and Religious Values”, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol. 48, (1980); 635-639.

⁴³ Jhon C. Norcross, “Evidence-Based Therapy Relationship,” Sponsored by the American Psychological Association’s (APA) Division of Psychotherapy and Division of Clinical Psychology (2010); 29-30.

⁴⁴ Ronald Siddle and others, “Religious Delusions in Patients Admitted to Hospital With Schizophrenia”, *SocPsychiatry Epidemiol*, Vol.37, (2002); 130-138.

⁴⁵ Ahmad Rusydi, *Kecemasan dan Psikoterapi Spiritual Islam: Dari Spiritual Disorder hingga Persoalan Eksistensi Menuju Kesehatan Psiko-Spiritual*, (Jakarta: Disertasi Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 30

⁴⁶ Carver, C.S., & Scheier, M.F. dalam Carolyn Aldwin, Crystal Park, Yu-Jin Jeong dan Tiwik Nath, “Differing Pathways Between Religiousness, Spirituality, and Health; a Self Regulation Perspective”, *Psychology of Religion and Spirituality*, Vol. 6, No. 1, (2014), 9-21.

negatif dan berusaha untuk mentransformasikan diri untuk melakukan hal yang positif.⁴⁷

Pandangan ini ditegaskan kembali oleh Hamzah yang mengatakan bahwa dalam perspektif Islam, spiritualitas merupakan sesuatu yang dapat memotivasi manusia untuk bertingkah laku baik. Menurutnya spiritualitas muncul karena dimotivasi oleh jiwa rasional.⁴⁸ Begitu pula pendapat al-Barā dan al-Ma'an yang menekankan spiritualitas sebagai entitas keruhanian dan kebaikan.⁴⁹ Ibnu Sina juga menjelaskan bahwa jiwa yang spiritualis dipengaruhi oleh jiwa yang suci. Dimana jiwa suci ini mampu melihat secara imajinatif apa yang terjadi pada dirinya dan bagaimana kondisi jiwanya. Jiwa suci ini dapat dicapai melalui akhlak dan perilaku-perilaku baik.⁵⁰

Senada dengan pandangan di atas, studi yang dilakukan oleh Aldwin at al (2014) juga menunjukkan bahwa spiritualitas dan agama berkorelasi positif terhadap regulasi diri, secara spesifik studi ini menegaskan bahwa agama berkorelasi positif dengan regulasi tindakan diri sementara spiritualitas berkorelasi positif dengan regulasi emosi diri.⁵¹ Namun demikian Aldwin at al melakukan penelitian mengenai pengaruh spiritual dan religiusitas terhadap kesehatan. Sementara disertasi ini berusaha memfokuskan penelitian pada pengaturan diri dalam akademik mahasiswa kedokteran yakni regulasi diri dalam belajar. Selanjutnya disertasi ini juga memfokuskan kajiannya pada sejauh mana integrasi spiritualitas dan regulasi diri tersebut dapat

⁴⁷Ibn Qayyim al- Jauziyah, *Al-Dāwa': Macam-Macam Penyakit Hati yang Membahayakan dan Resep Pengobatannya*, (Jakarta: Pustaka Imam as-Shafi'i, 2009), 54.

⁴⁸Rohana Hamzah, Kamarudzaman, dan Roziyah Mohammad Janor, "Spiritual Education Development Model", *Journal of Islamic and Arabic Education*, Vol. 2, N0.2, (2010); 1-12.

⁴⁹Abū al-Barā dan Usamah bin Yāsīn al-Ma'anī, "Manhaj Shar' fi 'Ilāj al-Mass wa al-Ṣar'," al-Silsilah al-'Ilmiyah, Naḥw Mausū'ah Shar'iyah fil 'Ilm al-Ruqy, (Dār al-Ma'āfi;2000), 5.

⁵⁰Ibn Sina, *Al-Fann al-Sādīs min al- Ṭabī'iyat min Kitāb al-Shifā'*, (Paris: Enterprise Universitaire, 1988), 107-260.

⁵¹Carolyn Aldwin, Crystal Park, Yu-Jin Jeong dan Tiwik Nath, "Differing Pathways Between Religiousness, Spirituality, and Health; a Self Regulation Perspective", *Psychology of Religion and Spirituality*, Vol. 6, No. 1, (2014), 9-21.

memengaruhi tingkat stres mahasiswa akibat stresor yang dihadapi oleh mereka.

Berdasarkan studi pendahuluan melalui observasi dan wawancara awal, penulis mendapatkan indikator yang menjurus pada kejadian stres yang dihadapi mahasiswa kedokteran di Jakarta, sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh salah seorang mahasiswa kedokteran UIN “tuntunan studi bidang kedokteran terasa cukup berat dengan materi yang sulit dan banyak serta jadwal perkuliahan yang cukup padat menjadi sangat melelahkan dan memberi tekanan psikologis tersendiri”.⁵² Seorang mahasiswa tahun pertama lainnya mengungkapkan “seringkali dirinya merasakan rasa kesal dan mudah marah dikarenakan sistem pembelajaran di kedokteran yang dituntut untuk belajar secara kolaboratif serta adanya sikap yang kompetitif, sementara sebagai mahasiswa baru seringkali dibenturkan dengan kepribadian yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakcocokan dan cara tersendiri dalam menyelesaikan tugas kuliah yang bersifat PBL (Problem Based Learning)”.⁵³

Namun demikian sebelum mengukur prevalensi kejadian stres di kalangan mahasiswa tersebut, penulis tertarik untuk terlebih dahulu mengeksplor stresor apa saja yang dihadapi mereka dan sejauh mana stresor tersebut dapat memengaruhi stres yang terjadi. Adapun mengetahui prevalensi stres juga diperlukan agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan kemampuan skill mahasiswa dalam menanggulangi stres dengan upaya optimalisasi potensi diri yakni seperti spiritualitas dan regulasi diri yang pada selanjutnya kedua hal ini dijadikan variabel yang akan turut diukur pengaruhnya atas stres yang dialami mahasiswa kedokteran.

Untuk selanjutnya penelitian ini akan dilaksanakan pada tiga kampus kedokteran yang berada di lokasi DKI Jakarta yang meliputi :1) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2) Universitas YARSI, dan 3) Universitas Trisakti. Pemilihan ketiga kampus tersebut berdasarkan letak geografis kampus yang berada di DKI Jakarta, kemudian pemilihan kampus berdasarkan kriteria kampus bernuansa Islam dengan beberapa tambahan mata kuliah keislaman dan satu kampus negeri umum pembandingan.

⁵²Wawancara mahasiswa UIN, Kamis 20 Agustus 2015.

⁵³Wawancara mahasiswa UIN, Kamis 20 Agustus 2015.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan holistik pada manajemen stres, yakni melihat bagaimana hubungan stresor (sebagai potensi negatif) dan spiritualitas (sebagai potensi positif) terhadap prevalensi stres yang dialami mahasiswa kedokteran di Jakarta dengan menggunakan variabel mediator (regulasi diri). Sebagaimana dijelaskan di atas yakni untuk memecahkan masalah morbiditas stres dengan perspektif holistik maka diperlukan usaha lain yang memungkinkan untuk menanggulangi berbagai tekanan yang dihadapi. Alasan penulis menggunakan variabel mediator ini adalah berdasarkan teori dari Levenson & Aldwin (2013)⁵⁴, bahwa untuk menguji hubungan antara spiritualitas dan kesejahteraan diri yang salah satu nya adalah terlepas dari stres maka dibutuhkan intervensi regulasi diri.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Melalui paparan latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa sumber stres (stresor) yang dialami mahasiswa kedokteran di DKI Jakarta.
2. Stresor diketahui dengan pasti memengaruhi stres pada mahasiswa kedokteran di DKI Jakarta.
3. Stres yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan permasalahan akademik lainnya seperti prestasi rendah, kurang konsentrasi belajar, bahkan gangguan psikologis yang lebih berat seperti depresi.
4. Spiritualitas dan regulasi diri dapat menjadi pengendali kejadian stres yang dirasakan mahasiswa kedokteran di DKI Jakarta

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengaruh

⁵⁴Carolyn Aldwin, Crystal Park, Yu-Jin Jeong dan Tiwik Nath, "Differing Pathways Between Religiousness, Spirituality, and Health; a Self Regulation Perspective", *Psychology of Religion and Spirituality*, Vol. 6, No. 1, (2014), 9-21.

stresor dan spiritualitas terhadap tingkat stres mahasiswa kedokteran di DKI Jakarta melalui regulasi diri sebagai mediator?.

Rumusan masalah tersebut di atas dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh stresor terhadap stres mahasiswa kedokteran?
2. Bagaimana pengaruh spiritualitas terhadap stres mahasiswa kedokteran?
3. Bagaimana pengaruh spiritualitas terhadap regulasi diri belajar?
4. Bagaimana pengaruh regulasi diri belajar terhadap stres mahasiswa kedokteran?
5. Bagaimana pengaruh spiritualitas dapat menekan stres melalui regulasi diri belajar sebagai mediator?
6. Bagaimana implementasi spiritualitas mahasiswa kedokteran yang dapat meningkatkan pertahanan diri dari stres?
7. Bagaimana implementasi keterhubungan antara spiritualitas dan regulasi diri belajar pada mahasiswa kedokteran?

3. Hipotesis

Hipotesis Mayor : Ada hubungan antara stresor, spiritualitas dan regulasi diri dengan stres yang dihadapi mahasiswa kedokteran di DKI Jakarta.

Hipotesis Minor:

- a) Stresor berhubungan positif dengan stres. Semakin tinggi stresor maka akan semakin tinggi stres yang dialami.
- b) Spiritualitas berhubungan negatif dengan stres. Semakin tinggi spiritualitas semakin rendah stres yang dialami.
- c) Spiritualitas berhubungan positif dengan regulasi diri belajar. Semakin tinggi spiritualitas semakin tinggi regulasi diri belajar.
- d) Regulasi diri berhubungan negatif dengan stres. Semakin tinggi regulasi diri semakin rendah stres yang dialami.
- e) Spiritualitas dapat menurunkan pengaruh stresor terhadap stres dengan regulasi diri sebagai mediatornya.

4. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang ada, maka fokus kajian penelitian ini hanya menganalisis pengaruh spiritualitas dan regulasi diri belajar terhadap stres serta peran mediasi regulasi diri belajar dalam hubungan antara spiritualitas dan stres. Sementara tingkat generalisasi hasil analisis terbatas pada sejumlah mahasiswa kedokteran di Tiga Kawasan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta terpilih, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah⁵⁵, Universitas Trisakti (Jakarta Barat) dan Universitas YARSI (Jakarta Pusat).

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di fakultas kedokteran dengan tujuan sebagaimana berikut ini:

1. Untuk menganalisis berbagai stresor yang dihadapi mahasiswa kedokteran di DKI Jakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh stresor terhadap tingkat stres yang dialami mahasiswa kedokteran di DKI Jakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh spiritualitas terhadap tingkat stres yang dialami mahasiswa kedokteran di DKI Jakarta.
4. Untuk menganalisis pengaruh spiritualitas terhadap regulasi diri pada mahasiswa kedokteran di DKI Jakarta.
5. Untuk menganalisis pengaruh regulasi diri sebagai mediator dalam hubungan stresor dan spiritualitas terhadap tingkat stres yang dialami mahasiswa kedokteran di DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Secara akademis hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam pengkayaan kajian literatur mengenai permasalahan mental yang dalam studi ini difokuskan pada fenomena stres di dunia pendidikan, khususnya disiplin pendidikan dokter. Pendekatan masalah dengan

⁵⁵Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah meskipun secara geografis berada di Tangerang Selatan-Banten setelah pemekaran tahun 2000 namun secara administratif kampus tersebut numpang nama di Provinsi DKI Jakarta. Lih UIN Jakarta memiliki 3 Gubernur diakses dari <http://www.uinjkt.ac.id/id/uin-jakarta-miliki-3-gubernur/>

perspektif spiritual tentunya akan menambah kajian psikologi agama yang menyoroti urgensi spiritualitas untuk mewujudkan pribadi dengan mental yang sehat.

Adapun secara praktis hasil studi ini dapat menjadi informasi penting bagi pihak otoritas perguruan tinggi mengenai tingkat dan level masalah mental yang dihadapi para mahasiswanya, sehingga diharapkan dapat memberikan intervensi melalui kurikulum berbentuk keahlian manajemen diri seperti kelas teori dan praktek relaksasi dan regulasi diri belajar atau memberikan akses layanan kesehatan mental bagi para mahasiswa.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian terhadap penelitian terdahulu ini diperlukan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang dimaksudkan dapat memberi kejelasan dan batasan informasi serta menunjukkan bahwa fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya.

Studi terdahulu telah mengungkapkan prevalensi stres di kalangan mahasiswa kedokteran lebih tinggi dibandingkan mahasiswa dari bidang dan jenis konsentrasi keilmuan lainnya. Fenomena ini tidak dapat dikatakan sebagai permasalahan lokal karena banyak negara lintas geografis dan budaya telah melakukan studi survei secara nasional mengenai hal ini, seperti studi yang dilakukan oleh Jonathan Mamo et al (2012) yang berjudul “*Psychological Stress amongst Maltese Undergraduate Medical Students*”, mengenai perbandingan fenomena stres antara mahasiswa kedokteran dan non kedokteran di Malta, bahwa dari 561 total subjek yang diikutsertakan (208 mahasiswa kedokteran dan 253 non-kedokteran) menunjukkan hasil tingkat stres yang lebih tinggi pada mahasiswa kedokteran, secara statistik terjadi perbedaan signifikan ($p < 0.5$) pada hasil skor yang diperoleh, studi ini juga menyebutkan bahwa mahasiswa perempuan memiliki tingkat stres yang lebih tinggi secara signifikan dengan mahasiswa laki-laki.⁵⁶

⁵⁶Jonathan Mamo, Raphael and others, “Psychological Stress amongst Maltese Undergraduate Medical Students”, *International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health*, Vol. 4, No. 5, (2012); 840-849.

Tingginya tingkat stres di kalangan mahasiswa kedokteran menarik minat para peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sumber resiko yang bisa menghantar kepada stres yang dirasakan. Seperti studi yang dilakukan oleh Seyedfatemi et al (2007) berjudul “*Experienced Stressors and Coping Strategies among Iranian Nursing Students*”, menyebutkan bahwa salah satu faktor pencetus tingginya stres yang dialami mahasiswa kedokteran adalah karena perubahan jadwal kegiatan sehari-hari yang salah satunya adalah perubahan kuantitas waktu tidur.⁵⁷ Sedikit berbeda dengan hasil studi yang dilakukan oleh Chilukuri et al (2012) berjudul “*Perceived Stress amongst Medical and Dental Students*”, mengenai berbagai sumber stres yang dihadapi mahasiswa pendidikan dokter umum dan gigi. Studi ini menunjukkan bahwa sumber resiko tingginya stres di kalangan mahasiswa kedokteran adalah terkait dengan akademik dan permasalahan personal, seperti mahasiswa mengeluh mata kuliah yang dianggap *overload*, tekanan dari guru dan orang tua serta permasalahan antar personal mahasiswa kedokteran itu sendiri.⁵⁸

Selanjutnya studi mengenai stres mahasiswa kedokteran juga menjadi *concern* beberapa penelitian mengingat bahwa dampak dari stres yang dirasakan dapat menimbulkan gangguan disfungsi psikologis yang lain dan bersifat lebih parah, seperti studi Sherina et al (2004) berjudul “*Psychological Stress Among Undergraduate Medical Students*” yang mengikutsertakan sejumlah 396 mahasiswa kedokteran dari berbagai kampus di Malaysia menyebutkan bahwa stres yang dirasakan oleh mahasiswa kedokteran memiliki hubungan signifikan dengan dampak depresi yang ditimbulkan.⁵⁹ Studi terbaru serupa juga dilakukan oleh Suhail (2013) di Lahore, Pakistan dimana hasil studi

⁵⁷Naiemah Seyedfatemi, Maryam Tafreshi dan Hamid Hagani, “Experienced Stressors and Coping Strategies among Iranian Nursing Students”, *BMC Nursing*, Vol. 6, No. 11, (2007). Diakses dari <http://www.biomedcentral.com/1472-6955/6/11/prepub>.

⁵⁸Harihar Chilukuri and others, “Perceived Stress amongst Medical and Dental Students”, *Ap J Psychological Medicine*, Vol. 13, NO. 2, (2012); 104-107.

⁵⁹Mohd. Sidik Sherina, Lekhraj Rampal dan Nadarjan Kaneson, “Psychological Stress Among Undergraduate Medical Students”, *Med J Malaysia*, Vol. 59, No. 2, (2004); 207-211.

menunjukkan bahwa stres memberi pengaruh terhadap rendahnya prestasi di kalangan mahasiswa kedokteran.⁶⁰

Bukti mengenai stres dan sumber stres yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian seperti diungkap di atas kemudian membantu sekolah kedokteran dalam manajemen yang lebih baik terhadap stresor dan juga tindakan koping sebagai kesatuan paket dari proses belajar mengajar. Sehingga ada beberapa penelitian yang secara khusus meneliti lebih dalam bagaimana tingkat stres dan kebiasaan koping yang banyak dilakukan oleh mahasiswa kedokteran itu sendiri, seperti penelitian yang dilakukan Nazcer dan Sultana (2014), studi ini mengeksplor berbagai faktor sumber stres yang dialami mahasiswa kedokteran sekaligus cara koping seperti apa yang banyak dilakukan oleh mereka. Hasil studi pada 400 mahasiswa kedokteran ini menunjukkan hasil bahwa sumber stres utama pada mereka adalah masalah akademik, dan selanjutnya koping yang diyakini sebagai cara dan usaha seseorang untuk mengurangi, mentoleransi, serta meminimalisir stres yang dirasakan, pada umumnya bentuk koping yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa adalah melakukan meditasi, berhubungan dengan teman dan menyalurkan hobi seperti mendengarkan musik, melakukan olah raga dan sebagainya.⁶¹

Studi serupa mengenai koping pada mahasiswa kedokteran dilakukan juga oleh Agustina (2009), studi ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh Lazarus dan Folkman (1985) yakni ada dua bentuk *ways of coping* yakni (1) *problem focused coping* (2) *emotion focused coping*,⁶² hasil studi menunjukkan bahwa secara umum

⁶⁰Nudrat Sohail, "Stress and Academic Performance Among Medical Students", *Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan*, Vol. 23, No. 1, (2013); 67-71.

⁶¹Mohd Nazeer, dan Razia Sultana, "Stress and It's Coping Strategies in Medical Students", *Scholar Journal of Applied medical Sciences (SJAMS)*, Vol. 2, No. 6D, (2014); 3111-3117.

⁶²*Problem focused coping* adalah usahaperilaku individu untuk mengatasi/mengurangi masalah, tekanan, dan tuntutan. Koping yang muncul adalah terfokus pada masalah individu yang akan mengatasi stres dengan mempelajari keterlampiran baru. Sementara *emotion focused coping* adalah bentuk koping yang untuk mengontrol respon emosional terhadap situasi yang menekan. Tujuan dari *emotion focused coping* adalah upaya untuk mencari dan memperoleh rasa nyaman serta memperkecil tekanan yang

derajat stres yang dialami responden (n=62) berada di tingkat sedang (66,1%) dan strategi yang lebih dominan dilakukan oleh mahasiswa koas pada program pendidikan profesi dokter gigi adalah *problem focused coping*.⁶³

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Christyanti et al (2010) yang lebih spesifik melihat bentuk coping berupa penyesuaian diri dan hubungannya dengan kecenderungan stres pada mahasiswa kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, penelitian ini mengikutsertakan mahasiswa kedokteran semester pertama dengan jumlah sampel 127 orang, hasil studi yang memakai analisis statistik korelasi *produk moment* ini membuktikan bahwa ada hubungan negatif antara penyesuaian diri terhadap tuntutan akademik dengan kecenderungan stres dengan hasil taraf signifikansi ($p < 0.5$). Namun demikian studi ini menyebutkan sumbangan efektif penyesuaian diri terhadap tuntutan akademik hanya 16,2%, sehingga hal ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 83,8% faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kecenderungan stres pada mahasiswa kedokteran.⁶⁴

Selanjutnya ada beberapa penelitian lainnya yang mencoba menghubungkan stres pada mahasiswa kedokteran ini dengan variabel-variabel lainnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rehman et al (2013) di Karachi yang menyoroti masalah kesadaran akan kesejahteraan (*aware of wellness*), penelitian ini sangat mendasar sekali dimana para peneliti tertarik untuk menyoroti kesadaran mahasiswa kedokteran terhadap pentingnya *welness*⁶⁵ untuk mengurangi stres,

dirasakan. Richard S. Lazarus dan Susan Folkman, *Stress, Appraisal and Coping*, (New York; Springer-Verlag, 1984), 34.

⁶³Rahayu Agustina, *Studi Mengenai Derajat Stress dan Coping Strategy* pada Koas Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran Angkatan 2009, diakses dari <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/Studi-Mengenai-Derajat-Stres>, tanggal 21 Januari 2016 pukul 14.28.

⁶⁴Dika Christyanti, Dewi Mustami'ah, dan Wiwik Sulistiani, "Hubungan antara Penyesuaian Diri terhadap Tuntutan Akademik dengan Kecenderungan Stress pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya", *Insani*, Vol. 12, No. 03, (2010); 153-159.

⁶⁵Istilah *wellness* seringkali digunakan untuk menjelaskan kesehatan yang seimbang antara pikiran (*mind*), tubuh (*body*) dan spirit (*spirit*) dimana secara keseluruhan merasakan sejahteraan memberi makna "keadaan yang sehat yakni keadaan yang senantiasa dapat mencari tujuan (*goal*)

selanjutnya kesadaran *wellness* dalam penelitian ini meliputi tiga aspek pengukuran yakni; (1) *physical wellness* (kesejahteraan fisik) yakni kesadaran akan “memberi kepada tubuh apa yang diperlukan untuk hidup sehat” yakni dengan makan teratur, olahraga, dan pilihan untuk gaya hidup yang lebih sehat. (2) *emotional wellness* (kesejahteraan emosi) yakni meliputi segala hal yang berhubungan dengan pikiran dengan cara eksplorasi kekuatan dari dalam diri untuk menekan stres, relaks, dan menumbuhkan pikiran positif dalam memandang hidup. (3) *spirituality wellness* (kesejahteraan spiritualitas) yakni meliputi pencarian akan makna dan tujuan dari eksistensi diri sebagai manusia. Pada akhirnya studi ini menjelaskan bahwa spiritualitas adalah kunci sukses dalam manajemen diri yang dilakukan oleh mayoritas mahasiswi kedokteran, adapun mahasiswa lebih cenderung mencari kesejahteraan diri dengan kegiatan-kegiatan fisik.⁶⁶

Dari berbagai kajian terdahulu yang relevan penulis tertarik untuk lebih jauh mengungkap fenomena stres yang terjadi di kalangan mahasiswa kedokteran sehingga dapat dikatakan ada kemiripan studi ini dengan studi terdahulu. Studi ini sama-sama menyoroti tingkat prevalensi stres pada mahasiswa kedokteran yang kemudian pada tulisan ini dikhususkan pada mahasiswa fakultas kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, Trisakti dan YARSI di Jakarta.

Disertasi ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian lain yakni menggali informasi mengenai sumber stres yang dihadapi mahasiswa kedokteran namun demikian untuk dua persamaan ini, penelitian dalam disertasi ini akan berbeda karena dalam studi terdahulu para peneliti hanya melakukan pengumpulan data melalui metode kuantitatif saja sementara penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*), yakni setelah menghasilkan data secara kuantitatif kemudian akan dilakukan pengecekan secara lebih akurat melalui cara kualitatif dengan cara wawancara mendalam.

oriented). Lih Peter La Cour dan Niels Christian Hvidt, “Research on Meaning-Making and Health in Secular Society, Secular, Spiritual and Religious Existential Orientations”, *Social Science & Medicine*, Vol. 71, No. 7, (2010); 1292-1299.

⁶⁶Rehana Rehman and others, “Health and Spirituality – Walk along- in Wellness Journey of Medical Students”, *J Pak Med Assoc*, Vol 63, No. 4, (2013); 495-500.

Selanjutnya studi ini berbeda dengan studi sebelumnya yakni dimana studi terdahulu hanya menghubungkan stres dengan sesuatu yang bersifat searah baik itu positif atau negatif saja. Misalkan hal positif yakni penyesuaian diri dan kecenderungan stres, spiritualitas dan stres, atau sebaliknya menyoroiti perihai pengaruh negatif saja seperti stresor dan stres. Adapun penelitian ini berbeda karena secara lebih seimbang disertasi ini menguji keadaan stres dengan melibatkan pengaruh positif dan negatif secara bersamaan. Stresor ditempati sebagai potensi negatif yang dapat menimbulkan stres dan spiritualitas dilihat secara positif sebagai sesuatu yang dapat mempertahankan diri dari kecenderungan stres.

Adapun pemilihan spiritualitas sebagai potensi positif dikarenakan asumsi dasar dari kejadian stres adalah disinyalir karena terlepasnya individu dari nilai spiritualitas yang seharusnya dimiliki. Studi ini secara khusus berbeda karena fokus menyoroiti spiritual sebagai potensi yang dapat membentengi mahasiswa dari keadaan yang tidak diinginkan ini. Dalam disertasi ini spiritual diposisikan secara positif. Maka posisi disertasi ini menyanggah pandangan Laurent et al (2013) yang mensinyalir spiritual dan agama justru menjadi resiko atas disfungsi psikologis seperti depresi. Agama dan spiritual tidak terbukti dapat menjadi *buffer* (penyanggah) untuk mengantisipasi penyakit disfungsi psikologis di masa depan.⁶⁷

Studi ini juga berbeda dikarenakan ketika studi lain hanya melihat hubungan spiritual dengan *health outcomes*, peneliti mencoba melihat fenomena tersebut dengan perspektif spiritualitas holistik yakni mendekati permasalahan dari berbagai cara yang mungkin dan tidak terbatas pada aspek spiritualitas itu saja. Diantara posibilitas tersebut adalah usaha untuk mengatur dan merubah respon diri terhadap stresor yang dialami yang dikenal dengan istilah *self regulated* (regulasi diri) dalam dunia akademik dikembangkan menjadi *self regulated learning* (regulasi diri dalam belajar) yakni dimana pelajar berusaha mengatur tindakan, motivasi dan kognisi diri yang paling cocok dalam proses belajar yang sedang dijalani.⁶⁸

⁶⁷Baptiste Laurent and others, "Spiritual and Religious Beliefs as Risk Factors for the Onset of Major Depression; an International Cohort Study", *Psychological Medicine*, Vol. 43, (2013); 2109-2120.

⁶⁸Mohamad Azrien Mohamed Adnan and others, "Self-Regulated Learning and Motivation of Islamic Studies and Non-Islamic Studies Stream

Selanjutnya regulasi diri akan ditempatkan sebagai variabel mediator dalam disertasi ini, sehingga hal ini menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu yang tidak menggunakan model mediator. Sehingga pada kesimpulannya studi ini akan berbeda dengan penelitian terdahulu karena menawarkan bentuk formulasi baru bahwa dengan kemampuan regulasi diri yang baik dalam belajar maka keberhasilan spiritualitas untuk menekan disfungsi psikologi (stres) akan semakin signifikan dan juga dengan mediasi regulasi diri yang baik keberadaan stresor dapat ditekan pengaruh negatifnya terhadap kecenderungan stres yang bisa dialami mahasiswa kedokteran di DKI Jakarta. Kemudian dengan metodologi yang lebih matang studi ini perlu dikaji untuk membuktikan keberhasilan model yang ditawarkan. Adapun metodologi tersebut akan diuraikan pada bagian selanjutnya dari proposal ini.

F. Metodologi Penelitian

Beberapa hal penting pada metodologi dalam penelitian ini diterangkan sebagaimana berikut ini:

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan sejumlah mahasiswa kedokteran di DKI Jakarta yang sedang menempuh studi ilmu kedokteran pada tiga kampus terpilih yakni; 1) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2) YARSI, dan 3) Universitas Trisakti. Pemilihan tiga kampus tersebut berdasarkan letak geografis dan administratif kampus yang berada di DKI Jakarta dan memiliki nilai akreditasi minimal B. Kemudian pemilihan kampus juga berdasarkan kriteria kampus bernuansa Islam dengan beberapa tambahan mata kuliah keislaman dan satu kampus umum pembandingan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis didapati melalui dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, kuesionair,

dan wawancara mendalam dengan berbagai informan. Adapun informan dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Segmen pertama adalah mahasiswa kedokteran di DKI Jakarta yang telah terlebih dahulu diikutsertakan dalam pengisian data kuesionair. Kemudian untuk mendapatkan sumber yang representatif sebagai informan peneliti menggunakan penentuan sampel secara purposif.
- 2) Segmen kedua adalah informan dari unsur pelaku manajemen yaitu dekan, dosen, dan pegawai administratif fakultas yang dapat memberi informasi tambahan.

Adapun sumber kedua dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan dari buku, jurnal, majalah, koran, data statistik dan publikasi lainnya dalam bentuk *hard print* ataupun *soft file* yang diakses dari berbagai media cetak dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi yang diteliti, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

a. Teknik Kuesioner

Kuesioner atau angket adalah tehnik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang.⁶⁹ Pengumpulan data melalui angket ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi tentang persepsi stres, stresor, spiritualitas dan regulasi diri belajar dari responden. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian adalah kuesioner tertutup dan terstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (*multiple choice questions*) yang sudah disediakan jawabannya.⁷⁰

Selanjutnya untuk mengukur variabel-variabel, penelitian ini menggunakan teknik skala yang didasari pada konsep teoritik berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun dalam model

⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 19

⁷⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 142

skala Likert lima poin⁷¹, sehingga partisipan dapat memberi respon jawaban dengan hanya tinggal mengisi atau menandai dengan mudah dan cepat. Ada empat skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; 1) Skala Medical Students Stressors Questionnaire (MSSQ), 2) Skala Spiritual Well-Being Questionnaire (SWBQ), 3) Skala Motivated Strategies for Learning Questionnaires (MSLQ), 4) Skala Perceived Stress Scale (PSS). Skala yang digunakan secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1) Skala Medical Students Stressors Questionnaire (MSSQ)

Skala ini disusun oleh Yusuf dan Abdul Rahim (2010) untuk mengidentifikasi sumber stres pada mahasiswa kedokteran. Enam indikator pada skala ini dikembangkan berdasarkan *review* atas beberapa penelitian yang berhubungan dengan stres yang kemudian dikembangkan sesuai dengan budaya dan nilai lokal.⁷²

Skala ini memiliki enam indikator dengan total 27 item soalan. Adapun deskripsi dimensi dan indikator instrumen ini dapat dilihat melalui *blueprint* pada tabel berikut:

Tabel 1.1. *Blueprint* Skala Stresor

No	Dimensi	Indikator stresor	Sebaran Nomor Item	Jumlah Item
1.	<i>Academic Related Stressors</i> (ARS)	- Ujian - Metode ujian dan penilaian - Jadwal	1, 5, 6, 8, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24	11 item

⁷¹Terdapat dua teknik pengukuran dengan kuesioner yang paling populer yakni a) Likert's Summated Rating (LSR); skala atau pengukuran sikap responden dimana jawaban pertanyaan dinyatakan dalam pilihan yang mengakomodasi jawaban antara Sangat Setuju Sekali sampai Sangat Tidak Setuju, dimana praktek yang banyak digunakan adalah 5, dan b) Semantic Differential (SD); responden menyatakan pilihan di antara dua kutub kata sifat atau frasa yang dibentuk dalam suatu garis nilai kontinyu. Lih. Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 65.

⁷²Muhammad Saiful Bahri Yusoff, dan Ahmad Fuad Abdul Rahim, *The Medical Students Stressors Questionnaire (MSSQ) Manual*, diakses dari <http://www.researchgate.net/publication/200640404> pada tanggal 09 November 2015 pukul 10.21 WIB.

		akademik - Aktifitas kemahasiswaan - Beban materi perkuliahan - Kesulitan Memahami isi pelajaran - Kurangnya waktu untuk revisi pelajaran - Banyaknya kompetisi - Kesulitan menyelesaikan tugas studi		
2.	<i>Intrapersonal and Interpersonal Related Stressors (IRS)</i>	- Rendah motivasi belajar - Abuse berbentuk Verbal, fisik, dan emosi dari orang lain - Konflik dengan guru, teman, dan staff kampus	2, 3, 17	3 item
3.	<i>Teaching and Learning Related Stressors (TLRS)</i>	- Kesesuaian tugas dari dosen - Kompetensi dosen untuk merevisi dan mengajar mahasiswa - kualitas <i>feedback</i> yang diberikan dosen - suport yang diberikan dosen	9, 13, 14, 25	4 item
4.	<i>Social Related Stressors (SRS)</i>	- waktu luang bersama	11, 19, 26	3 item

		keluarga dan teman - waktu untuk diri sendiri - interupsi bekerja dari orang lain		
5.	<i>Drive and Desire Related Stressors (DRS)</i>	- Tidak berkeinginan studi pada keilmuan ini (salah pilih tujuan, menjadi tidak termotivasi karena dihadapi pada realitas pengobatan, keinginan orang tua dan ikutan teman)	4, 21, 27	3 item
6.	<i>Group Activities Related Stressors (GARS)</i>	- partisipasi dalam kelompok diskusi - memenuhi harapan orang lain untuk melakukan yang terbaik	7, 10, 23	3 item
Jumlah total				27 item

Pada pengembangannya skala ini dibagikan pada sekitar 761 mahasiswa kedokteran yang mewakili berbagai etnik, agama dan budaya. Pada test validasi ini didapatkan bahwa MSSQ memiliki pengukuran psikometri yang baik serta hasil yang valid dan reabel untuk mengidentifikasi sumber stress. Hasil analisis reabilitas skala ini menunjukkan cronbach'alpha dengan internal konsistensi yang tinggi yakni 0.95. Adapun cronbach alfa pada setiap domain stresor ditunjukkan dengan angka secara berurut; (ARS): 0.921, (IRS): 0.895, (TLRS): 0.858, (SRS): 0.710, (DRS): 0.646, dan (GARS): 0.728.

Skala ini ditujukan untuk mengetahui sumber stres mana yang banyak memberi pengaruh pada tingkat stres, sehingga dapat meningkatkan cara kita untuk menanggulangi stres dengan manajemen stres yang lebih baik.

Skala ini memiliki 5 alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor sesuai dengan pernyataan, skala rating dimulai dengan 1-5 dengan rincian selengkapnya pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Alternatif Jawaban dan Skor *item* skala penelitian stresor

Skor <i>item</i>	Alternatif Jawaban
1	Menyebabkan Stres Sangat Ringan
2	Menyebabkan Stres Ringan
3	Menyebabkan Stres Sedang
4	Menyebabkan Stres Berat
5	Menyebabkan Stres Sangat Berat

2) Skala Spiritual Well-Being Questionnaire (SWBQ)

Skala yang digunakan untuk mengukur tingkat spiritualitas pada mahasiswa kedokteran adalah diadopsi dari alat ukur yang disusun oleh Gomez dan Fisher (2003). Skala ini dikonstruksi dengan 20 item soal yang dikembangkan validitas dan reliabilitasnya melalui empat kali studi. Studi pertama diberikan kepada 248 siswa menengah atas di Australia dengan range usia 11 sd 16 tahun. Studi kedua dilakukan terhadap 537 siswa menengah atas di Australia. Studi ini dilakukan dengan analisis faktor terhadap empat dimensi kuesioner (personal, interpersonal, environmental dan transedental dengan hasil yang signifikan pada hubungan antara keempat faktor ($p < 0,01$).

Sementara pada uji studi ke-3 yang melibatkan 832 mahasiswa dari enam universitas di Australia menunjukkan hasil CFA (*Confirmatory Factor Analysis*) pada keempat faktor memiliki model yang bagus dengan cronbach's alfa 0,82; 0,95; 0,83; 0,82. Adapun pada studi terakhir diberikan kepada 456 mahasiswa dari universitas di Australia, Inggris, dan Irlandia dengan range usia 18-

24. Hasil studi terakhir menguatkan validitas dan reabilitas dari SWBQ dengan nilai signifikan ($p < 0,01$).⁷³

Kuesionair ini terdiri dari empat dimensi dengan jumlah 20 item yakni; 1) *Personal domain*, 2) *Communal domain*, 3) *Environmental*, dan 4) *Transcendental*. Deskripsi keempat domain dijelaskan dengan indikator sebagaimana pada *blueprint* pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3. *Blueprint* Skala Spiritualitas

No	Domain	Indikator	Sebaran Nomor Item		Jumlah Item
			<i>Favourable</i>	<i>Unfavorable</i>	
1.	Personal	-meaning -purpose -values in life	5, 14, 18	9, 16	5 item
2.	Communal	-morality -culture -love -forgiveness -trust and hope in humanity	1, 17	3, 8, 19	5 item
3.	Environmental	-care for nature -sense of awe and wonder -unity with environment	4, 7, 20	10, 12	5 item
4.	Transcendental	-faith -adoration and worship -connectedness with devine/God	2, 11, 13, 15	6	5 item
Jumlah Total			12 item	8 item	20 item

Skala ini memiliki 5 alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor sesuai dengan pernyataan, skala rating dimulai dengan 1-5 dengan rincian selengkapnya pada tabel berikut ini:

⁷³Trevor Moodley, *The Relationship between Coping and Spiritual Well-Being during Adolescence*, Disertasi University of The free State, (Bloemfontein, 2008), 7-10.

Tabel 1.4. Alternatif Jawaban dan Skor *item* skala penelitian spiritualitas

Skor <i>item</i>	Alternatif Jawaban
1	Sangat Tidak Sesuai
2	Tidak Sesuai
3	Agak Sesuai
4	Sesuai
5	Sangat Sesuai

3) Skala Motivated Strategies for Learning Questionnaires (MSLQ)

Skala ini disusun oleh Pintrich et al (1991) yang sudah banyak sekali digunakan untuk mengukur kemampuan regulasi diri dalam belajar. Skala ini terdiri dari empat indikator utama yang diklasifikasikan sebagai berikut; *motivation* (6 item), *emotion* (6 item), *cognition* (9 item) dan *behavior* (8 item). Adapun dimensi dan indikator serta butir pernyataan skala regulasi diri belajar dapat dilihat dalam *blueprint* pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5. *Blueprint* Skala Regulasi Diri Belajar

No	Dimensi	Indikator	Sebaran Nomor Item		Jumlah Item
			<i>Favourable</i>	<i>Unfavourable</i>	
1.	Motivation (MV)	-Intrinsic goal orientation -Extrinsic goal orientation -Control of learning belief	3, 11 1, 13 2	20	6 item
2.	Emotion (EM)	- Self efficacy - Test anxiety - Task Value	4, 21 5 17	18 12	6 item
2.	Cognition (CG)	-Rehearsal -Elaboration -Organization -Critical Thinking Metacognitive Self Regulation	19, 26 6 27, 10 22, 15 25	7	9 item
3.	Behavior (BV)	-Time and environmental -Effort regulation -Peer learning -Help seeking	24 8 9, 29 16	28 23 14	8 item
Jumlah Total			22 item	7 item	29 item

Selanjutnya tabel berikut ini menjelaskan bahwa setiap item dari skala ini memiliki nilai skor dengan range 1 sampai dengan 5:

Tabel 1.6. Alternatif Jawaban dan Skor *item*
Skala Regulasi Diri Belajar

Skor <i>item</i>	Alternatif Jawaban
1	Sangat tidak setuju
2	Tidak setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat setuju

4) Skala The Perceived Stress Scale (PSS)

Skala ini disusun oleh Cohen (1994) yang banyak digunakan sebagai instrumen psikologi untuk mengukur persepsi dari stres yang dirasakan. Skala ini mengukur tingkat tekanan yang dialami seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Item-itemnya sangat mudah dipahami dan responden secara cepat dapat menangkap isi soal yang diajukan. Skala ini dimodifikasi menjadi 3 indikator yang diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1.7. *Blueprint* Skala Stres

No	Domain	Indikator	Sebaran Nomor Item		Jumlah Item
			<i>Favorable</i>	<i>Unfavorable</i>	
1.	<i>Unpredicted</i> (UP)	-Kecewa -Tidak percaya diri	1, 6, 8 10	4	5 item
2.	<i>Uncontrolled</i> (UC)	-tidak bisa mengontrol diri -merasa jengkel	2 7	5	3 item
3.	<i>Nervous</i> (NV)	-Gugup -marah-marah	3 9		2 item
Total			8 item	2 item	10 item

Soalan dalam PSS bertanya mengenai perasaan dan pikiran yang dirasakan dalam satu bulan terakhir, selain itu responden juga ditanya mengenai seberapa sering merasakan hal tersebut. Skala ini

memiliki 10 item pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban, skala rating dimulai dengan 1-5 dengan rincian selengkapnya pada tabel berikut ini:

Tabel 1.8. Alternatif Jawaban dan Skor *item* skala stres

Skor <i>item</i>	Alternatif Jawaban
1	Sangat Tidak Sesuai
2	Tidak Sesuai
3	Agak Sesuai
4	Sesuai
5	Sangat sesuai

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari tangan pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya dan menguji data lainnya.⁷⁴ Wawancara dilakukan terhadap dekan fakultas kedokteran, dosen, staf administrasi kemahasiswaan untuk memperoleh informasi tentang kebijakan kampus, pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, serta proses belajar-mengajar lainnya. Wawancara mendalam juga dilakukan terhadap sembilan orang mahasiswa yang dipilih secara *purposif* melalui analisis angket yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperoleh informasi mendalam terkait persepsi sumber stres, indikasi stres, implementasi spiritualitas dan aplikasi regulasi diri belajar yang mereka lakukan.

Dalam pelaksanaan teknik wawancara penulis menggunakan pedoman (a) wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya membuat garis besar daftar pertanyaan yang akan diajukan dan (b) Pedoman wawancara semi struktur, yaitu diawali dengan pertanyaan yang tidak terstruktur kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan lebih mendalam guna mendapatkan informasi lebih mendalam.

⁷⁴Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 55

c. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan pemusatan perhatian peneliti terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indera⁷⁵. Observasi dilakukan peneliti secara langsung dengan jenis observasi terkendali yakni melakukan pengamatan terhadap sasaran penelitian yang ditempatkan dalam lingkungan terbatas yang dapat diamati oleh peneliti dan peneliti bukanlah bagian dari aktivitas *observee*. Teknik observasi ini bertujuan untuk memperoleh data tentang interaksi sosial yang terjadi antara warga kampus, proses belajar dan mengajar, serta aktifitas keseharian mahasiswa di masing-masing kampus.

d. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk menggali data dalam bentuk-bentuk dokumen penting yang berkaitan dengan aspek penelitian seperti modul-modul pembelajaran yang diberikan pada proses belajar-mengajar, matrik kegiatan, dan silabus pendidikan. Peneliti juga menggunakan beberapa dokumen-dokumen tertulis lainnya seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulensi rapat, catatan harian dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau dengan aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian.⁷⁶ Metode analisis data pada penelitian ini terbagi pada dua kategori yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Adapun data kuantitatif dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dalam rangka penarikan kesimpulan. Pada analisis kuantitatif peneliti menggunakan analisis statistik *Multivariate Structural Equation Modelling* (SEM) dengan software LISREL *full version* sebagaimana diterangkan sebagai berikut:

a. Uji Validitas dan Realibilitas

Validitas karakteristik utama yang harus dimiliki oleh setiap skala. Validitas, dalam pengertiannya yang paling umum, adalah

⁷⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta; Rhineka Cipta, 2010), 199.

⁷⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 239.

ketepatan dan kecermatan skala dalam menjalankan fungsi ukurnya. Artinya sejauhmana skala itu mampu mengukur atribut yang dirancang untuk mengukurnya.⁷⁷ Sementara Reliabilitas sebenarnya mengacu kepada konsistensi atau keterpercayaan hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan pengukuran. Pengukuran yang tidak reliabel akan menghasilkan skor yang tidak dapat dipercaya. Pengukuran yang tidak reliabel tentu tidak akan konsisten pula dari waktu ke waktu.

Uji validitas dan reabilitas kuesioner pada penelitian ini diperlukan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan peneliti mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data variable yang diteliti secara tepat. Untuk itu peneliti menggunakan *software* program Lisrel 8.7 (Joreskog & Sorbom, 1999) untuk menganalisis validitas item-item variabel dengan tehnik *confirmatory factor analysis* (CFA) yang pada tahap pertama ini variabel-variabel yang teramati merupakan *first order*, dimana setiap dimensi diuji sendiri-sendiri per item, selanjutnya item pada indikator dianggap valid ketika *standard loading factor* (SLF) yang didapati ≥ 0.40 , tidak memiliki koefisien negatif⁷⁸ dan nilai t-hitung setiap item lebih besar dari t-kritis ($t > 1.96$).

Pada alat ukur stressor (X1) dijumpai bahwa dari total 27 item yang diuji tingkat validitasnya terdapat empat item yang dinyatakan tidak valid (gugur): pada indikator IRS yakni item no 3, pada indikator SRS yakni item no 1 dan 29 serta pada indikator DRS yakni item no 4. Adapun 23 item lainnya dinyatakan valid.⁷⁹ Adapun untuk mendapatkan nilai CR (*construct reliability*) peneliti menggunakan aplikasi online yakni *Composite Reliability Calculator*⁸⁰, dimana

⁷⁷Syaifuddin Azwar, MA., *Penyusunan Skala Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 7.

⁷⁸Umar (2012) lebih lanjut menjelaskan bahwa nilai koefisien muatan faktor pada item harus bermuatan positif, item yang bermuatan negatif maka skornya harus terlebih dahulu dibalik (*reversed*) sebelum analisis faktor dan perhitungan skor sehingga koefisien muatan faktor tetap positif. Jahja Umar, "Peran Pengukuran dan Analisis Statistika dalam Penelitian Psikologi", *Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia*, Vol. 1, No. 1, (2012); 47-55.

⁷⁹Lihat lampiran "Uji Validitas - Stresor".

⁸⁰The Statistical Mind at <http://www.thestatisticalmind.com/composite-reliability/>

pada alat ukur stresor didapati nilai CR yang cukup besar 0.92. Sebagaimana Hair (2016) menyatakan nilai CR ≥ 0.70 dikategorikan *good reliability*, sedangkan CR diantara 0.6 dan 0.7 termasuk *acceptable reliability*.⁸¹ Sehingga demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur stresor adalah valid dengan nilai reliabel yang cukup handal.

Selanjutnya hasil analisis pada alat ukur spiritualitas (X2) menunjukkan dari 20 item terdapat delapan item yang dinyatakan tidak valid (gugur): pada indikator *personal* (PS) yakni item no 5, 16, dan 18. Pada indikator *communal* (CM) yakni item no 1, 8 dan 19. Pada indikator *environmental* (EV) yakni item no 4 dan 10. Adapun indikator *transcendental* (TC) dinyatakan semua valid dengan demikian terdapat 14 item valid.⁸² Sementara berdasarkan hasil uji reliabilitas, skala spiritualitas yang digunakan juga memiliki reliabilitas cukup baik yakni dengan hasil *construct reliability* 0.81.

Selain dua variable yang telah dianalisis validitas dan reliabilitasnya di atas, variable yang memiliki item gugur adalah variabel regulasi diri belajar (M) dan variabel stress (Y). Pada variabel regulasi diri dari sejumlah 29 item terdapat 14 item yang gugur karena tidak memenuhi syarat validitas item: pada indikator *motivation* (MV) yakni item no 5, 11, 12, 18, 20. Pada indikator *cognition* (CG) yakni item no 7 dan 19. Sementara pada indikator *behavior* (BV) dari delapan item dinyatakan tujuh item gugur yakni item no 9, 14, 16, 23, 24, 28 dan 29.⁸³ Sementara nilai CR yang didapat adalah 0.86, sehingga demikian instrumen regulasi diri belajar dapat dikatakan cukup handal.

Adapun variabel terakhir yang diuji validitas itemnya adalah variabel eksogen (Y) yakni stres. Hasil analisis menunjukkan dari 10 item yang diamati terdapat tiga item gugur, pada indikator *upset* (UP) yakni item no 4 dan 8. Pada indikator *uncontrolled* (UC) yakni item no 5. Adapun tujuh item lainnya dinyatakan valid.⁸⁴ Sementara hasil CR variabel stres adalah 0.84, sehingga dengan demikian variabel “Y” memiliki reliabilitas cukup handal. Untuk memperjelas

⁸¹Joseph F. Hair and others, *Multivariate Data Analysis 7th Edition*, (New York: Pearson Prentice Hall, 2010), 679.

⁸²Lihat lampiran “Uji Validitas - Spiritualitas”.

⁸³Lihat lampiran “Uji Validitas - Regulasi Diri Belajar”.

⁸⁴Lihat lampiran “Uji Validitas - Stres”.

hasil tes validitas semua variabel teramati di atas dapat dilihat pada tabel 1.9. berikut:

Tabel 1.9. *Construct Reliability Variabel-Variabel Manifest*⁸⁵

Variabel Manifest	<i>Construct Reliability</i>	Keterangan
Stresor	0.92	Reliabilitas sangat baik
Spiritualitas	0.81	Reliabilitas sangat baik
Regulasi Diri Belajar	0.86	Reliabilitas sangat baik
Stres	0.84	Reliabilitas sangat baik

b. Uji Asumsi

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode statistik *Multivariate Structural Equation Modelling* (SEM). Ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengujian model dengan pendekatan SEM, yaitu sebagai berikut:

1. Uji Kecukupan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 1.670 mahasiswa yang tersebar pada tiga kampus partisipan.⁸⁶ Kemudian untuk pemilihan sampel, penulis menggunakan rancangan sample non probabilitas atau yang dikenal juga dengan istilah non random. Dalam hubungannya dengan teknik non random, penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental, pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yakni siapa saja yang mewakili populasinya, secara resmiizinkan oleh pihak kampus untuk diikutsertakan dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga menggunakan jenis teknik non

⁸⁵Lihat lampiran “*Construct Reliability Variabel-Variabel Manifest*”.

⁸⁶Data detail populasi berdasarkan kampus adalah UIN Syarif Hidayatullah berjumlah 279 orang, Trisakti berjumlah 576 orang dan YARSI berjumlah 815. Lih Lampiran Data Analisi- Deskripsi Subjek Penelitian Populasi dan Sampel.

random atas dasar strata (*stratified random sampling*),⁸⁷ karena sampel dan responden terbagi dalam enam semester yang berbeda maka mahasiswa yang diikutsertakan dalam studi ini akan terbagi setidaknya dalam tiga sel/strata yakni kluster mahasiswa tahun pertama, kedua dan ketiga dengan dua jenis kelamin berbeda yakni laki-laki dan perempuan.

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 378 mahasiswa. Jumlah sampel tersebut merupakan responden yang memenuhi syarat dalam menjawab kuesioner yang diberikan. Jumlah tersebut dinilai mencukupi karena berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael, populasi berjumlah >1.500 orang dengan tingkat kesalahan 5% adalah 340 orang. Jumlah sampel pada penelitian ini juga dinilai mencukupi, karena jumlah sampel minimal bagi penelitian yang menggunakan alat statistik SEM dengan prosedur *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) yaitu sebesar 5-10 observasi untuk setiap estimasi parameter⁸⁸ atau 100-200 responden. Jumlah parameter yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 15. Jadi sampel minimal yang digunakan sesuai dengan parameter yang ada pada penelitian ini adalah 150 (10X15). Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa 378 responden dinyatakan valid keikutsertaannya dalam riset ini. Dengan demikian uji sampel pada penelitian adalah cukup.

2. Uji Normalitas

Pengujian selanjutnya adalah melihat tingkat normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis SEM mewajibkan data berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data.⁸⁹

⁸⁷Dalam teknik random atas dasar strata populasi distratakan terlebih dahulu, strata disesuaikan dengan sifat-sifat atau ciri-ciri suatu populasi. Strata tersebut bisa dalam arti horisontal maupun vertikal. Dalam penelitian ini stratifikasi diperlukan karena melihat responden memiliki perbedaan semester yang sedang dijalani. Lih. Syamsir Alam dan Jaenal Aripin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), 49.

⁸⁸Ferdinand, *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*, Edisi 2, (Semarang: Fakultas Ekonomi UNDIP, 2002), 131.

⁸⁹Zainal Mustafa dan Tony Wijaya, *Panduan Teknik Statistik SEM dan PLS dengan SPSS AMOS: Konsep Dasar SEM dan PLS, Pengenalan AMOS dan Smart PLS, Contoh dan Penerapan SPSS AMOS dan Smart PLS*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), 36.

Asumsi normalitas dapat diuji dengan nilai statistik z untuk *skewness* dan *kurtosis*. Apabila nilai *zkurtosis* baik dan/atau *zskewness* signifikan (kurang dari pada 0.05 pada tingkat 5%) maka dapat dikatakan bahwa distribusi data tidak normal. Sebaliknya jika nilai z, baik *zkurtosis* dan/atau *zskewness* tidak signifikan (lebih besar dari 0.05 pada tingkat 5%) maka dapat dikatakan bahwa distribusi data normal. Sehingga disimpulkan uji normalitas diharapkan hasilnya tidak signifikan.⁹⁰

Berdasarkan hasil output menunjukkan bahwa beberapa indikator didapati nilai yang tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, data tersebut harus dinormalisasikan terlebih dahulu. Normalisasi data dilakukan dengan menggunakan menu: *statistic-normal score* yang tersedia di piranti lunak LISREL 8.8 *full version*⁹¹. Normalisasi data dalam Lisrel 8.8 *full version* menggunakan metode estimasi *unweighted least squares* (ULS).⁹² Adapun hasil pengujian setelah dilakukan normalisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10. Hasil Uji Univariat Normalitas⁹³

Variabel Laten	Variabel Teramati	Skewnes		Kurtosis		Skewness and Kurtosis	
		Z- Score	P- Value	Z- Score	P- Value	Chi-Square	P- Values
Stres	UP	0.115	0.909	-0.092	0.927	0.022	0.989
	UC	0.318	0.750	-0.595	0.552	0.455	0.797
	NV	0.218	0.828	-0.421	0.674	0.225	0.894
Stresor	ARS	-0.020	0.984	0.048	0.962	0.003	0.999
	IRS	-0.043	0.965	-0.368	0.713	0.137	0.934
	TLRS	0.030	0.976	-0.048	0.962	0.003	0.998
	SRS	0.274	0.784	-0.590	0.555	0.423	0.809
	DRS	0.356	0.722	-1.327	0.184	1.888	0.389
	GARS	0.045	0.964	-0.002	0.998	0.002	0.999
Spiritualitas	PS	-0.102	0.919	-0.086	0.931	0.018	0.991
	CM	-0.524	0.601	-0.388	0.698	0.425	0.809

⁹⁰Imam Ghazali, *Model Persamaan Struktural: Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 19.0*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 37.

⁹¹Setyo Hari Wijanto, *Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.8: Konsep dan Tutorial*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2008), 22.

⁹²Karl G. Joreskog, *Factor Analysis by MINRES*, diakses dari www.ssicentral.com/lisrel/techdocs pada tanggal 24/05.2017.

⁹³Lihat lampiran, "Hasil Uji Univariat Normalitas".

Regulasi Diri Belajar	EV	-0.250	0.803	-0.441	0.659	0.257	0.879
	TC	-0.441	0.659	-0.744	0.457	0.748	0.688
	MV	-0.662	0.508	-1.211	0.226	1.905	0.386
	CG	-0.042	0.966	-0.036	0.971	0.003	0.998
	BV	0.009	0.993	-0.028	0.978	0.001	1.000

Keterangan:

UP : *Unpredicted*

UC : *Uncontrolled*

NV : *Nervous*

ARS : *Academis Related Stressors*

IRS : *Intrapersonal and Interpersonal Related Stressors*

TLRS : *Teaching and Learning Related Stressors*

SRS : *Social Related Stressors*

DRS : *Desire Related Stressors*

GARS : *Group Activities Related Stressors*

PS : *Personal*

CM : *Communal*

EV : *Environmental*

TC : *Transcendental*

MV : *Motivation*

CG : *Cognition*

BV : *Behavior*

Tabel 3.18 di atas menunjukkan bahwa *p-value* untuk masing-masing variabel teramati mempunyai nilai lebih dari 0.05, hal ini berarti data penelitian ini telah berdistribusi secara normal.

c. Hipotesis

Uji hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan piranti lunak LISREL 8.8 *full version*. Selanjutnya peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat melalui analisis kuantitatif dan kualitatif secara deskriptif guna mendapatkan penjelasan yang telah dikorelasikan dengan teori-teori yang dibutuhkan dan mengacu pada prosedur-prosedur yang telah ditentukan.

Selanjutnya peneliti juga akan melakukan analisis data secara kualitatif. Data kualitatif ini akan dianalisis dalam tiga tahap yakni; 1) reduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan pola

serta membuang bagian yang tidak perlu.⁹⁴ Pada tahap ini penulis melakukan aktifitas abstraksi⁹⁵. Reduksi data ini dilakukan untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. 2) Penyajian data (*display* data) yakni sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.⁹⁶ Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan dan subpokok permasalahan. 3) Kesimpulan atau verifikasi, yakni tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini peneliti akan melakukan perbandingan dan penyesuaian dari pernyataan subjek penelitian dengan makna yang terkandung sesuai dengan konsep-konsep dasar atau teori yang telah dikemukakan dalam penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis untuk menjelaskan keadaan jiwa dengan gejala atau sikap keagamaan seseorang.⁹⁷ Secara khusus studi ini terfokus pada kajian pengaruh spiritualitas terhadap stres akademik pada mahasiswa kedokteran. Melalui teori-teori psikologi penulis dengan mudah mengetahui tingkat spiritualitas yang dihayati, dipahami dan diamalkan responden.

Sementara dilihat dari desain penelitiannya, riset ini menggunakan dua bentuk pendekatan penelitian atau yang disebut dengan

⁹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 338.

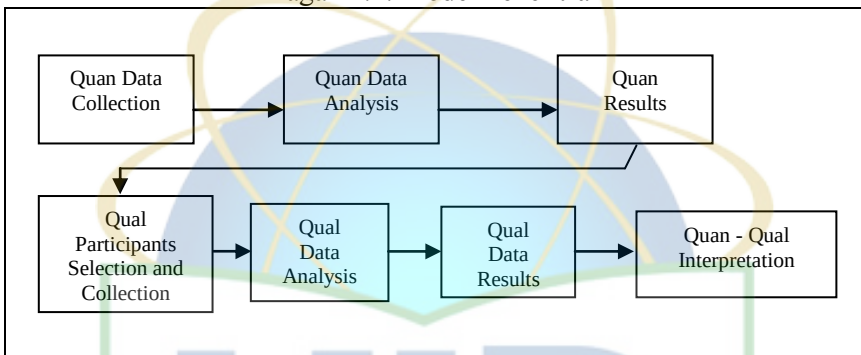
⁹⁵Abtraksi adalah usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

⁹⁶Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 151.

⁹⁷Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang menggunakan cara pandang ilmu psikologi, karena ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia, maka pendekatan psikologis hanya mengkaji tentang jiwa manusia. Ketika studi Islam didekati dengan pendekatan psikologis, maka yang menjadi objek dalam kajian tersebut adalah jiwa manusia yang dilihat dalam hubungannya dengan agama. Studi Islam yang didekati dengan pendekatan psikologis, selalu menggunakan teori-teori psikologi dan hubungannya dengan agama Islam. Lih. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 51

istilah penelitian metode campuran (*mixed methods*) yakni kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Desain penelitian yang digunakan adalah eksplanatori sekuensial (*sequential explanatory design*), yakni penelitian kuantitatif sebagai pendekatan utama dan kualitatif sebagai fasilitator.⁹⁸ Tujuan utama penulis menggunakan desain ini adalah data kuantitatif membantu memperjelas dan membentuk hasil kualitatif yang inisial. Melalui desain ini peneliti juga ingin membentuk kelompok yang didasarkan pada hasil kuantitatif dan akan menindaklanjuti kelompok tersebut melalui penelitian kualitatif.

Bagan 1.1. Model Penelitian



6. Identifikasi Variable Penelitian

Berdasarkan identifikasi variable penelitian, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki beberapa variable yang diterangkan sebagaimana berikut:

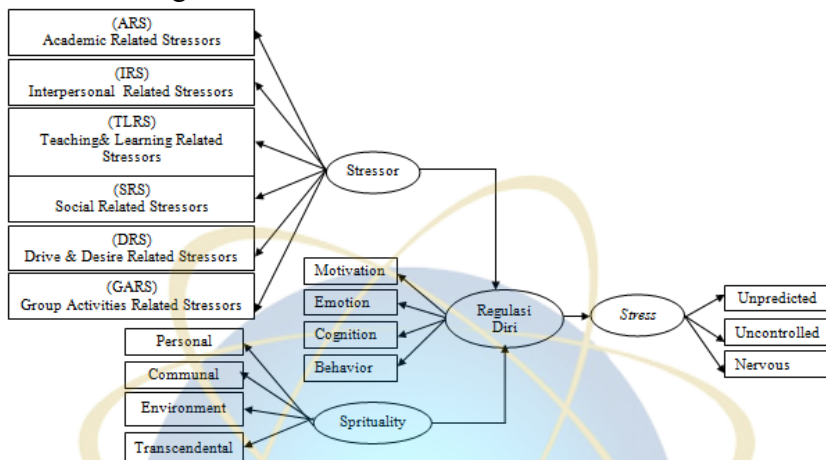
- Variabel *independent* (X1) : Stresor
- Variabel *independent* (X2) : Spiritualitas
- Variabel *dependent* (Y) : Stres
- Variable *mediator*⁹⁹ (M) : Regulasi Diri

⁹⁸Creswell et al 2003 dalam Nataliya V. Ivankova, Jhon Creswell dan Sheldon I. Stick, *Using Mixed-Mehods Sequential Explanatory Design from Theory to Practice*, <http://www.sagepub.com/foundations/includes/Appendix%20A.Ivankova,%20et%20al.2006.pdf>, diakses pada tanggal 28 Mei 2014 pukul 13. 52 WIB.

⁹⁹ Variable mediator menurut Preacher dkk (2007) berperan untuk menghantarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Lih; Kristopher J. Preacher, Derek, D. Rucker dan Andrew F. Hayes, "Addressing

Secara lebih sederhana hubungan antara variabel di atas diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

Bagan 1.2. Dimensi – dimensi Variabel Penelitian



G. Sistematika Pembahasan

Penulisan Disertasi ini secara terperinci akan diterangkan dalam lima bab yakni:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, Permasalahan yang meliputi: identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan hipotesis. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang signifikan, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai manajemen spiritual holistik pada stres yakni merupakan perdebatan akademik, bagaimana spiritual yang sebagian oleh para ahli diyakini sebagai bentuk abnormalitas justru sebaliknya pada sebagian ahli lainnya, spiritualitas dipandang sebagai potensi positif yang dapat mempertahankan diri dari stres. Sehingga pada bab ini peneliti mengawali pembahasan dengan terlebih dahulu membahas tentang konseptualisasi stres sebagai bentuk disfungsi psikologis. Dilanjutkan dengan deskripsi kesehatan mental dalam perspektif Islam, perbedaan stres positif

(eustress) dan stres negatif (*distress*), deskripsi teori mengenai stres sebagai *diseaseadaptation* dan *adjustment disorder*, faktor penyebab stres/ stresor, dan indikasi stres: fisio, psiko, dan behavior. Kemudian bab ini menjelaskan perdebatan reposisi spiritualitas dari bentuk abnormalitas menjadi *counter balancing effect* terhadap stres. Diawali dengan deskripsi konstruk spiritualitas melalui konsep Barat dan Islam dan pada akhirnya bab ini ditutup dengan landasan teori bahwa spiritualitas dan regulasi diri dapat menjadi protektor diri dari stres.

Pada bab ketiga, pembahasan sudah memasuki tema terkait pengaruh spiritualitas dan regulasi diri terhadap stres. Bab ini mendeskripsikan subjek penelitian, analisis tematik terkait kondisi mahasiswa kedokteran sebagai subjek pada penelitian ini. Keterhubungan dengan Tuhan dalam dominansi spiritualitas yang terdiri dari; stres dan kehilangan kontrol diri, tuntutan akademik sebagai stresor dominan, dominansi teo-spiritualitas mahasiswa kedokteran dan dominansi regulasi diri belajar melalui pengulangan (*rehearsal*).

Bab keempat merupakan paparan hasil penelitian kualitatif dengan judul besar spiritualitas dan regulasi diri potensi positif mekanisme koping stres. Secara terperinci penulis akan menjelaskan mekanisme respon stres pada mahasiswa kedokteran, efektifitas spiritualitas dalam pertahanan diri dari stres akademik melalui keterhubungan dengan Tuhan dan harmonisasi dengan alam dan manusia. Selanjutnya pembahasan pada bab ini diakhiri dengan penjelasan fungsi spiritualitas dan regulasi diri sebagai koping proaktif, dimana spiritualitas berperan sebagai koping emosi dan regulasi diri secara bersamaan menjadi koping perilaku.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari disertasi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kemudian penelitian ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran analisis data berikut pula beberapa surat keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian ini.



BAB II

SPIRITUALITAS DAN REGULASI DIRI BELAJAR: MENGUBAH *DISTRESS* MENJADI *EUSTRESS*

Pada bab kedua ini, peneliti memaparkan kajian teoritis mengenai stres sebagai satu bentuk disfungsi psikofisiologis manusia. Secara sistematis teori mengenai stres ini diawali dengan paparan kesehatan mental yang kemudian dilanjutkan dengan kajian stres sebagai *disease adaptation* dan *adjustment disorder*, faktor penyebab stres/stresor, dan indikasi stres: fisio, psiko, dan behavior. Kemudian secara lebih mendalam bab ini akan menjelaskan perbincangan dan perdebatan akademik mengenai peran spiritualitas dan regulasi diri sebagai bentuk *self counter* terhadap stres akibat dari stresor yang dijumpai.

Perbincangan mengenai spiritualitas adalah penting dikarenakan hal ini masih menjadi perdebatan para ahli mengenai spiritualitas dan korelasinya dengan kesehatan dan kesejahteraan diri. Sebagian ahli berpandangan bahwa spiritualitas berpotensi terhadap permasalahan disfungsi psikologis. Namun sebagian lagi membuktikan bahwa spiritualitas memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan psikologis dari berbagai populasi berbeda, latar belakang etnik dan bagi mereka penyandang penyakit ringan atau bahkan kronis sekalipun.

Perdebatan spiritualitas ini akan semakin menarik ketika perbincangan hal ini dikaitkan dengan kemampuan regulasi diri, dimana sebagian ahli meyakini bahwa spiritualitas adalah sebuah bentuk irasionalitas berpikir, sementara seorang individu untuk mampu meregulasikan diri, ia harus mampu melakukan tindakan regulasi tersebut secara sadar (*conscious*) dan penuh usaha (*effortful process*), sehingga dengan demikian pandangan mengenai spiritualitas sebagai bentuk kekacauan berpikir akan semakin dibenturkan dengan pandangan ahli yang menyebutkan bahwa kesadaran diri inilah yang men-

jadi kumpulan inti dari spiritualitas yang senantiasa tidak memberi persetujuan atas pikiran negatif dan berusaha mentransformasikan diri untuk melakukan hal yang positif.

Selanjutnya di akhir bab ini, peneliti akan mendeskripsikan teori analitik bagaimana spiritualitas dan regulasi diri secara bersamaan dan konsisten menjadi sinergi strategi koping yang efektif dalam mengolah pengaruh stresor yang dihadapi menjadi sebuah bentuk stres yang positif yakni *eustress* dan bukan *distress*.

A. Konseptualisasi Stres sebagai Bentuk Disfungsi Psikofisiologis

1. Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam

Pada awalnya kesehatan mental hanya dipahami sebagai ketiadaan penyakit atau gangguan psikologis pada individu dan stigma yang paling umum terjadi gangguan psikologis (jiwa) ini di kalangan masyarakat diidentikkan dengan “orang gila”. Namun sekarang kajian terkait kesehatan mental merupakan bagian dari psikologi positif¹ dengan pendekatan yang lebih holistik. Sebagaimana WHO (2005) memperluas fokus kesehatan mental pada keadaan yang lebih positif yakni keadaan sejahtera (*wellbeing*) dimana individu menyadari kemampuannya sendiri, mampu mengatasi tekanan yang normal dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif, dan mampu berkontribusi terhadap masyarakat.² Dengan demikian kesehatan mental akan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia.

Selanjutnya pendekatan kesehatan mental secara holistik meliputi emosi (afeksi/perasaan), kognisi (persepsi, pikiran dan penalaran), fungsi sosial (hubungan dengan orang lain dan masyarakat) dan

¹Psikologi positif adalah perspektif ilmiah tentang bagaimana membuat hidup lebih berharga. Martin E.P. Seligman berpendapat bahwa psikologi bukan hanya studi tentang penyakit, kelemahan dan kerusakan tetapi psikologi juga merupakan studi tentang kebahagiaan, kekuatan dan kebajikan. Bidang psikologi positif terdiri dari pengalaman subjektif yang positif, kesejahteraan dan pandangan kognitif yang konstruktif terhadap masa depan seperti optimisme, harapan dan keyakinan. Lih Martin E.P Seligman, Tracy A. Steen, Nansook Park dan Christopher Peterson, “Positive Psychology Progress Empirical Validation of Interventions “, *Positive Psychology Progress*, Vol. 42, (2005); 874-884.

²World Health Organization (WHO), *Promoting Mental Health*, (2005), 6.

koherensi (perasaan kebermaknaan dan tujuan hidup). Individu dapat dinyatakan sehat ketika semua komponen-komponen ini dapat beroperasi dengan maksimal. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Young (2001) bahwa kesehatan mental merupakan berfungsinya seluruh komponen mental ketika dihadapi tuntutan dan tantangan kehidupan.³ Begitupula dalam pandangan Islam kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik (*biological*), emosional (*affective*), dan agama (*spirituality*) yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu selaras dengan keadaan orang lain.⁴

Terkait hal ini Ryff dan Keyes (1995)⁵ menyebutkan beberapa istilah lain yang semakna dengan kesehatan mental dan fungsi positif psikologis ini termasuk pula kriteria yang dibuat tidak sama secara tekstual namun memiliki maksud yang sama seperti Rogers yang menggunakan istilah *fully functioning* (pribadi berfungsi sepenuhnya), Maslow menyebutnya *self actualization* (aktualisasi diri), serta Golden Allport menyatakannya dengan konsep *maturity personality* (kepribadian matang).⁶

Selanjutnya dalam literatur psikologi Islam El-Qusy (1997) menjelaskan kesehatan mental adalah keserasian yang sempurna atau

³Young (2001) dalam M. Noor Rochman Hadjam dan Wahyu Widhiarso, “Pengujian Model Peranan Kecakapan Hidup terhadap Kesehatan Mental”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 38, No. 1, (2011); 61-72.

⁴Suhaimi, “Gangguan Jiwa dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam”, *Jurnal Risalah*, Vol. 26, No. 4, (2015); 197-205.

⁵Carol D. Ryff dan Corey Lee M. Keyes, “The Structure of Psychological Well-Being Revisited”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 69, No. 4, (1995); 719-727.

⁶Menurut Carl Rogers *fully functioning person* ditandai (1) terbuka terhadap pengalaman; (2) ada kehidupan pada dirinya; (3) kepercayaan kepada organismenya; (4) kebebasan berpengalaman; dan (5) kreativitas. Menurut Allport untuk mencapai kondisi yang matang individu harus melalui proses *becoming*. Orang yang matang itu jika: (1) memiliki kepekaan pada diri secara luas; (2) hangat dalam berhubungan dengan orang lain; (3) keamanan emosional atau penerimaan diri; (4) persepsi yang realistik, keterlampaian dan pekerjaan; (5) mampu menilai diri secara objektif dan memiliki rasa humor; dan (6) menyatunya filosofi hidup Lih Moeljono Notoosoedirjo, *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 1999), 24-31.

integrasi antara fungsi-fungsi jiwa yang disertai kemampuan untuk menghadapi kegoncangan-kegoncangan jiwa yang ringan yang biasa terjadi pada siapa saja.⁷ Sementara Bastaman (1997) menyebutkan ada empat pola terkait pandangan-pandang kesehatan mental yakni pola *simtomatis*, pola penyesuaian diri, pola pengembangan potensi dan pola kerohanian.⁸ Sementara Mustafah Fahmi sebagaimana yang dikutip oleh Mujib dan Mudzkir (2002) menyebutkan dua pola dalam definisi kesehatan mental yakni pertama: pola negatif (*salabi*) bahwa kesehatan jiwa adalah bebas dari *neurosis* (*al-amrad al-‘asabiyyah*) dan *psikosis* (*al-amrad al-Zihaniyah*). Kedua: pola positif (*ijabi*) bahwa kesehatan mental adalah kemampuan individu dalam penyesuaian diri sendiri dan terhadap lingkungan sosial.⁹

Terkait pola *ijabi* (positif), kesehatan mental memiliki dua dimensi yakni *hedonic* yang merupakan perasaan yang positif (seperti bahagia dan kepuasan hidup) serta *eudemonic* yaitu keberfungsian yang positif (seperti penerimaan diri dan kemandirian).¹⁰ Hal ini selaras dengan Zakiah Daradjat (1983) yang menjelaskan bahwa fungsi

⁷Abdul ‘Aziz El-Qūsy, *Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa/Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 38.

⁸Pola *simtomatis* berarti hadirnya gejala (*symptoms*) dan keluhan (*complaints*), hal ini merupakan tanda adanya gangguan atau penyakit yang diderita seseorang. Pola penyesuaian diri berpandangan bahwa kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri merupakan unsur utama dari kondisi jiwa yang sehat. Penyesuaian diri harus bersifat aktif artinya memenuhi tuntutan diri sendiri tanpa melanggar hak-hak orang lain dan apabila penyesuaian diri bersifat aktif karena terjadi isolasi diri maka individu digolongkan sakit mental. Pola pengembangan potensi bermakna bahwa manusia memiliki kualitas insani (*human qualities*) seperti kreatifitas, rasa humor, tanggung jawan, cerdas, dan sebagainya. Sehat mental harus mampu mengembangkan potensi-potensi ini secara optimal sehingga mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Pola kerohanian bermaksud bahwa agama kerohanian memiliki daya yang dapat menunjang kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa diperoleh karena adanya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan. Lih Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi dengan Islam Menuju Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 133-135.

⁹Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2002), 54.

¹⁰Lynne Friedli, *Mental Health, Resilience and Inequalities*, (Belanda: WHO Europe, 2009), 10.

positif ini bermakna keserasian fungsi-fungsi jiwa (tidak ada konflik) dan tercipta penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungan yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sehingga individu dapat merasakan kebahagiaan, berharga dan mampu melejitkan potensi yang ada padanya seoptimal mungkin.¹¹

Pandangan Zakiah Daradjat di atas menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, kesehatan mental tidak hanya diukur dengan aspek humanistik saja, namun Islam juga menekankan aspek spiritualitas keagamaan melalui keimanan dan ketaqwaan. Dengan demikian individu yang sehat mentalnya dalam Islam adalah seseorang yang perilaku, fikiran, dan perasaannya mencerminkan ajaran Islam. Sementara itu menurut Said Hawa (2002), indikator kesehatan mental dalam Islam adalah sempurna dalam melaksanakan ibadah; muncul *al-akhlaq al-karimah* (akhlak yang baik) sebagai efek dari ibadahnya; mempunyai hati yang mantap bertauhid kepada Allah.¹²

Dengan demikian kesehatan mental yang dikembangkan oleh para ahli di atas pada akhirnya bermuara pada dua makna yakni ketiadaan gangguan atau penyakit psikis dan kedua adalah penyesuaian diri.¹³ Dalam lingkungan akademik khususnya pendidikan tinggi kajian kesehatan mental banyak terfokus pada kemampuan penyesuaian diri, hal ini dikarenakan sebagai pelajar tingkat perguruan tinggi mahasiswa menjalani proses transisi dari model pembelajaran kon-

¹¹Pengertian “keserasian fungsi-fungsi jiwa (tidak ada konflik)” adalah berkembangnya seluruh potensi kejiwaan secara seimbang sehingga manusia dapat mencapai kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, dan terhindar dari pertentangan batin, kegoncangan jiwa, kebimbangan dan keragu-raguan serta tekanan perasaan dalam menghadapi berbagai dorongan dan keinginan. Lih Zakiah Daradjat, *Islam dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 9.

¹²Said Hawa, *Mensucikan Jiwa Konsep Tazkiyatun an-Nafs Terpadu*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), 127.

¹³Penyesuaian diri dalam konteks kesehatan mental adalah usaha seseorang untuk melakukan penyesuaian diri yang sehat terhadap dirinya, yang mencakup pembangunan dan pengembangan seluruh potensi dan daya yang terdapat dalam dirinya, serta berkemampuan untuk memanfaatkan potensi dan daya itu seoptimal mungkin sehingga penyesuaian yang dilakukan membawa kepada kesejahteraan dan kebahagiaan diri dan orang lain. Lih Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), 142.

vensional kepada pembelajaran yang lebih aktif, eksploratif, inovatif, dan kompetitif. Terlebih lagi pada fakultas kedokteran, dimana tuntutan dan kewajiban akademik dinilai cukup memberi tekanan-tekanan sehingga dapat memunculkan pengaruh negatif terhadap fungsi psikologis dan kesejahteraan fisik (*physical wellbeing*).¹⁴

Penyesuaian mahasiswa terhadap dunia akademik merupakan suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan tingkah laku terhadap tuntutan formalnya yang berhubungan dengan tugas kewajiban akademik.¹⁵ Dengan demikian dapat dipahami ketika individu mahasiswa gagal melakukan penyesuaian diri dalam lingkungan akademik maka dirinya dapat dikatakan mengalami gangguan fungsi psikologis diri atau gangguan psikologis itu sendiri. Sebagaimana dilaporkan oleh American College Health Association Survey seperti-ga (35%) mahasiswa melaporkan mereka mengalami kesulitan dalam optimalisasi fungsi psikologis akibat berbagai tekanan dalam dunia akademik, seperti sulit konsentrasi, kontrol diri, gangguan istirahat dan tidur serta gangguan pencernaan dan pola makan. Selebihnya mahasiswa mengungkapkan bahwa mereka mengalami gangguan emosional negatif selama satu tahun terakhir masa pendidikannya.¹⁶

Gangguan emosional negatif merupakan gangguan yang berasal dari konflik alam bawah sadar yang menyebabkan kecemasan. Individu dengan gangguan emosional negatif meskipun masih melakukan aktifitas dalam lingkungannya sebenarnya mereka juga memerlukan bantuan/intervensi dari orang lain. Gangguan emosional negatif ini ditandai dengan menurunnya fungsi individu pada ranah keluarga, pekerjaan/pendidikan, dan komunitas/masyarakat,¹⁷ seperti merasa

¹⁴Jamshid Ahmadi, MD and others, "Mental Health of Dubai Medical College Students", *Iran Journal Psychiatry Behavir Sciences*, Vol. 6, No. 2, (2012); 79-83.

¹⁵Dika Christyanti, Dewi Mustami'ah dan Wiwik Sulsitiani, "Hubungan antara Penyesuaian Diri terhadap Tuntutan Akademik dengan Kecenderungan Stres pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya", *INSAN*, Vol. 12, No. 3, (2010); 153-159.

¹⁶American College Health Association, *American College Health Association-National College Health Assessment II: Reference Group Executive Summary Spring 2015*, (Hanover, MD: American College Health Association, 2015).

¹⁷Yudi Kurniawan dan Indahria Sulityarini, "Komunitas SEHATI (Sehat Jiwa dan Hati) sebagai Intervensi Kesehatan Mental Berbasis Masya-

sangat sedih, sendiri, cemas dan marah berlebihan dan kurang harapan. Beberapa riset dalam dunia akademik membuktikan bahwa gangguan emosional yang lazim terjadi pada mahasiswa yang menukrunkan kesehatan mental adalah ansietas, stres dan depresi.¹⁸

Kajian terkait penurunan kesehatan mental seringkali dihubungkan dengan stres karena secara klinis memang kesehatan mental dikonseptualisasikan sebagai sindrom psikologis yang terdapat pada individu dan diasosiasikan dengan *distress* dan *disability*.¹⁹ Selanjutnya penelitian ini hanya akan memfokuskan perhatian subjek pembahasan riset pada gangguan psikologis stres saja, dimana kajian teori stres akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

2. Stres sebagai *Disease Adaptation* dan *Adjustment Disorder*

Kata stres berasal dari bahasa Inggris “*strictus*”. Dalam kamus *Oxford*, stres setidaknya memiliki enam pengertian yang disesuaikan dengan penggunaannya di bidang-bidang yang berbeda, yakni: 1) tekanan atau kecemasan yang disebabkan oleh masalah-masalah dalam kehidupan seseorang; 2) tekanan yang diberikan ke suatu benda yang bisa merusak benda itu atau menghilangkan bentuknya; 3) kepentingan khusus yang diarahkan kepada sesuatu; 4) suatu kekuatan ekstra yang dikerahkan ketika mengecapkan suatu kata khusus; 5) suatu kekuatan ekstra yang digunakan untuk membuat suara khusus dalam musik; 6) penyakit yang ditimbulkan oleh kondisi fisik yang terganggu.²⁰

Namun secara terminologi stres merupakan konsep yang komplikatif, karena itu para peneliti tidak setuju untuk mendefinisikan kata stres dengan satu pengertian yang sama karena sifat stres

rakat”, *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 1, No. 2, (2016); 112-124.

¹⁸The Provost’s Committee on Student Mental Health, *The State of Student Mental Health on College and University Campuses with a Specific Assessment of the University of Minnesota, Twin Cities Campus*, (2016); 1-26.

¹⁹Suhaimi, “Gangguan Jiwa dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam”, *Jurnal RISALAH*, Vol. 26, No. 4, (2015); 197-205.

²⁰A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learners’s Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 19995), 1286.

itu sendiri yang sangat kompleks.²¹ Sehingga demikian tinjauan literatur ilmiah tentang stres memberikan definisi yang berbeda-beda, namun demikian terjadi kesamaan (*similarity*) dan keterhubungan makna. Bahwa pada dasarnya ada dua pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan studi stres yakni fisiologis dan psikologis. Pendekatan fisiologis merupakan bentuk kajian pertama kali mengenai stres yang kemudian kekinian saat ini banyak dikembangkan teori stres dengan pendekatan psikologis.

Menurut *American Institute Stress*, terminologi stres pertama kali dicetuskan oleh Hans Selye pada tahun 1936, dimana ia mendefinisikan stres sebagai respon tubuh yang bersifat non-spesifik terhadap beban tuntutan untuk berubah, kemudian teorinya banyak mendapatkan perhatian dan menjadi *buzzword* (kata kunci) pada penelitian-penelitian selanjutnya.²² Menurut Selye stres diawali dengan reaksi waspada (*alarm reaction*) terhadap adanya ancaman yang ditandai oleh proses respon tubuh secara otomatis, seperti: meningkatnya denyut jantung yang kemudian diikuti dengan penolakan terhadap sumber stres dan akan mencapai tahap kehabisan tenaga (*exhaustion*) jika individu merasa tidak mampu untuk terus bertahan dan kemudian ia mengalami gangguan pada satu atau lebih organ tubuh sehingga ia tidak dapat menjalankan fungsi pekerjaan dengan baik, maka individu tersebut mengalami *distress*.²³ Reaksi stres secara fisik yang dikeluarkan individu didominasi oleh keluhan-keluhan somatik (fisik).

Selanjutnya memahami determinasi stres melalui pendekatan psikologis menurut Lazarus dan Folkman (1984) adalah sebuah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau sangat melampaui kemam-

²¹Salami and others, "Impact of Work-Related Stress on Managers' Performance", *European Journal of Scientific Research*, Vol. 45, N0. 2, (2010); 249-252.

²²Malikeh Beheshtifar dan Rahele Nazarian, "Role of Occupational Stress in Organization", *Interdisciplinary Journal of Contemporary Reserach In Business*, Vol. 4, N0. 9, (2013); 648-657.

²³Philip L. Rice, *Stress and Health 2nd edition*, (California: Brooks/Cole Publishing Company, 1992), 43.

puan seseorang dan membahayakan kesejahteraannya.²⁴ Stres psikologis yang berkaitan dengan perubahan penampilan fungsi tubuh adalah perubahan dalam konsep diri.²⁵ Dimensi stres psikologis ini meliputi persepsi, pikiran, motivasi, kekuatan dan kelemahan pribadi, nilai-nilai, kepercayaan, dan spiritualitas.²⁶ Pada tekanan psikologis peristiwa yang dialami individu diwujudkan sebagai emosi dan perubahan kognisi. Emosi yang dihasilkan adalah hasil otomatis dari penilaian bawah sadar terhadap objek dan situasi.²⁷

Namun demikian mendefinisikan stres secara psikologis dan fisiologis bukan berarti menafikan hubungan keduanya, sehingga definisi kekinian yang berkembang mengenai stres adalah melihat stres dengan pendekatan psikofisiologis sebagaimana *APA Dictionary of Psychology* (2007) mendefinisikan stres sebagai respon fisiologis dan psikologis terhadap tuntutan dari luar (eksternal) dan dari dalam (internal), dimana stres menyebabkan perubahan yang memengaruhi bagaimana manusia berperasaan dan berperilaku.²⁸ Pendekatan psikofisiologis memandang stres sebagai tuntutan (*demand*) yang membuat *body* (tubuh) dan *psycho* (jiwa) melakukan sebuah tindakan adaptasi. Maka ketika tubuh gagal melakukan adaptasi, keadaan ini yang disebut oleh Selye (1956) dengan istilah “*disease of adaptation*”²⁹ adapun ketika fungsi psikologis gagal melakukan adap-

²⁴Richard S. Lazarus dan Susan Folkman, *Stress, Appraisal, and Coping*, (New York: Springer Publishing Company, 1984), 12.

²⁵Judith Fitzgerald Miller, *Coping with Chronic Illness: Overcoming Powerlessness* (3rd ed.) (Philadelphia: Davis, 2007), 78.

²⁶Joyce M. Black & Jane Hokanson Hawks, *Medical Surgical Nursing: Medical Management for Positive Outcome* (7th ed.), (Elsevier Saunders), 89.

²⁷Alexander Stamatios G. Antoniou dan Cary L. Cooper, *Research Companion to Organizational Health Psychology*, (USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2005), 188.

²⁸Gary R. VandenBos, *APA Dictionary of Psychology*, (Washington: American Psychological Association, 2007), 524.

²⁹European Agency for Safety and Health in Work, *Research on Work Related Stress*, (2000) diakses dari <https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/203>, pada tanggal 10 Februari 2016, pukul 15.25 WIB.

tasi keadaan ini yang kemudian disebut oleh Nevid at all (2008) dengan istilah *adjustment disorder*.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami kesamaan teori yang dikemukakan para ahli bahwa stres merupakan reaksi fisik dan emosional diri untuk berubah terhadap tuntutan dari sebuah keadaan yang tidak menyenangkan dan dianggap membahayakan bagi kesejahteraan dirinya. Secara umum stres menurut pandangan beberapa ahli diartikan dengan ketegangan, kecemasan, ketakutan, tekanan batin, tegangan dan konflik yang berarti.

Selanjutnya studi intensif mengenai stres dengan perspektif Islam yang dilakukan oleh Baqutayan (2011) membagi stres kedalam tiga term *qalaq/worry* (cemas), *ya's/despair* (putus asa), dan *qunut/helplessness* (keadaan tidak berdaya).³¹ Term stres pertama di dalam al-Qur'an adalah *al-qalaq*, *hasr* atau *halu*. Meski demikian kata *qalaq* sendiri tidak dapat di dalam al-Qur'an sehingga demikian kata yang lebih tepat untuk menggambarkan *worry/anxiety* adalah *halu*,³² sebagaimana secara jelas disebutkan dalam firman Allah :

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿

Artinya:

“Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan kecemasan (19) apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah (20)” (al-Ma'arij: 19-20).

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya “Al-Misbāh” menjelaskan kata *halu* terambil dari kata *hala'a* yang berarti cepat gelisah. Ia

³⁰ *Adjustment disorder* adalah sebuah bentuk kegagalan (*maladaptive*) reaksi diri terhadap sumber stres yang dihadapi yang dapat berupa gangguan fungsi di sekolah atau di tempat kerja, seperti memiliki kesulitan berpikir dan konsentrasi ketika belajar. Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, & Beverly Greene. *Abnormal Psychology in Changing World 7th editon*, (United State: Prentice Hall, 2000), 142.

³¹ Shadiyah Mohamed S. Baqutayan, “An Innovative Islamic Counseling”, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 1, No. 21, (2011): 178-183.

³² Che Zarrina Sa'ari, “Penyakit Gelisah (anxiety/al-haluca) dalam Masyarakat Islam dan Penyelesaiannya menurut Psiko-Spiritual Islam”, *Jurnal Usuludin* Vol. 14, (2001).

menjelaskan bahwa Tabatābā'i mengomentari ayat tersebut antara lain bahwa pada diri manusia ada potensi untuk meraih kebaikan dan manfaat untuk dirinya, kecendrungan ini membuat manusia seringkali merasa goyah dan gelisah ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dan membahayakan dirinya. Sehingga dengan keadaan yang tidak nyaman tersebut manusia akan berkeluh kesah.³³ Seseorang yang mengalami kecemasan akan turut merasakan ketakutan dan ketertekanan. Kecemasan akan hilang seiring dengan waktu dan apabila tidak hilang akan mendatangkan mudarat kepada orang tersebut sehingga ia merasakan murung, sedih dan berkeluh kesah.³⁴

Selanjutnya term kedua yang digunakan al-Qur'an untuk merujuk kata stres adalah *ya's/despair* (putus asa). Putus asa ini tidak hanya mengarahkan manusia pada jalan yang salah namun dapat memengaruhi kemampuan berpikir serta menghantarkan kepada kehancuran. Sehingga *ya's/despair* (putus asa) sangat dilarang di dalam agama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يَبْنِيْ اَدْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَاْيَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَآيِسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ

Artinya:

“Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”. (Yusuf: 87)

Yusuf Qardawi menjelaskan “*ya's* atau *despair* ini dengan penjelasan bahwa, keputus asaan adalah lawan dari harapan. Ia memadamkan api harapan di dada. Ia adalah penghalang serta menghancurkan motivasi kerja dan melemahkan tubuh dari segala kekua-

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mīshāh*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 441-442.

³⁴Salasiah Binti Hanin Hamjah, “Methods to Overcome Anxiety in Counseling: an Analysis from al-Ghazali Perspective”, *Jurnal Hadhari*, Vol. 3, No. 1, (2010): 41-57.

tan yang dimiliki.³⁵ Sementara Imam Ghazali menghubungkan stres dalam konteks putus asa dengan konsep kebahagiaan, ia menyebutkan bahwa bahagia salah satunya didapatkan dengan kerja keras dan usaha konstan, tetapi orang yang berputus asa tidak akan berusaha untuk sesuatu yang sebenarnya mungkin untuk diraih.³⁶

Adapun term ketiga dari makna stres dalam al-Qur'an sebagaimana diungkap oleh Baqutayan adalah *qunūt/helplessness* (keadaan tidak berdaya). Seseorang merasa tidak berdaya ketika ia benar-benar merasa frustrasi dan tidak ada harapan untuk mendapatkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an sebagai berikut:

﴿ قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

Artinya:

“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (az- Zumar: 53)

Kata *qunūt* bermakna berputus asa dan perasaan tidak berdaya (*helplessness*) yakni suatu keadaan di mana seseorang meyakini bahwa dirinya tidak lagi lagi mempunyai daya dan usaha untuk mengatasi keadaan yang dianggap membebani hidupnya. Berbeda dengan Baqutayan yang menjelaskan tiga istilah di atas sebagai indikasi stres, Zakiah Daradjat justru memaknai dua istilah terakhir yakni “*ya’as* dan *qunūt*“, sebagai penyakit hati. Beliau memaknai *qunūt* sebagai penyakit berputus asa atau pesimis. Sementara “*ya’as*” sebagai penyakit apatis. Dimana menurutnya, dalam pandangan psikologis *ya’as* (apatis) merupakan penyakit yang lebih berat dari pada pesimis. Orang yang apatis tampak padanya gejala murung, tidak

³⁵Yusuf Qardawi, *Al-Iman wal al-Hayat*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), 157.

³⁶Al-Ghazali, Abu Hamid, *Rauḍat al-Ṭalibīn wa ‘Umdat al-Sālikīn* dalam *Majmu‘at Rasāil al-Imam Al-Ghazālī*, (Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1986), 36.

acuh terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Misalnya orang yang apatis, ketika menghadapi masalah seringkali tidak mau bicara, malas meminta pertolongan orang lain, dan cenderung mengurung diri.³⁷

Menurut Baqutayan (2011), stres hanya ditemui dalam kehidupan dunia dimana manusia tidak bisa lepas dari kecemasan, takut dan tekanan.³⁸ Islam memahami bahwa, sifat dan keadaan stres merupakan keadaan naluri alamiah pada diri manusia. Sebagaimana disebutkan pada surah al-Ma'arij ayat 19-20 di atas, bahwa Allah menciptakan manusia memiliki rasa gelisah, berkeluh kesah dan merasa lemah sebagai reaksi alamiah sensitifitas dan sistem saraf tubuh terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, karena pada dasarnya musibah dan kesusahan bukanlah sesuatu yang diinginkan manusia pada umumnya. Stres merupakan bagian dari kehidupan manusia, artinya bahwa manusia tidak akan pernah luput dari pengalaman merasakan ketegangan dalam hidupnya.

Menurut Markam, individu akan mengalami stres apabila mengalami tekanan hidup dan konflik kebutuhan atau konflik tujuan. Konflik terjadi apabila suatu objek tujuan mempunyai nilai ganda bagi seseorang, atau contoh lain konflik terjadi ketika individu menghadapi lebih dari satu tujuan, di mana sukar untuk menentukan pilihan.³⁹ Senada dengan al-Qur'an, manusia memang akan diuji oleh Allah SWT melalui tekanan hidup dan konflik kehidupan, sebagaimana terdapat dalam QS. Ali-'Imran ayat 186:

لَتَبْلُوَنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيْرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

³⁷Zakiah Daradjat, *Psikoterapi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 72-73.

³⁸Shadiyah Mohamed S. Baqutayan, "An Innovative Islamic Counseling", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 1, No. 21, (2011); 178-183.

³⁹Suprpti Sumarmo, *Pengantar Psikologi Klinis*, (Jakarta: UI Press, 2003), 36.

Artinya:

“Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakinkan hati. jika kamu bersabar dan bertakwa, Maka Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk urusan yang patut diutamakan”. (Ali-‘Imran: 186)

Dengan demikian stres dapat dirasakan siapa saja tanpa memperhatikan usia, *gender*, bangsa dan agama. Termasuk para remaja, menurut Hosseini et al (2010) ada beberapa hal yang bisa diidentifikasi terkait perkembangan psikopatologi pada remaja. Pertama, ada beberapa catatan riset meningkatnya tipe psikopatologi pada masa remaja seperti stres, depresi, kecemasan sosial, masalah makan, psikosis dan kasus *abuse* lainnya. *Kedua*, ada perubahan signifikan dalam indikasi munculnya psikopatologi pada remaja seperti tanda kognitif dari stres dan depresi seperti tidak percaya diri, kurang harapan, dan gangguan stabilitas emosi.⁴⁰ Adapun kelompok yang termasuk usia remaja ini adalah para pelajar dan mahasiswa, dimana stres yang paling umum dialami oleh mahasiswa yaitu stres akademik. Stres akademik menurut Govaret & Gregoirea (2004) diartikan dengan keadaan dimana individu mengalami tekanan karena lingkungan perkuliahan yang merupakan hasil persepsi dan penilaian mahasiswa mengenai sumber stres akademik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan.⁴¹

Stres akademik terkait erat dengan kehidupan akademik yang dialami semua pelajar dari berbagai usia dari kelas yang paling rendah sampai dengan perguruan tinggi tergantung dimana seseorang tersebut

⁴⁰Maryam Hosseini and others, “A review Study on Spiritual Intelligence, Adolescence, and Spiritual Intelligence, Factors that May Contribute to Individual Differences in Spiritual Intelligence, and the Related Theories”, *International Journal of psychological Studies*, Vol. 2, No. 2, (2010); 179-188.

⁴¹Govaerst, S. & Gregoire, J. (2004) dalam Abraham Karuniawan dan Ika Yuniar Cahyanti, “Hubungan antara Academic Smartphone Addiction pada Mahasiswa Pengguna Smartphone”, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 2, No. 1, (2013); 16- 21.

mencari ilmu pengetahuan. Salah satu model studi yang bermanfaat untuk memahami stres akademik ini adalah “*the person environmental model*” dari McKean (2000), yakni berdasarkan model ini individu dapat menilai peristiwa stres sebagai tantangan atau ancaman. Ketika mahasiswa merasakan bahwa pendidikan mereka sebagai tantangan, stres dapat membawa mereka pada rasa kompetensi dan kapasitas peningkatan belajar. Namun, ketika pendidikan dianggap sebagai ancaman, stres dapat menimbulkan perasaan putus asa dan rasa firasat kehilangan, sehingga mengarah pada penurunan prestasi akademik.⁴² Sehingga demikian dalam dunia akademik stres yang dapat mendukung dan memfasilitasi belajar lebih disebut “*favourable stress*” dan sebaliknya stres yang menghalangi dan menekan proses belajar disebut “*unfavourable stress*”.⁴³

Model stres yang berbeda dikemukakan oleh Siegerist (1996) “*effort-reward model*”, yakni pada model ini stres terjadi karena banyaknya tuntutan usaha namun kurang umpan balasan, pada konteks mahasiswa kedokteran ada perhatian mengenai kurangnya pengakuan dan umpan balik positif atas usaha maksimal yang dilakukan mahasiswa. Hal ini yang kemudian pada beberapa penelitian yang menjadi penyebab tingginya tingkat stres pada mahasiswa kedokteran.⁴⁴

Menurut Ross dan Heckert (1999) ada beberapa penjelasan mengapa mahasiswa sangat beresiko mengalami stres. Pertama, mahasiswa harus melakukan penyesuaian yang signifikan terhadap kehidupan kampus. Kedua, karena tekanan studi dan ketegangan pada

⁴²Michelle McKean, “College Students’ Academic Stress and Its Relation to Their Anxiety, Time Management, and Leisure Satisfaction”, *American Journal of Health Studies*, Vol. 16, No. 1, (2000); 41 – 52.

⁴³Beberapa studi mengungkapkan *unfavourable stress* dengan rendahnya konsep diri, kecemasan dan depresi, kesulitan untuk menyelesaikan konflik interpersonal, gangguan tidur, konsumsi obat-obatan, berkurangnya perhatian dan konsentrasi serta ketidak jelasan akademik. Muhammad Saiful Bahri Yusoff and others, “The Development and Validity of the Medical Student Stressor Questionnaire (MSSQ)”, *ASEAN Journal of Psychiatry*, Vol. 11, No. 1, (2010); 1-12.

⁴⁴Muhamad Saiful Bahri Yusooof, and others, *Prevalence and Sources of Stress Among Medical Students in Universiti Sains Malaysia*. Medical Education (Universiti Sains Malaysia (USM), 2009).

hubungan interpersonal. Ketiga, perubahan gaya dan kebiasaan rutinitas perkuliahan. Stres yang dirasakan mahasiswa merupakan persepsi mereka akan sumber stres yang dihadapi. Sumber stres memengaruhi fungsi penting terhadap stres yang ditimbulkan. Sumber stres atau penyebab stres dikenali sebagai stresor, lanjutan sub bab setelah perbedaan *eustress* dan *distress* berikut ini akan menjelaskan teoritis stresor yang dihadapi mahasiswa kedokteran.

3. Perbedaan *Eustress* dan *Distress*

Stres atau tekanan pada hakikatnya merupakan reaksi alamiah tubuh terhadap keadaan yang tidak menyenangkan. Stres dirasakan hampir setiap manusia di belahan bumi dari berbagai latar belakang usia, *gender*, sosial ekonomi, perkotaan atau perdesaan dan sebagainya. Sebagaimana Baqutayan menjelaskan stres hanya ditemui dalam kehidupan dunia, hampir setiap manusia yang hidup tidak pernah luput dari pengalaman merasakan ketegangan, ketakutan dan kecemasan dalam hidupnya.⁴⁵

Ketegangan, ketakutan dan kecemasan dalam tingkat sederhana justru dapat meningkatkan kegairahan hidup dalam melawan tantangan.⁴⁶ Kajian mengenai stres berdasarkan persepsi dan respon individu menjelaskan bahwasanya stres tidak selamanya buruk untuk individu, stres bahkan dinilai dapat memberi pengaruh positif terhadap kesejahteraan diri. Selye dalam Rice (1992) menggolongkan stres menjadi dua golongan berdasarkan respon dan persepsi yang diberikan; 1) *Eustress*, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif. Ini adalah bentuk stres yang mendorong tubuh untuk beradaptasi dan meningkatkan kemampuan diri. 2) *Distress*, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif. *Distress* merupakan bentuk stres yang melebihi kemampuan untuk mengatasinya, membebani tubuh, dan menyebabkan masalah fisik atau psikologis.⁴⁷

⁴⁵Shadiyah Mohamed S. Baqutayan, "An Innovative Islamic Counseling", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 1, No. 21, (2011); 178-183.

⁴⁶Zaenal Abidin, "Ketika Stress Bereaksi Islam Punya Solusi", *Komunika*, Vol.3, No. 1, (2009); 148-166.

⁴⁷Philip L. Rice, *Stress and Health 2nd edition*, (California: Brooks/Cole Publishing Company, 1992), 43.

Islam mengajarkan pada pemeluknya untuk selalu bersikap positif bahwa ujian dan beban kehidupan akan dapat diselesaikan dengan baik. Ujian merupakan salah satu media meninggikan derajat dan martabat seseorang di sisi Allah dan sesama manusia. Untuk itu manusia diharapkan mampu menyiapkan ruhaniah, mental dan fisiknya untuk menghadapi tantangan hidup.⁴⁸ Melalui al- Qur'an, Allah menjanjikan bahwa di setiap kesulitan dan kesusahan akan datang kemudahan dan kesenangan. Sebagaimana disebutkan pada surah al-Insyirah ayat 5-6 sebagai berikut:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya:

“*Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*”.
(Al-Insirah 5-6)

Diantara contoh *eustress* yang bisa kita jumpai dalam persekitaran kita adalah ketika individu dituntut dapat mengerjakan tugas dan kerjaan pada waktu yang sudah ditentukan (*deadline*), maka individu tersebut akan melakukan dengan baik tugas tersebut, dirinya akan membuat strategi yang tepat untuk menyelesaikan tuntutan tugas tepat waktu. Individu dengan semangat yang positif mampu mengubah tekanan menjadi sebuah tantangan, ia berusaha keras menjadikan hidupnya berkualitas. *Eustress* diperlukan untuk menghasilkan prestasi yang tinggi. Mujib (2012) menjelaskan bahwa berprestasi merupakan syarat dalam rangka merealisasikan amanah Allah SWT menjadi *khalifah*-Nya di mukan bumi.⁴⁹

Teladan istimewa terkait *khalifah* dan manusia sempurna yang telah terbukti berhasil mengubah berbagai tekanan hidup menjadi positif adalah Rasulullah. Betapa tidak, beliau Rasulullah sejak

⁴⁸ Ahmad Yunus Bin Mohd Nor dan Siti Noorshafena Safe, “*Stress Management According to the Qur'an and the Hadits*”, diakses dari https://www.researchgate.net/profile/ahmad_mohd_noor4/publication/307639750_pengurusan_stress_menurut_al-quran_dan_hadith/links/57ce8d6608acd6789700c829/pengurusan-stress-menurut-al-quran-dan-hadith.pdf, pada tanggal 18 Januari 2018, Pukul. 07.46 WIB.

⁴⁹ Abdul Mujib, “Motivasi Berprestasi sebagai Mediator Kepuasan Kerja”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 39, No. 2, (2012); 143-155.

kecil telah menjadi seorang anak yatim dan piatu. Selanjutnya ujian beliau bertambah ketika kakek dan paman yang mengasuhnya turut meninggal dunia di beberapa tahun berikutnya. Setelah menikah, beliau *pun* ditinggalkan oleh istri dan anak-anak lelakinya. Dalam kajian psikologis, perubahan kehidupan seperti kematian orang tercinta menjadi salah satu sumber terjadinya stres. Namun nampaknya hal ini tidak terjadi pada Rasulullah, sebagai contoh beliau menanggapi kematian anaknya tanpa luapan emosi yang berlebihan, sebagai mana diceritakan oleh Anas bin Malik pada hadits berikut ini:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَذْرِفَانِ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟! فَقَالَ : ((يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ)) ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى ، فَقَالَ : (إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا لَفِرَاقُكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ)

Artinya:

“Rasulullah masuk (di rumah ibu susuan Ibrahim) menemui Ibrahim yang dalam keadaan sakaratul maut bergerak-gerak untuk keluar ruhnya. Maka kedua mata Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam pun mengalirkan air mata. Abdurrahman bin 'Auf berkata, "Engkau juga menangis wahai Rasulullah?". Maka Nabi berkata, "Wahai Abdurrahman bin 'Auf, ini adalah rahmah (kasih sayang)". Kemudian Nabi kembali mengalirkan air mata dan berkata, *"Sungguh mata menangis dan hati bersedih, akan tetapi tidak kita ucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah, dan sungguh kami sangat bersedih berpisah denganmu wahai Ibrahim"* (HR Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan bahwa dalam musibah yang dihadapi, Rasulullah tetap memiliki keridhaan pada takdir Allah atas dirinya. Menurut Tsabit (2009), orang yang berhati ridha pada Allah akan memiliki sikap optimis, lapang dada, kosong hatinya dari dengki, sempurna, penuh hikmah bahwa, semua yang terjadi sudah ada dalam rencana dan ketentuan Allah.⁵⁰ Akhmad Fadholi (2014) dalam bukunya “Tumpas Stres Seketika”, menjelaskan beberapa

⁵⁰Muhammad Khalid Tsabit, *Quantum Ridha*, (Jakarta: AMZAH, 2009), 9-13.

perbuatan dan pola hidup Rasulullah yang bisa diteladani dalam mengatasi stres seperti ridha, sabar, tawakal, syukur, berprasangka baik kepada Allah, mendirikan sholat, membaca al- Qur'an, bersilaturahmi, berdo'a dan sebagainya.⁵¹ Pada sub selanjutnya, penulis akan mendeskripsikan beberapa konsep tersebut dan relasinya dengan pencegahan terhadap stres dan kecemasan.

Beralih dari teladan Rasulullah, stres positif juga dapat dilihat mekanismenya dalam dunia akademik. Beberapa riset menjelaskan bahwa tuntutan, kesulitan dan tanggung jawab akademik tidak selamanya berdampak negatif pada mahasiswa. Persepsi, dukungan eksternal seperti penghargaan dari dosen, apresiasi dan hubungan baik dengan teman, akan menjadikan para mahasiswa bisa merasakan kesenangan dan kegairahan dalam menjalani aktivitas perkuliahan.⁵² Hal ini yang kemudian diistilah oleh Hanson sebagai "*frase joy of stress*", pengalaman stres yang dapat menimbulkan perasaan nyaman, senang dan bahagia.⁵³

Sebaliknya respon negatif terhadap stres memunculkan keadaan yang tidak sehat dan destruktif (bersifat merusak), hal ini yang dimaksud Selye di atas adalah *distress*. Respon emosional yang tidak stabil menyebabkan *distress* terjadi, individu yang mengalaminya akan merasa sangat tidak nyaman dan menyisakan kepedihan psikis yang mendalam. Dampak negatif stres dapat melampaui dan menembus benteng ruhaniannya. Rasa kepercayaan diri semakin melemah dan individu dengan *distress* akan merasa dirinya lemah, tidak punya potensi dan menyerah kepada keadaan. Gambaran keadaan individu dengan *distress* ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al- Isra' ayat 83

وَإِذَا أُنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَتَنَا بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَفْئُوسًا ﴿٨٣﴾

⁵¹Akhmad Fadholi, *Tumpas Stres Seketika*, (Yogyakarta: Diva Press, 2014).

⁵²Chris Gibbons, M. Dempster dan M. Mountray, "Stress and Eustress in Nursing Students", *Journal of Advanced Nursing*, Vol. 6, No. 3, (2008); 282-290.

⁵³Hanson dalam F. Philip Rice, *The Adolescent: Development, Relationships and Culture*, (USA: Allyn & Bacon, 1993), 89.

Artinya:

“Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong; dan apabila Dia ditimpa kesusahan niscaya Dia berputus asa”. (Al- Isra’: 83)

Ayat di atas menjelaskan, seseorang yang tidak dapat mengendalikan dirinya dalam menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan dan membebani dirinya akan menimbulkan efek negatif seperti berputus asa atau pesimis dengan dirinya sendiri. Dalam keadaan ini individu mengalami ketidakberdayaan dalam menghadapi problematika hidup yang dirasakan menekan dan menegangkan.⁵⁴ Sebagai contoh mahasiswa merasakan *distress* ketika dirinya mempersepsikan tuntutan akademik sebagai ancaman, sehingga mahasiswa tersebut mencari ketenangan dan pelepasan diri dari keadaan tersebut dengan hal-hal negatif seperti hanya mengurung diri, tidak berteman, atau menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Sebagaimana Najati (2001) menjelaskan bahwa individu yang berlebihan dalam memenuhi berbagai dorongan dan tuntutan hidup, kemudian tidak mampu mengendalikan dan memenuhinya. Maka hal ini akan menyebabkan penyimpangan perilaku dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan tersebut.⁵⁵

4. Faktor Penyebab Stres/ Stresor

Menurut Rasmun (2004), stresor adalah variabel yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab timbulnya stres.⁵⁶ Selanjutnya para ahli berbeda pendapat mengenai sumber dan faktor penyebab terjadinya stres. Menurut Brannon dan Feist (2007) stres dapat terjadi karena stresor dipersepsikan sebagai ancaman sehingga menimbulkan stres, stres tersebut dapat berasal dari tiga sumber, yaitu: 1) Katasrofi yakni kejadian besar yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat

⁵⁴Siti Nur Khalifah dan Nurul Lutfiah, “Religiopsikoneuroimunologi Al-Qur’an (Studi Klaborasi Terapi Al-Qur’an dan Fungsi Otak dalam Menghadapi Stres)”, *Buletin Psikologi*, Vol. 18, No. 1, (2010); 19-28.

⁵⁵Uthman Najati, *Al-Qur’an dan Psikologi*, (Jakarta: Aras Pustaka, 2001), 78.

⁵⁶Rasmun, *Pengertian Stres, Sumber Stres dan Sifat Stresor*, dalam *Stres, Koping, dan Adaptasi*, Edisi Ke-1, (Jakarta: Sagung Seto, 2004), 9.

diprediksi, seperti bencana alam dan perang, 2) Perubahan kehidupan, perubahan yang dialami dalam kehidupan seseorang dapat memicu terjadinya stres, seperti perceraian, kematian dan orang yang dicintai, 3) Kejadian sehari-hari yang dapat menimbulkan stres misalnya jadwal kerja yang padat, lalu lintas yang macet ataupun aktifitas antrian dan lain sebagainya.⁵⁷

Selanjutnya Gunaryo (2008) membagi tiga sumber utama stres, yaitu faktor lingkungan; yakni berbagai tuntutan akan penyesuaian diri terhadap hubungan antar sesama, faktor fisiologis; yakni tekanan yang bersumber dari tubuh karena perubahan kondisi tubuh seperti menua, kurang tidur dan faktor pikiran; yakni berupa pemaknaan diri dan lingkungan seperti pemahaman terhadap pengalaman dan antisipasi masa depan dimana hal ini dapat membuat relaks atau stres.⁵⁸

Adapun Suparto (2003) melihat sejauh mana stresor dapat menimbulkan stres karena beberapa faktor yang diantaranya adalah: 1) kepribadian; semakin optimis seseorang menghadapi kehidupan semakin jauh dari *distress*. 2) Falsafah hidup; yakni semakin berserah kepada Tuhan, semakin terbebas dari *distress*. 3) Persepsi; yakni semakin santai dalam menghadapi permasalahan semakin jauh dari *distress*. 4) Posisi sosial; semakin berperan dalam lingkungan sosial semakin jauh dari *distress*. 5) Pengalaman; semakin sering stresor dihadapi seseorang semakin kecil kemungkinan mengalami *distress*. 6) Kesehatan; semakin sehat jasmani dan rohani seseorang semakin jarang terkena *distress*.⁵⁹

Falsafah hidup, berpasrah kepada Tuhan sebagaimana diungkapkan di atas, searah dengan pandangan Najati (1992) yang menyebutkan keresahan yang dapat menimbulkan tekanan diri atau stres disebabkan berasal dari hati yang tidak tenang yakni ketika seseorang tidak menyerahkan sepenuhnya keyakinan diri akan ketentuan Allah

⁵⁷Linda Brannon & Jess Feist, *The Nervous System and the Physiology of Stress*. In: *Health Psychology: An Introduction to Behaviour and Health 6th edition*, (USA: Thomson Wadsworth, 2007), 99

⁵⁸Arlina Gunarya, *Manajemen Stress*, (Makassar: Modul MD08 TOT Basic Study Skill Angkatan ke V dan VI, 2008), 3.

⁵⁹Suparto, *Sihat Menjelang Usia Senja*, (Bandung: Rosda, 2003), 244-245.

Qada' dan Qadar dan hal ini menunjukkan kelemahan hati dan kelemahan iman.⁶⁰

Selanjutnya Alloy dalam Kawuryan (2009) menyebutkan tiga jenis stresor yakni, *pertama*; stresor fisik-biologik seperti kondisi dingin, panas, infeksi rasa nyeri dan pukulan, *kedua*; stresor psikologis, seperti perasaan takut, khawatir, cemas, kecewa, kesepian dan jatuh cinta, *ketiga*; stresor sosial budaya, misalnya mengganggu, perceraian dan perselisihan.⁶¹

Bentuk stresor kedua yang disebutkan di atas yakni stresor psikologis selaras dengan pandangan Islam yang menyebutkan bahwa perasaan takut, khawatir dan cemas yang dapat diidentifikasi sebagai gejala kecemasan umum (*general anxiety disorder/GAD*) dapat menyebabkan perasaan negatif dan menimbulkan stres pada seseorang. Ketika seseorang memiliki jiwa yang tidak tenang, hal ini akan berdampak pada pikiran, sehingga seseorang akan dihantui perasaan dan pikiran negatif.⁶²

Berbalik arah dengan keadaan tidak tenang yakni tentram dan tenang, Mujib dan Mudzakir (2002) membagi empat kondisi mental yang tentram dan tenang berdasarkan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an diantaranya: (a) Mampu menghadapi perubahan dan persoalan zaman. Jika terkena musibah diserahkan dan dikembalikan kepada Allah. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 156; (b) Mampu bersikap bersahaja dalam menghadapi sesuatu karena sesuatu yang dibenci terkadang memiliki nilai baik, sementara sesuatu yang disenangi memiliki nilai buruk. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 216; (c) Mampu bersabar dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang berat. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an

⁶⁰Muhammad Utsman Najati, *Psikoterapi Menurut al-Qur'an*, (Selangor: Human Enterprise, 1992), 36.

⁶¹Fajar Kawuryan, *Tinjauan Faktor-Faktor Psikologis dan Sosial dalam Memengaruhi Stres*, (Kudus: Mawas, 2009), 3.

⁶²Menurut al-Ghazali kecemasan merupakan penyakit mental yang berada di hati. Ia tumbuh dari jiwa yang tidak sehat. Al-Ghazali mensifati cemas sebagai rasa takut yang dapat menghantar pada keresahan dan perasaan frustrasi dan tertekan. Lih. Che Haslina Abdullah and others, "General Anxiety Disorder (GAD) from Islamic Perspective and Western Perspectives", *World Journal of Islamic History and Civilization*, Vol. 2, No. 1, (2012); 44-52.

surah al- Baqarah ayat 155; (d) Optimis menganggap baik dalam menempuh kehidupan karena setelah kesulitan akan datang kemudahan. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surah al-Insyirah ayat 5.⁶³

Selain tiga bentuk stresor di atas (fisik-biologik, psikologis, dan sosial budaya) terdapat pula bentuk stresor lainnya yakni stresor akademik. Stresor akademik muncul saat berlangsung proses pendidikan di kampus. Penyebab stres mahasiswa kedokteran berbeda antara satu individu dengan yang lain. Faktor yang dapat menyebabkan stres mahasiswa kedokteran menurut Margareth et (2015) terbagi pada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal berasal dari dalam diri individu mahasiswa sendiri seperti kondisi fisik, motivasi, dan tipe kepribadian mahasiswa. Adapun faktor eksternal biasanya berasal dari luar individu seperti keluarga, pekerjaan, fasilitas, lingkungan, dosen dan lain-lain.⁶⁴ Namun demikian mayoritas penyebab utama stres mahasiswa kedokteran adalah dikarenakan tuntutan akademik itu sendiri dibandingkan permasalahan pribadi mahasiswa.⁶⁵

Diantara *top teen* stresor yang berhubungan dengan akademik adalah test dan ujian, materi yang banyak, kurangnya waktu mengulang materi, kurang nilai, ekspektasi diri untuk mendapatkan nilai baik, skil yang tidak memadai untuk mengikuti praktik kedok-

⁶³ Artinya:“(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun" (QS. Al-Baqarah: 156). “Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (QS.al-Baqarah: 216). “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar” (QS. Al- Baqarah: 155). “Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah:5). Lih Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, 139-140.

⁶⁴Margaret Sutjiato, G.D. Kandou, dan A.A. T.Tucuman, “Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Tingkat Stress pada Mahasiswa Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, *JIKMU*, Vol. 5, No. 1, (2015); 30-42.

⁶⁵Elspeth Guthrie, and others, “Embarking upon a Medical Career: Psychological Morbidity in First Year Medical Students”, *Medical Education Joutnal*, (1995); 337-341

teran, tugas yang sulit, tidak cukup waktu untuk membaca, kesulitan memahami pelajaran, dan tidak mampu menjawab pertanyaan dosen.⁶⁶

Selanjutnya para peneliti juga menyebutkan faktor penyebab stres di kalangan mahasiswa kedokteran berbeda sesuai dengan tingkatan dan lamanya tahun belajar, faktor yang berhubungan dengan banyaknya materi studi, persepsi kemampuan diri dan tuntutan hasil banyak dialami mahasiswa tahun-tahun pertama. Pada periode belajar berikutnya sumber stres berasal dari praktik latihan ilmu kedokteran itu sendiri seperti berhubungan dengan pasien, penyakit dan kematian, hubungan dengan konsultan dan masalah pribadi lainnya.⁶⁷

Adapun Radman et al (2010) menyebutkan beberapa stresor yang sangat signifikan berhubungan dengan stres mahasiswa kedokteran diantaranya adalah kekhawatiran akan masa depan, kesulitan finansial, proses belajar, konflik interpersonal, masalah keluarga, rendah konsep diri, konflik dengan teman sekamar, kurangnya dukungan keluarga dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, jauh dari keluarga, perubahan kebiasaan makan dan tidur serta lain sebagainya.⁶⁸

Selanjutnya Yusuf et al (2010) secara khusus mengelompokkan stresor yang dihadapi mahasiswa kedokteran pada enam kategori: (1) *academic related stressors* (ARS)/stresor akademik, (2) *intrapersonal and interpersonal related stressors* (IRS)/stresor intrapersonal dan interpersonal, (3) *teaching and learning related stressors* (TLRS)/stresor belajar dan mengajar, (4) *social related stressors* (SRS)/stresor sosial, (5) *drive and desire related stressors* (DRS)/stresor hasrat dan keinginan, (6) *group activities related stressors* (GARS)/stresor aktifitas kelompok, selanjutnya keenam kategori

⁶⁶Muhamad Saiful Bahri Yusoff, and others, "A Study on Stress, Stressors, and Coping Strategies among Malaysian Medical Students", *International Journal of Students Research*, Vol. 1, No. 2, (2011); 45-50.

⁶⁷Sunita M. Stewart, and others, "Predicting Stress in First Year Medical Students: a Longitudinal Study", *Medical Education*, Vol. 31, No.3, (1997); 163-168.

⁶⁸Sami Abdo Radman al-Dubai, and others, "Stress and Coping Strategies of Students in Medical Students", *Malaysian Journal Medical Science*, Vol. 18, No. 3, (2011); 57-64.

sumber stres ini dideskripsikan secara jelas melalui tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1. Stresor Stres Mahasiswa Kedokteran⁶⁹

No	Stresor
1	Ujian
2	Berbicara dengan pasien tentang problem pribadi
3	Konflik dengan mahasiswa lain
4	Sistem Ujian
5	Makian verbal atau fisik dari mahasiswa lainnya
6	Harapan orang tua
7	Harapan diri (melakukan hal terbaik)
8	Materi yang tidak memadai
9	Konflik dengan personal
10	Tugas yang berat
11	Partisipasi pada diskusi kelas
12	Tidak Cukup Waktu membaca
13	Partisipasi pada presentasi kelas
14	Kurangnya bimbingan dosen
15	Merasa tidak mampu
16	Merasa tidak yakin akan harapan diri
17	Tidak cukup skill dalam praktik kedokteran
18	Kurang waktu bersama keluarga dan teman
19	Banyak persaingan dalam hasil belajar
20	Dosen – Kurang keahlian mengajar
21	Tidak mampu menjawab pertanyaan pasien

⁶⁹Stresor akademik berhubungan dengan segala hal terkait dengan sekolah, universitas, pendidikan atau kegiatan kemahasiswaan yang menyebabkan stres pada mahasiswa. Stresor interpersonal dan intrapersonal adalah segala hubungan yang terkait dengan diri sendiri atau pun dengan orang lain. Stresor sosial merujuk pada segala hubungan komunitas dan sosial yang menyebabkan stres. Stresor hasrat dan keinginan merujuk kepada pendorong eksternal dan internal yang memengaruhi sikap seseorang, emosi, pikiran, dan perbuatan yang dapat menyebabkan stres. Dan stresor aktifitas kelompok berhubungan dengan beberapa kegiatan kelompok dan gangguannya yang menyebabkan stres. Lih Muhammad Saiful Bahri Yusoff and others, "The Development and Validity of the Medical Student Stressor Questionnaire (MSSQ)", *ASEAN Journal of Psychiatry*, Vol. 11, No. 1, (2010); 1-12.

22	Tugas yang tidak sesuai
23	Memiliki kesulitan memahami materi
24	Menghadapi penyakit atau kematian pasien
25	Mendapatkan nilai yang buruk
26	Kurang motivasi belajar
27	Kurang waktu mengulang materi pelajaran
28	Celaan verbal ataupun fisik dari dosen
29	Mendapatkan gangguan tugas studi dari teman
30	Tidak mampu menjawab pertanyaan dosen
31	Konflik dengan dosen
32	Tidak memiliki keinginan untuk studi kedokteran
33	Materi yang banyak untuk dipelajari
34	Harus melakukan hal lebih karena paksaan orang lain
35	Tidak cukup <i>feedback</i> / umpan balasan dosen
36	Proses penilaian yang tidak fair
37	Kurang penghargaan atas tugas yang dikerjakan
38	Terlalu sering berhadapan dengan komputer
39	Celaan verbal maupun fisik dari seseorang
40	Tanggungjawab keluarga

Beberapa studi lainnya yang berupaya mengidentifikasi sumber-sumber stres mahasiswa kedokteran. Secara umum terdapat tiga area utama stresor mahasiswa: tekanan akademik, permasalahan sosial, dan masalah finansial biaya pendidikan dokter.⁷⁰ Dari begitu banyak faktor yang memengaruhi stres sebagaimana diungkapkan oleh para peneliti di atas kemungkinan akan terjadi sinergi antara satu stresor dengan stresor lainnya. Seorang mahasiswa yang mengalami stres akibat stresor akademik, kemungkinan dalam waktu yang bersamaan juga menghadapi stresor sosial atau stresor lainnya. Semakin variasi stresor yang dihadapi secara bersamaan akan memengaruhi kemampuan resistansi diri terhadap stres.

5. Indikasi Stres: Fisio, Psiko, dan Behavior

Individu yang mengalami stres akan menunjukkan perilaku yang berbeda dengan mereka yang tidak mengalami stres, karena

⁷⁰ Ajay T Shendarkar dan Vijay Patil, "A Study of Stressors in Medical College Students (Hostelities) in Northern Maharashtra", *Journal India Acad Forensic Med*, Vol.35, No. 5, (2013); 227-229.

stres dapat menghasilkan berbagai respon. Beberapa penelitian menyebutkan respon-respon tersebut dapat berguna sebagai indikator terjadinya stres pada individu sekaligus mengukur tingkat stres yang dialami. Sehingga demikian, kondisi individu yang mengalami stres dapat dilihat baik secara biologis, psikologis dan behavioral.⁷¹

a. Gejala Biologis/Fisiologis

Hawari (2001) mendeskripsikan secara jelas perubahan fisiologis yang dialami individu yang mengalami stres sebagai berikut:

Diantara perubahan fisiologis yang terjadi yakni perubahan pada rambut, warna rambut yang semula berwarna hitam pekat, perlahan mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan serta kusam, ubanan sebelum waktunya disertai juga kerontokan rambut. Perubahan pada mata, penglihatan menjadi kabur, hal ini disebabkan karena otot-otot bola mata mengalami kekenduran yang memengaruhi lensa mata. Perubahan pada telinga, pendengaran menjadi terganggu dengan suara berdenging. Perubahan daya pikir, Kemampuan untuk mengingat serta konsentrasi menurun dan mengeluh sakit kepala. Perubahan ekspresi wajah, nampak tegang, dahi berkerut, mimik nampak serius, tidak santai, bicara berat, sukar untuk senyum, dan kulit muka kedutan (*tic facial*). Perubahan pada mulut, terasa kering tenggorokan seolah ada yang mengganjal dimana hal ini disebabkan oleh otot-otot tenggorokan mengali spasme (*muscle cramps*) merasa tercekik. Perubahan pada kulit, reaksi kulit bermacam-macam seperti kulit menjadi kering, munculnya penyakit kulit secara berlebihan. Perubahan sistem pernafasan, nafas terasa berat dan sesak dan sesak disebabkan terjadi penyempitan pada saluran pernafasan.

⁷¹Perubahan fisik meliputi otot, tekanan darah, sakit kepala, sakit perut, sulit tidur, masalah makan, dan kurang energi. Adapun perubahan emosi meliputi gelisah, cemas, kurang antusias terhadap sesuatu yang awalnya digemari, marah, bermusuhan dengan teman, malu atau menarik diri, merasa tidak berdaya, dan putus asa. Sementara perubahan behavioral meliputi gangguan kebiasaan makan, dan terlalu banyak naik atau turun berat badan dalam waktu yang singkat. Mary Terzian and others, *Assessing Stress in Children and Youth: A Guide for Out-Of-School Time Program Practitioners*, Brief Research To Results Child Trends, (2010), 2.

san. Perubahan sistem kardiovaskuler, terganggunya sistem jantung dan pembuluh darah, jantung berdebar, pembuluh darah melebar (*dilatation*) atau menyempit (*constriction*) sehingga seseorang mukanya tampak pucat. Perubahan sistem pencernaan, lambung terasa kembung, mual dan pedih, hal ini disebabkan karena asam lambung yang berlebihan (*hyper-acidity*). Perubahan sistem perkemihan, frekuensi untuk buang air kecil lebih sering dari biasanya meskipun bukan penderita kencing manis. Perubahan sistem otot dan tulang, mengeluhkan otot-otot yang terasa sakit seperti ditusuk-tusuk pegal dan tegang. Perubahan sistem endoktrin atau hormonal, kadar gula meninggi dan bila berlanjut mengakibatkan menderita penyakit diabetes. Perubahan libido, gairah seseorang di bidang seksual menurun atau sebaliknya meningkat tidak sebagaimana biasanya.⁷²

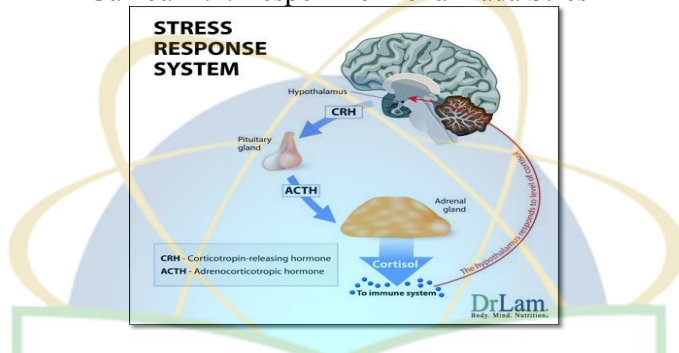
Tubuh bereaksi terhadap stresor yang dijumpai, jika ancaman dapat dipecahkan dengan cepat maka reaksi biologis lanjutan dapat dihindari dan fungsi fisiologis lainnya akan kembali normal. Namun jika situasi stres terus terjadi, timbul respon internal supaya beradaptasi. Selye dalam Sumiati (2010) menyebutkan tiga tahap reaksi fisiologis terhadap stresor yang diperoleh secara terus-menerus yang kemudian dikenal dengan istilah *General Adaptation Syndrome* (GAS) diantaranya adalah: 1) *alarm reaction*, 2) *Stage of Resistance*, 3) *Stage of Exhaustion*.⁷³

⁷²Dadang Hawari, *Manajemen Stress, Cemas, dan Depresi*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001), 37-43.

⁷³GAS merupakan respon fisiologis dari seluruh tubuh terhadap stres, terdiri dari fase 1) *Alarm Reaction* (waspada), tahap pertama ini melibatkan mekanisme pertahanan dari tubuh seperti pengaktifan hormon yang berakibat meningkatnya volume darah dan akhirnya menyiapkan individu untuk bereaksi. Hormon lainnya dilepas untuk meningkatkan kadar gula darah yang bertujuan untuk menyiapkan energi untuk keperluan adaptasi, kemudian epinefrin dan norepinefrin aktif dan mengakibatkan denyut jantung meningkat dan terjadi peningkatan aliran darah ke otot. Peningkatan oksigen dan meningkatnya kewaspadaan mental. Aktivitas hormonal ini menyiapkan individu untuk “respon melawan atau menghindari”, respon ini berlangsung dalam menit sampai jam, bila stresor masih menetap maka individu akan masuk ke fase selanjutnya. 2) *Stage of resistance* (melawan), pada fase ini individu masih terus melawan, tubuh berusaha menyeimbangkan

Selanjutnya dalam dunia kesehatan gejala fisiologis terhadap stres juga dapat diagnosis dengan melihat respon hormonal. Stres akan merangsang hipotalamus untuk menghasilkan *corticotrophic-releasing hormone* (CRH) yang menyebabkan pelepasan *adreno corticotroprin hormone* (ACTH). Pelepasan ACTH akan menimbulkan perangsangan korteks adrenal dan pada akhirnya dilepaskan kortisol.⁷⁴ Adapun mekanisme pelepasan hormon kortisol ini sebagaimana digambarkan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1. Respon Hormonal Pada Stres⁷⁵



kondisi fisiologis sebelumnya, gejala stres menurun ketika tubuh kembali stabil bila denyut jantung, termasuk hormon, tekanan darah, dan lain-lain kembali normal. Individu berupaya beradaptasi dengan stresor jika ini berhasil tubuh akan memperbaiki sel-sel yang rusak, dan bila gagal individu akan jatuh kepada tahap terakhir. 3) *Stage of exhaustion* (kelelahan), fase perpanjangan stres belum dapat tertanggulangi timbul gejala penyesuaian diri terhadap lingkungan seperti sakit kepala, gangguan mental, penyakit arteri koroner dan lain-lain sehingga terjadi kelelahan ketika hal ini terus terjadi menyebabkan kerusakan fisiologis dan dapat menyebabkan kematian. Sumi-ati, dkk, *Penanganan Stres*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), 75-79.

⁷⁴Kortisol disebut sebagai salah satu hormon stres yang berfungsi sebagai metabolisme karbohidrat, pertukaran protein, pembagian lemak serta pemeliharaan keseimbangan mineral tubuh dan air. Termasuk turut membantu fungsi sistem kerja jantung, pembuluh darah, sistem saraf otot, ginjal dan organ tubuh lain. Syarif Indra dan Syarif Isran, *Kepribadian dan Pola Hidup Adalah Sumber Penyakit Sekaligus Obat*, (Bekasi: Brain Health Service BHS, 2011), 34.

⁷⁵Michael Lam, *Adrenal Fatigue & Adrenal Support*, diakses melalui https://www.drlam.com/articles/adrenal_fatigue.asp pada tanggal 01 April 2016 jam 10.45 WIB.

Sebenarnya hormon-hormon dalam tubuh bekerja dengan sangat seimbang. Jumlah yang tepat dari setiap hormon akan menghasilkan hal yang positif, termasuk hormon Kortisol yang dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi bila jumlah hormon ini dikeluarkan secara berlebihan karena tekanan yang berlangsung lama dapat menyebabkan kadar gula darah dan insulin meningkatkan dan juga terus menekan kadar adrenalin, sementara adrenalin yang tinggi serta berkepanjangan dapat meningkatkan detak jantung, tekanan darah tinggi, dan penimbunan kolesterol. Dimana semua ini adalah keadaan yang tidak baik dan secara potensial dapat mematikan. Selanjutnya respon fisiologis terhadap stres yang mengakibatkan keluhan fisik dapat memengaruhi mental dan emosional, hal ini yang kemudian disebut dengan respon psikologis.

b. Gejala Psikologis

Emosi merupakan reaksi psikologis yang sangat terkait dengan stres. Reaksi emosional terhadap stres yaitu rasa takut, *phobia*, kecemasan, depresi, perasaan sedih dan marah.⁷⁶ Sukadiyanto (2010) menjelaskan secara psikologis individu yang mengalami stres, antara lain ditandai oleh: perasaan selalu gugup dan cemas, peka dan mudah tersinggung, gelisah, kelelahan yang hebat, enggan melakukan kegiatan, kemampuan kerja dan penampilan menurun, perasaan takut, pemusatan diri yang berlebihan, hilangnya spontanitas, mengasingkan diri dari kelompok dan *phobia*.⁷⁷

Termasuk diantara gejala psikologis juga selain emosi adalah kognisi, yakni dapat terlihat lewat terganggunya proses kognitif individu. Hardjana (2010) menyebutnya dengan istilah gejala intelektual yang antara lain adalah sulit membuat keputusan, pikiran menja-di kacau, menurunnya daya konsentrasi, pikiran berulang dan pikiran yang tidak wajar.⁷⁸

⁷⁶Edward P. Sarafino, *Health Psychology 2nd Edition*, (New York: John Wiley and Sons, 1994), 124.

⁷⁷Sukadiyanto, "Stress dan Cara Mengurangnya", *Cakrawal Pendidikan*, Vol.29, No. 1, (2010); 55-67.

⁷⁸Hardjana dalam Dika Christyanti dkk, "Hubungan antara Penyesuaian Diri terhadap Tuntutan Akademik dengan Kecenderungan Stres Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya", *Journal Insan*, Vol.12, No. 3, (2010), 153-159.

Individu yang mengalami stres perasaannya menjadi gelisah sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dengan lingkungan dan orang lain, hal ini disebut juga dengan indikasi psikologis-interpersonal, yakni mudah mempersalahkan orang lain dan tidak peduli dengan orang lain. Setiap hal yang ada disekitarnya dirasakan selalu mengawasi individu tersebut padahal semuanya berjalan biasa, normal dan lancar. Kemudian selanjutnya individu dengan gejala psikologis stres juga sering merasakan ketakutan yang berlebihan, sehingga terkadang ketakutan tersebut terbawa di alam mimpi yang menyebarkan sehingga saat tidur mestinya individu tersebut merasa segar, tetapi efek mimpi tersebut justru membuat dirinya merasa lelah.⁷⁹

Adapun indikasi stres psikologis lainnya adalah ketika individu seringkali merasakan gugup dan cemas ketika menghadapi permasalahan, seperti saat akan ujian atau menghadapi pimpinan. Selain itu individu yang mengalami stres juga cenderung kehilangan spontanitas dan keceriaan, sehingga tidak gembira dalam menghadapi situasi lingkungan. Ada muncul perasaan takut, bersalah, dan tidak bermanfaat bagi orang lain.

Pengalaman stres secara psikologis yang dialami seseorang tidak semestinya dianggap stres oleh orang lain, demikian pula gejala-gejala dan tanda stres akan berbeda setiap individu, hal ini disebabkan kemungkinan terjadi perbedaan mekanisme variabel psikologik yang memengaruhi respon stres yang dihadapi, diantara adalah: 1) Kontrol; keyakinan bahwa seseorang memiliki kontrol terhadap stresor akan mengurangi intensitas respon stres, 2) Prediktibilitas; stresor yang dapat diprediksi menimbulkan respon stres yang tidak begitu berat dibandingkan stresor yang tidak diprediksi, 3) Persepsi; pandangan individu tentang stresor yang dihadapi akan meningkatkan atau mengurangi respon stres, 4) Respon koping; ketersediaan dan efektivitas mekanisme mengikat ansietas dapat menambah atau menurunkan respon stres.⁸⁰

⁷⁹Grete Waitz, Sigmund Strome, Willi S.Railo, *Conquer Stress With Grete Waitz*, terjemahan Sinta A.W., (Bandung: Angkas, 2003), 41-50.

⁸⁰Aat Sariati, *Tinjauan Tentang Stres*, (Jatinangor: Fakultas Keperawatan Universitas Padjajaran, 2002), 28.

Pengaruh atas keempat variabel psikologik ini kemudian dapat mengklasifikasikan tingkat stres. Setiadi (2007) menyebutkan tiga tingkat stres yakni; 1) ringan; pada tingkat ini stres seringkali terjadi pada kehidupan sehari-hari dan kondisi dapat membantu individu menjadi waspada dan mampu mencegah berbagai kemungkinan yang dihadapi. 2) Stres sedang; pada tingkat stres ini individu lebih memfokuskan hal penting saat ini dan mengenyampingkan yang lain sehingga mempersempit lahan persepsinya, dan 3) Stres berat; pada tingkat ini lahan persepsi individu sangat menurun dan cenderung memusatkan perhatian pada hal-hal lain, semua perilaku ditujukan untuk mengurangi stres, individu tersebut mencoba memusatkan perhatian pada lahan lain dan memerlukan banyak pengarahan.⁸¹

c. Gejala Behavior

Stres dapat mengubah perilaku seseorang terhadap orang lain, situasi dan keadaan yang sedang dihadapi. Akibat stres yang dihadapi individu bisa berperilaku positif seperti belajar lebih giat karena tugas yang didapati cukup sulit, maupun negatif seperti stres yang diikuti rasa marah dapat menimbulkan perilaku sosial negatif bahkan dapat menimbulkan perilaku agresif. Individu yang mengalami stres dan mengalami perasaan gelisah dapat mewujudkan gejala perilaku dengan berjalan mondar-mandir tanpa tujuan yang jelas. Selain dari pada itu individu yang mengalami stres akan menunjukkan perilaku keadaan yang sangat lelah, sehingga enggan untuk melakukan berbagai kegiatan fisik, selanjutnya perilakunya menjadi lamban, kemampuan kerja dan penampilan juga menurun.⁸²

Gejala-gejala perilaku lainnya yang teramati pada individu yang mengalami stres adalah menunda, menghindari pekerjaan, absen dari kelas dan kerja, menurun prestasi dan produktivitas diri, meningkatnya kebiasaan minum alkohol, meningkatnya agresivitas, vandalisme, dan kriminalitas, bahkan mengurangi intensitas komunikasi dan hubungan dengan orang terdekat seperti keluarga, teman dan masyarakat luas. Selanjutnya Arora (2008) menyebutkan gejala peri-

⁸¹Setiadi, *Konsep dan Penulisan Riset Keperawatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 38.

⁸²Sukadiyanto, "Stress dan Cara Mengurangnya", *Cakrawal Pendidikan*, Vol.29, No. 1, (2010), 55-67.

laku orang stres diantaranya adalah: makan berlebihan, tidur berlebihan, kehilangan nafsu makan, marah, merokok.⁸³

B. Spiritualitas dan Regulasi Diri Belajar: Mengubah *Distress* Menjadi *Eustress*

1. Konstruksi Spiritualitas: Sintesis Barat dan Islam

Menurut perspektif bahasa “*spiritualitas*” berasal dari bahasa Latin “*spiritus*” yang berarti roh, jiwa, dan semangat. Dari kata Latin ini terbentuklah kata “*I’spirit*” dari bahasa Perancis dengan kata bendanya “*la spiritualite*”. Dari bahasa Perancis kita mengenal kata ini dalam bahasa Inggris yakni “*spirituality*” yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata “*spiritualitas*”.⁸⁴ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia spiritualitas adalah sesuatu yang hidup yang tak berbadan jasmani.⁸⁵ Menurut Simpson dan Weiner (1991) bahwasanya Kamus Bahasa Inggris Oxford menawarkan setidaknya dua definisi spiritualitas, *pertama*: spiritualitas merujuk pada aspek terpenting bagi hidup seseorang yang dalam bahasa Latin diartikan dengan “nafas”, *kedua*: spiritualitas dimaknai sebagai fitur subjektif dalam hidup sebagaimana perasaan seperti pendengaran dan penglihatan. Dimana fungsi perasa ini sangat penting bagi kehidupan, maka begitupula fungsi spiritualitas dalam hidup.⁸⁶

Sementara dalam bahasa Arab spiritualitas ekuivalen dengan *al-ruḥīyah* atau *al-ruḥānīyah*,⁸⁷ yakni kata yang diambil dari kata *al-ruh*. Dimana ruh merupakan fungsi gerak utama dalam kehidupan manusia yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidupnya. Sebagaimana Abū al-‘Abbas menjelaskan ruh merupakan esensi yang

⁸³ Anjali Arora, *5 Langkah Mencegah dan Mengatasi Stres*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), 9.

⁸⁴ Agus M. Hardjana, *Religiositas, Agama dan Spiritualitas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 64.

⁸⁵ W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 963.

⁸⁶ Simpson dan Weiner (1991) dalam Hena Jawaid, “Impact of Religion/Spirituality on Health: What are the Evidences?”, *African Journal of Psychiatry*, Vol. 17, No. 6, (2014); 1-5.

⁸⁷ ATA Software, *Barnamij al- Wafī al-Dhahabī li al- Tarjamah al-‘Arabiyah al- Furiyah*, ATA Software Technology, London, (2002).

menyebabkan jasad menjadi hidup, menurutnya ruh juga dapat diartikan para malaikat ataupun Jibril. Hal ini selaras dengan penjelasan Ibn Shamīl yang menyebutkan bahwa *al-ruhiyah* adalah esensi non-fisik (*laisat laha ajsam*) sebagaimana para malaikat.

Muhammad Husain Abdullah dalam bukunya “*Mafāhim Islāmīyah*” mendefinisikan *al-ruhaniyah* sebagai *idrak šillah billah* (kesadaran berhubungan dengan Allah SWT). Hidup dengan spiritualitas yang tinggi berarti sebuah kehidupan yang berada dalam kondisi iman yang baik (*jawwu iman*).⁸⁸ Sementara itu Ibn al-Muzaffar menjelaskan bahwa *al-ruh* yang merupakan kata dasar dari *al-ruhiyah* adalah sesuatu yang ditiupkan Allah, sesuatu yang lembut (*al-laṭifah*) dan tidak dapat dijangkau dengan penglihatan (*lā yudrikuha al-abṣar*).⁸⁹

Pembahasan tentang ruh karena bersifat imateri maka menjadi sulit dan pelik.⁹⁰ Sifatnya yang abstrak dan tidak mudah dilihat menjadi sulit bagi para ahli untuk bersepakat dalam mendefinisikan-

⁸⁸ Muhammad Husain Abdullah, *Mafāhim Islāmīyah*, terj. M. Romli, (Bangil: Al-Izzah, 2002), 35.

⁸⁹ Ibn Manẓūr dalam Ahmad Rusdi, *Kecemasan dan Psikoterapi Islam. Dari Spiritual Disorder hingga Persoalan Eksistensial Menuju Kesehatan Psiko-Spiritual*, (Disertasi UIN Pasca Sarjana: 2014), 50.

⁹⁰ Menurut Abuddin Nata meskipun ruh sulit dan pelik untuk dipahami, namun agar tidak menimbulkan dampak pertikaian dan perpecahan, maka diperlukan adanya pandangan dan sikap sebagai berikut: *Pertama*, kesulitan memahami ruh karena bersifat imaterial, sedangkan manusia yang mencoba memahaminya bersifat materi. Untuk itu upaya memahami ruh juga harus bersifat imaterial juga. *Kedua*, luasnya pengertian ruh sama sekali tidak akan membingungkan apabila manusia mencoba memahami ruh dalam konteks yang tepat. Sehingga dibutuhkan pemahaman yang tepat terhadap ayat-ayat al-Qur'an. *Ketiga*, ketidakmampuan manusia memahami ruh secara utuh, jelas dan *integrated* harus menimbulkan kesadaran bahwa ilmu manusia sangat terbatas dan sangat sedikit. *Kempat*, ketika seseorang dapat menangkap makna ruh berdasarkan penalarannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an maka hendaknya tidak menutup diri dari pendapat orang lain dan tidak menganggap pandangannya paling benar. *Kelima*, Kemampuan manusia menangkap makna ruh juga harus menyadarkan dirinya bahwa di dalam diri manusia terdapat sebuah potensi misterius di mana diri sendiri tidak sanggup memahaminya. Lih. Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Pendidikan Kedokteran*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2016), 106-107.

nya. Di dalam al- Qur'an misalnya, kita diingatkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Isra' ayat 85:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya:

"dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". (Al-Isra': 85)

Terkait dengan ayat di atas Musa Asy'ari berkomentar bahwa persoalan ruh sangat pelik sehingga memunculkan anggapan pada sebagian orang bahwa ruh tidak perlu dipelajari karena dirasa membingungkan. Namun pada sebagian lagi ruh dianggap penting untuk dipelajari karena fungsinya yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bukankah sesuatu yang penting harus diketahui?. Sehingga menurutnya pengetahuan tentang ruh tidak bisa disamakan dengan pengetahuan manusia tentang jasad. Pengetahuan tentang ruh bersifat spiritual karena berhubungan dengan medan imaterial.⁹¹

Menurut M. Quraish Shihab, bahwa antara manusia dengan makhluk lain seperti tumbuhan dan hewan bisa sama-sama memiliki *nafs* (soul/jiwa)⁹², namun demikian hadirnya ruh menjadikan manusia makhluk yang unik dan istimewa dan berbeda dengan makhluk lainnya.⁹³ Ekuivalensi spiritualitas dengan *al- Ruhīyah* ditegaskan oleh Baharuddin dalam bukunya "Paradigma Psikologi Islami",

⁹¹Musa Asy'ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al- Qur'an*, cet-1, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992), hal. 70.

⁹²Terkait pembahasan *nafs*, Ibnu Sina menjelaskan ada tiga jenis *nafs*. Pertama, jiwa tumbuhan (*an- nafs an-nabatiyah*), jiwa jenis ini memiliki tiga daya yaitu daya makan (*al-gaziyah*), daya tumbuh (*al-munmiyah*), daya membiak (*al-muwalidah*). Kedua, jiwa binatang (*an-nafs al-hayawaniyah*) yang memiliki dua daya yaitu daya penggerak (*al-muharikah*), dan daya instink/persepsi (idrak). Ketiga, jiwa manusia (*an-nafs al-insaniyah*) yang memiliki daya berpikir (*an-natiqah/al-'aql*). Tumbuhan hanya memiliki daya jiwa tumbuhan, sementara hewan memiliki daya jiwa hewani dan tumbuhan. Sementara manusia memiliki semua daya pada ketiga jenis jiwa ini. Lih. Ibnu Sina, *An-Najāt*, (Kairo: Mustafā al- Babi al-Halabi, 1988), 158.

⁹³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an – Tafsir Maudu'ī atas Pelbagai Permasalahan Umat*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 293.

menurutnya manusia memiliki dimensi spiritualitas, yakni sisi jiwa yang memiliki sifat-sifat *ilahiyah* (ketuhanan) dan memiliki daya untuk menarik dan mendorong sifat-sifat Tuhan dalam dirinya. Pemilikan sifat-sifat Tuhan bermakna memiliki potensi-potensi luhur batiniah. Potensi-potensi itu melekat pada dimensi-dimensi psikis manusia dan memerlukan aktualisasi.⁹⁴ Dengan demikian dapat

⁹⁴Dalam bukunya Baharudin menyebutkan beberapa istilah yang digunakan Al-Qur'an dalam menjelaskan aspek psikis manusia diantaranya; *nafs*, *al-'aql* dan *qalb* serta *al-ruh*. *Al-Nafs* merupakan elemen dasar psikis manusia. Salah satu karakteristik yang ditampilkan oleh *al-nafs* adalah fungsinya mewadahi atau menampung dimensi-dimensi jiwa lainnya. *Al-nafs* karena kebesarannya mampu mewadahi dimensi-dimensi lainnya seperti *al'aql*, *al-qalb*, *al-ruh*. Secara esensial *al-nafs* juga mewadahi potensi-potensi dari masing-masing dimensi psikis berupa *taqwa* (potensi positif), maupun potensi *fujur* (potensi negatif). *Al-'Aql* dan *Qalb* merupakan dimensi *insaniyah* psikis manusia. *Al-'Aql* merupakan potensi untuk membedakan antara yang *haq* dan *batil*. Akal bukanlah otak sebagai salah satu organ tubuh, tetapi daya pikir. Dengan demikian akal menjadi potensi gaib yang tidak dimiliki oleh setaip makhluk yang memiliki otak. Dalam al-Qur'an tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan *al-'aql* dalam kata benda (*isim*) semua diungkapkan dalam bentuk kata kerja (*fi'il*). Hal ini menunjukkan bahwa akal bukanlah suatu substansi (*jauhar*) melainkan aktivitas dari suatu substansi. Sehingga muncul pertanyaan apakah substansi yang berakal tersebut?. Para ahli berbeda pendapat tentang apakah kalbu atau otak yang berakal. Al-Ghazali menyatakan bahwa yang berakal adalah *qalb*, hal ini didasari pada beberapa surah di Al-Qur'an diantaranya surat al-Hajj: 46, Al-A'raf: 179 dan Qaf: 37. Sementara Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa yang berakal adalah akal. Dengan demikian baik akal maupun kalbu keduanya memiliki potensi berakal/berpikir. Namun demikian *al-'aql* lebih menekankan sisi rasional-empiris atau realitas konkrit yang menggunakan kekuatan pikir. Sementara itu *al-qalb* menekankan sisi rasional dan emosional, ia menggunakan daya zikir dalam proses pemahaman terhadap ayat-ayat Allah dan dengan itu manusia mampu memahami realitas spiritual. Dalam al-Qur'an istilah *al-qalb* seringkali disebutkan dengan beberapa istilah lainnya, seperti disebut *sadr*, karena *al-qalb* merupakan tempat terbitnya cahaya iman dan Islam (QS. Az-Zumar: 22), disebut *fu'ad*, karena *al-qalb* menjadi tempat terbitnya *ma'rifah* kepada Allah (QS. An-Najm: 11-15), disebut dengan *al-Lub*, karena *al-qalb* tempat terbitnya tauhid (QS. At-Talaq: 10), dan disebut dengan *as-syagaf*, karena *al-qalb* tempat munculnya kecintaan terhadap sesama manusia (QS. Yusuf: 30). *Selanjutnya* kata yang digunakan al-Qur'an dalam menjelaskan dimensi manusia adalah *al-ruh*. *Al-Ruh* merupakan

dipahami bahwa spiritualitas merupakan entitas ruhani karena ia bersifat non-fisik, immateri dan metafisik, serta memiliki kedekatan dengan Tuhan.

Selanjutnya pada kajian psikologis pemaknaan kata spiritualitas dikaitkan dengan salah satu bentuk kecerdasan manusia sehingga menjadi kata majemuk “kecerdasan spiritual”. Kecerdasan adalah kemampuan mempelajari sesuatu, kemampuan menangani situasi-situasi baru.⁹⁵ Kecerdasan menurut Ali bin Abi Thalib merupakan karunia tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia.⁹⁶ Pada awalnya kecerdasan ini hanya dihubungkan dengan akal (intelektual) akan tetapi kecerdasan intelektual ternyata belum cukup untuk menjamin ketetapan keputusan, sehingga dewasa ini orang mulai membicarakan tentang kecerdasan lain yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.⁹⁷

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa. Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan makna, tujuan dan nilai-nilai kehidupan. Dimana menurut Mujib dan Mudzakir (2002) kecerdasan spiritual ini meliputi hasrat untuk bermakna (*the will to meaning*) yang memotivasi kehidupan manusia untuk senantiasa mencari makna hidup (*the meaning of life*) dan mendambakan hidup bermakna (*the meaningful life*).⁹⁸

potensialitas internal dalam diri manusia yang akan terwujud secara aktual sebagai *khalifah* Allah. Dengan dimensi *al-ruh* manusia menjadi makhluk yang istimewa dan unik yang berbeda dengan makhluk lainnya yang sama-sama juga memiliki *nafs*. Dengan terciptanya fisik manusia, maka dengan sendirinya akan tercipta kehidupannya. Pada tahap ini *nafs* belum memiliki *al-ruh*, *al-‘aql* dan *al-qalb*. Setelah *an-nafs* manusia menerima *al-ruh*, maka *nafs* tersebut siap menerima daya *sam‘un* (mendengar), *abṣar* (melihat) dan *af‘idah* (hati) yang kesemuannya fungsi indera ini menjadi sarana bagi *aql* dan *qalb* untuk memperoleh pengertian dan pemahaman. Lih. Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 64-146.

⁹⁵Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, (Bandung: CV. Pionir jay, 2000), 233.

⁹⁶Suharsono, *Melejitkan IQ, IE, IS*, (Depok: Insiasi Press, 2005), 160.

⁹⁷Ahmad Mubarak, *Psikologi Qurani*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 71.

⁹⁸Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islami*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 325.

Menurut Kertawirian (2004) pada hakikatnya pada setiap diri manusia ada sifat Tuhan padanya, bila otak kiri berfikir tentang rasionalitas, maka ada Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Kokoh, Maha Pemberi Petunjuk atas rasionalitas. Bila otak kanan berfikir tentang emosioanalitas, maka ada yang Maha Penyayang, Maha Pemaaf, Maha Pembalas. Sehingga kemanapun otak berpikir, bila kita mau merenung tentang makna kehidupan, maka disanalah selalu ada nilai Maha. Sekali kita berfikir tentang nilai Maha, maka seluruh bagian otak (kiri dan kanan) akan merasa tersentuh, dan seluruh bagian kalbu akan bergetar.⁹⁹ Dengan demikian kecerdasan spiritual merupakan pangkal yang melandasi kecerdasan-kecerdasan lainnya dimana antara kecerdasan satu dengan kecerdasan lainnya akan saling terhubung dan saling mengisi.

Selanjutnya para ahli berbeda pandangan dalam memaknai spiritualitas secara terminologi. Dimana penggunaan istilah spiritualitas seringkali digunakan secara bergantian (*interchangeably*) atau diartikan sama dengan istilah religiusitas, menurut Fuller (2001) kedua kata ini dianggap sama sebelum abad 21, namun kemudian terjadi diskusi panjang diantara para ahli untuk mendefinisikan serta membedakan kedua kata ini¹⁰⁰. Religiusitas” dihubungkan dengan dogma dan ajaran yang diuraikan oleh institusi agama¹⁰¹, sementara “spiritualitas” didefinisikan secara individualistik yakni pencarian seseorang akan sesuatu yang suci/kudus.¹⁰²

Suci dalam hal ini tidak hanya dihubungkan dengan Tuhan/ sesuatu yang memiliki kekuatan, namun dipahami juga sebagai manifestasi dari sesuatu yang dianggap suci seperti tujuan hidup, tujuan

⁹⁹Rajendra Kertawirian, *12 Langkah Membentuk Manusia Cerdas*, (Jakarta: Hikmah, 2004), 170.

¹⁰⁰Fuller (2001) dalam Howayda A. Aly, *Spirituality and Psychological Well-Being in The Muslim Community: an Exploratory Study*, Disertasi pada Universitas La Verne, (2010).

¹⁰¹Royce E. Frazier, dan Nancy Downing Hansen, “Religious/ Spiritual Psychotherapy Behaviors: Do We Do What We Believe To Be Important?”, *Profesional Psychology: Reserach and Practice*, Vol. 40, No. 1, (2009); 81-87.

¹⁰²Ana Maria Rizzuto, :Psychoanalytic Consideration about Spirituality Oriented Psychotherapy”. In Len Sperry & E.P. Shafranske (Eds), *Spirituality Oriented Psychotherapy*, (Washington, D.C.: American Psychological Association, 2005), 31-55.

akhir, keselamatan dan juga hubungan dengan orang lain termasuk juga dengan alam. Meskipun terjadi perbedaan dalam definisi dua kata ini, Pargement (2003) mengungkapkan, bahwa spiritualitas seringkali ditemukan dalam konteks agama, tetapi dapat juga terjadi di luar konteks atau tradisi keagamaan.¹⁰³ Sementara MacKinlay (2006) menambahkan selain dari pada agama, spiritualitas dapat dicapai dengan media lain seperti seni, hubungan dengan orang lain atau Tuhan, bahkan melalui lingkungan.¹⁰⁴

Pandangan kedua tokoh di atas menjelaskan bahwa di dunia Barat spiritualitas diyakini dimiliki oleh setiap individu dan bermanifestasi menjadi kedamaian dalam diri yang muncul dari hubungan transendental kepada Tuhan. Namun di sisi lain ada beberapa tokoh yang menjelaskan bahwa spiritualitas merupakan suatu realitas subjektif yang berpusat pada pemahaman masing-masing individu terhadap apa yang dimaksud sebagai sesuatu yang tertinggi dalam hidupnya. Rusdi (2014) melakukan analisis pandangan beberapa tokoh Barat mengenai konsep duo-sentrik spiritualitas, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Konsep Spiritualitas Para Tokoh Barat¹⁰⁵

Sentral	Tokoh	Definisi Spiritualitas	Analisis
ANTROPOSENTRIK	Dossey	Esensi keberadaan hidup manusia dan bagaimana manusia hidup di dunia	Spiritualitas cenderung subjektif. Merupakan pengalaman makna hidup dan arti hidup. Lebih cenderung kepada makna hidup
	Shafranske dan Gorsuch	Spiritualitas adalah dimensi transenden di dalam hidup manusia. Ditemukan	Spiritualitas merupakan dimensi transenden murni yang

¹⁰³Kenneth Pargament "Advances in the Conceptualization and Measurement of Religion and Spirituality: Implication for Physical and Mental Health Research", *Am Psychol*, Vol. 58, (2003); 64-74.

¹⁰⁴Elizabeth Mackinley, *Spiritual Growth and Care in the Fourth Age of Life*, (London: Jessica Kingsley Publisher, 2006), 13.

¹⁰⁵Ahmad Rusdi, *Kecemasan dan Psikoterapi Islam, Dari Spiritual Disorder hingga Persoalan Eksistensial Menuju Kesehatan psiko-Spiritual*, (Disertasi UIN Pasca Sarjana, 2014), 41.

TEOSENTRIK		melalui pencarian individu akan makna atas eksistensi diri yang mendorong dirinya untuk menempatkan ke dalam konteks realitas yang lebih luas.	didapati melalui pencarian makna diri
	Vaughan	Spiritualitas adalah pengalaman sakralitas yang bersifat subjektif	Segala bentuk sakralitas dan nilai-nilai kesucian yang berasal dari subjektivitas masing-masing individu
	Atchley	Spiritualitas adalah suatu kapasitas yang dapat menyadari adanya suatu kehidupan yang menyertai pengalaman sensoris dan pengalaman mental.	Esensi terdalam psikologis (sensoris, mental dan emosional manusia)
	Testerman	Spiritualitas adalah dimensi kehidupan transenden, yaitu sesuatu di balik ego pribadi dan pengalaman inderawi. Transendensi bisa dicapai dengan pencarian makna hidup	Spiritualitas cenderung gabungan konsep transendental dan makna hidup
	Narayanasamy	Spiritualitas adalah kedamaian dalam diri sekaligus kekuatan yang muncul dari hubungan transendental kepada Tuhan	Spiritualitas cenderung pada konsep transendental yang merupakan pengalaman tertinggi yang disebut "Tuhan"
	Murray dan Zenter	Spiritualitas adalah suatu kualitas yang ada di balik agama yang berupa inspirasi, yang dihormati, yang dikagumi, yang penuh makna dan tujuan	Spiritualitas merupakan makna terdalam dari agama
	Benner	Spiritualitas adalah respon manusia atas panggilan kasih sayang Tuhan dengan manusia	Spiritualitas merupakan hubungan antara manusia dan Tuhan

	Milner	Spiritualitas adalah kekuatan gerak manusia, prinsip hidup yang menyebar di seluruh aspek kehidupan, dapat diekspresikan dan dialami melalui hubungan ganda dengan diri sendiri, orang lain, alam dan Tuhan.	Menekankan pada aspek kekuatan keterhubungan (connection). Spiritualitas hanya dapat dirasakan melalui bentuk keterhubungan.
--	--------	--	--

Tabel di atas menjelaskan bahwa spiritualitas di Barat seringkali cenderung dimaknai secara teosentrik yakni berpusat pada Tuhan, dan bagi mereka yang tidak mempercayai agama dan Tuhan spiritualitas diyakini berpusat pada nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri manusia dan selalu mencoba untuk harmonis dengan alam. Adapun aspek dan komponen spiritualitas itu sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi, sehingga memunculkan konsep dan teori spiritualitas yang terus diperbincangkan.

Mengenai aspek spiritualitas menurut Klerk seorang pakar spiritual dari University of the Free State, Afrika Selatan, spiritualitas memiliki tiga dimensi yaitu sensasi menyatu dengan alam (sense of unity with universe), makna hidup (meaning in life), dan kesadaran akan kekuatan dan hidup (awareness of a life force).¹⁰⁶ Seaward (2006) membagi dua dimensi spiritualitas yakni dimensi vertikal yakni spiritualitas yang berhubungan dengan Tuhan dan dimensi horizontal yakni spiritualitas dengan hubungan yang lainnya. Hal ini selaras dengan pandangan Paloutzian (1982) seorang pakar psikologi agama dimana menurutnya spiritualitas adalah kebahagiaan yang mencakup dua dimensi, yaitu dimensi vertikal; merupakan kebahagiaan karena berdekatan dengan Tuhan dan dimensi horizontal; merupakan kebahagiaan karena terhubung dengan orang lain.¹⁰⁷

¹⁰⁶De Klerk, "Spirituality, Meaning in Life and Work Wellness: A Research Agenda", The International Journal of Organizational Analysis, Vol. 13, No.1, (2005); 64-88.

¹⁰⁷Paloutzian dan Ellison, "Loneliness, Spiritual Well-Being and Quality of Life", in Loneliness: A Sourcebook of Current Theory: Research and Therapy, Ed. Peplau L. Perlman D, (New York: Wiley Interscience, 1982), 224.

McDonald dan Friedman (2009) para pakar transpersonal menjelaskan ada empat aspek spiritualitas, yaitu kepercayaan pada Tuhan; meliputi pandangannya mengenai agama, pencarian hikmah (search for wisdom); meliputi filosofis keberadaan diri sendiri, kesadaran interaksi (conscious interaction compassion); meliputi kepedulian terhadap orang lain dan kekuatan transenden (transcendence conviction); meliputi keyakinan akan eksistensi kekuatan tertinggi.¹⁰⁸

Fisher seorang tokoh yang hampir 20 tahun masa pengabdianannya sebagai seorang ahli pendidikan sekaligus pendeta sangat tertarik membahas *spirituality wellness*, Fisher menyebutkan bahwa kesejahteraan atau kesehatan spiritualitas merupakan salah satu aspek penting diantara aspek-aspek kesehatan hidup lainnya (seperti fisik, mental, emosi, sosial dan kerjaan). Fisher dan Gomez (2003) Keduanya mendefinisikan *spiritual* adalah keadaan manusia yang mencerminkan perasaan positif, perilaku, kognisi dari hubungan dengan diri sendiri dan orang lain, transenden yang pada gilirannya memberikan individu dengan rasa identitas, keutuhan, kepuasan, kebahagiaan, keindahan, cinta, hormat, sikap positif, kedamaian batin dan harmoni, tujuan dan arah dalam hidup.¹⁰⁹

Spiritualitas menurut Fisher dan Gomez (2003) direfleksikan dengan kemampuan seseorang untuk hidup harmonis berhubungan dengan empat domain: hubungan dengan dirinya sendiri (*personal*), yang lain (*communal*), alam (*nature*) dan Tuhan (*god and transcendental others*). Teori spiritualitas yang digagas oleh keduanya sangat menyeluruh dan komprehensif, yakni spiritualitas tidak hanya berpusat pada diri sendiri, namun lebih dari itu yakni keterhubungan dengan nilai-nilai umum universal, alam dan Tuhan. Semua keempat domain tersebut memberi hubungan satu kesatuan yang utuh.

Domain *personal* meliputi hubungan dengan diri sendiri yakni kemampuan mencapai *meaning* berupa makna dan hakikat yang signifikan dalam kehidupan, *purpose* berupa tujuan kebaikan yang ingin dicapai dalam hidup, dan *value* berupa keyakinan standar dan

¹⁰⁸MacDonald dan Friedman, "Measures of Spiritual and Transpersonal Construct for Use in Yoga Research", *International journal of Yoga*, Vol. 2, No.1, (2009); 2-12.

¹⁰⁹John W. Fisher dan Gomez, "Domains of Spiritual Well-Being and Development and Validation of the Spiritual Well-Being Questionnaire", *Personality and Individual Differences*, Vol. 35, (2003), 1975-1991.

patokan hidup yang harus dihargai.¹¹⁰ Selanjutnya domain *communal* adalah hubungan dengan masyarakat umum lainnya yang terikat dengan nilai moral, kultur, cinta, memaafkan dan harapan dalam kemanusiaan. Adapun domain *environmental* merupakan hubungan keterkaikatan dengan alam yang diwujudkan dengan menghargai alam, kagum terhadap alam, serta menyatu dengan lingkungan. Sementara domain transendental merupakan pengalaman dan pemahaman pada dimensi di balik dirinya yang melebihi batasan-batasan diri. Domain ini meliputi *faith* (keyakinan), *worship* (ibadah), *connectedness with God* (keterhubungan dengan Tuhan).

Pandangan beberapa tokoh Barat sebagaimana penulis uraikan di atas yang mengklasifikasi spiritualitas pada dua dimensi vertikal dan horizontal, termasuk pula pandangan Fisher dan Gomez yang lebih rinci membagi empat dimensi spiritualitas, sepintas terlihat ada kesamaan dan tumpang tindih antara konsep spiritualitas dan emosional, dimana kajian terkait kecerdasan emosional selalu dikaitkan dengan bangunan hubungan antara sesama manusia. Namun demikian menurut analisa penulis meskipun para ahli di Barat memasukkan dimensi komunal hal ini bukan berarti ada tumpang tindih konsep spiritualitas dan emosionalitas. Spiritualitas dipahami sebagai kekuatan umum dalam diri manusia yang mengarahkan dirinya untuk bertingkah laku. Sebagaimana Piedmont (2001) menyebutkan bahwa spiritualitas merupakan rangkaian motivasional (*motivational trait*) dan kekuatan afektif nonspesifik yang mendorong dan mengarahkan individu untuk memilih tingkah lakunya.¹¹¹

Dengan demikian dapat dipahami individu yang memiliki keterhubungan (*connectedness*) vertikal yakni dengan Tuhan, maka hubungan tersebut akan menjadi *inner drives* (dorongan dalam diri) untuk juga menjalin hubungan horizontal yang baik dengan sesama manusia dan alam semesta. Hal ini cukup beralasan karena pada hakikatnya spiritualitas berdimensi sangat luas dan jauh di luar sana. Sebagaimana Preston (2007) menjelaskan bahwa alam memiliki ke-

¹¹⁰Peter Gilbert, *The Spirituality Foundation: Awareness for Context People's Live Today in Spirituality, Value, and Mental Health*, (London: Jessica Kingsley Publisher, 2007), 24.

¹¹¹Piedmont, "Spiritual Transcendence and the Scientific Study of Spirituality", *Journal of Rehabilitation*, Vol. 67, No. 1, (2001); 4-14.

kuatan yang sangat kompleks dan menjadi suatu kesempurnaan, maka spiritualitas merupakan sisi dalam (*inner side*) pada manusia yang mengikuti kekuatan tersebut.¹¹² Dimana Yastion (2009) menegaskan bahwa sumber kekuatan alam berasal dari sumber kekuatan Tuhan (*Divine source of energy*).¹¹³

Dengan demikian keempat domain yang dijelaskan oleh Fisher dan Gomez dan para ahli Barat lainnya sebagaimana diungkap di atas dapat dianalisis secara sederhana oleh penulis bahwa spiritualitas sangat dekat sekali dengan agama dan tidak dapat dipisahkan dari keterhubungan dengan Tuhan. Nilai tidak akan menjadi suci dan sakral ketika tidak diyakini bersumber dari kekuatan yang tertinggi yakni Tuhan. Sehingga dengan hal ini dipahami bahwa pandangan keduanya selaras dengan pandangan Islam yang melihat spiritualitas dan religiusitas terjadi bersamaan dan *overlap* dalam sebuah keharmonisan.

Tanpa spiritualitas, agama dapat menjadi irasional dan rutinitas tanpa pertimbangan¹¹⁴ dan dibutuhkan penguatan spiritual dalam pelaksanaan keberagamaan. Agama yang terlepas dari nilai spiritualitas akan menjadi kering karena terputus dari mata airnya, karena kering maka agama akan mati karena kehilangan jiwa dan semangatnya. Kesadaran beragama harus ditumbuhkan melalui penghayatan yang tinggi melalui nilai transendental, sehingga dengan penghayatan tersebut tumbuh kualitas imani yang kemudian dimanifestasikan dengan kualitas moral dan keluhuran budi pekerti. Menurut Komaruddin Hidayat (2006), kemerdekaan spiritual merupakan kemerdekaan tertinggi karena tanpa kesadaran dan komitmen spiritualitas, prestasi lain akan mengalami jalan buntu.¹¹⁵

Pandangan ini juga selaras dengan konsep *al-wasatiyah* dalam agama Islam, yakni dimana menurut ‘Abd al-Salam al-Huras nilai

¹¹²David Lawrence Preston, *365 Steps to Practical Spirituality: A Day-by-Day Guide to Finding Health, Contentment, and Inner Peace*, (Oxford: How to Content, 2007), 3.

¹¹³Layla Yastion, *Handbook for A Spiritual Revolution*, (Maryland: Hamilton Books, 2009), 11.

¹¹⁴Mahjabeen Ahmad dan Shamsul Khan, “A Model of Spirituality for Ageing Muslims”, *Journal Religion Health*, (2015); 1-14.

¹¹⁵Komaruddin Hidayat, *Psikologi Beragama: Menjadikan Hidup Lebih Nyaman dan Santun*, (Jakarta: Hikmah, 2006), 102.

dalam Islam adalah keseimbangan yaitu nilai baik yang menyeluruh baik secara eksternal maupun internal. Nilai dalam Islam muncul dari aqidah dan tercermin dalam ibadah dan interaksi keseharian, sehingga aplikasi nilai tersebut memunculkan keindahan diri, terpenuhinya makna diri (*al-mufīdah*) diinginkan banyak orang dan dicintai banyak orang.¹¹⁶

Teori spiritualitas dengan domain transenden (keterhubungan dengan Tuhan) yang dijelaskan oleh para tokoh Barat searah dengan definisi spiritualitas itu sendiri dalam Islam. Dalam Islam dimensi *connectedness* (hubungan dengan Tuhan) dalam spiritualitas harus diimplementasikan dalam bentuk keta'atan beribadah kepada-Nya. Ibadah dalam Islam disebut sebagai media "*sirat mustaqim*" (jalan yang lurus).¹¹⁷ Ibadah merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap agama yang dalam pelaksanaannya hanya boleh mengikuti petunjuk agama dengan mereferensi ajaran tersebut dari sumber-sumber suci (al-Qur'an dan Sunnah) tanpa sedikitpun ruang untuk mengganti cara dan tata laksananya. Ibadah dalam konteks agama Islam berkaitan dengan keteguhan jiwa dan ketabahan hati menempuh hidup karena ada harapan kepada Tuhan. Sementara harapan kepada Tuhan merupakan iman yang dapat memberikan rasa aman.¹¹⁸

Sementara Nasr (1997) menyebutkan spiritualitas adalah adanya hubungan dengan Allah yang kemudian akan memengaruhi nilai diri, makna dan hubungan dengan yang lain serta hubungan dengan alam sekitar. Spiritualitas diyakini bersumber dari ajaran agama Islam yang meliputi kepercayaan, ritual ibadah, perilaku dan sikap hidup sehari-hari dan ilmu.¹¹⁹ Selaras dengan Nasr, Marzband (2016) menegaskan spiritualitas dalam Islam harus berlandaskan teologi yakni keimanan dan keyakinan akan Tuhan, Allah dilukiskan sebagai

¹¹⁶ Abd al-Salām al-Hurās, *al-Islam Dīn al-Wasāṭiyah wa al-Fadā'il wal al-Qayyim al-Khalidah*, (al-Maktabah al-Shamilah V.3.12, T.Th), 28.

¹¹⁷ Ammar Fauzi Heryadi, "Logika Tindakan: Membangun Sistem Nilai Religius", *Al-Huda*, Vol. 2, N0. 8, (2003), 106.

¹¹⁸ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Tela'ah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderanan*, (Jakarta: Paramadina, 1992), 57.

¹¹⁹ Sayyed Husain Nasr (1997) dalam Bagher Gobary Bonab, "Attachment to God in Islamic Spirituality", *Journal of Muslim Mental Health*, Vol. 7, No. 2, (2013), 77-104.

Zat pemilik sifat kasih sayang kepada hamba seperti dekat, bertanggung jawab, pengasih, Zat pemberi rasa nyaman dan pelindung dari berbagi bahaya, sehingga demikian iman menjadi prasyarat spiritualitas dalam Islam.¹²⁰

Dalam ajaran Islam spiritualitas harus berlandaskan teosentrik karena pada hakikatnya Allah SWT menjelaskan secara langsung orang yang cerdas secara spiritualitas adalah mereka yang disebut dengan istilah *ulul al-albab*. Sebutan *ulul al-albab* menurut Hamka (1999) adalah kekuatan dalam diri manusia untuk berhubungan dengan Allah dalam segala tindakannya serta kehalusan budi pekerti.¹²¹ Sementara al-Maraghi (2001) menjelaskan perkataan *ulul al-albab* bermakna orang-orang yang menerima ayat-ayat Allah dan mau mengikuti petunjuk-Nya dan tidak lalai pada-Nya.¹²² Dengan demikian status *ulul al-albab* ini bisa digapai dengan menjalin hubungan dengan Allah sesuai dengan tuntunan al-Qur'an surah az-Zumar ayat 9 sebagai berikut:

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Artinya:

“(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”. (az- Zumar: 9)

Hanefar et al (2016) menjelaskan bahwa menurut Al-Ghazali transenden dalam Islam adalah mengakui keberadaan Tuhan berikut

¹²⁰Rahmatollah Marzband, Seyed Hamzeh Hosseini dan Zeinab Hamzehgradeshi, “A Concept Analysis of Spiritual Care Based on Islamic Sources”, *Religions*, Vol. 7, No. 61, (2016); 1-11.

¹²¹Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka, *Tafsir al- Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1999), 53.

¹²²Ahmad Mustafā al- Marāghī, *Tafsir al- Marāghī*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), 5871.

sifat dan perbuatan-Nya dan meyakini ada interkoneksi antara Tuhan dan manusia. Menurutnya sifat dan kebajikan manusia adalah refleksi dari Sifat Allah, sehingga sejak dari awal penciptaannya manusia sejatinya meyakini keberadaan Tuhan.¹²³ Apa yang disampaikan al-Ghazali dibuktikan oleh penelitian medis pada masa kekinian bahwa di bagian otak depan manusia (*lobus frontalis*), terdapat suatu bagian tertentu yang apabila diberikan rangsangan-rangsangan gelombang mikroelektrik akan menimbulkan rasa kekhusyuan, *sakinah*/ketenangan, kedamaian serta rasa dekat dengan Tuhan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramachandaran yang menemukan bahwa di bagian otak terdapat titik yang berhubungan dengan jiwa, kalbu/spiritual dan kemudian bermuara pada Tuhan.¹²⁴ Bagian otak ini selanjutnya disebut dengan istilah “*God Spot*”.¹²⁵

Menindak lanjuti pendapat al-Ghazali yang menyatakan bahwa sifat dan perbuatan Tuhan termanifestasi dalam diri manusia. Yunasril Ali (2005) menjelaskan bahwa, kendati manusia memiliki kesempurnaan citra ilahi, tetapi kemudian ketika manusia terjatuh dari protipe ketuhanan, kesempurnaan itu semakin berkurang. Untuk itu, satu-satunya jalan untuk mencapai kesempurnaan itu kembali adalah kembali pada Tuhan dengan iman dan amal saleh.¹²⁶ Hal ini

¹²³Shamsiah Banu Hanefar, Che Zarrina Sa’ari dan Saedah Siraj, “A Synthesis of Spiritual Intelligence Themes from Islamic and Western Philosophical Perspectives”, *J Relig Health*, Vol. 55, No. 3, (2016).

¹²⁴Penelitian yang dilakukan oleh Ramachandran menegaskan bahwa ada hubungan antara otak dan agama/Tuhan. Lih Syarif Indra dan Syarif Islam, *Kepribadian dan Pola Hidup adalah Sumber Penyakit Sekaligus Obat*, 29-30.

¹²⁵Zohar dan Marshal penemu dari kecerdasan ketiga manusia yakni “*spiritual quotient*” menjelaskan bahwa *God Spot* atau Titik Tuhan adalah sekumpulan jaringan saraf yang terletak di daerah lobus temporal otak yakni bagian yang terdapat di balik pelipis. Jaringan saraf ini berfungsi untuk membuat manusia mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental seputar makna eksistensi dan membuat manusia mencari jawaban-jawaban fundamental tersebut. Titik Tuhan ini akan aktif ketika manusia merasa sedang berhubungan dengan kebenaran-kebenaran agama yang dianut. Lih Danah Zohar dan Ian Marshal, *Spiritual Capital: Memberdayakan SQ di Dunia Bisnis*, terj. Helmi Mustafa, (Bandung: Mizan, 2005), 120-121.

¹²⁶Yunasril Ali, *Manusia Citra Ilahi: Perkembangan Konsep Insan Kamil Ibn ‘Arabi oleh al-Jili*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 3.

ditegaskan kembali oleh Komaruddin Hidayat bahwa seorang muslim untuk melanggengkan atribut ketuhanan pada dirinya wajib secara sadar meniru sifat-sifat mulia Allah dalam ‘*amaliyah*’ kesecariaannya.¹²⁷

Spiritualitas yang diyakini sebagai sumber kebajikan dalam Islam tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan Tuhan dan ajaran agama. Ahmad Mansur, Al-Shirbini dan al-Faqqiy menegaskan bahwa agama Islam itu berorientasi untuk melindungi manusia dari rasa takut, cemas dan kegoncangan jiwa. Islam menghasilkan ketenangan dan kedamaian, melalui keimanan yang benar dan kokoh seorang muslim tidak akan memiliki penyakit jiwa yang biasanya mengakibatkan penyakit psikologis dan fisiologis.¹²⁸ Islam melalui sepe-rangkat ajarannya menjadi nasihat dan pedoman kehidupan, hal ini secara jelas dituliskan dalam al-Qur’an surah Yûnus ayat 57 :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“*Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman*”. (Yûnus: 57)

Dalam ajaran Islam dimensi transenden dan keterhubungan dengan Tuhan dalam spiritualitas sangat erat dengan kajian tasawuf,¹²⁹ karena pada intinya tasawuf mengajarkan sebuah bentuk

¹²⁷Komaruddin Hidayat, *Psikologi Ibadah*, (Jakarta: Serambi, 2008),

¹²⁸Abd al- Majid Sayyid Ahmad Mansur, Zakariyah Ahmad al-Sharbini dan Ismail Muhammad al- Faqqiy, *Al-Suluk al-Insani bayna al-Tafsîr al- Islamiy wa Usus ‘Ilm an- Nafsi al- Mu’asir*, (Kairo: Maktabat al-Anjilu al-Misriyyah, 2001), 393.

¹²⁹Dalam kajian tasawuf hubungan manusia dengan Allah dilakukan secara batiniah melalui potensi spiritual, yaitu *qalb* (hati) yang digunakan untuk mencintai Allah; *ruh* (roh) yang digunakan untuk mengenal Allah; *fu’ad* yang digunakan menerima hidayah Allah; *sirr* yang digunakan untuk merasakan kehadiran Allah; dan *zauq* yang digunakan untuk mendapatkan

kesadaran akan adanya hubungan komunikasi manusia dengan Tuhan-nya, yang selanjutnya mengambil bentuk rasa dekat (*qurb*) dengan Tuhan.¹³⁰ Ajaran tasawuf mengajarkan bahwasanya untuk sampai pada kedekatan diri dengan Allah maka seseorang harus berjuang menembus rintangan-rintangan materi untuk menjadikan jiwanya suci, karena Allah hanya dapat didekati oleh yang suci. Tasawuf menjelaskan perjuangan ini adalah tarik menarik yang ketat antara “*sprit*” (kebaikan) dan “*ego*” (keburukan).¹³¹ Pandangan ini kemudian ditegaskan oleh Komaruddin Hidayat (2006) bahwa dimensi-dimensi spiritualitas dalam Islam ketika diposisikan dalam konteks ilmu keislaman, melahirkan ilmu tasawuf dan selanjutnya melahirkan gerakan tarikat. Namun, apabila spiritualitas dilihat bukan sebagai objek keilmuwan, melainkan hanya penghayatan, posisinya justru menjadi amat sentral dan merupakan inti dari denyut iman dan keragamaan.¹³²

Dalam ajaran tasawuf untuk mencapai dimensi transenden dan keterhubungan dengan Tuhan, individu harus menempuh tahap-tahap spiritualitas yang disebut dengan istilah *maqamat*.¹³³ Nasution (2008) menjelaskan *maqamat* dalam ilmu tasawuf berarti kedudukan seorang hamba dalam pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakannya.¹³⁴ Bahkan dalam kajian tasawuf konektivitas dengan Allah tidak semata-mata hubungan transaksional, tetapi adanya saling ketergantungan bahkan meleburkan identifikasi-identifikasi

hikmah Allah. Lih Al-Qusyairy an- Naisabury, *Ar-Risalah al- Quṣairiyah fi ‘Ilmi at- Tasawuf*, (Mesir: Dar al- Khair, tt), 91.

¹³⁰Ujam Jaenudin, *Psikologi Transpersonal*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 162.

¹³¹Muhammad Shafwan, *Wacana Spiritual Timur dan Barat*, (Yogyakarta: Qalam, 2000), 7.

¹³²Menurutnya dalam kajian sufistik, puncak tertinggi pengalaman manusia adalah kesadaran bahwa pada diri manusia adalah jelmaan sifat dan atribut Tuhan sehingga pada dasarnya watak manusia adalah bersifat baik. Lih Komaruddin Hidayat, *Psikologi Kematian: Mengubah Ketakutan Menjadi Optimisme*, (Jakarta: Hikmah, 2006), 39 dan 41.

¹³³M. Solihin dan Rasihan Anwar, *Kamus Tasawuf*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 126.

¹³⁴Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisme dalam Islam*, Cetakan ke 12 (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), 62.

diri satu dengan yang lain, menurut Mujib (2015) pada paham tertentu dalam tasawuf hal ini mencapai tingkat yang disebut dengan “*pantheism*” (*wihdatul wujud*).¹³⁵

Setiap individu yang ingin mencapai *maqāmāt* harus melakukan usaha (*mujahad*) dan latihan batinian (*riyāḍah baṭiniyah*).¹³⁶ Dimana pada setiap *maqāmāt* akan terjadi pengalaman spiritual yang disebut dengan “*ḥal*”, yakni suatu momem spiritual dan psikologis yang membuat takjub bagi pelaku (*salik*), sebab dirinya memperoleh suatu pencerahan spiritual.¹³⁷ Hal ini selaras dengan pandangan DeLaune dan Ladner bahwa diantara dimensi spiritualitas selain dari pada transedensi adalah pencerahan (*enlightment*).¹³⁸

Diantara jalan-jalan (*sulūk*) yang harus ditempuh para *salik* sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tasawuf adalah; *taubah*; memohon ampun atas segala dosa yang disertai penyesalan dan bersungguhsungguh tidak ingin kembali pada perbuatan tersebut.¹³⁹ *Zuhud*; meninggalkan kesenangan dunia dan melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dan mengutamakan ukhrawi. *Ṣabr*; keadaan jiwa yang kokoh, stabil dan konsekuen dalam pendirian. *Waraʿ*; menjauhkan diri dari maksiat dan segala sesuatu yang tidak jelas hukumnya baik baik menyangkut makanan, pakaian, dan lainnya.¹⁴⁰ *Tawakkal*; pasrah dan menyerahkan diri segalanya pada Allah setelah melakukan rencana dan usaha. *Ridha*; rela, senang dan suka dalam artian tidak menentang *qada* dan *qadar* nya Allah dan

¹³⁵Abdul Mujib, “Implementasi Psiko-Spiritual dalam Pendidikan Islam”, *Madania*, Vol. 19, No. 2, (2015); 195-204.

¹³⁶*Mujahadah* yakni berusaha dengan sungguh-sungguh sekuat tenaga mengendalikan hawa nafsu dengan jalan berpuasa, shalat, zikir dan sebagainya. Sementara *riyāḍah* yakni latihan mengelolah fisik dan hawa nafsu agar senantiasa berada dekat dengan Allah. Lih Abuddin Nata, Achmad Gholib dan Fauzan, *Fikih Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2017), 48.

¹³⁷Abdul Mujib, “Implementasi Psiko-Spiritual dalam Pendidikan Islam”, 200.

¹³⁸DeLaune dan Ladner, *Fundamentals of Nursing: Standards and Practice*, (New York: Thompson Delmar Learning, 2006), 9.

¹³⁹Totok Jumanthoro dan Samsul Munir Amin, *Kamis Ilmu Tasawuf*, (Jakarta: Amzah, 2005), 268.

¹⁴⁰Revay Siregar, *Tasawuf dari Sufi Klasik dan Neo-Sufisme*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 118.

menerimanya dengan hati yang senang. *Tafakkur*; mengumpulkan kembali makna-makna yang sulit untuk diraba secara fisik menjadi makna non-fisik.¹⁴¹ *Muraqabah*; Kesadaran diri bahwa Allah dalam keadaan selalu mengawasi hamba-Nya, sehingga kesadaran ini menumbuhkan sikap selalu menjaga diri (*self correction*) dari perbuatan maksiat.¹⁴² *Al-Hazan*; mengendalikan hati agar senantiasa tidak lupa kepada Allah. *Al-Yaqin*; percaya dengan sepenuhnya terhadap janji Allah. *Asy-Syukur*; senantiasa berterima kasih kepada Allah setelah berusaha dengan keras. *As-Sabr*; senantiasa berpegang teguh pada aturan Allah dalam ketaatan kepada-Nya dan menerima berbagai cobaan dan musibah dari-Nya. *Raja'*; keterpautan hati kepada sesuatu yang diinginkan terjadi di masa yang akan datang.¹⁴³ *Isti'anah* : meminta pertolongan kepada Allah ketika dalam keadaan sukar dan sulit. *As-Sumtu*, menjaga ucapan dari kata-kata dusta. *Az-Zikr*; senantiasa ingat kepada Allah

Beberapa jalan yang diajarkan dalam tasawuf sebagaimana dijelaskan di atas berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan, dimana bermula dari jalinan konektivitas secara vertikal ini manusia akan sampai pada nilai-nilai keunggulan moral (*supreme morality*). Dengan bahasa yang berbeda tasawuf tidak hanya mengajarkan keterhubungan dengan Tuhan, namun juga banyak mengajarkan perilaku mulia dalam hubungan sosial yang dikenal dengan istilah *akhlaq*. Sebagaimana Syekh as-Suyuti pernah berkata “tasawuf mengajarkan kesucian diri kepada Allah dan berakhlak baik kepada makhluk”.

Dengan demikian pandangan Barat yang menegaskan spiritualitas memiliki dua dimensi, vertikal; hubungan personal terhadap sosok transenden dan mencakup *inner drive* (dorongan dalam diri), idealisme, pemikiran, perasaan dan pengharapan mutlak, spiritualitas juga mencakup lintang horizontal; ekspresi hubungan moralitas terhadap sesama adalah sangat sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana ditegaskan oleh Elmi dan Zainab (2013) bahwa spiritualitas dalam

¹⁴¹Hasan Amer, *The Psycholgy of al-Ghazali*, (Ttp: Akadimiyah al-Qasimi, 2006), 1-6.

¹⁴²Abdul Mujib dan Yusuf Muzakkir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, 159.

¹⁴³Al-Qusyairy an- Naisabury, *Ar-Risalah al-Qusairiyyah fi 'Ilmi at-Tasawuf*, 133

Islam adalah hubungan dengan Allah begitupula dengan sesama manusia dengan cara melakukan hal-hal baik dan menghindari kemungkaran “*amr ma‘ruf wa nahy ‘an al-munkar*”.¹⁴⁴ Sehingga demikian spiritualitas dalam Islam harus bisa memotivasi muslim untuk senantiasa menahan gejolak emosional dalam dirinya, mempertahankan kesejahteraan dirinya, dan mengajak pada perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya.¹⁴⁵

Pandangan Barat dan Islam terkait dimensi horizontal ini dapat dipahami mengingat dalam kajian psikologi sangat sarat dengan pengukuran (*measurement*) maka segala sesuatu yang muncul dari jiwa harus dapat dilihat dan diukur dimensi perilaku atau amaliyahnya (*the behavioral dimension*). Maka keterhubungan yang baik individu dengan Tuhan harus dapat dilihat dan diukur pula kualitas proses relasi dengan dirinya sendiri (*personal*) sesama manusia (*communal*) dan lingkungan (*environmental*). Dalam bahasa yang berbeda Piedmont (1999) menjelaskan dimensi vertikal ini dengan istilah “*universality*” yakni suatu keyakinan terhadap kesatuan dan tujuan hidup, sebuah perasaan bahwa kehidupan saling berhubungan dan hasrat berbagi tanggung jawab pada makhluk ciptaan lainnya.¹⁴⁶ Sementara Burkhardt (1989) menyebut keterhubungan manusia dengan selainnya meliputi sesama manusia, bumi, lingkungan, dan kosmos dengan istilah “*harmonisasi*”.¹⁴⁷

Menurut Nasr individu manusia pada hakikatnya memang tidak dapat dipisahkan dari keterhubungannya dengan dunia di luar dirinya, karena menurutnya pada sebagian ahli tasawuf ruh setelah bersatu dengan jasad disebut “jiwa”, jiwa merupakan subjek dari kegiatan “*spiritual*”. Selanjutnya jiwa digambarkan oleh tokoh-tokoh sufi sebagai alam yang tak terukur besarnya, ia adalah keseluruhan

¹⁴⁴Elmi Baharuddin dan Zainab Ismail, “Spiritual Intelligent Relationship of Elderly People with the Religious Practice in the Welfare Home”, *Islamiyyat*, Vol.35, No. 1, (2013); 19-28.

¹⁴⁵Benaouda Bensaid, Saleh ben Tahar Machouche dan Fadila Grine, “A Qur’anic Framework for Spiritual Intelligence”, *Religions*, Vol. 5, No. 1, (2014); 179-198.

¹⁴⁶Piedmont, “Spiritual Transedence and the Scientific Study of Spirituality”, *Journal of Rehabilitation*, Vol. 67, No. 1, (2001); 4-14.

¹⁴⁷Margaret A. Burkhardt, “Spirituality; an Analysis of the Concept”. *Holistic Nursing Practice*, Vol. 3, No. 3, (1989); 69-77.

alam semesta, karena ia adalah salinan dari-Nya segala hal yang ada di dalam alam semesta terjumpai di dalam jiwa, hal yang sama segala apa yang terdapat di dalam jiwa ada di alam semesta, oleh sebab inilah, maka ia yang telah menguasai alam semesta, sebagaimana juga ia yang telah diperintah oleh jiwanya pasti menguasai diperintah oleh seluruh alam semesta.¹⁴⁸ Maka ketika jiwa ingin berhubungan dengan Tuhan secara bersamaan dirinya dituntut untuk menjalani konektivitas dengan sesama manusia dan alam lingkungan lainnya.

Hubungan dengan diri sendiri (*persona*) adalah hubungan diri terhadap makna dan tujuan hidup dan pengenalan diri sendiri. Dalam Islam makna dan tujuan hidup adalah pengabdian diri hanya pada Allah dengan penuh ketulusan sebagaimana ditegaskan dalam surah al- Dzariyah ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (Az-Zariyah: 56)

Di antara manifestasi harmonisasi dengan sesama manusia adalah perilaku *takhalluq* yakni secara sadar meniru sifat-sifat mulia sebagaimana sifat-sifat Allah dalam muamalah sehari-hari.¹⁴⁹ Mencintai orang lain, menolong dan memaafkan orang lain. Imam al-Qusairi menegaskan pentingnya menjaga harmonisasi antar sesama manusia guna menghindari penyakit sosial. Dalam kitabnya *ar-Risalah al-Qusairiyah*, beliau menegaskan sejumlah sikap yang dapat menyebabkan hubungan tidak baik dengan manusia seperti membohongi orang lain, menggunjing, atau memperbincangkan keburukan orang lain (*ghibah*), dengki, sombong, zalim, membenci, melanggar janji, marah, khianat, kikir, serakah dan berbantah-bantah.¹⁵⁰

¹⁴⁸Seyyed Hossein Nasr, *Tasawuf Dulu dan Sekarang*, terj: Abdul Hadi, Mengutip dari Syaikh al-‘Arabi al- Darqawi, *Letter of a Sufi*, 4.

¹⁴⁹Komaruddin Hidayat, *Psikologi Ibadah*, (Jakarta: Serambi, 2008), 14

¹⁵⁰Al-Qusyairy an- Naisabury, *Ar-Risalah al- Qusairiyah fi ‘Ilmi at-Tasawuf*, 154-155.

Sementara harmonisasi dengan alam dapat dimanifestasikan dengan “*tawassum*” yakni perilaku untuk memahami tanda-tanda alam. Memperhatikan fenomena alam semesta akan memberi pelajaran dan mendapatkan sensasi spiritual dari perkara-perkara materi.¹⁵¹ Hal ini ditegaskan dalam Islam melalui surah al-Hijr ayat 75:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.*” (Q.S. al- Hijr: 75).

Dalam buku tafsirnya, Imam Ibn Katsir menjelaskan bahwa para Mujahid memaknai *mutawassimin* yaitu orang-orang yang memandang kejadian alam semesta dengan pandangan mata dan hatinya. Ibnu Katsir mengutip bahwa Qatadah mengatakan *mutawassimin* artinya orang-orang yang mengambil pelajaran, sementara Malik mengatakan dari sebagian Ulama' Madinah *mutawassimin* artinya orang-orang yang merenungkan.¹⁵² Adapun kata lain yang digunakan al-Qur'an untuk menjelaskan hubungan perilaku manusia dan alam semesta adalah *tafakur* dan *tadabbur*. Sebagaimana disebutkan pada dua ayat berikut ini:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٠١﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٠٢﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi*

¹⁵¹Maulana Wahiduddin Khan, *Spirituality in Islam*, (tt), 7 diakses dari <https://dokumen.tips/documents/spirituality-in-islam-by-maulana-wahiduddin-khan.html> pada tanggal 11 September 2017, pukul 22.09 WIB.

¹⁵²Abu Fada' Isma'il Ibnu Katsir, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 6, (Jakarta: Sinat Baru al- Gensindo, 2004), 54.

orang-orang yang berakal (190) (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam kea-dan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka). (Ali 'Imran: 190-191)

Berkaitan dengan ayat ini Aisyah istri Rasulullah, suatu hari mengisahkan bahwa suatu saat Rasulullah SAW terlihat sangat khu-su' dengan shalat tahajutnya. Saat sholat Rasul menitikkan air mata. Air mata itu mula-mula hanya membasahi pipi, lalu jenggot beliau, sampai akhirnya membasahi tempat beliau shalat. Rasul tak henti-hentinya menangis dalam shalat, hingga Bilal mengumandangkan azan subuh. Aisyah bertanya, "*Mengapa engkau menangis seperti itu?*" Rasul Menjawab, "*Wahai Aisyah, aku menangis seperti ini karena Allah baru saja menurunkan ayat kepadaku. Orang yang membaca ayat QS. Ali Imran*" 190-191 *ini akan celaka jika tidak mentadab-burinya.*¹⁵³

Berdasarkan ayat al-Qur'an surah Ali 'Imran 190-191 dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban di atas, didapati istilah *tafakkur* dan *tadabbur*. *Tafakkur* adalah proses menggunakan daya akal untuk menemukan ilmu pengetahuan. Semua ayat yang menggunakan kata *fakara* tersebut adalah rangka memikirkan hal-hal yang kongkret sampai hal-hal yang metafisik, seperti memikirkan penciptaan langit dan bumi. Sedangkan kata *tadabbur* secara bahasa berasal dari kata *dabbara* yang artinya membelakangi sesuatu. Dalam hubungannya dengan aktifitas berpikir, maka *tadabbur* adalah memikirkan yang ada di balik sesuatu, atau memikirkan yang tersirat di balik tersurat. Dengan kata lain mencari makna di balik makna tersurat.¹⁵⁴

Dengan demikian alam semesta ketika dilihat dengan proses *tafakkur* maka ia akan melahirkan teori-teori ilmu pengetahuan. Namun bila dilihat dengan proses *tadabbur* maka akan memunculkan

¹⁵³Muhbib Abdul Wahab, *Tadabur Ayat dan Alam*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/11/09/26/1s3sq0-tadabur-ayat-dan-alam>, pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 19.41 WIB.

¹⁵⁴Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami*, 123.

sensasi spiritual yang baik seperti *mahabbatullah*: semakin mencintai Allah, *safarul 'ibadah*: perjalanan ibadah karena mentaati perintah Allah untuk mentadabburi alam semesta, *as-syukru*: menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, *riayah al-'alam*: (menjaga dan melestarikan alam semesta, *quwwatul ukhuwah*: saling mempererat ukhuwah, karena bersama-sama menjaga alam semesta. Dalam ajaran Islam penciptaan alam semesta merupakan tanda kuasa Allah dan akan menjadi sumber inspirasi spiritual bagi mereka yang memperhatikannya. Dalam kajian Barat hal ini disebut dengan istilah “*nature centered spirituality*”.

Relasi antara manusia dan alam semesta diatur dalam etika lingkungan hidup. Etika lingkungan hidup pada dasarnya tidak hanya menjelaskan perilaku manusia terhadap alam, melainkan mengenai semua relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup atau dengan alam secara keseluruhan. Secara teoritis, terdapat tiga model teori lingkungan yang disepakati banyak ahli lingkungan yaitu *Shallow Environmental Ethic* (antroposentrisme); *Intermediate Environmental Ethics* (biosentrisme); dan *Deep Environmental Ethic* (ekosentrisme).¹⁵⁵ Ketiga

¹⁵⁵ Antroposentrisme adalah teori lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Pada teori ini, etika hanya berlaku pada manusia, hanya manusia yang mempunyai hak, kepentingan dan nilai atas alam semesta. Kepentingan manusia adalah yang paling utama, paling penting dan paling tinggi. Teori ini disebut egoistik karena hanya mengutamakan kepentingan manusia, sehingga kemudian teori ini disebut sebagai etika lingkungan hidup yang dangkal dan sempit (*shallow environmental ethics*). Biosentrisme merupakan suatu pandangan yang menempatkan alam sebagai yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri dan terlepas dari kepentingan manusia. Teori ini menjelaskan bahwa alam perlu mendapatkan penghargaan dan kepedulian terlepas apakah dia bernilai atau tidak bagi kehidupan manusia. Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori lingkungan biosentrisme. Pada etika ekosentrisme etika tidak berpusat pada manusia, tetapi pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Teori ekosentrisme sering disamakan begitu saja dengan biosentrisme, karena adanya banyak kesamaan di antara kedua ini. Namun sebenarnya ada perbedaan antara biosentrisme dan ekosentrisme. Biosentrisme hanya membatasi pada etika pada komunitas makhluk hidup (bio), sehingga demikian teori ini disebut dengan istilah

teori ini mempunyai cara pandang yang berbeda tentang manusia, alam, dan hubungan manusia dengan alam.

Sejalan dengan perkembangan teori etika lingkungan hidup, beberapa ahli lingkungan seperti Palmer, David E.Cooper dan Joy A. Palmer (1998) berupaya mengkompilasi tulisan belasan sarjana internasional dari perlbagai bidang seperti filsafat, agama, sains, pendidikan, sastra, antropologi, dimana hampir kesemuanya sepakat bahwa wawasan spiritual terhadap alam menjadi sebuah kebutuhan nyata dalam upaya kita memelihara lingkungan hidup dan menyelamatkan planet bumi.¹⁵⁶

Hal ini sejatinya juga telah ditegaskan oleh Nasr (2008) menurutnya, para sarjana dan manusia modern umumnya perlu menghadirkan kembali dimensi spiritualitas ke dalam kehidupan global, hal ini diperlukan sebagai wujud kesungguhan mencintai, tanggung jawab dan peduli terhadap Bumi. Menurut Nasr krisis ekologis dan pelbagai kerusakan di Bumi salah satunya berasal dari krisis spiritual dan eksistensial manusia modern. Menurut Nasr dalam pandangan modernisme, kosmos telah mati dan ia hanyalah kumpulan ongkongan benda mati, tidak bernilai, tidak benyawa dan berperasaan. Menurut Nasr eksploitasi alam adalah bentuk kegagalan manusia untuk melihat “Tuhan” dalam lingkungan, oleh karena itu menurutnya tidak ada pilihan kecuali melakukan sesuatu yang ia sebut resakralisasi alam semesta (*resacralization of nature*). Dalam pandangan Nasr, membangun etika lingkungan tanpa wawasan spiritual terhadap kosmos adalah tidak mungkin dan sekaligus tidak berdaya.¹⁵⁷

Selaras dengan pandangan Nasr, kini semakin banyak ahli pemerhati/aktivis lingkungan (*environmentalist*) yang menyadari bahwa manusia modern perlu kembali merevitalisasi ajaran agama, kontekstualisasi agama harus meliputi berbagai aspek kehidupan

lainnya *intermediate environmental ethics*. Sementara ekosentrisme memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun yang tidak. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Lih. A. Sony Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 47-69.

¹⁵⁶Subair, “Agama dan Etika Lingkungan Hidup”, *Tasamuh*, Vol, 4, No. 1, (2012); 31-43.

¹⁵⁷Sayyed Husein Nasr, *Islamic Spirituality*, (London: Routledge & Kegan Paul, 2008), 621-623.

yang luas. Diperlukan bangunan kosmologi baru yang berbasis kepada tradisi spiritualitas agama yang sarat makna dan kaya kearifan. Arif Sumantri pada bukunya “Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam” banyak menawarkan sinergitas agama dan sains, ia mencoba menjelaskan relasi hubungan manusia dan lingkungan dengan pendekatan nilai-nilai keislaman. Penulis menyebut istilah “harmonisasi alam semesta” dalam perpektif Islam dengan istilah “kesalehan lingkungan”. Melalui istilah ini, beliau ingin menegaskan bahwa kesalehan bagi masyarakat yang diartikan sebagai bentuk keta’atan terhadap hukum agama yang diimplementasikan dengan ritual keagamaan seperti shalat, puasa, atau naik haji pada hakikatnya bisa diperluas dengan melakukan hubungan yang baik dengan lingkungan sebagai tempat berpijak. Menurutnya kesalehan yang sesungguhnya adalah akhlak yang paripurna karena sesungguhnya agama itu adalah akhlak yang baik (*Husnul Huluk*).¹⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa spiritualitas sebagaimana yang dijelaskan oleh Fisher dan Gomez memiliki dua dimensi yakni vertikal dan horizontal yang diadopsi penulis untuk mengukur dimensi-dimensi spiritualitas dapat dibenarkan, hal

¹⁵⁸ Arif Sumantri menawarkan lima prinsip kesalehan lingkungan di antaranya: 1) *Muhasabah* (evaluasi diri); koreksi dan evaluasi diri untuk menjadi lebih baik dalam pengelolaan lingkungan manusia perlu memelihara, merawat, menjaga, melindungi dan melestarikan lingkungan beserta isinya. 2) *Muraqabah* (Kedekatan dengan Pencipta Alam); kesadaran bahwa segala perilaku manusia dengan alam semesta juga akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Tanggung jawab ini tidak hanya subjektif namun juga kolektif, dalam artian semua orang harus dapat berbuat dan menjadi contoh terbaik dalam berperilaku yang baik pada lingkungan. 3) *Muahaddah* (kesatuan); prinsip ini muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta, hal ini mendorong manusia untuk menyelamatkan semua kehidupan di alam ini. Ukhuwah kosmis akan mencegah manusia untuk tidak merusak dan mencemari alam dan seluruh kehidupan di dalamnya. 4) *Muaqobah*; prinsip menakar keseimbangan proporsi antara keinginan dan kebutuhan, dan hidup dengan mulia dan sederhana tanpa perlu menjadi tamak dan mengeksploitasi alam tanpa batas. 5) *Mujahadah*; Prinsip ini menuntut setiap manusia agar dapat melakukan ikhtiar atau perjuangan pengelolaan lingkungan untuk kepentingan bersama. Lih. Arif Sumatri, *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 244.

ini dikarenakan semua nilai-nilai spiritualitas yang menjadi alat ukur tersebut secara implisit juga menggambarkan seperangkat nilai-nilai spiritualitas yang diajarkan dalam Islam. Konstruk spiritualitas antara Barat dan Islam ini dijelaskan penulis pada tabel 2.3. berikut ini :

Tabel 2.3. Konstruk Spiritualitas: Sintesis Barat dan Islam

HORIZONTAL	Dimensi	Barat	Islam
	Personal	Meaning: keberartian hidup	<i>al-ma‘na</i> : asal dan tujuan hidup manusia adalah dari dan untuk Allah
	Communal	Morality	<i>Akhlak</i>
		Love	<i>Mahabbah</i>
		Forgiveness	<i>Al‘afwu</i>
		Good in humanity	<i>Takhalluq</i>
	Environmental	Care of nature	<i>Ri‘ayah al- ‘Alam</i>
		Sense of awe and wonder to nature	<i>Tawassum</i>
		Connected to the nature	<i>Muahadah</i>
		Simplicity	<i>Muqabah</i>
VERTIKAL	Transcendental	Faith	<i>Iman</i> <i>Yaqin</i>
		Connectedness to God	<i>Tawakkal</i> <i>Tafakkur</i> <i>Rida</i> <i>Muraqabah</i> <i>Raja’</i> <i>Isti‘anah</i> <i>Sabr</i>
		Worship	<i>‘Ibadah</i>

Tabel di atas menjelaskan semua empat dimensi yang dirumuskan oleh Fisher dan Gomez pada hakikatnya adalah selaras dengan ajaran Islam namun hanya pada bagian keterhubungan dengan Tuhan (*connectedness to God*), Islam memiliki konsep dan petunjuk jelas bagaimana jalinan tersebut dapat dibangun. Sebagaimana aja-

ran-ajaran tersebut diajarkan dalam kajian tasawuf seperti iman, tawakal, tafakur, ridha, muraqabah, roja' dan khauf, isti'anah dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan para ahli sebagaimana dipaparkan di atas, penulis menggaris bawahi bahwa ada persamaan dan perbedaan konsep spiritualitas menurut Barat dan Islam. Persamaannya baik Islam dan Barat menyepakati bahwa konsep yang paling fundamental dari spiritualitas adalah dimensi transenden, yaitu sesuatu yang ada di balik ego dan pengalaman inderawi. Dalam bahasa berbeda Barat dan Islam menyadari ada makna dan tujuan dibalik pengalaman sensoris dan pengalaman mental.

Namun demikian antara Islam dan Barat berbeda dalam menjelaskan lebih lanjut makna transenden ini. Barat meyakini keberartian yang memberikan makna dan arah pada kehidupan seseorang atau sakralitas tidak hanya terbatas pada agama, nilai-nilai kesucian bisa berasal dari subjektivitas masing-masing individu. Menurut Barat spiritualitas mungkin berasal dari keagamaan dan kelompok mungkin juga tidak. Sementara dalam Islam spiritualitas harus berlandaskan teologi keimanan kepada Allah. Hal ini menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam spiritualitas tidak bisa dipisahkan dari ajaran agama Islam itu sendiri melalui ketaatan beragama dan beribadah.

2. Spiritualitas Sebagai *Counter Ballancing* Atas Stresor

Stres akademik akan sangat mengkhawatirkan bagi para pelajar dan mahasiswa, karena akan menjadi penghambat kelancaran studi yang dijalani dan performansi akademik lainnya. Stabilitas psikologis merupakan prediktor penting yang berkontribusi kepada prestasi akademik yang lebih baik.¹⁵⁹ Beberapa studi menunjukkan bahwa performansi mahasiswa dipengaruhi oleh stres yang dihadapi sehingga menyebabkan pada permasalahan lain seperti: sulit konsentrasi, kurang

¹⁵⁹Aris Safree Yasin dan Mariam Adawiah Dzulkifli, "Difference in Depression, Anxiety, and Stress between Low-and High- Achievement Students", *Journal of Sustainability Science and Management*, Vol. 6, No. 1, (2011); 169-178.

motivasi dan minat, absen kehadiran, gangguan kesehatan fisik lainnya seperti kelelahan dan sakit kepala.¹⁶⁰

Selanjutnya beberapa studi dilakukan untuk memberikan solusi dalam menghadapi tingginya tingkat stres di kalangan mahasiswa, khususnya kedokteran. Spiritualitas menjadi salah satu bentuk perhatian dan usaha yang digunakan untuk memperkuat suasana dan lingkungan positif bagi para mahasiswa. Seiring dengan ketertarikan para peneliti pada aspek dimensi spiritual ini, terjadi perbedaan pandangan ahli mengenai apakah perlu ada ruang bagi spiritualitas pada pendidikan tinggi?. Beberapa merasa tidak perlu, karena menganggap spiritualitas adalah masalah personalitas yang seharusnya tidak di~~merj~~jasikan dalam pendidikan kampus. Bahkan Waaijman (2007) menyebutkan di awal-awal abad 20, studi spiritualitas sangat di larang pembahasannya di perguruan tinggi di Perancis.¹⁶¹

Ditengah penolakan *merging* spiritualitas di dunia pendidikan, sebaliknya pada pandangan berbeda justru para ahli menunjukkan gelombang ketertarikan akan variabel spiritual dalam pendidikan tinggi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh The Higher Education Research Institute (HERI) di UCLA (2003) mengenai spiritualitas di perguruan tinggi, hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% mahasiswa mengatakan mereka mencari tujuan dan makna dalam hidup dan 50% mereka mengatakan bahwa penting bagi mereka untuk berkembang secara spiritualis serta 80% mereka mengatakan bahwa mereka memiliki tertarik akan spiritualitas.¹⁶²

Dalam kajian selanjutnya spiritualitas diyakini menjadi salah satu sumber bernilai dalam hidup, menurut pandangan humanistik-eksistensial “*meaning in life* (makna hidup)” merupakan bagian dari spiritualitas, seseorang akan merasa lebih tertekan ketika makna hidup yang ada pada dirinya hilang, terblok atau rusak. Kurang tujuan

¹⁶⁰Lauri Dusselier, and others, “Personal, Health, Academic, and Environmental Predictors of Stress for Residence Hall Students, *Canadian Journal of Counselling*, Vol. 54, (2005); 15-24.

¹⁶¹Kees Waaijman, “Spirituality—a Multifaceted Phenomenon”, *Studies in Spirituality*, Vol. 17, (2007); 1-113

¹⁶²University of California at Los Angeles (UCLA) (2006) dalam Eric L. Bacon, *Spirituality in Higher Education: Spirituality and Students Engagement in First Year College Students*, Disertasi pada Universitas Northern Arizona, 2008.

dan makna hidup sangat erat sekali hubungannya dengan psikopatologi seperti stres, depresi dan bunuh diri.¹⁶³ Hal ini senada dengan teori stres “*conservation of resources theory* (CRS)” yang menyatakan bahwa tekanan psikologi terjadi ketika sumber signifikan hilang.¹⁶⁴ Salah satu sumber signifikan atau *valued resource* yang dapat mempertahankan kesehatan psikologis adalah terpenuhinya kesejahteraan spiritualitas (*spirituality wellnes*). Sehingga mengabaikan kebutuhan spiritual dapat memberikan kontribusi ke tingkat stres yang lebih tinggi.

Sebagaimana Najati (1993) menjelaskan bahwa kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan pokok manusia. Pemenuhan kebutuhan spiritual dapat memberikan kepuasan hidup, rasa aman, tentram dan bahagia. Bahkan sebaliknya pengabaian pada kebutuhan ini akan membuat individu tidak dapat merasa ketenangan, merasa gelisah dan dihantui perasaan bahwa kelak dia akan celaka. Menurutny dalam Islam secara fitrah kebutuhan spiritual ini adalah bertauhid, mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepada-Nya, dan meminta pertolongan kepada-Nya ketika dalam situasi genting.¹⁶⁵ Hal ini selaras dengan ajaran Nabi Musa kepada kaumnya sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al- A'raf ayat 128 sebagai berikut:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۖ

Artinya:

“Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa". (Al- A'raf: 128)

¹⁶³Prem S. Fry dan Corey L.M. Keyes, *New Frontiers in Resilient Aging, Life Strengths and Well-Being in Late Life*, (New York: Cambridge University Press, 2010), 22-23.

¹⁶⁴Debie Cohen and others, *Factors that Impact on Medical Students Wellbeing – Perspective of Risk*, Cardiff University, (2013), 1-83.

¹⁶⁵Najati, Muhammad 'Uthman. *Al-Qur'an wa 'Ilm al-Nafs*. (Cairo: Dar al-Syurūk, 1993), 36.

Senada dengan pendapat Zakiah Darajat yang menyebutkan bahwa dalam diri manusia terdapat kebutuhan pokok, yaitu: kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Pemenuhan kebutuhan yang seimbang pada keduanya berdampak bagi aspek fisiologis, psikologis dan hubungan sosial.¹⁶⁶ Pemenuhan spiritualitas secara mapan dapat menjadikan individu ridha dengan apa yang telah diatur oleh Allah untuk dirinya dan mampu bertahan dalam kehidupan yang menantang.¹⁶⁷

Sementara itu Maslach and Leither (1997) menuliskan “stres dan depresi” adalah indeks dari terlepasnya individu antara siapa dia dan apa yang seharusnya ia lakukan, hal ini merupakan representasi dari hilangnya nilai, martabat, spirit dan keinginan dari jiwa manusia”.¹⁶⁸ Sehingga hal ini dapat dipahami bahwa stres adalah masalah spiritual, yakni stres merupakan krisis akan makna dan tujuan di dalam hidup, dimana bagian terdalam dalam diri kita tidak dapat merealisasikan seharusnya dan bagaimana kita. Selaras dengan pandangan ini, Hamdani Bakran Adz-Dzaky (2001) menyatakan dalam perspektif psikologi Islam, problematika yang terjadi dalam kehidupan manusia disebabkan oleh mentalitas dan sprituitas manusia yang mengalami sakit kronis. Spiritualitas sebagai kecerdasan fitrah ilahiyah semakin menghilang dan memudar dalam kehidupan manusia.¹⁶⁹

Memperhatikan dampak yang muncul dari hilangnya fungsi positif spiritualitas dalam kehidupan manusia yang dapat mengakibatkan krisis pertahanan mental, sebaliknya membuat beberapa peneliti meyakini bahwa spiritualitas memiliki efek positif terhadap *human life well-being* (kehidupan manusia yang sehat) dan salah satu indikator nya adalah terhindar dari stres. Fabricatore et al (2000) menyebutkan bahwa spiritualitas meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan subjektif, penyakit sangat erat sekali hubungannya dengan

¹⁶⁶Zakiah Darajat, *Islam dan Kesehatan Mental*, 13.

¹⁶⁷Elmi Baharuddin dan Zainab Ismail, “Spiritual Intelligent Relationship of Elderly People with the Religious Practice in the Welfare Home”, *Islamiyyat*, Vol.35, No. 1, (2013); 19-28.

¹⁶⁸Maslach dan Leiter dalam Jonathan Golden, and others, “Spirituality and Burnout: an Incremental Validity Study”, *Journal of Psychology and Theology*, Vol. 32, No. 2, (2004); 115-125.

¹⁶⁹Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Psikoterapi dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 9

mereka yang rendah spiritualitasnya, dalam kata lain spiritualitas memberikan sumbangan positif terhadap kesejahteraan dan kesehatan individu.¹⁷⁰

Adapun salah satu teori stres yang digunakan dalam melihat hubungan stres dan spiritualitas adalah teori “*distress-deterrent model*” atau “*stress counter-balancing model*”, pada teori ini spiritualitas diyakini dapat menjadi *buffer* (penyanggah) akan terjadi stres akibat stresor yang dijumpai.¹⁷¹ Gracie et al (2006) menjelaskan pada individu yang menghadapi stresor berupa sakit kronis, maka spiritualitas dan religiusitas yang dimiliki akan menekan stres yang dirasakan akibat penyakit yang diderita.¹⁷²

Fungsi spiritualitas sebagai *buffer* atas stres juga dapat dipahami dengan memahami bahwa perasaan keterhubungan dengan Tuhan akan memberikan individu *framework* berupa pemahaman yang lebih baik akan kejadian dan keadaan yang dihadapi, keadaan yang menekan akan dilihat sebagai bagian dari rencana Tuhan dimana suatu saat akan terlihat kebaikan dibalik kejadian tersebut.¹⁷³

Sheik Muhammad Salih al-Munajjid menjelaskan berbagai pilihan solusi yang ditawarkan Islam untuk menghadapi stres yang dihadapi, salah satu nya adalah mempercayakan dan menyadarkan

¹⁷⁰Fabricatore, Anthony., Handal Paul J, Fenzel, I. Mickey, “Personal Spirituality as a Moderator between Stressors and Subjective Well-Being”, *Journal of Psychology and Theology*, Vol. 28, (2000); 221-228.

¹⁷¹Untuk mempelajari hubungan antara spiritualitas dan stres ada tiga model teori yang ditawarkan. 1) *Suppressor model* yakni spiritualitas bertambah sebagai respon terhadap stres, 2) *Moderator model*; spiritualitas mengurangi stres hanya di waktu mengalami pengalaman ekstrem, seperti sakit kronis, disabilitas, atau kematian. 3) *distress-deterrent model*, spiritualitas adalah tidak dipengaruhi stres, artinya ia bukan bentuk respon dari stres bahkan ia sangat berguna dalam menghadapi stres. Lih. Harold. G. Koenig, *Handbook of Religion and Mental Health*, (United States Of America: Elsevier Science, 1998), 131.

¹⁷²Gracie H. Boswell, Eva Kahana, Peggye Dilworth Anderson, “Lifestyle Behaviors: Stress Counter-Balancing Effect on the Well-Being of Older Adults”, *Journal of Religion and Health*, Vol. 45, Np. 4, (2006); 587-602.

¹⁷³Russell A. Carleton, and others, “Stress, Religious Coping Resources, and Depressive Symptoms in an Urban Adolescent Sample”, *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 47, No. 1, (2008); 113-121.

segala urusan perkara kepada Allah yang disebut dengan istilah “tawakkal”. Ketika seseorang menyerahkan urusan kepada Allah maka dia akan terbebas dari berbagai pikiran negatif dan kecemasan serta rasa tertekan dari apa yang sedang dihadapinya. Bahkan sebaliknya jiwa seseorang tersebut akan mendapatkan kekuatan serta merasakan relaks dan kegembiraan.¹⁷⁴ Dalam al-Qur’an Allah memberikan janji-Nya untuk menyelesaikan urusan seseorang yang bertawakkal kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah at-Talaq ayat 3 :

.. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ...

Artinya:

“Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya”. (Al- Ahqaf: 3).

Islam meyakini bahwa spiritualitas dapat menjadi alat yang berguna dan memberi dampak positif terhadap kesehatan fisik dan psikologis. Seorang muslim senantiasa menjadikan *belief* (keimanan) sebagai obat akan tekanan psikologis yang dihadapi dan muslim senantiasa memandang positif bahwa ada kebaikan dari setiap keadaan baik dan buruk. Dengan demikian seorang muslim dapat menerima segala peristiwa yang dihadapi dengan pikiran yang jernih dan hati yang nyaman.¹⁷⁵ Sebagaimana Sedgman (2005) menyatakan bahwa seseorang yang paham akan pondasi alami pikiran mereka dan tetap berpikir jernih akan memiliki kebijaksanaan dan kesejahteraan diri serta terhindar dari tekanan (stres) hidup.¹⁷⁶

William James seorang filosof dan Psikolog Barat menegaskan bahwa terapi terbaik bagi keresahan jiwa adalah keimanan pada Tuhan. Keimanan kepada Tuhan adalah salah satu kebutuhan yang

¹⁷⁴Sheik Muhammad Salih al-Munajjid, *Dealing With Worries and Stress*, (Inited Kingdom, Dar as-SunnahPublisher, 2013), 14.

¹⁷⁵Sumaya Laher dan Sumayyah Khan, “ Exploring the Influence of Islam on the Perception of Mental Illness of Volunteers in Johannesburg Community-Based Organisation”, *Psychology & Developing Societies*, Vol. 23, No. 1, (2011); 63-84.

¹⁷⁶Sedgeman, “Health Realization/Innate Health: Can a Quite Mind and Positive Feeling State be Accessible Over the Lifespan without Stress-Relief Techniques?”, *Medical Journal of Experimental and Clinical Research*, Vol. 11, No. 12, (2005); 32-47.

harus dipenuhi agar manusia terbimbing dalam hidupnya. Lebih jauh, James mengatakan bahwa antara manusia dan Tuhan terdapat ikatan yang tidak terputus. Apabila manusia senantiasa menundukkan diri di bawah pengarahan-Nya, cita-cita dan keinginannya, maka manusia akan terlindungi dari keresahan, selalu terjaga keseimbangannya, dan selalu siap untuk menghadapi segala malapetaka yang terjadi.¹⁷⁷

Pernyataan James yang menyatakan hubungan manusia dan Tuhan yang tidak pernah terputus akan memunculkan ketenangan adalah selaras dengan ajaran Islam yang dikenal dengan aktivitas *zikrullah* (mengingat Allah). Dalam Islam *zikr* adalah menyebut dan mengingat Allah dalam setiap keadaan. Menurut Mubarak (2001) zikir adalah kesadaran untuk selalu berhubungan dengan Allah sehingga zikir merupakan aktivitas mental, bukan aktivitas lisan. Meski demikian menurutnya zikir dalam aktivitas mental seringkali diawali dengan kebiasaan dengan zikir lisan¹⁷⁸ *Zikr* bertujuan untuk menjalin ikatan batin (kejiwaan) antara hamba dengan Allah sehingga timbul rasa cinta, hormat dan jiwa merasa dekat dan selalu dalam pengawasan Allah.¹⁷⁹ Dalam al-Qur'an Allah menyebutkan lebih kurang 358 ayat terkait tentang zikir. Hal ini menjelaskan bahwa Islam sangat mengajarkan umatnya untuk selalu menghubungkan dirinya kepada Allah kapan saja, di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Sebagaimana salah satunya disebutkan di dalam al-Qur'an surah al- Ahzab ayat 41-42.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝ۭ وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاٰصِيْلًا ۝ۭ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang”. (Al-Ahzab: 41-42).

¹⁷⁷Djamaluddin Ancok dan Fuaf Nashori Suroso, *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 95.

¹⁷⁸Ahmad Mubarak, *Psikologi Qur'ani*, 124.

¹⁷⁹Simuh, *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 113-114.

Menurut Sajari (2014), zikir kepada Allah dapat dilakukan secara *sirr* (rahasia), diam-diam (*khafī*) ataupun terang-terangan (*jahr*), secara sendiri-sendiri (*nafsi-nafsi*) ataupun bersama (*bi al-jama'ah*) dengan ucapan (*bi al-lisan*) ataupun dengan hati (*bi al-qalb*).¹⁸⁰ Melalui aktivitas zikir dengan bersyukur (Al-Baqarah:152), bertafakkur ('Ali Imran:191), dan bertasbih (Al-Insan: 26) kepada Allah sebenarnya kita sedang melakukan proses internalisasi sifat-sifat Allah ke dalam diri kita.¹⁸¹ Bagi kalangan sufi, zikir merupakan metode spiritual dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyebut nama-nama Allah secara berulang-ulang di bawah bimbingan guru (*mursyid*).¹⁸²

Selanjutnya dalam Islam diyakini bahwa ketiada putusan hubungan dengan Allah melalui zikir ini akan memberikan ketenangan dan ketentraman hati serta terhindar dari kegelisahan. Hal ini ditegaskan Allah pada firman-Nya surah ar-Ra'd ayat 28.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”. (Ar-Ra'd: 28).

Apa yang menyebabkan zikir bisa memberikan ketenangan?. Karena ketika kita ingat kepada Allah, maka pada saat itu kita berada dalam kepasrahan penuh kepada Allah SWT. Namun demikian zikir yang dapat menghantarkan kepada ketenangan menurut Cholil (2013) harus dilakukan melalui tiga komponen, *Pertama*, zikir dilakukan dengan lisan; *Kedua*, zikir dilakukan dengan hati; *Ketiga*, zikir dilakukan dengan perilaku (*bi al-hal*), orang yang perilakunya berzikir adalah orang yang memiliki pola sikap yang Islami.¹⁸³ Sebagaimana

¹⁸⁰Dimiyati Sajari, “Dzikir: Makanan Spiritual Sang Sufi”, *Dialog*, Vol. 37, No. 1, (2014), 2.

¹⁸¹Komaruddin Hidayat, *Psikologi Beragama: Menjalani Hidup lebih Nyaman dan Santun*, 132.

¹⁸²Muhammad Arifin Ilham, *Indonesia Berdzikir*, Cet 1, (Jakarta: Intuisi Press, 2004), 23.

¹⁸³Adam Cholil, *Meraih Kebahagiaan Hidup dengan Zikir dan Do'a*, (Jakarta: AMP Press, 2013), 49

ditegaskan oleh al-Darini bahwasanya individu yang senantiasa berzikir maka seluruh anggota tubuhnya turut berzikir, ketika melakukan sesuatu maka perilaku yang ditampakkan akan selalu sejalan dengan apa yang tidak dilarang oleh Allah SWT, beliau menjelaskan inilah yang dinamakan zikir hati yang menggerakkan seluruh anggota tubuh untuk selalu mengingat Allah SWT.¹⁸⁴

Berdasarkan pendapat dua tokoh di atas dapat dipahami bahwa dalam keadaan tertekan dan penuh masalah zikir dengan kepasrahan kepada Allah SWT dapat memberikan ketenangan, karena dengan kepasrahan berbagai persoalan yang kita hadapi akan menjadi lebih ringan dan memberi kita ketenangan. Adapun dalam persoalan hidup yang lebih luas, zikir akan memberikan ketenangan karena dengan zikir individu akan selalu merasa dirinya terhubung dengan Allah dan secara sadar dia akan meregulasi perilaku dirinya untuk selalu dalam keta'atan kepada Allah dan meninggalkan maksiat dan dosa, karena dosa dan maksiat akan memberi bekas pada diri pelakunya, salah satunya adalah kegelisahan dan kecemasan.

Dengan demikian perasaan selalu terhubung dengan Tuhan merupakan dimensi terpenting dalam spiritualitas yang dengannya individu dapat merasakan ketentraman dan kenyamanan hidup. Sebagaimana Pargament, Koenig dan Perez (2000) menjelaskan bahwa terdapat lima kunci terpenting mengapa spiritualitas dapat memengaruhi kesehatan psikologis 1) *meaning* (makna) ketika seseorang menghadapi keadaan yang tidak menentu spiritualitas akan memberikannya makna untuk memahami dan menafsirkan keadaan tersebut, 2) *control* (kontrol) dimensi selaras dengan makna berserah diri (*surrendering*), 3) *comfort* (nyaman) spiritualitas mengurangi rasa takut berlebihan seseorang ketika menghadapi kebingungan dalam masalah hidup, 4) *intimacy* (keintiman) spiritualitas akan mengarahkan manusia untuk saling berdekatan dengan sesama sebagai pencarian dukungan sosial, dan 5) *life transformation* (transformasi hidup) spiritualitas terkadang mendorong proses konversi pada individu

¹⁸⁴Al-Darini, *Ṭahārāh al- Qulūb wa al- Khudu li al-‘Alam al-Ghuyub*, terj. Ida Nursida dan Tiar Anwar Bachtiar, (Bandung: Mizania, 2008), 51.

untuk meninggalkan nilai-nilai yang lama dan mulai memikirkan serta mengikuti nilai-nilai yang baru.¹⁸⁵

Para mahasiswa kedokteran dengan berbagai jenis stresor akademik yang membebani mereka, membuat beberapa ahli menyarankan mereka untuk menjadikan spiritualitas dan religiusitas menjadi salah satu bentuk koping dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah psikologis-sosial. Berbagai penelitian menunjukkan hasil positif bahwa remaja dan mahasiswa dengan spiritualitas yang baik memiliki mental positif dan lebih puas akan kehidupan yang dihadapi.¹⁸⁶

Rehana et al (2013) dalam studinya juga membuktikan bahwa kesejahteraan spiritualitas yakni pencarian akan makna dan tujuan eksistensi diri menjadi salah satu kunci sukses dalam manajemen diri yang dilakukan oleh mayoritas mahasiswa dalam menyikapi berbagai stresor akademik yang mereka hadapi pada fakultas kedokteran.¹⁸⁷ Margaret Will (2007) bahkan sebelumnya menyebutkan bahwa spiritualitas tidak hanya memengaruhi proses belajar bagi para pelajar perguruan tinggi namun dapat memengaruhi pikiran dan tubuh mereka sekigus.¹⁸⁸

Akan tetapi energi positif spiritualitas terhadap stres bukan merupakan suatu hal yang bisa diterima begitu saja, melainkan terjadi penolakan beberapa tokoh, ahli dan peneliti mengenai peranan spiritualitas terhadap kesejahteraan dan kesehatan individu. Keyakinan bahwa spiritualitas dapat menjadi *buffer* dan sebagai bentuk pertahanan diri dari stres, justru menurut Freud salah satu tokoh klasik

¹⁸⁵Kenneth I. Pargament, Harold G. Koenig dan Lisa M. Perez, "The Many Methods of Religious Coping: Development and Initial Validation of the RCOPE", *Journal of Clinical psychology*, Vol. 56, No. 4, (2000); 519-543.

¹⁸⁶Abdulraouf Y. Lamoshi, "Religion as a Resilience Tool to Manage Stress in Adolescents: Islamic Approach", *Global Journal of Human Social Science*, Vol. 15, No. 3, (2015); 5-7.

¹⁸⁷Rehana Rehman and others, "Health and Spirituality-Walk along in Wellness Journey of Medical Students", *J Pak Med Assoc*, Vol 63, No. 4, (2013); 495-500.

¹⁸⁸Margaret Wills, "Connection, Action and Hope: an Invitation to Reclaim the "Spiritual" in Health Care", *Journal Religion Health*, Vol. 46, (2007); 423-436.

menyatakan bahwa proses mempertahankan diri membuat manusia berhalusinasi bahwa ada sosok “super” yang dapat melindunginya, sehingga demikian spiritualitas memberikan efek negatif terhadap psikologis manusia.¹⁸⁹

Pandangan efek negatif spiritualitas atas kesehatan mental juga justru diyakini oleh sebagian besar para profesional kesehatan, sebagaimana hasil studi yang dilakukan oleh Fosket et al (2004) yang menyebutkan bahwa 45 % ahli profesional kesehatan meyakini bahwa spiritualitas dan religiusitas secara bersamaan dapat menyebabkan kepada penyakit mental, dan hanya 39% meyakini hal sebaliknya.¹⁹⁰

Selanjutnya Leurent et al (2013) meyakini hal serupa bahwa individu yang memiliki pengalaman spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari lebih cenderung mengalami gangguan depresi dibandingkan mereka yang memiliki pandangan sekuler. Dimana hasil studi yang ia lakukan terhadap 8318 responden menunjukkan hasil bervariasi dengan hasil yang signifikan dari sampel di UK, dimana individu spiritualis tiga kali lebih beresiko mengalami depresi dibandingkan kelompok sekular, sementara kelompok dengan keyakinan yang kuat justru dua kali lipat beresiko depresi dibandingkan mereka dengan keyakinan yang rendah. Secara keseluruhan hasil studi menunjukkan bahwa spiritualitas dan agama tidak terbukti menjadi penyanggah akan terjadi depresi setelah menghadapi kejadian serius dalam hidup.¹⁹¹

Pendapat dan pandangan di atas menjelaskan bahwa spiritualitas yang tinggi justru akan meningkatkan resiko gangguan mental

¹⁸⁹Freud menyebut orang yang beragama sebagai “*the universal obsessional neurosis of humanity*”, orang yang beragama diibaratkan sama seperti pasien neurotis yang ditanganin oleh Freud, mereka sama-sama melakukan bentuk-bentuk seremonial dan dalam waktu yang bersamaan mereka akan merasa bersalah seandainya tidak melakukan ritual-ritual tersebut dengan sempurna. Hans Kung, *Freud and the Problem of God*, (Washington: The Wilson Quarterly, 1979), 162.

¹⁹⁰Jhon Foskett, James Marriott, and Fay Wilson Rudd, “Mental Health, religion, and spirituality: Attitudes, Experience, and Expertise among Mental Health Professionals and Religious Leaders in Somerset, *Mental Health, Religion, and Culture*, Vol. 7, No. 1, (2004); 55-22.

¹⁹¹Baptiste Laurent and others, “Spiritual and Religious Beliefs as Risk Factors for the Onset of Major Depression: an International Cohort Study, *Psychological Medicine*, Vol. 43, (2013); 2109-2120.

yang salah satunya stres dan depresi, pendapat ini tentunya bertentangan dengan hipotesis penelitian ini. Adapun penelitian ini mendukung pandangan positif atas spiritualitas dan hubungan positif antara spiritualitas tersebut dengan kesehatan psikologis. Sebagaimana McMahon dan Biggs (2012) menjelaskan bahwa pandangan yang menyatakan spiritualitas merupakan salah satu bentuk keyakinan irasional, hal ini akan selalu menjadi perdebatan bagi para psikolog dan kesehatan karena dilihat semakin hari semakin banyak orang yang menjadikan spiritualitas sebagai bantuan psikologis dan bentuk positif dari coping stres.¹⁹²

3. Regulasi Diri Belajar sebagai Koping Stres

Regulasi diri atau pengelolaan diri merupakan aspek penting dalam menentukan perilaku individu. Meskipun regulasi diri melibatkan tiga aspek penting (metakognisi, motivasi dan perilaku), namun regulasi diri bukan kemampuan mental atau kemampuan akademik, melainkan bagaimana individu mengolah dan mengubah bentuk aktivitasnya.¹⁹³ Ormrod dan Kumara (2002) menjelaskan regulasi diri merupakan standar dan tujuan yang kita tetapkan bagi diri kita sendiri, cara kita memonitoring dan mengevaluasi proses-proses kognitif dan perilaku sendiri, serta konsekuensi-konsekuensi yang kita tentukan sendiri untuk setiap kesuksesan dan kegagalan.¹⁹⁴

Dalam menjelaskan regulasi diri belajar, menurut para ahli ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan yakni; metakognisi, motivasi dan perilaku. Aspek metakognisi mengacu pada pengetahuan seseorang terhadap daya kognisi yang dimilikinya dan pengaturan kognisi tersebut. Metakognisi dalam regulasi diri belajar meliputi perencanaan dan (planing) pemantauan (*monitoring*).¹⁹⁵

¹⁹²Brenden T McMahon dan Herbert C. Biggs, "Examining Spirituality and Intrinsic Religious Orientation as a Means of Coping with Exam Anxiety" (2012) diakses dari: <http://dx.doi.org/10.3402/vgi.v3i0.14918>, pada tanggal 08 September 2017, pukul 11.53 WIB.

¹⁹³M. Nur Ghufro dan Rini Risnawati, *Teori-Teori Psikologi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 57.

¹⁹⁴Jeanne Ellis Ormrod dan Amitya Kumara, *Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang*, Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2002), 30.

¹⁹⁵M. Nur Ghufro dan Rini Risnawati, *Teori-Teori Psikologi*, 60.

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan ke mana harus melangkah. Islam sangat mengajarkan adanya perencanaan yang baik dalam diri manusia atas segala tindakannya di dunia yang bisa menghantar dirinya pada kebaikan akhirat. Dalam surah al-Hasyr ayat 18 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Hasyr: 18).

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengintrospeksi dan memperhatikan apa-apa yang telah dikerjakan untuk perbaikan diri di masa yang akan datang, secara implisit ayat ini mengajarkan perencanaan untuk menjadikan hidup lebih terarah dan bertujuan jelas.

Selanjutnya aspek terpenting dari regulasi diri adalah motivasi. Motivasi berperan mengarahkan seseorang terhadap tingkah laku kesehariannya. Menurut Feist dan Feist (2010), manusia memotivasi dan mengarahkan tindakan mereka melalui kontrol proaktif dengan membuat tujuan yang bernilai yang dapat menciptakan suatu keadaan yang *disequilibrium* dan kemudian mengarahkan segala usaha yang diperlukan untuk sampai pada tujuan.¹⁹⁶ Islam mengajarkan bahwa untuk menjadikan segala sesuatu bernilai ibadah harus berlandaskan motivasi mencari ridha Allah, sehingga akan muncul dari motivasi tersebut perbuatan-perbuatan yang baik dan terus mendorong ikhtiar sempurna, adapun hasilnya maka Allah sendiri yang akan memberikan hasil atas apa yang telah manusia perbuat. Sebagaimana ditegaskan dalam surah an-Najm ayat 39-41:

¹⁹⁶Feist dan Feist, *Tecori Kepribadian*, Edisi 7, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010), 219.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٦٦﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٦٧﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ
الْجِزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٦٨﴾

Artinya:

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya). Kemudian akan diberi Balasan kepadanya dengan Balasan yang paling sempurna”. (Al-Kahfi: 39-41)

Adapun aspek ketiga dari regulasi diri adalah perilaku. Regulasi diri perilaku menurut Zimmerman (1989) merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi, dan memanfaatkan maupun menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas.¹⁹⁷ Diantara pengaturan terpenting dari regulasi diri adalah manajemen waktu. Sebagaimana Stoeger dan Ziegler (2011) menegaskan salah satu aspek terpenting pada pengelolaan diri adalah manajemen waktu.¹⁹⁸ Sebaliknya menurut Golan (2011) kebiasaan membuang waktu adalah salah satu bentuk kegagalan regulasi diri.¹⁹⁹ Sementara dalam Islam manajemen waktu ini sangat penting, dimana setiap muslim selayaknya dapat mengatur waktunya dengan baik sehingga tidak terbuang sia-sia, karena salah satu karakter dari waktu adalah cepat bergulir. Dalam al-Qur'an waktu sangat dimuliakan sampai-sampai banyak sumpah Allah atas nama waktu, seperti “Demi waktu (surah al-‘Asr:1), “Demi waktu dhuha (surah ad-Dhuha:1), “Demi waktu ma-

¹⁹⁷Barry Z. Zimmerman, “A Social Cognitive View of Self Regulated Academic Learning”, *Journal of Educational Psychology*, Vol. 81, (1989); 329-339.

¹⁹⁸Heidrun Stoger and Albert Ziegler, “Self Regulatory Training through Elementary-School Students’ Homework Completion. In Barry Zimmerman dan Dale H. Schunk, *Educational Psychology Handbook Series. Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance*, (New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2011), 87.

¹⁹⁹Moria Golan, “Good-Enough Parenting, Self Regulation, and the Management of Weight-Related Problems”, in Debasis Bagchi, *Global Perspective on Childhood Obesity: Current Status, Consequence and Prevention*, (UK: Academic Press, 2011), 43-55.

lam (surah al-Lail: 1), “Demi waktu siang (Surah al-Lail:2)” dan sebagainya.

Berdasarkan tiga aspek penting regulasi diri sebagaimana dijelaskan di atas (metakognisi, motivasi, dan perilaku), menurut Wibowo (2011) standar nilai dan moral dalam regulasi diri islami adalah akidah Islam, lebih lanjut dirinya menjelaskan regulasi diri islami adalah terdiri dari: (1) pengarahan metakognisi sesuai dengan akidah Islam yaitu pemahaman dan kesadaran tentang proses kognitif, merencanakan, mengorganisasi, mengukur diri, dan menginstruksikan diri dalam kerangka keimanan, (2) pengarahan motivasi yang islami, mencakup semua pemikiran, tindakan atau perilaku dimana seseorang berusaha memengaruhi pilihan, usaha dan ketekunannya dalam rangka beribadah dan bermuamalah yang diwujudkan dalam bentuk dorongan berjuang di jalan Allah (*jihad*) dan dorongan untuk melakukan muamalah atau beramal soleh (*amilussolihat*); dan (3) pengarahan perilaku aktif sebagai *abdullah* dan *khalifatullah*.²⁰⁰

Selanjutnya kemampuan individu meregulasi kognisi, motivasi dan perilaku dalam konteks akademik dikembangkan menjadi regulasi diri belajar (*self regulated learning*) yakni dimana pelajar berusaha mengatur tindakan, motivasi dan kognisi diri yang paling cocok dalam proses belajar yang sedang dijalani.²⁰¹

Regulasi diri belajar didefinisikan secara variatif oleh para ahli, menurut Pintrich & Groot (1990) regulasi diri belajar harus mencakup tiga komponen aktif yang bisa diukur dan diamati indikatornya yakni *academic cognition*, *academic motivation*, dan *academic behavior*.²⁰² Ketiga komponen dasar dalam regulasi diri ini menjadi kunci

²⁰⁰Ugung Dwi Ario Wibowo, “Peran Regulasi Diri Islami dan Karakteristik Pekerjaan terhadap Komitmen Organisasional pada Karyawan Organisasi Syariah”, *Jurnal Psikologika*, Vol. 18, No. 1, (2013); 89-97.

²⁰¹Mohamad Azrien Mohamed Adnan and others, “Self-Regulated Learning and Motivation of Islamic Studies and Non-Islamic Studies Stream Students”, *GESJ; Education Science and Psychology*, Vol. 32, No. 6, (2014); 1-16.

²⁰²*Academic cognition* adalah kemampuan yang digunakan untuk mahasiswa untuk belajar, mengingat, dan mengerti materi-materi yang dipelajarinya. *Academic motivation*, motivasi disini digunakan juga untuk mengukur dimensi emosi pada regulasi diri, seperti mengontrol kepercayaan belajar. *Academic behavior* adalah usaha yang dilakukan mahasiswa dengan merencanakan langkah-langkah dalam strategi belajar. Lih Paul R. Pintrich

dalam manajemen dan merubah keadaan/situasi yang penuh tekanan, sehingga stres yang biasa ditimbulkan oleh stresor dapat dihindari.

Lebih lanjut Pintrich (1999) mendeskripsikan regulasi diri belajar sebagai proses aktif dan konstruktif dimana pelajar mengatur tujuan, membuat rancangan kegiatan, memonitor, mengatur dan mengontrol pikiran, motivasi dan tindakan untuk mencapai kesuksesan dalam belajar.²⁰³ Mahasiswa dengan regulasi diri belajar yang baik memiliki penyesuaian psikologis yang lebih baik, hubungan interpersonal yang lebih baik, dan performansi prestasi yang lebih baik, bahkan menjadi prediktor keberhasilan akademik dibandingkan intelegensi.²⁰⁴

Menurut Zimmerman, regulasi diri belajar digambar sebagai siklus yang berputar yang meliputi *forethought*, *performance*, dan *self reflection*. *Forethought* merupakan fase persiapan, dimana individu membuat tujuan dan sasaran tugas belajar serta merencanakan strategi belajar. *Performance (during)* merupakan tahap yang dilakukan selama proses belajar yang meliputi penggunaan strategi dan monitoring performa diri. *Self reflection* merupakan tahap terakhir yakni tahap sesudah belajar, pada tahap ini individu akan melakukan evaluasi diri sejauh mana target belajar dicapai melalui strategi-strategi yang telah dilakukan.²⁰⁵

Terkait dengan konsep regulasi *reciprocal* dalam regulasi diri belajar yang dikemukakan oleh Zimmerman di atas, Shukor dan Mohd Noor (2014) dalam studinya terkait implementasi regulasi diri belajar dalam pembelajaran studi Islam melakukan konstruk proses regulasi

dan Elisabeth V. De Groot, "Motivational and Self Regulated learning Components of Classroom Academic Performance", *Journal of Educational Psychology*, Vol. 82, No. 1, (1990); 33-40.

²⁰³Paul R. Pintrich, "The Role of Motivation in Promoting and Sustaining Self-Regulated Learning, *International Journal of Educational Research*, Vol. 31, No. 6, (1999); 459-470.

²⁰⁴Angela L. Duckworth & Martin, E.P. Seligman., "Self-Discipline Outdoes IQ in Predicting Academic Performance of Adolescents. *Psychological Science*, Vol. 16, (2006); 939-944.

²⁰⁵Barry J. Zimmerman, "Becoming a Self-Regulated Learner: an Overview", *Theory into Practice*, Vol. 41, No. 2, (2002); 64-70.

diri belajar studi Islam berdasarkan model regulasi diri Zimmerman sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Fase Regulasi Diri Belajar pada Studi Islam²⁰⁶

Fase	Sub-Proses	Regulasi Diri Belajar pada Studi islam
<i>Forethought</i> (Sebelum)	- Pengaturan tujuan - Motivasi - Perencanaan	- Pelajar membuat tujuan belajar - Pelajar Memperkuat motivasi keimanan - Pelajar membuat rencana dan memilih strategi belajar
<i>Performance</i> (selama)	- Penggunaan Strategi	- Pelajar melakukan strategi pembelajaran meliputi: - i- <i>Sima'ah</i> (mendengarkan) - ii- <i>Tajawwub</i> (respon) - iii- <i>Tafakkur</i> dan <i>tadzakkur</i> (berpikir dan mengingat) - iv- <i>Tadzawwuq</i> (pengorganisasian) - v- <i>Taqrir</i> (pengulangan)
<i>Self-Reflection</i> (Refleksi Diri)	- Evaluasi diri - Pengawasan diri	- Pelajar melakukan evaluasi diri dan penilaian diri terkait perkembangan belajar dan melakukan <i>follow up</i> - Pelajar merubah tujuan belajar dan strategi belajar untuk mendapatkan prestasi lebih baik.

Pada tabel di atas regulasi belajar digambarkan sebagai siklus, karena ia merupakan *feedback* dari tingkah laku dan bentuk respon penyesuaian diri terhadap keadaan yang dihadapi. Pelajar khususnya mahasiswa kedokteran yang menyadari berbagai stresor yang dihadapi akan membuat penyesuaian usaha dengan cara mengopti-

²⁰⁶Khairunnisa A. Shukor, dan Ahmad Firdaus Mohd Noor, "Self-Regulated Learning Strategies in Islamic Education", *World Journal of Islamic History and Civilization*, Vol. 4, No.1, (2014); 25-31.

malkan kemampuan berpikir, perilaku dan perasaan agar dapat bertahan dalam proses belajar yang dijalani dan mencapai tujuan studi kedokteran yang telah ditetapkan.

Menurut Zimmerman (1989) regulasi diri dibutuhkan untuk menghantar kepada tujuan.²⁰⁷ Persepsi mahasiswa terhadap tujuan pendidikan sebagai tantangan dapat mengubah stresor yang dihadapi menjadi dorongan rasa berkompetisi dan meningkatkan kompetensi belajar. Sebaliknya persepsi yang memandang tujuan pendidikan adalah ancaman maka stresor yang dihadapi akan memberikan perasaan *hopeless* (kurang harapan) dan menandakan rasa kehilangan yang selanjutnya dapat mengurangi prestasi akademik.²⁰⁸

Stresor yang dihadapi pada dasarnya menimbulkan respon fisiologis dan psikologis yang adaptif pada individu, sehingga demikian kemampuan adaptif inilah yang akan menyebabkan stresor memberikan dampak positif (*eustress*) atau sebaliknya dampak negatif (*distress*). Regulasi diri kemudian diyakini sebagai salah satu bentuk tindakan adatif yang diperlukan untuk menghadapi stresor.²⁰⁹ Aspinwall dan Taylor (1997) menyebutkan bahwa regulasi diri merupakan satu bentuk koping yang proaktif terhadap stres. Regulasi diri dapat mengantisipasi potensi stres dengan cara menganalisis bagaimana menghindari dan menghilangkan dampak stresor, serta membuat tindakan terencana sehingga individu tersebut dapat menekan sejumlah stresor karena regulasi diri yang diterapkan menjadi bentuk penyesuaian diri yang baik.²¹⁰

²⁰⁷Barry J. Zimmerman., "A social Cognitive View of Self Regulated Academic Learning", *Jurnal of Educational Psychology*, Vol. 81, (1989); 329-339.

²⁰⁸Mussarat Jabeen Khan, Seema Altaf dan Hafsa Kausar, "Effect of Perceived Stress on Students' Performance", *FWU Journal if Social Science*, Vol. 7, No. 2, (2013); 146-151.

²⁰⁹John C. Buckner, Enrico Mezzacappa, dan William R. Baerdslee, "Self-Regulation and Its Relations to Adaptive Functioning in Low Income Youths", *American Journal of Orthopsychiatry*, Vol. 79, N0. 1, (2009);19-30.

²¹⁰Aspinwall, Lisa G. dan Shelly, E. Taylor "A Stich in Time: Self Regulation and Proactive Coping", *Psychological Bulletin*, Vol. 121, (1997); 417-436.

Stres dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, sehingga demikian individu tersebut akan mencoba melakukan sesuatu yang dapat mengurangi ketegangan fisik dan emosional akibat stres tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan adalah bagian dari *coping*. *Coping* adalah proses dimana seseorang mencoba untuk mengatur perbedaan yang diterima antara *demands* dan *resources* yang dinilai sebagai penyebab munculnya situasi stres.²¹¹

Alexander et al (2012) mendefinisikan *coping* adalah tindakan untuk merubah kognitif dan tingkah laku untuk mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang dinilai membebani seorang individu.²¹² Selanjutnya Folkman dan Lazarus menegaskan bahwa *coping* harus dilakukan dengan mengikut sertakan usaha (*effortfull*), sehingga hal ini kemudian yang membedakan antara *coping* dan tindakan refleksi. Keduanya mendefinisikan *coping stress* sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang ketika dihadapkan pada tuntutan-tuntutan internal atau mengurangi *distress*.²¹³

Ketika individu menghadapi keadaan yang penuh stres pada umumnya tindakan *coping* yang akan dilakukan adalah dalam dua bentuk *defensive* dan *direct coping*.²¹⁴ Individu yang meyakini bahwa

²¹¹Edward P. Sarafino, *Health Psychology 2nd Edition*, (New York: John Wiley and Sons, 1994), 124.

²¹²Alexander Faisal, Mariangela Gentil Savonia dan Paulo Rossi Menezes, "Coping Style and Depressive Symptomatology during Pregnancy in a private Setting Sample", *The Spanish Journal of Psychology*, Vol. 15, No. 1, (2012); 195-305.

²¹³Lazarus dan Folkman dalam Nuzulia, "Peran Self-Efficay dan Strategi *Coping* terhadap Hubungan antara Stresor Kerja dan Stres Kerja", *Jurnal Psikologika*, No. 19, (2005); 32-40.

²¹⁴1) *Defensive coping* adalah salah satu cara seseorang dalam menghadapi stres dengan lari dari masalah yang menimbulkan stres tersebut baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Freud seluruh tipe *defensive coping* merupakan penyesuaian diri pada realitas yang tidak sehat, kebanyakan pola ini merupakan pelarian dari situasi yang traumatis. 2) *Direct coping* adalah salah satu cara seseorang dalam menghadapi stres dengan menghadapi permasalahan dan mengatasinya. *Direct coping* meliputi pengidentifikasian stres yang masuk (yang dihadapi), kemudian mengadakan perhitungan cara untuk mengatasinya. Lih Ruchan Gokdag, "Defense Mechanism Used by University Students to Cope with Stress, *International Journal on*

stresor tidak dapat dinegosiasi efeknya terhadap stres bersikap seolah menipu sendiri dengan cara meninggalkan keadaan tersebut. Sementara sebaliknya pada *direct coping* individu mengetahui terdapat stresor yang menekan sehingga ia berpikir dan mencari jalan untuk keluar dari keadaan yang dirasakan memberi tekanan (*stressfull*).

Salah satu bentuk *direct coping* atau yang disebut juga dengan istilah efektif *coping* ini adalah regulasi diri. Aldwin (2010) seorang ahli teoretikal regulasi diri menjelaskan hubungan *overlapping* antara *coping* dan regulasi diri. Ketika suatu studi lebih tertarik menyoroti kemampuan seseorang dalam mengatur dan mengarahkan tindakan, emosi dan perhatian secara umum hal ini menjadi regulasi diri, namun ketika usaha untuk merubah kognisi, emosi dan perilaku dikhususkan pada cara menghadapi keadaan tertentu yang menekan, maka hal ini disebut *coping*. *Coping* bersifat sangat fleksibel, individu dapat merubah dan memodifikasi strategi *coping* nya ketika diyakini satu bentuk strategi tidak berhasil dengan baik mengatasi keadaan.²¹⁵

Selanjutnya hubungan regulasi terhadap stresor dapat disebut juga *buffer* terjadinya stres, salah satu faktor terpenting regulasi diri adalah *self efficacy*, mahasiswa yang yakin bahwa mereka mampu menjalani proses pembelajaran akan memiliki kemampuan regulasi diri yang lebih baik dan mampu bertahan dalam sulitnya materi akademik.²¹⁶ Sementara untuk terhindar dari stres karena berbagai stresor akademik yang dihadapi mahasiswa, *self efficacy* juga menjadi salah satu sumber psikologis yang dapat mempertahankan diri dari stres.²¹⁷

Menurut (Bandura, 1997) *self efficacy* menjadi satu bentuk *judgment* “kapasitas mengorganisir dan membuat rancangan tindakan yang dibutuhkan untuk mendapatkan performa yang telah

New Trends in Education and Their Implications, Vol. 6, No. 2, (2015); 1-12.

²¹⁵Carolyn M. Aldwin and others, “Coping and Self-Regulation Across the Life Span”, *Handbok of Life Span Development*, (John Wiley and Sons, Inc, 2014), 563-564.

²¹⁶Dale H. Schunk “Self Regulated Learning: the Educational Legacy of Paul R. Pintrich”, *Educational Psychologist*, Vol. 40, (2005); 85-94.

²¹⁷Christopher J. McCarthy and others, “Psychological Resources as Stress Buffers: Their Relationship to University Students’s Anxiety and Depression”, *Journal of College Counseling*, Vo. 9, (2006); 99-112.

ditentukan”, persepsi diri dapat memengaruhi usaha seseorang dan ketekunannya untuk menghadapi berbagai rintangan.²¹⁸ Sehingga demikian self efficacy secara bersamaan menjadi faktor penting dalam sistem pertahanan psikologis terhadap serangan stres dan juga menjadi inti (*core*) dalam proses regulasi diri.

Dengan demikian dapat dipahami regulasi merupakan usaha spesifik yang terencana untuk mengubah situasi (*planful problem-focused*) dari bentuk *coping*. Regulasi diri dapat dikategorikan sebagai bentuk koping terfokus masalah karena digunakan untuk mengurangi stresor dengan mempelajari cara atau keterlampiran yang baru. Adapun keterlampiran mengolah diri dalam dunia akademik dikenal dengan istilah *self regulated learning*/regulasi diri belajar.

Berbagai pandangan di atas mendeskripsikan posisi regulasi diri sebagai *coping* terhadap stres, karena regulasi diri merupakan salah satu bentuk “*self mastery*/penguasaan diri”, yakni kemampuan individu untuk menguasai kejadian dalam hidupnya, dimana kemampuan ini dapat meniadakan efek stres dan menjadi *buffer* efektif antara potensi stresor dan symptoms stres.²¹⁹ Berdasarkan teori-teori tersebut di atas selanjutnya pada disertasi ini regulasi diri menjadi variabel yang memediasi antara hubungan stresor dan stres, peran regulasi diri dapat mengubah potensi stresor dari *distres* menjadi *eustress*.

C. Spiritualitas dan Regulasi Diri Belajar sebagai Protektor Diri dari Stres

Stres merupakan mekanisme yang sangat kompleks dan menghasilkan berbagai respon (fisiologis, psikologis dan behavior) pada individu yang mengalaminya. Mekanisme yang terjadi kemudian bersifat individual, artinya proses yang dialami dan dirasakan berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam kehidupannya seorang individu akan seringkali menjumpai faktor-faktor yang menyebabkan respon stres yang kemudian disebut dengan stresor.

²¹⁸Albert Bandura, *Self Efficacy: The Exercise of Control*, (New York: Freeman, 1997), 391.

²¹⁹Gordon. S. Gates, Mimi Wolverton, & Walter H. Gmelch, *Research on Stress and Coping in Education*, (Greenwich: Information Age, 2002), 37.

Namun pada hakikatnya stresor tidak selamanya menimbulkan respon stres negatif (*distress*), berbagai pola perilaku atau pikiran-pikiran seseorang yang secara sadar digunakan untuk mengatasi tuntutan-tuntutan dalam situasi yang menekan (*stressful*) dan menegangkan akan menjadikan respon terhadap stresor yang dihadapi menjadi positif (*eustress*).

Proses dinamis individu mengubah secara konstan pikiran dan perilaku mereka dalam merespon stresor inilah yang kemudian disebut *coping*. Ada dua jenis *coping* yang dilakukan individu apabila menghadapi stresor, yakni 1) *emotional-focused coping* yakni jenis *coping* yang digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres. 2) *problem-focused coping* yakni digunakan untuk mengurangi stresor dengan mempelajari cara atau keterlampaian yang baru.²²⁰ Koping stres dilakukan individu untuk mengatasi keadaan atau situasi yang menekan, menantang atau bahkan mengancam dengan menggunakan sumber dalam dirinya maupun lingkungannya. Sumber dalam diri individu yang dikenal juga dengan istilah *personal/psychological resources* dapat menjadi *buffer* (penyagah) terjadinya stres sekaligus *coping* stres. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab terdahulu yang menjadi fokus pada disertasi ini adalah spiritualitas dan regulasi diri.

Spiritualitas menjadi sumber positif pada diri individu dalam menghadapi keadaan yang menekan, karena spiritualitas memberikan pandangan positif dibalik situasi dan keadaan yang terjadi dan memberikan perasaan/emosi yang positif pula. Menurut Lazarus dan Folkman (1984) salah satu cara mengatur respon emosional dalam rangka menyesuaikan diri terhadap stresor adalah dengan *positive reappraisal*, yakni usaha untuk mencari makna positif dari permasalahan dengan terfokus pada pengembangan diri, biasanya hal ini didapat dari hal-hal yang bersifat religius dan spiritual.²²¹

Lazarus dan Folkman (1984) menambahkan bahwa salah satu elemen terpenting dalam proses *appraisal* adalah *belief* (percaya), percaya ini memiliki dua bentuk. Pertama, percaya pada kemampuan

²²⁰Shelly E. Taylor, *Health Psychology*, (New York: McGraw Hill Inc, 2006), 67.

²²¹Richard S. Lazarus dan Susan Folkman, *Stress, Appraisal and Coping*, (New York: Springer-Verlag, 1984), 38.

diri untuk mengontrol keadaan (*personal belief*). Kedua, percaya akan sesuatu yang eksistensial seperti Tuhan dan takdir. *Belief* (percaya) dalam Islam akan menimbulkan keberanian pada diri muslim untuk menghadapi berbagai masalah, karena yakin semua berjalan atas kehendak Allah, bersamaan dengan itu muslim berharap pertolongan akan datang dari Tuhan. Muslim yakin bahwa Tuhan menjamin setiap kesusahan yang sedang dirasakan pasti akan digantikan dengan kesenangan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah ash-Sharh yang ditegaskan sampai dua kali berturut :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ

Artinya:

“(5) Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (6) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (QS. Ash-Sharh: 5-6)

Belief menjadi faktor yang memengaruhi persepsi terhadap stresor, ketika rasa percaya hilang maka *hope* (harapan) akan digantikan dengan rasa *hopelessness* (keputusasaan) dan menimbulkan stres.²²² Ahmad Toha (1992) menyatakan stres merupakan bentuk dominasi syaitan atas diri manusia dan jiwa yang sakit. Hal ini dikarenakan rendahnya kepercayaan beragama dan tidak terjalinnya hubungan dengan Allah.²²³ Sementara Al-Jauzi membagi dua bentuk penyakit yakni *soul* (jiwa) dan *physical* (fisik), obat untuk sakit jiwa adalah menjalin hubungan dengan Tuhan. Menurut al-Jauzi menjaga kesehatan jiwa adalah sumber sehatnya fisik. Mengenal Allah, percaya atas kehendak-Nya dan bergantung pada-Nya adalah nutrisi bagi jiwa yang sehat, ketika hal ini diabaikan maka individu akan merasakan kecemasan, kesedihan, stres dan depresi.²²⁴ Kehilangan *belief* menunjukkan pengabaian akan nilai spiritualitas dan penga-

²²² Richard S. Lazarus dan Susan Folkman, 64.

²²³ Ahmad Toha, *Kedokteran Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), 36.

²²⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Healing with the Medicine of the Prophet*, (KSA; Darussalam, 2003), 36.

baian kepada spiritualitas akan memberikan kontribusi ke tingkat stress yang lebih tinggi.²²⁵

Sehingga demikian pada beberapa penelitian spiritual dibuktikan dapat menjadi protektor dan faktor yang menghantar pada usaha mencegah dan koping terhadap berbagai permasalahan mental. Sementara studi lainnya menunjukkan hasil bahwa spiritualitas dan koping menegaskan reaksi seseorang terhadap stres dipengaruhi kualitas spiritualitas yang dimilikinya.²²⁶ Dengan demikian spiritual diyakini dapat menjadi *buffer* terhadap stres dan juga sekaligus merupakan bentuk koping yang terfokus pada emosi (*emotional focused coping*).

Namun demikian mengatasi stres dengan perspektif spiritual bukan berarti menafikan aspek perbuatan lainnya. Spiritual dalam pandangan holistik menuntut Kita untuk mendekati masalah dengan berbagai cara yang *possible*.²²⁷ Hal ini selaras dengan teori strategi koping itu sendiri bahwa untuk melakukan proses koping individu tidak hanya dituntut mengatur respon emosi namun juga mengubah atau mengatur masalah yang dihadapi dan lingkungan sekitarnya yang menyebabkan terjadi tekanan yakni koping yang terfokus pada masalah (*problem focused coping*).

Salah satu strategi untuk melakukan koping terfokus masalah seseorang harus melakukan *planful problem solving* yakni rangkaian usaha yang terencana, penuh kehati-hatian, bertahap dan analitis. Salah satu tindakan yang bersifat terencana adalah regulasi diri. Menurut Zimmerman seorang pakar regulasi diri menyatakan bahwa regulasi dilakukan dengan mengkoordinasikan pikiran, perasaan, dan

²²⁵Cheryl L. Monaghan and others, *Medical Students Stress and Burnout*, Committedd on Physician Health and Rehabilitation, (2013), 2-3.

²²⁶Darius Krok, "The Role of Spirituality in Coping: Examining the Relationship between Spiritual Dimension and Coping Styles", *Mental Helath, Religion, and Culture*, Vol. 11, No. 7, (2008): 78-84.

²²⁷Stephen G. Wright, *Burnout- Spiritual Crisis*, diakses dari http://mindtouch.jankifoundation.org/api/deki/files/112/=Burnout_-_Spiritual_Crisis.__Wright%252c_Nursing_Standard_2005.pdf pada tanggal 12 Mei 2015 pukul 10.15 WIB

tindakan dimana semuanya digerakkan secara sinergis untuk mencapai tujuan personal.²²⁸

Spiritualitas dapat dilihat sebagai bentuk kecerdasan karena ia dapat memprediksi adaptasi dan menawarkan kapabilitas yang dapat memungkinkan individu memecahkan masalah dan mencapai tujuan.²²⁹ Adapun al-Ghazali menyampaikan bahwa untuk sampai pada tujuan seseorang harus memiliki ilmu pengetahuan akan Tuhan, alam dan dirinya sendiri. Dengan demikian dapat dipahami ada hubungan antara spiritualitas dan regulasi diri.

McCullough dan Willoughby (2009) melakukan analisis literatur terkait hubungan religiusitas/spiritualitas, kontrol diri dan regulasi. Hubungan spiritualitas/religiusitas dari berbagai literatur dapat disarikan dalam tabel 2.5. berikut:

Tabel.2. 5. Proposisi Hubungan/
Pengaruh Spiritualita dan Regulasi Diri²³⁰

Proposisi
1. Spiritualitas/religiusitas memengaruhi regulasi diri dengan cara memengaruhi tujuan seseorang
a. Spiritualitas memengaruhi pemilihan tujuan
b. Spiritualitas meningkatkan pentingnya tujuan dengan mensucikan tujuannya
c. Spiritualitas menekan konflik beberapa tujuan yang dimiliki
d. Spiritualitas memengaruhi bagaimana tujuan tersebut diinternalisasikan
2. Spiritualitas memengaruhi regulasi diri dengan cara meningkatkan <i>self monitoring</i> (monitoring diri)

²²⁸Barry J. Zimmerman, "A social Cognitive View of Self Regulated Academic Learning", *Jurnal of Educational Psychology*, Vol. 81, (1989); 329-339.

²²⁹Maryam Hosseini and others, "A Review Study on Spiritual Intelligence, Adolescence and Spiritual Intelligence, Factors that May Contribute to Individual Differences in Spiritual Intelligence and the Related Theories", *International Journal of Psychological Studies*, Vol. 2, No. 2, (2010); 179-188.

²³⁰Michael E. McCullough and Brian L.B. Willoughby, "Religion, Self-Regulation, and Self Control. Associations, Explanations, and Implications", *Psychological Bulletin*, Vol. 135, No. 1, (2009); 69-93.

- a. Persepsi diperhatikan dan diawasi Tuhan meningkatkan monitoring diri
- b. Komunitas agama sebagai audiensi moral meningkatkan monitoring diri
- c. Beberapa ritualitas agama meningkatkan monitoring diri
3. Spiritualitas memengaruhi regulasi diri dengan cara menunjukkan cara untuk merubah diri
4. Spiritualitas memberi efek kesehatan, kesejahteraan dan tindakan positif sosial melalui regulasi diri sebagai mediatornya.

Hubungan antara spiritualitas sebagaimana disarikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa spiritualitas dan regulasi diri terhubungkan karena faktor *goal accomplishment* (pencapaian tujuan). Wenger (2007) dalam penelitiannya menjelaskan maksud keterhubungan “*goal accomplishment*” adalah seseorang dengan keberimanan yang kuat memiliki usaha yang jelas dan terencana untuk sampai ke tujuan dibandingkan kelompok yang kurang keimanannya.²³¹

Belief yang menjadi inti dari spiritualitas juga dapat memengaruhi regulasi diri, Koole et al (2010) menyebutkan regulasi diri akan meningkat ketika individu mampu menginternalisasikan *faith* (keimanan)/spiritualitas pada dirinya dan akan berusaha keras untuk sampai pada tujuannya, secara implisit individu yang merasakan keterhubungan akan Tuhan senantiasa akan mampu mengontrol dan meregulasi dirinya secara baik.²³²

Dalam konsep Islam *connectedness to God* menjadi inti dari spiritualitas Islam, bahkan berbagai ritualitas dalam Islam seperti sholat adalah sebagai satu bentuk jalan untuk memperkuat ikatan hamba dengan Tuhannya. Keterhubungan dengan Allah khususnya dibutuhkan oleh individu ketika ia dalam tekanan psikologis atau ancaman fisik. Individu dengan spiritualitas yang tinggi mampu menekan gejala emosi ketika dalam kesedihan, kemudian memun-

²³¹ Jay L. Wenger, “The Implicit Nature of Intrinsic Religious Pursuit”, *International Journal for The Psychology of Religion*, Vol. 17, No. 1, (2007); 47-60.

²³² Sander L. Koole, and others, “Why Religion’s Burdens Are Light: From Religiosity to Implicit Self Regulation, *Personality and Social Psychology Review*, Vol 14, No. 1, (2010); 95-107.

culkan emosi positif untuk meregulasi stres yang dirasakan.²³³ Sementara menurut Hamdan (2010) spiritualitas dalam Islam khususnya pada aspek ibadah dapat meningkatkan disiplin diri.²³⁴ Regulasi diri yang terhubung dengan spiritualitas akan memunculkan keberanian untuk berkeinginan besar dan keyakinan diri serta kemantapan berusaha dan optimis dalam diri.²³⁵

Salah satu teori yang menghubungkan antara spiritualitas, regulasi diri dan stres adalah teori yang dikembangkan oleh Nelson (2009) yakni “*indirect effect*” maksudnya adalah spiritualitas tidak secara langsung memengaruhi rendah, sedang atau tinggi stres yang dirasakan, namun spiritualitas terlebih dahulu meningkatkan strategi koping stres yang lebih baik, kemudian secara berkelanjutan baru bisa menjadi *buffer* terhadap kejadian stres. Dengan demikian diperlukan intervensi aspek lain untuk melihat pengaruh spiritualitas terhadap kesehatan/kesejahteraan.

Salah satu studi yang menggunakan model moderator adalah studi yang dilakukan oleh Aldwin²³⁶ et al (2014) dimana secara bersamaan penelitian tersebut membuktikan bahwa ada hubungan positif antara spiritualitas, religiusitas dan regulasi diri. Hasil studi menunjukkan bahwa religiusitas berkorelasi positif dengan regulasi tindakan diri yakni kebiasaan hidup sehat. Sementara spiritualitas berkorelasi positif dan menjadi penghantar emosi positif dalam menghadapi penyakit kronis seperti kardiovaskular dan kanker.

Berbagai teori dan hasil-hasil studi di atas membuktikan bahwa spiritualitas mampu memberikan fungsi positif terhadap regulasi

²³³ Bagher Gobary Bonab and others, “Attachment to God in Islamic Spirituality”, *Journal of Muslim Mental Health*, Vol. 7, No. 2, (2013); 77-104.

²³⁴ Aishah Hamdan (2010), “A Comprehensive Contemplative Approach from the Islamic Tradition, Bab dalam Thomas G. Plante, *Contemplative Practice in Action: Spirituality, Meditation, and Health*, (Santa Barbara: Praeger, 2010), 122-142.

²³⁵ Aftina Nurul Husna, Frieda N.R., Hidayati, dan Jati Ariati. “Regulasi Diri Mahasiswa Berprestasi”, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 13, No. 1, (2014); 50-63.

²³⁶ Carolyn Aldwin, Crystal Park, Yu-Jin Jeong dan Tiwik Nath, “Differing Pathways Between Religiousness, Spirituality, and Health: a Self Regulation Perspective”, *Psychology of Religion and Spirituality*, Vol. 6, No. 1, (2014); 9-21

diri, sehingga demikian pandangan yang mengatakan bahwa spiritualitas dan keyakinan (*belief*) kepada Tuhan adalah sebagai bentuk irasionalitas dapat dibantahkan. Seperti Ellis yang mengatakan bahwa spiritualitas dan keyakinan terhadap Tuhan adalah pola pikir yang irasionalistik bahkan berpotensi terhadap permasalahan psikologis lainnya.²³⁷

Beberapa peneliti lainnya seperti Norcross²³⁸ dan Siddle²³⁹ cenderung memaknai spiritualitas sebagai abnormalitas. Bahkan studi terakhir Laurent et al (2013) memberikan hipotesis bahwa kelompok yang memiliki spiritualitas yang lebih tinggi akan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami serangan depresi dibandingkan mereka kelompok sekular.²⁴⁰

Kemampuan regulasi diri menjadi jawaban mengapa statement “spiritualitas adalah bentuk irasionalitas dan abnormalitas” dapat dibantahkan karena beberapa peneliti menyatakan bahwa regulasi diri dilakukan secara sadar (*conscious*) dan proses yang penuh usaha (*effortful process*)²⁴¹ dan spiritualitas menjadi elemen penting yang dapat meningkatkan kemampuan regulasi diri tersebut. Spiritualitas terbukti dapat meningkatkan pikiran positif seperti optimisme, selanjutnya optimisme diperlukan dalam *self esteem*, sedangkan *self esteem* menjadi aspek penting dalam proses regulasi diri.

²³⁷ Albert Ellis, “Psychotherapy and Atheistic Values; A Reason to AE Bergin’s Psychotherapy and Religious Values”, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol. 48, (1980); 635-639.

²³⁸ Jhon C. Norcross, “Evidence-Based Therapy Relationship,” Sponsored by the American Psychological Association’s (APA) Division of Psychotherapy and Division of Clinical Psychology (2010); 29-30.

²³⁹ Ronal Siddle and others, “Religious Delusions in Patients Admitted to Hospital With Schizophrenia”, *SocPsychiatry Epidemiol*, Vol.37, (2002); 130-138.

²⁴⁰ Baptiste Laurent and others, “Spiritual and Religious Beliefs as Risk Factors for the Onset of Major Depression: an International Cohort Study”, *Psychological Medicine*, Vol. 43, (2013); 2109-2120.

²⁴¹ Carver, C.S., & Scheier, M.F. dalam Carolyn Aldwin, Crystal Park, Yu-Jin Jeong dan Tiwik Nath, “Differing Pathways Between Religiousness, Spirituality, and Health: a Self Regulation Perspective”, *Psychology of Religion and Spirituality*, Vol. 6, No. 1, (2014); 9-21.

Penelitian ini tertarik untuk mengidentifikasi model hubungan stres, stresor, spiritualitas dan regulasi diri. Pada umumnya stres ditimbulkan karena pengaruh stresor yang dihadapi namun demikian tidak semua stresor akan disikapi sama dan memberikan dampak yang sama dan searah secara negatif antara satu individu dengan individu lainnya. Ketika individu mampu mempertahankan sumber psikologis positif yang salah satunya adalah spiritualitas, maka tekanan stresor terhadap stres dapat dikurangi bahkan dihilangi. Sehingga demikian spiritualitas pada penelitian ini diposisikan sebagai *buffer* (penyanggah) terjadinya *distress*. Namun demikian pada penelitian ini efek spiritualitas sebagai pertahanan morbiditas juga melibatkan aspek penting lainnya dalam proses coping stres itu sendiri yakni regulasi diri.

Adapun regulasi diri pada penelitian ini diposisikan sebagai variabel yang memoderasi hubungan stresor, spiritualitas dan regulasi diri. Sehingga secara bersamaan dalam proses coping stres, spiritualitas dapat menjadi coping yang terfokus pada emosi (*emotional focused coping*) dan regulasi diri adalah bentuk coping yang terfokus pada masalah (*problem-focused coping*). Pola dan model coping spiritualitas dan regulasi secara holistik yang ditawarkan pada disertasi ini diharapkan dapat mengubah potensi yang akan ditimbulkan oleh stresor yakni dari *distress* menjadi *eustress*.

Akhirnya berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan dan dianalisis di atas yaitu teori CRS (*conservation of resources theories*) yang menyatakan bahwa tekanan psikologis terjadi ketika sumber signifikan hilang. Ketika teori ini dihubungkan dengan teori "*distress-detterent model/stress counter balancing model*" yang menyatakan bahwa spiritualitas diyakini dapat menjadi *buffer* (penyanggah) akan terjadinya stres, maka pengabaian kebutuhan spiritualitas dapat memberikan kontribusi stres yang lebih tinggi. Bersamaan dengan kedua teori tersebut, penulis juga menggunakan pendekatan tasawuf untuk lebih jauh mengungkap dimensi keterhubungan dengan Tuhan sebagai aspek fundamental dalam spiritualitas seperti iman, tawakkal, ridha, tafakur, muraqabah, raja', isti'anah, takhalluq dan sebagainya. Teori-teori ini selanjutnya digunakan penulis untuk menganalisis temuan-temuan pada penelitian kuantitatif dan kualitatif yang dijelaskan pada dua bab berikutnya.

BAB III

PENGARUH STRESOR, SPIRITUALITAS DAN REGULASI DIRI TERHADAP STRES MAHASISWA KEDOKTERAN

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan desain penelitian *sequential explanatory* yakni penelitian kuantitatif sebagai pendekatan utama dan kualitatif sebagai fasilitator. Sehingga dengan demikian pada bab ketiga ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian empiris yang difokuskan pada analisis data kuantitatif.

A. Deskripsi Kampus Partisipan

Penelitian ini dilakukan pada tiga Fakultas Kedokteran dari beberapa Universitas terpilih di DKI Jakarta yang terdiri dari: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Trisakti, dan Universitas YARSI. Adapun profil setiap kampus partisipan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah merupakan mata rantai sejarah perkembangan perguruan tinggi Islam dalam menjawab kebutuhan pendidikan tinggi Islam modern di Indonesia. Namun demikian UIN Syarif Hidayatullah tidak hanya menjadi “Jendela Islam di Indonesia”, tetapi juga sebagai simbol bagi kemajuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pembangunan sosial-keagamaan. Sebelum tahun 1998/1999 UIN Syarif Hidayatullah memiliki konsep pendidikan setingkat institut. Pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Azyumardi Azra, pendidikan tinggi ini lebih diintensifkan berkonversi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dengan dibukanya jurusan Psikologi dan Pendidikan Matematika pada fakultas Tarbiyah pada tahun 1998 dan Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Syariah pada tahun 1998. Langkah konversi ini semakin dimantapkan dengan dibu-

kanya program studi Agrobisnis dan Teknik Informatika pada tahun 2000 dan satu tahun setelahnya yakni 2001 diresmikan Fakultas Psikologi dan Dirasat Islamiyah. Pada perkembangan selanjutnya, melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 031 tanggal 20 Mei 2002 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi resmi menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Satu langkah pemantapan eksistensi UIN Syarif Hidayatullah sebagai pendidikan tinggi terkemuka dalam integrasi keilmuan agama dan umum dibuktikan dengan kembali diresmikannya ilmu kedokteran Islam¹ dengan dibukanya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada tahun 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1338/D/T/2004. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan semakin mantap menjadikan Visi FKIK-UIN Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi kedokteran dan ilmu kesehatan terkemuka dalam mengintegrasikan aspek keilmuan kedokteran, kesehatan, ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

Visi FKIK-UIN Syarif Hidayatullah ditegaskan dengan dibentuknya program unggulan “*Integrated Moslem Doctor and Bioethics*” (IMDB) yakni sebuah modul yang mempelajari serta mendiskusikan berbagai ajaran Islam yang berkaitan dengan kesehatan dilihat dari sudut pandang ilmu kedokteran saat ini. IMDB menjadi

¹Menurut Abuddin Nata ada beberapa karakteristik ilmu kedokteran Islam diantaranya; *pertama*, ilmu kedokteran Islam menekankan pada aspek pencegahan (*preventifi*) dari pada pengobatan (*kuratif*). Dengan prinsip ini ilmu kedokteran Islam berupaya menumbuhkan kehidupan yang sehat dengan menerapkan pola hidup sehat dengan makanan yang sehat, meninggalkan makanan yang berbahaya, serta meningkatkan olah raga tubuh dan istirahat yang cukup. *Kedua*, ilmu kedokteran Islam berbasis pada penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, bukan berdasarkan khurafat, bid'ah, dan takhayul. *Ketiga*, ilmu kedokteran Islam bersifat *integrated* dan holistik yakni ilmu kedokteran yang didasari pada pandangan bahwa terjadinya penyakit bukan hanya disebabkan karena hubungan yang tidak baik dengan alam (makan, minuman, tempat tinggal, pola hidup dan lainnya) namun juga dapat disebabkan oleh hubungan yang tidak baik dengan Allah SWT dan sesama manusia. *Keempat*, ilmu kedokteran Islam menekankan pola hidup sederhana dan seimbang, serta menerapkan pola konsumsi yang berbasis vegetarian, yakni lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayuran dibandingkan makhluk bernyawa. Lih Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011), 407-408.

ciri khas UIN Syarif Hidayatullah dibandingkan Pendidikan Ilmu Kedokteran berbasis Perguruan Tinggi Keislaman lainnya di DKI Jakarta, dikarenakan pelaksanaan IMDB terintegrasi secara langsung pada modul-modul keilmuan kedokteran yang diberikan kepada mahasiswa pada tahap kesatu dan tahap kedua.²

Adapun jumlah mahasiswa sampai dengan tahun 2016 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) dari tiga angkatan yang diikutsertakan sebagai populasi pada penelitian ini adalah berjumlah 279 mahasiswa/i dengan rincian: Mahasiswa tahun 2016 (tahun pertama) sejumlah 83 orang; mahasiswa tahun 2015 (tahun kedua) sejumlah 104 orang; dan mahasiswa tahun 2014 (tahun ketiga) sejumlah 92 orang. Dari keseluruhan populasi yang ada jumlah sampel dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

2. Universitas Trisakti

Universitas Trisakti merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbesar dan universitas swasta yang pertama didirikan di Indonesia. Universitas Trisakti resmi didirikan pada tanggal 29 November 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 013/dar/1965 yang ditanda tangani oleh Dr. Syarif Thayeb. Dimana pada tahun berikutnya 1967 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri, SH menawarkan agar Universitas Trisakti menjadi perguruan Tinggi Negeri,

²Kurikulum FKIK UIN Syarif Hidayatullah adalah berbasis kompetensi, selanjutnya PSPD (Program Studi Pendidikan Dokter) ini dibagi menjadi tiga tahap pendidikan sebagai berikut: Pendidikan tahap kesatu merupakan pendidikan kedokteran berupa keterlampilan belajar sepanjang hayat, keterlampilan generik dan sikap peduli terhadap lingkungan/masyarakat. Modul yang terdapat pada tahun pertama adalah pembelajaran sistem tubuh manusia secara fisiologis. Tahap kedua merupakan pendidikan terintegrasi horizontal dan vertikal untuk mencapai pengetahuan kedokteran dalam menanggulangi pasien dan masyarakat secara ilmiah berlangsung minimal 6 semester. Modul yang diberikan adalah pembelajaran sistem tubuh manusia secara patologis. Tahap ketiga merupakan pendidikan berbasis kompetensi sebagai kemampuan profesi klinik dan kedokteran komunitas yang berlangsung minimal 3 semester. Wawancara dosen FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis 12 Januari 2017.

namun pihak Universitas memutuskan untuk tetap sebagai Perguruan Tinggi Swasta.

Fakultas kedokteran Trisakti didirikan bersama-sama dengan fakultas lainnya di tahun yang sama di masa peresmian dengan dua jurusan yakni Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi. Melalui Fakultas Kedokteran dan Kedokteran GIGI pihak kampus berkeinginan mampu menghasilkan lulusan yang dapat mandiri dan mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan iptekdok sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dengan kecakapan khusus di bidang kesehatan kerja, geriatri dan penelitian.³

Sistem pengajaran di FK Trisakti terbagi pada dua program. *Pertama*, Program Studi Sarjana Kedokteran (PSKK), program ini berjalan selama enam semester kuliah modul dan satu semester untuk kepaniteraan klinik dasar. *Kedua*, Program Studi Profesi Dokter (PSPD), pada program ini beban studi dan lama kepaniteraan yang ditempuh adalah selama empat semester. dibuktikan dengan kembali diresmikannya Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan.⁴ Adapun jumlah mahasiswa disebutkan bahwa sampai dengan tahun 2016 dari tiga tingkatan yang diikutsertakan sebagai populasi dalam penelitian ini terdapat 576 mahasiswa/i yang secara aktif masih mengikuti perkuliahan dengan rincian: Mahasiswa tahun 2016 (tahun pertama) berjumlah 163 orang; mahasiswa tahun 2015 (tahun kedua) sejumlah 205 orang; dan mahasiswa tahun 2014 (tahun ketiga) sejumlah 206 orang.⁵ Dari keseluruhan populasi yang ada jumlah sampel dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

3. Universitas YARSI

Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) diketuai oleh Prof. dr. Asri Rasad, M.Sc., Ph.D. pada tanggal 11 April 1967 guna memfokuskan pada sumber daya Muslim pada lapangan medik atau kesehatan yang saat itu masih sangat jarang. Selanjutnya pada tahun

³Wawancara staf pegawai akademik Fakultas kedokteran Universitas Trisakti, Selasa 24 Januari 2017.

⁴Sistem Pendidikan FK Trisakti, diakses dari <http://fk.trisakti.ac.id/tentang-fk/sistem-pendidikan> pada hari Jum'at, 8 Desember 2017, Pukul 21.55 WIB

⁵Wawancara staf pegawai akademik Fakultas kedokteran Universitas Trisakti, Selasa 24 Januari 2017.

1969 YARSI memberikan pelayanan jasa pendidikan sebagai Perguruan Tinggi Kedokteran YARSI Jakarta dan statusnya berubah menjadi Sekolah Tinggi Kedokteran YARSI Jakarta. Sampai pada saat itu YARSI mempertegas komitmennya sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran Islam yang sangat diperhitungkan eksistensi saat itu.

Dengan prestasi yang baik sebagai sekolah kedokteran, para pendiri memutuskan untuk membuka beberapa fakultas baru sesuai dengan perencanaan yayasan untuk mengembangkan konsep Sekolah Tinggi menjadi Universitas, sehingga pada tahun 1988-1999 dibuka tiga fakultas baru yakni Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknologi Industri dan Sekolah Tinggi Kedokteran menjadi Fakultas Kedokteran. Pada tahun 2007 YARSI membuka Fakultas Psikologi dan beberapa tahun berikutnya dibuka Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi (Prodi IKG) sehingga sampai saat ini pada Fakultas Kedokteran terdapat dua Program yakni Kedokteran dan Kedokteran Gigi.

Sebagai Perguruan Tinggi Islam yang terpadang melalui Fakultas Kedokteran YARSI memiliki visi untuk mewujudkan para dokter muslim yang bermutu dan mengamalkan profesinya sesuai dengan ajaran Islam.⁶ Kurikulum FKUY (Fakultas Kedokteran Umum YARSI) dirancang untuk dapat diselesaikan dalam 10 semester yang terdiri dari 7 semester program sarjana dokter (146 SKS) dan 3

⁶Para dokter muslim telah merumuskan 9 (sembilan) etika kedokteran muslim: 1) Dokter-dokter muslim harus berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi, jauh dari i'tikad dan perbuatan syirik, munkar, *takhayul* dan *bid'ah*; 2) Diusahakan membangkitkan kembali kedokteran Islam yang murni; 3) Pemberantasan perdukunan, kebatinan, sihir dan sebagainya; 4) Membuang semua cara pengobatan yang bertentangan syariat dan *syubhat*; 5) Menguasai membuang semua lambang berbau jahiliyah dan lambang berbau non-Islam lainnya; 6) Berusaha memilih obat-obatan yang halal dan baik, bersih dari unsur *khamar* dan barang haram lainnya; 7) Berusaha mengimbangi kedokteran sekular secara *ihsan*; 8) Mengharamkan dokter-dokter Islam membantu lembaga-lembaga yang anti Islam; 9) Berusaha mendirikan lembaga-lembaga kedokteran, rumah sakit, klinik dan lainnya sambil menyampaikan dakwah dan *tabligh*. Lih Abuddin Nata, Achmad Gholib dan Fauzan, *Fikih Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2017), 100.

semester program profesi dokter. Sistem Pendidikan di FKUY dilaksanakan dalam bentuk kegiatan perkuliahan, diskusi, tutorial, praktikum dan skill lab (keterampilan klinik) dengan sistem pembelajaran PBL (*problem based learning*). Selanjutnya kurikulum fakultas secara menyeluruh dievaluasi setiap 5 tahun serta dievaluasi periodik setiap tahunnya terhadap pelaksanaan kurikulum. Untuk kurikulum YARSI memberikan studi keagamaan secara intensif yang diberikan hampir di setiap semester mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 bernama Blok Agama 1 sampai Blok Agama 5.⁷

Adapun jumlah mahasiswa sampai dengan tahun 2016 dari tiga tingkatan yang diikutsertakan sebagai populasi dalam penelitian ini terdapat 815 mahasiswa/i yang secara aktif masih mengikuti perkuliahan dengan rincian: Mahasiswa tahun 2016 (tahun pertama) berjumlah 250 orang; mahasiswa tahun 2015 (tahun kedua) sejumlah 275 orang; dan mahasiswa tahun 2014 (tahun ketiga) sejumlah 290 orang.⁸ Dari keseluruhan populasi yang ada jumlah sampel dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

B. Deskripsi Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui metode angket yang berlangsung dari tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan 20 Desember 2016. Sebanyak 378 partisipan dari tiga Universitas di Jakarta mengikuti proses penelitian pada tahap awal ini. Adapun hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara akan dijelaskan pada berikutnya.

Subjek penelitian dideskripsikan berdasarkan kriteria Universitas dimana partisipan sedang menjalani proses pendidikan ilmu kedokteran, tahun pendidikan, *gender* dan agama partisipan. Selanjutnya setiap kriteria tersebut di atas dijelaskan pada sub pembahasan berikut ini:

⁷Profil Kurikulum Fakultas Kedokteran YARSI diakses dari <http://fk.yarsi.ac.id/struktur-kurikulum/> pada tanggal 13 Desember 2017, pukul 21.13 WIB

⁸Wawancara staf pegawai akademik Fakultas kedokteran Universitas YARSI, Selasa 24 Januari 2017.

1. Universitas Partisipan

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa ilmu kedokteran di Jakarta. Melalui proses perizinan yang cukup panjang akhirnya tiga universitas bersedia mengikut sertakan mahasiswanya secara aktif pada penelitian ini. Ketiga Universitas tersebut adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sebanyak 135 orang (35.7%), Universitas Trisakti sebanyak 115 orang (30.4%) dan Universitas YARSI sebanyak 128 orang (33.9). Tabel 3.1 di bawah ini memperjelas demografi responden berdasarkan universitas tempat studi Ilmu Kedokteran yang sedang dijalankan.

Tabel 3.1. Jumlah Partisipan Berdasarkan Universitas⁹

UNIVERSITAS	FREKUENSI	PERSENTASE
UIN	135	35.7 %
TRISAKTI	115	30.4 %
YARSI	128	33.9 %
JUMLAH	378	100 %

2. Tahun Pendidikan Partisipan

Penelitian ini hanya dibatasi pada mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan ilmu kedokteran pada tahun pertama, kedua dan ketiga. Adapun mahasiswa dari tahun keempat dan seterusnya ke atas tidak dapat diikutsertakan, hal ini dikarenakan mahasiswa pada tahun tersebut tidak terkonsentrasi secara aktif di dunia kampus melainkan sudah terfokus pada berbagai kegiatan terkait pra dan pre-program dokter muda seperti KKR yaitu pengenalan kegiatan koas (ko-asisten) di setiap stase/bagian dan pembekalan koas bahkan beberapa sudah aktif menjalankan program koas ko-asisten (koas).¹⁰

Pada table 3.2 partisipan dengan kategorisasi tahun pendidikan dijelaskan sebagai berikut : tahun pertama sebanyak 126 orang (33.3%), tahun kedua sebanyak 130 orang (34.4%) dan tahun ketiga sebanyak 122 orang (32.3%).

⁹Lihat lampiran, “Deskripsi Subjek Penelitian – Universitas Partisipan”.

¹⁰Periode praklinik adalah periode dimana mahasiswa kedokteran belajar dikampus seperti layaknya mahasiswa fakultas lain. Sementara Koas merupakan suatu periode pendidikan dokter yang ditekankan pada penerapan (aplikasi) teori-teori yang sebelumnya sudah didapat dari periode praklinik.

Tabel 3.2. Jumlah Partisipan Berdasarkan Tahun Pendidikan¹¹

TAHUN PENDIDIKAN	FREKUENSI	PERSENTASE
Tahun ke-1	126	33.3%
Tahun ke-2	130	34.4%
Tahun ke-3	122	32.3%
JUMLAH	378	100 %

3. *Gender* Partisipan

Pada tabel 3.3 partisipan terbanyak adalah perempuan yakni sebanyak 265 orang (70.1%) dan laki-laki sebanyak 113 orang (29.9%), meskipun demikian penelitian ini dilakukan tanpa kecenderungan *gender* tertentu tetapi hanya berdasarkan sampel yang ditemui saat pengumpulan data kuantitatif berlangsung.

Tabel 3.3. Jumlah Partisipan Berdasarkan *Gender*¹²

<i>GENDER</i>	FREKUENSI	PERSENTASE
Laki-laki	113	29.9%
Perempuan	265	70.1%
JUMLAH	378	100 %

4. Agama Partisipan

Penelitian ini tidak membatasi pada mahasiswa muslim, namun demikian data penelitian menunjukkan bahwa agama mayoritas partisipan adalah Islam yakni sebanyak 361 orang (95.5%), Katolik sebanyak 6 orang (1.6%), Protestan sebanyak 9 orang (2.4%), Hindu 1 orang (0.3%), dan Budha 1 orang (0.3%). Tabel 3.4 di bawah ini memperjelas frekuensi agama partisipan:

¹¹Lihat lampiran, “Deskripsi Subjek Penelitian – Tahun Pendidikan Partisipan”.

¹²Lihat lampiran, “Deskripsi Subjek Penelitian – *Gender* Partisipan”.

Tabel 3.4. Jumlah Partisipan Berdasarkan Agama¹³

AGAMA	FREKUENSI	PERSENTASE
ISLAM	361	95.5%
KATOLIK	6	1.6%
PROTESTAN	9	2.4%
HINDU	1	0.3%
BUDHA	1	0.3%
JUMLAH	378	100 %

C. Analisis Tematik: Kondisi Mahasiswa Kedokteran

Pada sub bab tematik, penulis akan menguraikan beberapa identifikasi masalah secara tematik yang berhasil diungkap pada penelitian ini. Sub bab ini akan menguraikan kondisi mahasiswa kedokteran yang meliputi aspek prevalensi stres, stresor yang dihadapi mahasiswa, selanjutnya akan menjelaskan signfikasi spiritualitas dan regulasi diri terhadap penekanan pengaruh negatif stresor terhadap stres yang dihadapi mahasiswa. Selain itu dinamika kondisi di atas akan dikorelasikan signifikansinya terhadap perbedaan demografi responden berdasarkan tahun pendidikan dan latar belakang *gender*.

1. Prevalensi Stres Mahasiswa Kedokteran

Perubahan dan perkembangan zaman saat ini mengakibatkan masalah yang dihadapi semakin beragam, dimana diantaranya adalah masalah lingkungan dan tuntutan, serta persaingan antar individu dan kelompok. Seiring dengan perubahan waktu tersebut terdapat harapan dan pencapain kualitas diri, dimana ketika individu tidak sanggup memenuhi tuntutan dan harapan tersebut, maka hal tersebut dapat menimbulkan stres.¹⁴ Pada tahap awal stres terjadi karena ketiadaan keseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki individu, selanjutnya semakin tinggi kesenjangan tersebut semakin tinggi kemungkinan stres dapat terjadi.

¹³Lihat lampiran, “Deskripsi Subjek Penelitian – Agama Partisipan”.

¹⁴Vilaseeni V. Pathmanathan & M. Surya Husada, “Gambaran Tingkatan Stres Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Semester Ganjil Tahun Akademik 2012/2013”, *E-Journal FK USU*, Vol. 1, No. 1, (2013); 1-4.

Stres merupakan suatu ketidakseimbangan yang besar antara tuntutan baik fisik maupun psikologis dengan kemampuan respon sehingga terjadi kegagalan untuk memenuhi permintaan tersebut.¹⁵ Stres merupakan suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dialami oleh setiap orang, bahkan manusia memiliki pengalaman terhadap stres sebelum mereka lahir.¹⁶ Stres dapat terjadi pada siapa saja tanpa pandang usia yakni dari bayi, remaja, dewasa sampai lanjut usia. Diantara kelompok yang mudah terpapar stres adalah mahasiswa.

Selanjutnya mahasiswa yang secara umum diketahui memiliki keunikan tantangan akademis¹⁷ yang lebih tinggi dibandingkan rekan mahasiswa mereka lainnya dari fakultas berbeda adalah mahasiswa ilmu kedokteran.¹⁸ Berbagai riset terakhir mengungkapkan perbandingan prevalensi yang cukup tinggi terkait permasalahan psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi antara mahasiswa kedokteran dengan rekan sejawat mereka dari populasi keilmuan berbeda.¹⁹

Beberapa riset mendokumentasikan hasil studi terkait tingkat stres pada mahasiswa kedokteran, secara umum tingkat stres maha-

¹⁵Heiman dan Kariv, "Task Oriented Versus Emotion-Oriented Coping Strategies: The case of College Students", *College Students Journal*, Vol. 39, No. 1, (2005); 72-89.

¹⁶Smeltzer & Bare, *Textbook of Medical Surgical Nursing Vol. 2*, (Philadelphia: Lippincott William & Wilkins, 2008), 78.

¹⁷Mahasiswa kedokteran memiliki tantangan studi lebih tinggi dikarenakan mereka dituntut untuk mempelajari dan menguasai ilmu yang cukup banyak dan spesifikasi keahlian. Ditambah lagi tuntutan sosial masyarakat yang menuntut tingkat profesionalisme yang cukup tinggi untuk standarisasi dokter, sehingga tidak jarang menempatkan mereka di bawah tekanan yang lebih besar. Lih Sherina Mohd. Sidik dan Nadarajan Kaneson, "The Prevalence of Depression Among Medical students", *Malaysian Journal of Psychiatry*, Vol. 11, No. 1, (2003); 12-17.

¹⁸Marc Schmitter and others, "Chronic Stress in Medical and Dental Education", *MED Teach*, no. 29, (2005); 1085-1088.

¹⁹Ayat R. Abdullah and Hala M. Gabr, "Depression, Anxiety, and Stress among First Year Medical Students in an Egyptian Public University", *International Research Journal of Medicine and Medical Sciences*, Vol. 2, No. 1, (2014); 11-19.

siswa berada di *range* dari 12% sampai dengan 73%.²⁰ Adapun berdasarkan data kuantitatif studi ini lebih lanjut membagi tiga kategorisasi prevalensi stres mahasiswa kedokteran secara umum melalui metode angket, sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5. Kategorisasi Prevalensi Stres²¹

SKOR	KATEORI	FREKUENSI	PERSENTASE
11-20	Rendah	65	17.2 %
21 - 32	Sedang	256	67.7 %
≥ 32	Tinggi	57	15.1 %
Jumlah		378	100%

Berdasarkan tabel 3.6 tingkat kategorisasi stres pada mahasiswa kedokteran terbanyak masuk pada kategori sedang dengan jumlah responden sebanyak 256 atau hasil persentase 67.7%, sebanyak 65 orang mahasiswa memiliki stres ringan yakni 17.2% dan diketahui sebanyak 57 orang mahasiswa berada pada kategorisasi stres ringan atau sejumlah 15.1%. Tabel 3.5 mengindikasikan bahwa mahasiswa kedokteran memiliki tingkat stres yang relatif bervariasi dan tidak cenderung tinggi dan rendah.

Menurut Rasmun (2004) pembagian stres kepada tiga kategori menjelaskan stres ringan adalah stres yang tidak merusak aspek fisiologis dari seseorang. Stres ringan dapat dirasakan oleh setiap orang. Stres ringan biasanya terjadi dalam beberapa menit atau beberapa jam. Keadaan stres ringan tidak akan menimbulkan kondisi yang berbahaya kecuali jika dihadapi terus menerus.²² Stres sedang terjadi lebih lama, dari beberapa jam bisa mencapai beberapa hari.

Sementara tingkat stres tinggi atau berat adalah stres jenis kronis yang terjadi dan berlangsung beberapa minggu, bulan bahkan tahun. ketika stres kronis terjadi pada mahasiswa akan menimbulkan

²⁰Ibrahim Ginawi, and others, "Do Study of Medicine Leads to Increase Depression and Anxiety, Study from Ha'il University, Saudi Arabia", *Journal of Public Health*, Vol. 9, No. 1, (2014); 7-14.

²¹Lihat lampiran "Analisis Tematik- Kategorisasi Prevalensi Stres".

²²Rasmun, *Stres, Koping dan Adaptasi*, Edisi ke-1, (Jakarta: Sagung Seto, 2004), 13.

efek negatif pada emosi, mental dan kesejahteraan fisik lainnya.²³ Sebuah studi menunjukkan stres psikologis yang berkepanjangan pada mahasiswa kedokteran berhubungan signifikan dengan rendahnya konsep diri²⁴, kecemasan dan depresi²⁵, gangguan tidur²⁶, sinisme, berkurangnya fokus dan konsentrasi belajar serta ketidakpercayaan diri dalam menyelesaikan studi²⁷. Pada akhirnya bisa jadi mahasiswa merasa tidak pantas dan tidak puas dengan karir profesi dokternya di masa depan.²⁸

Stres yang dihadapi mahasiswa kedokteran dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, penurunan konsentrasi belajar dan penurunan daya ingat.²⁹ Namun demikian tingkat stres yang dirasakan mahasiswa berbeda berdasarkan lamanya tahun pendidikan yang sedang dijalani, dalam artian stres dapat menurun seiring dengan bertambahnya masa pendidikan, mahasiswa semester awal cenderung mengalami tingkat stres yang lebih tinggi. Adapun berdasarkan hasil uji komparasi pada penelitian ini, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan stres yang signifikan antara tahun pendidikan pertama, kedua, dan ketiga. Melalui uji *Independent sample t-test*, stres berda-

²³Muhammad Saiful Bahri Yusoff dan Ab Rahman Esa, "Stress Management for Medical Students: A Systematic Review", *Social Sciences and Humanities: Applications and Theories*, Book 3, In Press.

²⁴Henry K. Silver and Anita Duhal Glicken, "Medical Students Abuse: Incidence, Severity, and Significance", *JAMA*, Vol. 263, No. 4, (1990); 950-952.

²⁵Shauna L. Shapiro and others, "Stress Management in Medical Education: A Review of the Literature", *Acad Med*, Vol. 75, No. 7, (2000); 748-759.

²⁶Paivi M. Niemi and Paula T. Vainiomaki, "Medical Students Distress – Quality, Continuity and Gender Difference during a Six-Year Medical Programme", *Med Teach*, Vol. 28, No. 2, (2006); 136-141.

²⁷Liselotte, N. Dyrbye and others, "Medical Students Distress: Causes, Consequences, and Proposed Solutions", *Mayo Clin Proc*, Vol. 80, No. 12, (2005); 1613-1622.

²⁸Ratana, Saipanish, "Stress among Medical Students in a Thai Medical School", *Journal Medical Teacher*, Vol. 2, No. 5, (2003); 502-506.

²⁹Margaret Sutjiato, G.D. Kandaou, dan A.A.T Tucuman, "Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Tingkat Stres pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado", *JIKMU*, Vol. 5, No. 1, (2015); 30-42.

sarkan tahun pendidikan memiliki nilai signifikansi sebesar $\text{sig} = 0.285$ ($p > 0.05$),³⁰ maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan varian pada data stres berdasarkan perbedaan tahun pendidikan.

Namun demikian, jika dilihat rata-rata skor stres terlihat bahwa mahasiswa tahun pertama memiliki kecenderungan tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dua tahun pendidikan di atasnya yakni tahun kedua dan ketiga. Sedangkan tahun ketiga memiliki kecenderungan stres yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa dari tahun pendidikan kedua. Tabel 3.6 menjelaskan data kuantitatif dinamika kejadian stres berdasarkan tahun pendidikan:

Tabel 3.6. Perbandingan Nilai Mean Tahun Pendidikan terhadap Stres³¹

Stres Mahasiswa Kedokteran	Tahun Pendidikan	Mean
	Tahun ke-1	26.60
	Tahun ke-2	25.48
	Tahun ke-3	26.33

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbedaan stres berdasarkan tahun pendidikan tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu besar, sekalipun skor stres mahasiswa tahun pertama menduduki posisi pertama dengan skor *mean* sebesar 26.60, kemudian dilanjutkan oleh mahasiswa dari tahun ketiga dengan skor *mean* sebesar 26.33 dan terakhir mahasiswa tahun ketiga memiliki nilai skor *mean* yang paling rendah yakni sebesar 25.48.

Hasil penelitian ini selaras dengan beberapa laporan riset terdahulu yang menjelaskan bahwa mahasiswa kedokteran dengan tingkat stres yang tertinggi adalah mereka yang berada di tahun pertama pendidikan dokter.³² Demikian pula studi yang dilakukan di Zimbabwe melaporkan bahwa tujuh bulan setelah mahasiswa memasuki fakultas kedokteran didapati sebanyak 64.5% mereka merasakan

³⁰Lihat lampiran, “Analisis Komparasi Tahun Pendidikan *One Way Anova* Stres”.

³¹Lihat lampiran, “Analisis Komparasi Tahun Pendidikan *One Way Anova* Stres”

³²Bibhusan Basnet and others, “Depression among Undergraduate Medical Students”, *Medical Education*, Vol. 10, No. 3, (2012); 56- 59.

berbagai tingkat stres termasuk depresi.³³ Mahasiswa tahun pertama bisa jadi mengalami stres yang lebih dikarenakan mereka masih memasuki masa adaptasi sistem pembelajaran yang sangat berbeda ketika mereka masih belajar di sekolah menengah atas.

Selanjutnya stres menurun pada tahun kedua pendidikan dikarenakan mahasiswa sudah mulai terbiasa dan mampu beradaptasi dengan lingkungan kampus dan pola pembelajaran di perguruan tinggi.³⁴ Namun demikian stres meningkat kembali ketika mahasiswa memasuki tahun ketiga masa pendidikannya, dikarenakan beban materi perkuliahan semakin banyak dengan tingkat kesulitan yang semakin tinggi, ditambah lagi mahasiswa tahun ketiga sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke masa pra klinik. Hal ini senada dengan hasil studi di Saudi Arabia yang menjelaskan tingkat tertinggi stres dialami mahasiswa tahun pertama yang kemudian diikuti oleh mahasiswa praklinik tahun ketiga.³⁵

Kajian terkait stres pada mahasiswa kedokteran tidak hanya menyoroti pada perbedaan tingkat stres berdasarkan tahun pendidikan, beberapa studi terdahulu menjelaskan perbedaan signifikan pada stres berdasarkan *gender* (laki-laki dan perempuan). Perbedaan stres yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dikarenakan pandangan mereka terhadap subjek, dosen, program akademik, ruangan kelas dan sikap mereka terhadap stresor yang ditemui.³⁶ Namun demikian hasil komparasi penelitian ini mengungkapkan tidak ada perbedaan stres yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Melalui uji *t-test*, perbedaan stres pada mahasiswa kedokteran dalam penelitian ini signifikansinya sebesar $\text{sig}=0.465$ dengan nilai $F 0.086$ karena

³³RF. Vaz, EF Mbajorgu and SW. Acuda, "A Preliminary Study of Stress Levels among First Year Medical Students at University of Zimbabwe", *Cent Afr J Med*, Vol. 44, No. 9, (1998); 214-219.

³⁴Ajit Singh, Amar Lal, and Shekhar, "Prevalence of Depression among Medical Students of a Private Medical College in India", *Online Journal of Health and Allied Sciences*, Vol. 9, No. 4, (2010); 1-3.

³⁵Bazmi Inam, "Anxiety and Depression among Students of a Medical College in Saudi Arabia", *International Journal Health Science (Qassim)*, Vol. 1, No. 2, (2007); 214-219.

³⁶Glenn M. Calaguas, "College Academic Stress: Differences along Gender Lines". *Journal of Social and Development Sciences*, Vol.1, No. 5, (2011); 194-201.

$p > 0.05$ maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan varian data stres pada mahasiswa laki-laki dan perempuan.

Namun, jika dilihat perbedaan nilai *mean* stres pada laki-laki dan perempuan, penelitian ini menjelaskan bahwa laki-laki memiliki stres yang lebih tinggi dari perempuan sebagaimana *mean* laki-laki adalah $26.47 > 25.98$ (*mean* perempuan) meski dengan selisih yang sangat tipis diantara keduanya. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini berikut:

Tabel 3.7. Perbandingan Nilai Mean *Gender* terhadap Stres³⁷

Stres Mahasiswa Kedokteran	Tahun Pendidikan	Mean
	Laki-laki	26.47
	Perempuan	25.98

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan, hal ini selaras dengan riset yang dilakukan oleh Mostafa et al (2008) bahwa hasil studi mengenai perbedaan *gender* terhadap mahasiswa kedokteran tidak menunjukkan hasil yang signifikan dikarenakan memang pada fakultas kedokteran tingkat seleksi mahasiswa yang cukup ketat ditambah lagi sifat homegenitas dan keunikan masing-masing karakter mahasiswa sangat diperlukan dalam persaingan lingkungan sekolah kedokteran.³⁸

Sementara pada hasil perbandingan *mean* dimana pada penelitian ini laki-laki memiliki tingkat stres yang lebih tinggi adalah berbeda dengan beberapa hasil terdahulu yang secara umum menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan memiliki tingkat stres yang lebih tinggi, seperti studi yang dilakukan oleh Sherina and Kaneson (2003) menyebutkan prevalensi stres pada mahasiswa perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki.³⁹

³⁷Lihat lampiran, “Analisis Komparasi Gender (*Independent Sample t-Test*) Stres”.

³⁸Mostafa Amr Md, and others, “Does Gender Predict Medical Students’ Stress in Mansoura, Egypt?”, *Medical Education Online*, Vol. 13, No. 1, (2008); 1-8.

³⁹Mohd Sidik Sherina dan Nadarajan Kaneson, “The Prevalence of Depression among Medical Students”, *Malaysian Journal of Psychiatry*, Vo. 11, No. 1, (2003); 12-17.

Namun demikian kecenderungan stres pada laki-laki menurut beberapa ahli sangat mungkin terjadi dikarenakan lelaki kurang mendapat dukungan sosial padahal dukungan sosial sangat diperlukan untuk menekan stres akibat kejadian sehari-hari (*daily life events*), sehingga demikian kerentanan stres kepada laki-laki sangat mungkin terjadi. Bahkan diantara tiga kasus bunuh diri mahasiswa kedokteran di Indonesia yang cukup mencengangkan publik pelakunya adalah laki-laki. Pada tahun 2011 seorang mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Jakarta berinisial SW usia 23 tahun melakukan lompat dari lantai 24 apartemennya dan tewas seketika.⁴⁰ Sementara itu, pada tahun 2014 seorang mahasiswa kedokteran Perguruan Tinggi Negeri di Banda Aceh inisial FA usia 25 tahun didapati gantung diri di rumah kontrakannya.⁴¹ Kasus lain pada tahun 2014, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan dari Perguruan Tinggi Negeri di Bogor, dimana korban berinisial AB (21 tahun) ditemukan tewas gantung diri di rumah korban.⁴²

Selanjutnya perbedaan stres pada *gender* dikarenakan strategi pengelolaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, untuk menghilangkan stres perempuan cenderung mengungkapkan dengan cara menangis dan berbagi perasaan dengan lainnya dalam artian meminta dukungan sosial. Sementara laki-laki lebih cenderung menutup permasalahan hidupnya dan lebih banyak menyelesaikan masalah dengan aktifitas fisik seperti olahraga. Sehingga pada analisis kejadian stres mahasiswa laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan karena untuk menghilangkan stres dengan fisik tentu mahasiswa laki-laki tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk beraktifitas

⁴⁰Detik News, *Motif Bunuh Diri Mahasiswa Kedokteran UIN Masih Misterius*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/1731491/motif-bunuh-diri-mahasiswa-kedokteran-ui-masih-misterius>, pada Tanggal 18 Januari 2018, Pukul 10.19 WIB.

⁴¹Aceh Tribun News, *Kasus Bunuh Diri Calon Dokter Sangat Mengejutkan Kita*, diakses dari <http://aceh.tribunnews.com/2014/08/29/kasus-bunuh-diri-calon-dokter-sangat-mengejutkan-kita>, pada Tanggal 18 Januari 2018, Pukul 10. 24 WIB.

⁴²Merdeka.com. *Mahasiswa Kedokteran IPB ditemukan Tewas Gantung Diri*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/mahasiswa-kedokteran-ipb-ditemukan-tewas-gantung-diri.html>, pada Tanggal 18 Januari 2018, Pukul 10.26 WIB.

secara fisik mengingat padatnya waktu dan banyaknya tugas studi kedokteran yang harus mereka kerjakan.

2. Dinamika Stresor Mahasiswa Kedokteran

Menurut Lazarus stres terjadi ketika individu mempersepsikan keadaan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bahkan membahayakan dan ia tidak mampu mengatasinya.⁴³ Stres yang muncul merupakan hasil interaksi antara stresor (sumber stres) dan persepsi individu terhadap stresor tersebut.⁴⁴ Studi kedokteran dianggap sebagai profesi mulia di tengah masyarakat dan seringkali dianggap sulit dengan persaingan yang ketat. Oleh karena itu pendidikan kedokteran dianggap sebagai sebuah lingkungan penuh tekanan bagi pelajar.⁴⁵

Saat ini para ahli banyak mengungkap penyebab timbulnya stres di kalangan mahasiswa kedokteran. Stresor akademik muncul saat berlangsungnya proses pendidikan di kampus. Penyebab stres pada mahasiswa kedokteran adalah berbeda antar satu individu dengan individu lainnya. Berdasarkan beberapa penelitian akademik, sosial, fisik dan emosi menjadi faktor yang dipersepsikan memengaruhi stres pada mahasiswa kedokteran.⁴⁶

Menurut Margaret et al (2015) faktor yang menyebabkan stres mahasiswa kedokteran terbagi pada faktor eksternal dan internal. Faktor internal berasal dari dalam diri mahasiswa sendiri seperti kondisi fisik, motivasi, dan tipe kepribadian. Adapun faktor eksternal

⁴³Richard S. Lazarus, "Coping Theory and Research: Past, Present, and Future", *Psychosom Med*, Vol. 55, No. 3, (1993); 234-247.

⁴⁴Sami abdo Radman al-Dubai and others, "Stress and Coping Strategies of Students in a Medical Faculty in Malaysia", *Malaysian, J Med Sci*, Vol. 18, NO. 3, (2011); 57-64.

⁴⁵Muhammad Saiful Bahri Yusoff and others, "Prevalence and Source of Stress among Universiti Sains Malaysia Medical Students", *Malaysian J Med Science*, Vol. 17, No. 1, (2010); 30-37.

⁴⁶Mohd Nazeer and Razia Sultana, "Stress in it's Coping Strategies in Medical Students", *Sch. J. App. Med. Sci*, Vol. 2, No. 6D, (2014); 3111-3117.

biasanya berasal dari luar individu seperti keluarga, pekerjaan, lingkungan kampus, dosen dan lain-lain.⁴⁷

Yusoff (2011) mendefinisikan stresor sebagai faktor individu atau lingkungan dan kejadian yang dapat menyebabkan stres. Selanjutnya setelah melakukan analisis kajian-kajian terkait stres ia memformulasikan enam stresor yang dihadapi mahasiswa yakni stresor terkait akademik (*academic related stressors*) atau ARS, stresor terkait inter dan intrapersonal (*interpersonal and intrapersonal related stressors*) atau IRS, stresor terkait pengajaran dan pembelajaran (*teaching and learning related stressors*) atau TLRS, stresor terkait sosial (*social related stressors*) atau SRS, stresor terkait keinginan studi (*desire related stressors*) atau DRS dan stresor terkait aktifitas group (*group activities related stressors*) atau GARS.⁴⁸

Selanjutnya dalam mengidentifikasi sumber stres pada mahasiswa kedokteran penelitian ini mengadopsi alat ukur yang dikembangkan oleh Yusoff tersebut. Tabel 3.8. menjelaskan hasil analisis urutan keenam stresor tersebut berdasarkan nilai mean yang didapatkan pada setiap jenis stresor:

Tabel 3.8. Tingkat Stresor berdasarkan *Mean Degree*⁴⁹

No	Aspek Stresor	Mean	St. Deviasi
1.	ARS	36.31	6.88
2.	TLRS	11.51	2.75
3.	GARS	8.81	2.11
4.	IRS	6.10	1.69
5.	DRS	5.51	1.95
6.	SRS	2.83	0.94

Tabel di atas menjelaskan bahwa stresor terkait akademik menempati posisi teratas dengan nilai mean 36.31, selanjutnya posisi kedua ditempati stresor terkait pengajaran dan pembelajaran dengan

⁴⁷Margaret Sutjiato, G.D. Kandaou, dan A.A.T Tucuman, “Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Tingkat Stres pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado”, *JIKMU*, Vol. 5, No. 1, (2015); 30-42.

⁴⁸Muhammad Saiful Bahri Yusoff, “A Confirmatory Factor Analysis Study on the Medical Students Stressor Questionnaire among Malaysian Medical Students”, *Medicine Journal*, Vol. 3, No. 1, (2011); e44-e53.

⁴⁹Lihat lampiran “Analisis Tematik – Stresor”.

nilai mean 11.51. Selanjutnya secara berurut posisi ketiga adalah stresor terkait aktifitas kelompok ($mean = 8.81$), keempat adalah stresor terkait interpersonal dan intrapersonal ($mean = 6.10$), kelima adalah stresor terkait keinginan studi ($mean = 5.51$) dan keenam stresor terkait sosial ($mean = 2.83$).

Selain dari pada enam kategori stresor yang dideskripsikan pada hasil penelitian di atas beberapa studi lain mengungkap faktor munculnya stres seperti Radman et al (2011) menyebutkan diantara sumber stres lainnya yang dihadapi mahasiswa kedokteran adalah kekhawatiran masa depan, kesulitan finansial, masalah keluarga, rendahnya konsep diri, tinggal jauh dari keluarga, perubahan pola makan dan jam istirahat, suasana klinik dan rumah sakit praktek, serta kondisi ruangan perkuliahan yang tidak nyaman.⁵⁰

Dalam proses pendidikan akademik, setiap mahasiswa memiliki tingkat stres yang berbeda antar satu individu dengan individu lainnya, termasuk sumber stres yang mereka rasakan dan persepsikan juga bisa berbeda antar individu ataupun perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan lamanya masa pendidikan yang telah ditempuh. Sebagaimana hasil uji komparasi pada penelitian ini, menunjukkan hasil bahwa ada perbedaan yang signifikan antara tahun pendidikan pertama, kedua dan ketiga terhadap stresor yang mereka hadapi dan rasakan. Melalui perhitungan *oneway anova* didapati nilai signifikan sebesar 0.037 .⁵¹

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang juga mengemukakan ada perbedaan signifikan antara tahun pendidikan dan stresor.⁵² Pada penelitian ini stresor paling tinggi dijumpai oleh mahasiswa kedokteran tahun pendidikan ketiga sebagaimana tabel 3.9 mendeskripsikan lebih lengkap perbedaan nilai *mean* stresor berdasarkan tahun pendidikan:

⁵⁰Sami Abdo Radman al-Dubai and others, "Stress and Coping Strategies of Students in a Medical Faculty in Malaysia", *Malaysian, J Med Sci*, Vol. 18, NO. 3, (2011); 57-64.

⁵¹Lihat lampiran "Hasil Analisis Komparatif Stresor dan Tahun Pendidikan- *Compare Mean Anova*".

⁵²Zaid, ZA, Sook Ching Chan, and Jacqueline Ho, "Emotional Disorders among Medical Students in a Malaysian Private Medical School", *Singapore Med J*, Vol. 48, No. 10, (2007); 895-899.

Tabel 3.9. Perbandingan Nilai Mean Tahun Pendidikan terhadap Stresor⁵³

Stresor Mahasiswa Kedokteran	Tahun Pendidikan	Mean
	Tahun ke-1	69.37
	Tahun ke-2	70.61
	Tahun ke-3	73.13

Berdasarkan tabel perbedaan nilai *mean* tahun pendidikan dan stresor pada mahasiswa kedokteran menunjukkan bahwa mahasiswa dari tahun ketiga memiliki stresor yang lebih tinggi dengan nilai *mean*=73.13, dilanjutkan oleh mahasiswa tahun kedua dengan nilai *mean*=70.61 dan terakhir mahasiswa tahun pertama dengan nilai *mean*= 69.37. Hal ini dapat dipahami yakni ketika sumber stres terkait akademik merupakan stresor utama yang dihadapi oleh mahasiswa⁵⁴ maka analisis lebih lanjut membuktikan bahwa pada tingkat yang lebih tinggi tingkat spesifikasi keilmuan dirasakan lebih sulit oleh mahasiswa, ditambah lagi pada tahun ketiga mahasiswa sudah dalam persiapan diri untuk mengikuti program praktikum dan klinik.

Selain perbedaan tahun pendidikan dan stresor, dalam penelitian ini juga dilakukan pengujian komparasi antara perbedaan *gender* dan stresor. Berdasarkan uji komparasi melalui *t-test* dengan signifikansi sebesar $\text{sig}=0.932$ ($p>0.05$) menunjukkan bahwa perbedaan *gender* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stresor yang dihadapi mahasiswa kedokteran. Akan tetapi apabila dilihat dengan nilai *mean* perempuan memiliki sumber stres yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki (laki-laki= 70.97, perempuan= 71.10)⁵⁵. Tabel 3.10 mendeskripsikan nilai perbedaan *mean* stresor berdasarkan perbedaan *gender*.

⁵³Lihat lampiran, “Analisis Komparasi Tahun Pendidikan *One Way Anova* – Stresor”.

⁵⁴Johari AB, I Noor Hassim, “Stress And Coping Strategies Among Medical Students In National University Of Malaysia, Malaysia University Of Sabah And University Kuala Lumpur Royal College Of Medicine Perak”, *J Community Health*, Vol 15, (2009); 106-115.

⁵⁵Lihat lampiran “Hasil Analisis Komparatif Stresor dan Tahun Pendidikan- *Independent Sample T-Test*”.

Tabel 3.10. Perbandingan Nilai *Mean Gender* terhadap Stresor⁵⁶

Stresor Mahasiswa Kedokteran	<i>Gender</i>	<i>Mean</i>
	Laki-laki	70.97
	Perempuan	71.10

Berdasarkan tabel di atas mahasiswa perempuan dengan nilai *mean*=71.10 lebih tinggi menyetujui bahwa item yang diformulasikan dalam penelitian ini merupakan sumber stres, sementara mahasiswa laki-laki dengan nilai *mean*=70.97 memiliki persepsi yang lebih rendah dalam mempersepsikan item tersebut sebagai stresor. Berkaitan dengan perbedaan stresor antara laki-laki dan perempuan dikarenakan persepsi yang muncul diantara keduanya adalah berbeda, bahwa perempuan lebih cemas akan ketidakmampuannya dibandingkan laki-laki, sementara laki-laki lebih rileks, aktif dan eksploratif dan perempuan lebih sensitif.⁵⁷ Semakin santai seseorang semakin rendah keadaan atau kejadian yang dihadapi sehari-hari dipersepsikan sebagai sumber stres.⁵⁸

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa mahasiswi perempuan memiliki stresor yang lebih tinggi dengan mahasiswa laki-laki adalah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thomson & Dey (1998) yang menyebutkan perempuan memiliki eksperien stresor yang lebih tinggi dari laki-laki.⁵⁹ Meski demikian meskipun perempuan memiliki persepsi stresor yang lebih tinggi bukan berarti akan selalu diikuti dengan kekurangan antusias dalam studi.⁶⁰ Meskipun

⁵⁶Lihat lampiran, “Analisis Komparasi *Gender (Independent Sample t-Test)* – Stresor”.

⁵⁷Margaret Sutjiato, G.D. Kandaou, dan A.A.T Tucuman, “Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Tingkat Stres pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado”, *JIKMU*, Vol. 5, No. 1, (2015); 30-42.

⁵⁸Suparto, *Schat Menjelang Usia Senja*, (Bandung: Rosda, 2003), 244.

⁵⁹Carolyn, J. Thompson and Eric, L. Dey, “Pushed to the Margins: Sources of Stress for African American College and University Faculty, *The Journal of Higher Education*, Vol. 69, No. 3, (1998); 324-345.

⁶⁰Darwin, D. Hendel, “The Relationship between Academic Life Conditions and Perceived Sources of Faculty Stress Over Time”, *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, Vol. 17, No. ½, (2008); 61-88.

stresor dianggap lebih tinggi belum pasti akan menyebabkan stres yang lebih tinggi, sebagaimana hasil analisis stres dan *gender* justru laki-laki memiliki stres yang lebih tinggi meskipun mereka memiliki persepsi stresor yang lebih rendah, dalam hal ini diperlukan analisis aspek lain yang dapat memengaruhi hubungan stresor dengan stres, maka penelitian ini lebih lanjut akan membahas secara khusus interaksi spiritualitas dan regulasi diri belajar dalam hubungannya terhadap stres.

3. Domain Spiritualitas Mahasiswa Kedokteran

Stresor yang dihadapi mahasiswa kedokteran akan memberikan dampak yang berbeda pada setiap individu mahasiswanya. Stresor dipahami sebagai situasi, keadaan, rangsangan lain yang dianggap tantangan atau ancaman, artinya stresor dapat memberi pengaruh positif atau negatif. Ketika individu menghadapi kejadian hariannya, ia akan membangun persepsi akan hal tersebut apakah menjadi ancaman atau tantangan, diantara berbagai faktor yang memengaruhi persepsi individu terhadap kejadian hariannya adalah faktor psikologis⁶¹ dan spiritualitas merupakan salah satu dimensi psikologis manusia yang dapat mempertahankan kognitif dan persepsi positif untuk tetap stabil dalam keadaan menghadapi stresor.⁶²

Dalam konteks akademik dan pendidikan tinggi, spiritualitas diyakini menjadi integritas dan identitas diri bagi mahasiswa, Braskamp (2007) kemudian menyebut istilah “*whole student*” atau mahasiswa seutuhnya.⁶³ Mahasiswa meyakini bahwa dalam proses

⁶¹Faktor pikiran yakni berupa pemaknaan diri dan lingkungan, seperti pemaknaan terhadap pengalaman dan antisipasi kedepan bisa membuat *relax* atau *stress*. Arlina Gunarya, *Manajemen Stres*, (Makasar: Modul MD 08 TOT Basic Study Skills, Angkatan ke V dan VI, 2008), 3.

⁶²Anthony N. Fabrucatore, and others, “Personal Spirituality as a Moderator between Stressors and Subjective Well-Being”, *Journal of Psychology and Theology*, Vol. 28, N0. 3, (2012); 221-228.

⁶³Menurut Braskamp mahasiswa diharapkan dapat tumbuh menjadi “*whole student/holistic students*”, yakni dalam tumbuh kembangnya pelajar diharapkan dapat berkembang secara utuh baik secara intelektual, fisik, kognitif, emosi dan spiritual. Larry A. Braskamp, “Fostering Religious and Spiritual Development of Students during College (Electronic Version), diakses dari <http://religion.ssric.org/reforum/Braskamp.pdf> pada tanggal 27 April 2017 pukul 15.46.

pendidikan yang sedang mereka jalani merupakan salah satu usaha pencarian makna hidup dan bagaimana berhubungan dengan orang lain.⁶⁴ Sehingga dengan demikian secara otomatis dalam proses pendidikan yang mereka jalani secara bersamaan merupakan salah satu bentuk usaha pengembangan nilai spiritualitas dalam diri mereka, karena spiritualitas dapat bermakna pencarian seseorang akan makna dan tujuan hidup.⁶⁵

Pada beberapa penelitian menjelaskan pada kenyataannya mahasiswa perguruan tinggi menyatakan bahwa spiritualitas menjadi bagian terpenting dalam kehidupan mereka, mahasiswa memiliki level spiritualitas yang tinggi, melalui spiritualitas mereka mencoba mencari makna dan tujuan hidup, bahkan lebih dari itu mahasiswa juga menunjukkan komitmen yang cukup tinggi dalam beribadah, pada akhirnya spiritualitas diyakini memainkan peran penting dalam psikologis dan kesejahteraan fisik mahasiswa.⁶⁶

Pada penelitian ini deskripsi tingkat spiritualitas mahasiswa kedokteran diawali dengan paparan hasil kuantitatif tiga tingkat kategorisasi tinggi, sedang dan rendah dengan nilai minimum 52 sampai dengan nilai maksimum 93. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat spiritualitas pada mahasiswa kedokteran yang terbanyak berada pada kategori tinggi dengan jumlah 177 mahasiswa (46.8%), dalam kategori rendah sebanyak 131 mahasiswa (34.7%) dan pada kategori sedang sebanyak 70 mahasiswa (18.5%). Artinya hasil ini menunjukkan bahwa tingkat spiritualitas mahasiswa kedokteran relatif bervariasi dengan mayoritas berada pada kategori tinggi. Untuk diketahui lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini:

⁶⁴University of California at Los Angeles (UCLA), *Spirituality in Higher Education*, diakses dari <http://www.spirituality.ucla.edu>. Pada tanggal 27 April 2017 pukul 16.03.

⁶⁵Thomas, J. Johnson, Jean Kristeller and Virgil, L. Sheets, "Religiousness and Spirituality in College Students: Separate Dimensions with Unique and Common Correlates", *Journal of College and Character*, Vol. 2, (2004); 1-36.

⁶⁶University of California at Los Angeles (UCLA), *Spirituality in Higher Education*, diakses dari <http://www.spirituality.ucla.edu>. Pada tanggal 27 April 2017 pukul 16.03.

Tabel 3.11. Tingkat Kategorisasi Spiritualitas⁶⁷

SKOR	KATEORI	FREKUENSI	PERSENTASE
52-71	Rendah	131	34.7
72-74	Sedang	70	18.5
≥ 75	Tinggi	177	46.8
Jumlah		378	100 %

Dalam mendefinisikan istilah spiritualitas, beberapa peneliti menghubungkan spiritualitas dengan hubungan kepada sesuatu yang memiliki kekuatan atas diri manusia, seperti Fenzel (1996) mengembangkan sebuah alat ukur untuk mengukur tipe spiritualitas individu yang kemudian ia namakan “*spiritual life integration/SLI*”, dia menggunakan SLI untuk mengukur sejauh mana individu memiliki persepsi terkait hubungannya dengan Tuhan, kemudian bagaimana individu tersebut mengintegrasikan hubungan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana ia menyakini bahwa dengan hubungan tersebut ia dapat mengendalikan berbagai kesulitan dalam hidupnya. Berdasarkan pengukuran ini, individu yang memiliki skor yang tinggi menurut SLI akan memiliki tekanan (stres) yang rendah dan memiliki daya tahan diri yang lebih tangguh dalam menghadapi stresor.⁶⁸ Bahkan spiritualitas dapat memberikan harapan tanpa batas.⁶⁹ Dengan demikian spiritualitas merupakan potensi positif yang tidak mengenal batas yang dimiliki individu.

Spiritualitas yang dikonseptualisasikan sebagai potensi positif manusia kemudian menarik perhatian para peneliti. Seperti Fabricatore et al (2000) dalam studi mereka menemukan spiritualitas berhubungan positif dengan kesejahteraan diri. Mereka menguji dari 120 mahasiswa, stresor memiliki impek negatif terhadap kesejahteraan diri, tetapi kemudian spiritualitas individu secara positif langsung memengaruhi kesejahteraan diri dan mampu memoderasi hubungan

⁶⁷Lihat lampiran, “Analisis Tematik – Spiritualitas”.

⁶⁸L. Mickey Fenzel, *Spiritual Involment Scale*, (Unpublished Manuscript, Layola Collage in Maryland, Balumore, MD).

⁶⁹Marion Beauregard & Denyse O’Leary, *The Spiritual Brain A Neuroscientist’s Case for the Existence of the Soul*, (London: HarperCollins Publishers Ltd, 2007), 73.

antara stresor dan kesejahteraan diri, spiritual secara signifikan mampu menambah prediksi kesejahteraan diri.⁷⁰

Pada penelitian lain spiritualitas berhubungan terbalik dengan stres, pada studi terhadap 332 orang berusia 19 sampai dengan 79 tahun ditemukan tingkat spiritualitas berhubungan dengan pengalaman tingkat stres dalam hidup, dan ternyata *gender* memiliki pengaruh signifikan terhadap spiritualitas, dimana laki-laki memiliki perbedaan signifikan dengan perempuan terkait tingkat spiritualitas yang mereka miliki.⁷¹ Hasil penelitian tersebut selaras dengan hasil studi yang dilakukan oleh penulis dimana didapati perbedaan yang signifikan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan terkait tingkat spiritualitas dengan signifikan sebesar $\text{sig}=0.032$ karena $p<0.05$ maka dapat dikatakan ada perbedaan varian pada data spiritualitas pada mahasiswa laki-laki dan perempuan.⁷² Tabel 3.12. di bawah mendeskripsikan lebih jelas berikut ini:

Tabel 3.12. Perbandingan Nilai *Mean Gender* terhadap Spiritualitas⁷³

Spiritualitas Mahasiswa Kedokteran	<i>Gender</i>	<i>Mean</i>
	Laki-laki	45.65
	Perempuan	48.86

Tabel di atas menjelaskan ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan pada spiritualitas. Nilai *mean* spiritualitas pada mahasiswa perempuan (48.86) lebih tinggi dari nilai *mean* laki-laki (45.65). Namun demikian pada beberapa riset lainnya seperti Rich (2012) justru menunjukkan hasil sebaliknya dimana tidak ada

⁷⁰Anthony N. Fabructore, and others, "Personal Spirituality as a Moderator between Stressors and Subjective Well-Being", *Journal of Psychology and Theology*, Vol. 28, N0. 3, (2012); 221-228

⁷¹B.J. James, & C.A. Samuels, "High Stress Life Events and Spiritual Development", *Journal of Psychology and Theology*, Vol. 27, No. 3, (1999); 250-260.

⁷²Lihat lampiran, "Hasil Analisis Komparatif *Gender* terhadap Spiritualitas- *Independent Sample t-Test*."

⁷³Lihat lampiran, "Analisis Komparasi *Gender (Independent Sample t-Test – Spiritualitas)*".

perbedaan konstruk spiritualitas antara laki-laki dan perempuan dan perbedaan laki-laki hanya sedikit saja di bawah perempuan.⁷⁴

Signifikansi pengaruh perbedaan *gender* terhadap spiritualitas juga disampaikan oleh Bryant (2007) yang secara khusus meneliti perbedaan *gender* dalam perkembangan spiritualitas selama masa perkuliahan, hasil penelitian terhadap sampel 3.680 mahasiswa menunjukkan hasil bahwa ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan memiliki tingkat spiritualitas yang lebih tinggi selama masa studinya. Mahasiswa perempuan memiliki pengalaman dan pencarian spiritualitas yang lebih tinggi terkait kebijaksanaan, makna, dan keindahan. Mereka meyakini ada perubahan positif searah dengan spiritualitas yang mereka miliki selama masa perkuliahan. Mahasiswi juga menjadi lebih aktif dalam berbagai kegiatan amal bakti (*charity*) dibandingkan laki-laki sebagai wujud perhatian mereka dengan orang lain dan meyakini mereka adalah individu penuh kasih sayang dengan sesama.⁷⁵

Adapun Buchko (2004) mendapati hasil analisis yang sama bahwa mahasiswi memiliki tingkat spiritualitas yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa, hal tersebut terindikasi dari tingkat rutinitas keterhubungan dengan Tuhan sehari-hari melalui ibadah, mencari tokoh agama untuk mendapat petunjuk dalam menyelesaikan problema hidup, merasa bahwa Tuhan bersama, merasa nyaman dan aman dengan keyakinan dan imannya dan mengekspresikan syukur kepada Tuhan.⁷⁶

Perbandingan antara laki-laki dan perempuan pada aspek psikologis memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti karena memang pada dimensi perkembangan manusia perbedaan *gender* secara langsung ataupun tidak langsung berbeda antara keduanya, perempuan seringkali dianggap unik dalam proses pencarian

⁷⁴ Alyin Rich, *Gender and Spirituality, Are Woman Really More Spiritual?*, diakses dari <http://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1293&context=honors> pada tanggal 01 Mei 2017 pukul, 23.02 WIB.

⁷⁵ Allyssa N. Bryant, "Gender Differences in Spiritual Development during the College Years", *Sex Roles*, Vol. 56, No. 11, (2007); 835–846.

⁷⁶ Kathleen J. Buchko, "Religious Beliefs and Practices of College Woman as Compared to College Men", *Journal of College Students Development*, Vol. 45, (20004); 89-98.

alasan (*reasoning*), cara mengetahui sesuatu (*knowing*), emotional, atau style *attachment*.

Namun dalam dunia akademik perbedaan spiritualitas juga akan terlihat dalam perbedaan masa pendidikan, karena pada beberapa penelitian spiritualitas berhubungan terbalik dengan pengalaman stres yang dihadapi.⁷⁷ Sebagaimana pada pembahasan di atas terdapat perbedaan stres berdasarkan tahun pendidikan, maka selanjutnya akan dianalisis pula hubungan perbedaan tingkat spiritualitas berdasarkan tahun pendidikan.

Hasil uji komparasi pada penelitian ini, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara tahun pendidikan pertama, kedua dan ketiga terhadap spiritualitas yang dimiliki. Melalui perhitungan *oneway anova* didapati nilai signifikan sebesar 0.208.⁷⁸ tabel 3.13 mendeskripsikan lebih lengkap perbedaan nilai *mean* spiritualitas berdasarkan tahun pendidikan:

Tabel 3.13. Perbandingan Nilai *Mean* Tahun Pendidikan terhadap Spiritualitas⁷⁹

Spiritualitas Mahasiswa Kedokteran	Tahun Pendidikan	Mean
	Tahun ke-1	46.87
	Tahun ke-2	46.76
	Tahun ke-3	45.83

Berdasarkan tabel perbedaan nilai *mean* tahun pendidikan dan spiritualitas pada mahasiswa kedokteran menunjukkan bahwa mahasiswa dari tahun pertama memiliki tingkat spiritualitas yang lebih tinggi dengan nilai *mean*=46.87 dilanjutkan oleh mahasiswa tahun kedua dengan nilai *mean*=46.76 dan terakhir mahasiswa tahun ketiga dengan nilai *mean*=45.83. Secara eksplisit dapat terlihat bahwa semakin keatas ternyata tingkat spiritualitas terlihat semakin

⁷⁷David V. Powers, Robert J. Cramer and Joshua M. Brubka, "Spirituality, Life Stress, and Affective Well-Being", *Journal of Psychology and Theology*, Vol. 35, No. 3, (2007); 235-243.

⁷⁸Lihat lampiran "Hasil Analisis Komparatif Spiritualitas dan Tahun Pendidikan- *Compare Mean Anova*".

⁷⁹Lihat lampiran, "Analisis Komparasi Tahun Pendidikan (*One Way ANOVA*) – Spiritualitas".

menurun. Jhonson et al dari Universitas Negeri Indiana melakukan riset terkait religiusitas dan spiritualitas pada mahasiswa, diantara hasil yang mereka kemukakan bahwa spiritualitas dan religiusitas dapat berubah dalam masa studi mahasiswa. Selama masa studi berlangsung spiritualitas bisa jadi meningkat pada sebagian mahasiswa, sebagian lagi menurun atau pada sebagian lain tidak mengalami perubahan.⁸⁰

Namun pada penelitian ini tidak dapat pula dikatakan dengan mudah begitu saja bahwa semakin keatas spiritualitas terlihat semakin rendah karena studi ini hanya dilakukan dalam jangka waktu pendek maka untuk mendapat kesimpulan demikian studi lanjutan terhadap perubahan tingkat spiritualitas pada mahasiswa dimana untuk mendapatkan hasil yang akurat maka studi jangka panjang perlu (*longitudinal research*) akan sangat diperlukan.

Sebagaimana data menunjukkan bahwa mahasiswa tahun pertama memiliki tingkat spiritualitas yang paling tinggi dan secara bersamaan mahasiswa dari tahun pertama juga memiliki tingkat stres yang paling tinggi maka dapat dipahami sebagaimana Pargament (1997) menjelaskan bahwa spiritualitas dapat menjadi strategi koping akibat berbagai pengalaman stres yang telah dilalui.⁸¹ Berbagai pengalaman stres yang dirasakan oleh mahasiswa tahun pertama menjadikan spiritualitas semakin tinggi karena spiritualitas berperan aktif dalam kontrol persepsi terhadap keadaan yang tidak menyenangkan. Pada sub bab lanjutan disertasi ini akan lebih jelas menghubungkan pengaruh spiritualitas terhadap munculnya stres pada mahasiswa kedokteran.

4. Aplikasi Regulasi Diri Belajar Mahasiswa Kedokteran

Dalam pendidikan kedokteran regulasi diri belajar sejatinya terintegrasi dalam proses belajar yang mereka jalani, karena metode pembelajaran pemecahan masalah (*problem based learning*/PBL)

⁸⁰Thomas, J. Johnson, Jean Kristeller and Virgil, L. Sheets, "Religiousness and Spirituality in College Students: Separate Dimensions with Unique and Common Correlates. *Journal of College and Character*, Vol. 2, (2004); 1-36.

⁸¹Koeing Pargament, "The Psychology of Religion and Spirituality? Yes and No", *The International Journal for the Psychology of Religion*, Vol. 9, No. 1, (1999); 3-16.

yang diterapkan pada pendidikan dokter memberikan kesempatan untuk mahasiswa meregulasi belajarnya⁸². Sistem pembelajaran PBL memberi kesempatan mereka untuk meregulasi cara berpikir kritis, belajar yang efektif, *assesment* aktifitas diri, dan selalu *update* dengan informasi, sehingga *habit* yang diterapkan dalam PBL dapat dikategorikan dengan regulasi diri belajar. Pada akhirnya regulasi diri belajar dalam kurikulum kedokteran diharapkan akan meningkatkan skil kedokteran mahasiswa.⁸³

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan tingkat kategorisasi regulasi diri belajar mahasiswa kedokteran dimana kebanyakan partisipan berada pada tingkat sedang dengan jumlah 265 orang atau 70.1%, 58 partisipan berada pada kategori tinggi atau 15.3% dan 55 partisipan berada pada kategori rendah atau 14.6%. Untuk jelasnya mengenai tingkat kategorisasi regulasi diri belajar dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14. Tingkat Kategorisasi Regulasi Diri Belajar⁸⁴

SKOR	KATEORI	FREKUENSI	PERSENTASE
73-94	Rendah	55	14.6 %
95-113	Sedang	265	70.1 %
≥ 113	Tinggi	58	15.3 %
Jumlah		378	100 %

Dalam tabel 3.14 di atas meskipun mahasiswa mayoritas berada pada kategori regulasi diri belajar sedang, namun bila dibandingkan antara yang rendah dan tinggi maka frekuensi mahasiswa yang berada pada kategori tinggi lebih banyak jumlahnya. Hal ini menunjukkan beberapa mahasiswa memiliki tingkat kemampuan regulasi diri belajar yang cukup tinggi. Regulasi diri belajar yang tinggi

⁸²Nicole N. Woods, Maria Mylopoulos, dan Ryan Brydges, “Informal Self-Regulated Learnig on a Surgical Rotation: Uncovering Students Experiences in Context”, *Advances in Health Science Education*, Vol. 16, No. 5, (2011); 643-653.

⁸³John Sandars dan Timthy J Cleary, “Self Regulation Theory: Application to Medical Education- AMEE Guide”, *Med Teach*, Vol. 33, No. 58, (2011); 875-886.

⁸⁴Lihat lampiran, “Analisis Tematik – Regulasi Diri Belajar”.

menunjukkan proses adaptiv yang cukup baik terhadap stresor yang ditemui dalam proses studi yang sedang dijalani.

Para profesional kedokteran dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu dan pengetahuan untuk mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien, sehingga demikian para mahasiswa kedokteran mengetahui bahwa mereka akan selalu menjadi pelajar seumur hidup. Menurut Ericsson (2015) regulasi diri belajar sangat penting untuk proses belajar seumur hidup bagi para dokter masa depan⁸⁵. Regulasi diri membantu mahasiswa untuk selalu bertanggung jawab dalam proses belajar mereka dan profesionalisme dokter pada lingkungan medis.

Selanjutnya regulasi diri belajar mahasiswa diyakini mengalami perubahan sepanjang studi akademik kedokteran yang mereka jalani, hal ini didasari pada lingkungan belajar, ketika lingkungan belajar berubah maka regulasi diri juga akan mengalami perubahan.⁸⁶ Sehingga demikian perubahan masa pendidikan memberi pengaruh tersendiri terhadap perubahan regulasi diri. Namun pada penelitian ini tidak ditemukan perbedaan signifikan antara mahasiswa tahun pertama, kedua dan ketiga terhadap regulasi diri belajar dengan hasil signifikansi sebesar $= 0.330$ karena $p > 0.05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan varian pada data regulasi diri berdasarkan masa tahun pendidikan.

Namun jika dilihat perbedaan nilai *mean* regulasi diri belajar pada mahasiswa tahun ketiga lebih besar (51.85) dibandingkan dua tahun pendidikan lainnya yakni tahun pertama (51.54) dan tahun kedua (50.75). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.15 sebagai berikut:

⁸⁵K. Anders Ericsson, "Acquisition and Maintenance of Medical Expertise: a Perspective from the Expert Performance Approach which Deliberate Practice", *Academic Medicine*, Vol. 90, No. 11, (2015); 1471-1486.

⁸⁶Ryan Brydges, "A Reflective Analysis of Medical Education Research on Self-Regulation in Learning and Practice", *Med Educ*, Vol. 46, No. 1, (2012); 71-79.

Tabel 3.15. Perbandingan Nilai *Mean* Tahun Pendidikan terhadap Regulasi Diri Belajar⁸⁷

Regulasi Diri Belajar Mahasiswa Kedokteran	Tahun Pendidikan	Mean
	Tahun ke-1	51.54
	Tahun ke-2	50.75
	Tahun ke-3	51.85

Data di atas menunjukkan bahwa mahasiswa tahun ketiga memiliki regulasi diri belajar yang paling tinggi, apabila dihubungkan pada tingkat stresor sebagaimana yang telah dijelaskan diawal bahwasannya stresor dipersepsikan oleh mahasiswa tahun ketiga paling tinggi, dengan demikian dapat dipahami bahwa stresor yang dihadapi mahasiswa kedokteran pada dasarnya dapat memunculkan respon adaptif pada aspek fisiologis dan psikologis. Kemampuan adaptif inilah kemudian yang menyebabkan efek positif dari stresor, sehingga stres yang muncul adalah stres positif (*eustress*), atau ketika gagal dalam proses adaptif maka yang muncul adalah stres negatif (*distress*). Park and Adler (2006) menjelaskan efektifitas dan ketepatan strategi koping diyakini dapat mengurangi level stres di kalangan mahasiswa kedokteran.⁸⁸

Dalam menghadapi stresor akademik regulasi diri belajar kemudian diyakini sebagai salah satu kemampuan koping adaptif yang diperlukan para pelajar.⁸⁹ Regulasi diri belajar dapat mengantisipasi potensi stres dengan cara individu menganalisis bagaimana ia dapat menghindari dan menghilangkan dampak stresor, kemudian mem-

⁸⁷ Lihat lampiran, “Analisis Komparasi Tahun Pendidikan (*One Way ANOVA*) – Regulasi Diri Belajar”.

⁸⁸ Crystal L Park, and Nancy E Adler, “Coping Styles as a Predictor of Health and Wellbeing across the First Year of Medical School”, *Health Psychology*, Vol. 22, No. 6, (2003); 627-631.

⁸⁹ John C. Buckner, Enrico Mezzacapa and William R. Baerdslee, “Self Regulation and its Relations to Adaptive Functioning in Low income Youths”, *American Journal of Orthopsychiatry*, Vol. 79, No. 1, (2009); 19-30.

buat rencana tindakan, kognisi dan emosi sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap tuntutan keadaan.⁹⁰

Hasil studi ini selaras dengan riset yang dilakukan oleh Cho et al (2017) dimana pada penelitian tersebut para peneliti menganalisis perubahan regulasi diri belajar mahasiswa kedokteran pada masa transisi dari praklinik ke klinik⁹¹, hasil studi tersebut menjelaskan bahwa skil regulasi diri belajar mahasiswa klinik berkembang semakin baik seiring sebelum mereka memasuki masa klinik, artinya masa praklinik memengaruhi regulasi diri belajar mahasiswa.⁹² Studi di Korea juga menjelaskan bahwa regulasi diri belajar berubah seiring bertambahnya waktu dan perubahan motivasi belajar serta kecemasan ujian, semakin keatas kecemasan ujian mahasiswa semakin tinggi. Dalam hubungan dengan regulasi diri strategi kognitif memberi pengaruh positif terhadap penurunan kecemasan ujian.⁹³

Selain dari pada dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, regulasi diri juga dipengaruhi oleh *gender*, metode pengajaran, personaliti, latar belakang keluarga dan berbagai variabel lainnya.⁹⁴ Namun pada penelitian ini hanya akan dibatasi pada hubungan antara *gender* dan regulasi diri belajar. Hasil analisis mendapatkan perbedaan yang

⁹⁰Lisa G. Aspinwall dan Shelly, E. Taylor, "A Stich in Time: Self Regulation and Proactive Coping", *Psychological Bulletin*, Vol. 121, (1997); 417-436.

⁹¹Menurut Radcliffe dan Lester masa awal transisi dari praklinik dan klinik merupakan fase paling krusial ketika para mahasiswa berganti lingkungan belajar dari ruang-ruang kelas ke lingkungan medis. Sehingga pada masa ini mahasiswa memerlukan pengaturan diri yang lebih besar dan harus beradaptasi pada pola pembelajaran secara langsung dan mandiri. Lih Christina Radcliffe dan Helen Lester, "Perceived Stress during Undergraduate Medical Training: a Qualitative Study", *Medical Education*, Vol. 37, No. 1, (2003); 32-38.

⁹²Kenneth K. Cho and others, "Medical Students Changes in Self-Regulated Learning during the Transition to the Clinical Environment", *Bio Med Central*, (2017).

⁹³Kyong-Jee Kim dan Hye W. Jang. "Changes in Medical Students' Motivation and Self -Regulated Learning: a Preliminary Study", *International Journal of Medical Education*, Vol. 6, (2015); 213-215.

⁹⁴Zahra Jouhari, Fariba Haghani dan Tahereh Changiz, "Factors Affecting Self Regulated Learning in Medical Students; a Qualitative Study", *Med Edic Online*, (2015).

signifikan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap kemampuan regulasi diri belajar dengan signifikansi sebesar $=0.040$ dimana $p > 0.05$, maka dapat dikatakan ada perbedaan varian pada data regulasi diri belajar pada laki-laki dan perempuan.⁹⁵ Lebih jelasnya tabel 3.16 menjelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.16. Perbandingan Nilai *Mean Gender* terhadap Regulasi Diri Belajar⁹⁶

Regulasi Diri Belajar	<i>Gender</i>	<i>Mean</i>
Mahasiswa Kedokteran	Laki-laki	50.78
	Perempuan	54.65

Tabel di atas menjelaskan ada perbedaan nilai *mean gender* terhadap regulasi diri belajar dimana mahasiswa perempuan memiliki kemampuan regulasi diri belajar yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki ($54.65 > 50.78$). Hasil analisis selaras dengan studi pendahulu yang juga mengungkap bahwa perempuan memiliki regulasi diri belajar yang lebih tinggi dari laki-laki, dimana perempuan memiliki pengaturan tujuan dan perencanaan belajar yang lebih tinggi dari laki-laki.⁹⁷

Selanjutnya para peneliti saat ini pun mulai tertarik menganalisis terkait efek regulasi diri belajar, dimana melalui regulasi diri belajar beberapa studi secara umum mengungkapkan prestasi akademik pelajar perempuan didapati lebih tinggi daripada laki-laki.⁹⁸ Menurut Bjorklund dan Kipp (1996) kemampuan perempuan mengontrol emosinya membuat ia memiliki kemampuan regulasi diri belajar

⁹⁵ Lih Lampiran “Hasil Analisis Komparatif *Gender* terhadap Regulasi Diri Belajar-*Independent Sample t-Test*”.

⁹⁶ Lihat lampiran, “Analisis Komparasi *Gender (Independent Sample t-Test)* – Regulasi Diri Belajar”.

⁹⁷ Barry J. Zimmerman dan Manuel Martinez-Pons, “Students Differences in Self Regulated Learning: Relating Grades, Sex, and Giftedness to Self Efficacy and Strategy Use”, *Journal of Educational Psychology*, Vol. 82, No. 1, (1990); 51-59.

⁹⁸ Mirjam Weis, Tobias Heikamp dan Gisela Trommsdorff, “Gender Differences in School Achievement; The Role of Self Regulation”, *Frontiers in Psychology*, Vol. 4, (2013); 1-10.

yang lebih tinggi.⁹⁹ Sementara Davis (1995) mengatakan perempuan diharapkan dapat berkelakuan sesuai aturan sehingga hal tersebut membuat ia lebih pandai meregulasi diri.¹⁰⁰ Adapun berdasarkan teori model koping dan stres, perempuan lebih cenderung melakukan koping stres melalui strategi berorientasi masalah sementara laki-laki lebih cenderung melakukan strategi berorientasi emosi dalam menghadapi keadaan tertekan.¹⁰¹ Adapun regulasi diri sebagai koping stres akan dijelaskan secara lebih rinci pada sub bab berikutnya.

D. Keterhubungan dengan Tuhan dalam Dominansi Spiritualitas

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan, terdapat empat hipotesis bersifat verikatif yang diajukan dan akan diuji dalam penelitian ini. Adapun berkenaan dengan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kausalitas atau hubungan atau pengaruh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan tersebut, maka tehnik analisis yang digunakan adalah SEM (*Structural Equation Models*). Penggunaan metode analisis SEM dikarenakan SEM dapat mengidentifikasi dimensi-dimensi dari sebuah konstruk dan pada saat yang bersamaan mampu mengukur pengaruh atau derajat hubungan antar *factor* yang telah diidentifikasi dimensi-dimensinya.¹⁰²

Dalam SEM ada dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran (*measurement model*) dan model struktural (*structural model*). Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan hasil analisis pada model pengukuran terlebih dahulu, dimana model pengukuran ini akan menjelaskan *proporsi variance* masing-masing indikator (variabel manifest) yang dapat dijelaskan di dalam variabel laten.

⁹⁹David F. Bjorklund dan Katherine Klipp, "Parental Investment Theory and Gender Differences in the Evolution of Inhibition Mechanism", *Psychological Bulletin*, Vol. 120, No. 2, (1996); 163-188.

¹⁰⁰Teresa L. Davis, "Gender Differences in Masking Negative Emotions: Ability or Motivation?", *Developmental Psychology*, Vol. 31, No. 4, (1995); 660-667.

¹⁰¹Heike Eschenbeck, Carl-Walter Kohlmann, dan Arnold Lohaus, "Gender Differences in Coping Strategies in Children and Adolescents", *Journal of Individual Differences*, Vol. 28, (2007); 18-26.

¹⁰²Joseph F. Hair and others, *Multivariate Data Analysis 7th Edition*, (New York: Pearson Prentice Hall, 2010), 679.

Tujuan analisis model pengukuran ini untuk mengetahui indikator mana yang dianggap signifikan dalam membentuk variabel laten. Hasil analisis model pengukuran ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Stres dan Kehilangan Kontrol Diri

Pada dasarnya stres secara normal dirasakan oleh setiap individu dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktifitas harian. Melalui stres individu tersebut akan berpikir dan berusaha keras dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sebagai bentuk adaptasi untuk bertahan.¹⁰³ Pada mahasiswa tuntutan akademik dan segala kegiatan dan aktifitas di dalamnya dapat menjadi bagian stres yang bisa dialami.

Stres akademik yang dirasakan oleh mahasiswa sekolah tidak dapat dipisahkan dan mereka cenderung lebih mudah mengalami stres karena stres yang dirasakan sejatinya berjalan seiring dengan masa perkembangan mereka yang tergolong masa remaja¹⁰⁴. Masa remaja merupakan masa puncak gejala emosi, intensitas emosi yang tinggi ini dapat meningkatkan emosi-emosi negatif seperti stres, depresi dan ansietas.¹⁰⁵ Seiring dengan hal tersebut tanggung jawab dan tuntutan mahasiswa internal maupun eksternal dari kehidupan akademik dan non akademik ketika dirasakan berlebihan dan diluar kemampuan mereka dapat mengakibatkan terjadinya stres dalam bentuk kelelahan fisik dan mental, daya tahan menurun, dan emosi yang tidak stabil.

Sementara itu respon stres yang muncul akan berbeda antar mahasiswa, pada penelitian ini analisis terhadap respon mahasiswa berguna sebagai indikator terjadinya stres sekaligus mengukur tingkat stres yang dialami. Gambar 3.1 berikut menjelaskan hasil uji model variabel stres yang diwakili oleh tiga variabel teramati (*observed*

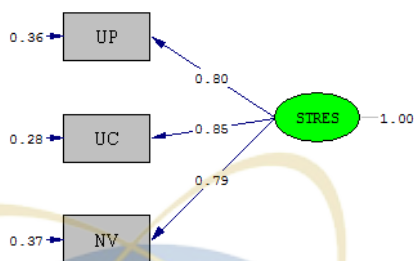
¹⁰³Potter & Perry, *Fundamental of Nursing: Concept, Process and Practice*, (Asih Y. Et all, Penerjemah), (Jakarta: EGC, 2005), 27.

¹⁰⁴Mahasiswa secara usia tergolong masuk kategori remaja akhir yakni kisaran usia 18-20 tahun. Lih. Wong's & Hockenbery, *Wong's Nursing Care of Infants and Children*, 8th edi, (Canada: Mosby Elsevier, 2007), 59.

¹⁰⁵Marie Good dan Teena Willoughby, "Adolescence as a Sensitive Period for Spiritual Development", *Child Development Perspectives*, Vol. 2, No. 1, (2014); 32-37.

variables), yaitu: *upset*/kecewa (UP), *uncontrolled*/tidak terkontrol (UC) dan *nervous*/gugup (NV).

Gambar 3.1. Uji Model Pengukuran Variabel Laten Stres¹⁰⁶



Dari diagram lintasan pada gambar 3.1 bisa dilihat bahwa hasil estimasi awal model struktural/ *full model* sudah menunjukkan bahwa semua variabel teramati memiliki nilai *standarized loading factor* (SLF) ≥ 0.40 . Menurut Ferdinad (2002)¹⁰⁷ dan Kusnendi (2007)¹⁰⁸ menyatakan bahwa suatu indikator dinyatakan valid jika nilai bobot faktor yang distandarkannya (SLF) tidak kurang dari 0.40 dan nilai t-hitung dari SLF tersebut > 1.96 , maka demikian semua variabel teramati dapat dikatakan valid.

Selanjutnya untuk melihat kehandalan variabel laten peneliti juga menganalisa ukuran uji *convergent validity*¹⁰⁹ lainnya yakni

¹⁰⁶Lihat Lampiran, “Analisis Hasil Uji Model Pengukuran – Stres”.

¹⁰⁷Ferdinand, *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*, Edisi 2, (Semarang: Fakultas Ekonomi UNDIP, 2002), 131.

¹⁰⁸Kusnendi, *Model-Model Persamaan Struktural*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 33.

¹⁰⁹*Convergent Validity* merupakan suatu uji untuk menguji apakah variabel-variabel indikator yang digunakan benar-benar signifikan dalam hal mencerminkan variabel konstruk atau laten. Selain *standarized loading factor* (SLF) juga ada dua jenis uji validitas konvergen, yaitu: (1) *construct reliability* (CR) merupakan indikator penentu yang menunjukkan baik tidaknya sifat *convergent validity* dan (2) *average variance expected* (AVE) merupakan properti validitas diskriminan karena koefisien ini menggambarkan interkorelasi internal yaitu korelasi antar indikator di dalam model. Lih. Wahyu Widhiarso, *Estimasi Reliabilitas Pengukuran dalam Pendekatan Model Persamaan Struktural*, diakses dari <http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files/>

construct reliability (CR) dan *average variance extracted* (AVE). Hair et al (2010) menyatakan nilai $CR \geq 0.70$ termasuk *good reliability* sedangkan nilai CR diantara 0.60 dan 0.70 termasuk *acceptable reliability* dengan catatan variabel-variabel indikator menunjukkan nilai validitas yang baik dan $AVE \geq 0.50$ menunjukkan *adequate convergence*.¹¹⁰ Adapun hasil penghitungan CR dan AVE dapat dilihat lebih jelas pada tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17 *Convergent Validity* Laten Stres¹¹¹

Variabel Laten	Nilai SLF (≥ 0.40)	Nilai Error	Nilai CR (≥ 0.70)	Nilai AVE (≥ 0.50)	Kesimpulan Perhitungan
Stres			0.85	0.64	Reliabilitas Baik
<i>Upset</i> (UP)	0.80	0.36			
<i>Uncontrolled</i> (UC)	0.85	0.85			
<i>Nervous</i> (NV)	0.79	0.37			

Tabel di atas menjelaskan bahwa variabel laten stres memiliki konstruk pengukuran dengan nilai reliabilitas baik, dimana semua variabel manifest memiliki nilai SLF ≥ 0.40 dengan nilai masing-masing sebesar: *unpredicted* (0.80), *uncontrolled* (0.85) dan *nervous* (0.79). Adapun nilai CR (0.85) dan AVE (0.64). Selanjutnya untuk menguji apakah data penelitian mendukung model yang ada, maka indikator nilai *Goodness of Fit Indices* (GOFI)¹¹² variabel laten stres dapat dilihat pada tabel 3.18 di bawah ini:

Widhiarso%20-%20Estimasi%20Reliabilitas%20Pengukuran%20Dalam%20Pendekatan%20SEM.pdf pada tanggal 05 Mei 2017 pukul 13.21 WIB.

¹¹⁰Joseph F. Hair and others, *Multivariate Data Analysis 7th Edition*, (New York: Pearson Prentice Hall, 2010), 679.

¹¹¹Lihat Lampiran, “Analisis Hasil Uji Model Pengukuran – Stres”.

¹¹²Menurut Wijanto (2008) SEM tidak mempunyai satu uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran *Goodness of Fit Indices* (GOFI) yang dapat digunakan bersama-sama atau kombinasi. Dengan dasar ini maka respesifikasi model yang bertujuan meningkatkan kecocokan model dapat diukur, selanjutnya nilai-nilai berdasarkan GOFI akan dievaluasi. Diantara GOFI yang akan dipaparkan pada penelitian ini ada 9 ukuran kecocokan model antara lain: RMSEA, NFI, NNFI, CFI, IFI, RFI, SRMR, GFI,

Tabel 3.18. *Goodness of Fit Indices (GOFI) Variabel Stres*¹¹³

N o	GOFI	Nilai Standard Untuk Kecocokan Model	Estimasi	Tingkat Kecocokan
1	Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)	$RMSE \leq 0.08$	0.05	Baik
2	Normed Fit Index (NFI)	$NFI \geq 0.90$	0.97	Baik
3	Non-Normed Fit Index (NNFI)	$NNFI \geq 0.90$	0.96	Baik
4	Comparative Fit Index (CFI)	$CFI \geq 0.90$	0.98	Baik
5	Incremental Fit Index (IFI)	$IFI \geq 0.90$	0.98	Baik
6	Relative Fit Index (RFI)	$RFI \geq 0.90$	0.95	Baik
7	Standardized Root Mean Square Residual (RMR)	$RMR \leq 0.05$	0.03	Baik
8	Goodness of Fit Index (GFI)	$GFI \geq 0.90$	0.96	Baik
9	Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)	$0.8 \leq AGFI < 0.9$	0.91	Baik

Tabel di atas menunjukkan bahwa data mendukung model untuk pengukuran variabel laten stres, kelayakan model sudah memenuhi nilai ideal dari kriteria suatu model yang baik. Dengan demikian model pada gambar 3.1 merupakan model yang dapat diterima sebagai model yang mampu merepresentasikan indikasi stres pada mahasiswa kedokteran. Dari ketiga indikator model pengukuran stres (*upset, uncontrolled, nervous*) indikator *uncontrolled* lebih dominan dalam pembentukan variabel laten (stres) dibandingkan dua indikator lainnya.

Pada mahasiswa yang dilibatkan pada penelitian ini memperlihatkan indikasi stres psikologis yang terkait dengan ketidakmampuan mengontrol emosi seperti tidak mampu mengontrol perilaku penting dalam aktifitas keseharian dan tidak mampu mengontrol kejengklakan akibat tekanan harian. Hal ini secara fisiologis dapat dipahami mengingat pada usia mereka terjadi peningkatan hormon yang mengakibatkan mereka labil dalam menghadapi pengalaman hidup.¹¹⁴ Padahal sebaliknya prediktor kontrol diri menjadi hal pen-

dan AGFI. Lih. Setyo Hari Wijanto, *Structural Equation Modelling dengan LISREL 8.8*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 235.

¹¹³Lihat Lampiran, “Analisis Hasil Uji Model Pengukuran – Stres”.

¹¹⁴Tobroni 2010 dalam Ira Suwartika, Agus Nurdin, dan Edi Ruhmadi, “Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Stress Akademik

ting untuk mengarahkan mahasiswa mendapatkan manfaat positif dari kondisi stres yang dialami.¹¹⁵

Selanjutnya diantara indikasi lain dari stres yang dialami mahasiswa dapat terlihat dari kekecewaan. Kekecewaan disini dimaksudkan ketidak mampuan responden menyikapi keadaan yang tiba-tiba muncul, merasa gagal dalam menyelesaikan tugas dan masalah, serta kekecewaan diri terhadap ketidak mampuan diri memenuhi tuntutan terkait akademik dan non akademik. Hal ini senada dengan pandangan Sukadiyanto (2010) yang mengatakan secara psikologis individu yang mengalami stres diantaranya ditandai oleh kemampuan kerja dan penampilan (*performance*) yang menurun dan hilangnya spontanitas.¹¹⁶ Dalam analisis penulis, berkurangnya kemampuan kerja dan penampilan menyebabkan munculnya rasa kecewa atas kegagalan diri melakukan adaptasi terhadap tuntutan yang ada dan hilangnya spontanitas dimaksudkan kegagalan mahasiswa menghadapi keadaan yang biasanya dan sepatutnya dalam keadaan normal mereka dapat menyelesaikannya.

Termasuk diantara indikasi stres yang dapat dianalisis pada penelitian ini sebagaimana yang diungkap oleh responden adalah gejala psikologis emosional gelisah, gugup dan takut. Hal ini senada dengan apa yang disebutkan oleh Najati (1993)¹¹⁷ dan Taufik (1998)¹¹⁸ stres dapat terlihat dari luapan (*tension*) emosi yang tidak stabil dikarenakan kondisi psikologis yang tidak tenang sehingga nampak seperti gelisah, marah, cemas, dan ketakutan. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa dari tiga indikasi psikologis stres *upset, uncontrolled, nervous* secara signifikan dapat mendeskripsikan

Mahasiswa Reguler Program Studi D III Keperawatan Cirebon Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya”, *Jurnal Keperawatan Soedirman*, Vol. 9, No. 3, (2014); 173-189.

¹¹⁵Chris Gibbons and others, “Stress, Coping and Satisfaction in Nursing Students”, *Journal of Advance Nursing*, Vol. 67, No. 3, (2011); 621-632.

¹¹⁶Sukadiyanto, “Stres dan Cara mengatasinya”, *Cakrawala Pendidikan*, Vol. 29, No. 1, (2010); 55-67.

¹¹⁷Muhammad 'Uthman Najati, *Al-Qur'an wa 'Ilm al-Nafs*, (Cairo: Dar al-Syuruk, 1993), 59.

¹¹⁸Muhammad Izudin Taufik, *al- Ta'asil al-Islamiyah al- Dirasat al- Insaniyah*, (Cairo: Dar al- Salam), 25.

stres mahasiswa. Adapun indikasi stres mahasiswa dalam aspek fisiologis dan perilaku akan diungkap deskripsinya pada bab ke empat sebagai hasil analisis kualitatif.

2. Tuntutan Akademik sebagai Stresor Dominan

Stres akademik yang dirasakan mahasiswa muncul dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantara temuan para peneliti terkait faktor dan sumber pencetus stres dapat penulis sarikan sebagai berikut: manajemen waktu, beban finansial, interaksi dengan dosen, tujuan diri, aktivitas sosial, pengaturan diri terhadap lingkungan kampus, dan kurangnya dukungan dari keluarga, teman dan lainnya, prosedur pendaftaran perguruan tinggi, harapan tinggi orang tua, kurikulum akademik, waktu kuliah yang kurang tepat, perbedaan ratio dosen dan mahasiswa, lingkungan kuliah yang tidak kondusif, hubungan yang tidak sehat antara dosen dan mahasiswa, hukuman fisik, tugas yang tidak seimbang, metodologi mengajar, harapan diri mahasiswa sendiri terhadap dirinya, dan harapan orang tua.

Stresor akademik yang muncul di kalangan mahasiswa akan berbeda sesuai dengan bidang keilmuan dan taraf kesulitan dari keilmuan yang mereka pelajari. Pada mahasiswa yang notabene terekspos dengan tugas yang banyak, tingkat kompetensi dan tuntutan skill medis yang cukup tinggi¹¹⁹, beberapa hasil riset menjelaskan beberapa stresor akademik yang secara umum hanya dirasakan oleh mahasiswa kedokteran seperti perasaan tidak mampu, ujian tes fisik pertama kali terhadap pasien, praktek-praktek pembedahan, proses diagnosis penyakit, takut terkena penyakit, bahkan traumatik ketika menghadapi kematian pasien.¹²⁰

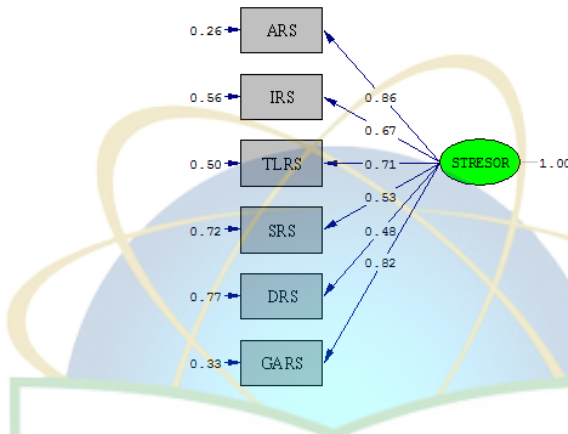
Melalui analisis review literasi terkait stresor mahasiswa akademik Yusoff, Rahim dan Yaacob (2010) mengembangkan instrument yang dapat diukur validitas dan reliabilitas berbagai stresor tersebut yang kemudian dinamakan *Medical Students Stressor Ques-*

¹¹⁹Tetsuo Tamaki and others, "Prevalence of and Factors Associated with Smoking among Japanese Medical Students", *J. Epidemiol*, Vol. 20, No. 4, (2010); 339-345.

¹²⁰Liselotte N. Dyrbye, and others, "Systematic Review of Depression, Anxiety, and Others Indicators of psychological Distress among US and Canadian Medical Students", *Academic Medicine*, Vol. 81, No. 4, (2006); 354-373.

tionnaire (MSSQ). Pada penelitian ini guna ketepatan model pengukuran MSSQ ini peneliti melakukan test uji model pengukuran dimana keenam indikator MSSQ dinyatakan valid dalam merepresentasikan stresor yang dihadapi mahasiswa, Gambar 3.2 berikut menjelaskan hasil uji model variabel stresor.

Gambar 3.2. Uji Model Pengukuran Variabel Laten Stresor¹²¹



Gambar 3.2. menunjukkan hasil analisis model struktural sudah menunjukkan bahwa semua variabel teramati memiliki *standardized loading factor* (SLF) ≥ 0.40 dan bisa dilihat bahwa hasil estimasi awal model struktural/ *full model* sudah menunjukkan bahwa semua variabel teramati memiliki nilai > 1.96 . Secara rinci t-hitung yang didapati adalah sebagai berikut: *academic relates stressors* (ARS)= 19.73, *intrapersonal and interpersonal related stressors* (IRS)= 13.84, *teaching and learning related stressors* (TLRS)= 15.06, *social related stressors* (SRS)= 10.54, *desire related stressors* (DRS)= 9.40 dan *group activities related stressor*= 18.38. Adapun uji kehandalan variabel laten didapati hasil *construct reliability* (CR) ≥ 0.70 dan *average variance extracted* (AVE) ≥ 0.50 . Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.19 berikut:

¹²¹Lihat Lampiran, “Analisis Hasil Uji Model Pengukuran – Stresor”.

Tabel 3.19. *Convergent Validity* Laten Stresor¹²²

Variabel Laten	Nilai SLF (≥ 0.40)	Nilai Error	Nilai CR (≥ 0.70)	Nilai AVE (≥ 0.50)	Kesimpulan Perhitungan
Stresor			0.84	0.60	Reliabilitas Baik
Academic Related Stres (ARS)	0.86	0.26			
Intrapersonal and Interpersonal Related Stressors (IRS)	0.67	0.56			
Teaching and Learing Related Stressors (TLRS)	0.71	0.50			
<i>Social Related Stressors</i> (SRS)	0.53	0.72			
<i>Desire Related Stressors</i> (DRS)	0.48	0.72			
<i>Group Activities Related Stressors</i> (GARS)	0.82	0.77			

Tabel di atas menjelaskan bahwa variabel laten stresor memiliki konstruk pengukuran dengan nilai reliabilitas baik, dimana semua variabel manifest memiliki nilai SLF ≥ 0.40 dengan nilai masing-masing sebesar: ARS (0.86), IRS (0.67), TLRS (0.71), SRS (0.53), DRS (0.48), dan GARS (0.82). Selanjutnya untuk menguji apakah data penelitian mendukung model yang ada, maka indikator nilai *Goodness of Fit Indices* (GOFI) variabel laten stresor dapat dilihat pada tabel 3.20 di bawah ini:

¹²²Lihat Lampiran, “Analisis Hasil Uji Model Pengukuran – Stresor”.

Tabel 3.20. *Goodness of Fit Indices (GOFI)* Variabel Stresor

N o	GOFI	Nilai Standard Untuk Kecocokan Model	Estimasi	Tingkat Kecocokan
1	Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)	$RMSE \leq 0.08$	0.07	Baik
2	Normed Fit Index (NFI)	$NFI \geq 0.90$	0.98	Baik
3	Non-Normed Fit Index (NNFI)	$NNFI \geq 0.90$	0.98	Baik
4	Compartive Fit Index (CFI)	$CFI \geq 0.90$	0.99	Baik
5	Incremental Fit Index (IFI)	$IFI \geq 0.90$	0.99	Baik
6	Relative Fit Index (RFI)	$RFI \geq 0.90$	0.97	Baik
7	Standarized Root Mean Square Residual (RMR)	$RMR \leq 0.05$	0.03	Baik
8	Goodness of Fit Index (GFI)	$GFI \geq 0.90$	0.98	Baik
9	Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)	$0.8 \leq AGFI < 0.9$	0.95	Baik

Tabel GOFI di atas menunjukkan bahwa model dapat dikatakan *fit* dengan data dalam mengukur variabel laten stresor. Kelayakan model sudah memenuhi nilai ideal dari kriteria suatu model yang baik. Dengan demikian model pada gambar 3.2. merupakan model yang dapat diterima sebagai model yang mampu menjelaskan sumber stres pada mahasiswa kedokteran. Sementara tabel 3.19. menjelaskan kemaknaan dari dimensi-dimensi yang terekstrasi dalam membentuk variabel laten stresor adalah baik, dari keenam indikator model pengukuran stresor (ARS, IRS, TLRs, SRS, DRS, DAN GARS) indikator ARS lebih dominan dalam pembentukan variabel laten stresor dibandingkan kelima indikator lainnya.

Dengan demikian hasil studi menunjukkan bahwa stresor akademik memberikan sumbangan proporsi sumber stres terbesar. Stresor akademik adalah kesatuan segala hal yang terkait dengan tuntutan akademik yang melebihi kemampuan adaptasi mahasiswa untuk menanggulangnya¹²³, yakni segala sumber stres yang terkait

¹²³Scot E. Wilks, "Resilience Amid Academic Stress: the Moderating Impact of Social Support among Social Work Students", *Advances in Social Work*, Vol. 9, No. 2, (2008); 106-125.

dengan kurikulum, ujian, metode ujian, jadwal kuliah serta aktifitas akademik lainnya seperti tugas dan praktikum. *Top teen list* stresor akademik pada penelitian ini adalah kesulitan memahami materi, kurang waktu untuk mengulangi materi, materi perkuliahan yang *overload*, mendapatkan nilai yang buruk, ujian, tidak cukup waktu untuk membaca, harapan atas diri sendiri, tugas yang berat, persaingan belajar, dan penilaian yang dianggap kurang *fair*.¹²⁴

Sumber stres kedua yang dipersepsikan menjadi sumber stres tertinggi adalah *group activities related stressors* yakni segala aktifitas terkait kerja bersama secara kelompok seperti partisipasi dalam diskusi grup, presentasi mewakili grup dan harapan dari luar dirinya untuk melakukan terbaik. Menurut analisis penulis sistem pembelajaran dengan cara PBL yang diterapkan dalam proses pendidikan kedokteran dan kesehatan dengan metode pendekatan pembelajaran diskusi kelompok mewajibkan semua siswa untuk aktif dan progresif mengikuti cara belajar secara bersama, sehingga pola belajar ini dapat meningkatkan daya saing diantara mereka yang kemudian tidak sedikit memberikan tekanan belajar yang lebih kompetitif diantara mereka. Sebagaimana pada penelitian di Saudi Arabia sistem pembelajaran dengan PBL dipersepsikan sebagai salah satu sumber stres yang memengaruhi tingkat stres mahasiswa.¹²⁵ Sebagaimana pula Nazeer dan Sultana (2014) menjelaskan bahwa mempelajari materi studi kedokteran secara berkelompok dengan motivasi, kompetisi, intelegensi yang sama dapat memberi tekanan bagi mahasiswa untuk secara cepat menguasai materi.¹²⁶

Stresor pengajaran dan pembelajaran berhubungan dengan segala hal terkait dengan pengajaran atau pembelajaran. Secara umum adalah terkait dengan kesesuaian tugas dari dosen, kompetensi dosen, kualitas *feedback* dan *support* dari dosen, serta kejelasan

¹²⁴Lihat Lampiran, “Analisis Hasil Uji Model Pengukuran – Stresor”.

¹²⁵Ahmad Dagistani and others, “Stress in Medical Students in a Problem-Based Learning Curriculum”, *International Journal of Higher Education*, Vol. 5, No. 3, (2016); 12-19.

¹²⁶Moh. Nazeer dan Razia Sultana, “Stress and it’s Coping Strategies in Medical Students”, *Scholars Journal Applied Medical Science*, Vol. 2, No. 6D, (2014); 3111-3117.

tujuan belajar yang disampaikan oleh dosen.¹²⁷ Selanjutnya stresor intrapersonal dan interpersonal adalah sumber stres yang terkait interaksi individu dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Interpersonal seperti rendah motivasi dan konflik diri. Sementara intrapersonal seperti mendapatkan cacian verbal, fisik dan emosi dari orang serta konflik dengan guru, teman dan mungkin staf kampus. Peneliti lainnya menghubungkan sumber stres intrapersonal dengan stresor sosial, dimana mahasiswa dianggap memiliki konflik antara dirinya dengan orang lain¹²⁸. Adapun stresor sosial adalah terkait dengan kurang waktu bersama keluarga dan teman, serta minimnya waktu untuk dirinya sendiri. Khusus pada mahasiswa klinik stresor sosial meningkat dalam interaksi mahasiswa dengan pasien, dokter dan staf rumah sakit.

Selanjutnya sumber stres yang dihadapi mahasiswa kedokteran adalah stresor keinginan dan dorongan (*drive and desire*) yakni segala hal yang terkait dengan dorongan internal dan eksternal yang memengaruhi sikap, emosi, pikiran dan tindakan individu yang dapat menyebabkan stres. Dalam konteks pendidikan dokter, keinginan dan dorongan ini berhubungan dengan ketidak inginan mahasiswa untuk mengikuti studi kedokteran karena salah pilihan, merasa dimotivasi ketika mengetahui realitas dalam dunia kedokteran, hanya mengikuti keinginan orang tua, dan ikutan teman. Studi di Pakistan menunjukkan bahwa stresor yang sangat umum dijumpai pada mahasiswa kedokteran adalah tingginya harapan orang.¹²⁹ Tanpa adanya dorongan dan keinginan yang kuat mahasiswa kedokteran akan cenderung menyerah diri dalam menyelesaikan studinya.¹³⁰

¹²⁷Muhammad Saiful Bahri Yusoff dan Ahmad Fuad Abdul Rahim, "The Medical Students Stressor Questionnaire (MSSQ) Manual", *Research Gate*, (2010), diakses melalui <http://www.researchgate.net/publication/200640404> pada tanggal 09 November 2015.

¹²⁸Mohd Nazeer and Razia Sultana, "Stress in it's Coping Strategies in Medical Students", *Sch. J. App. Med. Sci*, Vol. 2, No. 6D, (2014); 3111-3117.

¹²⁹Mohsin Shah and others, "Perceived Stress, Sources and Severity of Stress among Medical Undergraduates in a Pakistani Medical School", *BMC Med Educ*, Vol. 10, No. 2, (2010).

¹³⁰Muhammad Saiful Bahri Yusoff dan Ahmad Fuad Abdul Rahim, "The Medical Students Stressor Questionnaire (MSSQ) Manual", *Research*

3. Dominansi Teo-Spiritualitas Mahasiswa Kedokteran

Pada beberapa tahun terakhir, kajian terkait spiritualitas banyak menarik perhatian para peneliti termasuk dalam kajian klinis dan kesehatan. Diantara beberapa hasil riset yang dilakukan tersebut membuktikan bahwa spiritualitas berhubungan dengan hasil yang positif dan baik, seperti dan tidak terbatas pada kemampuan untuk mengatasi stres, mengurangi munculnya penyakit seperti depresi dan kecemasan, mengurangi resiko bunuh diri dan tindakan kriminal, penggunaan rokok, narkoba, dan alkohol.¹³¹

Riset-riset kuantitatif menjelaskan hubungan positif spiritual dan kesehatan mental, seperti studi Smith et al (2003) menyebutkan hubungan spiritual dengan kesehatan tersebut lebih kuat terjadi diantara individu yang menghadapi berbagai stres kehidupan.¹³² Ketika literasi terkait spiritual menjadi perbincangan akademik, beberapa peneliti akhirnya tertarik melihat hubungan spiritualitas dalam dunia akademik salah satunya adalah pada perguruan tinggi. Bates et al (2001) menjelaskan spiritualitas berhubungan positif dengan kesejahteraan diri para mahasiswa¹³³ dan Lindholm (2007) menemukan para pelajar meyakini bahwa spiritualitas merupakan salah satu elemen yang memengaruhi prestasi akademik bahkan hasil studi tersebut menyebutkan mahasiswa yang didapati dan dilabeli dengan mahasiswa *ber-spiritual* tinggi dapat mengatasi kesulitan lebih mudah.¹³⁴

Meskipun kajian spiritualitas telah banyak dikembangkan namun sampai saat ini konsep spiritualitas sendiri masih menjadi per-

Gate, (2010), diakses melalui <http://www.researchgate.net/publication/200640404> pada tanggal 09 November 2015.

¹³¹Aisha Hamdan, "Gognitive Restructuring: an Islamic Perspective", *Journal of Muslim Mental Health*, Vol. 3, (2008); 99-116.

¹³²Timothy B. Smith, Michael E. McCullough, dan Justin Poll, "Religiousness and Depression: Evidence for a main Effect and the Moderating Influence of Stressful Life Events", *Psychological Bulletin*, Vol. 129, No. 4, (2003); 614-636.

¹³³Jeffrey M. Bates, Diane L. Cooper, dan Peter M. Wachs, "Assessing Wellness in College Students: a Validation of the Salubrious Lifestyle Scale of the Student Developmental Task and Lifestyle Assessment", *Journal of College Student Development*, Vol. 42, No. 3, (2001); 193-203.

¹³⁴Jennifer A. Lindholm, "Spirituality in the Academy: Reintegrating our Lives and the Lives of our Students", *About Campus*, Vol. 12, No. 4, (2007); 10-17.

debatan akademisi. Tidak ada kesepakatan para ahli dalam mendefinisikan makna spiritualitas. Namun secara garis besar para ahli mendefinisikan spiritualitas dengan dua pendekatan. *Pertama*, spiritualitas dihubungkan dengan agama atau istilah yang digunakan adalah *theistic approach*. *Kedua*, pendekatan *nontheistic* yang mana seringkali didasarkan pada pemahaman sekular, humanistik dan eksistensi.¹³⁵ Pada disertasi ini untuk mengungkap tingkat spiritualitas penulis menggunakan pendekatan *theistic* dimana, agama dan spiritualitas meskipun berbeda makna namun keduanya saling berkaitan. Sebagaimana Gilbert (2007) menyebutkan bahwa agama mencakup banyak aspek yang salah satunya konsep spiritualitas.¹³⁶

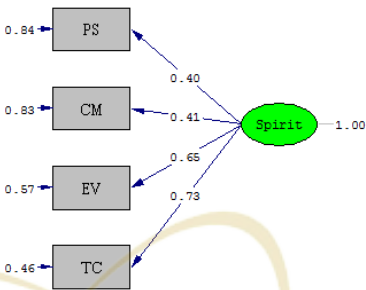
Diantara tokoh lainnya yang mendeskripsikan keterkaitan spiritualitas dengan agama adalah Fisher dan Gomez (2003) yang merefleksikan spiritualitas sebagai kemampuan seseorang untuk hidup harmonis dalam empat domain: hubungan dengan diri sendiri (*personal*), hubungan dengan orang lain (*communal*), hubungan dengan alam (*nature*) dan hubungan dengan Tuhan (*transcendental*).¹³⁷ Selanjutnya teori spiritualitas berdasarkan pandangan Fisher dan Gomez inilah yang digunakan penulis dalam menjelaskan dinamika spiritualitas pada mahasiswa kedokteran. Gambar 3.3 berikut menjelaskan hasil uji model variabel spiritualitas sebagaimana yang diwakili oleh empat domain (indikator) tersebut di atas.

¹³⁵Eltica de Jager Meezenbroek and others, "Measuring Spirituality as a Universal Human Experience: Development of the Spiritual Attitude and Involvement List (SAIL)", *Journal of Psychology Oncology*, Vol. 30, (2012); 141-167.

¹³⁶Peter Gilbert, "The Spiritual Foundation: Awareness for Context People's Live Today" in *Spirituality, Values, and Mental Health* ed Marry Ellen Coyte, Peter Gilbert, & Vicky Nicholls, (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25.

¹³⁷John W. Fisher dan Gomez, "Domains of Spiritual Well-Being and Development and Validation pf the Spiritual Well_being Questionnaire", *Personality and Individual Differences*, Vol. 35, (2003); 1975-1991.

Gambar 3.3. Uji Model Pengukuran Variabel Laten Spiritualitas¹³⁸



Gambar 3.3 menjelaskan hasil analisis model struktural telah menunjukkan semua variabel teramati memiliki *standarized loading factor* (SLF) ≥ 0.40 dan bisa dilihat bahwa hasil estimasi awal model struktural/*full model* sudah menunjukkan bahwa semua variabel teramati memiliki nilai >1.96 . Secara rinci *t*-hitung yang didapatkan adalah sebagai berikut: *personal* (PS)= 6.71, *communal* (CM)= 6.88, *environmental* (EV)= 10.36, dan *transcendental* (TC)= 11.22. Adapun uji kehandalan variabel laten didapatkan hasil *construct reliability* (CR) ≥ 0.70 dan *average variance extracted* (AVE) ≥ 0.50 . Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.21 berikut:

Tabel 3.21. *Convergent Validity* Variabel Laten Spiritualitas¹³⁹

Variabel Laten	Nilai SLF (≥ 0.40)	Nilai <i>Error</i>	Nilai CR (≥ 0.70)	Nilai AVE (≥ 0.50)	Kesimpulan Perhitungan
Spiritualitas			0.72	0.53	Reliabilitas Cukup
<i>Personal</i> (PS)	0.40	0.84			
<i>Communal</i> (CM)	0.41	0.83			
<i>Environmental</i> (EV)	0.65	0.57			
<i>Transcendental</i> (TC)	0.73	0.46			

¹³⁸Lihat Lampiran, “Analisis Hasil Uji Model Pengukuran – Spiritualitas”.

¹³⁹Lihat Lampiran, “Analisis Hasil Uji Model Pengukuran – Spiritualitas”.

Tabel di atas menjelaskan bahwa variabel laten spiritualitas memiliki konstruk pengukuran dengan nilai reliabilitas baik, dimana semua variabel manifest memiliki nilai SLF ≥ 0.40 dengan nilai masing-masing sebesar: PS (0.40), CM (0.41), EV (0.65), dan TC (0.73). Selanjutnya untuk menguji apakah data penelitian mendukung model yang ada, maka indikator nilai *Goodness of Fit Indices* (GOFI) variabel laten spiritualitas dapat dilihat pada tabel 3.22 di bawah ini:

Tabel 3.22. *Goodness of Fit Indices* (GOFI) Variabel Spiritualitas¹⁴⁰

N o	GOFI	Nilai Standard Untuk Kecocokan Model	Estimasi	Tingkat Kecocokan
1	Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)	$RMSE \leq 0.08$	0.07	Baik
2	Normed Fit Index (NFI)	$NFI \geq 0.90$	0.97	Baik
3	Non-Normed Fit Index (NNFI)	$NNFI \geq 0.90$	0.95	Baik
4	Comparative Fit Index (CFI)	$CFI \geq 0.90$	0.98	Baik
5	Incremental Fit Index (IFI)	$IFI \geq 0.90$	0.98	Baik
6	Relative Fit Index (RFI)	$RFI \geq 0.90$	0.92	Baik
7	Standarized Root Mean Square Residual (RMR)	$RMR \leq 0.05$	0.03	Baik
8	Goodness of Fit Index (GFI)	$GFI \geq 0.90$	0.99	Baik
9	Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)	$0.8 \leq AGFI < 0.9$	0.96	Baik

Tabel GOFI di atas menunjukkan bahwa model dapat dikatakan *fit* dengan data dalam mengukur variabel laten spiritualitas. Kelayakan model sudah memenuhi nilai ideal dari kriteria suatu model yang baik. Dengan demikian model pada gambar 3.3. merupakan model yang dapat diterima sebagai model yang mampu menjelaskan sumber stres pada mahasiswa kedokteran. Sementara tabel 3.21 menjelaskan kemaknaan dari dimensi-dimensi yang terekstraksi dalam membentuk variabel laten spiritualitas adalah baik, dari keempat indikator model pengukuran stresor (PS, CM, EV dan TC) indikator

¹⁴⁰Lihat Lampiran, “Analisis Hasil Uji Model Pengukuran – Spiritualitas”.

TC/*transcendental* lebih dominan dalam pembentukan variabel laten spiritualitas dibandingkan ketiga indikator lainnya.

Hasil analisis model pengukuran spiritualitas yang menunjukkan dominasi aspek transenden menjelaskan bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia, khusus nya para pelajar yang menjadi responden dalam penelitian ini membuktikan bahwa spiritualitas sangat sulit dipisahkan dari agama. Pada aspek spiritualitas beribadah kepada Tuhan merupakan wujud ekspresi keta'atan mendominasi jawaban responden terkait spiritualitas. Artinya mereka yang spiritualis menjadikan ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Hasil ini selaras dengan hampir 22 penelitian yang dilakukan oleh Fisher dari berbagai populasi, bahwa dalam dimensi spiritualitas aspek transenden “hubungan dengan Tuhan” merupakan faktor yang sangat penting dalam pembentukan variabel manifes spiritualitas.¹⁴¹ Namun hasil studi ini agaknya berbeda dengan beberapa studi konvensional terutama di Barat, dimana para mahasiswa meskipun mereka menyatakan mereka cukup spiritualis, namun mereka tidak menghubungkan hal tersebut dengan praktek ibadah keagamaan.¹⁴²

Hal ini dapat dipahami mengapa kemudian para mahasiswa mengatakan dirinya spiritualis namun tidak agamis, karena di dunia Barat spiritualitas didefinisikan sebagai urusan personal yang dimaknai sebagai usaha pencarian makna hidup, keterhubungan diri dengan dunia luar secara harmonis dan baik. Spiritualitas mereka pahami lebih luas maknanya dari pada religiusitas, mereka merasa cukup dengan hanya menjadi spiritualis, karena hakikatnya spiritualitas

¹⁴¹Fisher melakukan studi dimensi spiritualitas kurang lebih sebanyak 22 penelitian dari 9956 responden dari berbagai kalangan. Satu studi dengan 146 staf sekolah menengah, lima studi dengan 3873 siswa sekolah menengah, dua studi pada 966 guru di Australia dan hongkong, enam studi dengan 2963 mahasiswa di Australia, Hongkong, UK, Nederland dan Turki, lima studi dengan 974 pegawai kesehatan dari Australia, Canada dan Skotlandia. Dua studi dengan 539 pegawai di Australia dan Iran. Dimana 18 dari 22 riset-riset tersebut, didapati bahwa dimensi transpersonal menjadi indikator dominan dalam spiritualitas. Lih Jhon Fisher, “The Importance of Relating with God for Spiritual Well-being”, *Journal of Beliefs & Values*, Vol. 31, No. 3, (2010); 323-332.

¹⁴²Alyson St. Ahmad, *Interest in Religion Rises among College Students*, diakses dari <http://huntnewsnu.com/2004/01/interest-in-religion-rises-among-college-students/>, pada tanggal 14 Mei 2017, pukul 08.35 WIB.

meyakini sesuatu yang mulia yang tidak hanya terbatas pada penghambaan pada zaat yang dumuliakan, namun lebih dari itu keterhubungan dengan alam dan nilai-nilai mulia merupakan inti dari kehidupan.¹⁴³ Spiritualitas merupakan pengalaman sakralitas yang sangat bersifat subjektif. Sehingga spiritualitas mungkin berasal dari keagamaan dan kelompok dan bisa juga tidak.¹⁴⁴

Transenden dalam domain spiritualitas sulit dipisahkan dari agama, karena ada sosok Tuhan yang disucikan dalam domain ini, sementara petunjuk keberadaan Tuhan hanya didapat melalui institusi yang namanya agama. Melalui aspek transenden, hasil analisis menjelaskan bahwa ibadah menjadi sarana komunikasi antara individu dengan Tuhannya, individu merasakan kedekatan dengan Tuhannya, berdo'a serta merasakan ketenangan dengan Tuhan. Agama menjelaskan asal kehidupan manusia, artinya agama memberikan tuntunan makna dan tujuan hidup. Agama membuat kerangka tentang kebenaran, pemaknaan pengalaman hidup sehari-hari bahkan penjelasan terkait kematian dan kehidupan setelahnya.¹⁴⁵

Bonab et al (2013) menjelaskan kedekatan dengan Tuhan "*attachment to God*" merupakan inti dari spiritualitas, dimana kepada Tuhannya seorang muslim mencari kedamaian dari berbagai keadaan yang menekan dirinya, hubungan kepada Allah merupakan salah satu bentuk kepasrahan, ketundukkan, ketergantungan, kedekatan dan keringanan rasa cemas.¹⁴⁶ Bukti kedekatan seorang muslim kepada Allah banyak ditemui dalam berbagai ayat dalam al-Qur'an. Seperti

¹⁴³Dawn V. Overstreet, "Spiritual vs Religious: Perspectives from Today's Undergraduate Catholics", *Catholic Education: a Journal of Inquiry and Practices*, Vol. 14, No. 2, (2010); 238-263.

¹⁴⁴Elizabeth Mackinlay, *Spiritual Growth and Care in the Fourth Age of Life*, (London: Jessica Kingsley Publisher, 2006), 13.

¹⁴⁵Peter Gilbert, "The Spiritual Foundation: Awareness for Context People's Live Today" in *Spirituality, Values, and Mental Health* ed Marry Ellen Coyte, Peter Gilbert, & Vicky Nicholls, (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25.

¹⁴⁶Bagher Ghobary Bonab and others, "Attachment to God in Islamic Spirituality", *Journal of Muslim Mental Health*, Vol. 7, No. 2, (20013); 77-104.

ayat 4 dari surah al-Hadid,¹⁴⁷ ayat 16 dari surah Qaf,¹⁴⁸ ayat 85 dari surah al-Waqi'ah,¹⁴⁹ dan ayat 115 dari Surah al-Baqarah.¹⁵⁰ Melalui petunjuk agama timbul keyakinan pada individu bahwa kepada Tuhan ia dapat menggantungkan kejadian-kejadian dalam hidupnya, seperti keyakinan akan mukjizat, kekuatan dalam diri, keyakinan akan Tuhan yang selalu menyertai, dan sebagainya.¹⁵¹

Hasil analisis disertasi ini yang menjelaskan besarnya domain transenden dalam menjelaskan spiritualitas membuktikan pentingnya keterhubungan dengan Tuhan dalam spiritualitas, karena spiritualitas akan mengalami jalan buntu ketika individu gagal memahami eksistensi Tuhan. Namun demikian perenungan terhadap konektivitas dengan alam sekitar juga diperlukan sehingga muncul hubungan positif dua dimensi dimana menurut Seaward (2006) dua dimensi ini adalah vertikal spiritualitas yang hubungannya dengan Tuhan dan dimensi horizontal yakni spiritualitas yang hubungannya dengan sesama makhluk lainnya.¹⁵²

Pada analisis model struktural spiritualitas, domain kedua yang dominan adalah *environment/nature* yakni keterhubungan dengan alam dalam posisi menjaga alam, mengagumi alam serta merasakan kedekatan kesatuan diri terhadap alam. Menurut McDonald dan Friedman (2009) para pakar psikologi transpersonal aspek spiritualitas keterhubungan dengan alam dikatakan sebagai aspek kesadaran interaksi (*conscious interaction*) yakni kepedulian terhadap

¹⁴⁷Firman Allah SWT dalam QS al-Hadid ayat 4: “*Ia bersama kami, dimana saja kami berada*”.

¹⁴⁸Firman Allah SWT dalam QS Qaf ayat 16: “*dan kami lebih dekat dari urat lehernya*”.

¹⁴⁹Firman Allah SWT dalam QS al-Waqi'ah ayat 85: “*dan kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu, tetapi kamu tidak mengetahuinya*”.

¹⁵⁰Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah ayat 115: “*dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap disanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas, maha mengetahui*”.

¹⁵¹Van Leeuwen and others, “Aspects of Spirituality Concerning Illness”, *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, Vol. 21, (2008); 482-489.

¹⁵²Seaward, *Managing Stress: Principles and Strategies for Health and Well-Being*, (Sudbury: Jones and Bartlett, 2006), 224.

lingkungan.¹⁵³ Selaras dengan pandangan ini, Nasher (2008) dalam bukunya *Islamic Spirituality* menuliskan dalam satu bab terkait spiritual dan kosmos (sistem keteraturan alam) menjelaskan spiritualitas dalam Islam tidak hanya bersumber pada bacaan apa yang tertulis dalam al-Qur'an (*al-Qur'an al-tadwini*) tetapi juga terurai melalui ayat-ayat kosmik al-Qur'an (*al-Qur'an al-takwini*) yang menjadi pelengkap. Alam (*nature*) dalam spiritualitas Islam bukan lawan tetapi teman para *traveler* dalam perjalanan spiritualitas dan akan menambah pandangannya terhadap makna spiritualitas.

Sehingga dalam al-Qur'an menurut Nasher, Allah menggunakan istilah yang sama untuk menjelaskan tanda-tanda kebesaran-Nya "Ayat", dimana kata ayat bermakna ayat teks al-Qur'an tapi dalam waktu yang berbeda penciptaan alam semesta Allah juga menggunakan istilah kata "ayat", artinya baik teks al-Qur'an dan penciptaan bumi, langit dan semesta merupakan tanda kebesaran Allah. Dengan demikian dalam pencarian spiritualitas, individu tetap harus menjaga keharmonisan dirinya dengan alam semesta (kosmos).¹⁵⁴ Al-Qur'an dan penciptaan semesta keduanya merupakan sarana komunikasi Allah kepada manusia yang berpikir.¹⁵⁵ Dalam al-Qur'an disebutkan beberapa ayat terkait perintah pemeliharaan bumi seperti pada surah al-A'raf: 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan

¹⁵³McDonald dan Friedman, "Measures of Spiritual and Transpersonal Constructs for Use in Yoga", *International Journal of Yoga*, Vol. 2, NO. 1, (2009); 2-12.

¹⁵⁴Sayyed Hossein Nasr, *Islamic Spirituality*, (London: Routledge & Kegan Paul, 2008), 614-624

¹⁵⁵Charles Le Gai Eaton, *Islam and the Destiny of Man*, (New York: State University of New York Press, 1985), 87.

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (al-A'raf: 56)

dan perintah pentadaburan proses penciptaannya dan semua yang ada di dalamnya sebagaimana dalam surah *al-'Ankabut* ayat 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya:

"Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (al-'Ankabut: 20)

Selanjutnya domain ketiga dari pengukuran spiritualitas yang diungkap pada disertasi ini adalah *communal* (CM) yakni dimensi spiritualitas terkait hubungan individu dengan orang lain, ekspresi spiritualitas terhadap orang lain dalam bentuk menghormati orang lain, memaafkan kesalahan sesama, kasih sayang, dan menolong orang lain. Hidup dalam suasana harmoni dengan orang lain dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dalam konsep spiritualitas.¹⁵⁶

Hasil analisis aspek *communal* item yang dominan adalah *"saya menghormati orang lain meskipun berbeda pendapat"*. Hasil analisis sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Svoboda (2005) yang menyebutkan bahwa mahasiswa menunjukkan tingkat toleransi yang cukup tinggi terkait perbedaan yang ada di sekitarnya. Mahasiswa menunjukkan kenyamanan diri dengan perbedaan pendapat, mereka bisa berlainan pendapat namun tetap menghormati pendapat orang lain.¹⁵⁷ Selanjutnya item terpenting dalam hubungan *communal*

¹⁵⁶Harlina Nurtjahjanti, "Spiritualitas Kerja sebagai Ekspresi Keinginan Diri Karyawan untuk Mencari Makna dan Tujuan Hidup dalam Organisasi", *Jurnal Psikologi*, Vol. 7, No. 1, (2010); 27-30.

¹⁵⁷Svoboda (2005) dalam David R. Brown dan Mark S. Parrish, "College Student Spirituality: Helping Explore Life's Existential Questions", *VISTAS*, (2011).

adalah sifat saling memaafkan “*mudah bagi saya memaafkan orang lain*”.

Agama sangat menganjurkan individu untuk memaafkan orang lain, berbagai riset pun membuktikan manfaat positif sifat memaafkan. Memaafkan adalah penangkal sifat marah, permusuhan, dan kebencian. Sementara kemampuan diri untuk menghindari amarah dan merasa terhina karena orang lain dapat memberi efek positif kepada kesehatan mental.¹⁵⁸ Dalam ajaran Islam memaafkan kesalahan orang lain sangat dianjurkan, sehingga beberapa ayat dari al-Qur'an secara jelas mengajarkan perihal memaafkan orang lain seperti QS *al-‘Araf* ayat 199, dan memberi maaf merupakan ciri orang yang bertakwa QS *Ali Imran* ayat 134. Hal ini menunjukkan bahwa spiritualitas tidak hanya terbatas pada transendensi, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya:

“*Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*”. (QS *al-‘Araf*:199)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya;

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS *Ali Imran*: 134)

Domain terakhir dari spiritualitas yang ternyata memberikan sumbangan skor terkecil terhadap pembentukan spiritualitas adalah aspek *personal* (PS). Aspek ini terkait dengan makna hidup, pengena-

¹⁵⁸Thomas G. Plante, “What Do the Spiritual and Religious Traditions Offer the Practicing Psychologists?”, *Pastoral Psychol*, (2008).

lan diri sendiri, dan tujuan hidup. Diantara lima item yang mengukur dimensi ini hanya ada dua item yang dinyatakan valid yakni “*mengenai kelebihan dan kekurangan diri sendiri*” dan “*merasakan makna nilai kegembiraan*”. Hal ini selaras dengan pandangan Fisher (2011) yang menyebutkan spiritualitas merupakan kesadaran individu akan dirinya sendiri terkait dengan kemampuan mengidentifikasi nilai tentang diri sendiri dan tujuan dan makna hidup.¹⁵⁹

Aspek ini sangat kecil dominasinya dalam pengukuran spiritualitas dikarenakan para mahasiswa sejatinya mereka masih dalam proses pengembangan diri dan pencarian makna hidup.¹⁶⁰ Bahkan menurut Erikson (1968) krisis terbesar pada masa remaja adalah pencarian makna untuk konsistensi identitas diri.¹⁶¹ Sehingga dengan demikian kegagalan mahasiswa dalam pencarian makna dibalik peristiwa yang terjadi masih dianggap sesuatu yang wajar karena sesuai dengan masa perkembangan pada diri mereka yang masih berada pada masa pencarian makna dan tujuan hidup. Namun demikian lingkungan kampus dan proses pembelajaran di perguruan tinggi pada beberapa penelitian menyebutkan bahwa mahasiswa meyakini proses akademisi yang sedang mereka jalani membantu mereka dalam penemuan makna dan tujuan hidup.

4. Dominansi Regulasi Diri Belajar Melalui Pengulangan (*Rehearsal*)

Usaha untuk mengatur dan merubah respon diri terhadap stresor yang dialami dikenal dengan istilah regulasi diri (*self regulated*) dalam dunia akademik dikembangkan menjadi regulasi diri belajar (*self regulated learning/SRL*) yakni dimana pelajar berusaha mengatur motivasi, emosi, kognisi dan tindakan yang dirasa paling cocok dalam menjalankan proses akademik yang sedang berlangsung.

¹⁵⁹Jhon Fisher, “The Four Domains Model: Connecting Spirituality, health and Well-Being”, *Religion*, Vol. 2, (2011); 17-28.

¹⁶⁰William Damon, Jenni Menon, dan Kendall Cotton Bronk, “The Development of Purpose During Adolescence”, *Applied developmental Science*, Vol. 7, No. 3, (2003); 119-128.

¹⁶¹Erikson (1980) dalam Robert G. Blair, “Helping Older Adolescents Search for Meaning in Depression”, *Journal of Mental Health Counseling*, Vol. 26, No. 4, (2004); 333-347.

sung.¹⁶² Prinsip utama dalam regulasi diri belajar adalah pelajar yang secara personal mampu meregulasi dirinya akan lebih efektif dalam belajar.¹⁶³

Sistem pembelajar PBL yang diterapkan pada pendidikan dokter membentuk karakter pelajar yang mandiri, sehingga regulasi diri belajar menjadi faktor krusial bagi para pelajar yang mampu mengambil manfaat dari lingkungan sistem akademik tersebut.¹⁶⁴ Pada beberapa riset dibuktikan bahwa regulasi diri dapat menjadi penentu prestasi akademik, karena melalui regulasi diri pelajar dapat menyesuaikan keadaan dan situasi berbeda yang dihadapi dalam lingkungan belajar.¹⁶⁵

Bagi mahasiswa kedokteran skil regulasi diri sangat diperlukan khususnya mereka yang sedang mengikuti program klinis, dimana regulasi diri ini diperlukan ketika berhadapan dengan pasien, belajar, berpikir kritis, assesmen aktifitas pribadi, dan mendapatkan informasi-informasi terkini.¹⁶⁶ Pada disertasi ini guna menganalisis tingkat regulasi diri belajar mahasiswa kedokteran penulis mengadopsi skala yang disusun oleh Pintrich et al (1999) "*Motivation Strategies for learning Questionnaire (MSLQ)*" yang sudah banyak sekali digunakan untuk mengukur kemampuan regulasi diri dalam

¹⁶²Mohammad Azrien Mohamed Adnan and others, "Self-Regulated Learning and Motivation of Islamic Studies and Non-Islamic Studies Stream Students:", *GESJ; Education Science and Psychology*, Vol. 32, No. 6, (2014); 1-16.

¹⁶³Dale H. Schunk dan Barry Zimmerman, *Self Regulated Learning: from Teaching to Self-Reflective Practice*, (New York: Guilford Press, 1998), 76.

¹⁶⁴Salah Eldin Kassab and others, "Relationship between the Quality of Blended Learning Expetience, Self Regulated Learning, and Academic Achievement of Medical Students: a Path Analysis, *Advances in Medical Education and Practice*, Vol. 6, (2015); 27-34.

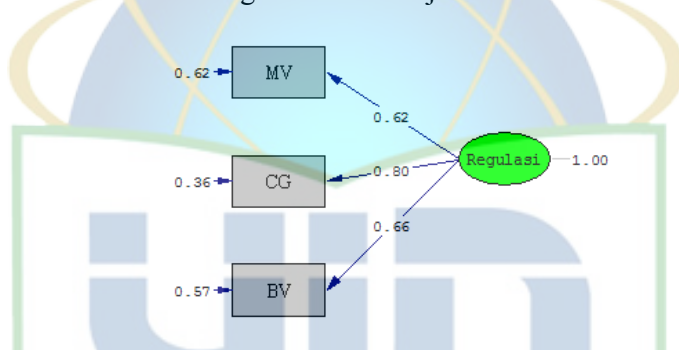
¹⁶⁵Michael, CW. Yip, "Differences between High and Low Academic Achieving University Students in Learning and Study Strategies; a Further Investigation", *Educational Research and Evaluation*, Vol. 16, No. 6, (2009); 561-570.

¹⁶⁶Nicole, N. Woods, Maria Mylopoulos dan Ryan Brydges, "Informal self Regulated Learning on a Surgical Rotation: Uncovering Student Experiences in Context", *Advances in Health Sciences Education*, Vol. 16, No. 5, (2011); 643-53.

belajar yang tentunya terlebih dahulu telah disesuaikan dengan konteks kajian setempat dan pengurangan beberapa item yang awalnya berjumlah 81 item menjadi 29 item melalui bimbingan tenaga profesional untuk analisis alat ukur.

Berdasarkan teori sosial kognitif MSLQ merupakan instrumen rapor diri yang didesain untuk mengukur orientasi motivasi dan strategi pelajar.¹⁶⁷ Beberapa studi yang dilakukan di kalangan akademisi kedokteran juga menggunakan MSLQ dimana hasil studi tersebut menemukan hubungan antara prestasi mahasiswa kedokteran dengan regulasi diri belajar melalui penggunaan skala MSLQ.¹⁶⁸ Adapun hasil analisis model pengukuran penelitian ini terhadap alat ukur MSLQ diilustrasikan pada gambar 3.4 berikut ini:

Gambar 3.4. Uji Model Pengukuran Variabel Laten Regulasi Diri Belajar¹⁶⁹



Dari diagram lintasan pada gambar 3.4 bisa dilihat bahwa hasil estimasi model pengukuran variabel laten regulasi diri belajar menunjukkan semua variabel teramati memiliki *standardized loading factor* (SLF) ≥ 0.40 dan bisa dilihat bahwa hasil estimasi model struktural/ *full model* sudah menunjukkan bahwa semua variabel

¹⁶⁷Paul R. Pintrich dan Elisabeth, V. De Groot, “Motivational and Self-Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance”, *Journal of Educational Psychology*, Vol. 82, (1990); 33-40.

¹⁶⁸David A. Cook and others, “The Motivated Strategies for Learning Questionnaire: Score Validity among Medicine Residents”, *Med Educ*, Vol. 45, (2011); 230-240.

¹⁶⁹Lihat Lampiran, “Analisis Hasil Uji Model Pengukuran – Regulasi Diri Belajar”.

teramati memiliki nilai >1.96 . Secara rinci t-hitung yang didapati adalah sebagai berikut: *motivation* (MV)= 11.12, *cognition* (CG)= 13.75, dan *behavior* (BV)= 10.36. Adapun uji kehandalan variabel laten didapati hasil *construct reliability* (CR) ≥ 0.70 dan *average variance extracted* (AVE) ≥ 0.50 . Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.23. berikut:

Tabel 3.23. *Convergent Validity* Laten Regulasi Diri Belajar¹⁷⁰

Variabel Laten	Nilai SLF (≥ 0.40)	Nilai Error	Nilai CR (≥ 0.70)	Nilai AVE (≥ 0.50)	Kesimpulan Perhitungan
Regulasi Diri Belajar			0.74	0.58	Reliabilitas Cukup
Motivation(MV)	0.62	0.76			
Cognition (CG)	0.80	0.36			
Behavior (BV)	0.66	0.57			

Tabel di atas menjelaskan bahwa variabel laten regulasi diri belajar memiliki konstruk pengukuran dengan nilai reliabilitas cukup, dimana semua variabel manifest memiliki nilai SLF ≥ 0.40 dengan nilai masing-masing sebesar: MV (0.62), CG (0.80), dan BV (0.66). Selanjutnya untuk menguji apakah data penelitian mendukung model yang ada, maka indikator nilai *Goodness of Fit Indices* (GOFI) variabel laten regulasi diri belajar dapat dilihat pada tabel 3.24 di bawah ini:

¹⁷⁰Lihat Lampiran, “Analisis Hasil Uji Model Pengukuran – Regulasi Diri Belajar”.

Tabel 3.24. *Goodness of Fit Indices (GOFI)*
Variabel Regulasi Diri Belajar¹⁷¹

No	GOFI	Nilai Standard Untuk Kecocokan Model	Estimasi	Tingkat Kecocokan
1	Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)	$RMSE \leq 0.08$	0.08	Baik
2	Normed Fit Index (NFI)	$NFI \geq 0.90$	0.97	Baik
3	Non-Normed Fit Index (NNFI)	$NNFI \geq 0.90$	0.94	Baik
4	Comparative Fit Index (CFI)	$CFI \geq 0.90$	0.98	Baik
5	Incremental Fit Index (IFI)	$IFI \geq 0.90$	0.98	Baik
6	Relative Fit Index (RFI)	$RFI \geq 0.90$	0.92	Baik
7	Standardized Root Mean Square Residual (RMR)	$RMR \leq 0.05$	0.03	Baik
8	Goodness of Fit Index (GFI)	$GFI \geq 0.90$	0.99	Baik
9	Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)	$0.8 \leq AGFI < 0.9$	0.95	Baik

Tabel GOFI di atas menunjukkan bahwa model dapat dikatakan *fit* dengan data dalam mengukur variabel laten regulasi diri belajar. Kelayakan model sudah memenuhi nilai ideal dari kriteria suatu model yang baik. Dengan demikian model pada gambar 3.4 merupakan model yang dapat diterima sebagai model yang mampu menjelaskan regulasi diri belajar pada mahasiswa kedokteran. Sementara tabel 3.23 menjelaskan kemaknaan dari dimensi-dimensi yang terekstrasi dalam membentuk variabel laten regulasi diri belajar adalah baik, dari ketiga indikator model pengukuran regulasi diri belajar (MV, CG dan BV) indikator CG/*cognition* paling dominan dalam pembentukan variabel laten regulasi diri belajar dibandingkan kedua indikator lainnya.

Regulasi diri belajar kognisi melibatkan penggunaan regulasi diri melalui strategi berpikir (kognisi) dalam proses pembelajaran, seperti mengulangi pelajaran (*rehcarsal*) “*ketika belajar, saya mengulangi lagi dan lagi materi yang sudah diajarkan*”, elaborasi “*saya*

¹⁷¹Lihat Lampiran, “Analisis Hasil Uji Model Pengukuran – Regulasi Diri Belajar”.

membuat ringkasan ide materi dari dosen dan hasil diskusi”, organisasi ide pikiran “*memberi tanda khusus untuk memudahkan penyusunan ide utama materi perkuliahan, membuat diagram chart atau sejenis untuk merangkum materi, berpikir kritis (mengembangkan ide pemahaman ketika mengulangi materi, mencari teori baru dan bukti lainnya yang mendukung materi)*”, kontrol proses belajar (*membuat pertanyaan pribadi untuk meningkatkan fokus bacaan*).

Diantara indikator regulasi diri “*rehearsal* (mengulang-ngulang materi)” merupakan regulasi diri kognisi yang paling dominan dilakukan oleh para partisipan. Prinsip repetisi ini juga diterapkan oleh Rasulullah ketika menyampaikan hadits kepada para sahabatnya. Sebagaimana kita menjumpai dalam beberapa riwayat, bahwa Rasulullah mengulangi sabdanya yang sama sampai tiga kali, sehingga para sahabat paham dan menguasai ajaran yang beliau sampaikan. Diantaranya Anas berkata, “*Sesungguhnya Nabi SAW, jika menyampaikan suatu kalimat, beliau akan mengulanginya sebanyak tiga kali, sehingga ungkapan itu benar-benar bisa dipahami*”.¹⁷²

Repetisi diperlukan dalam proses belajar, karena kebanyakan materi atau keahlian yang telah dipelajari membutuhkan proses pengulangan dan latihan sampai dikuasai dengan sempurna.¹⁷³ Dengan demikian repetisi diperlukan tidak hanya memperkuat hafalan namun juga pengulangan diperlukan untuk menanamkan kebiasaan. Ketika sebuah aktivitas diulang berkali-kali, pelakunya akan terbiasa dan semakin mahir.

Sementara itu, Bandura di awal tahunan 1960-an dan 1970-an menjelaskan bahwa, individu tidak semuanya hanya menjadi seorang yang pasif dalam belajar. Pada sebagian pelajar mereka akan menjadi sangat aktif dalam mengontrol proses belajarnya terutama dalam meregulasi kognisinya, dan cara belajarnya. Seperti seorang pelajar yang merasakan frustrasi dengan rutinitas membacanya, akan melakukan *self talk* terkait dengan apa yang dibaca dan akan mengu-

¹⁷²HR Bukhārī dan Abu Dawūd, dalam *Nāṣif*, vol 1 hal 71, dan *An-Nawāwī*, Vol. 1, hal. 664.

¹⁷³Muhammad Utsman Najati, *The Ultimate Psychology – Psikologi Sempurna ala Nabi SAW*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), 213.

lang-ngulang (melakukan repetisi) bacaan yang penting menurutnya.¹⁷⁴

Selanjutnya indikator kedua *dominan* dari laten regulasi diri belajar adalah aspek perilaku/tindakan (*behavior*), yakni kontrol aktif atau penggunaan sumber yang tersedia bagi pelajar untuk memudahkan proses belajar mereka seperti memanfaatkan waktu, tempat belajar, usaha dan teman-teman sebaya.¹⁷⁵ Tindakan yang paling banyak dilakukan oleh responden pada penelitian ini adalah memanfaatkan teman sebaya seperti : *belajar dengan mahasiswa lain untuk menyelesaikan tugas kuliah, bertanya dengan teman, menjelaskan materi kepada teman*, selanjutnya adalah pengelolaan waktu belajar “*memanfaatkan waktu sebaik mungkin*. Regulasi diri dalam tindakan memungkinkan seseorang untuk mengingat dan berkonsentrasi kepada tugas tanpa mendapatkan gangguan. Sehingga dengan itu beberapa riset menunjukkan hubungan positif antara regulasi tindakan dengan hasil yang baik dalam proses belajar.¹⁷⁶

Sementara domain regulasi diri yang ketiga adalah motivasi. Tingkat dominasi pada regulasi diri sebagaimana yang didapati pada hasil analisis pengukuran, bukan bermakna bahwa dalam aplikasinya regulasi diri harus berurutan *mengikut* tiga fase di atas, karena menurut Pintrich pembagian indikator regulasi diri tidak bersifat hierarki/ bertingkat bahwa yang satu indikator mendahului indikator lainnya. Regulasi diri dapat terjadi secara simultan dan dinamis.¹⁷⁷

Regulasi diri motivasi meliputi kontrol diri terhadap keyakinan motivasi diri, seperti efikasi diri, orientasi tujuan, memaknai test

¹⁷⁴Bandura dalam John Sandars dan Timothy J Cleary, “Self Regulation Theory: Applications to Medical Education”, *Medical Teacher*, Vol. 33, No. 11, (2011); 875-886.

¹⁷⁵Paul R. Pintrich, “A Conceptual Framework for Assessing Motivation and Self- Regulated Learning in College Students”, *Educ Psychol Rev*, Vol. 16, (2004); 385-407.

¹⁷⁶Megan M. McClelland and others, “Links between Behavioral Regulation and Preschoolers’ Literacy, Vocabulary, and Math Skills”, *Dev. Psychol.* Vol. 43, (2007); 947–959.

¹⁷⁷Paul R. Pintrich, “The Role of Goal Orientation in Self-Regulated Learning”, *Handbook of self-regulation*, (San Diego CA: Academic Press, 2000), 451–502.

yang dihapin.¹⁷⁸ Motivasi terbanyak yang dimiliki oleh responden berdasarkan analisis kajian adalah “*melakukan hal terbaik untuk menunjukkan kemampuan diri pada keluarga, teman dan semua orang*”, selanjutnya diikuti dengan efikasi diri yakni “*merasa mampu mempelajari materi sulit asalkan dengan cara belajar yang tepat*”. Sementara pada memaknai ujian/*test values* diekspresikan dengan ungkapan “*saya ingin mendapatkan nilai terbaik diantara mahasiswa sekelas lainnya*”.

Hasil analisis di atas dapat dipahami bahwa dalam aspek regulasi diri motivasi ada dua bentuk motivasi yang dimiliki pelajar Internal/*intrinsic* “*motivasi kemampuan diri sendiri*” dan juga eksternal/*extrinsic* “*motivasi ingin menunjukkan kepada orang lain*”. Menurut Deci dan Ryan (2000) motivasi intrinsik dipahami sebagai individu melakukan suatu aktifitas dikarenakan untuk kepuasan diri sendiri dibandingkan karena tuntutan dari luar. Sementara motivasi ekstrinsik adalah individu melakukan sesuatu lebih atau melakukan suatu tugas dikarenakan tuntutan dari luar seperti ingin mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman.¹⁷⁹

Dalam literasi berbeda terkait dengan konsep regulasi diri belajar, domain motivasi dipahami sebagai domain regulasi diri dalam bentuk emosi. Menurut Zimmerman regulasi diri belajar itu meliputi regulasi berpikir, perasaan (emosi) dan tindakan. Regulasi motivasi merupakan bagian dari regulasi emosi karena didalamnya ada efikasi diri, ekspektasi hasil belajar dan orientasi tujuan.¹⁸⁰ Apabila dihubungkan dengan model transaksi antara stres dan koping, regulasi diri belajar dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *direct*

¹⁷⁸Salah Eldin Kassab and others, “Relationship between the Quality of Blended Learning Experience, Self Regulated Learning, and Academic Achievement of Medical Students: a Path Analysis”, *Advances in Medical Education and Practice*, No. 6, (2015); 27-34.

¹⁷⁹Edward L. Deci dan Richard M. Ryan, “The “what” and “why” of Goal Pursuit: Human Needs and the Self-Determination of Behavior”, *Psychological Inquiry*, Vol. 11, No. 4, (2000); 227-268.

¹⁸⁰Efikasi diri bermakna kepercayaan diri untuk mampu belajar secara efektif, dan ekspektasi hasil merupakan keyakinan terkait hasil akhir performa diri dalam belajar. Lih Barry J. Zimmerman, “A social Cognitive View of Self Regulated Academic Learning”, *Jurnal of Educational Psychology*, Vol. 81, (1989), 329-339.

coping atau yang disebut dengan istilah efektif coping. Regulasi diri belajar bisa mengarah pada tindakan coping *behavior* karena regulasi diri mengarah pada tindakan yang disebut *behavioral self regulation* (regulasi tindakan diri) dan satu lagi mengarah *emotional self regulation* (regulasi emosi diri)¹⁸¹ yang mana kedua bentuk regulasi diri ini memiliki konsep semakna dalam dua bentuk coping yakni *problem oriented strategies* dan *emotion oriented strategies*.¹⁸² Penjelasan pemaknaan regulasi diri sebagai bentuk coping akan dibahas lebih detail pada bab selanjutnya.

E. Pengaruh Mediasi Regulasi Diri Belajar dalam Hubungan Spiritualitas dan Stres

Setelah semua asumsi dapat dipenuhi sebagaimana model pengukuran masing-masing variabel laten eksogen dan endogen telah terlebih dahulu dijabarkan, selanjutnya akan diuraikan model struktural antar variabel laten yang terbentuk dari model pengukuran tersebut. Tabel 3.25 berikut menjelaskan uji kecocokan keseluruhan model. Uji ini untuk menentukan bahwa data yang digunakan mempunyai kecocokan dengan model penelitian.

¹⁸¹Carolyn Aldwin, and others, "Differing Pathways between Religiousness, Spirituality and Health: a Self Regulation Perspective", *Psychology of Religion and Spirituality*, Vol. 6, No. 1, (2014); 9-21.

¹⁸²Mirjam Weis, Tobias heikamp dan Gisela Trommsdorff, "Gender Differences in School Achievement: the Role of Self Regulation", *Frontiers in Psychology*, Vol. 4, (2013); 1-10.

Tabel 3.25. *Goodness of Fit Indices (GOFI)*
Uji Model Struktural¹⁸³

No	GOFI	Nilai Standard Untuk Kecocokan Model	Estimasi	Tingkat Kecocokan
1	Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)	$RMSE \leq 0.08$	0.05	Baik
2	Normed Fit Index (NFI)	$NFI \geq 0.90$	0.94	Baik
3	Non-Normed Fit Index (NNFI)	$NNFI \geq 0.90$	0.96	Baik
4	Compative Fit Index (CFI)	$CFI \geq 0.90$	0.97	Baik
5	Incremental Fit Index (IFI)	$IFI \geq 0.90$	0.97	Baik
6	Relative Fit Index (RFI)	$RFI \geq 0.90$	0.92	Baik
7	Standarized Root Mean Square Residual (RMR)	$RMR \leq 0.05$	0.06	Baik
8	Goodness of Fit Index (GFI)	$GFI \geq 0.90$	0.94	Baik
9	Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)	$0.8 \leq AGFI < 0.9$	0.91	Baik

Hasil tabel GOFI di atas menunjukkan bahwa data mendukung model untuk uji model pengukuran struktural, dimana seluruh indikator menunjukkan kecocokan yang baik dan mendukung model penelitian.

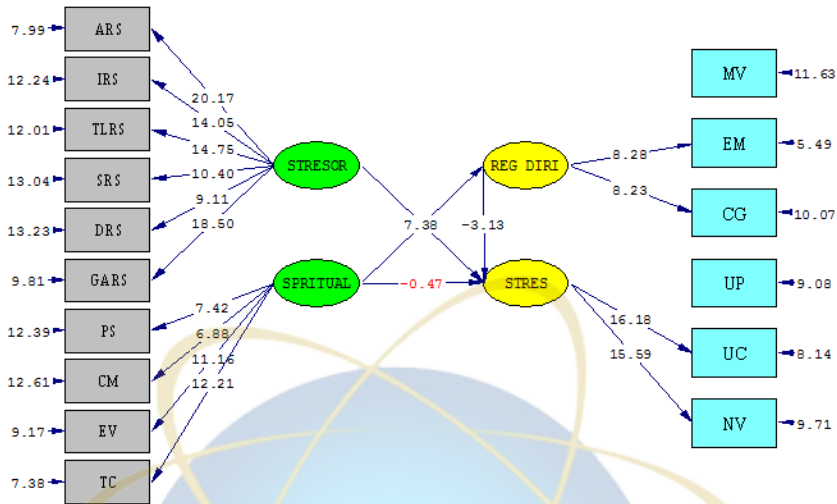
Selanjutnya Hasil analisis struktural akan memberikan rincian hipotesa mana saja yang diterima dan ditolak. Hipotesa diterima jika nilai *t-value* (> 1.96) dan tanda koefisien (positif atau negatif) harus sesuai dengan pernyataan hipotesa. Gambar hasil uji model struktural ditampilkan dalam dua bentuk yaitu:

- 1) Berdasarkan nilai *t-value* untuk uji hipotesa
- 2) Berdasarkan nilai standar /*standardized solutions*, untuk melihat besar kecilnya pengaruh antar variabel laten penelitian pada hipotesa.

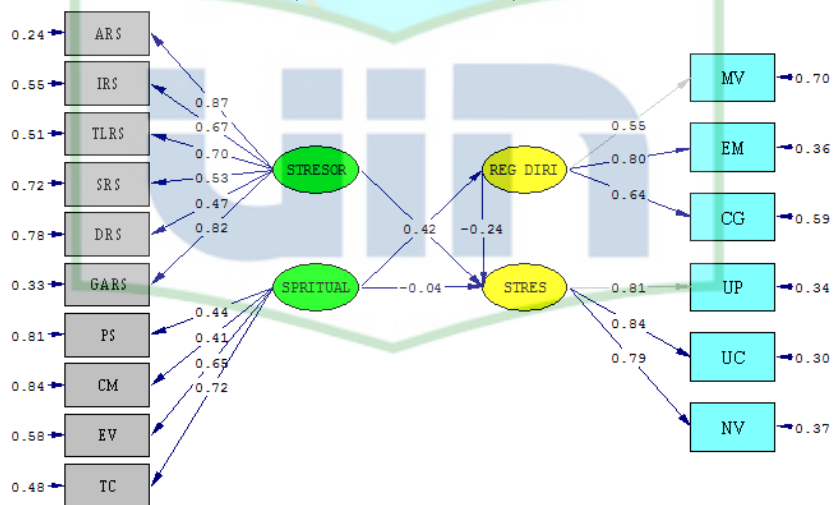
Gambar 3.5. dan 3.6. berikut menjelaskan hasil uji model struktural keduanya.

¹⁸³Lihat lampiran, “Analisa Hasil Uji Model Struktural”.

Gambar 3.5. Hasil Uji Model Struktural Penelitian (*t-value*)



Gambar 3.6. Hasil Uji Model Struktural Penelitian (Koefisien Standar)



Dari dua diagram lintasan pada gambar 3.5 dan 3.6 bisa dilihat bahwa estimasi koefisien model struktural dari hubungan stresor dan stres mengindikasikan adanya hubungan positif, hubungan spiritualitas dan stres mengindikasikan adanya hubungan negatif,

hubungan spiritualitas dan regulasi diri belajar mengindikasikan adanya hubungan positif, hubungan regulasi diri belajar dan stres mengindikasikan hubungan positif, sementara model struktural dari mediasi regulasi diri belajar mengindikasikan adanya hubungan negatif signifikan. Hal ini dapat dipahami bahwa spiritualitas dapat menekan tingkat stres melalui perantara regulasi diri yang baik. Tabel 3.26 menjelaskan estimasi koefisien model struktural.

Tabel 3.26. Estimasi Koefisien Model Struktural

Path	Total Pengaruh		Pengaruh Langsung		Pengaruh tidak Langsung	
	Estimasi Koefisien	t-hitung	Estimasi Koefisien	t-hitung	Estimasi Koefisien	t-hitung
Spiritualitas → RDB → Stres					-0.12	-2.96***
Spiritualitas → Stres	-0.16	-2.56** *	-0.04	-0.47		
Stresor → Stres			0.42	7.38** *		
Spiritualitas → RDB			0.51	6.09** *		
RDB → Stres			-0.24	-3.13** *		

Tabel 3.26 di atas menjelaskan spiritualitas memiliki pengaruh total negatif signifikan terhadap stres sebesar -0.16 ($t=-2.56$) > ($t=1.96$), nilai total pengaruh ini didapatkan sebagai penjumlahan dari pengaruh langsung (-0.04) dan pengaruh tidak langsung (-0.12). Stresor memiliki pengaruh langsung positif signifikan terhadap stres sebesar 0.42 ($t=7.38$), besaran nilai ini sekaligus menjadi pengaruh total dikarenakan stresor diasumsikan hanya memiliki hubungan langsung terhadap stres. Spiritualitas memiliki pengaruh langsung positif signifikan terhadap regulasi diri belajar sebesar 0.51 ($t=6.09$), besaran nilai ini sekaligus menjadi pengaruh total dikarenakan spiritualitas diasumsikan hanya memiliki hubungan langsung terhadap regulasi diri belajar. Terakhir, regulasi diri belajar memiliki hubungan langsung negatif signifikan terhadap stres sebesar -0.24 ($t=-3.13$), besaran nilai ini sekaligus menjadi pengaruh total dikarenakan regu-

lasi diri belajar diasumsikan hanya memiliki hubungan langsung terhadap stres.

Berdasarkan hasil output analisis struktural didapatkan bahwa R^2 keseluruhan model adalah sebesar 0.26.¹⁸⁴ Hal ini menjelaskan bahwa kesemuhan variabel yang diuji pada penelitian yakni stresor, spiritualitas dan regulasi diri belajar secara bersama-sama memberikan pengaruh pada stres sebesar 26%, sisanya 74% stres mahasiswa kedokteran dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dikemukakan pada penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan tabel pengujian model struktural di atas, maka secara garis besar ada lima sub struktur yang dapat dianalisis sekaligus merupakan hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini, yaitu:

1. Pengaruh Stresor terhadap Stres

Etiologi stres adalah sangat kompleks dan multi faktor serta berbeda sesuai dengan lingkungannya. Di kalangan mahasiswa, persepsi stres muncul dari proses akademik yang dijalani. Stres yang dihadapi mahasiswa dapat mengganggu lingkungan luar dan dalam diri pelajar yang kemudian menyebabkan perubahan psikologis yang dapat mengancam homeostasis.¹⁸⁵

Miliu pendidikan kedokteran selalu dianggap sebagai atmosfer belajar yang penuh tekanan. Ada beberapa stresor potensial yang dapat menimbulkan psikologis stres bagi mahasiswa medis. Kemudian berdasarkan hasil beberapa riset menyebutkan bahwa stres yang dirasakan memengaruhi konsep diri mahasiswa, yang mana di kemudian hari mereka akan merasakan tidak puas dengan proses akademik yang sudah dijalani dan mengurangi kepercayaan diri dan profesionalisme sebagai tenaga medis.¹⁸⁶ Sehingga karena itu beberapa peneliti menyatakan pentingnya melakukan diagnosis awal terkait sumber

¹⁸⁴Lihat lampiran “Analisis hasil Uji Model Struktural - *Structural Equation*”.

¹⁸⁵Christopher, E. Ekpenyong and others, “Academic Stress and Menstrual Disorder among Female Undergraduate in Uyo, South eastern Negeria- the Need for Health Education”, *Niger J. Physiol Sci*, Vol. 26, (2011); 193-198.

¹⁸⁶Ratana Saipanish, “Stress among medical Students in a Thai Medical School”, *Journal Medical Teacher*, Vol. 25, No. 5, (2003); 502-506.

stres yang dihadapi mahasiswa yang mungkin berhubungan positif secara langsung terhadap stres yang dirasakan.

Berdasarkan analisis hubungan kausalitas antara stresor dengan stres yang dipersepsikan mahasiswa menunjukkan bahwa stresor berpengaruh terhadap stres dan memiliki hubungan positif signifikan sebesar 0.42 ($t = 7.38$). Hal ini memiliki makna bahwa stresor cenderung meningkatkan potensi stres. Selanjutnya nilai t hitung yang lebih besar dari t kritis menunjukkan bahwa pada tingkat kepercayaan 99% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel stresor terhadap stres. Dari keenam dimensi stresor didapati sumber stres terkait akademik memberikan sumbangan terbesar dengan nilai koefisien 0.87 (Lihat gambar 3.6 di atas).

Hasil analisis senada dengan *review* beberapa riset yang menyebutkan stresor terkait akademik memberikan efek negatif khususnya terkait dengan tingkat depresi, stres, dan kecemasan di kalangan para mahasiswa kedokteran.¹⁸⁷ Selanjutnya terkait sumber stres yang berhubungan dengan akademik, test dan sistem ujian memberikan pengaruh yang paling tinggi munculnya stres¹⁸⁸. Kemudian mahasiswa juga terekspos dengan materi yang *overload* di tengah lingkungan belajar yang kompetitif serta kurangnya waktu untuk mengulang materi, hal ini menyebabkan perubahan pada kebiasaan aktifitas harian mereka seperti kurang tidur, kurang makan dan istirahat, sehingga kemudian memunculkan keadaan tertekan dan gangguan psikologis seperti stres dan depresi.¹⁸⁹

Pada penelitian ini analisis menunjukkan hasil yang cukup menarik, dimana sumber stres terkait aktifitas group didapati memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap stres dengan nilai koefisien sebesar 0.82 (lihat gambar 3.7 di atas). Hal ini bermakna ketika aktifitas kelompok semakin tinggi dipersepsikan sebagai sumber

¹⁸⁷Abdus Salam and others, "Stress among Medical Students in Malaysia: a Systematic Review of Literatures", *International Medical Journal*, Vol. 20, No. 6, (2013); 649-655.

¹⁸⁸David Kaufman, David Mensink dan Victor Day, "Stressors in Medical School: Relation to Curriculum Format and Year of Study", *Teaching and Learning in Medicine*, (1998).

¹⁸⁹Ali Sahraian, Javadpour, "Sleep Disruption and its Correlation to Psychological Distress among Medical Students", *SEMI*, Vol. 11, (2010); 12-17.

stres, maka resiko kejadian stres akan semakin tinggi. Kenyataan ini setidaknya menyoroti satu hal bahwa selain pengembangan keilmuan dalam bidang medis, mahasiswa juga harus dikembangkan skil kerja bersama tim. Penekanan dalam tugas kelompok diarahkan sebagai salah satu proses pengembangan skil untuk mahasiswa sebagai calon medis mampu bekerjasama dan sama-sama kerja.

2. Determinasi Spiritualitas terhadap Stres

Stres terjadi karena penilaian individu terhadap suatu peristiwa atau kejadian harian yang dianggap sebagai sesuatu yang mengancam, menantang ataupun membahayakan diri secara psikologis, emosional, kognitif dan perilaku. Dengan demikian sesuatu didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan (*stressfull event*) atau tidak bergantung pada respon yang diberikan oleh individu.¹⁹⁰ Dalam teori humanistik, subjektifitas persepsi manusia terhadap kejadian hidup dipengaruhi oleh penilaian diri terhadap sumber ketahanan yang ada dalam dirinya.¹⁹¹ Rogers (1961) kemudian mengatakan salah satu sumber ketahanan diri yang dapat memengaruhi persepsi adalah tingkat spiritualitas dalam diri individu. Ia menegaskan pentingnya peran spiritualitas dalam membentuk persepsi diri, nilai hidup dan perilaku.¹⁹²

Di kalangan para peneliti spiritualitas memang dianggap sebagai aspek penting yang dapat memengaruhi kesejahteraan diri baik psikologis, sosial dan perilaku. Kesejahteraan diri (*well-being*) bermakna optimalisasi fungsi psikologis untuk sebaik mungkin tetap merasakan nyaman dan senang dalam berbagai keadaan, yang salah satunya adalah mampu terhindar dari disfungsi psikologis stres. Mekanisme spiritualitas dalam memengaruhi fungsi positif psikologis dapat terlihat contohnya lewat ibadah sholat atau meditasi yang dijadikan sebagai sebuah proses pencarian kekuatan, dukungan dan petunjuk. Spiritualitas sumber pertahanan dalam diri memberikan perasaan

¹⁹⁰Fitria Fausiah dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal*, (Jakarta: UI-Press, 2007), 10.

¹⁹¹Albert Ellis, *Humanistic Psychotherapy: the Rational-Emotive Approach*, (New York: Mc-Gram-Hill, 1973), 73.

¹⁹²Carl R. Rogers, *On Becoming a Person*, (Boston: Houghton Mifflin, 1961), 126.

kuat di saat-saat kritis atau ketika menghadapi kenyataan hidup yang tidak menentu.¹⁹³

Dalam konteks akademik, spiritualitas dikonsepsikan sebagai sumber ketahanan diri yang bermanfaat bagi para mahasiswa untuk mempertahankan keseimbangan diri ketika menghadapi stresor.¹⁹⁴ Spiritualitas berhubungan terbalik dengan emosi negatif, dalam artian spiritualitas dapat menekan (tapi tidak terbatas) stres. Hasil analisis jalur pada penelitian ini membuktikan bahwa spiritualitas melalui regulasi diri belajar memiliki pengaruh total negatif signifikan terhadap stres sebagaimana dikutip pada tabel 3.29 di atas dengan nilai koefisien sebesar -0.12 dan *t-value* (-2.96 > -1.96).

Pada analisis jalur sebagaimana diilustrasikan pada gambar 3.5 memang terlihat hubungan langsung tidak signifikan dengan nilai *t-value* (-0.47 < 1.96), hal ini adalah wajar karena pada analisis ini, regulasi diri sebagai variabel diikut sertakan pada analisis keseluruhan model. Hasil analisis justru diharapkan hubungan langsung spiritualitas terhadap stres tidak lagi signifikan dikarenakan ada variabel regulasi diri sebagai mediator. Sebagaimana dijelaskan oleh Baron dan Kenny (1986) bahwa jalur hubungan langsung *independent variabel* (IV) terhadap *dependent variabel* (DV) tidak lagi signifikan ketika dimediasi oleh *variabel mediator* (M).¹⁹⁵

Untuk menegaskan dan membuktikan bagaimana nilai signifikansi hubungan spiritualitas terhadap stres, penulis melakukan analisis parsial antara spiritualitas dan stres tanpa regulasi diri sebagai mediator. Hasil analisis menunjukkan bahwa spiritualitas terbukti memiliki hubungan negatif signifikan dengan stres sebesar nilai koefisien -0.20 dan *t-value* (-2.95 > -1.96).¹⁹⁶ Dari keempat dimensi

¹⁹³Dirk Van Dierendonck dan Krishna Mohan, "Some Thoughts on Spirituality and Eudaimonic Well-Being", *Mental Health, Religion and Culture*, Vol. 9, No. 3, (2006); 227-238

¹⁹⁴David R. Brown dan Mark S. Parrish, "College Student Spirituality: Helping Explore Life's Existential Questions", *Vistas*, (2011).

¹⁹⁵Reuben M. Baron, dan David, A. Kenny, "The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 51, No. 6, (1986); 1173-1182.

¹⁹⁶Lihat lampiran "Analisis Parsial Uji Hipotesa-Pengaruh Spiritualitas terhadap Stres".

spiritualitas didapati dimensi transenden, memberikan sumbangan terbesar dalam proporsi spiritualitas mahasiswa kedokteran dengan nilai koefisien 1.97.¹⁹⁷ Hal ini menjelaskan bahwa keterhubungan dengan Tuhan memberikan sumbangan terbesar pada dimensi spiritualitas dalam menekan kejadian stres di kalangan mahasiswa kedokteran.

Domain transenden bermakna hubungan diri dengan sesuatu atau seseorang di luar batas dimensi manusia. Dalam domain ini melibatkan kepercayaan, penghambaan dan ibadah kepada sumber Ghaib di alam semesta.¹⁹⁸ Namun dalam beberapa pengertian yang ditawarkan, para ahli lainnya menjelaskan bahwa dimensi transenden merupakan perjalanan pencarian makna, dimana pencarian makna bisa dilakukan dengan pencarian Tuhan atau pencarian kekuatan tertinggi lainnya melalui diri sendiri atau puncak realitas atau apapun yang dianggap sebagai puncak tertinggi (supreme).¹⁹⁹

Pada disertasi ini penulis mengkaitkan makna transenden dengan hubungan kepada Tuhan. Sebagaimana McDonald (2000) menyebutkan transenden merupakan konsep yang paling fundamental dari spiritualitas yaitu hubungan manusia dengan penciptanya atau Tuhannya. McDonald mengungkapkan bahwa seseorang ketika menghadapi potensi stresor, pertama ia akan mengerahkan segala sumber daya diri untuk mengatasi hal tersebut. Bersamaan dengan itu ia menyadari bahwa keadaan di luar kemampuan kontrol dirinya, lalu ia menyerahkan hal tersebut kepada Tuhannya. Dalam keadaan seperti ini maka individu tersebut meyakini bahwa hidup dan segala kejadian ia serahkan kepada Tuhannya dan tidak lagi merasa terbebani.²⁰⁰

Makna implisit dari apa yang disampaikan oleh Donald di atas adalah *surrender to God* (berpasrah diri kepada Tuhan). Clements

¹⁹⁷ Lihat lampiran “Analisis Parsial Uji Hipotesa-Pengaruh Spiritualitas terhadap Stres”.

¹⁹⁸ Jhon Fisher, “The Four Domains Model: Connecting Spirituality, Health and Well-Being”, *Religions*, No. 2, (2011); 17-28.

¹⁹⁹ Ahmad Rusydi, *Kecemasan dan Psikoterapi Spiritual Islam: Dari Spiritual Disorder hingga Persoalan Eksistensi Menuju Kesehatan Psiko-Spiritual*, (Jakarta: Disertasi Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 31-32.

²⁰⁰ Ana Wong McDonald dan Richard Gorsuch, “Surrender to God; an Additional Coping Styles?”, *Journal of Psychology and Theology*, Vol. 28, No. 2, (2012); 149-161.

dan Ermakova (2012) dalam penelitian mereka terkait berpasrah kepada Tuhan membuktikan bahwa berpasrah kepada Tuhan berhubungan dengan level stres yang rendah yang kemudian hal ini berpengaruh terhadap kesehatan mental.²⁰¹ Hal ini selaras dengan konsep Islam yang disebut dengan “*tawakkal*”. Tawakkal bermakna percaya dan bersandar diri kepada Allah. Ketika muslim bersandar kepada Allah maka hal ini dapat mengurangi beban stres, cemas, dan kecewa. Karena ia yakin Allah akan menjaga orang yang percaya pada-Nya dan yakin atas janji-Nya. Setelah muslim berpasrah kepada Allah, maka stresnya akan berkurang, susahny menjadi mudah dan rasa takut menjadi rasa aman.²⁰² Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah *Ali Imran* ayat 159:

ط
 .. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

“..Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali ‘Imran: 159).

Sejalan dengan ayat di atas yang mengajarkan muslim untuk bertawakkal, keterhubungan dengan Allah juga menunjukkan kadar keimanan yang kuat. Seseorang yang benar-benar beriman tidak merasa khawatir serta gentar dalam menghadapi bencana dan cobaan. Rasulullah SAW juga mengisyaratkan kondisi orang mukmin, manakala menghadapi kegagalan atau musibah. Sebagaimana disebutkan beliau dalam hadits riwayat Ṭabrānī yang artinya sebagai berikut:

Artinya:

“Tidaklah berkumpul harapan dan kekhawatiran dalam hati seorang mukmin kecuali Allah Yang Maha Perkasa dan Mulia memberinya harapan dan mengamankannya dari kekhawatiran”. (H.R. Ṭabrānī)

²⁰¹ Andrea D. Clements dan Anna V. Ermakova, “Surrender to God and Stress: a Possible Link between Religiosity and Health”, *Psychology of Religion and Spirituality*, Vol. 4, No. 2, (2012); 93-107.

²⁰² Aisha Hamdan, “Cognitive Restructuring: an Islamic Perspective”, *Journal of Muslim Mental Health*, No.3, (2008), 99-116.

Pada domain transenden, *item* spiritualitas yang tertinggi sesuai dengan jawaban responden adalah “*ketika beribadah, saya merasa seperti berkomunikasi dan berhubungan dengan Tuhan*”. Hasil analisis ini mengungkapkan bahwa transedensi yang diajarkan agama adalah meyakini bahwa transedensi tertinggi adalah Tuhan. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Ghazi seorang ahli ilmu al-Qur’an, transedensi merupakan bagian esensi ruhiyah yang dengan-nya individu merasakan kehadiran dan keterhubungan Tuhan.²⁰³ Hasil analisis ini juga selaras dengan teori dasar yang dijelaskan penulis pada bab sebelumnya bahwa dimensi spiritualitas dalam Islam salah satunya harus diimplementasikan dalam bentuk ketaatan beribadah kepada Allah.²⁰⁴ Selanjutnya hasil signifikansi hubungan spiritualitas dan stres pada analisis kuantitatif ini juga selaras dengan pandangan Nurcholish Madjid (1992) yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa ibadah yang dilaksanakan dengan tata laksana yang benar akan menumbuhkan rasa aman dan tentram.²⁰⁵ Sementara individu yang senantiasa dapat merasakan kenyamanan, kebahagiaan, serta ketentraman dan kedamaian dengan problematika hidupnya dapat dikategorikan terbebas dari gangguan psikologis stres.

Namun demikian koneksi antara manusia dan Tuhan harus dilengkapi dengan koneksi dengan lainnya. Pada disertasi ini hasil analisis menunjukkan hasil secara berurut terkait konektifitas tersebut adalah keterhubungan dengan alam (*environmental*), sesama manusia (*communal*) dan diri sendiri (*personal*). Hasil analisis ini juga selaras dengan pernyataan Elmi dan Zainab (2013) yang dikutip penulis pada bab sebelumnya bahwa spiritualitas dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Allah sebagai Tuhan-nya, namun juga hubungan positif dengan dirinya sendiri, orang lain

²⁰³Ghāzī Ṣabḥī, *Al-Qur’an Manhaj al- Hayah*, (al Maktabah al-Shamilah, V. 3.28), 446.

²⁰⁴Yusuf al-Qardhawi, *Retorika Islam*, terj. Abdillah Noor Ridho, (Jakarta: Khalifah, 2004), 93-96.

²⁰⁵Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Tela’ah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderanan*, (Jakarta: Paramadina, 1992), 57.

dan sesama makhluk dengan senantiasa melakukan hal-hal baik dan menghindari kemungkaran “*amr ma‘ruf wa nahy ‘an al-munkar*”.²⁰⁶

Domain spiritualitas *environmental*, menurut Gilbert (2007) disebut dengan istilah aspek keterhubungan diri dengan dunia fisik (*physical world*), dimana dunia fisik ini meliputi daratan, lautan, hewan, tumbuhan dan benda-benda mineral.²⁰⁷ Hubungan manusia dengan alam merupakan domain spiritualitas yang cukup besar urgensitasnya. Keniger et al (2013) dalam riset literatur mereka terkait manfaat interaksi manusia dengan alam, pada aspek kesehatan mental hasil studi literasi mereka menyebutkan bahwa keterhubungan dengan alam secara psikologis dapat meningkatkan konsep diri, meningkatkan *mood*, menekan marah dan frustrasi, menekan kecemasan dan meningkat perilaku positif.²⁰⁸

Mekanisme pengaruh positif unsur alam kepada kesehatan diri seperti penekan stres menurut Mills et al (2008) didapati melalui proses *sensory immersion* (peleburan sensori) yaitu sebuah proses keterhubungan diri dengan alam dengan cara meleburkan semua sensori tubuh untuk merasakan alam. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menciumi bau bunga dan tanaman, mengangguni warna, bentuk dan suara yang terdengar dari alam. *Sensory immersion* dapat menimbulkan pengaruh positif, sensasi bahagia yang mana hal tersebut dapat mengurangi tekanan hidup seseorang.²⁰⁹ Hal ini selaras dengan respon mahasiswa bahwa dalam hubungan dengan alam mereka merasakan keajaiban dan ketakjuban dari alam semesta seperti dengan memperhatikan luasnya langit dan dalamnya lautan.

²⁰⁶Elmi Baharuddin dan Zainab Ismail, “Spiritual Intelligent Relationship of Elderly People with the Religious Practice in the Welfare Home”, *Islamiyyat*, Vol.35, No. 1, (2013); 19-28.

²⁰⁷Peter Gilbert, *The Spiritual Foundation: Awareness for Context People’s Live Today*, (London: Jessica Kingsley Publisher, 2007), 24.

²⁰⁸Lucy E. Keniger and others, “What are the Benefits of Interacting with Nature?”, *Int. J. Environ Res Public Health*, Vol. 10, (2013); 913-935.

²⁰⁹Harry Millis, Natalie Reiss, dan Mark Dombeck, *Environmental, Social and Spiritual Strategies for Stress Relief*, diakses dari <https://www.mentalhelp.net/articles/environmental-social-and-spiritual-strategies-for-stress-relief/> pada tanggal 27 Mei 2017, pukul 11.44 WIB.

Sementara itu dalam konteks ajaran Islam semakin sering seseorang mengamati kejadian alam, maka akan semakin ia mengenal Tuhannya karena alam semesta merupakan tanda dari keberadaan dan kekuasaan Allah.²¹⁰ Ketika individu meyakini bahwa untuk hal sebesar alam semesta Tuhan mampu mengaturnya apalagi insan kecil seperti manusia, sehingga demikian persepsi akan kuasa Tuhan akan mengurangi beban hidup termasuk gangguan psikologis seperti stres.

Domain ketiga dari spiritualitas adalah *communal* (hubungan dengan orang lain) yaitu hubungan antara diri sendiri dengan orang lain yang meliputi perasaan saling sayang dan mencintai, saling menghormati, saling memaafkan, dan saling menolong.²¹¹ Dalam dimensi interaksi *communal* yang lebih dominan dilakukan oleh mahasiswa adalah saling menghormati orang lain meski berbeda pendapat dan mudah memaafkan orang lain.

Menurut Hathout seorang ahli metafisika dari Mesir yang belakangan setelah meninggalnya di tahun 2009 didirikan Yayasan Hassan Hathout yang fokus pada penyebaran nilai-nilai universal dari ajaran Islam, beliau mengatakan memaafkan yang merupakan bagian dari etika berhubungan antar manusia adalah sebuah perintah akan nilai dan bentuk kebajikan. Semakin mudah seseorang memaafkan orang lain akan semakin bahagia dirinya.²¹² Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Oman et al (2008) menjelaskan bahwa dalam *training* manajemen stres yang diberikan pada mahasiswa

²¹⁰Penciptaan alam semesta merupakan tanda dari kebesaran Allah, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 164: "*Seungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, bergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati (kering) dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkiaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti*".

²¹¹Jhon Fisher, "The Four Domains Model: Connecting Spirituality, Health and Well-Being", *Religions*, No. 2, (2011); 17-28.

²¹²Hassan Hathout, *Forgiveness in Islam* diakses dari <http://hhlf.org/Forgiveness%20in%20Islam.pdf> pada tanggal 27 Mei 2017, pukul 13.30 WIB.

didapati bahwa memaafkan orang lain berhasil menekan gangguan psikologis stres.²¹³

Adapun dimensi *personal* merupakan hubungan individu dengan dirinya sendiri seperti makna hidup, tujuan, dan nilai-nilai hidup. Keterhubungan dimensi *personal* dengan stres adalah dengan dimensi ini individu mengetahui tujuan dan makna hidupnya sehingga ia akan melakukan sesuatu yang penting selama hidupnya, dengan makna dan tujuan individu akan mampu menjalani hidup dengan seimbang dan konsisten.²¹⁴ Dengan kata lain ketika seseorang mampu mempertahankan keseimbangan dirinya dengan tuntutan maka ia akan terhindari dari keadaan stres.

3. Tingginya Spiritualitas sebagai Penguat Regulasi Diri Belajar

Geyer dan Baumeister (2005) dalam diskusi literasi mereka terkait religiusitas/spiritualitas dan regulasi diri memetakan skema pembahasan mengapa spiritualitas/religiusitas memiliki potensi positif untuk mendukung proses regulasi diri. Menurut mereka spiritualitas memberikan standar boleh dan tidak kepada individu untuk berperilaku. Dimensi makna diri (*meaning*) yang terkandung dalam spiritualitas memberikan petunjuk diri untuk hanya melakukan yang terbaik dan sampai pada tujuan hidup (*life goal*). Untuk sampai pada tujuan, individu senantiasa harus memiliki proyek pengelolaan diri yang kemudian disebut regulasi diri.²¹⁵

Regulasi diri merupakan usaha individu untuk mengatur atau merubah respon diri khususnya (tapi tidak terbatas) pada situasi tertekan/stres.²¹⁶ Aldwin (2010) mendefinisikan regulasi diri merupakan usaha sadar yang dilakukan individu dalam mengatur dan me-

²¹³Douh Oman and others, "Meditation Lowers Stress and Supports Forgiveness among College Students: a Randomized Controlled Trial", *Journal of American College Health*, Vol. 56, No. 5, (2008).

²¹⁴Van Leeuwen and others, "Aspects of Spirituality Concerning Illness", *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, Vol 21, (2008); 482-489.

²¹⁵Anne L. Geyer dan Roy F. Baumeister, *Religion, Morality and Self Control: Values, Virtues and Vices*, (2005) dalam Earl. D. Bland, "An Appraisal of Psychological and Religious Perspectives of Self Control", *J Relig Health*, Vol. 47, (2008); 4-16.

²¹⁶Nancy Eisenberg dan Qing Zhou, "Regulations from a Developmental Perspective", *Psychological Inquiry*, Vol. 11, No. 3, (2000); 166-171.

ngarahkan tindakan, emosi dan perhatian diri.²¹⁷ Adapun dalam dunia akademik pengkhususan keterlampilan mengolah diri dikenal dengan istilah regulasi diri belajar.

Regulasi diri belajar adalah kemampuan siswa untuk mengelola secara efektif pembelajaran sendiri, menumbuhkan motivasi diri, dan mengembangkan kepercayaan diri serta memilih atau mengatur sendiri lingkungan belajarnya baik fisik dan nonfisik.²¹⁸ Regulasi diri belajar merupakan salah satu bentuk skil non-kognitif yang dalam beberapa riset skil ini berhubungan positif dengan efikasi diri atau keyakinan diri (*belief*).²¹⁹ Ketika ada keyakinan diri maka diasumsikan bahwa regulasi diri akan berhubungan dengan spiritualitas, hal ini yang kemudian dibuktikan pada hasil analisis bahwa spiritualitas dan regulasi diri belajar berhubungan positif signifikan, sebagaimana dikutip pada tabel 3.26 di atas. Hasil analisis struktural menyebutkan hubungan positif signifikan antara spiritualitas dan regulasi diri belajar dengan nilai koefisien dan $t=$ value sebesar 0.51 ($t= 6.09 > 1.96$).

Tabel 3.26. menjelaskan koefisien jalur bertanda positif memiliki makna bahwa spiritualitas cenderung meningkatkan potensi regulasi diri belajar. Selanjutnya nilai thitung yang lebih besar dari tkritis menunjukkan bahwa pada tingkat kepercayaan 99% dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel spiritualitas terhadap regulasi diri belajar. Dari keempat dimensi spiritualitas didapati dimensi transendensi memberikan sumbangan terbesar dalam proporsi spiritualitas mahasiswa kedokteran terhadap peningkatan regulasi diri belajar.

Percaya kepada Tuhan dan merasa keterhubungan dengannya memberikan konsekuensi psikologis, individu yang percaya bahwa

²¹⁷Carolyn Aldwin, Crystal Park, Yu-Jin Jeong dan Tiwik Nath, "Differing Pathways Between Religiousness, Spirituality, and Health: a Self Regulation Perspective", *Psychology of Religion and Spirituality*, Vol. 6, No. 1, (2014), 9-21.

²¹⁸Nym. Doni Pramana, AA. Gede Agung dan Ni N. Madri Antari, "Pengaruh Model Pembelajaran *Self Regulated Learning* (SRL) terhadap Sikap Spiritual dan Hasil Belajar PPKn", *E-Journal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3, No.1, (2015).

²¹⁹Jefry A. Rosen and others, *Noncognitive Skill in the Classroom: New Perspectives on Educational Research*, (USA: RTI Press, 2010), 73.

dia memiliki keterbatasan kemampuan dan Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu akan membuat individu tersebut merasa relaks dan optimis. Dari sifat optimis inilah kemudian akan muncul keyakinan (*belief*). *Belief* merupakan inti dari spiritualitas, dari keyakinan inilah akan muncul motivasi dan kreatifitas untuk mengatasi permasalahan hidup.²²⁰ Sementara menurut Koole et al (2010) keyakinan dan keterhubungan dengan Tuhan akan membuat individu mampu mengontrol dan meregulasi diri dengan baik.²²¹

Menurut Carter et al (2012) regulasi sebagai *feedback* dari tingkah laku dan bentuk respon penyesuaian diri terhadap keadaan setidaknya harus memiliki tiga elemen yaitu: (1) tujuan, (2) pengawasan (*monitoring*), dan (3) hasil. Pada aspek pengawasan bermakna pengawasan diri sendiri (*self monitoring*) dan pengawasan orang lain (*monitored by others*).²²² Selanjutnya melalui mekanisme pengawasan inilah spiritualitas dapat memengaruhi regulasi diri.²²³ Briki (2014) mengaitkan konsep *monitoring by others* ini dalam konsep Islam adalah perasaan di bawah pengawasan Allah SWT yakni konsep “*muraqabah*”. Individu yang yakin bahwa Allah mengawasi segala tingkah lakunya maka ia akan senantiasa berperilaku sesuai dengan norma agama dan standar sosial masyarakat.

Hasil analisis juga menjelaskan bahwa spiritualitas memberikan pengaruh positif signifikan terhadap tiga dimensi regulasi diri. *Pertama*, spiritualitas berhubungan positif dengan motivasi, diantara

²²⁰Harold G. Koening dan S. Al- Shohaib, *Health and Well-Being in Islamic Societies: Background, Research, and Applications*, (Switzerland: Springer International Publishing, 2014), 29.

²²¹Sander L. Koole, and others, “Why Religion’s Burdens Are Light: From Religiosity to Implicit Self Regulation, *Personality and Social psychology Review*, Vol 14, No. 1, (2010): 95-107.

²²²Pengawasan dikonseptualisasikan sebagai sebuah keadaan dari kesadaran diri tentang bagaimana seseorang ketika ia berperilaku harus sesuai dengan nilai norma dan standar. Lih Evan C. Carter, Michael E. McCullough dan Charles S. Carver, “The Mediating Role of Monitoring in the Association of Religion with Self-Control”, *Social and Psychological and Personality Science*, Vol. 3, No. 6, (2012); 691-697.

²²³Michael E. McCullough and Brian L.B. Willoughby, “Religion, Self-Regulation, and Self Control. Associations, Explanations, and Implications”, *Psychological Bulletin*, Vol. 135, No. 1, (2009): 69-93.

item terpenting pada dimensi motivasi adalah orientasi tujuan (*goal orientation*) dan pencapaian tujuan (*goal accomplishment*). Seseorang yang memiliki tingkat spiritualitas yang baik tentu akan memiliki tujuan hidup dan secara bersamaan akan muncul regulasi diri yang baik untuk sampai pada tujuan (*goal accomplishment*).²²⁴ Dimana Wenger (2007) menyebutkan seseorang dengan tingkat keimanan dan spiritualitas yang tinggi akan memiliki usaha yang jelas dan terencana untuk sampai ke tujuan dibandingkan kelompok yang kurang keimannya.²²⁵

Kedua, spiritualitas berhubungan positif signifikan dengan aspek kognisi. James dan Wells (2003) menjelaskan spiritualitas dan religiusitas dapat memengaruhi proses kognisi (berpikir) yang kemudian dapat meningkatkan proses perhatian (*attention*) dan berpikir kritis (*critical thinking*) individu terhadap keadaan yang sedang dihadapi.²²⁶ Berpikir kritis meliputi kemampuan untuk melakukan interpretasi, analisis, evaluasi, menarik kesimpulan dan menjelaskan. Menurut Jafari (2014) spiritualitas menuntut kemampuan untuk berpikir termasuk berpikir kritis, seseorang yang memiliki tingkat kritis berpikir yang tinggi tidak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain termasuk orang yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi tidak akan mudah dipengaruhi pandangan-pandangan doktrin kepercayaan yang tidak logis. Sehingga demikian dapat dipahami bahwa antara spiritualitas dan kognitif memiliki hubungan yang saling terkait.²²⁷

Ketiga, spiritualitas berhubungan positif dengan aspek perilaku yakni ketika spiritualitas dapat membantu individu dalam proses penetapan tujuan, selanjutnya dari tujuan tersebut individu

²²⁴Walid Briki, "Involvement in Religion and Self-Regulations: Explanations of Muslims' Affects and Behaviors during Ramadan", (USA: OMICS Group e-Book, 2014), 7.

²²⁵Jay L. Wenger, "The Implicit Nature of Intrinsic Religious Pursuit", *International Journal for The Psychology of Religion*, Vol. 17, No. 1, (2007), 47-60.

²²⁶Abigail James dan Adrian Wells, "Religion and Mental health: Towards a Cognitive-Behavioural Framework", *British Journal of Health Psychology*, Vol.8, (2003); 359-376.

²²⁷Forough Jafari, "Comparison of Relation between Critical Thinking and Spiritual Intelligent in Iranian Male and Female", *The International Journal of Humanities & Social Studies*, Vol. 2, No. 11, (2014); 127-134.

akan mewujudkannya melalui tindakan yang efektif.²²⁸ Individu dengan tingkat spiritualitas yang tinggi akan melakukan sesuatu secara penuh kesadaran, terencana dan penuh usaha. Dalam konteks regulasi diri tingkah laku juga harus dilakukan dengan penuh kesadaran pada tahap ini dapat dipahami bahwa ada hubungan keterkaitan antara spiritualitas dan regulasi diri.

Melalui tiga aspek regulasi diri belajar yang kesemuannya dalam analisis kuantitatif terbukti signifikan dipengaruhi oleh spiritualitas, maka menurut penulis hasil analisis kuantitatif pada bab ini selaras dengan landasan teori regulasi diri yang dikemukakan oleh Koole et al (2010) sebagaimana penulis telah kutipkan pada bab sebelumnya, yakni regulasi diri akan meningkat ketika individu mampu menginternalisasikan keimanan/spiritualitas pada dirinya dan akan berusaha keras untuk sampai pada tujuannya, secara implisit individu yang merasakan keterhubungan akan Tuhan senantiasa akan mampu mengontrol dan meregulasi dirinya secara baik.²²⁹ Begitupula Regulasi diri yang terhubung dengan spiritualitas akan memunculkan keberanian untuk berkeinginan besar dan keyakinan diri serta kemantapan berusaha dan optimis dalam diri.²³⁰

4. Rendahnya Regulasi Diri Belajar sebagai Penguat Stres

Beberapa riset menjelaskan bahwa regulasi diri belajar tidak hanya memediasi proses belajar tapi berhubungan juga dengan hasil belajar. Menurut Susanto (2013) hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga demikian regulasi diri belajar dapat dijadikan sebagai sebuah variabel *independent* atau pun

²²⁸Michael E. McCullough dan Evan C. Carter, "Religion, Self-Control and Self-Regulation: How and Why Are They Related", dalam *Handbook of Psychology, Religion, and Spirituality*, Vol 1, (2013), 130.

²²⁹Sander L. Koole, and others, "Why Religion's Burdens Are Light: From Religiosity to Implicit Self Regulation, *Personality and Social Psychology Review*, Vol 14, No. 1, (2010); 95-107.

²³⁰Aftina Nurul Husna, Frieda N.R.. Hidayati, dan Jati Ariati. "Regulasi Diri Mahasiswa Berprestasi", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 13, No. 1, (2014); 50-63.

variabel *dependent*.²³¹ Jika pada sub bab terdahulu penulis mendeskripsikan hasil analisis regulasi diri sebagai variabel yang dipengaruhi oleh spiritualitas pada sub bab ini regulasi diri diposisikan sebagai variabel yang memengaruhi.

Sebagaimana beberapa riset menjelaskan hubungan regulasi diri belajar dengan hasil studi seperti prestasi, motivasi dan efikasi diri.²³² Regulasi diri juga berhubungan dengan kesehatan psikologis. Trevisani (2015) secara bersama menguji hubungan regulasi diri belajar, stres dan *mindfulness* di kalangan mahasiswa perguruan tinggi strata satu. Hasil studi menjelaskan *mindfulness* berhubungan positif dengan regulasi diri belajar dan regulasi diri belajar berhubungan negatif dengan stres mahasiswa.²³³ Hasil studi tersebut selaras dengan hasil analisis jalur pada penelitian ini yang membuktikan bahwa regulasi diri belajar berhubungan negatif signifikan dengan stres. Gambar 3.5 dan 3.6 sebagaimana diilustrasikan di atas menegaskan temuan ini, dimana regulasi diri belajar memiliki hubungan negatif signifikan dengan stres dengan nilai koefisien -0.24 dan *t-value* (-3.13 > 1.96).

Begitupula tabel 3.29 di atas menjelaskan koefisien jalur bertanda negatif memiliki makna bahwa regulasi diri belajar cenderung menekan potensi stres. Selanjutnya nilai *t*-hitung yang lebih besar dari *t*-kritis menunjukkan bahwa pada tingkat kepercayaan 99% dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel regulasi diri belajar terhadap stres. Hasil ini memberi makna bahwa semakin tinggi regulasi diri maka akan semakin rendah tingkat stres yang dirasakan. Adapun regulasi diri kognisi memberikan sumbangan terbesar dalam proporsi regulasi diri yang memengaruhi stres.

Menurut Aldwin (2010) regulasi diri kognisi termasuk salah satu bentuk regulasi emosi (*emotional self regulated*) dan bentuk

²³¹Kyong-Jee Kim dan Hye W.Jang, "Changes in Medical Students' Motivation and Self-Regulated Learning; a Preliminary Study", *International Journal of Medical Education*, Vol.6, (2015): 213-215.

²³²Zahra Jouhari, Fariba Haghani dan Tahereh Chagiz, "Assessment of Medical Students' Learning and Study Strategies in Self-Regulated Learning", *Journal of Advances in Medical Education & Professionalism*, Vol. 4, No. 2, (2016); 72-79.

²³³Cassandra Trevisani, "A Correlational Study of Self Regulated Learning, Stress and Mindfulness in Undergraduate Students", *Honours Thesis*, (2015), 2.

kedua regulasi diri adalah regulasi tindakan diri (*behavioral self-regulated*). Menurutnya ketika regulasi diri dikhususkan sebagai sebuah cara untuk menghadapi keadaan yang tertentu yang dianggap menekan, maka hal ini dapat dikatakan bahwa regulasi diri tersebut sebagai bentuk *coping*.²³⁴ Strategi koping pada konteks psikologi pendidikan lebih cenderung berhubungan dengan stres. Hubungan dimensi regulasi diri kognisi dan stres dapat dipahami dengan mekanisme persepsi. Stresor yang sama dan dalam waktu yang bersamaan bisa saja dipersepsikan berbeda oleh mahasiswa. Sehingga demikian ketika individu mahasiswa memiliki regulasi diri kognisi dan emosi yang tinggi maka persepsi sebuah keadaan dan kenyataan dianggap sebagai sesuatu yang menekan akan semakin kecil.

Hasil analisis kuantitatif pada tabel 3.29 di atas juga menjelaskan bahwa aspek stres yang paling dominan dipengaruhi oleh regulasi diri adalah aspek *unpredicted* (2.12*)²³⁵, sementara item yang paling dominan terkait indikasi stres yang dialami mahasiswa adalah tidak percaya diri. Tidak percaya diri dalam kajian psikologi dihubungkan dengan konsep efikasi diri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa regulasi diri belajar dapat menekan rasa ketidakpercayaan diri mahasiswa, dalam eksplanasi terbalik regulasi diri belajar dapat menekan stres dengan meningkatkan rasa kepercayaan diri atau efikasi diri.

Menurut analisa penulis hasil analisis kuantitatif ini sejalan dengan pandangan Schunk (2005) yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya bahwa pengaruh regulasi diri belajar terhadap stres dapat dipahami melalui mekanisme regulasi motivasi yang salah satu item di dalamnya adalah efikasi diri (*self efficacy*). Efikasi diri merupakan salah satu faktor penting dalam regulasi diri belajar, mahasiswa yang meyakini kemampuan diri untuk dapat menjalani proses belajar meski sulit sekalipun, akan memiliki regulasi diri yang lebih baik dan akan mampu bertahan dalam proses akademik yang berlangsung.²³⁶ Semen-

²³⁴Carolyn M. Aldwin and others, "Coping and Self-Regulation Across the Life Span", *Handbok of Life Span Development*, (John Wiley and Sons, Inc, 2014), 563-564.

²³⁵Lihat lampiran "Analisis Hasil Uji Hipotesis - Pengaruh Regulasi Diri Belajar terhadap Stres".

²³⁶Dale H. Schunk "Self Regulated learning: the Educational Legacy of Paul R. Pintrich", *Educational Psychologist*, Vol. 40, (2005), 85-94

tara untuk terhindar dari stres karena paparan berbagai stresor maka efikasi diri menjadi salah satu sumber psikologis yang dapat mempertahankan diri dari stres.²³⁷

5. Regulasi Diri Belajar sebagai Penguat Fungsi Positif Spiritualitas

Spiritualitas memainkan peran penting dalam kehidupan, hal ini dapat dibuktikan ketika beberapa riset yang dilakukan menjelaskan terdapat hubungan positif antara spiritualitas dengan psikologis positif termasuk pula berhubungan negatif dengan beberapa bentuk psikologis negatif seperti stres dan depresi. Aldwin (2010) menjelaskan fungsi psikologis manusia seperti spiritualitas memiliki pengaruh atas kesehatan dengan dua cara: perilaku sehat dan pengaruh psikologis secara langsung. Pada studinya lebih lanjut Aldwin menggunakan konsep regulasi diri sebagai bentuk perilaku sehat yang dapat memediasi pengaruh positif spiritualitas terhadap kesehatan penderita diabetes dan kanker.²³⁸

Model yang digunakan oleh Aldwin di atas sejatinya menjelaskan bahwa pada penelitian psikologi kesehatan seringkali keterkaitan antara dua fenomena tidak hadir dalam bentuk langsung karena terkadang ketertarikan tersebut diperantarai oleh fenomena lainnya. Terutama khususnya hubungan antara anteseden (stimulus) dan respons yang muncul selalu diperantarai oleh variabel organismik yang berfungsi sebagai perantara.²³⁹ Selanjutnya dengan menggunakan pola atau model penelitian mediasi, penelitian disertasi ini selain mengungkap hubungan langsung spiritualitas dengan stres, namun juga menjelaskan bahwa fungsi psikologis tersebut dimediasi oleh kemampuan mahasiswa meregulasi diri belajar mereka. Gambar 3.5

²³⁷Christopher J. McCarthy and others, "Psychological Resources as Stress Buffers: Their Relationship to University Students's Anxiety and Depression", *Journal of College Counseling*, Vol. 9, (2006): 99-112.

²³⁸Carolyn Aldwin, Crystal Park, Yu-Jin Jeong dan Tiwik Nath, "Differing Pathways Between Religiousness, Spirituality, and Health: a Self Regulation Perspective", *Psychology of Religion and Spirituality*, Vol. 6, No. 1, (2014), 9-21.

²³⁹Siti Urbayatun dan Wahyu Widiarso, "Variabel Mediator dan Moderator dalam Penelitian Psikologi Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Psikologi*, Vol. 39, No. 2, (2012); 180-188.

dan 3.6 di atas memberikan ilustrasi hasil analisis pengaruh spiritualitas terhadap stres dengan variabel mediator regulasi diri.

Pada diagram lintasan pada gambar 3.6 di atas bisa dilihat bahwa estimasi koefisien model struktural dari mediasi regulasi diri belajar terhadap hubungan spiritualitas dan stres mengindikasikan adanya hubungan negatif signifikan. Hal ini dapat dipahami bahwa spiritualitas dapat menekan tingkat stres melalui perantara regulasi diri yang baik.

Tabel 3.26 di atas menjelaskan beberapa hasil analisis yang menegaskan bahwa regulasi diri belajar merupakan variabel mediasi dalam hubungan kausal. Spiritualitas memiliki pengaruh langsung yang lebih kecil terhadap stres dibandingkan regulasi diri sebagai variabel mediator ($-0.47 < -3.13$). Sebagaimana Widhiarso (2010) menyebutkan pengaruh *independent variable* (IV) atas *dependent variable* (DV) diharapkan lebih kecil dari pengaruh *mediator* (M) terhadap DV.

Tabel 3.29 di atas juga menjelaskan signifikansi regulasi diri belajar sebagai mediator dengan dibuktikan perubahan nilai *t-value* pengaruh langsung spiritualitas terhadap stres setelah dimediasi, yang awalnya adalah signifikan sebesar ($t = -2.95 > -1.96$) menjadi tidak signifikan ($t = -0.47 < -1.96$). Hal ini selaras dengan apa yang digariskan oleh Baron dan Kenny (1986) yang menjelaskan bahwa jalur hubungan langsung *independent variable* (IV) terhadap *dependent variable* (DV) tidak lagi signifikan ketika dimediasi oleh *variable mediator* (M).²⁴⁰

Adapun analisis terakhir yang menegaskan peran regulasi diri belajar sebagai mediator efektif adalah nilai koefisien dan *t-values* pada hubungan tidak langsung yang lebih besar dan signifikan dibandingkan hubungan langsung yakni -0.12 ($t = -2.96$) > -0.04 ($t = -0.47$). Hal ini memenuhi syarat bahwa porsi jalur peranan tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan peranan secara langsung. Selain itu

²⁴⁰Reuben M. Baron, dan David, A. Kenny, "The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 51, No. 6, (1986); 1173-1182.

peranan tidak langsung tersebut diharapkan signifikan secara statistik (koefisien=-0.16 dan $t=-2.56$).²⁴¹

Menurut Aldwin (2010) terjadi *overlapping* antara konsep coping dan regulasi diri. Ketika suatu studi hanya terfokus pada kemampuan individu dalam mengatur dan mengarahkan tindakan, emosi dan perilaku secara umum maka hal ini menjadi riset regulasi diri. Namun ketika usaha untuk mengubah kognisi, emosi dan perilaku dikhususkan sebagai strategi dalam menghadapi keadaan yang menekan, maka hal ini dapat disebut coping.²⁴² Memposisikan regulasi diri sebagai salah satu bentuk coping dikarenakan regulasi diri merupakan salah satu bentuk penguasaan diri (*self mastery*), yakni kemampuan individu untuk menguasai kejadian dalam hidupnya, dimana kemampuan ini dapat meniadakan efek stres dari berbagai kejadian harian yang menekan (*daily stressful events*).

Posisi regulasi diri sebagai variabel mediator terbukti sangat efektif sebagaimana studi Ning dan Downing (2012) menjelaskan regulasi diri belajar terbukti signifikan memediasi antara perilaku belajar dan prestasi akademik.²⁴³ Begitupula Desmond et al (2013) mengungkapkan bahwa regulasi diri secara signifikan memediasi hubungan negatif antara religiusitas dan perilaku minum-minum dan merokok di kalangan para remaja.²⁴⁴

Fungsi mediasi regulasi terhadap kausalitas spiritualitas dan stres menurut Khadivi et (2012) berdasarkan hasil riset mereka adalah melalui mekanisme efikasi diri (*self efficacy*), dimana spiritualitas memengaruhi secara positif signifikan efikasi diri, selanjutnya seseorang dengan efikasi diri yang baik akan memiliki segi positif dalam

²⁴¹Siti Urbayatun dan Wahyu Widiarso, "Variabel Mediator dan Moderator dalam Penelitian Psikologi Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Psikologi*, Vol. 39, No. 2, (2012): 180-188.

²⁴²Carolyn M. Aldwin and others, "Coping and Self-Regulation Across the Life Span", *Handbok of Life Span Development*, (John Wiley and Sons, Inc, 2014), 563-564.

²⁴³Hoin Kwang Ning dan Kevin Downing, "Influences of Students Learning Experience on Academic Performance: the Mediator and Moderator Effects of Self Regulation and Motivation", *British Educational Research Journal*, Vol. 38, No. 2, (2012); 219-237.

²⁴⁴Scott A. Desmond, Jeffery T. Ulmer dan Christopher D. Bader, "Religion, Self Control, and Substance Use", *Deviant Behavior*, Vol. 34, No. 5, (2013); 384-406.

hubungan dengan orang lain, sebaliknya individu dengan efikasi diri yang rendah akan lebih tertutup dalam kehidupan dan cenderung takut untuk berhubungan dengan orang lain.²⁴⁵ Dalam proses regulasi diri belajar efikasi diri yang baik akan membuat mahasiswa mampu bertahan dalam sulitnya materi akademik.²⁴⁶ Sementara untuk terhindar dari stres karena berbagai stresor akademik yang dihadapi mahasiswa, efikasi diri juga menjadi salah satu sumber psikologis yang dapat mempertahankan diri dari stres.²⁴⁷

Hasil analisis kuantitatif yang menunjukkan fungsi mediator regulasi diri belajar signifikan memengaruhi spiritualitas dalam menekan stres adalah selaras dengan mekanisme pengaruh tidak langsung spiritualitas yang dikemukakan oleh Nelson (2009) dengan teorinya “*indirect effect*” yang telah dikutip penulis pada bab sebelumnya, menjelaskan bahwa dalam hubungan tidak langsung terhadap stres, spiritualitas terlebih dahulu meningkatkan kemampuan strategi koping yang kemudian secara berkelanjutan melalui koping stres tersebut tingkat stres dapat ditekan.²⁴⁸ Hasil analisis kuantitatif ini juga menegaskan bahwa pola dan model koping spiritualitas dan regulasi secara holistik yang ditawarkan pada penelitian ini terbukti dapat menekan pengaruh stresor terhadap tingkat stres yang lebih tinggi.

Pada akhirnya, secara ringkas uraian hasil uji hipotesa dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.27 di bawah ini:

²⁴⁵Asodalah Khadivi, Yusef Adib dan farnaz Farhangpour, “Relationship between Spiritual Intelligence and Self-Esteem with Students’ Educational Improvement”, *European Journal of Experimental Biology*, Vol. 2, No. 6, (2012); 2408-2414.

²⁴⁶Dale H. Schunk “Self Regulated learning: the Educational Legacy of Paul R. Pintrich”, *Educational Psychologist*, Vol. 40, (2005), 85-94.

²⁴⁷Christopher J. McCarthy and others, “Psychological Resources as Stress Buffers: Their Relationship to University Students’s Anxiety and Depression”, *Journal of College Counseling*, Vo. 9, (2006): 99-112.

²⁴⁸James M. Nelson, *Psychology, Religion, and Spirituality*, (New York: Springer, 2009), 311.

Tabel 3.27. Hasil Uji Signifikansi Hipotesa²⁴⁹

No	Hubungan/Pengaruh Antar Variabel Laten	Nilai t-hitung	Koefisien Standar	Kesimpulan Hasil Uji Signifikansi Hipotesa
1	H1: adanya pengaruh stresor terhadap stres	7.38	0.42	H1 diterima, nilai $t > 1.96$, ada pengaruh positif antara stresor dan stres.
2	H1: adanya pengaruh spiritualitas terhadap stres	-2.95	-0.20	H2 diterima, nilai $t > -1.96$, ada pengaruh negatif antara spiritualitas terhadap stres.
3	H3: Adanya pengaruh spiritualitas terhadap regulasi diri belajar	6.09	0.51	H3 diterima, nilai $t > 1.96$, ada pengaruh positif antara spiritualitas terhadap stres.
4	H4: Adanya pengaruh regulasi diri belajar terhadap stres	-3.13	-0.24	H4 diterima, nilai $t > -1.96$, ada pengaruh negatif antara regulasi diri belajar terhadap stres.
5	H5: Adanya pengaruh mediasi regulasi belajar terhadap hubungan antara spiritualitas dan stres	-2.96	-0.12	H5 diterima, nilai $t > -1.96$, ada pengaruh mediasi negatif regulasi diri belajar terhadap kausalitas antara spiritualitas dan stres

Dari hasil pengujian hipotesis sebagaimana yang dijabarkan pada tabel di atas menutup pembahasan Bab 3 ini, ada beberapa kesimpulan yang disampaikan penulis berdasarkan hasil temuan data penelitian kuantitatif. *Pertama*, stresor dapat memengaruhi stres. Prediksi nilai positif yang diperoleh mengindikasikan bahwa hubungan stresor terhadap stres adalah positif, artinya bahwa semakin tinggi stresor yang dirasakan akan semakin tinggi stres. *Kedua*, spiri-

²⁴⁹Hasil pengujian hipotesis dilihat dari hasil uji model struktural penelitian berdasarkan t-hitung untuk uji hipotesa dan berdasarkan nilai koefisien standar untuk melihat besar kecilnya pengaruh antara variabel laten penelitian pada hipotesa.

tualitas dapat memengaruhi stres. Prediksi nilai negatif yang diperoleh mengindikasikan hubungan terbalik antara spiritualitas dan stres, artinya semakin tinggi spiritualitas mahasiswa maka akan semakin rendah tingkat stres yang mereka rasakan.

Ketiga, spiritualitas dapat memengaruhi regulasi diri belajar. Prediksi nilai positif yang diperoleh mengindikasikan bahwa semakin tinggi spiritualitas yang dimiliki oleh mahasiswa hal ini akan diikuti dengan semakin meningkatnya kemampuan regulasi diri belajar mereka. *Kempat*, regulasi diri belajar terbukti signifikan memengaruhi tingkat stres. Prediksi nilai negatif yang diperoleh mengindikasikan hubungan terbalik antara regulasi diri belajar dan stres, artinya semakin tinggi kemampuan regulasi diri belajar pada mahasiswa maka tingkat stres yang dirasakan akan semakin rendah. *Kelima*, regulasi diri belajar terbukti signifikan memediasi hubungan kausalitas antara spiritualitas dan stres, prediksi nilai negatif mengindikasikan mediasi yang terjadi adalah sebab akibat yang linier, artinya spiritualitas memengaruhi stres secara tidak langsung, karena harus melewati regulasi diri belajar sebagai mediator.





BAB IV

SPIRITUALITAS DAN REGULASI DIRI BELAJAR DALAM MEKANISME KOPING STRES

Bab keempat ini merupakan hasil analisis pendekatan kedua pada penelitian ini yakni kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk memperkuat analisis yang telah didapatkan, diperlukan untuk memperbaiki, memperluas atau menjelaskan gambaran umum dari hasil analisis kuantitatif yang terdahulu. Sehingga pembahasan pada bab ini terfokus pada analisis data kualitatif yang didapati penulis melalui metode wawancara. Dari sejumlah 378 responden yang terlibat pada pengisian data melalui kuesioner, pada tahap kedua ini hanya melibatkan sejumlah sembilan orang mahasiswa yang dianggap representatif dan menjadi sampel secara *purposive*. Proses wawancara berlangsung dari tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan 20 Februari 2017.

A. Mekanisme Kejadian Stres

Meskipun setiap tahun para peminat pendidikan dokter semakin meningkat, namun dinamika sistem pendidikan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dengan metode pembelajaran CBL (*concept based learning*) dan PBL (*problem based learning*) yang diterapkan di Fakultas kedokteran dapat memberikan tekanan dan tuntutan yang tidak menutup kemungkinan dapat memicu terjadinya stres.¹

¹Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menuntut mahasiswa untuk berperan aktif dalam proses belajar. Pada kurikulum ini metode pembelajaran yang diterapkan adalah *Concept Based learning* (CBL) dan *Problem Based Learning* (PBL). CBL merupakan proses pembelajaran yang ditujukan mahasiswa dapat memiliki kemampuan untuk menjelaskan konsep-konsep yang harus dipelajari. Sementara PBL merupakan pelaksanaan proses pembelajaran berdasarkan problem klinik yang ada sampai mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengkonsep penatalaksanaan problem klinik yang

Pada hakikatnya stres merupakan kejadian umum yang biasa terjadi, bahkan Kupriyanov dan Zhdanov (2014) menyatakan bahwa stres yang ada saat ini adalah sebuah atribut kehidupan modern.² Hal ini dikarenakan stres sudah menjadi bagian yang tidak bisa dielakkan, demikian pula tuntutan kehidupan akademik pada mahasiswa sebagaimana di atas merupakan bagian stres yang biasa dialami mahasiswa yang secara khusus selanjutnya disebut dengan istilah stres akademik. Stres akademik merupakan interaksi individu dengan lingkungan pendidikan yang memunculkan ketegangan emosional, perasaan terancam dan tidak nyaman sehingga memunculkan reaksi-reaksi fisik, psikologis, dan tingkah laku.³

Reaksi dalam mengelola stres oleh masing-masing mahasiswa berbeda-beda tergantung faktor pencetusnya. Beban yang dirasakan individu sehingga menimbulkan stres disebut dengan stresor.⁴ Jadi secara kausalitas stres muncul sebagai respon individu terhadap stresor yang dipandang menyebabkan cekaman, gangguan keseimbangan baik internal maupun eksternal.⁵ Sebagaimana hasil analisis kuantitatif pada bab terdahulu menjelaskan tinggi rendah stres dipengaruhi oleh sumber stres (stresor) yang mencetus persepsi negatif pada mahasiswa.

Popa et al (2014) menjelaskan tingkat persepsi (subjektif) terhadap ketegangan situasi menjadi prediktor tingkat stres yang lebih menentukan dibandingkan mengukur situasi itu sendiri (objektif).⁶ Hal ini dipahami bahwa situasi yang terjadi sifatnya objektif, akan tetapi reaksi terhadap situasi tersebut sifatnya subjektif. Dalam kon-

dihadapi. Lih Dika Christyanti, Dewi Mustami'ah dan Wiwik Sulistiani, "Hubungan antara Penyesuaian Diri terhadap Tuntutan Akademik dengan Kecenderungan Stres pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya", *INSAN*, Vol. 12, No. 03, (2010): 153-159.

²Roman Kupriyanov and Renald Zhdanov, "The Eustress Concept: Problems and Outlooks", *World Journal of medical Sciences*, Vol. 11, No. 2, (2014); 179-185.

³Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 36.

⁴Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, (Bandung: Tonis, 1982), 286.

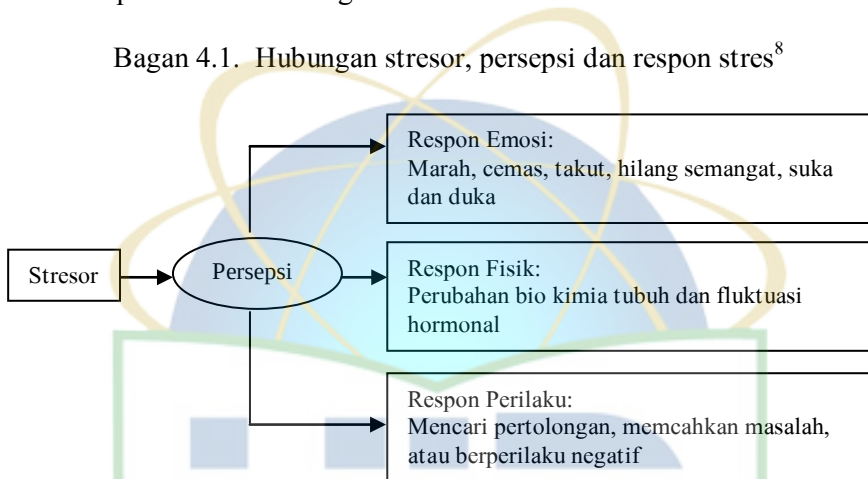
⁵Arlina Gunarya, "Manajemen Stres", *Modul MD08 TOT Basic Study Skills Angkatan ke V dan VI*, (2008), 3.

⁶Bogdan Popa, Laurent Guillet, dan Etienne Mullet, "Cultural Differences in the Appraisal of Stress", *Psicologica*, Vol. 35, (2014); 745-760.

teks akademik mahasiswa yang mengalami tekanan stres karena mempersepsikan proses belajarnya di perguruan tinggi sebagai stresor yang mengancam keseimbangan homeostasis.⁷

Sehingga demikian dapat dipahami untuk mengukur stres maka persepsi individu menjadi faktor penentu dan perbedaan persepsi dapat mengakibatkan respon stres yang berbeda meskipun stresor yang dijumpai bisa jadi adalah sama. Lebih lanjut Yusuf dan Nurihsan (2009) menggambarkan hubungan antara stresor, persepsi dan respon stres dalam bagan berikut:

Bagan 4.1. Hubungan stresor, persepsi dan respon stres⁸



Bagan di atas mendeskripsikan model stres yang terjadi adalah model stres transaksional. Stres pada model transaksional berfokus pada respon emosi dan proses kognitif yang mana didasarkan pada penilaian individu terhadap stresor yang kemudian akan menentukan respon individu tersebut. Ketika individu menjumpai situasi ia

⁷Ira Suwartika, Agus Nurdin dan Edi Ruhmadi, "Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Stress Akademik Mahasiswa Regular Program Studi D III Keperawatan Cirebon Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya", *Jurnal Keperawatan Soedirman*, Vol. 9, N0. 3, (2014); 173-189.

⁸Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihasan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Rosdakarya, 2009), 254.

akan melakukan tindakan penilaian (*appraisal*) dan penanggulangan (*coping*).⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Subjek A mengenai persepsinya terkait stresor akademik dalam perkuliahan. Dirinya menjelaskan pola pembelajaran di perguruan tinggi khususnya pada pendidikan dokter ini sangat berbeda dengan kebiasaan belajar di masa SMU di mana biasanya guru yang banyak menyampaikan informasi, namun pada pembelajaran sistem PBL yang diterapkan di Fakultas kedokteran menuntut dirinya untuk banyak belajar secara mandiri dan harus menyelesaikan beberapa tugas tepat waktu. Namun seiring dengan tuntutan tersebut seringkali Subjek merasakan ketakutan setiap mendapatkan tugas baru dikarenakan di waktu yang bersamaan tugas pada materi perkuliahan lain juga harus diselesaikan. Subjek juga seringkali merasa bingung memilih prioritas materi apa saja yang harus dipelajari terlebih dahulu. Bahkan terkadang menghadapi tugas yang berturut-turut dirinya merasakan sedikit penyesalan mengapa harus mengambil bidang keilmuan ini.¹⁰

Namun demikian hasil wawancara terkait persepsi sumber stres akademik ditanggapi berbeda oleh Subjek B. Subjek B menjelaskan pola pembelajaran dengan sistem PBL justru memberikan kesempatan untuk lebih banyak membaca dan berdiskusi dengan teman-teman dan Subjek merasakan nyaman-nyaman saja terlebih lagi perubahan yang ada hanya pada cara belajar, adapun konten materi menurut Subjek B dirasakan tidak terlalu sulit karena ada beberapa materi yang masih terkait dengan materi dulu di waktu SMU. Subjek tidak merasakan perubahan yang berarti terkait perkuliahannya.¹¹

Hasil wawancara pada dua Subjek di atas menjelaskan bahwa keduanya memiliki persepsi atau penilaian (*appraisal*) yang berbeda meskipun keduanya dihadapi dengan situasi yang sama. Pada Subjek B sumber stres ditanggapi sebagai tantangan dan keyakinan dirinya

⁹Nasib Tua Lumban Gaol, "Teori Stres: Stimulus, Respons, dan Transaksional", *Buletin Psikologi*, Vol. 24, No. 1, (2016); 1-11.

¹⁰Wawancara dengan Subjek A (mahasiswa tahun pertama dengan tingkat stres tinggi), pada hari Senin, Tanggal 6 Februari 2017, Pukul 09.30 WIB.

¹¹Wawancara dengan Subjek B (mahasiswa tahun pertama dengan tingkat stres rendah), pada hari Senin, Tanggal 6 Februari 2017, Pukul 12.30 WIB.

mampu menghadapi tuntutan studi. Namun pada Subjek A situasi yang dihadapi dianggap berlebihan dan seringkali kehabisan kemampuan diri untuk mengatasi tanggung jawab dan tuntutan studi.

Merujuk pada pendapat Lazarus dan Folkman (1984) dalam Gaol (2016) penilaian terhadap stresor yang dilakukan oleh Subjek A dan Subjek B merupakan *primary appraisal* (penilaian tahap awal). Pada Subjek B penilaian yang dilakukannya disebut dengan istilah *irrelevant* (tidak terkait) yakni individu tidak mendapatkan dampak apapun dari situasi yang dihadapi. Subjek B tidak merasakan dampak apapun dari stresor akademik yang dihadapinya, artinya ia tidak membutuhkan usaha apapun ketika menghadapi sebuah permasalahan atau kejadian. Bahkan pernyataan Subjek B bahwa ia merasa nyaman dengan tuntutan akademik menandakan Subjek B berada pada tahap kedua dari *primary arousal* yang disebut dengan istilah *benigh-positive* (berdampak baik), artinya individu dalam menghadapi pergulatan dengan stresor mendapatkan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan (*wellbeing*) sehingga timbul luapan perasaan nyaman dan senang.

Adapun hasil analisis pada Subjek A menunjukkan bahwa Subjek berada pada tahap *stressful* dari tiga tahap penilaian awal. *Stressful* terjadi karena individu A tidak lagi memiliki kemampuan secara personal dalam menghadapi stresor. Sehingga akibatnya respon yang muncul pada Subjek A adalah *harmful*, *threatening* dan *challenging*. Sebagaimana Gaol (2016) menjelaskan *harmful* adalah tanda bahwa sesuatu yang membahayakan sedang terjadi. *Threat* adalah tanda bahwa adanya kemungkinan-kemungkinan yang membahayakan itu akan berlanjut dikemudian hari. *Challenge* merupakan keterlibatan individu dengan tuntutan yang ada.¹²

Sebenarnya stresor hanya memberikan rangsangan dan mendorong terjadi stres pada seseorang. Stresor berperan sebagai pemicu stres pada individu. Beberapa stresor secara universal menimbulkan respon yang sama pada setiap orang. Menurut Brannon dan Feist

¹² *Primary appraisal* (penilaian tahap awal) dilakukan oleh individu pada saat mulai mengalami sesuatu peristiwa. Lih Nasib Tua Lumban Gaol, "Teori Stres: Stimulus, Respons, dan Transaksional", *Buletin Psikologi*, Vol. 24, No. 1, (2016); 1-11.

(2007)¹³ stresor yang secara universal memunculkan reaksi yang sama disebut dengan istilah “Katastrofi” yakni kejadian besar yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi seperti bencana alam dan perang.

Namun pada jenis stresor *daily events* (peristiwa-peristiwa kehidupan) yang berfokus pada tuntutan perubahan kehidupan yang begitu banyak terjadi dalam waktu singkat *pun* seringkali memunculkan respon stres yang sama. Spurgeon, Jakson dan Beach (2001) menemukan sepuluh peristiwa kehidupan yang paling penting dan dapat memicu terjadinya stres, yaitu kematian pasangan, perceraian, kehilangan anggota keluarga, terpenjara, masalah keuangan, pertengkaran dalam keluarga, tunawisma, pengangguran, anggota keluarga yang tiba-tiba bunuh diri, dan penyakit kronis.¹⁴

Adapun pada mahasiswa stresor berjenis *daily events* (peristiwa kehidupan) bisa menjadi pencetus stres, karena khususnya pada mereka yang baru memasuki tahun pertama pendidikan dituntut dapat melakukan perubahan pola belajar dalam waktu singkat dan perlu melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan pendidikan baru yang sedang dijalani. Sebagaimana hasil analisis data kuantitatif pada bab terdahulu menunjukkan meskipun tidak ada perbedaan signifikan pada prevalensi stres dan tahun pendidikan, mahasiswa tahun pertama cenderung memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dua tahun pendidikan di atasnya yakni mahasiswa tahun kedua dan ketiga.

Stres pada mahasiswa tahun pertama dipengaruhi oleh stresor jenis *daily events* seperti diungkap di atas sejalan dengan Subjek C dalam wawancara mengemukakan dirinya merasa pola pembelajaran berbasis PBL menuntut dirinya harus melakukan banyak hal secara mandiri. Dirinya mengeluh kurang istirahat karena menghabiskan waktu mengerjakan tugas-tugas kuliah. Terlebih lagi beberapa referensi bahan bacaan berbahasa Inggris menambah tingkat kesulitan untuk memahami materi. Seringkali Subjek merasakan lelah yang

¹³Linda Brannon dan Jess Feist, *Health Psychology: an Introduction to Behavior and Health*, (San Fransisco: Wadsworth, 2007), 245.

¹⁴A. Spurgeon, C.A. Jackson and J.R. Beach, “The Life Events Inventory: re-Scaling based on an Occupational sample”, *Occup Med*, Vol. 51, (2001); 287-293.

berlebihan akibat rutinitas kampus. Subjek merasa perlu usaha lebih keras untuk bertahan sebagai mahasiswa disini.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Subjek C memiliki stres yang cukup tinggi dikarenakan proses adaptasi yang dituntut cepat dilakukan terlebih lagi dalam waktu yang sama proses adaptasi tersebut harus berbarengan dengan tuntutan dan kewajiban penyelesaian tugas kuliah yang harus tepat waktu sehingga terjadi kelelahan. Hasil analisis senada dengan studi yang dilakukan oleh Palmer et al (2013) pada sejumlah mahasiswa bahwa stresor harian menimbulkan kelelahan (*fatigue*) dan stres pada mahasiswa yang pada akhirnya memengaruhi proses belajar dan fungsi kognitif.¹⁶

Pada literasi berbeda tuntunan adaptasi pada mahasiswa kedokteran memiliki pemaknaan yang sama dengan penyesuaian diri (*self adjustmen*).¹⁷ Penyesuaian diri merupakan usaha individu untuk

¹⁵Wawancara dengan Subjek C (mahasiswi tahun pertama dengan tingkat stres tinggi), pada hari Jum'at, Tanggal 17 Februari 2017, Pukul 09.30 WIB.

¹⁶Fungsi kognitif dalam penelitian ini meliputi kemampuan konsentrasi dan daya ingat mahasiswa lih Laura, K. Palmer and others, "The Relationship between Stress, Fatigue, and Cognitive Functioning", *College Student Journal*, Vol. 47, No. 2, (2013); 312-325.

¹⁷Istilah adaptasi seringkali digunakan bergantian dengan istilah penyesuaian diri. Sebagaimana Schneiders (1964) menjelaskan penyesuaian diri mengandung beberapa penafsiran lainnya, seperti: (1)*adaptation*, yaitu kemampuan untuk dapat mempertahankan keberadaan diri dalam mengadakan hubungan dengan lingkungan; (2)*conformity*, yaitu bahwa dalam proses penyesuaian diri, individu harus mempertimbangkan norma sosial dan hatinuraninya; (3)*mastery*, yaitu bahwa penyesuaian diri merupakan kemampuan individu dalam membuat suatu perencanaan dan mengorganisir respon-respon sedemikian rupa, sehingga individu mampu menguasai atau menanggapi segala macam konflik, kesulitan, masalah hidup, dan frustrasi-frustrasi dengan cara efisien; (4)*individual variation*, yaitu terdapat perbedaan yang bersifat individual pada perilaku dan respon individu dalam menghadapi berbagai masalah. (5) *emotional maturity*, yaitu bahwa penyesuaian diri menuntut kemampuan individu untuk memiliki emosi yang tepat pada setiap situasi. Individu perlu melakukan kontrol terhadap emosinya agar penyesuaian diri yang sehat dapat tercapai. Lih Pergiawati Pristiana Kusuma dan Uly Gusniarti, "Gifted Review: Hubungan antara Penyesuaian Diri Sosial dengan

bereaksi terhadap tuntutan dalam diri maupun situasi eksternal yang dihadapinya. Pada umumnya penyesuaian diri di perguruan tinggi setelah sekolah menjadi masa transisi yang cukup sulit bagi sebagian mahasiswa. Menurut Sunarto (2008) diantara faktor yang memengaruhi penyesuaian diri terhadap tuntutan akademik adalah kondisi fisik.¹⁸

Sebagaimana kelelahan dipahami sebagai penurunan performa fisik beriring dengan bertambah banyaknya tugas dan latihan lainnya,¹⁹ sehingga dapat dipahami stres yang terjadi pada Subjek C berawal dari kelelahan. Apa yang terjadi pada Subjek C berdasarkan analisis penulis berdasarkan model stres respon²⁰ adalah Subjek

Stres pada Siswa Akselerasi”, *Jurnal Keberbakatan & Kreativitas*, Vol. 02, No. 01, (2008); 31-43.

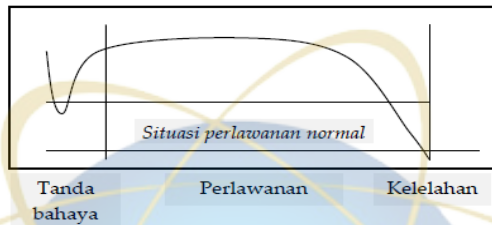
¹⁸Sunarto dan Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2008), 229.

¹⁹Hoda Mohammed Abdelfattah, Fatch H. Abdelazeim and Shroul Elshennawy, “Physical and Cognitive Consequence of Fatigue: a Review”, *Journal of Advanced Research*, Vol. 6, (2015); 351-358.

²⁰Stres model respon dikembangkan oleh Hans Selye menurutnya stres adalah respon tubuh yang bersifat non spesifik terhadap segala tuntutan dan beban. Selye menformulasikan konsep stres model respon dalam *General Adaptation Syndrome* (GAS). GAS ini berfungsi sebagai respon otomatis baik fisik dan emosi pada diri individu. Dirinya mengatakan bahwa setiap tubuh kita bereaksi sama terhadap berbagai stresor yang tidak menyenangkan, tubuh seolah memiliki sistem alarm yang tidak berhenti sampai sampai tubuh memberikan respon antara berjuang atau melarikan diri (*fight or flight reaction*) respon ini menurut Selye merupakan reaksi tahap awal yang disebut dengan istilah reaksi waspada (*alarm reaction stage*), selanjutnya pada tahap kedua tubuh akan memberikan reaksi resistansi (*resistance stage*) dimana pada tahap ini tubuh akan berusaha untuk bertahan menghadapi stres yang berkepanjangan dan menjaga sumber-sumber kekuatan dengan membentuk tenaga baru dan memperbaiki kerusakan yang disebut pula dengan reaksi adaptasi. Apabila stresor tetap berlanjut atau dihadapi stresor baru yang dapat memperburuk keadaan maka pada tahap ketiga tubuh akan merasakan reaksi kelelahan (*exhaustio stage*) pada tahap ini ketika tubuh tidak berhasil melakukan pertahanan dan terus dalam keadaan kelelahan karena sumber stres menetap maka individu bisa mengalami penyakit adaptasi (*adaptation disease*) penyakit yang rentangnya panjang mulai dari reaksi alergi sampai jantung, bahkan sampai kematian. Lih Voic-hita M. Dumitru dan Doina Cozman, “The Relationship between Stress and

sebelum mengalami kelelahan terlebih dahulu telah melakukan perlawanan (*resistance*) namun karena terus menerus dihadapi dengan stresor yang sama akhirnya Subjek merasakan kelelahan yang seringkali berlebihan. Sebagaimana Rice (2012) memberikan ilustrasi pada gambar 4.1. ketika tubuh melakukan perlawanan (*resistance*) sebelum akhirnya merasakan kelelahan berlebihan (*exhaustion*).

Gambar 4.1. Model Pada *Resistance*²¹



Ketika fisik dalam keadaan lelah, individu akan mengalami kegagalan penyesuaian diri. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kusuma dan Gusniarti (2008) kegagalan individu dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan perubahan-perubahan yang terjadi dapat menentukan tingkat stres.²² Demikian pula ketidakmampuan Subjek C dalam menyalurkan kebutuhannya dengan tuntutan lingkungan meningkatkan tingkat stres pada dirinya. Tuntutan eksternal yang dialami mahasiswa dan melampaui batas kemampuan (*overload*) mengakibatkan penurunan kemampuan untuk beradaptasi terhadap stres.²³

Personality Factors”, *Human and veterinary Medicine International Journal of the Bioflux Society*, Vol. 4, No. 1, (2012); 34-39.

²¹Virginia H. Rice, *Handbook of Stress, Coping, and Health: Implications for Nursing Research, Theory, and Practice*, (USA: Sage Publication, Inc, 2012), 24

²²Pergiawati Pristiana Kusuma dan Uly Gusniarti, “Gifted Review: Hubungan antara Penyesuaian Didi Sosial dengan Stres pada Siswa Aksele-rasi”, *Jurnal Keberbakatan & Kreativitas*, Vol. 02, No. 01, (2008); 31-43.

²³Ira Suwartika, Agus Nurdin dan Edi Ruhmadi, “Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Stres Akademik Mahasiswa Regular Program Studi D III Keperwatan Cirebon Poltekkes Kemenkes Tasikma-laya”, *Jurnal Keperwatan Soedirman*, Vol. 9, No. 3, (2014); 173-189.

Kesulitan adaptasi yang dialami Subjek C nampaknya tidak terjadi pada teman mahasiswa sejawatnya di tahun pertama lainnya yakni Subjek D yang mengatakan bahwa memang secara usia dirinya berada di atas rekan sekelas lainnya karena tahun ini menjadi tahun kedua dirinya mengikuti test masuk perguruan tinggi setelah tahun sebelumnya gagal dalam beberapa test masuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan pada akhirnya dinyatakan lulus pendidikan dokter pada perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutny tahun pertama pendidikan dokter memang cukup melelahkan karena banyak sekali kegiatan yang harus diikuti mulai dari sesi fasil, masa bimbingan sampai dengan perkuliahannya itu sendiri. Namun dirinya tetap senang dan nyaman saja. Terlebih lagi pengalaman kuliah satu tahun sebelumnya PTS lainnya pada fakultas tehnik Kimia menjadikan dirinya tidak terlalu kaget dengar aktivitas perkuliahan namun Subjek mengakui bahwa perkuliahan pada ilmu kedokteran lebih padat dan sibuk dibandingkan perkuliahan sebelumnya.²⁴

Menurut analisis penulis, Subjek D tidak mengalami ketegangan stres tinggi dikarenakan Subjek dengan faktor usia yang lebih tua diindikasikan memiliki kematangan emosi sehingga mampu mengelola perasaan, pikiran dan perilakunya terhadap tuntutan dan tanggung jawab akademik. Sebagaimana Mohan (1992) menyatakan kematangan emosi dan penyesuaian diri berkembang seiring bertambahnya usia.²⁵ Menurut Bhagat et al (2017) kematangan emosi ini diperlukan dalam proses belajar orang dewasa seperti mahasiswa yang sistem pembelajarannya tidak lagi berorientasi pedagogi melain-

²⁴Sesi Fasil merupakan sesi mahasiswa baru bersama dua orang mahasiswa senior untuk berdiskusi mengenai lingkungan kampus, cara belajar dan informasi terkait keilmuan kesehatan lainnya, setiap fasil bisa dilakukan di dalam atau di luar kampus sebanyak lima kali. Adapun Masa bimbingan (maBim) merupakan program kaderisasi dimana mahasiswa baru dijelaskan mengenai manajemen waktu, organisasi serta diskusi dengan senior yang lagi koas. MaBim dilakukan sebanyak empat kali yang biasanya dilakukan setelah jadwal kuliah. *Wawancara* dengan Subjek D (mahasiswa tahun pertama dengan tingkat stres rendah), pada hari Jum'at, Tanggal 17 Februari 2017, Pukul 10.00 WIB.

²⁵Mohan, "Analysis of Problems and Adjustmen of University Research Scholars", Paper at the National Conference of Indian Academy of Applied Psychology, Tirupati.

kan andragogi²⁶, kematangan emosi menjadikan individu mampu mengontrol impuls, berpikir sebelum bertindak dan berperilaku sesuai. Kematangan emosi terlihat dari kepercayaan diri dan komitmen untuk menyelesaikan tugas meski dihadang berbagai kesulitan.²⁷

Hal ini senada dengan pandangan Wagde dan Ganaie (2013) individu yang memiliki kematangan emosi akan terlebih dahulu memahami situasi yang ada sebelum memberikan reaksi secara impulsiv. Kematangan emosi akan menjadikan individu mampu mengontrol diri dalam keadaan tertekan, sengasara dan gagal sekalipun.²⁸ Subjek D yang gagal pada test tahun pertama di pendidikan dokter tidak berputus asa untuk mencoba kembali pada tahun berikutnya, dirinya masih mempunyai keyakinan sebagaimana yang diungkapkannya bahwa ia yakin dapat menyelesaikan studi pendidikan kedokteran ini dengan baik.²⁹

Perbedaan Subjek C dan D berada pada kematangan emosi yang dimiliki diantara keduanya adalah sebuah kewajaran, sebagaimana hasil studi Sharma (2012) menjelaskan mahasiswa yang baru memasuki pendidikan dokter pada umumnya menunjukkan ketidakmatangan emosi, seiring dengan bertambahnya masa pendidikan

²⁶Pedagogi dan andragogi merupakan seni dan ilmu pengetahuan tentang mendidik. Pedagogi berfokus pada seni mengajar kanak-kanak secara lebih tepatnya pedagogi mewujudkan pendidikan yang berfokus pada guru (*teacher centered*) dan guru mengarahkan pembelajaran. Sementara pada andragogi seni mengajar orang dewasa dalam andragogi yang terpenting dalam proses interaksi belajar adalah kegiatan belajar mandiri yang berpusat pada si pembelajar itu sendiri dan tidak pada guru (*learner centered*). Lih I Wayan Rai, "Andragogi dan Belajar Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Majalah Aplikasi Iptek Ngayah*, Vol. 4, No. 1, (2013); 1-7.

²⁷Vidya Bhagat and others, "Emotional Maturity among Medical Students and its Impact on their Academic Performance", *Transactions on Science and Technology*, Vol. 4, No. 1, (2017); 48-54.

²⁸Amit Dharmपाल Wadge dan Showkat Ahmed Ganaie, "Study on Emotional Maturity and Coping Strategies among the Students Pursuing Rehabilitation Studies", *International Journal of Science and Research*, Vol. 2, No. 8, (2013); 451-457.

²⁹Wawancara dengan Subjek D (mahasiswa tahun pertama dengan tingkat stres rendah), pada hari Jum'at, Tanggal 17 Februari 2017, Pukul 10.00 WIB.

mereka menjadi lebih stabil secara emosi.³⁰ Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Subjek F bahwa ia masih mengingat ketika masuk kuliah kedokteran tahun pertama mengalami *shock* dengan sistem pembelajaran PBL yang diterapkan oleh kampus, namun semakin naik ke semester atas meskipun secara materi dirasakan bertambah sulit namun dirinya merasakan sudah terbiasa dengan situasi dan tuntutan akademik jadi semua dapat dijalani dan dirasakan tanpa beban yang berarti.³¹

Apa yang diungkapkan oleh Subjek F sesuai dengan analisis kuantitatif yang menjelaskan bahwa stresor berhubungan akademik (*academic related stressors*/ARS) secara signifikan dihadapi oleh mahasiswa tahun ketiga dimana item no 15 adalah tertinggi yakni “memiliki kesulitan memahami materi”. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Christyanti et al (2010) sistem KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) yang diterapkan di Fakultas Kedokteran sering menjadikan mahasiswa kurang istirahat karena menghabiskan banyak waktu untuk memahami materi yang semakin ke atas masa studinya semakin sulit ditambah lagi mahasiswa semester atas dituntut untuk menggunakan buku-buku referensi berbahasa Inggris sehingga memperpanjang waktu untuk memahami materi.³²

Kekebalan Subjek F dari potensi stres dengan tingkat stresor tinggi dikarenakan Subjek memiliki kebiasaan, pengalaman dan adaptasi dengan sistem pembelajaran yang ada. Bahkan ujian yang menjadi salah satu stresor yang cukup tinggi dalam ARS ternyata tidak menyebabkan stres yang berarti bagi Subjek F dikarenakan dirinya sudah terbiasa dengan banyaknya ujian-ujian yang ditemui selama masa pendidikan, sehingga ketika ujian berlangsung dirinya tidak lagi merasakan sensasi tegang dan cemas yang berlebihan.

³⁰Bharti Sharma, “Adjustment and Emotional Maturity among First Year College Students”, *Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology*, Vol. 10, No. 2, 92012); 32-37.

³¹Wawancara dengan Subjek F (mahasiswi tahun ketiga dengan tingkat stres rendah), pada hari Rabu, Tanggal 8 Februari 2017, Pukul 09.30 WIB.

³²Dika Christyanti, Dewi Mustami’ah, dan Wiwik Sulistiani, “Hubungan antara Penyesuaian Diri terhadap Tuntutan Akademik dengan Kecenderungan Stres pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya”, *INSAN*, vol. 12, No. 3, (2010); 153-159.

Apa yang dirasakan Subjek F selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasmun (2004) bahwa pengalaman dan kebiasaan berhadapan dengan stresor dapat memengaruhi kemampuan individu untuk mengatasi respon berlebihan.³³ Begitupula Lahey (2007) berpendapat bahwa tinggi atau rendahnya stres yang diperoleh individu dipengaruhi pengalaman stres (*prior experience with the stress*) dimana secara umum orang yang sudah terbiasa dengan situasi yang menimbulkan stres akan memiliki stres yang rendah dibandingkan orang yang belum pernah dihadapkan dengan situasi yang menstimulus kejadian stres.³⁴ Respon seseorang dalam berhadapan dengan stresor tidak akan sama dengan saat pertama kali, seseorang cenderung lebih mudah mengelola stresor ketika sudah terbiasa dan sering terpapar dengan stresor yang sama.³⁵ Dengan demikian pengalaman Subjek F pada semester-semester terdahulu dalam menghadapi stresor dapat menjadi bekal dalam menghadapi stres berikutnya karena dirinya sudah memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik.

Pada wawancara yang berbeda dengan Subjek G menurutnya meskipun materi perkuliahan pada semester atas semakin sulit ditambah lagi persiapan mengikuti program praklinik dan klinik. Namun demikian dirinya merasa ketika dihadapi kesulitan materi perkuliahan dirinya banyak melakukan diskusi dengan teman dan untuk persiapan praklinik dan klinik dirinya sering berbagi pengalaman dengan para senior sehingga ketegangan dan kecemasan yang berlebihan kadang sedikit mereda.³⁶

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Subjek G tidak merasakan stres yang cukup berarti meskipun diterpa stresor yang lebih variatif seperti materi yang semakin banyak dan sulit ditambah lagi persiapan program pra dan klinik. Keadaan Subjek sangat baik

³³Rasmun, *Stres, Koping, dan Adaptasi Edisi ke-1*, (Jakarta: Sagung Seto, 2004), 26.

³⁴Benjamin B. Lahey, *Psychology: an Introduction, 8th edition*, (New York: McGraw Hill, 2007), 203.

³⁵Sophie Govaerts dan Jacques Gregoire, "Stressful Academic Situation: Study on Appraisal Variables in Adolescence", *European Review of Applied Psychology*, Vol. 54, No. 4, (2004); 261-271.

³⁶Wawancara dengan Subjek G (mahasiswi tahun ketiga dengan tingkat stres rendah), pada hari Selasa, Tanggal 14 Februari 2017, Pukul 12.30 WIB.

dikarenakan dirinya sering membuka diskusi dan dialog terkait kesulitan-kesulitan dalam belajar dengan teman sebaya pada semester yang sama atau berbagi pengalaman dengan para senior yang telah lebih dulu menyelesaikan program kliniknya. Berdasarkan analisis penulis berdasarkan model stres adaptasi menyebutkan diantara faktor lain yang menentukan apakah situasi menimbulkan stres atau tidak adalah praktik dan norma dari kelompok lain yang mengalami stres. Jika kelompoknya menganggap wajar untuk membicarakan stresor maka individu dapat mengeluhkan dan mendiskusikan hal tersebut³⁷.

Pertahanan diri yang dilakukan oleh Subjek G dapat dikategorikan juga dengan reaksi berorientasi pada tugas (*task orientation reaction*) yakni upaya mengatasi masalah yang berorientasi pada penyelesaian masalah yang salah satunya dengan berbicara dengan orang lain, mencari informasi tentang keadaan yang akan dialami dan melakukan latihan yang kesemuanya ditujukan untuk mengurangi respon berlebihan terhadap stresor yang dijumpai.³⁸ Dengan demikian respon/reaksi ini dapat membantu proses adaptasi terhadap stres, atau individu dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan perilaku kelompok sebayanya. Sehingga stimulus stresor terhadap kejadian stres dapat ditekan.

Namun demikian ketika hubungan individu dengan kelompoknya lebih banyak bersifat kompetitif, maka keadaan ini justru cenderung menjadi stresor bagi individu. Sebagaimana hasil temuan kajian pada bab sebelumnya menunjukkan stresor yang dipersepsikan cukup tinggi adalah stresor yang berhubungan dengan tugas berkelompok (*group activities relates stressor*/GARS). Sebagaimana Subjek E menjelaskan dirinya memang terbantu dengan sistem pembelajaran secara berkelompok namun sebagai mahasiswa tahun pertama justru dalam diskusi dan presentasi kelompok hampir setiap teman pada kesempatan yang ada justru sama ingin menunjukkan penguasaan diri terkait bahasan materi dan tugas bersama, dengan demikian dirinya merasa bahwa setiap teman saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Begitupula pembagian porsi tugas yang tidak seimbang

³⁷Potter Perry, *Fundamental Keperawatan Edisi 7 Buku 2*, (Jakarta: Salemba Medika, 2005), 35.

³⁸Gail W. Stuart, *Principles and Practices of Psychiatric Nursing 10th Edition*, (St Louis: Mosby, 2006), 265.

seperti pembuatan laporan, makalah dan presentasi seringkali menimbulkan konflik dan memicu permasalahan interpersonal.³⁹

Tuntutan berkompetisi dikarenakan siswa ingin meraih prestasi di kalangan teman sebayanya. Kebutuhan ingin menjadi terbaik merupakan motivasi bagi banyak pelajar dalam lingkungan akademik. Berkompetisi merupakan salah satu motivasi psikologis yang sangat lumrah dimiliki individu yang tinggal di masyarakat. Budaya masyarakat dan berbagai sistem nilai yang berlaku akan membatasi beberapa hal yang dianggap baik untuk dikompetisikan. Komunitas sosial akan memacu anggotanya untuk berkompetisi dalam semua hal.⁴⁰ Sebagaimana biasanya berkompetisi seringkali diajarkan oleh orang tua dan guru sejak si anak kecil, yakni dirinya dituntut untuk menjadi terdepan diantara yang lain.

Tuntutan berkompetisi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal mendorong mahasiswa menemukan cara bagaimana menjadi terbaik. Pada umumnya terdapat tiga bentuk kompetisi yang terjadi di kalangan pelajar: 1) *real competition* (kompetesi riil) yakni bentuk kompetisi di kalangan pelajar yang jelas standar ukurnya dengan hasil kompetisi ini, pengajar dapat mengukur performa muridnya apakah berada di tingkat yang tinggi atau rendah; 2) *perceived competition* (kompetesi persepsi) yakni individu merasa dirinya berkompetisi dengan teman lainnya tapi sejatinya dirinya tidak memiliki bukti bahwa dirinya sedang berkompetisi melawan mereka biasanya ini terjadi dalam bentuk kompetisi antar *gender*, untuk menghilangkan *stereotype* perbedaan *gender* di masyarakat individu saling berkompetisi untuk menjadi terbaik pada bidang keahlian tertentu; dan 3) *self competition* (kompetesi diri sendiri) yakni individu berkompetisi dengan dirinya sendiri. Dirinya tidak puas dengan performa akademik yang sudah diperoleh dan ingin menjadi yang terbaik.⁴¹

³⁹ Wawancara dengan Subjek E (mahasiswi tahun pertama dengan tingkat stres tinggi), pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, Pukul 12.00 WIB.

⁴⁰ Muhammad 'Utsman Najati, *Psikologi dalam Tinjauan Hadits Nabi*, (Jakarta; Mustaqim, 2003), 41.

⁴¹ Jerry Trusty and others, "Effects of Gender, Socioeconomic Status, and Early Academic Performance on Postsecondary Education Choice", *Journal of Counseling & Development*, Vol. 78, No. 4, 463-472.

Pada hakikatnya memang belajar secara berkelompok atau belajar dengan teman sejawat (*peer learning*) dapat memberikan efek positif pada pelajar, sebagaimana Gulfro dan Obsa (2015) menjelaskan bahwa belajar berkelompok mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik, dimana pada pembelajaran konvensional guru yang terlalu banyak bicara dan seringkali menciptakan kejenuhan. Namun pada pembelajaran berkelompok setiap pelajar mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan mengemukakan temuan dan pandangannya sehingga pada beberapa riset membuktikan bahwa belajar berkelompok tidak hanya meningkatkan hasil belajar namun juga menumbuhkan sifat saling membantu sesama pelajar dan merasa bangga bisa bekerja dan sukses bersama grup.⁴²

Berlainan dari pada hasil riset mengenai dampak positif belajar berkelompok pada umumnya, beberapa riset pada mahasiswa kedokteran tidak jarang justru menunjukkan studi kelompok menciptakan persaingan diantara mahasiswa kedokteran, hal ini tentunya terjadi ketika belajar berkelompok disikapi sebagai bentuk persaingan. Sebagaimana studi pada salah satu perguruan tinggi ilmu kedokteran swasta di India terhadap 147 mahasiswa kedokteran tahun pertama, hasil studi mendapati hasil bahwa studi kelompok yang diikuti dengan tingkat persaingan antar teman sejawat menjadi salah satu stresor akademik tertinggi.⁴³ Menurut Nazeer dan Sultana (2014) pada lingkungan pendidikan kesehatan dan dokter ketika mempelajari materi perkuliahan secara berkelompok dengan motivasi, kompetisi, intelegensi yang sama dapat memberikan tekanan bagi mahasiswa untuk secara cepat dan tepat menguasai materi.⁴⁴

⁴²Efrem Gulfo dan Oukula Obsa, "Students towards One-to-Five Peer Learning: a New Approach for Enhancing Education Quality in Wolaita Sodo University, Ethiopia", *Journal of Education and Practice*, Vol. 6, No. 19, (2015); 152-159.

⁴³Anandhalakshmi Swaminathan and others, "Perceived Stress and Sources of Stress among First-year medical Undergraduate Students in a Private Medical College – Tamil Nadu", *National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology*, Vol. 6, No. 1, (2016); 9-14.

⁴⁴Moh. Nazeer dan Razia Sultana, "Stress and it's Coping Strategies in Medical Students", *Scholars Journal Applied Medical Science*, Vol. 2, No. 6D, (2014); 3111-3117.

Sebagaimana stresor terkait aktifitas berkelompok yang dideskripsikan Subjek E menimbulkan persaingan diantara teman sebaya dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung dirinya juga menghadapi sumber stres yang terkait interaksi dengan dirinya sendiri (*intrapersonal*) dan dengan orang lain (*interpersonal*). Dalam wawancara selanjutnya Subjek E merasakan bahwa ketika menghadapi konflik dengan teman sebayanya di perguruan tinggi seringkali karena dirinya tinggal berjauhan dengan orang tua, sesekali ia kehilangan tempat curhat, terlebih lagi teman-teman akrab semasa SMU sudah tidak intens lagi berkomunikasi.⁴⁵

Menurut literasi dan riset terkait stresor intrapersonal dan interpersonal berhubungan dengan stresor sosial, dimana mahasiswa dianggap memiliki konflik dengan dirinya dan orang lain. Menurut analisa penulis konflik intrapersonal yang terjadi pada Subjek E adalah perasaan kesendirian (*loneliness*) dikarenakan Subjek tinggal berjauhan dengan orang tua dan belum terlalu akrab dengan teman barunya. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Seyedfatemi et al (2007) bahwa perasaan kesendirian cenderung dialami oleh mahasiswa baru (*freshmen*) dikarenakan mereka masih beradaptasi dengan lingkungan baru, suasana baru dan teman-teman baru. Ketika terjadi konflik biasanya mereka akan merasakan kesendirian dikarenakan dalam menghadapi konflik tersebut mereka kurang mendapat dukungan orang tua, saudara, dan teman akrab semasa sekolah.⁴⁶

Begitupula riset yang dilakukan oleh Muzafar et al (2015) di kalangan 777 mahasiswa kedokteran di Pakistan menunjukkan bahwa stresor dengan frekuensi yang cukup tinggi dan menempati posisi kedua dan ketiga dari 26 sumber stresor yang diidentifikasi setelah materi yang banyak adalah kurangnya dukungan teman dan minimnya dukungan sosial.⁴⁷ Pada riset lainnya stresor interpersonal tidak hanya

⁴⁵ Wawancara dengan Subjek E (mahasiswi tahun pertama dengan tingkat stres tinggi), pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, Pukul 12.00 WIB.

⁴⁶ Naiemeh Seyedfatemi, Maryam Tafreshi dan Hamid Hagani, "Experienced Stressors and Coping Strategies among Iranian Nursing Students", *BMC Nursing*, Vol. 6, No. 11, (2007); 1-10.

⁴⁷ Yumna Muzafer and others, "Burnout and its Association Factors in Medical Students of Lahore, Pakistan", *Open Acces Original Article*, (2015); 1-12.

terjadi karena hubungan dengan teman namun juga karena hubungan dengan dosen yang terkadang dijumpai terlalu keras, banyak tuntutan akademik dan kurang membimbing.⁴⁸

B. Mekanisme Respon Stres

Selanjutnya mekanisme stres rendah dan tinggi yang dialami mahasiswa kedokteran sebagaimana yang dijelaskan di atas, guna analisa lebih lanjut mekanisme kejadian stres tersebut harus diuji kembali lewat respon yang muncul. Berdasarkan model respon, stres dipahami sebagai respon tubuh terhadap stimulus yang diterima. Lyon (2012) kemudian mengistilahkan respon tubuh terhadap stresor sebagai variabel terikat atau hasil.⁴⁹ Hasil stres ini meliputi perubahan kondisi psikis, emosional dan psikologis.⁵⁰ Dengan demikian dapat dipahami bahwa hubungan antara stresor dan hasil stres tidak bisa dipisahkan dari reaksi tubuh terhadap stresor, oleh karena itu perlu bagi penulis menjelaskan indikasi stres pada mahasiswa kedokteran guna memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

1. Respon Psikologis

Pada umumnya indikasi psikologis stres sangat terlihat jelas dari reaksi emosional. Emosi yang muncul adalah hasil otomatis dari penilaian bawah sadar terhadap objek atau situasi.⁵¹ Analisis kuantitatif pada bab terdahulu menjelaskan indikasi secara psikologis mahasiswa yang mengalami stres dapat diukur dari tiga indikator yakni perasaan kecewa (*upset*), tidak terkontrol (*uncontrolled*) dan gugup (*nervous*). Untuk memperkuat hasil temuan ini, penulis melakukan wawancara terhadap tiga orang Subjek (A, C dan E) sebagai mahasis-

⁴⁸Sonia Betzabeth Ticona Benavente dan Ana Lucia Siquire Costa, "Physiological and Emotional Responses to Stress in Nursing Students; an Integrative Review of Scientific Literature", *Acta Paul Enferm*, Vol. 24, No. 4, (2011); 571-576.

⁴⁹Brenda L. Lyon, *Stress, Coping and Health a Conceptual Overview*, (Detroit: Sage Publication, 2012), 49.

⁵⁰Deborah Carr dan Debra Umberson, *The Social Psychology of Stress, Health, and Coping* dalam DeLameter, J. & Ward, A. (Eds.). *Handbook of Social Psychology* (Netherlands: Springer, 2013), 456.

⁵¹Alexander Stamatious G. Antanious dan Carry L. Cooper, *Research Companion to Organizational Health Psychology*, (Northampton: Edward Elgar Publishing Limited, 2005), 188.

wa tahun pertama dengan hasil kuantitatif yang menunjukkan indikasi psikologis stres cukup tinggi dan dianggap dapat mewakili sampel penelitian ini.

Subjek E pada analisis kuantitatif dirinya memiliki indikasi psikologis stres tinggi pada aspek kecewa. Pada sesi wawancara Subjek E menjelaskan dirinya seringkali merasa khawatir setiap kali mendapatkan tugas dan takut tidak dapat menyelesaikan tugas secara benar dan tepat waktu, dirinya juga kerap kali merasa kecewa karena seringkali merasa tugas yang telah ia kerjakan kurang sempurna meskipun tepat waktu.⁵² Menurut Sukadiyanto (2010) secara psikologis individu yang mengalami stres ditandai dengan menurunnya kemampuan diri melakukan sesuatu yang biasanya dapat ia lakukan, sehingga muncul rasa khawatir.⁵³ Menurut analisa penulis kekhawatiran terhadap hasil tugas pada Subjek E selanjutnya memunculkan perasaan kecewa pada dirinya sendiri.

Berbeda dengan Subjek C meskipun pada hasil analisis kuantitatif dominansi indikasi stres pada aspek *uncontrolled* namun hasil wawancara menunjukkan bahwa perubahan psikologis Subjek tidak hanya terindikasi dari ketidakmampuan mengontrol emosi namun juga diiringi indikasi psikologis stres lainnya. Sebagaimana Subjek menjelaskan bahwa dirinya akibat kelelahan mengikuti berbagai aktifitas, tugas dan rutinitas perkuliahan seringkali ketika pulang ke rumah melampiaskan emosi marah, kesal, kecewa kepada keluarga. Ketika di rumah dirinya merasa lebih sensitif, mudah tersinggung, lebih banyak diam memendam perasaan, bahkan kurang komunikasi dengan keluarga.⁵⁴ Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Wilda et al (2016) ketidakmampuan individu mengontrol emosi mengakibatkan individu tersebut mudah kehilangan kesabaran dan

⁵² Wawancara dengan Subjek E (mahasiswi tahun pertama dengan tingkat stres tinggi), pada hari Selasa, Tanggal 14 Februari 2017, Pukul 12.00 WIB.

⁵³ Sukadiyanto, "Stres dan Cara Mengatasinya", *Cakrawala Pendidikan*, Vol. 29, No. 1, (2010); 55-67.

⁵⁴ Wawancara dengan Subjek C (mahasiswi tahun pertama dengan tingkat stres tinggi), pada hari Jum'at, Tanggal 17 Februari 2017, Pukul 09.30 WIB.

ketenangan, mudah marah bahkan berlaku agresif pada situasi-situasi kecil yang tidak terlalu penting.⁵⁵

Emosi mudah marah pada beberapa literasi dilaporkan menjadi indikasi psikologis stres yang paling mudah dan banyak teramati. Marah memang biasanya muncul ketika sebuah tuntutan tidak dapat dipenuhi, jika individu merasa dirinya berhalangan memenuhi tuntutan, maka demi melampiaskan tuntutan yang tidak terpenuhi maka dia akan marah dan gelisah. Faruqi (2011) dalam risetnya terkait disregulasi marah menjelaskan bahwa individu yang memiliki tingkat kemarahan yang tinggi menunjukkan kualitas hidup yang rendah dan mengalami kesulitan fungsi sosial.⁵⁶ Hal ini menurut analisis penulis Subjek C dengan tingkat sensi marah yang mudah meledak membuatnya sulit menjalin komunikasi yang baik dengan anggota keluarga.

Dalam keadaan marah biasanya terjadi perubahan fisiologis pada diri individu, sebagaimana dideskripsikan oleh Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al Huzri RA dalam sabda beliau:

Artinya:

“Ingatlah, sesungguhnya marah itu adalah bara api yang terdapat dalam hati anak keturunan Adam. Tidaklah kalian melihat warna merah pada kedua matanya dan urat-urat lehernya yang mengembang (ketika seseorang sedang marah)”.

Merujuk pada hadits ini, Najati (2003) menjelaskan emosi marah menyebabkan perubahan pada organ fisik yang bersifat internal dan eksternal. Perubahan eksternal adalah berubahnya rona muka, perubahan suara dan tegangnya otot pada organ tubuh sementara perubahan internal adalah ketika marah jantung akan berdebar-debar, lambung mengerut, aliran darah mendesak ke bagian dada

⁵⁵Tesa Wildan, “Hubungan Resiliensi Diri terhadap Tingkat Stres pada Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Riau”, *JOM FK*, Vol. 3, No. 1, (2016); 1-9.

⁵⁶Faruqi and others, “Anger Arousal and Wellbeing as Markers of Social Functioning and Quality of Life in the Aftermath of Exposure to Life Threatening Trauma”, *European Psychiatry*, Vol. 26, No. 1, (2011), 1584.

sehingga sampai akhirnya membuat wajah mejadi merah padam. Bahkan suhu tubuh mejadi panas.⁵⁷

Menurut analisis penulis indikasi psikologis stres yang dirasakan Subjek C seperti marah, kesal, kecewa dan gelisah terjadi karena individu tersebut kehilangan kontrol diri dan dalam keadaan sangat lelah memang Subjek justru menjadi lemah dan merasa tidak berdaya. Keluhan yang disampaikan oleh Subjek A dan C sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Baqutayan (2011) secara psikologis individu yang mengalami tekanan akan muncul reaksi emosi kecemasan (*qalaq*), putus asa (*ya's*) dan tidak berdaya (*qunut*) dan menurutnya apapun bentuk khawatir yang berlebihan akan memunculkan rasa takut.⁵⁸

Respon stres terkait kecemasan dalam perspektif Islam disebabkan oleh tidak stabilnya mental dan emosional. Kecemasan dalam Islam merupakan salah satu penyakit hati. Şalih ibn 'Abd Allah menyebutkan tiga definisi kecemasan diantaranya *pertama*, cemas merupakan kondisi menyakitkan (*al-mu'allamah*) yang memunculkan kondisi lemah (*al-jaza'*) dan takluk (*al-iḥbāt*). *Kedua*, cemas merupakan perasaan bingung (*ghamiḍ*) yang dapat menyebabkan gangguan psikis dan fisik (*al-'raḍ'an- nafsīyah wa jasamiyah*). *Ketiga*, cemas adalah kondisi emosi (*ḥalah infī'aliyah*) yang dekat dengan atau mirip dengan rasa takut (*maṣḥubah bi al-khauf*), kaget dan khawatir (*al-faza'*) yang mendorong manusia untuk berperilaku khawatir seperti melakukan sesuatu berulang-ulang.⁵⁹ Definisi ketiga ini selaras dengan pandangan 'Abd al- Rahman Muhammad Iswa mengatakan bahwa menurut al- Ghazali kecemasan dekat dengan perasaan takut, kecemasan muncul karena penyakit jiwa, selain kecemasan jiwa yang

⁵⁷Muhammad Utsmān Najati, *Psikologi dalam Tinjauan Hadits Nabi*, (Jakarta; Mustaqim, 2003), 134.

⁵⁸Shadiyah Mohamed S. Baqutayan, "An Inovative Islamic Counseling", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 1, No. 21, (2011); 178-183.

⁵⁹Şalih ibn 'Abd Allāh, *Naḍrah al- Na'im fi Makārim al- Akhlāq al- Rasūl al- Karīm*, (Jedah: Dar al- Waṣīlah li al- Nasr wa al- Tawzī, 1998), 5338.

tidak sehat juga akan mengakibatkan berbagai emosi negatif lainnya seperti marah, benci, sedih, sombong dan sebagainya.⁶⁰

Khawatir berlebihan dapat dipahami sebagai bentuk kecemasan. Pandangan Baqutayan, Ṣālih ibn ‘Abd Allāh dan al- Ḡazālī yang menghubungkan antara khawatir/kecemasan dan takut dapat dipahami karena sebagaimana pada diskusi awal disebutkan bahwa stres muncul karena individu merasa dirinya terancam dengan stresor yang dihadapi sedangkan takut merupakan emosi yang bersifat fitrah dirasakan manusia pada situasi berbahaya atau mengancam kenyamanan dirinya. Bahkan Zhū al-Nūn menyebutkan bahwa seseorang berjalan karena takut, rasa takut ini diperlukan. Apabila rasa takutnya telah hilang maka dia akan tersesat.⁶¹

Kecemasan dan takut meskipun terkadang digunakan bergantian secara terminologi namun sebenarnya keduanya adalah berbeda. Takut (*fear*) merupakan reaksi atas sesuatu yang spesifik, yakni bahaya akan sesuatu dapat terlihat dan dirasakan.⁶² Namun kecemasan seringkali terjadi tanpa objek, kemudian dalam kajian psikologis kecemasan yang berlebihan dianggap sebagai salah satu bentuk gangguan psikologis yakni ansietas.⁶³ Dalam batas normal kecemasan

⁶⁰: Abd al- Raḥmān Muḥammad Iswā dalam Che Haslina Abdullah and others, “Generalized Anxiety Disorder (GAD) from Islamic and western Perspectives”, *World Journal of Islamic History and Civilization*, Vol. 2, No. 1, (2012); 44-52.

⁶¹ Zhū al-Nūn, *Al-Risalah al- Qushairiyah*, (T.tp: al-Maktabah al-Shamilah, T.th), 59.

⁶² Ahmad Rusdi menjelaskan tiga macam jenis ketakutan dalam perspektif Islam. *Pertama*, *al-khauf* adalah syarat orang beriman sebagaimana disebutkan dalam a- Qur’an surah Āli ‘Imrān: 175. *Kedua*, *khashyah* adalah ketakutan yang menyebabkan seseorang harus mendekat kepada Allah. *Ketiga*, *Haibah* adalah ketakutan yang diwujudkan dengan rasa gentar diri terhadap Allah sehingga individu tersebut memelihara dirinya dari dosa dan keburukan. Lih Ahmad Rusdi, *Kecemasan dan Psikoterapi Spiritual Islam: Dari Spiritual Disorder hingga Persoalan Eksistensi Menuju Kesehatan Psiko-Spiritual*, (Jakarta: Disertasi Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 60.

⁶³ Ada tiga jenis kecemasan yaitu kecemasan nyata dan objektif, kecemasan neoutotik, dan kecemasan moral. 1) Kecemasan nyata dan objektif disebabkan oleh bahaya yang ada secara fisik di dunia nyata. 2) Kecemasan neorotik disebabkan oleh masa kecil karena terjadi konflik antara kenya-

justru menjadi salah satu bentuk sistem pertahanan dan kecerdasan manusia untuk menghindari bahaya. Namun ketika cemas dirasakan berlebihan maka ia akan memunculkan kondisi sesak di dada dan tidak bisa menerima keadaan dikarenakan individu saat cemas berlebihan akan kehilangan kemampuan berpikir sehat. Kecemasan menyebabkan seseorang tidak bisa merasakan keadaan santai dan tenang (‘*adam al-irtiyah wa al- istiqrar*).⁶⁴

Begitupula rasa takut seseorang yang masih pada batas normal dan tidak berlebihan akan bermanfaat baginya untuk mendorong melakukan hal-hal yang baik. Dalam ajaran Islam rasa takut yang dimiliki umatnya akan menjadikan diri mereka sebagai orang-orang yang taat pada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sebagaimana disebutkan dalam surah *Ali Imran* ayat 175:

وَحَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

“tetapi takutlah kepadaKu, jika kamu benar-benar orang yang beriman”. (Ali Imran :175).

Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang ancaman dan siksa Allah memberikan pengaruh efektif terhadap emosi takut dan dengan rasa takut itu manusia menjadi lebih baik. Sebagaimana Abu Uthman mengatakan bahwa sebenar-benarnya rasa takut adalah menjaga diri dari dosa secara zahir dan batin (*al-wara’ an al-atham zahira wa batina*). Selanjutnya ditegaskan oleh Imam Qusairi bahwa rasa takut apabila telah tertanam dalam hati maka akan menyingkirkan syahwat dan nafsu duniawi.⁶⁵ Sementara Mujib (2006) menjelaskan individu yang senantiasa takut kepada Allah

taan dan harapan. 3) Kecemasan moral disebabkan oleh konflik antara *id* dan *superego*. Lih Duane P. Schultz dan Sydme E. Schultz, *Theories of Personality*, (Belmont: Wadsworth, 2005), 58-60.

⁶⁴Ihsan al- Ma’rawi, *Maqalat Mauqi ‘al-Alukah* (Maktabah al-Shamilah, V. 3.28), 1.

⁶⁵Al-Qusyairy an- Naisabury, *Ar-Risalah al- Qusairiyah fi ‘Ilmi at-Taṣawuf*, (Mesir: Dār al- Khair, tt), 59.

merupakan cerminan kepribadian *yaum ākhiri*, yakni kepribadian yang menyiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat.⁶⁶

Sebaliknya kalau rasa takut yang dimiliki individu sudah pada batas yang tidak wajar, maka hal ini bisa berakibat buruk. Rasa takut yang masih normal bisa membuat seorang pelajar bersiap-siap menghadapi ujian dan serius untuk belajar. Sedangkan rasa takut yang berlebihan bisa mengakibatkan seorang pelajar malah tidak bisa berkonsentrasi untuk menghadapi ujian.⁶⁷

Kendler (2003) menjelaskan bahwa individu yang mengalami cemas dan takut berlebihan sedikitnya akan mengalami empat pengalaman yaitu; *pertama*, kehilangan yakni pengalaman merasa kehilangan keterhubungan dengan dirinya sendiri seperti hilang rasa bahagia, kehormatan, semangat atau kontrol diri ataupun hilang keterhubungan dengan orang lain. *Kedua*, merasa rendah (*humiliated*) yakni kehilangan diri untuk memengaruhi orang lain atau merasa gagal memengaruhi diri sendiri. *Ketiga*, terjebak pada lingkungan yang sulit, individu hanya punya pilihan untuk bertahan dan merasa belum menemukan solusi yang tepat. *Keempat*, merasa bahaya bahwa pada masa yang akan datang dirinya akan menjumpai keadaan yang tidak menyenangkan. Ketiga Subjek (A, C dan E) menurut analisis penulis mengalami hampir keempat pengalaman ini seperti Subjek C mengalami kehilangan kontrol emosi dan Subjek A merasa tidak berdaya, sementara Subjek E seringkali merasa bahwa dirinya cemas dan takut tugas yang telah dikerjakan belum cukup baik dan sempurna.

2. Respon Kognisi

Kesulitan konsentrasi yang dialami mahasiswa menjelaskan bahwa emosi berhubungan dengan kognisi, itulah mengapa pada beberapa literasi menjelaskan indikasi psikologis stres ini tidak hanya terbatas pada emosi tapi juga meliputi gejala kognisi atau intelektual, dan interpersonal. Gejala kognisi dan intelektual ini dapat terlihat lewat terganggunya proses berpikir individu, seperti sulit berkonsen-

⁶⁶ Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 239.

⁶⁷ Edwar More, *Ad-Da'fi'iyah wal Infi'al* diterjemahkan oleh Ahmad Abdul Aziz Salamah diedit oleh Muhammad Utsman Najati, *Psikologi dalam Tinjauan Hadits Nabi*, (Jakarta; Mustaqim, 2003), 129.

trasi, susah mengingat dan mudah lupa, pikiran menjadi kacau dan tidak wajar. Sebagaimana Subjek C (mahasiswi tahun pertama stres tinggi) mengungkapkan dirinya seringkali ketika hendak mengerjakan tugas atau mempelajari materi yang cukup rumit entah mengapa sering merasakan gugup menghadapi tugas tersebut sehingga ketika ingin mengerjakan tugas dengan mencari sumber bacaan dirinya merasa sulit untuk memulai meskipun ia sudah membaca namun terkadang sulit sekali baginya untuk memahami bacaan yang dia pelajari bahkan terkadang untuk satu atau dua paragraph dia harus membaca dua sampai tiga kali agar bisa paham.⁶⁸

Menurut analisa penulis gejala stres yang terjadi pada Subjek C adalah gangguan pada fungsi kognitif⁶⁹ yang kemudian membuatnya kesulitan dalam pengendalian kemampuan berpikir. Hal ini terlihat dari sulit berkonsentrasi, sulit membaca dan memahami secara komprehensif serta mudah lupa. Sebagaimana Sanderson (2013) menyatakan dampak stres terhadap fungsi kognitif meliputi beberapa indikator yaitu atensi, konsentrasi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah dan kendali impuls.⁷⁰ Pada kenyataannya, banyak individu yang tidak mampu berkonsentrasi ketika menghadapi tekanan.⁷¹ Sebagaimana konsentrasi dipahami sebagai pemusatan pikiran pada suatu hal dengan cara menyampingkan hal-hal lain yang tidak berhubungan,⁷² sehingga dengan banyaknya beban akademik seringkali mahasiswa terpecah-pecah dalam berbagai arus pemikiran yang

⁶⁸Wawancara dengan Subjek C (mahasiswi tahun pertama dengan tingkat stres tinggi), pada hari Jum'at, Tanggal 17 Februari 2017, Pukul 09.30 WIB.

⁶⁹Fungsi kognitif adalah kemampuan berpikir dan memberikan rasional, termasuk proses belajar, mengingat, menilai, orientasi persepsi dan memperhatikan. Herlina, *Pengaruh Triterpen Total Pegagan terhadap Fungsi Kognitif Belajar dan Mengingat pada Mencit Jantan Albino*, (Palembang, FMIPA Universitas Sriwijaya, 2010), 12.

⁷⁰Sanderson (2013) dalam Amalia Rahmandani, Pemaafan dan Aspek Kognitif daro Stres pada Mahasiswa Jurusan Kebidanan Tingkat Dua", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 14, No. 2, (2015); 118-128.

⁷¹Siswanto, *Kesehatan Mental: Konsep, Cakupan dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2007), 65.

⁷²Slameto, *Belajar dan Fakotor-Faktor yang Memengaruhinya*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010), 86.

membuat persoalan menjadi semakin kabur, tidak terarah dan sulit ditangani dikarenakan dirinya teringat tugas-tugas kampus atau permasalahan personal lainnya.

Salah satu aktifitas yang terjadi ketika belajar adalah berpikir, ketika berpikir bagian tubuh yang banyak bekerja adalah otak, Hashempour dan Mehrad (2014) menyebutkan aktifitas otak dan prosedur kognisi bisa saja terganggu karena dipengaruhi emosi negatif. Dalam keadaan stres reaksi emosi yang muncul adalah cemas, takut, khawatir dan tidak tenang, sehingga sangat jelas sekali bisa dipahami ketika reaksi emosi negatif ini muncul maka proses belajar dapat terganggu yang salah satu efek yang muncul adalah kesulitan konsentrasi dan pemusatan perhatian.⁷³ Selain dari pada pemusatan perhatian dan konsentrasi, stres juga bisa merusak proses kognisi lainnya seperti ingatan (memori).

Keluhan Subjek terkait susah mengingat dan gampang lupa maka hal ini sangat terkait dengan proses gangguan kognisi⁷⁴ yang terkait dengan memori (daya ingat). Memori merupakan kemampuan individu untuk menyimpan informasi yang kemudian informasi tersebut dapat dipergunakan pada lain waktu. Memori ini merupakan unsur inti dari perkembangan kognitif khususnya pada aktifitas belajar yang hampir keseluruhannya melibatkan memori. Proses ingat dan lupa (*remembering and forgetting*) saling berkesinambungan dengan proses belajar dan mengingat (*learning and memory*), individu dengan ingatan yang baik dapat dikatakan sebagai pelajar yang baik.

Ada tiga proses penting dalam memori yakni *encoding* (penyandian), *retention* (retensi), dan *retrieval* (retrival).⁷⁵ Ketika

⁷³Sara Hashempour dan Aida Mehrad, "The Effect of Anxiety and Emotional Intelligence on Students' Learning Process", *Journal of Education and Social Policy*, Vol.1, No. 2, (2014); 115-122.

⁷⁴Gangguan fungsi kognitif merupakan gangguan fungsi luhur otak berupa orientasi, perhatian, konsentrasi, daya ingat dan bahasa serta fungsi intelektual yang diperlihatkan dengan adanya gangguan dalam berhitung, bahasa, daya ingat semantik (kata-kata) dan pemecahan masalah. Gangguan fungsi kognitif erat kaitannya dengan fungsi otak karena kemampuan untuk berpikir akan dipengaruhi otak. Lihat Isnaini, *Senam Vitalisasi Otak dapat Meningkatkan Fungsi Kognitif Usia Dewasa Muda*, (Jakarta: Fisioterapi Universitas Kristen Indonesia, 2012), 23.

⁷⁵*Encoding* (penyandian) merupakan proses pencatatan informasi, *retention* (retensi) sebagai tahap kedua yang disebut juga dengan istilah *sto-*

aktifitas memori ini dikaitkan dengan stres maka secara tidak langsung memori ini juga dikaitkan dengan emosi, dimana berdasarkan teori neuropsikologis ketika individu dalam keadaan emosi positif maka akan dibarengi dengan peningkatan dopamin dan hal ini menyebabkan peningkatan kinerja berbagai tugas kognitif termasuk memori.⁷⁶

Para ahli psikologi kognisi dewasa ini menganggap penting untuk melakukan kajian mengenai pengaruh emosi (afektif) terhadap proses kognisi khususnya terkait memori. Salah satu eksperimen yang mencoba menganalisa kedua hal ini adalah Schwabe dan Wolf (2010) dimana keduanya mencoba mengungkap bagaimana proses belajar yang terjadi dalam keadaan stres dapat mengganggu sistem kerja memori. Riset ini melibatkan 48 mahasiswa dari Universitas Ruhr Bochum Jerman yang kemudian dibagi dalam dua kelompok satu grup kontrol dan satu lagi grup intervensi. Grup uji coba dimanipulasi untuk berada dalam keadaan stres. Peneliti menggunakan tehnik *socially evaluated cold pressor test* (SECPT) yakni Subjek diminta mencelupkan tangannya ke dalam air es bersuhu 0-2° C selama 3 menit dimana metode ini banyak digunakan dalam banyak riset eksperimen terkait induksi stres. Untuk memastikan tingkat stres para peneliti juga melakukan pengukuran tekanan darah dan test air liur untuk mendapatkan kadar kortisol. Kemudian setelah 10 menit responden diberikan beberapa kata dalam sesi *free recall* (Subjek diminta untuk melihat kata-kata dan mengingatnya). Kemudian di hari selanjutnya Subjek diminta untuk melakukan *recall/recognition* (mengingat kembali). Studi ini ternyata menemukan gangguan memori yang cukup besar ketika belajar dalam keadaan stres. Belajar dalam keadaan stres mengurangi

rage (penyimpanan) informasi dan *retrieval* (retrival) sebagai tahap ketiga yakni proses pemanggilan kembali (*recall*) dari informasi yang sudah tersimpan. Lihat Jhon R. Anderson, *Learning and Memory: An integrated approach*, 4th Edition. (New York: John Wiley & Sons, Inc, 1995), 49.

⁷⁶Martono dan Dicky Hastjarjo, "Pengaruh Emosi terhadap Memori" *Buletin Psikologi*, Vol. 16, No. 2, (tt); 98-102.

kemampuan *free recall* dan *recognition* sebanyak 30% hal ini terjadi sejak awal lagi ketika proses mengingat yakni ketika *encoding*.⁷⁷

Menurut penulis penjelasan yang memungkinkan dari riset ini adalah gangguan memori akibat stres terjadi dikarenakan stres mengganggu proses memori sejak proses awalnya yakni *encoding*, individu dalam waktu yang bersamaan terpecah fokusnya tidak hanya pada materi tapi juga berusaha melepaskan diri dari keadaan yang menekannya. Selanjutnya ketika *encoding* ini terganggu maka kemampuan memori untuk melakukan penyimpanan (*storage*) sangat terbatas sehingga dapat dimaklumi kemampuan *recognition* sangat rendah dan selanjutnya individu akan sangat mudah mengalami kelupaan terkait materi yang sudah dipelajari. Analisis ini sesuai dengan model alokasi yang dikembangkan oleh Ellis dan Ashbrook dimana mereka mengasumsikan bahwa kapasitas perhatian sangat terbatas untuk melaksanakan tugas kognitif dan emosi memengaruhi kapasitas perhatian tersebut. Pengaruh emosi akan bersifat disruptif terhadap perhatian seperti emosi tertekan akan mengurangi kemampuan mengingat kembali informasi.⁷⁸

3. Respon Fisiologis

Selain dari pada gangguan kognisi sebagaimana diungkap di atas, stres juga dapat terlihat dari indikasi fisiologis yang salah satunya adalah stres dapat mengakibatkan berbagai bentuk keluhan pada otot dan tulang (*musculoskeletal*).⁷⁹ Keluhan muskuloskeletal ini dapat terjadi sementara dan biasanya akan segera hilang ketika pembebanan dihentikan. Ketika keluhan terus terjadi meskipun beban kerja dihentikan artinya individu mengalami keluhan muskuloskeletal menetap.

Beberapa Subjek yang terindikasi memiliki tingkat stres pada penelitian ini (seperti Subjek A, Subjek C dan Subjek E mahasiswa tahun pertama) secara umum mengungkapkan bahwa mereka sering

⁷⁷Lars Schwabe dan Oliver T. Wolf, "Learning under Stress Impairs Memory Formation", *Neurobiology of Learning and Memory*, Vol. 93, (2010); 183-188.

⁷⁸Martono dan Dicky Hastjarjo, "Pengaruh Emosi terhadap memori" *Buletin Psikologi*, Vol. 16, No. 2

⁷⁹Tarwaka, *Ergonomi Industri*, (Surakarta: Harapan Press, 2010), 21.

merasakan beberapa keluhan muskoleskeletal seperti pegal, kesemutan, dan kaku. Bagian tubuh yang paling banyak dirasakan keluhannya adalah bagian pantat, pinggang, punggung, pergelangan tangan, siku-siku dan leher. Tiga bagian ini memang secara umum didapati pada mahasiswa dikarenakan proses belajar yang mereka jalani seringkali dalam postur dan posisi statis dengan frekuensi yang cukup lama seperti lama duduk. Keluhan pada pantat dikarenakan pada posisi duduk memang bagian ini berfungsi sebagai penopang tubuh dan mengalami tekanan akibat berat tubuh. Sementara pinggang dan punggung berfungsi menahan tubuh menjadi tegak dan menyanggah sebagian berat badan.

Keluhan pada pinggang dan punggung muncul akibat postur kerja yang tidak ergonomis⁸⁰ seperti melakukan kegiatan membungkuk dikarenakan Subjek melakukan aktifitas menulis atau mengetik menggunakan laptop. Begitupula bagian leher dirasakan paling sering mengalami keluhan muskuloskeletal dikarenakan mahasiswa sering menundukkan kepalanya selama proses belajar dalam posisi duduk atau membaca dalam posisi tiduran dengan bantal penahan leher yang tidak tepat dan dalam durasi yang cukup lama.

⁸⁰ Istilah ergonomi berasal dari bahasa latin yaitu *ergon* (kerja) dan *nomos* (hukum alam) dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau menurut anatomi, fisiologi, psikologi, mesin, manajemen dan desain. Ergonomi juga disebut sebagai *human factors* karena saling berinteraksi dengan lingkungan dan fasilitas kerjanya. Lih Binarfika Maghfiroh Nuryaningtyas dan Tri Martiana, “Analisis Tingkat Risiko *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) dengan *The Rapid Upper Limbs Assessment* (RULA) dan Karakteristik Individu terhadap Keluhan MSDs”, *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, Vol. 3, No. 2, (2014); 160-169.

Gambar 4.2. Titik-titik beresiko pada penggunaan laptop⁸¹

Postur tubuh yang tidak seimbang dan berlangsung lama dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan stres postural pada bagian tubuh tertentu dan kurangnya istirahat pada bagian tubuh tertentu.⁸² Keluhan pada muskeleskeletal yang dirasakan mahasiswa memang diakibatkan aktifitas fisik namun demikian beberapa riset juga menyebutkan bahwa keadaan stres dapat memicu terjadinya *low back pain* (nyeri ringan di bagian punggung) seperti riset yang dilakukan oleh Reene Shibukawa (2011) yang menyebutkan bahwa karyawan dengan stres kerja memiliki risiko untuk mengalami *low back pain* sejumlah 4.93 lebih besar dibandingkan karyawan yang tidak mengalami stres kerja.⁸³

Hubungan antara stres dengan keluhan muskuloskeletal dalam dunia akademik dibuktikan dalam riset yang dilakukan oleh Ekpenyong et al (2013) terhadap 1365 mahasiswa S1 di Universitas Nigeria dimana hasil studi menunjukkan bahwa stres yang diakibatkan oleh stresor akademik memiliki pengaruh signifikan terhadap *musculoskeletal disorders* (MSDs) pada mahasiswa. Keluhan ini lebih

⁸¹Hendra dan Devie Fitri Octaviani, “Keluhan Kesehatan Akibat Penggunaan Laptop pada Mahasiswa FKM UI” diakses dari [https://www.acedmia.edu/25789238/Keluhan Kesehatan Akibat Penggunaan Laptop pada Mahasiswa FKM UI](https://www.acedmia.edu/25789238/Keluhan%20Kesehatan%20Akibat%20Penggunaan%20Laptop%20pada%20Mahasiswa%20FKM%20UI) hendra Devie Fitri Octaviani, pada tanggal 18 Agustus 2017, pukul 14.02.

⁸²Stephen Pheasant, *Body Space 2nd Edition*, (Philadephia: Taylor & Francis, 2003), 68.

⁸³Reene Shibukawa dalam Arifandhy Teguh Wijaya, Risqa Rina Darwita dan Armasastra Bahar, “The Relation between Risk Factors and Musculoskeletal Impairment in Dental Students: a Preliminary Study”, *Journal of Dentistry Indonesia*, Vol. 18, No. 2, (2011); 33-37.

tinggi ketika mahasiswa sedang mengikuti ujian semester kampus dibandingkan sebelum dan sesudah ujian.⁸⁴

Indikasi fisiologis selain dari pada keluhan muskuloskeletal, penulis juga menemukan hasil wawancara yang mengungkapkan bahwa secara fisiologis stres yang terjadi membuat mahasiswa sering merasakan sakit dan nyeri kepala. Terkait indikasi stres sakit kepala penulis tidak melakukan penelitian secara klinis, hasil indikasi hanya didapati dari beberapa keluhan responden, salah satunya Subjek H dirinya mengemukakan seringkali merasakan sakit kepala di bagian tengah kepala sebelah kiri dan kepala bagian belakang, sakit pada bagian-bagian tersebut meskipun tidak dirasakan secara permanen namun dirinya menjelaskan seringkali merasakan sakit secara berulang.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa Subjek lainnya yang terindikasi stres tinggi, tiga orang menyatakan dirinya secara medis memiliki penyakit kepala migrain. Meskipun penulis tidak melakukan penelitian korelasi antara stres dan penyakit migrain dan nyeri kepala lainnya, namun beberapa penelitian menjelaskan hubungan keduanya, seperti riset yang dilakukan oleh Tandaju et al (2016) menjelaskan bahwa keluhan nyeri kepala primer pada mahasiswa angkatan 2013 Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado dari 176 responden terbukti sebanyak 64% mahasiswa memiliki tipe nyeri kepala tegang dan 20% migrain tanpa aura, 15% migrain dengan aura dan 1% nyeri kepala klaster. Studi ini menunjukkan bahwa stres memicu 84% dari kasus nyeri kepala.⁸⁶ Begitupula studi pada mahasiswa kedokteran di Kuwait University didapati bahwa 43 orang (24,9%) dari 621 mahasiswa menyatakan

⁸⁴Christopher E. Ekpenyong, Nyebuk E. Daniel dan Ekpe O. Aribio, "Associations between Academic Stressors, Reactions to Stressm Coping Strategies and Musculoskeletal Disorders among College Students", *Ethiop Journal Health Science*, Vol. 23, No. 2, (2013); 98-112.

⁸⁵Wawancara dengan Subjek H (mahasiswi tahun ketiga dengan tingkat stres tinggi), pada hari Senin, Tanggal 20 Februari 2017, Pukul 09.30 WIB.

⁸⁶Yafet Tandaju, Theresia Runtuwene, Mieke A.H. N. Kembun, "Gambaran Nyeri Kepala Primer pada Mahasiswa Angkatan 2013 Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado", *Jurnal e-Clinic (eCI)*, Vol. 4, No. 1, (2016);1-4.

bahwa pemicu keluhan nyeri sakit kepala adalah akibat stres yang dihadapi.⁸⁷

Terkait indikasi fisiologis stres dengan nyeri sakit kepala beberapa literasi menyebutkan bahwa faktor pencetusnya adalah karena permasalahan atau gangguan istirahat dan tidur. Dalam penelitian ini gangguan tidur selanjutnya dikelompokkan pada indikasi stres perilaku, karena stres dapat mengubah perilaku seseorang. Sebagaimana Arora (2008) menyebutkan gejala perilaku orang stres diantaranya adalah kurang tidur atau akan tidur berlebihan, kehilangan nafsu makan atau akan makan berlebihan dan sering merokok.⁸⁸

4. Respon Perubahan Perilaku

Kegiatan akademik yang dijalani mahasiswa memang sebagian besar merubah perilaku dan pola tidur sebelum memasuki dunia kampus. Sebagaimana penelitian Gaultney (2010) menyebutkan 27% dari 1.845 mahasiswa yang ikut serta pada penelitiannya mengalami setidaknya satu jenis gangguan tidur dan yang paling sering dialami adalah jenis narkolepsi, hipersomnia, obstruksi henti nafas saat tidur, dan insomnia.⁸⁹ Beberapa riset lainnya juga menyebutkan adanya sindrome kegelisahan saat tidur.⁹⁰

Berbagai tuntutan dan kewajiban kampus seringkali membuat mahasiswa merasa tegang untuk dapat segera menyelesaikan semua tugas tepat waktu, ketegangan emosional tersebut membuat individu selalu terjaga dan sulit tidur, sering terbangun ketika tidur atau mungkin sebaliknya akan banyak tidur.⁹¹ Sebagaimana Subjek I yang mengungkapkan bahwa pada tahun ketiga ini dirinya merasa materi-

⁸⁷Jasem Y al-Hashel and others, "Migraine among Medical Students in Kuwait University", *The Journal of Headache and Pain*, Vol. 15, No. 26, (2014); 1-6.

⁸⁸Anjali Arora, *5 Langkah Mencegah dan Mengatasi Stres*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), 9.

⁸⁹Jane F. Gaultney, "The Prevalence of Sleep Disorders in College Students: Impact on Academic Performance", *Journal of American College Health*, Vol. 59, No. 2, (2010); 91-97.

⁹⁰Clete A. Kushida and others, "Symptom-based Prevalence of Sleep Disorders in an Adult Primary Care Population", *Sleep and Breathing*, Vol. 4, No. 1, (2000); 11-15.

⁹¹Potter Perry, *Fundamental Keperawatan Edisi 7 Buku 2*, (Jakarta: Salemba Medika, 2005), 68.

materi perkuliahan semakin banyak, tugas semakin sulit, aktifitas semakin padat. Dirinya menyebutkan karena semakin sibuk dengan segala hal terkait dengan perkuliahan di pagi dan siang hari, pola tidurnya bergeser biasanya ia tidur lebih awal namun ia memilih untuk tidur sepulang dari kampus kemudian bangun pada jam 21.00 WIB dan baru akan tertidur lagi sekitar jam 02.00 bahkan meskipun dirinya sudah berusaha keras memejamkan mata nampaknya ia perlu waktu lebih untuk lebih rileks dan baru tertidur pulas di bawah jam 03.00 dan harus terbangun lagi pagi di jam 06.00 pagi. Seringkali justru ketika ia terlalu padat melakukan aktifitas di siang hari, dirinya juga mengalami kesulitan untuk tidur di malam hari.⁹²

Dari hasil wawancara sebagaimana dikutip di atas terlihat bahwa durasi tidur Subjek I sangat pendek yakni kurang dari enam jam. Hal ini selaras dengan hasil riset yang menyebutkan prevalensi durasi tidur pada mahasiswa didapati lebih dari 40% dari mereka memiliki durasi tidur yang pendek yakni kurang dari tujuh jam.⁹³ Meskipun kebutuhan durasi tidur berbeda bagi setiap individu namun beberapa literasi riset menyebutkan durasi tidur yang kurang dari 6-7 jam/hari akan menyebabkan gangguan produktifitas di siang hari, gangguan neurokognitif dan psikomotorik (seperti perhatian, konsentrasi, memori, kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis), dan penurunan performa dan prestasi akademik.⁹⁴

Selanjutnya beberapa riset yang dilakukan terkait permasalahan tidur khususnya di kalangan mahasiswa kedokteran mengungkapkan bahwa stres, kecemasan dan simptom depresi merupakan

⁹² Wawancara dengan Subjek I (mahasiswi tahun ketiga dengan tingkat stres tinggi), pada hari Selasa, Tanggal 8 Februari 2017, Pukul 12.30 WIB.

⁹³ Daniel J. Taylor dan Adam D. Mramoweth, "Patterns and Consequences of Inadequate Sleep in College Students: Substance Use and Motor Vehicle Accidents", *Journal of Adolescent Health*, Vol. 46, No. 6, (2010); 610-612.

⁹⁴ Hanan Ez ElArab, Menan A.M. Rabie dan Dalia H.Ali, "Sleep Behavior and Sleep Problems among Medical Students Sample in Relation to Academic Performance: a Cross-Sectional Questionnaire-Based Study", *Middle East Current Psychiatry*, Vol. 21, (2014); 72-80.

faktor pencetus kesulitan tidur terjadi di kalangan mereka.⁹⁵ Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rafknowledge (2004) bahwa stres berat sangat berhubungan dengan kualitas dan durasi tidur yang lebih pendek.⁹⁶ Hubungan antara stres dan kesulitan tidur dapat dipahami karena tubuh manusia secara otomatis memiliki mekanisme pertahanan diri sebagai respon terhadap stres yang sedang dihadapi. Reaksi cemas, sedih dan berbagai emosi lainnya dalam waktu yang bersamaan membuat individu tidak lagi merasa mengantuk, otak bersiaga penuh dan beberapa anggota tubuh tidak dapat beristirahat dan siap menghadapi tantangan. Apabila stres berkepanjangan dapat menyebabkan kebiasaan tidur yang buruk.

Kebiasaan buruk dan gangguan tidur sebaiknya cepat di atasi karena tidur merupakan salah satu kebutuhan hidup yang banyak sekali manfaatnya. Tidur memiliki manfaat dan dampak yang cukup besar terhadap biologis, fisiologis, dan kekuatan mental karena menyebabkan keseimbangan energi di dalam otak.⁹⁷ Ketika tidur beberapa hormon seperti epineprin, serotonin dan hormon pertumbuhan dilepaskan dan beberapa perubahan kimiawi terjadi yang kemudian menambah perkembangan jaringan-jaringan sel, menjadi nutrisi dan sumber energi untuk esok hari. Begitupula ketika tidur otak melakukan pengorganisasian ulang terhadap informasi yang sudah diterima selama seharian, otak mendapat asupan dan suplai oksigen dengan optimal dan terjadi pemulihan memori dan fungsi kognitif lainnya.⁹⁸

Manfaat tidur juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, menurutnya ada dua manfaat besar tidur. *Pertama*, tidur mengistirahatkan anggota badan dari kelelahan dan untuk membantu proses pencernaan

⁹⁵Renu Lohitashwa, and others, "Effect of Stress on Sleep in Quality in Young Adults Medical Students: a Cross Sectional Study", *International Journal of Research in Medical Sciences*, Vol. 3, No. 12, (2015); 3519-3523.

⁹⁶Rafknowledge, *Insomnia dan Gangguan Tidur Lainnya*, (Jakarta, Gramedia, 2004), 23.

⁹⁷Usaf Aslani and others, "Sleep Disorders in Patients with Congestive Hearth Failure Hospitalized in Hajar Hospital, Shahrekord 2003, *Journal Shahrekord University Medical Sciences*, Vol. 9, No. 1, (2007); 44-49.

⁹⁸M. Zakerimoghdam, and others, "Comparison of effective Factors on Sleeping the Nurses and Hospitalized Patients' Viewpoints", *Journal of Hayat*, Vol.12, No. 2, (2006); 4-12.

makanan, karena suhu panas yang muncul ketika tidur akan meresap ke perut dan membantu proses pencernaan terhadap makanan. *Kedua*, tidur juga bermanfaat sebagai sarana untuk mengembalikan semangat baru dalam beramal dan beribadah setelah merasa capek.⁹⁹ Dalam a-Qur'an sendiri disebutkan beberapa ayat yang secara jelas menggunakan kata *naum* (tidur dalam bahasa Arab) sebagai waktu beristirahat anggota tubuh sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Furqon ayat 47 dan surah an-naba' ayat 9:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ تُشُورًا ﴿٤٧﴾

Artinya:

“Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha”. (Al-Furqon: 47)

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾

Artinya:

“Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat”. (An-Naba': 9)

Melalui dua ayat di atas dan beberapa ayat lainnya terkait dengan tidur seperti Q.S. ar-Rum: 23,¹⁰⁰ Q.S. al-Anfal: 43,¹⁰¹ dan az-Zumar: 42¹⁰² menegaskan bahwa dalam tidur terdapat banyak

⁹⁹Ibnu Qayyim dalam Abu Abdillah Syahrul Fatwa al-Atsari, *Sifat Tidur Nabi SAW*, (Bogor: Media Tarbiyah, 2014), 27.

¹⁰⁰Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan”*.(Q.S. ar-Rum: 23)

¹⁰¹Artinya: *“(yaitu) ketika Allah Menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu (berjumlah) sedikit. dan Sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu (berjumlah) banyak tentu saja kamu menjadi gentar dan tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati”*. (Q.S. al-Anfal: 43)

¹⁰²Artinya: *“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; Maka Dia*

manfaat dan tanda-tanda kebesaran Allah. Manfaat tidur sangat besar dalam membantu pemenuhan kesehatan, ia menjadi sarana terbaik dan mudah untuk dilakukan serta memberikan kenyamanan bagi individu setelah terbangun dari tidur. Jadi individu yang mengalami gangguan tidur karena tingkat stres yang dimilikinya memiliki potensi lebih besar perubahan pada fungsi tubuh dan perilaku keseharian lainnya. Seseorang yang kurang cukup menjalani tidur jenis REM¹⁰³ maka esok harinya akan menunjukkan kecenderungan untuk hiper-

tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir”.(Q.S. az- Zumar: 42)

¹⁰³Tidur merupakan proses alamiah yang terjadi bergantian dengan bangun selama 24 jam. Ada dua jenis tidur Non Rapid Eye Movement (NREM) dan Rapid Eye Movement. 1) NREM merupakan tahap tidur yang tenang, ditandai dengan denyut jantung dan frekuensi pernapasan yang stabil dan melambat serta tekanan darah yang rendah. Tidur NREM terbagi pada empat tahap, tahap pertama tidur ringan: individu masih dapat mengingat pergerakan tidur dan halusinasi sebelum tidur. Pernafasan melambat, detak jantung melambat dan tekanan darah turun, temperatur otak naik dan aliran darah ke otak meningkat. Ketika seseorang terbangun pada tahap ini artinya dia memang belum tidur sama sekali. Tahap ini berlangsung 5 sd 10 menit. Tahap kedua tidur sebenarnya: pada tahap ini tingkat kesadaran akan lingkungan luar akan menghilang tapi individu akan mudah terbangun karena bunyi dari luar atau temperatur udara sekitar. Tahap ini terjadi antara 5 sd 15 menit. Tahap ketiga tidur lebih pulas: tahap ini individu tertidur lebih dalam dan perlu usaha lebih untuk membangunkannya dan walaupun ia terbangun dia tidak bisa mengingat kejadian tidurnya sendiri. Tahap ini juga berlangsung antara 5 sd 15 menit dan tahap keempat tidur terpulsa: tahap ini aktifitas dan fungsi tubuh menurun signifikan, sangat sulit membangunkan seseorang pada tahap ini. Orang yang terbangun pada tahap ini akan mengalami kesulitan ketika berdiri. 2) REM tidur ini ditandai dengan pergerakan mata, hilangnya kekuatan otot dan mimpi yang tampak nyata. REM ini disebut juga aktivitas otak yang tinggi dalam tubuh yang lumpuh atau paradoks. Lihat Mohammad Reza Heidari, Reza Norouzadeh dan Mohammad Abbasi, “Sleep in the Qur’an and Health Sciences”, *Health, Spiritual Med Ethics*, Vol. 1, No. 1, (2014); 30- 36.

aktif, kurang dapat mengendalikan diri dan emosi, nafsu makan bertambah dan menjadikan diri kurang gesit di hari berikutnya.¹⁰⁴

Hubungan pola tidur dan pola makan akibat stres pada umumnya memang terjadi beriringan. Kedua indikasi perubahan perilaku ini dapat terlihat dengan jelas. Meskipun beberapa Subjek menyatakan dirinya tidak mengalami perubahan banyak makan sebaliknya kurang makan tapi hampir semua Subjek menyatakan bahwa terjadi pergeseran pola dan waktu makan akibat rutinitas perkuliahan. Hal ini selaras dengan hasil studi pada mahasiswa kedokteran di Sudan dimana hasil riset menjelaskan meskipun asupan makan pada mahasiswa kedokteran masih terbilang normal, namun frekuensi makan seperti sarapan, *snack*, makan siang dan makan malam terjadi pergeseran waktu, hal ini dikarenakan kendala waktu antara waktu makan dan tingginya tingkat aktivitas kampus.¹⁰⁵ Hal ini dapat dipahami bahwa terkadang memang akibat stres muncul nafsu makan berlebih namun tidak sampai pada status gizi gemuk/obes dan seringkali justru akibat stres nafsu makan berkurang tapi tidak sampai memiliki status gizi kurus. Namun demikian terdapat beberapa riset lainnya yang menunjukkan hubungan antara morbiditas seperti stres, depresi dan ansietas pada remaja seperti penelitian di Riau yang menjelaskan dari 132 Subjek yang ikut serta pada penelitian tersebut 66 orang Subjek memiliki status obes dan 66 responden lainnya memiliki status gizi kurus. Hasil analisis menggunakan *chi-Square* menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan bermakna antara depresi dengan obesitas dan stres dengan obesitas.¹⁰⁶

¹⁰⁴Potter Perry, *Fundamental Keperawatan Edisi 7 Buku 2*, (Jakarta: Salemba Medika, 2005), 53.

¹⁰⁵Malak Eisa Abdalla al-Haj and others, "Eating Habits among Medical Students in a Sudanese Medical faculty", *International Research Journal of Medicine and Medical Sciences*, Vol. 3, No. 3, (2015); 64-69.

¹⁰⁶Hariatul Masdar and others, "Depresi, Ansietas, dan Stres serta Hubungannya dengan Obesitas pada Remaja", *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, Vol. 12, No. 4, (2016);138-143.

C. Efektifitas Spiritualitas dalam Pertahanan Diri dari Stres Akademik

1. Implementasi Spiritualitas melalui Keterhubungan dengan Tuhan

Menurut McDonald dan Gorsuch (2012) ketika seseorang menghadapi potensi stresor, pertama dia akan mencari dan melihat sumber daya yang ada untuk memecahkan masalahnya.¹⁰⁷ Kemudian berdasarkan teori *conservation of resources* (CRS) tekanan psikologis seperti stres seringkali terjadi ketika sumber signifikan dalam diri individu hilang.¹⁰⁸ Lantas apa sumber psikologis tersebut?. Para ahli pastinya berbeda pendapat akan hal ini berdasarkan hasil riset yang telah mereka lakukan. Para ahli sains sosial dan psikologi menemukan bahwa stres berhubungan dengan *personal resources* (sumber daya diri) seperti kontrol diri, efikasi diri, serta persepsi dan *social resources* (seperti dukungan emosional, bantuan dari teman dan keluarga), kedua sumber ini dapat menjadi penyanggah pengaruh negatif dari stres harian dalam hidup.¹⁰⁹ Dengan demikian sumber pertahanan stres bisa berasal dari dalam diri (internal) dan dari luar diri (eksternal). Sumber internal dalam kajian psikologis lebih dikenal dengan istilah *psychological resources* (sumber-sumber psikologis).

Selanjutnya munculnya psikologi positif sebagai kajian modern dalam dunia psikologi diharapkan dapat mendorong manusia untuk menyadari sifat-sifat positif yang dimilikinya, termasuk ketika individu mengalami tekanan dan tuntutan hidup. Pada hakikatnya psikologi positif menyakini ada sumber potensi psikologis (*positive psychological resources*) dari dalam dirinya sendiri yang dapat menjadi penyanggah terjadinya stres. Dalam konteks akademik McCarthy et al (2006) menjelaskan ketika mahasiswa meyakini dirinya memiliki sumber psikologis positif maka dirinya akan terlindungi dari stres

¹⁰⁷Ana Wong McDonald dan Richard Gorsuch, "Surrender to God: an Additional Coping Style?", *Journal of Psychology and Theology*, Vol. 28, No. 2, (2012); 149.

¹⁰⁸Naiemah Seyedfatemi, Maryam Tafreshi dan Hamid Hagani, "Experienced Stressors and Coping Strategies among Iranian Nursing Students", *BMC Nursing*, Vol. 6, No. 11, (2007).

¹⁰⁹Celeste Alvaro, "Conservation of Resources Theory and Research Use in Health Systems", *Implementation Science*, Vol. 5, No. 79, (2010); 1-20.

akibat stresor dan akan memiliki kehidupan akademik yang lebih sehat.¹¹⁰

Selaras dengan pandangan humanistik-eksistensial sumber psikologis haruslah berupa sumber bernilai dalam hidup, kemudian spiritualitas diakui menjadi salah satu sumber psikologis yang sangat penting dalam hidup disamping aspek kepribadian, efikasi diri dan persepsi. Spiritualitas merupakan aspek penting dalam hidup karena menurut Simpson dan Weiner (1991) dalam kamus bahasa Inggris Oxford setidaknya menawarkan dua definisi spiritualitas, pertama: spiritualitas merujuk pada aspek terpenting bagi hidup seseorang yang dalam bahasa Latin diartikan dengan “nafas”, kedua: spiritualitas dimaknai sebagai fitur subjektif dalam hidup sebagaimana perasaan seperti pendengaran dan penglihatan. Dimana fungsi perasa ini sangat penting bagi kehidupan, maka begitupula fungsi spiritualitas dalam hidup.¹¹¹

Spiritualitas memberikan pandangan tentang hidup dan bagaimana seharusnya hidup.¹¹² Melalui spiritual individu bisa memaknai apa yang terjadi di balik kejadian hidupnya.¹¹³ Hasil riset dari beberapa ahli psikologi membuktikan bahwa spiritualitas mampu memberikan sumbangan positif terhadap kesehatan individu, seperti studi yang dilakukan oleh Gracie et al (2006). Hasil studi penelitian tersebut menjelaskan bahwa spiritualitas dan religiusitas dapat menekan stres yang dirasakan akibat penyakit kronis.¹¹⁴ Sementara studi

¹¹⁰Christopher J. McCarthy and others, “Psychological Resources as Stress Buffers Their Relationship to University Students’ Anxiety and Depression”, *Journal of College Counseling*, Vol. 6, (2006); 99-112.

¹¹¹Simpson dan Weiner (1991) dalam Hena Jawaid, “Impact of Religion/Spirituality on Health: What are the Evidences?”, *African Journal of Psychiatry*, Vol. 17, No. 6, (2014); 1-5.

¹¹²Daniel A. Helminiak, “Treating Spiritual Issues in Secular Psychotherapy”, *Counseling and Values*, Vol. 45, No. 3, (2001); 163-189.

¹¹³Timothy B. Smith, Michael McCullough dan Justin Poll, “Religiousness and Depression: Evidence for a Main Effect and the Moderating Influence of Stressful Life Events”, *Psychological Bulletin*, Vol. 129, No. 4, (2003); 614-636.

¹¹⁴Gracie H. Boswell, Eva Kahana, Peggye Dilworth Anderson, “Lifestyle Behaviors: Stress Counter-Balancing Effect on the Well-Being of

pada 303 mahasiswa jurusan psikologi di Universitas Midsize menunjukkan hasil bahwa spiritualitas terbukti secara signifikan memoderasi hubungan antara pengalaman hidup negatif dengan depresi dan ansietas, spiritualitas juga berhubungan positif dengan penyesuaian diri.¹¹⁵

Menurut Pargament et al (1998) spiritualitas dapat menurunkan tingkat stres tidak hanya pada kalangan tertentu seperti pasien kronis tapi juga pada berbagai kalangan lainnya seperti pelajar perguruan tinggi dan para pegawai dengan tingkat profesi stres cukup tinggi. Spiritualitas dapat memberikan keteguhan akan makna dari berbagai pengalaman-pengalaman hidup.¹¹⁶ Selaras dengan pengalaman Subjek D yang menyatakan bahwa meskipun dirinya pada Sekolah Menengah Umum (SMU) duduk di kelas unggulan dengan notabene siswa-siswa jenius, namun hasil akhir UN tidak memuaskan, test SNMPTN gagal, SBMPTN juga gagal bahkan test di perguruan swasta juga gagal meluluskan keinginannya untuk duduk di bangku kuliah ilmu kedokteran. Kecewa iya! Tapi dirinya tetap yakin bahwa Allah bukan membenci diri dan usahanya. Menurutny Allah hanya ingin dia berusaha dan belajar lebih. Sehingga pada akhirnya di tahun kedua setelah sempat duduk di bangku kuliah ilmu Kimia di perguruan tinggi swasta di Semarang, Subjek lulus pendidikan dokter bahkan di dua perguruan tinggi swasta sekaligus. Sehingga Subjek menyatakan akan memanfaatkan kesempatan studi ini sebaik mungkin, karena pada akhirnya Allah mengabulkan niat dan keinginan besar dalam hidupnya.¹¹⁷

Ungkapan jujur Subjek D yang menyebutkan dirinya kecewa dan sedih akan hasil akhir dari segala usahanya merupakan sesuatu

Older Adults", *Journal of Religion and Health*, Vol. 45, Np. 4, (2006), 587-602.

¹¹⁵J Scott Young, Graig S. Cashwell, dan Julia Shcherbakova, "The Moderating Relationship of Spirituality on Negative Life Events and Psychological Adjustmen", *Counseling and Values*, Vol. 45, No. 1, (2000); 49-57.

¹¹⁶Kenneth I. Pargament and others, "Patterns of Positive and Negative Religious Coping with Major Life Stressors", *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 37, No. 4, (1998); 710-724.

¹¹⁷Wawancara dengan Subjek D (mahasiswa tahun pertama dengan tingkat stres rendah), pada hari Jum'at, Tanggal 17 Februari 2017, Pukul 10.00 WIB.

yang wajar dialami manusia. Namun kemudian Subjek D masih memiliki keyakinan dan prasangka baik terhadap Tuhan, mekanisme inilah kemudian disebut dengan pertahanan spiritual. Menurut Adz-Zaky (2001) ketahanan spiritualitas akan menghasilkan daya tahan mental yang kokoh dan kuat dalam menghadapi pelbagai problem hidup dan kehidupan.¹¹⁸

Subjek D juga menunjukkan sifat keteguhan dan optimis yang baik, hal ini menegaskan bahwa Subjek memiliki tingkat spiritual yang baik, karena menurut Ṣālih Ibn ‘Abd Allāh individu yang memiliki masalah spiritualitas akan memiliki sifat dan perilaku negatif seperti putus harapan (*al-jaza’*), buruk sangka (*su’ al-zann*), ragu-ragu (*al-shakk*), terburu-buru (*al-‘ajalah*), putus asa (*al-ya’s*), pesimis (*al-Qunūt*), terhina (*al-wahn*), mengikuti hawa nafsu (*ittiba’ al-hawā*), lemah (*al-da’f*), merasa gagal (*al-ihbāt*), takut (*al-khauf*) dan was-was (*al-waswasah*).¹¹⁹

Menurut analisis penulis Subjek D tidak mengalami stres pada kegagalannya karena Subjek berhasil melakukan refleksi diri terkait hal tersebut, Subjek berpendapat dirinya gagal karena usahanya belum maksimal dan sekiranya dirinya dapat lebih keras berusaha maka kemungkinan besar dirinya dapat lulus pada test tahun yang akan datang. Al-Ghazali dalam bukunya *Mizan al-‘Amal* dan *Kimia’ al- Sa‘adah* menjelaskan bahwa kemampuan refleksi (*tafakur*) merupakan satu diantara kemampuan sensorik internal manusia. *Tafakur* berfungsi untuk mengumpulkan kembali makna-makna yang sulit untuk diraba secara fisik menjadi makna non-fisik. Daya refleksi ini terletak di bagian tengah otak (*parient lobe*).¹²⁰

¹¹⁸Hamdani Bakran adz-Dzaky, *Psikoterapi dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 1-2.

¹¹⁹Ṣālih Ibn ‘Abd Allāh, *Naḍrah al- Na‘īm fī Makārim al- Akhlāq al- Rasūl al- Karīm*, (tt), 5338.

¹²⁰Al-Ghazali menjelaskan manusia memiliki kemampuan sensorik kompresif (*mudrikah*) yang digunakan untuk mempersepsi bahaya dan apa yang baik untuk dirinya. Sensorik ini terdiri dari sensorik luar dan sensorik dalam. Sensorik luar adalah pendengaran, penglihatan, peraba, sensor aroma, dan organ indera lainnya. Sementara sensorik dalam terdiri dari imajinasi (*mutakhayyilah*); daya sensor yang berfungsi untuk memelihara objek yang telah hilang di hadapan indera luar, refleksi (*tafakur*); kemampuan mengumpulkan kembali makna-makna yang sulit untuk diraba secara fisik menjadi

Ketahanan spiritualitas pada Subjek D juga menggiringnya menjadi pribadi yang pandai mengambil pelajaran dan memahami apapun dengan baik, hal ini ditegaskan dengan ungkapan Subjek bahwa kegagalan yang didapati bukan karena kebencian Tuhan pada dirinya, namun Tuhan hanya ingin dirinya bekerja keras. Sebaliknya apabila individu memiliki kelemahan dalam pertahanan diri melalui spiritualitas ini, maka dirinya tidak akan bisa mengambil pelajaran dari kejadian hidup yang dilalui. Keadaan ini sebenarnya sudah ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 126 yang berbunyi:

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٦﴾

Artinya:

“Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali Setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?” (Q.S. at- Taubah: 126)

Terkait tafsiran ayat ini, at- Ṭabari menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki penyakit hati mereka tidak akan memahami makna dan tujuan Allah atas kejadian-kejadian berupa musibah, kelaparan, penyakit dan sebagainya seperti kegagalan yang menimpa mereka.¹²¹ Ayat ini menjelaskan individu tanpa pertahanan spiritualitas yang baik maka akan melihat kejadian dalam hidupnya secara negatif, sementara individu dengan ketahanan spiritualitas yang baik justru sebaliknya akan melihat segala sesuatu secara posi-

makna non-fisik , dan ingatan (*ḥafīzah*); daya kognisi yang berfungsi untuk menyimpan kesan dan impresi yang diterima oleh indra luar. Sensor luar dan dalam ini membantu manusia untuk mempelajari masa lalu dan menghindari situasi di masa yang akan datang. Lih Hasan Amer, *The Psychology of al-Ghazali*, (Ttp: Akadimiyah al-Qasimi, 2006), 1-6.

¹²¹ Abu Ja'far al- Ṭabari, *Jami' al- Bayan fi Ta'wil al- Qur'an* Jilid 14, (Mu'assasah al- Risalah, 2000), 582.

tif. Selanjutnya orang yang berpikir positif dapat menjadi lebih rileks dan dapat mengontrol stres dengan baik.¹²²

Ketahanan spiritualitas Subjek D dari kejadian stres meskipun gagal pada ujian tahun pertamanya, hal tersebut juga dikarenakan dirinya masih memiliki harapan (*hope*) dan optimisme tinggi untuk bisa lulus di tahun berikutnya. Optimisme pada Subjek A ini menurut Lin et al (2010) dikarenakan dirinya berpikir positif sebagaimana menurut mereka pikiran positif dapat meningkatkan optimisme dalam diri, memperbaiki dan mempermudah aktifitas. Begitu pentingnya pola pikir positif ini dapat mempertahankan kesehatan mental dan fisik.¹²³ Mengurangi pikiran negatif sama saja seperti meningkatkan antidepresi alami di dalam tubuh.¹²⁴

Ketahanan mental yang sehat pada Subjek D selaras dengan landasan teori yang dikemukakan penulis pada bab sebelumnya bahwa menurut Mujib dan Mudzakir (2002) dalam buku "*Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*", individu dengan pertahanan spiritualitas akan memiliki kesehatan mental yang tenang. Menurut penulis karakteristik jiwa yang tenang yang dideskripsikan oleh kedua ahli Psikologi Islam ini dapat teridentifikasi pada Subjek D.¹²⁵

Sebaliknya dalam perspektif Islam sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa diantara indikasi orang yang stres menurut Baqutayan salah satunya adalah kehilangan harapan "*ya'as*/"

¹²²Gilbert dan Orlick, "Teaching Skills for Stress Control and Positive Thinking to Elementary School Children", *Journal of Excellence*, Vol. 7, No. 1, (2007); 1.

¹²³Lin and others, "The Relationship between Optimism and Life Satisfaction for Patients Waiting or Not Waiting for Renal Transplantation", *Transplantation Proceedings*, Vol. 42, No. 3, (2010); 763-765.

¹²⁴Fava and others, "Hostility Changes Following Antidepressant Treatment: Relationship to Stress and negative Thinking", *Journal of Psychiatric Research*, Vol. 30, No. 3, (1999); 349-362.

¹²⁵Berdasarkan landasan teori pada bab sebelumnya, Subjek D dinyatakan memiliki kondisi mental yang tenang dikarenakan: (a) Subjek D mampu menyerahkan kembali makna kegagalannya kepada Allah, (b) Subjek D juga dapat mengambil hikmah dibalik kegagalannya, meskipun kegagalan menjadi hal yang tidak disukai semua orang, (c) Subjek D meskipun gagal dalam ujian, dirinya dapat bersabar, (d) Subjek D masih memiliki rasa optimistik bahwa kegagalannya suatu saat akan membawa dirinya pada keberhasilan di masa yang akan datang.

(despair)". Sebaliknya harapan merupakan determinan penting dalam mekanisme koping spiritualitas.¹²⁶ Harapan juga memberikan implikasi kepada kesehatan emosi seseorang yang berperan dalam proses penafsiran kognitif.¹²⁷ Dalam penelitian pengobatan psikosomatik harapan memiliki efek memperbaiki dan mempercepat kesembuhan.¹²⁸ Begitupula riset menemukan bahwa individu dengan harapan yang tinggi cenderung bisa mencari makna dan manfaat dari kesulitan dan kejadian traumatis.¹²⁹

Mekanisme pertahanan spiritualitas pada Subjek A mengarah pada dimensi transenden, dimana selaras dengan hasil kuantitatif dimensi transenden lebih dominan dalam pembentukan variabel spiritualitas pada mahasiswa. Pada dimensi transenden ini jawaban partisipan didominasi oleh perasaan keterhubungan dengan Tuhan (*connectedness*), do'a dan beribadah, serta tenang (*comfort*) ketika mengingat Tuhan. Beberapa riset menjelaskan bahwa keterhubungan manusia dengan Tuhan memberikan peran penting pada proses coping. Orang yang terhubung dengan Tuhan menunjukkan rendahnya kesendirian, depresi, kecemasan, penyakit fisik, dan tingginya kepuasan hidup.¹³⁰ Lindholm (2007) menemukan mahasiswa dengan

¹²⁶Harapan merupakan bangunan kognisi yang meliputi motivasi seseorang untuk mencapai tujuan dan persepsi kemampuan diri untuk dapat mencapai tujuan tersebut di kemudian waktu. Lih Charles R. Synder, David R. Sigmon dan David B. Feldman, "Hope for the Sacred and Vice versa: Positive Goal-Directed Thinking and Religion", *Psychological Inquiry*, Vol. 13, (2002); 234-238.

¹²⁷Charles R. Synder, "Hope Theory: Rainbows of the Mind", *psychological Inquiry*, Vol. 13, (2002); 249-275.

¹²⁸Johanna J. Mytko dan Sara J. Knight. "Body, Mind and Sprit: towards the Integration of Religiosity and Spirituality in Cancer Quality of Life Research", *Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer*, Vol. 8, No. 5, (1999); 439-450.

¹²⁹Susan Nolen- Hoeksema dan Christopher Davis, "Positive Responses to Loss: Perceiving Benefits and Growth", dalam Christopher R. Synder dan Shane J. Lopez, *Handbook of Positive Psychology*, (New York: Oxford University Press, 2002). 598.

¹³⁰Terry Lyn Gall and others, "Understanding the Nature and Role of Spirituality in Relation to Coping Health: A Conceptual Framework:", *Canadian Psychological Association*, (2005); 9-10.

tingkat spiritualitas dan keterhubungan yang tinggi dengan Tuhan akan lebih mudah melakukan koping ketika menghadapi kesulitan.¹³¹

Bentuk koping spiritualitas dalam dimensi keterhubungan (*connection*) memunculkan perasaan mencintai dan dicintai Tuhan, menyayangi dan disayangi Tuhan, serta dijaga oleh Tuhan ketika menghadapi keadaan yang mengancam atau tidak menyenangkan seperti situasi penuh stres. Hal ini selaras dengan pandangan ‘Uthman al- ‘Āmir keterhubungan dengan Tuhan merupakan bagian dari spiritualitas yang dengannya individu akan merasakan dekat dengan Tuhannya, merasakan sensasi seolah bersama-Nya di setiap waktu dan tempat. Dirinya merasa dalam pengawasannya sehingga muncul rasa takut kepada-Nya, senantiasa baik sangka pada-Nya dan selalu percaya bahwa Allah akan menolongnya.¹³² Dengan demikian pada dimensi keterhubungan ini, Tuhan dapat dirasakan sebagai pesona yang Maha Hadir, Maha Mendengar dan Maha Mutlak sehingga individu merasa seolah berbicara dan berkomunikasi bahkan berkeluh kesah pada seseorang. Keyakinan dan perasaan kemahadiran Tuhan inilah yang kemudian akan memberikan kekuatan, pengendalian dan juga kedamaian hati, seseorang yang bersangkutan senantiasa berada dalam kumparan orbit ilahiyah, bukan polarisasi dunia yang tidak jelas ujung pangkalnya.¹³³

Menurut Benner (1998) manusia tidak memiliki komponen kepribadian khusus untuk dapat berhubungan dengan Tuhan.¹³⁴ Bahkan menurut Willard (1999) manusia memang didesain agar dapat berhubungan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Individu yang terpu-tus dengan Tuhannya akan mengalami ketidakwajaran sebagaimana

¹³¹Jennifer A. Lindholm, “Spirituality in the Academy: Reintegrating our Lives and the Lives of our Students”, *About Campus*, Vol. 12, No. 4, (2007); 10-17.

¹³²‘Uthmān al- Āmir, *Mas’ūliyah al- Muthaqqaf al- Islāmī Tujāh Qaḍaya al- Irḥāb*, (al- Maktabah al- Shamilah, V.3.28), 3.

¹³³Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta: Media Cita, 2002), 102.

¹³⁴David Benner, *Care of Souls*, (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1998), 62.

manusia mestinya.¹³⁵ Menurut Hamdan adz-Dzaky problematika antara individu dengan Tuhannya dapat menghasikan keadaan stres dan depresi. Karena dirinya kehilangan sandaran kehidupan, menurutnya konektifitas dengan Tuhan akan menghasilkan ketahan mental dalam menjalani hidup.¹³⁶

Dimensi keterhubungan ini menurut Mitroff dan Denton (1999) dapat diartikan sebagai perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya.¹³⁷ Dimensi keterhubungan dengan Tuhan merupakan bagian yang sangat penting dalam spiritualitas. Hasil wawancara dengan Subjek F dirinya mengungkapkan bahwa meskipun dirinya menyadari tidak semua yang dia inginkan lalu didapatkan, namun dirinya tetap yakin bahwa Allah suatu saat akan memberikan sesuatu yang lebih, sehingga dirinya termotivasi untuk kembali dekat pada-Nya dan meningkatkan ibadah dan doa, karena yakin Allah mendengar semua do'a-do'a yang dipanjatkannya. Ketika Subjek ditanya terkait kesulitan yang dihadapi selama masa pendidikan dokter, individu menyebutkan seringkali dirinya dalam do'a mengeluhkan semua itu. Setiap kali selesai berdo'a dirinya merasa sedikit ringan dan merasa nyaman dari beban pikiran dan perasaan serta berbagai tekanan-tekanan akademik.¹³⁸

Subjek F menjelaskan bahwa spiritualitas memengaruhi pola pikirnya dalam menghadapi keadaan stres. Dirinya mampu meframe bahwa tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan bisa jadi Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Menurut McDonald dan Goursuch (2004) hubungan individu dengan Tuhannya tergantung pada pengetahuan dan konseptualisasi Tuhan menurut individu tersebut. Melihat Tuhan sebagai Sang Penuh Kebajikan, Omni (Maha Kuasa dan Maha dimana-mana), Pemberi Petunjuk, Maha Kuat, Maha Pengasih akan memotivasi orang yang beri-

¹³⁵Dalls Willard, *Hearing God: Developing a Conversational Relationship with God*, (Downers Groov, IL: InterVarsity Press, 1999), 20.

¹³⁶Hamdan Bakran Adz- Dzaky, *Psikoterapi dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 1-2.

¹³⁷Mitroff dan Denton, "A Study of Spirituality in the Workplace", *Sloan Management Review*, Vol. 40, No. 4, (1999); 83-92.

¹³⁸Wawancara dengan Subjek F (mahasiswi tahun ketiga dengan tingkat stres rendah), pada hari Rabu, Tanggal 8 Februari 2017, Pukul 09.30 WIB.

man tersebut untuk semakin dekat kepada Tuhan. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki imaginari tersebut kepada Tuhan tidak akan tertarik untuk dekat pada-Nya.¹³⁹

Konseptualisasi positif tentang Tuhan yang dimiliki oleh Subjek F memotivasi dirinya bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dirinya harus lebih dekat kepada Allah dengan meningkatkan doa dan lebih rajin beribadah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hubungan Tuhan dengan manusia memerlukan media dan mekanisme yang mengatur, salah satunya dimanifestasikan dalam bentuk ibadah seperti sholat dan do'a. Sebagaimana Van Leeuwen and others menegaskan bahwa individu yang memiliki spiritualitas yang baik harus melakukan suatu hal yang konkrit seperti ibadah, meditasi, membaca kitab suci, dan sebagainya.¹⁴⁰

McCullough (1995) menyebutkan seseorang yang senantiasa menjaga ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, akan memiliki ekspektasi positif tentang stres karena bisa menilai ulang peristiwa yang menegangkan dengan cara yang positif.¹⁴¹ McMahon dan Biggs (2012) menyebutnya dengan istilah "*spiritual devotion*/ ketaatan spiritual" untuk mengekspresikan individu yang senantiasa menjaga ibadah dalam keterhubungannya dengan Tuhan. Dimana *spiritual devotion* ini selanjutnya menjadi salah satu bentuk coping yang berhasil menekan tingkat stres.¹⁴² Sebaliknya menurut Rajab (2014) pengabaian terhadap ibadah atau ketidak taatan akan memberi efek negatif secara psikologis sehingga mengganggu kesehatan mental.¹⁴³

¹³⁹ Ana Wong Mc-Donald dan Richard Goursuch, "Surrender to God: an Additional Coping Style", *Journal of Psychology and Theology*, Vol. 32, No. 4, (2004); 318-334.

¹⁴⁰ Van Leeuwen and others. "Aspects of Spirituality Concerning Illness". *Scandinavian Journal of Caring Sciences*. Vol. 21. (2008): 482-489.

¹⁴¹ Michael E. McCullough, "Prayer and Health: Conceptual Issues, Research Review, and Research Agenda", *Journal of Psychology and Theology*, Vol. 23, (1995); 15-29.

¹⁴² Brendan T McMahon dan Herbert C. Biggs, "Examining Spirituality and Intrinsic Religious Orientation as a Means of Coping with Exam Anxiety", (2012), DOI: 10.3402/vgi.v3i0.14918.

¹⁴³ Khairunnas Rajab, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014), 61-62.

Dalam Islam diyakini bahwa yang menjadi sentral spiritualitas adalah sholat. Menurut Henry (2013) sholat dapat menghasilkan energi spiritual melalui dua mekanisme. *Pertama*, sholat merupakan hubungan langsung dengan Allah, kemudian hubungan ini akan memberikan kekuatan luar biasa dan meningkatkan perasaan di bawah pengawasan-Nya secara langsung dan memberikan berlimpah sumber daya untuk hidup. *Kedua*, melalui pengaruh keimanan, sholat merupakan wujud keimanan kepada Allah yang kemudian akan bertransformasi menjadi kekuatan dalam hidup.¹⁴⁴

Menurut Komaruddin Hidayat (2006) shalat dalam Islam merupakan perjalanan spiritual menuju Allah. Dalam kata shalat terkandung empat pengertian pokok. *Pertama*, rasa kehadiran (*waṣola*). *Kedua*, rasa keterhubungan (*sillah*) dengan Allah baik fisik maupun rohani. *Ketiga*, shalat juga bermakna menyampaikan penghargaan, pujian dan penghormatan kepada Allah. *Keempat*, shalat mengandung makna doa atau permohonan.¹⁴⁵ Hal ini selaras dengan pandangan Henry (2013) yang menyebutkan bahwa sholat merupakan salah satu ibadah wujud ketaatan hamba kepada Allah yang mampu memberikan sensasi spiritualitas dengan dimensi keterhubungan dengan Allah, dimana sholat pada beberapa riset dibuktikan dapat memberikan manfaat bagi kesehatan psikologis.¹⁴⁶ Sebagaimana Mujib (2006) menyebutkan bahwa shalat selain memiliki nilai spiritual ilahiah, shalat juga bermanfaat untuk mengatur dan mengontrol harmonisasi dimensi ragawi manusia mulai dari syaraf, otot-otot, peredaran darah, pernapasan, pencernaan, kelenjar reproduksi, dan sebagainya.¹⁴⁷

Dengan demikian ketika hendak melakukan sholat, seorang muslim dituntut untuk mempersiapkan dirinya, mengenyampingkan segala pikiran-pikiran negatif termasuk meletakkan segala urusan dunianya termasuk memasrahkan beban hidup dan kegelisahannya, karena dirinya meyakini akan berhubungan langsung dengan Allah

¹⁴⁴Hani M. Henry, "Spiritual Energy of islamic Prayers as a Catalyst for Psychotherapy", *Journal of Religion and Health*, (2013).

¹⁴⁵Komaruddin Hidayat, *Psikologi Beragama: Menjadikan Hidup Lebih Nyaman dan Santun*, (Jakarta: Hikmah, 2006), 177-178.

¹⁴⁶Hani M. Henry, "Spiritual Energy of Islamic Prayers as a Catalyst for Psychotherapy", *Journal of Religion and Health*, (2013); 1-13.

¹⁴⁷Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, 265.

dan akan mendapatkan dukungan hidup dari-Nya.¹⁴⁸ Hal ini selaras dengan firman Allah surah al- Baqarah ayat 277¹⁴⁹, yakni orang yang senantiasa menjaga shalat dirinya tidak akan merasakan ketakutan yang tidak berarti dalam hidup. Sementara itu, diantara indikasi orang stres adalah seringkali merasakan ketakutan yang berlebihan, sehingga demikian dapat dipahami sholat dapat menjadi penyanggah stres.

Studi dari Khan (2006) terhadap klien Muslim yang bertempat tinggal di Toledo, Ohio mengungkapkan bahwa mayoritas partisipan mencari ketenangan dari sholat ketika merasakan stres.¹⁵⁰ Senada dengan hasil tersebut Hamdan (2010) menjelaskan bahwa sholat bisa mengurangi kecemasan dan stres serta memberikan perasaan tenang.¹⁵¹ Adapun studi Lakyntiew et al (2014) pada sejumlah mahasiswa perguruan tinggi di Kota Shillong menunjukkan hasil bahwa meditasi dan sholat menjadi salah satu bentuk koping positif terhadap stres tertinggi yang dilakukan oleh mahasiswa, dimana selanjutnya adalah mendengarkan musik, menonton tv, tidur, melakukan hobi, berbicara kepada teman dan latihan olah raga dan yoga.¹⁵²

Fungsi sholat yang pada beberapa riset diketahui dapat menekan tingkat stres adalah ketika sholat tersebut didirikan dengan baik dan benar. McCullough (1995) menyebutkan bahwa sembahyang

¹⁴⁸ Meguellati Achour, Benaouda Bensaid, dan Mohd Roslan Bin Mohd Nor, "An Islamic Perspective on Coping with Life Stressors", *Applied Reserach Quality Life*, (2015).

¹⁴⁹ Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. al-Baqarah: 277).

¹⁵⁰ Zeenat Khan, "Attitudes towards Counseling and Alternative Support among Muslim in Toledo, Ohio", *Journal of Muslim Mental Health*, Vol. 1, No. 1, (2006);21-42.

¹⁵¹ Aishah Hamdan (2010), " A Comprehensive Contemplative Approach from the Islamic Tradition dalam T. Plante, *Contemplative Practice in Action: Spirituality, Meditation, and Health*, (Santa Barbara: Praeger, 2010), 122-142.

¹⁵² Lakyntiew Pariat, Angelyne Rynjah dan Joplin MG. Kharjana. "Stress Level of College Students: Interrelationship between Stressors and Coping Strategies", *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, (Vol. 19, No. 8, (2014); 40-46.

dapat memunculkan ekspektasi positif terkait stres karena individu dapat menilai kondisi stres secara positif.¹⁵³ Begitupula Watts (2001) berargumen bahwa sembahyang akan membantu individu pulih dari tekanan hidup karena mampu menenangkan pikiran dan tubuh.¹⁵⁴ Sementara dalam Islam sholat menurut Hamdan (2010) dapat menghilangkan rasa was-was dan stres karena bisa memberikan rasa kedamaian.

Efek sholat bagi pendirinya adalah akan mendapatkan keteguhan hati dan ketenangan jiwa yang meliputi perasaan optimis dalam menjalani kehidupan yang sulit sekalipun.¹⁵⁵ Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa diantara indikasi psikologis seseorang yang mengalami stres adalah dirinya akan merasa gelisah dan akan berkeluh kesah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa gelisah dan keluh kesah merupakan aspek biologis alamiah yang terjadi pada manusia, namun demikian respon ini tidak akan dialami secara berlebihan bagi mereka yang menjaga sholatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Q.S. al- Ma'arij: 19-22 :

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۚ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۚ ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir (19) Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah (20) Dan apabila ia mendapat kebaikan ia Amat kikir (21) Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat (22)” (Q.S. al-Ma'arij: 19-22).

Berhubungan dengan ayat ini, Utsman Najati dalam bukunya “Psikologi dalam Tinjauan Hadits Nabi” menyebutkan bahwa sahabat

¹⁵³Michael McCullough, “Prayer and Health: Conceptual Issues, Research Review and Research Agenda”, *Journal of Psychology and Theology*, Vol. 23, (1995); 15-29.

¹⁵⁴Fraser Watts, *Perspective on Prayer*, (Chippenham: Rowe, 2001), 39.

¹⁵⁵Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Tela'ah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Paramadina, 1992), 66-67.

Huzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Dawud, Huzaifah menceritakan bahwa:

Artinya:

“Jika Rasulullah merasa gundah, karena suatu perkara, maka beliau menunaikan shalat”.¹⁵⁶

Senada dengan hasil riset yang dilakukan oleh Haslina et al (2013) diantara intervensi psikoterapi yang diberikan kepada mahasiswa yang mengalami GAD (*generalized anxiety disorder*) adalah shalat¹⁵⁷, ketika Subjek mengikuti psikoterapi shalat dirinya dapat merasakan ketenangan, mendapatkan kekuatan mental dan stabilitas emosi dalam menghadapi stresor kehidupan.¹⁵⁸ Hal ini sesuai dengan ajaran Islam ketika seorang muslim merasa dirinya tidak nyaman akibat musibah, cobaan dan keadaan yang tidak menyenangkan dan menegangkan maka mintalah pertolongan kepada Allah melalui shalat dan sabar, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 45:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Artinya:

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” (Q.S. al- Baqarah: 45).

¹⁵⁶ Muhammad Utsman Najati, *Psikologi dalam Tinjauan Hadits Nabi*, (Jakarta: Mustaqim, 2000), 402.

¹⁵⁷ Menurut Komarudin Hidayat, shalat merupakan perjalanan ritual menuju Allah. Terdapat empat makna dalam shalat, *pertama*: rasa kehadiran (*wasōla*) dihadapan Allah, *kedua*, rasa keterhubungan (*silah*) dengan Allah, *ketiga*, penghargaan pujian dan penghormatan kepada Allah, dan *keempat*: bermakna doa dan permohonan. Lih Komaruddin Hidayat, *Psikologi Bera-gama: Menjadikan Hidup Lebih Nyaman dan Santun*, (Jakarta: Hikmah, 2006), 177-178.

¹⁵⁸ Che Haslina Binti Abdullah and others, “The Effectiveness of Generalized Anxiety Disorder Intervention through Islamic Psychotherapy: the Preliminary Study”, *Asian Social Science*, Vol. 9, No. 13, (2013); 157-162.

Dalam Islam hubungan seorang hamba dengan Allah akan sangat dekat di dalam sholat khususnya ketika posisi sujud, sebagaimana dikatakan dalam hadis nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»

Artinya:

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Keadaan paling dekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia dalam keadaan sujud, maka perbanyak doa (di dalamnya)” (HR. Muslim).

Di kalangan ulama muslim dan beberap penelitian terkini, posisi sujud dalam sholat banyak memberi manfaat, seperti menambah suplai darah ke otak yang akan memberikan makan otak yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas memori, penglihatan, konsentrasi, dan kemampuan kognitif lainnya. Bahkan terdapat penelitian yang membuktikan bahwa rutinitas posisi sujud dapat menekan munculnya gangguan sakit kepala, masalah psikologis dan gangguan kognitif lainnya.¹⁵⁹ Sehingga demikian ketika para mahasiswa dapat menjaga ibadah sholatnya maka diharapkan dan diyakini akan meningkatkan kualitas daya kognisi dalam proses belajar yang sedang dijalani.

Adapun perasaan ringan dan nyaman setelah berdoa sebagaimana diungkapkan oleh Subjek F merupakan efek positif dari berdoa, dimana do'a merupakan mediasi komunikasi dengan Tuhan yang menurut Sayyid Qutub individu akan merasakan kedamaian, ketenangan dan rasa kebebasan ketika mampu berhubungan dan berkomunikasi dengan Allah.¹⁶⁰ Burkhaedt dan Nagai-Jacobson menuliskan do'a merupakan ekspresi dari spirit dan do'a merupakan instink terdalam yang dimiliki manusia yang menghubungkan antara tingkat

¹⁵⁹M Ashraf al- Haq and others, “Islamic Prayer, Spirituality, and Priductivity: an Exploratory Conceptual Analysis”, *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economic*, Vol. 8, No. 2, (2016); 271-286.

¹⁶⁰Sayyid Qutub, *Fi Zilal al- Qur'an*, (al- Maktabah al- Syamilah V. 3.28), 367.

kesadaran tertinggi dari manusia dengan Zat yang *supreme*.¹⁶¹ Meskipun tidak ada bukti eksperimen riset yang menjelaskan efek mekanisme fisiologis do'a, namun beberapa riset membuktikan bahwa do'a dan ibadah berkontribusi pada kesehatan dan stabilitas emosi.¹⁶²

Dalam perspektif Psikologi Islam doa dapat menyebabkan stres berkurang dan menurunkan tekanan darah, pada sebagian orang sakit doa memiliki peran penting dalam pemulihan atau mengatasi penyakit. Rasulullah mengajarkan kepada umat mukmin yang sedang dirundung kegelisahan, kecemasan, depresi dan sebagainya, melalui hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda: Tiada kecemasan dan kesusahan diri yang menimpa seorang hamba, lantas ia berdoa:

لَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

¹⁶¹ Menurut Burkhardt dan Jacobson ada beberapa tipe doa', yakni: *petitionary prayer* meliputi permintaan kepada Zat tertinggi untuk memenuhi permintaan tertentu seperti kesembuhan dan kesuksesan, *intercessory prayer* sering disebut doa berjarak yakni permohonan yang ditujukan untuk orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan, *adoration prayer* meliputi pujian terhadap Zat Maha Kuasa, *ritual prayer*, meliputi membaca kitab-kitab suci dan tuntutan ibadah ritual seperti sholat dan membaca al-Qur'a, dan zikir, *meditative/contemplative prayer* meliputi mendengarkan sesuatu bersuara kecil dan semisal yang bisa memunculkan emosi keterhubungan dengan Zat Maha Kuasa dan diharapkan dapat melakukan transendensi melalui kata-kata atau pikiran dan terakhir *colloquial prayer* yakni berkomunikasi dengan Zat Maha Tinggi dengan penuh kesadaran, ketundukan dan kepasrahan seolah-olah berbicara dengan teman. Tipe do'a seperti ini biasanya dilakukan untuk meminta petunjuk dan arahan dalam membuat keputusan. Lih Margaret A. Burkhardt dan Mary Gail Nagai-Jacobson, *Spirituality: Living our Connectedness (Healer)*, (Delmar: Thomson learning, 2005), 147.

¹⁶² Elizabeth Johnston Taylor, *Spiritual Care: Nursing Theory, Research, and Practice*, (New York: Prentice Hall, 2002), 207.

Artinya:

*“Ya ALLAH, sesungguhnya aku berlindung kepada-MU dari rasa gundah dan sedih, rasa lemah dan malas, sifat bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang”.*¹⁶³

Selanjutnya bentuk implementasi koping stres melalui spiritualitas dalam dimensi hubungan dengan Tuhan adalah membaca kitab suci. Aktivitas membaca pada dasarnya dapat menjadi salah satu cara keluar dari keadaan yang menegangkan, karena ketika membaca seseorang akan memasuki dunia literasi dan sejenak melupakan apa yang dirasakan dan dihadapinya. Membaca dapat merelaksasi tubuh dengan menekan tekanan jantung dan meregangkan ketegangan otot. Studi pada Universitas Sussex (2009) menunjukkan hasil bahwa membaca dapat menekan stres lebih dari 60%, dimana membaca terbukti bekerja lebih baik dan lebih cepat dalam menekan stres dibandingkan mendengarkan musik, atau minum teh dan kopi hangat.¹⁶⁴

Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa, salah satu aktivitas kesehariannya untuk menjaga hubungan dengan Tuhan adalah membaca kitab suci. Subjek D menyebutkan seberapa sibuk dirinya dengan tugas kuliah dirinya selalu berusaha untuk minimal satu kali dalam sehari membaca al-Qur'an. Ketika membaca al-Qur'an setidaknya sejenak saya bisa mengistirahatkan diri dari berbagai macam pikiran terkait tuntutan kampus. Setelah membaca al-Qur'an saya merasa siap kembali untuk melanjutkan proses belajar lainnya.¹⁶⁵

Menurut analisa penulis ungkapan Subjek sebagaimana dinarasikan di atas menegaskan fungsi al-Qur'an dalam Islam diyakini dapat menjadi terapi bagi keadaan penyakit dan tekanan hidup yang dirasakan manusia. Menurut Imran Khan melalui pengalaman membaca al-Qur'an, individu dapat merasakan perubahan karakter, kepri-

¹⁶³Zaenal Abidin, “Ketika Stress Bereaksi Islam Punya Solusi”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, (2009);148-166.

¹⁶⁴University of Minnesota, *Reading for Stress Relief*, diakses dari <https://www.takingcharge.csh.umn.edu/reading-stress-relief> pada tanggal 07 September 2017 pukul 08.39 WIB.

¹⁶⁵Wawancara dengan Subjek D (mahasiswa tahun pertama dengan tingkat stres rendah), pada hari Jum'at, Tanggal 17 Februari 2017, Pukul 10.00 WIB.

badian, proses pemikiran dan kekuatan fisik.¹⁶⁶ Fungsi positif al-Qur'an ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surah al-Isra' ayat 82.

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya:

“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”. (Al-Isra’: 82)

Melalui ayat ini Sulaiman (2013) menyebutkan bahwa membaca al-qur'an dapat dijadikan sebagai terapi psikologis, bacaan al-Qur'an dapat memberikan energi positif dan mengurangi energi negatif yang ada dalam tubuh, jiwa dan pikiran.¹⁶⁷ Bacaan al-Qur'an dapat menghilangkan penyebab tegangan pada emosi dan dapat menyembuhkan jiwa dengan perasaan damai dan kepuasan pada diri sendiri.¹⁶⁸ Riset yang dilakukan oleh Radzi et al (2014) mendapatkan hasil bahwa pada mahasiswa tahfidz yang mengikuti perkuliahan teknik menunjukkan bahwa untuk mengatasi tuntutan dan kesulitan akademik, aktifitas membaca al-Qur'an menjadi salah satu bentuk implementasi spiritual coping dalam mengatasi stres akademik.¹⁶⁹

Selanjutnya ketika penulis meminta responden menarasikan bagaimana spiritualitas termanifestasi dalam kehidupan akademik, tiga responden menjelaskan sebagaimana kutipan berikut:

¹⁶⁶Iredho Fani Reza, *Mengatasi Kerentanan Stres melalui Coping Religius: Studi pada Pasien Gagal Ginjal Kronik*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), 205.

¹⁶⁷Sulaiman, “Healing in Islam: a Psychological Perspective”, *IFE Psychologia: Psychotherapy- Unity in Diversity*, Vol. 21, No.3, (2013).

¹⁶⁸Furqan Institute of Qur'anic Healing, *Medical Miracle of the Qur'an*, diakses dari <http://www.fiqh.org/2009/04/medical-miracle-of-the-quran/> pada tanggal 09 September 2017, pukul 11.30 WIB.

¹⁶⁹Husni Mohd Radzi and others, “Religious and Spiritual Coping Used by Student in Dealing with Stress and Anxiety”, *International Journal of Asian Social Science*, Vol. 4, No. 2, (2014); 314-319.

Subjek G:

*“Sampai di tahun ke tiga ini saya merasakan bahwa kehidupan akademik semakin membuat saya stres, dimana orang tua dan teman saya rasakan tidak terlalu banyak membantu, tapi karena keyakinan saya kepada Tuhan Yesus yang kemudian membuat saya bertahan. Keyakinan saya adalah Tuhan akan membantu saya melewati masa-masa penuh stres selama kuliah ilmu kedokteran”.*¹⁷⁰

Subjek F :

*“Saya pernah merasakan gagal dalam satu modul kuliah, nilai saya sangat kecil saat itu. Namun kemudian saya merasakan seolah mukjizat Allah itu benar-benar datang, saya berdoa semoga saya mendapat kesempatan. Setelah beberapa hari menerima nilai tersebut saya mencoba menghubungi dosen sekiranya saya diberi kesempatan untuk remedial, awalnya beliau menolak tapi kemudian memberi kesempatan kedua, meskipun nilai remedial tidak mencapai hasil akhir A, setidaknya saya mendapatkan nilai yang lebih baik. Saat itu saya sangat yakin bahwa ini semua karena pertolongan Allah”.*¹⁷¹

Subjek D :

“Menurut saya hubungan dengan Tuhan itu adalah pasrah. Ketika saya sudah menyelesaikan tugas kampus atau mengikuti ujian biasanya saya tidak ingin banyak memikirkan tentang hasil yang akan saya dapatkan jadi saya tidak merasa terbebani dengan hal tersebut. Kalau berharap hasil yang didapati akan baik, iya pastinya!. Tetapi lagi-lagi saya serahkan semua hasil akhir kepada Allah, terpenting buat saya

¹⁷⁰ Wawancara dengan Subjek G (mahasiswi tahun ketiga dengan tingkat stres rendah), pada hari Selasa, Tanggal 14 Februari 2017, Pukul 12.30 WIB.

¹⁷¹ Wawancara dengan Subjek F (mahasiswi tahun ketiga dengan tingkat stres rendah), pada hari Rabu, Tanggal 8 Februari 2017, Pukul 09.30 WIB.

*adalah berusaha maksimal dan hasil akhir terserah Tuhan saja”.*¹⁷²

Dari tiga narasi di atas dapat disimpulkan bahwa pada Subjek F menunjukkan bahwa Subjek memiliki keyakinan besar kepada Tuhan, bahwa sukses dan gagal dirinya dalam akademik adalah karena intervensi Tuhan. Keyakinan Keyakinan (*belief*) menjadi *core* pengalaman spiritualitas. Dimana menurut Good dan Willoughby (2006) perasaan percaya pada Tuhan akan memotivasi dan mendorong seseorang untuk lebih keras berusaha.¹⁷³ Subjek F meyakini bahwa Tuhan ikut serta dalam keberlangsungan pendidikannya dan memberikan solusi atas masalahnya.

Sementara pada Subjek F implementasi spiritualitas dijelaskan dengan keyakinan bahwa keberhasilan dan kebaikan pada dirinya adalah berkat pertolongan Allah. Bagi Subjek F Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam masa-masa krisis selama proses belajar. Dalam Islam seorang muslim diminta untuk meyakini bahwa dirinya sangat lemah dan dianjurkan meminta pertolongan dan dukungan kepada Allah dalam suatu urusan, kesulitan dan beban hidup. Dalam Islam hal ini disebutkan dengan istilah “*isti‘ānah* dan *istighasah*” sebagaimana disebutkan pada dua ayat berurutan berikut ini:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَغِيثُوا بِإِلَهِهِ وَأَصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنَ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۚ

Artinya:

“Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa". (Al- A'raf: 128)

¹⁷² Wawancara dengan Subjek D (mahasiswa tahun pertama dengan tingkat stres rendah), pada hari Jum'at, Tanggal 17 Februari 2017, Pukul 10.00 WIB.

¹⁷³ Good dan Willoughby, *Spiritual Development*, dalam Roger J.R. Levesque, *Encyclopedia of Adolescence*, (New York: Springer, 2011), 231.

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ
مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾

Artinya:

“(ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu Malaikat yang datang berturut-turut”. (Al- Anfal: 9)

Terkait dengan dua ayat di atas, para ulama membedakan antara *isti‘anah* dan *istighasah* meskipun secara kebahasaan makna keduanya kurang lebih sama yakni meminta pertolongan. *Isti‘anah* berarti meminta pertolongan dengan arti yang lebih luas dan umum sementara *istighasah* adalah meminta pertolongan ketika keadaan sukar dan sulit.¹⁷⁴ Dalam Islam individu yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah akan merasakan ketenangan jiwa, tidak gelisah, dan tidak dihantui perasaan-perasaan negatif lainnya.¹⁷⁵

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Greenfield, Vaillant dan Marks (2007) spiritualitas dalam hal keterhubungan dengan Tuhan akan memberikan ketentraman dalam hati dimana Tuhan dimanifestasikan sebagai penolong yang memberikan dan menjadi sumber kekuatan di saat-saat tertekan dalam dunia akademik yang dijalani.¹⁷⁶ Begitupula dalam Islam keimanan (*belief*) merupakan potensi dalam diri luar biasa yang dapat memberikan kekuatan dalam memikul beban hidup. Spiritualitas yang berlandaskan pada keimanan akan menjauhkan individu dari rasa gelisah dan kebingungan.

¹⁷⁴Ibn Muhammad Abdul Wahab, *Kitab Tauhīd*, (TT: Dārul ‘Arabiyah, 1969), 33.

¹⁷⁵Najati, Muhammad 'Uthmān. *Al-Qur'an wa 'Ilm al-Nafs*. (Cairo: Dār al-Syūrūk, 1993), 36.

¹⁷⁶Emily Greenfield, George E. Vaillant dan Nadine F. Marks, “Formal Religious Participation and Daily Spiritual ExperiencesL Separate, but Equal, Linkage with Psychological Well-Being?”, *Center for Demography and Ecology University of Wisconsin- Madison*, (2007); 1-35.

banagan yang secara luas banyak dialami manusia modern.¹⁷⁷ Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam surah al- Ahqāf ayat 13:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah[1388] Maka tidak ada kekawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita”. (Al- Ahqāf: 13)

Istiqamah pada ayat ini bermakna teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal saleh. Mukmin yang betul-betul yakin kepada Allah akan takdir baik dan buruk-Nya akan hilang darinya ketakutan dan kesedihan. Kepercayaan kepada Allah juga bermakna *tawakkal* yakni meyakini dan memasrahkan segala urusan kepada Allah, meyakini bahwa setiap rencana Tuhan akan bekerja dengan sempurna. Muslim dituntut untuk menyerahkan segala bentuk kesudahan, kesulitan, kegelisahan hanya kepada Allah.

Beberapa ayat dalam al-Qur’ān banyak menyebutkan tentang ajakan kepada muslim untuk bertawakkal kepada Allah seperti tertulis dalam surah al-An’ām ayat 102, surah Hūd ayat 123 dan surah at-Taubah ayat 51.¹⁷⁸ Tawakkal kepada Allah merupakan motivasi intrinsik bagi seorang muslim, tawakkal bukan berarti bersikap pasif akan usaha, namun sebaliknya tawakkal memunculkan perilaku

¹⁷⁷ Abd al- Majīd Sayyid Ahmad Mansūr, Zakariyya Ahmad al-Shirbini dan Ismāil Muhammad al- Faqīy, *Al- Suluk al- Insanī Bayna al- Tafsīr wa Usus ‘Ilm- Nafsi al- Mu‘asir*, (Kairo: Maktabat al- Anjilu al- Miṣriyyah, 2001), 395.

¹⁷⁸ Artinya: “(yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan selain dia; Pencipta segala sesuatu, Maka sembahlah dia; dan Dia adalah tempat berserah atas segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah:102), “Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di bumi dan kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, Maka sembahlah Dia, dan bertawakkallah kepada-Nya. dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Hūd: 123), “Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakkal". (Q.S. at- Taubah: 51).

giat dan tekun bekerja, karena hasil tidak akan menyalahi proses. Hanya saja ketika segala usaha telah dilakukan tawakal memberi ketenangan pada diri untuk tidak terlalu khawatir pada sesuatu yang tidak bisa diprediksi hasilnya.

Namun spiritualitas keterhubungan dengan Tuhan pada Subjek D menurut analisa penulis lebih cenderung pada implementasi emosi berpasrah pada Tuhan atau dalam istilah psikologi konvensional disebut “*surrendering to God*”. Dalam Islam menurut Nygard (1996) diantara arti kata “islam” adalah “berserah diri”, dengan demikian “muslim” bermakna “seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Menurutnya kepasrahan kepada Allah dengan demikian menjadi karakteristik dan identitas seorang muslim. Menurutnya pasrah/*surrender* kepada tuhan memiliki beberapa penjelasan, diantaranya pasrah bermakna ketaatan kepada Allah tanpa kompromi, pasrah merupakan bagian terdalam dari keimanan, pasrah bermakna manusia tetap mendapat kebebasan memilih, pasrah bermakna respon manusia yang hanya diserahkan kepada Allah, kepasrahan merupakan wujud kemahakuasaan Allah, dan kepasrahan merupakan penyatuan antara tubuh dan jiwa.¹⁷⁹

Sementara hubungan antara kepasrahan kepada Tuhan dan stres, menurut Clements dan Erkanova (2012) individu yang menyerahkan keinginannya kepada Tuhan berarti menyerahkan kesedihannya kepada Tuhan, individu tersebut meyakini bahwa dirinya dalam kontrol Tuhan sehingga menekan kerentanan dan tingkat stres. Hal ini dibuktikan dalam riset yang dilakukannya pada 460 mahasiswa dari Universitas Appalachian yang mengisi kuesionnaire *the surrender scale* dan *the state trait-anxiety inventory*. Hasil studi membuktikan bahwa aspek kepasrah pada Tuhan mampu menjadi variabel yang memoderasi hubungan negatif antara religiusitas dan stres mahasiswa.¹⁸⁰

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa spiritualitas sangat sulit dipisahkan dari aspek *connectedness* kepada Tuhan yang diimplementasikan dalam ritual ibadah dan do’a sebagaimana dianjurkan dan diajarkan dalam agama. Hal ini selaras dengan studi yang

¹⁷⁹Mark Nygard, “The Muslim Concept of Surrender to God”, *International Journal of Frontier Missions*, Vol. 13, No. 3, (1996); 125-130.

¹⁸⁰Andrea D. Clements dan Anna V. Ermakova, “Surrender to God and Stress: a Possible Link between Religiosity and Health”, *Psychology of Religion and Spirituality*, Vol. 4, No. 2, (2012); 93-107.

dilakukan oleh Graham et al (2001) bahwa mahasiswa yang memiliki spiritualitas yang diaplikasikan dalam ketaatan beribadah dan beragama lebih rendah kerentanan efek negatif stres dibandingkan mahasiswa yang hanya menyatakan diri mereka spiritualis namun tidak religius.¹⁸¹

2. Implementasi Spiritualitas melalui Harmonisasi dengan Alam dan Manusia

Bentuk implementasi spiritualitas yang bersifat hubungan dengan Tuhan sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya disebut dengan istilah hubungan vertikal. Implementasi spiritualitas tidak cukup hanya bergaris vertikal ke atas saja, namun diperlukan hubungan positif terhadap sesama manusia, makhluk dan lingkungan lainnya yang disebut dengan istilah hubungan horisontal. Menurut Willard (1999) hubungan vertikal dan horisontal adalah dua hubungan yang saling terkait. Untuk mengadakan dan mendapatkan hubungan vertikal yang baik, individu juga harus dapat menjalin dan mempertahankan hubungan yang baik secara horisontal.¹⁸² Dalam bahasa Islam kedua hubungan ini disebut *hablun min Allah* (hubungan vertikal) dan *hablun lin nas wal makhul* (hubungan horisontal). Sementara Burkhardt (1989) menyebut keterhubungan manusia dengan selainnya meliputi sesama manusia, bumi, lingkungan, dan kosmos dengan istilah “harmonisasi”.¹⁸³

Dalam pengertian luas keterhubungan dengan alam/*connection to nature* bermakna berbagai perasaan dan sikap yang dimiliki individu terhadap alam. Keterhubungan juga memiliki arti mencintai alam, memiliki perasaan terpesona dan kagum dan bisa juga bermakna memelihara alam.¹⁸⁴ Menurut Schultz (2002) keterhubungan

¹⁸¹Stephanie Graham and others (2001), “Religion and Spirituality in Coping with Stress”, *Counselling and Values*, Vol. 46, No. 1, (2001); 2-13.

¹⁸²Dallas Willard, *Hearing God: Developing a Conversational Relationship with God*, (Downers Groov, IL: InterVarsity Press, 1999), 20.

¹⁸³Margaret A. Burkhardt, “Spirituality; an Analysis of the Concept”. *Holistic Nursing Practice*, Vol. 3, No. 3, (1989); 69-77.

¹⁸⁴Jack Gelsthorpe, “Disconnect from Nature and its Effect on Health and Well-being- A Public Engagement Literature Review”, *Natural History Museum*, (2017), 2.

dengan alam dapat didefinisikan sebagai sejauh mana pandangan individu tentang alam, kemudian digabungkan ke dalam persepsi mereka tentang perasaan diri mereka sendiri.¹⁸⁵

Menurut MacKinlay (2006) spiritualitas tidak hanya bisa dicapai dengan media agama saja, melainkan bisa dicapai melalui media lain seperti seni, hubungan dengan orang lain bahkan lingkungan.¹⁸⁶ Sebagaimana keterhubungan dengan Tuhan merupakan tuntunan agama, pada hakikatnya keterhubungan manusia dengan alam (*nature*) dan manusia lainnya (*communal*) juga merupakan ajaran agama, dimana agama mengajarkan untuk memperhatikan satu sama lain, meningkatkan kesadaran sosial dan keharmonisan dengan masyarakat dan alam sekitar.¹⁸⁷

Menurut Taylor (2002) keterhubungan yang kuat antara manusia dengan alam sejatinya telah ada sepanjang sejarah, semua agama dan tradisi kultural. Agama menganggap lingkungan dan bagian luar bumi seperti ruang angkasa dan alam semesta semuanya diberi kehidupan sebagai hasil karya Sang Maha Pencipta.¹⁸⁸ Sebagai contoh tradisi agama kuno di Amerika mengekspresikan hubungan positif dengan alam yang mereka sebut dengan istilah "*nature-centered spirituality*" yakni spiritualitas yang terpusat pada alam.¹⁸⁹

Selaras dengan pandangan Taylor, Islam juga merujuk ciptaan alam semesta dengan istilah "*ayah/sign*" tanda kebesaran Allah, begitupula secara bergantian istilah "*ayat*" ini merujuk pada teks al-Qur'an, sebagaimana al-Qur'an merupakan tanda kuasa Allah begitu-

¹⁸⁵Paul Wesley Schultz, "Inclusion with Nature: The Psychology of Human Nature Relations", dalam Peter Schmuck dan Wesley P. Schultz, *Psychology of Sustainable Development*, (Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002), 61.

¹⁸⁶Elizabeth MacKinlay, *Spiritual Growth and Care in the Fourth Age of Life*, (London: Jessica Kingsley Publisher, 2006), 13.

¹⁸⁷Vacher Miller, "Purpose and Connection: Spirituality in a Learning Society", Center for International Education at the University of Massachusetts-Amherst, (2013); 1-6.

¹⁸⁸Elizabeth Johnston Taylor, *Spiritual Care: Nursing Theory, Research, and Practice*, (New York: Prentice Hall, 2002), 262.

¹⁸⁹Barbara Montgomery Dossey, *Core Curriculum for Holistic Nursing*, (Gaithersburg, MD, Aspen, 1997), 135.

pula semua ciptaan-Nya.¹⁹⁰ Dalam Islam alam semesta diperindah oleh Allah dalam penciptaanya agar dapat menjadi sumber inspirasi spiritual. Di dalam al-Qur'an hal ini disebut dengan istilah "*tawasum*" sebagaimana dituliskan dalam surah al-Hijr ayat 75:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

Artinya:

"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda."(Q.S.al- Hijr: 75).

Tawasum berarti kemampuan untuk memahami tanda-tanda alam. Dengan memperhatikan fenomena alam semesta akan memberi pelajaran dan mendapatkan sensasi spiritual dari perkara-perkara materi.¹⁹¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa seorang muslim untuk melihat kekuasaan Tuhan dituntut untuk membaca dan mentadaburi ayat-ayat al-qur'an tetapi juga memperhatikan tanda-tanda kebesaran-Nya yang terdapat pada berbagai ciptaan makhluk-makhluk lain selain dirinya, individu dituntut melakukan hubungan dan kontak dengan alam.

Selaras dengan pandangan Islam, pandangan ahli psikologi sosial juga menegaskan pentingnya keterhubungan dengan alam sebagaimana kita memiliki perasaan memiliki antar kelompok masyarakat,¹⁹² karena menurut Kellert dan Wilson pada hakikatnya manusia secara universal memiliki hubungan lahiriah dengan alam.¹⁹³ Hubungan lahiriah ini ditegaskan kembali oleh Schultz (2002) bahwa manusia sebenarnya bagian dari alam, bagaimana tidak? Kita dilahir-

¹⁹⁰Fazlun Khalid, "Islam and the Environment Ethics and Practice", *The 15th General Conference of the Environment in Islam*, (Amman: The Hashemite Kingdom of Jordan, 2010), 5.

¹⁹¹Maulana Wahiduddin Khan, *Spirituality in Islam*, (tt), 7 diakses dari <https://dokumen.tips/documents/spirituality-in-islam-by-maulana-wahiduddin-khan.html> pada tanggal 11 September 2017, pukul 22.09 WIB.

¹⁹²F. Stephan Mayer and others, "Why is Nature Beneficial? The role of Connectedness to Nature", *Environment and Behavior*, Vol. 41, No. 5, (2009); 607-643.

¹⁹³Stephan R. Keller dan Edward O. Wilson, *The Biophilia Hypothesis*, (Washington, DC: Island Press, 1993).

kan di alam, tubuh kita terbentuk dari alam, dan kita hidup karena aturan alam. Sebagai seorang individu, kita merupakan penduduk di alam dunia; sebagai masyarakat, kita dikelilingi sumber daya alam; sebagai spesies, kita tergantung pada keseimbangan ekosistem di alam.¹⁹⁴

Namun demikian, manusia saat ini seolah ingin melarikan diri dari alam. Kecanggihan teknologi mengasingkan dan memisahkan manusia dari alam. Berbagai kesibukan harian tidak lagi memberi kesempatan untuk menikmati keindahan alam. Salah satu studi di Amerika menyebutkan rata-rata manusia saat ini menghabiskan 90% hidupnya untuk tinggal di dalam ruangan.¹⁹⁵ Hal ini dirasakan pula oleh kebanyakan mahasiswa kedokteran sebagaimana hasil data kuantitatif yakni item yang mendeskripsikan kedekatan diri mereka dengan alam seperti mendaki gunung, pergi ke pantai, menikmati keindahan taman sangat kecil sekali nilai kontribusinya pada dimensi “nature”. Berdasarkan hasil wawancara ternyata responden Subjek H menjelaskan bahwa kesibukan dan padatnya perkuliahan dengan berbagai tugas individu dan kelompok tidak memberi mereka waktu cukup untuk melakukan hal tersebut.¹⁹⁶

Padahal masih menurut Taylor aktifitas kedekatan dengan alam dapat dianggap sebagai bentuk pengalaman spiritualis yang dapat berkontribusi kepada kesehatan diri.¹⁹⁷ Melalui alam, individu berinteraksi dengan energi prima yang ada di bumi, air, api dan udara.¹⁹⁸ Dalam dunia kesehatan dan perawatan orang sakit diantara

¹⁹⁴Paul Wesley Schultz, “Inclusion with Nature: The Psychology of Human Nature Relations”, 61.

¹⁹⁵Gary W. Evans dan Janetta Mitchell McCoy, “When Buildings Don’t Work: the Role of Architecture in Human Life”, *Journal of Environmental Psychology*, Vol. 18, No. 1, (1998); 85-94.

¹⁹⁶Wawancara dengan Subjek H (mahasiswi tahun ketiga dengan tingkat stres tinggi), pada hari Senin, Tanggal 20 Februari 2017, Pukul 09.30 WIB.

¹⁹⁷Elizabeth Johnston Taylor, *Spiritual Care: Nursing Theory, Research, and Practice*, (2002), 346.

¹⁹⁸Melalui **bumi**, manusia mendapatkan keseimbangan dan energi spiritual terdalam karena memang sifat bumi adalah seimbang tidak goyang dan dalam. Untuk berhubungan dengan bumi, individu bisa melakukan aktifitas berjalan di taman, bertaman, bersepeda, dan camping. Melalui **air**: menghabiskan waktu di dekat atau di dalam air akan berkontribusi pada kese-

pelayanan berbasis spiritual-natural yang diberikan pihak rumah sakit kepada pasien adalah dengan meletakkan beberapa photo panorama alam, meletakkan bunga di kamar pasien, dan menyediakan jendela yang berhadapan dengan halaman dan pandangan sekitar, hal ini ditujukan untuk memfasilitasi pelayanan spiritual berbasis pada kedekatan dengan alam, dimana penelitian Suzuki dan McConnell (2002) menyebutkan bahwa ketika pasien dengan penyakit terminal kanker diminta untuk berbicara tentang alam, pasien rata-rata mendeskripsikan bahwa pengalaman keterhubungan dengan alam memberikan harapan bahwa mereka ingin pulih kembali untuk dapat menikmati keindahan alam sekitar.¹⁹⁹

Begitupula ketika mahasiswa diminta untuk mendeskripsikan sekiranya mereka dapat berada di alam bebas, perasaan apa yang akan muncul serta implementasi seperti apa yang bisa dilakukan sebagai wujud keterhubungan diri dengan alam. Subjek G salah satunya mengungkapkan bahwa dirinya akan sangat senang untuk dapat melakukan hal tersebut agar bisa beristirahat sejenak dari segala kesibukan kampus, Subjek bisa membayangkan pasti akan sangat merasa nyaman, penuh damai ketika bisa secara langsung merasakan hembusan angin dan udara yang bersih. Membayangkan keindahan alam, menurut Subjek dirinya bertanggung jawab untuk keindahan tersebut dengan cara menjaga lingkungan atau setidaknya tidak merusak anugerah Tuhan tersebut. Menurutnya dirinya dan alam semesta memiliki hak yang sama untuk terus hidup dan manusia pada hakikatnya

jahteran diri. Berenang di lautan atau pun sungai memberikan tambahan energi positif untuk hidup. Karena sifat air adalah menyegarkan. Melalui **Api**: individu dapat mendapatkan efek gelora semangat, karena pada masyarakat primitif di Amerika api menjadi simbol ritual yang digunakan untuk dapat berhubungan dengan Ruh yang disucikan. Dan melalui **udara**: Udara merupakan manifestasi zat yang paling suci, dimana udara merupakan elemen terpenting untuk hidup dan sehat. Lih Janet Ruffing, "To Have Been One with the Earth: Nature in Contemporary Christian Mystical Experience", *Presence: the Journal of Spiritual Directors International*, Vol. 3, N0. 1, (1997); 40-54.

¹⁹⁹David Suzuki dan Amanda McConnell, *The Sacred Balance: Rediscovering our Place in Nature*, (Vancouver, BC: Greystone Books, 2002), 126.

memang tidak bisa memisahkan diri dengan alam semesta, kita merupakan makhluk satu kesatuan.²⁰⁰

Bagian akhir dari hasil wawancara menjelaskan prinsip *mua-hadah* (kesatuan), hal ini selaras dengan prinsip etika lingkungan sebagaimana penulis kutip pada kajian teori. Menurut Arif Sumantri melalui prinsip *muahadah* muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti dan dirawat. Semakin mencintai lingkungan, manusia semakin berkembang menjadi manusia yang matang dan menjadi pribadi dengan identitas kepedulian sosial yang kuat.²⁰¹

Pemeliharaan alam dan tidak merusaknya seperti yang disampaikan oleh Subjek G sejatinya memang merupakan ajaran agama. Dalam Islam segala bentuk ciptaan Allah disebut “*khalq/creation*”, kata ini disebutkan sebanyak 261 kali dengan berbagai perubahan dari katanya yakni “*khalaqo*”. Kata *khalaq* ini merujuk pada ciptaan Allah berupa manusia, alam semesta dan segala isinya seperti planet, langit, bintang, matahari, pohon, lautan, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini bermakna ketika Allah menyebutkan berbagai bentuk ciptaan-Nya, hal tersebut tidak hanya menjelaskan bentuk kuasa-Nya namun juga menjelaskan fungsi keseimbangan antara semua ciptaan tersebut. Kemudian dengan diangkatnya manusia sebagai *khalifah fi al- arḍ*, maka kewajiban untuk menjaga dan memelihara ciptaan tersebut diberikan kepadanya. Allah melarang pengrusakan alam setelah Dia menyempurnakan setiap ciptaan-Nya tersebut. Sesungguhnya pada pemeliharaan alam ada manfaat buat manusia, sebaliknya dalam pengrusakannya terdapat *muḍarat*/bahaya. Secara sempurna al-Qur’an surah an- Nahl ayat 65-69 menjelaskan hal tersebut:

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾ وَإِنَّ لِكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِطُكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ

²⁰⁰ Wawancara dengan Subjek G (mahasiswi tahun ketiga dengan tingkat stres rendah), pada hari Selasa, Tanggal 14 Februari 2017, Pukul 12.30 WIB.

²⁰¹ Arif Sumatri, *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 252.

وَدَمَّرْ لَبْنًا خَالِصًا سَابِغًا لِلشَّرِبِينَ ﴿٦٦﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلَفٌ ۚ لَوْنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya:

“Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran). (65) Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. (66) Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (67) Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", (68) Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. (69)” (Q.S. an- Nahl: 65-69).

Manfaat positif psikologis dari alam hanya bisa didapati lewat interaksi.²⁰² Hubungan harmonis antara manusia dan alam menurut Suzuki (2002) dapat menjadi sumber potensial positif bagi individu untuk mengatasi stres.²⁰³ Begitupula Gall et al (2005) menyebutkan keterhubungan dengan alam akan memberi perasaan emosi yang menyenangkan dan menenangkan bagi individu yang mengalami stres.²⁰⁴ Panorama alam yang memungkinkan perubahan *tune* emosi positif, perubahan positif pada aktifitas fisiologis, dan perubahan perilaku serta fungsi kognitif disebut dengan istilah “*restorative environment*/ lingkungan restoratif”.²⁰⁵

Hubungan antara lingkungan restoratif dan stres, menurut Bratman et al (2012) dapat dijelaskan melalui “teori penekanan stres/ *stress reduction theory* (SRT)”. Menurut SRT pemandangan dengan hamparan air, pepohonan dan pegunungan akan memoderasi dan mengurangi arah dan pikiran negatif dalam hitungan menit melalui psikofisiologis proses. Dalam analisis review terkait fungsi positif alam terhadap kesehatan yang ditulis oleh Bratman et (2012), penulis mengutip beberapa riset yang menggunakan teori SRT ini seperti studi di Jepang dimana pada studi ini setelah masyarakat Urban

²⁰²Terdapat tiga tipologi interaksi manusia dengan alam yakni; *indirect*, *incidental*, dan *intentional*. Interaksi *indirect* (tidak langsung); memiliki pengalaman dengan alam tapi tidak dengan kontak fisik secara langsung, seperti melihat panorama alam lewat gambar, melihat alam melalui jendela. Interaksi insidental/kebetulan (*incidental*); menikmati pemandangan karena kebetulan sedang dalam perjalanan seperti menikmati jalan ketika berjalan kaki ke tempat kerja, dan interaksi yang disengaja/diniatkan (*intentional*); menikmati pengalaman bersama alam secara langsung dengan perencanaan seperti *hiking*, kamping, berkebuh, dsb. Lih Lucy E. Keniger, Kevin J. Gaston dan Richard A. Fuller, “What are the Benefit of Interacting with Nature?”, *International Journal of Envirinmental Research and Public Health*, Vol. 10, No. 3, (2013); 913-935.

²⁰³David Suzuki dan Amanda McConnell, *The Sacred Balance: Rediscovering our Place in Nature*, 126.

²⁰⁴Terry Lynn Gall and others, “Understanding the Nature and Role of spirituality in Relation to Coping and Health: a Conceptual Framework, *Canadian psychology*, Vol. 46, No. 2, (2005); 88-104.

²⁰⁵Rita Berto, “The role of Nature in Coping with Psycho-Physiological Stress: a Literature Review on Restorativeness”, *Behavioral Sciences*, Vol. 4, (2014); 394-409.

diberi kesempatan untuk bisa menikmati pemandangan hutan dalam waktu 15 menit ternyata terjadi perubahan signifikan pada kadar hormon kortisol dari air ludah, tekanan darah, dan denyut nadi serta secara keseluruhan berhasil menekan tingkat stres. Begitupula konektifitas dengan alam dapat meningkatkan mood positif pada mahasiswa yang mengalami stres karena ujian. Mahasiswa yang diperlihatkan gambar-gambar pemandangan memiliki penurunan emosi negatif takut dan peningkatan emosi positif dibandingkan mahasiswa yang diperlihatkan potongan-potongan gambar suasana kota urban.²⁰⁶

Keniger et al (2013) pada analisis review terkait apa saja manfaat interaksi dan keterhubungan dengan alam menyebutkan serangkaian manfaat yang sangat besar dari interaksi dengan alam. Pada literasi tersebut mereka menuliskan beberapa tipologi manfaat hubungan manusia dengan alam sebagaimana dirangkumkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Tipologi Manfaat Interaksi dengan alam²⁰⁷

Manfaat	Deskripsi	Contoh
Kesejahteraan diri (<i>psychological well-being</i>)	Efek positif pada proses mental	Meningkatkan self esteem Meningkatkan mood Menekan amarah/frustasi Menekan kecemasan Meningkatkan perilaku positif
Kognitif	Efek positif pada fungsi kognitif	Restorasi perhatian Menekan kelelahan mental Meningkatkan performa akademik Kesempatan belajar dari alam

²⁰⁶Greogy N. Bratman, J. Paul Hamilton dan Gretchen C. Daily, "The Impact of Nature Experience oh Human Cognitive Function and Mental Health", *Annals of the New York Academy of Science*, (2012); 118-136.

²⁰⁷Lucy E. Keniger, Kevin J. Gaston dan Richard A. Fuller, "What are the Benefit of Interacting with Nature?", *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 10, No. 3, (2013); 913-935.



Fisiologis	Efek positif pada fungsi dan kesehatan fisik	Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah Meningkatkan fungsi kognitif pada anak Meningkatkan produktifitas Menekan tingkat stres Mengurangi tekanan darah Mengurangi level kortisol Mengurangi sakit kepala Mengurangi resiko kematian akibat penyakit peredaran darah Mempercepat kesembuhan Memulihkan perilaku adiktif
Sosial	Efek positif secara individu, komunitas dan skala nasional	Mengurangi resiko kardiovaskular, penyakit respirasi dan penyakit berkelanjutan Memfasilitasi interaksi sosial Penguatan fungsi dan kekuatan sosial Mengurangi tingkat kriminalitas Memungkin interaksi antar ras Meningkatkan kepaduan/kohesi sosial
Spiritual	Efek positif pada peningkatan religiusitas dan kesejahteraan spiritualitas	Meningkatkan dukungan sosial Meningkatkan inspirasi Meningkatkan kesejahteraan spiritualitas

Tangible	Barang material yang bisa dimiliki individu untuk hak kekayaan dan kepemilikan	Suplai makanan Uang dan harta
-----------------	--	----------------------------------

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa alam yang kita berada di dalamnya sangatlah indah dan eksotik. Birunya laut, gemuruh ombak, hijaunya alam dengan aneka flora dan faunanya adalah anugerah Tuhan yang tiada tara. Keeksotikan dan keindahan alam adalah modal untuk kita berpikir, merenung, dan bermuara pada aktivitas untuk memanfaatkan, mengelola, dan menjaga dengan penuh tanggung jawab.²⁰⁸

Selanjutnya dimensi kedua dari dimensi horisontal spiritualitas adalah keterhubungan dengan sesama manusia. Spiritualitas manusia mampu merasakan keterhubungan dengan sesama manusia lain di luar dirinya dan menjadi bagian dari mereka. Fernando (2007) menegaskan bahwa spiritualitas tidak hanya terkait hubungan manusia dengan Tuhan, namun terkait juga dengan hubungan sosial dan lingkungan.²⁰⁹ Keterhubungan antar manusia sejatinya menjadi ajaran agama karena sebagian ritual beragama dilakukan secara bersama-sama, melalui kebersamaan ini spiritualitas pada akhirnya tidak hanya menjadi pengalaman subjektif namun bisa juga menjadi pengalaman kolektif.²¹⁰

Manifestasi dari spiritualitas keterhubungan dengan sesama manusia adalah perilaku yang baik (*amal sholeh*). Sementara Fisher (2010) menyebutnya dengan istilah nilai-nilai moral dan kemanusiaan.²¹¹ Dalam Islam nilai-nilai moral dapat dikatakan pula dengan istilah *akhlak* dimana menurut ‘Abd al-Salam hakikat ajaran Islam

²⁰⁸ Arif Sumatri, *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*, 246.

²⁰⁹ Suman Fernando, “Spirituality and Mental Health Across Culture” in *Spirituality, Values, and Mental Health*, ed Marry Ellen Coyte, Peter Gilbert. & Vicky Nicholls, (London: Jessica Kingsley Publisher, 2007), 63-65.

²¹⁰ Vacher Miller, *Meaning*, “Purpose and Connection: Spirituality in a Learning Society”, Center for International Education at the University of Massachusetts-Amherst, (2013); 1-6.

²¹¹ Jhon Fisher, “Development and Application of a Spiritual Well-Being Questionnaire Called SHALOM”, *Religions*, Vol.1, (2010); 105-121.

berada pada hubungan masyarakat yang memiliki akhlak yang kuat. Muslim yang kuat adalah muslim yang memiliki keterkaitan yang kuat antara satu dengan lainnya dan keistimewaan seorang muslim tercermin dari akhlak yang baik.²¹² Menurut keterhubungan antara sesama manusia merupakan salah satu anugrah Allah yang akan menumbuhkan rasa kasih sayang diantara mereka. Penjelasan ini selaras dengan firman Allah dalam surah Ali ‘Imran ayat 103 sebagai mana berikut :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya :

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. (Q.S. Ali ‘Imran: 103)

Hubungan yang baik ini dapat diekspresikan dalam wujud cinta, peduli, memaafkan, menghormati orang lain dan kerendahan hati. Borins (2011) menuliskan bahwa suatu saat Bunda Teresa pernah menyatakan bahwa penyakit yang sedang mewabah secara global saat ini adalah *“spiritual deprivation/tercabutnya spiritualitas”*, hal ini dapat dilihat dengan hilangnya rasa cinta antara sesama manusia. Menurut ada dinding yang memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Padahal cinta merupakan kekuatan pendorong (*powerful force*) yang memungkinkan setiap individu akan berperilaku baik

²¹² Abd al-Salām al- Hurās, *Al-Islām Dīn al-Wasāṭiyah wa al-Faḍā’il wa al-Qayyim al- Khalīdah* (T.Tp: al-Maktabah al-Shamilah, V. 28, T.Th), 29.

dengan sesama.²¹³ Sebaliknya tanpa keterhubungan cinta antar sesama manusia menyebabkan kekacauan, permusuhan, perpecahan, saling membunuh dan saling dendam.²¹⁴

Cinta menurut Sandep Singh adalah meleburkan rasa ego, karena ego merupakan salah satu bentuk pemisahan diri dengan orang lain yakni (menjadikan orang lain bukan bagian dari diri sendiri). Dengan demikian menurutnya spiritualitas itu adalah *egolessness*. Ketika yang ada pada individu adalah *egolessness* maka yang muncul berikutnya adalah cinta. Cinta bermakna menjadikan orang lain bagian dari sendiri. Menurut cinta adalah menjadikan orang lain bukan seperti orang lain tapi diri sendiri, perilaku menyakiti orang lain adalah menyakiti diri sendiri, menyenangkan orang lain menyenangkan diri sendiri dan mengambil sesuatu dari orang lain bermakna menghilangkan sesuatu dari diri sendiri.²¹⁵

Menurut Denros (2011), orang dengan sifat egoisme hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Egoisme melunturkan semangat kerjasama dan sifat tolong menolong, selanjutnya memunculkan penyakit *tabaghud* (saling membenci), ketika *tabaghud* tidak bisa dipadamkan akan menjadi *'adawah* (permusuha), dan kalau *'adawah* ini tidak bisa dikendalikan akan memunculkan *al-baghyu* yakni pengkhianatan terhadap siapa saja yang dimusuhi. Sehingga pada akhirnya, ketika *al-baghyu* tidak dapat di atasi akan meningkat menjadi *al-haraj* (sudi membunuh), sampai pada saat ini kita tidak lagi melihat masyarakat yang manusiawi.²¹⁶ Dengan demikian dapat dipahami bahwa moralitas adalah bersumber dari cinta, dan imoralitas bersumber dari egoisme.

²¹³Mel Borins, "Pronoia: Attitudinal Change, Love and Spirituality", *The International Journal of Healing and Caring*, Vol.11, No. 3, (2011), t.h.

²¹⁴Hanisah Osman and others, "Islamic View on the Muslim Ethich of Loving", *World Applied Sciences Journal*, Vol. 27, No. 10, (2013); 1380-1384.

²¹⁵Sandeep Singh, *Two Aspects of Spirituality: Ego and Love*, diakses dari <http://www.cshe.smsvaranasi.com/.../Two%20Aspects%20of%20Spiritual> pada tanggal 13 September 2017, pukul 07.43 WIB.

²¹⁶Mukhlis Denros, *Memanusiakkan Manusia: Menjadi Manusia yang Diridhoi Allah Sesuai Contoh Rasulullah*, (Jakarta: Qibla, 2011), 55-56.

Apa yang disampaikan oleh Sandep Singh dan Denros adalah selaras dengan ajaran Islam, dimana tolok ukur kesempurnaan Iman adalah seseorang dapat mencintai saudaranya/sesama manusia seperti mencintai dirinya serta memperlakukan saudaranya sebagaimana seseorang ingin diperlakukan oleh orang lain.

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya:

“Tidak beriman seseorang diantara kalian sehingga ia bisa mencintai saudaranya atau (Rasulullah juga berkata) tentangnya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”. (HR Bukhari dan Muslim)

Beberapa ulama klasik seperti an-Nawawi dalam *Sharah al-Arba'in*, Ibnu Hajar al-Haytami dalam *Fath al-Mubin*, Hamzah Muhammad Qasim dalam *Manar al-Qari* kata “saudara” dalam hadits ini bermakna hukum universal bagi sesama saudara muslim maupun non muslim.²¹⁷

Cinta tidak hanya merupakan perasaan dalam diri, tapi cinta harus dapat dilihat kilauannya dari luar diri orang yang mencintai. Menurut Spangler (2008) manifestasi dari cinta sangat banyak namun ungkapan pertama dari cinta adalah peduli dan kasih sayang.²¹⁸ Peduli dan kasih sayang dalam ungkapan psikologi seringkali dirangkai dalam satu kata, yakni “*comppasion*”. Kata *compassion* memiliki makna sangat luas. *Comppasion* bermakna merasakan simpati, empati terhadap orang lain. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain sedih, susah, kesakitan atau senang dan bahagia. Dalam hal ini *compassion* bermakna peduli. Dalam definisi yang berbeda *compassion* juga berarti penyucian sifat Tuhan yang berarti Maha Pengasih.

Menurut Asghar Ali (2009) menuliskan bahwa mengapa peduli dan kasih sayang/*compassion* menjadi indikator pertama dari

²¹⁷ Abu Amina Elias, “Golden Rule in Islam to Love for Humanity what You Love for Your Self”, *Faith in Allah*, diakses dari <https://abuaminaelias.com/golden-rule-in-islam-love-for-humanity-what-you-love-for-your-self/> pada tanggal 13 September 2017, pukul 11.48 WIB.

²¹⁸ David Spangler, *Crafting Relationship: the Holding of Others*, (Everett, WA: Lorian Press, 2008), 127.

rasa cinta, beliau menjelaskan bahwa setiap surah dari al-Qur'an yang berjumlah 114 bermula dengan bacaan *Bismillahirrahmanirrahim* yang bermakna dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kecuali hanya pada satu surah ke-9 yakni surah Tau-bah.²¹⁹ Arti kata Pengasih dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menterjemahkan kata tersebut digunakan kosa kata "*passionate*" – *In the name Allah Who is Comppasionate and Merciful*-. Sementara menurut Komaruddin Hidayat seorang muslim memiliki kewajiban *takhalluq* yakni secara sadar meniru sifat-sifat mulia sebagaimana sifat-sifat Allah.²²⁰

Dengan demikian dapat dipahami mengapa kemudian beberapa ahli ilmu kejiwaan menyebutkan bahwa peduli dan berkasih sayang merupakan inti dari keterhubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif hubungan antara manusia dengan manusia dijelaskan rasa kasih sayang ini terjalin sejak lagi ketika seseorang lahir, perasaan awal yang terjalin antara ibu dan anak yang muncul pertama kali adalah rasa kasih sayang. Ikatan melalui rasa kasih sayang sangat vital, darinya kehidupan dimulai dan dengannya kehidupan manusia bertahan.

Aspek peduli dan kasih sayang pada beberapa profesi pekerjaan sangat dibutuhkan sebagai bentuk totalitas pelayanan kerja, seperti para pekerja pada pelayanan publik terkhusus pekerja di bidang kesehatan seperti dokter dan perawat. Menurut Grant dan Kinman (2013) para pegawai di pelayanan publik seperti dokter dan perawat merupakan profesi yang menuntut rasa peduli dan kasih sayang sangat tinggi. Tingginya intensitas waktu bekerja memungkinkan mereka mengalami gangguan kelelahan kerja atau yang dikenal dengan istilah "*burnout*", sehingga stabilitas rasa peduli dan kasih sayang harus tetap terjaga untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pasien.²²¹

²¹⁹Asghar Ali Engineer, "Compassion: Islamic Perspective", *Crescent Life* diakses dari http://www.crescentlife.com/spirituality/compassion_islamic_perspective pada tanggal 13 September 2017, pukul 14.11.

²²⁰Komaruddin Hidayat, *Psikologi Ibadah*, (Jakarta: Serambi, 2008),

²²¹Louise Grant dan Gail Kinman, "The Importance of Emotional Resilience for Staff and Students in Helping Professions: Developing and

Terkait dengan tuntutan tersebut salah seorang Subjek pada penelitian ini mengungkapkan bahwa dirinya menyadari untuk menjadi dokter merupakan pilihan profesi yang tidak sama seperti profesi lainnya, karena dalam pelayanan kesehatan selain penguasaan keilmuan, kecepatan dan ketepatan tindakan praktis medis, dirinya menyadari perihal yang terpenting di atas semua itu adalah memberikan pertolongan dan kasih sayang kepada orang lemah khususnya orang sakit. Pasti akan sangat menyenangkan dan menenangkan hati ketika kita dapat melakukan tugas ini dengan baik nantinya.²²²

Berdasarkan ungkapan Subjek di atas, penulis menggaris bawahi bahwa keterhubungan dengan orang lain sebagai dimensi dari spiritualitas dimanifestasikan oleh Subjek dengan keinginan untuk bisa menolong orang lain. Dalam pandangan Islam, berbuat baik seperti menolong orang lain adalah salah satu bentuk kebaikan yang diperintahkan Allah dan dapat bernilai ibadah sebagaimana dituliskan pada ayat 36 dari surah an-Nisa' berikut ini:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, Ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”. (An-Nisa’: 36)

Emotional Curriculum”, *The Higher Education Academy* diakses dari https://www.heacademy.ac.uk/system/files/emotional_resilience_louise_grant_march_2014_0.pdf pada tanggal 13 September 2017, pukul 16.52 WIB.

²²² Wawancara dengan Subjek F (mahasiswi tahun ketiga dengan tingkat stres rendah), pada hari Rabu, Tanggal 8 Februari 2017, Pukul 09.30 WIB.

Keinginan untuk menolong sebagaimana yang diungkap oleh Subjek F berawal dari rasa empati terhadap orang lain. Menurut Canda dan Furman (1999) inti dari spiritualitas adalah menolong, berempati dan mengasihi, dorongan untuk memberi pelayanan kepada orang lain.²²³ Rasa empati dan sikap menolong bisa bermanfaat bagi psikologis. Empati merupakan suatu sifat yang berada pada pusran keterhubungan manusia dengan orang lain. Tanpa rasa keterhubungan dengan orang lain maka individu tidak akan dapat merasakan empati, belas kasih, memaafkan, dan menolong.

Rasa empati sangat diperlukan oleh para ahli medis, karena para ahli medis yang memiliki empati yang tinggi akan meningkatkan rasa nyaman dan kepercayaan pasien, sehingga dapat meningkatkan efek terapeutik dan kualitas hidup pasien.²²⁴ Sebagaimana riset yang dilakukan di Universitas Duke-Program Pusat Bantuan Pasien Jantung para peneliti perilaku gemar menolong orang lain dapat meningkatkan makna hidup dan menekan level stres dan depresi.²²⁵ Sementara studi terkait empati dan stres pada 20 kampus kedokteran di Koreas Selatan dengan melibatkan sekitar 2.702 mahasiswa menunjukkan hasil bahwa empati berhubungan negatif dengan stres, dimana semakin tinggi empati yang dimiliki oleh mahasiswa kedokteran maka mereka akan mengalami tingkat stres yang rendah dalam menjalani masa perkuliahan kedokteran.²²⁶

Berdasarkan penjelasan keseluruhan dari subbab efektifitas spiritualitas dalam pertahanan diri dari stres akademik dapat disimpulkan bahwa hasil analisis kualitatif sejalan dengan hasil analisis kuantitatif yang menyebutkan bahwa dominansi spiritualitas yang

²²³Edward R. Canda dan Leola Dyrud Furman, *Spiritual Diversity in Social Work Practice: the Hearth of Healing 2nd Edition*, (New York: Free Press, 2009), 74.

²²⁴Hanne-Lise Eikeland and others, "The Pshysician's Role and Empathy- a Qualitative Study of Third Year Medical Students", *BMC Medical Education*, Vol. 14, (2014); 1-8.

²²⁵Gwynn Sullivan dan Martin Sullivan, "Promoting Wellness in Cardiac Rehabilitation: Exploring the Role of Altruism", *Journal of Cardiovascular Nursing*, Vol. 11, No. 3, (1997); 43-52.

²²⁶Kyung Hye Park and others, "The Relationship between Empathy, Stress and Social Support among Medical Students", *International Journal of Medical Education*, Vol. 6, (2015); 103-108.

dimiliki mahasiswa adalah teo-sentrik yakni spiritualitas yang terfokus pada keterhubungan diri dengan Tuhan. Hanya saja pada analisis kualitatif dominansi keterhubungan dengan Tuhan lebih jelas dapat diidentifikasi manifestasinya, seperti: *tawakal* (berpasrah diri), *raja'* (berharap), *i'tiqad* (percaya dan yakin), *muraqabah* (merasa diawasi), *isti'anah* (minta pertolongan). Selanjutnya keterhubungan dengan Tuhan juga dimanifestasikan mahasiswa lewat ibadah *salah* (shalat) dan *tilawah al-Qur'an* (membaca al-Qur'an). Dengan demikian hal ini selaras dengan pandangan Nasr (1997) sebagaimana penulis kutipkan pada bab sebelumnya teori yang telah bahwa spiritualitas dalam Islam harus berlandaskan teologi yakni keimanan dan keyakinan akan Tuhan dan diimplementasikan dalam bentuk ritual ibadah, perilaku dan kehidupan sehari-hari.

Namun demikian dominansi domain keterhubungan dengan Tuhan bukan berarti menafikan keterhubungan spiritualitas mahasiswa dengan sesama dan makhluk lainnya. Hasil analisis kualitas menjelaskan keterhubungan dengan diri sendiri dimanifestasikan dengan *qasad* (tujuan) dan *mufidah* (makna) hidup; hubungan komunal dimanifestasikan dengan *'amal al-salih* (perbuatan baik), *takhalluq* (meniru sifat Allah); dan hubungan dengan lingkungan dimanifestasikan dengan *tadabur* (memahami alam), *tawassum* (mengagumi alam) dan *al-hifz* (menjaga alam). Secara lebih ringkas hasil analisis kualitatif ini dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. Manifestasi Spiritualitas: Dari *Distress* Menuju *Eustress*

Indikasi Distress	Dimensi Spiritualitas	Manifestasi Spiritualitas	Indikasi Eustress
. Cemas . Bermalasan	Transenden (Hubungan Vertikal)	Hubungan dengan Tuhan	. Tenang . Giat berusaha
. Putus asa . Berburuk sangka			. Optimis . Berbaik sangka
. Tidak puas . Takut			. Puas . Berani
. Merasa sendirian			. Merasa ditemani
. Merasa Lemah			. Mendapatkan kekuatan

			Pertolongan)	
. Gelisah			<i>Ṣalah</i> (Sholat)	. Tentram
. Sedih . Cemas .Sulit konsentrasi		Ibadah	<i>Tilāwa al-Qur’ān</i> (Membaca al-Qur’an)	. Bahagia . Tenang .Mudah konsentrasi
. Tidak terarah . Tidak teratur			<i>‘qasd</i> (tujuan)	. Terarah . Teratur
.Tidak percaya diri		Personal	<i>‘al-mufidah</i> (makna diri)	. Percaya diri
. Apatis . Dis-sosial .Mudah tersinggung . Murung	Harmonisasi sesama manusia dan alam (hubungan horisontal)		<i>‘Amal al-ṣalih</i> (Perbuatan baik) . menolong . memaafkan	. Simpati . Altruis .Nyaman . Ceria
. Sinis . Cuek . Benci . Apatis		Komunal	<i>Takhalluq</i> (meniru sifat Allah) . mencintai . menyanyangi	. Ramah . Peduli . Cinta . Empati
. Sedih . Cemas			<i>Tadabbur</i> (memahami alam)	. Bahagia . Nyaman
. Gelisah			<i>Tawassum</i> (Mengagumi alam)	.Rileks
. Tidak peduli		Lingkungan	<i>Al- hifz</i> (menjaga alam)	. Peduli

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa teori “*conservation of resources theory*” yang menyatakan bahwa tekanan psikologis terjadi ketika sumber signifikan hilang adalah selaras dengan hasil

analisis pada penelitian ini, yakni ketika mahasiswa mampu mempertahankan fungsi positif spiritualitas pada dirinya dan mampu memantapkan spiritualitas secara seimbang antara keterhubungan diri dengan Tuhan (vertikal) dan keterhubungan diri dengan sesama manusia dan makhluk lainnya (horizontal), maka mereka akan terhindar dari gangguan psikologis stres. Hasil analisis kualitatif ini juga selaras dengan hasil analisis kuantitatif dimana secara signifikan spiritualitas berpengaruh menekan stres, yakni semakin tinggi spiritualitas individu semakin rendah stres yang dirasakan.

Hubungan spiritualitas dan stres pada hasil kualitatif ini juga selaras dengan teori “*distress-deterring model*” atau “*stress counterbalancing model*” yakni spiritualitas berguna dalam menghadapi stres.²²⁷ Dimana dalam perspektif Islam Syekh Muhammad Ṣalih al-Munajjid sebagaimana dikutipkan penulis pada bab sebelumnya menjelaskan bahwa ketika seseorang menyerahkan urusan kepada Allah maka dia akan terbebas dari berbagai pikiran negatif, kecemasan dan rasa tertekan dari apa yang sedang dihadapinya. Bahkan sebaliknya jiwa seseorang tersebut akan mendapatkan kekuatan serta merasakan relaks dan kegembiraan.²²⁸

Dari deskripsi penulis terkait analisis kualitatif pengaruh spiritualitas terhadap stres, dapat dipahami bahwa manifestasi spiritualitas yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengatasi stres adalah melalui dua cara. *Pertama*, menjalin hubungan pada Tuhan dengan meningkat kepercayaan, kepasrahan diri, dan harapan pada-Nya. Termasuk pula pada aspek keterhubungan dengan Tuhan ini diimplementasikan mahasiswa dengan cara meningkatkan ketaatan diri dalam beragama seperti dengan menjalani sholat, berdoa dan membaca kitab suci. *Kedua*, menjalin hubungan harmoni dengan alam dengan cara menjaga lingkungan dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Secara khusus dalam rangka proses menjadikan diri mereka sebagai para ahli medis profesional, maka meningkatkan rasa empati dan dorongan bisa banyak menolong orang lain menjadi cara implementasi spiritualitas yang dapat mengurangi stres akademik yang dirasakan.

²²⁷Harold. G. Koenig, *Handbook of Religion and Mental Health*, (United States Of America: Elsevier Science, 1998), 131.

²²⁸Sheik Muhammad Ṣalih al-Munajjid, *Dealing With Worries and Stress*, (United Kingdom, Dar as-Sunnah Publisher, 2013), 14.

D. Spiritualitas dan Regulasi Diri Belajar Sebagai Koping Proaktif

1. Implementasi Regulasi Diri Belajar melalui *Self Testing* dan *Self Talking*

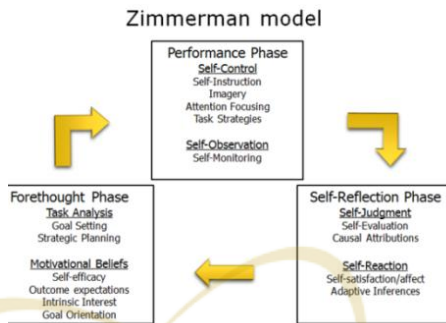
Proses regulasi diri dalam beberapa literasi penelitian terbukti berhubungan dengan optimalisasi fungsi diri pada anak-anak, remaja dan dewasa dengan berbagai perbedaan latar belakang, baik dari kalangan akademik, atlet, musisi maupun sebagai sistem pemeliharaan kesehatan mental.²²⁹ Pada disertasi ini regulasi diri hanya berfokus pada dunia akademik sehingga menjadi regulasi diri belajar pada remaja yakni mahasiswa. Adapun pemeliharaan kesehatan mental dalam hal ini dibatasi pada keterhubungannya dengan stres akademik.

Pada prinsipnya di kalangan mahasiswa kedokteran regulasi diri belajar diaplikasikan dalam dua area: *pertama*, meningkatkan prestasi akademik dan menghindari segala gangguan untuk itu, *kedua*, meningkatkan performa klinis. Adapun penulis hanya fokus kepada area pertama dikarenakan mahasiswa yang ikut adalah mahasiswa preklinik yakni mahasiswa tahun pertama, kedua dan ketiga. Proses regulasi diri belajar terjadi ketika mahasiswa mengaktifkan ketiga sistem diri yakni kognitif, motivasi dan perilaku mereka dalam proses belajar mengajar.

Regulasi diri belajar merupakan proses siklus yang berputar yang meliputi *forethought*, *performance*, dan *self reflection*. *Forethought* merupakan fase persiapan, dimana individu membuat tujuan dan sasaran tugas belajar serta merencanakan strategi belajar. *Performance (during)* merupakan tahap yang dilakukan selama proses belajar yang meliputi penggunaan strategi dan monitoring performa diri. *Self reflection* merupakan tahap terakhir yakni tahap *sesudah* belajar, pada tahap ini individu akan melakukan *evaluasi* diri sejauh mana target belajar dicapai melalui strategi-strategi yang telah dilakukan.

²²⁹Jhon Sandars dan Timothy J. Cleary, "Self-Regulation Theory: Applications to Medical Education", *Medical Teacher*, Vol. 33, No. 11, (2012); 875-886.

Bagan 4.2. Fase Regulasi Diri Belajar



Sumber: Barry J. Zimmerman, “Becoming a Self-Regulated Learner: an Overview”, *Theory into Practice*, Vol. 41, No. 2, (2002); 64-70.

Dari bagan di atas dapat dipahami bahwa agar dapat melakukan regulasi diri belajar yang efektif individu harus memulai dengan tujuan (*goal*) dan motivasi terlebih dahulu, selanjutnya melakukan strategi belajar yang tepat dan terakhir melakukan evaluasi performa diri. Kemudian regulasi diri belajar akan terus berulang dari tahap akhir ke tahap awal kembali selama individu melakukan refleksi diri dan akan menyesuaikan dan mempersiapkan tugas belajar berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif pada bab sebelumnya, indikator kognitif merupakan manifest dominan pada pembentukan laten variabel regulasi diri belajar. Regulasi diri kognitif bermakna kemampuan dan kesadaran diri untuk mengontrol belajar, merencanakan, memilih strategi, memperbaiki kesalahan, dan monitoring perkembangan belajar.²³⁰ Diantara strategi pembelajaran terkait regulasi diri kognisi yang diungkap pada analisis kualitatif adalah mahasiswa cenderung melakukan strategi kognisi ini dengan cara menguji diri sendiri atau *self testing*. Sebagaimana diungkapkan oleh Subjek B, bahwa dirinya ketika belajar terbiasa untuk membaca dulu sumber-sumber terkait dengan materi yang harus dikuasai. Berikutnya dirinya mencoba lebih memahami materi dengan cara menyelesaikan quiz-

²³⁰Sevgi Turan, Özcan Demirel dan Iskender Sayek, “Metacognitive Awareness and Self-Regulated Learning Skills of Medical Students in Different Medical Curricula”, *Medical Teacher*, Vol. 31, No. 10, (2009); e477-e483.

quiz seperti pertanyaan-pertanyaan *multiple choice* yang biasanya disediakan di bagian belakang dari beberapa buku-buku ajar. Sekiranya pada beberapa buku tidak ada dirinya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh dirinya sendiri. Kemudian dari test yang dilakukannya sendiri, dirinya bisa menilai sejauh mana dirinya telah menguasai materi-materi perkuliahan.²³¹

Menurut analisa penulis apa yang dinarasikan oleh Subjek B menunjukkan bahwa dalam proses belajar dirinya melakukan bagian dari regulasi diri kognisi yang berupa “*self testing*”. *Self testing* merupakan salah satu bentuk cara praktek mengulang pelajaran (*retrieval practice*). Pada umumnya ketika mengulangi pelajaran, para pelajar kebanyakan melakukannya dengan cara membaca ulang catatan atau membaca ulang buku ajar. Namun dalam *self testing* individu cenderung melakukan penguatan pemahaman materi dan penguasaan materi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang sedang dipelajari.²³²

Hasil analisis kualitatif ini selaras dengan hasil studi West and Sadoski yang mengkonfirmasi bahwa *self-testing* merupakan prediktor utama yang dipakai oleh mahasiswa kedokteran khususnya mahasiswa dari tahun pertama.²³³ Pada studi lainnya terkait keilmuan kesehatan, 90% mahasiswa kedokteran menyatakan bahwa *self testing* bermanfaat meningkatkan hasil belajar klinis.²³⁴ Pada penelitian serupa 85% mahasiswa ilmu kesehatan mendapatkan peningkatan nilai pada setiap ujian dari empat blok perkuliahan ketika memprak-

²³¹Wawancara dengan Subjek B (mahasiswi tahun pertama dengan tingkat stres rendah), pada hari Senin, Tanggal 6 Februari 2017, Pukul 12.30 WIB.

²³²David Stewart and others, “Pharmacy Students Self-Testing as a Predictor of Examination Performance”, *American Journal of Pharmaceutical Education*, Vol. 78, No. 2, (2014); 1-6.

²³³Coutney West, Mark Sadoski, “Do Study Strategies Predict Academic Performance in Medical School?”, *Medical Education*, Vol. 45, No. 7, (2011); 696-703.

²³⁴Douglas P. Larsen, Andrew C. Butler dan Henry L. Roediger, “Comparative Effects of Test-Enhanced Learning and Self-Explanation on Long-Term Retention”, *Medical Education*, Vol. 47, No. 7, (2013); 674-682.

tekan *self testing*.²³⁵ Dengan hal ini pada hasil-hasil riset menunjukkan fungsi positif *self testing* dalam meningkatkan performa akademik.

Pada hasil analisis kualitatif yang berbeda, regulasi kognisi ini dimanifestasikan dengan cara *self talk* (berbicara dengan diri sendiri). Sebagaimana hasil wawancara dengan Subjek F yang mengungkapkan bahwa ketika belajar dirinya seringkali mengeraskan suara pada beberapa teks dari buku yang dibaca, seolah-olah ia menjelaskan kepada dirinya sendiri bagian tersebut. Ketika belajar ia juga seringkali berbicara dengan diri sendiri bagian-bagian mana saja yang penting dan harus betul-betul dipahami, dipelajari, serta diingat. Termasuk pula kalau sedang belajar untuk ujian, biasanya Subjek membuat pertanyaan-pertanyaan kecil dari materi yang ia pelajari yang terkadang ia tuliskan dan terkadang hanya muncul dalam pikirannya saja. Apa yang Subjek lakukan menurutnya akan mengurangi rasa tegang dan cemas ketika keesokan harinya memasuki ruangan ujian. Subjek juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa lebih tenang dan lebih siap untuk ujian.²³⁶

Sebagaimana Bandura mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia bukan partisipan pasif dalam belajar, tetapi mereka sangat proaktif untuk mengontrol perilaku, kognisi dan lingkungan belajar. Seorang yang frustrasi dengan tuntutan membaca buku, biasanya akan mencari tempat yang tenang untuk membaca dan akan mengaktifkan "*self talk*". *Self talk* merupakan salah satu regulasi kognisi, seringkali digunakan dalam aktifitas membaca untuk meningkatkan pusat perhatian ketika membaca, memblock gangguan konsentrasi membaca, dan meningkatkan efikasi diri.²³⁷

²³⁵Peter C. Panus and others, "A Subgroup Analysis of the Impact of Self-Testing Frequency on Examination Scores in a Pathophysiology Course", *American Journal of Pharmaceutical Education*, Vol. 78, No. 9, (2014); 1-8.

²³⁶Wawancara dengan Subjek F (mahasiswi tahun ketiga dengan tingkat stres rendah), pada hari Rabu, Tanggal 8 Februari 2017, Pukul 09.30 WIB.

²³⁷Jhon Sandars dan Timothy J. Cleary, "Self-Regulation Theory: Application to Medical Education", *Medical Teacher*, Vol.33, No. 11, (2011); 875-886.

Self talk bisa dilakukan dengan suara yang dikeluarkan lewat mulut sehingga terdengar oleh telinga sendiri, dan atau juga bisa dilakukan dengan tanpa suara atau samar-samar yang bisa didengarkan oleh seseorang itu sendiri atau istilahnya “*covert self-talk*”, karena manusia pada fungsi dirinya memiliki “*inner ear*” yang dapat mendeteksi suara kecil yang ada di dalam kepalanya.²³⁸ *Self talk* merupakan fenomena yang hampir bisa kita temui dimana saja kita berada, hampir dari waktu ke waktu kita sering melakukan monolog dengan diri sendiri, khususnya ketika dalam keadaan stres. *Self talk* berperan untuk meregulasi pikiran untuk lebih rileks menghadapi keadaan yang menegangkan, sebagaimana Subjek menjelaskan dengan melakukan *self talk* dan memberikan sugesti yang baik pada diri sendiri, dirinya dapat merasa lebih tenang dan nyaman meskipun sedang menghadapi keadaan yang menegangkan seperti ujian. Hal ini senada dengan hasil studi yang dilakukan oleh Kros et al(2014) bahwa manipulasi *self talk* yang diberikan kepada total 585 responden menunjukkan hasil bahwa *self talk* dapat meningkatkan *self-distance*, meregulasi stres yang terjadi di persekitaran, mengurangi tingkat stres dan mengurangi koping *maladaptive* ketika menghadapi stres.²³⁹

2. Spiritualitas dan Peningkatan Regulasi Diri Belajar

Keterhubungan antara spiritualitas dan regulasi diri belajar dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, spiritualitas dan regulasi diri merupakan kemampuan diri manusia, dimana dengan keduanya individu bisa memprediksi adaptasi dan optimalisasi fungsi diri untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan mencapai tujuan yang dikehendaki.²⁴⁰ *Kedua*, Spiritualitas dan regulasi diri merupakan bentuk

²³⁸James Hardy, “Speaking Clearly: a Critical Review of the Self-Talk Literature”, *Psychology of Sport and Exercise*, Vol. 7, (2006); 81-97.

²³⁹Ethan Kross and others, “Self-Talk as a Regulatory Mechanism: How You Do it Matters”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 106, No. 2, (2014); 304-324.

²⁴⁰Maryam Hosseini and others, “A Review Study on Spiritual Intelligence, Adolescence, and Spiritual Intelligence, Factors that may Contribute to Individual Differences in Spiritual Intelligence and the Related Theories, *International Journal of Psychology Studies*, Vol.2, No. 2, (2010); 179-188.

kesadaran diri/*self consciousness*, spiritualitas terpusat kepada kesadaran diri untuk terhubung dengan orang lain diluar dirinya meliputi Tuhan, manusia, lingkungan, hewan dan alam semesta.²⁴¹ Sementara regulasi diri harus dilakukan secara sadar (*conscious*) dan penuh usaha (*effortful*) untuk mencapai sebuah tujuan.²⁴² Pada beberapa literasi penelitian psikologi *self consciousness* ini diperlukan untuk melakukan kontrol diri dan menghindari diri dari gangguan psikologis seperti stres.²⁴³ Sebagaimana hasil analisis pada sub bab sebelumnya menegaskan bahwa spiritualitas dan regulasi diri berhubungan negatif dengan stres akademik.

Pada analisis kualitatif yang dilakukan penulis, hubungan antara spiritualitas dan regulasi diri belajar pada penelitian ini terjadi melalui dimensi regulasi diri emosi (*emotional self regulation*) dan regulasi tindakan diri (*behavioral self regulation*). Pertama, aspek spiritualitas yang berhubungan dengan regulasi diri emosi adalah efikasi diri. Efikasi diri merupakan salah satu konsep diri, berupa kepercayaan individu akan kemampuannya untuk sukses melakukan sesuatu. Dalam konsep regulasi diri, efikasi diri merupakan salah satu bentuk regulasi diri emosi yang berfungsi untuk meningkatkan keterlibatan individu secara aktif dalam proses belajar. Individu dengan *self esteem* yang tinggi yakin akan kemampuan dirinya untuk bisa menyelesaikan tugas, menemukan jawaban yang paling tepat, memenuhi tujuan dan seringkali mengungguli teman-teman sebayanya.²⁴⁴

²⁴¹William G. Huiit dan Jennifer L. Robbins, *An Introduction to Spiritual Development*, Paper Presented at the 11th Annual Conference: Applied Psychology in Education, mental Health, and Business, (2003), diakses dari

<http://www.edpsycinteractive.org/papers/spirituality.pdf>, pada tanggal 18 September 2017, pukul 15.23 WIB.

²⁴²Hilal Bashir dan Liyaqat Bashir, "Investigating the Relationship between Self-Regulation and Spiritual Intelligence of Higher Secondary School Students", *Indian Journal of Health and Wellbeing*, Vol. 7, No. 3, (2016); 327-329.

²⁴³Georgia Panayiotou dan Constantinos M. Kokkinos, "Self-Consciousness and Psychological Distress: a Study Using the Greek SCS", *Personality and Individual Differences*, Vol. 41, (2006); 83-93.

²⁴⁴Sy-Yi Tzeng dan Hwa-Ming Nieh, "How Self-Concept, Self-Efficacy and Self-Evaluation Relate to Achievement Outcomes", *Pro-*

Sebagaimana dimensi keterhubungan dengan Tuhan merupakan dimensi spiritualitas yang dominan pada mahasiswa. Maka keterhubungan akan Tuhan akan memunculkan perspektif diri bahwa Tuhan telah memberikan kemampuan atas masing-masing individu untuk melakukan tugas dan kewajibannya. Dalam ajaran Islam hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 286.²⁴⁵ Subjek D menjelaskan meskipun dirinya menyadari bahwa ke depannya nanti proses pendidikan kedokteran ini akan sangat sulit dijalani mulai dari penguasaan materi pada masa preklinik sampai nanti memasuki masa klinik, dimana semua proses belajar yang akan dihadapi pasti akan sangat membutuhkan ketahanan mental. Namun demikian Subjek tidak terlalu banyak mengkhawatirkan hal tersebut. Sebagaimana dirinya yakin bahwa Allah yang membukakan jalan dirinya untuk bisa duduk di fakultas ini, maka ia juga meyakini bahwa Tuhan pula akan memberinya kemampuan luar biasa nantinya untuk bisa menyelesaikan studi ini.²⁴⁶

Dengan demikian melalui spiritualitas keterhubungan yang baik dengan Tuhan Subjek meyakini bahwa dirinya pasti mampu menyelesaikan beban studi perkuliahan. Hal ini selaras dengan ajaran Islam bahwa konsep kepercayaan diri merupakan pengendalian diri pada bakat, kemampuan, potensi, martabat dan ketergantungan diri hanya pada Tuhan yang telah menganugerahkan berbagai kelebihan pada manusia. Dalam Islam manusia harus memuliakan dirinya sendiri sebagaimana Allah sendiri telah menyatakan bahwa manusia adalah *khalifah fī al-ard*.²⁴⁷

Selanjutnya ketidakkhawatiran Subjek terhadap kesulitan yang mungkin akan dihadapi menjelaskan efek *self esteem* yang ia miliki terhadap kesehatan mental dirinya. Dimana kesehatan mental

ceedings of International Conference on Interactive Collaborative Teaching, (Italia: 2015).

²⁴⁵“*Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya,....*” (al-Baqarah: 286).

²⁴⁶Wawancara dengan Subjek D (mahasiswa tahun pertama dengan tingkat stres rendah), pada hari Jum'at, Tanggal 17 Februari 2017, Pukul 10.00 WIB.

²⁴⁷Fatimah Ghodrati, “The Importance of Self-Esteem in Islam and Its Impact on Physical and Mental Health”, *Scholar Journal of Applied Medical Science*, Vol. 4, No. 5B, (2016); 1566-1569.

ini bermanfaat bagi individu untuk bisa mengatasi stres harian dan berhubungan baik dengan orang lain sebagai bagian dari masyarakat.²⁴⁸ Dengan demikian dapat dipahami ketidakhawatiran Subjek merupakan keadaan tidak cemas, sehingga secara singkat bisa diungkapkan bahwa spiritualitas dapat meningkatkan kepercayaan diri sebagai bagian dari regulasi diri emosi dan kepercayaan diri ini berhubungan negatif dengan kecemasan. Semakin tinggi spiritualitas maka regulasi diri emosi individu akan semakin tinggi.

Kedua, aspek spiritualitas yang berhubungan dengan regulasi diri tindakan adalah manajemen waktu. Alasan mengapa mahasiswa kedokteran sangat beresiko dengan stres harian, beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka berpacu dengan waktu, tugas cukup banyak namun waktu yang dimiliki sangat terbatas. Sehingga manajemen waktu merupakan aspek krusial dalam regulasi diri belajar tindakan (*self regulated behavior*) dalam menyikapi kesibukan harian mahasiswa sebagai pelajar. Carrol (1963) menjelaskan teori manajemen waktu dalam regulasi diri yang dikembangkan menjadi "*Carroll's model of student learning*", menurutnya manajemen waktu berkembang dalam tiga elemen proses belajar. Elemen-elemen ini adalah *apptitude*, yakni sejumlah waktu yang diperlukan untuk mempelajari tugas di bawah kondisi instruksional yang optimal; *perseverance*, yakni sejumlah waktu yang diinginkan pelajar untuk terlibat aktif dalam proses belajarnya; dan *opportunity to learn*, yakni waktu yang tersedia untuk belajar.²⁴⁹

Dalam konsep psikologi belajar, regulasi diri perilaku belajar diimplementasikan dengan optimalisasi penggunaan sumber-sumber yang bisa memaksimalkan proses belajar yang meliputi; waktu, tempat dan sumber media belajar. Dalam artian pelajar harus menyadari waktu yang paling tepat buat dirinya belajar dan mengulangi pelajaran.²⁵⁰ Beberapa Subjek dalam penelitian ini rata-rata menyebutkan

²⁴⁸Bruce Byrne, "Relationship between Anxiety, Fear, Self-esteem, and Coping Strategies in Adolescence", *Journal of Adolescence*, Vol. 35, (2000); 201-215.

²⁴⁹Jhon B. Carrol, "A Model of School Learning", *Teachers College Record*, No. 64, (1963); 723-733.

²⁵⁰Sayedeh Hannaneh Hadavi, Masoud Ahmadi dan Saied Saffarian Hamedani "Understanding the Relationship between ICT and Self-Regulated Learning Students of , Islamic Azad University of Sari", *International*

spesifik waktu yang telah meraka atur untuk belajar. Salah satunya Subjek D mengungkapkan dirinya terbiasa dengan pengelolaan waktu dan disiplin diri sendiri untuk setidaknya bisa membaca al-qur'an minimal 1 halaman selesai magrib. Pada waktu-waktu tertentu, biasa karena lelah setelah mengikuti perkuliahan seharian dirinya seringkali tidur di awal waktu malam, kemudian akan bangun sekira pukul 22.00 atau 23.00 malam untuk mengerjakan sholat Isya' yang dilanjuti dengan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Subjek juga menjelaskan dirinya terbiasa bangun pagi juga karena harus mengerjakan sholat shubuh.²⁵¹

Menurut analisis penulis ketaatan beribadah yang dimiliki oleh Subjek D secara tidak langsung memunculkan regulasi diri waktu dan disiplin diri. Sebagaimana menurut Hamdan (2010) sebagaimana dikutip penulis pada bab sebelumnya, bahwa spiritualitas dalam Islam khususnya pada aspek ibadah dapat meningkatkan disiplin diri.²⁵² Hasil analisis kualitatif ini selaras dengan hasil kuantitatif yang terlebih dahulu pada bab sebelumnya penulis deskripsikan, bahwa domain spiritualitas yang paling tinggi memengaruhi regulasi diri belajar adalah keterhubungan dengan Tuhan, sementara aspek regulasi diri belajar yang paling dominan dipengaruhi oleh domain ini adalah aspek perilaku (*behavior*). Subjek D dengan konsistensi diri menjaga waktu sholat, secara tidak langsung memengaruhi dirinya untuk meregulasi perilaku aktifitas hariannya yakni bangun di waktu pagi.

Beberapa ibadah dalam Islam telah diatur tata cara, tempat dan waktu pelaksanaannya, seperti sholat wajib lima waktu dalam Islam secara tidak langsung mengajarkan manajemen waktu yang baik. Ungkapan Subjek terkait pembagian waktu malam untuk membaca al-Qur'an merupakan kebiasaan yang baik. Dimana berdasarkan

Journal of Economy, Management and Social Sciences, Vol. 3, No. 12, (2014); 905-908.

²⁵¹ Wawancara dengan Subjek D (mahasiswa tahun pertama dengan tingkat stres rendah), pada hari Jum'at, Tanggal 17 Februari 2017, Pukul 10.00 WIB.

²⁵² Aishah Hamdan (2010), "A Comprehensive Contemplative Approach from the Islamic Tradition, Bab dalam Thomas G. Plante, *Contemplative Practice in Action: Spirituality, Meditation, and Health*, (Santa Barbara: Praeger, 2010), 122-142.

riset yang dilakukan Di Malaysia pada sejumlah 416 Mahasiswa di International Islamic University Malaysia (IIUM), hasil studi mengungkapkan bahwa terdapat hubungan interaksi moderasi antara kebiasaan membaca al-Qur'an dan regulasi diri belajar dengan prestasi akademik.²⁵³

Spiritualitas yang diwujudkan dengan ketaatan beribadah secara tidak langsung memunculkan disiplin diri untuk meregulasi waktu dengan baik, seperti Subjek yang terbiasa terbangun malam untuk sholat kemudian diikuti belajar malam secara tidak langsung menjelaskan bahwa kebiasaan terjaga dan belajar malam diawali dengan ibadah sholat. Termasuk pula kebiasaan bangun di awal pagi juga terbentuk karena ketaatan individu untuk menjalankan ibadah sholat shubuh. Al-Jeraisy (2008) menjelaskan manajemen waktu dalam Islam, bahwa diantara perilaku muslim dalam manajemen waktu adalah tidur di awal waktu malam dan terbangun sebelum matahari tinggi. Menurutnya para ulama salaf seringkali terbingungkan bagaimana seseorang mengharap keberkahan dan kebahagiaan hidup sementara dirinya mendirikan sholat shubuh kesiang.²⁵⁴

Dengan demikian dapat dipahami hasil analisis kualitatif yang menunjukkan bahwa spiritualitas berhubungan positif dengan regulasi diri belajar adalah selaras dengan analisis kuantitatif yang secara statis dibuktikan memiliki hubungan signifikan positif, dalam artian semakin tinggi spiritualitas maka semakin tinggi regulasi diri belajar. Hasil analisis ini juga selaras dengan pandangan Koole et al (2010) sebagaimana dikutipkan penulis pada bab sebelumnya, bahwa spiritualitas dan religiusitas secara otomatis dan implisit berhubungan dengan regulasi diri.²⁵⁵ Pada analisis kualitatif hal ini ditegaskan dengan spiritualitas mahasiswa dapat meregulasi tindakan diri terkait dengan manajemen waktu. Ellis (2000) menegaskan bahwa manaje-

²⁵³Esam Eltigani Mohamed Ibrahim, and others, "Interaction with the Qur'an and Self Regulated Learning Vis-a-Vis Academic Achievement of Undergraduate Students", *International Journal of Current Research and Academic Review*, Vol.3, No. 9, (2015); 189-197.

²⁵⁴Khaled Ibn Abdul- Rahman, *Time Mangement from Islamic and Administrative Perspective* (1st Edition), (al-Riyad, 2008), 126

²⁵⁵Sander L. Koole and others, "Why Religion's Burdens Are Light: from Religiosity to Implicit Self-Regulation", *Personality and Social Psychology Review*, Vol. 14, No. 1, (2010); 95-107.

men waktu ini merupakan salah satu komponen dari banyak program strategi dan keterlampiran belajar yang disampaikan di perguruan tinggi. Pada beberapa kajian riset manajemen waktu juga terbukti dapat memberikan pengaruh positif seperti meningkatkan efikasi diri, menekan tingkat stres dan meningkatkan nilai IPK mahasiswa.²⁵⁶

3. Koping Emosi dan Perilaku melalui Spiritualitas dan Regulasi Diri

Memperhatikan bahwa stres saat ini seolah menjadi bagian dari kehidupan yang seolah tidak terpisahkan, maka pengembangan literasi terkait stres selanjutnya banyak membahas terkait upaya positif dan pengembangan pertahanan diri individu dari kejadian stres yang lebih akut. Hal-hal yang dapat diupayakan individu untuk mengurangi atau menghilangkan ketidaknyamanan efek stres terhadap kualitas diri inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *coping*/koping. Menurut Mosely (1992) koping usaha inidividu untuk merubah kognitif, tingkah laku ketika untuk mengelolah, mengurangi atau mengontrol stres.²⁵⁷ Strategi koping positif dapat mengurangi stres dan bermanfaat jangka panjang, namun koping negatif bisa meringankan stres hanya dalam jangka waktu pendek tapi dapat berbahaya bagi fisik dan psikis di kemudian hari.²⁵⁸ Dalam artian singkat koping yang baik dapat meringankan stres dan sebaliknya koping yang buruk justru dapat meningkatkan stres.

Terkait koping positif dan koping negatif kemudian banyak dikembangkan oleh para ahli yang secara umum pandangan-pandangan mereka berdasarkan pada dua dimensi seperti (+)*adaptiv* vs (-) *mal-adaptive*, (+)*approach* vs (+)*avoidance* atau (+)*direct* vs (-)*defensive*. Makna ketiga istilah yang digunakan para ahli pada hakikatnya

²⁵⁶Krista P. Smith Terry, *The Effects of Online Time Management Practice on Self Regulated Learning and Academic Self Efficay*, Disertasi Doktor Teknologi Pendidikan pada Virginia Polytechnic Institute and State University, (2002).

²⁵⁷Thomas H. Mosely and others, "Stress, Coping and Well-Being among Third Year Medical Students", *Academic Medicine*, Vol. 69, N0. 9, (1994); 765-767.

²⁵⁸Layntiwe Pariat and others, "Stress levels of College Students: Interrelaionship between Stressors and Coping Strategies", *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 9, No. 19, (2014); 40-46.

adalah sama yakni pada tanda positif (+) menjelaskan bahwa individu mengetahui bahwa sumber stres yang dihadapi tidak menyenangkan namun ia berpikir dan mencari jalan untuk menghadapi stres tersebut dengan melakukan sesuatu. Namun sebaliknya pada tanda negatif (-) bermakna individu meyakini bahwa stresor tidak dapat dinegosiasi efeknya terhadap dirinya sehingga ia bersikap seolah menipu sendiri dengan cara meninggalkan keadaan tersebut atau bisa disebut juga dengan istilah lari dari masalah.

Selain dari pada beberapa istilah koping yang saling berlawanan seperti di atas, terdapat salah satu teori koping yang juga telah banyak diketahui dan digunakan yakni teori Lazarus (1991), dalam hal ini Lazarus memisahkan koping pada dua dimensi yakni *emotions-focused coping* (koping berbasis emosi) dan *problem-focused coping* (koping yang berbasis pemecahan masalah). Adapun penelitian ini menggunakan teori dari Lazarus yang selanjutnya *emotion-focused coping* dijelaskan dengan spiritualitas dan *problem-focused coping* dijelaskan dengan regulasi diri belajar.

Emotions-focused coping merupakan usaha untuk meregulasi emosi yang timbul akibat stres. Koping berbasis emosi ini juga bisa berarti tindakan atau usaha kognitif yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan sosial ketika menghadapi keadaan yang tertekan.²⁵⁹ Terkait pencarian dukungan sosial untuk penguatan diri, Nelson (2009) menjelaskan ada tiga tipe dukungan: *direct support* (dukungan langsung) seperti teman, keluarga dan masyarakat sosial, *indirect support* (dukungan tidak langsung) seperti stabilitas pernikahan, hubungan keluarga dan pertemanan dan dukungan Tuhan atau sumber-sumber Suci lainnya, tipe kesatu dan kedua merupakan bentuk dukungan horisontal adapun yang ketiga adalah hubungan vertikal.²⁶⁰ Menurut analisa penulis, dengan demikian spiritualitas secara tidak langsung menjadi sebuah bentuk koping emosi karena melalui perilaku-perilaku spiritualitas (seperti sholat, do'a dan membaca kitab) dan keyakinan serta kepasrahan diri pada tuhan sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan pada bab sebelumnya menjadi salah bentuk

²⁵⁹Jane Ogden, *Health Psychology: A Textbook*, (UK: Mc Graw-Hill Education, 2007), 257.

²⁶⁰James M. Nelson, *Psychology, Religion, and Spirituality*, (New York: Springer, 2009), 311.

koping emosi yang dilakukan mahasiswa dalam menghadapi stres akademik.

Pada hasil analisis kualitatif terkait manifestasi spiritualitas oleh mahasiswa pada sub bab sebelumnya dapat dipahami hal tersebut secara tidak langsung merupakan bentuk koping emosi. Seperti kepercayaan dan ketaatan beribadah yang dilakukan oleh mahasiswa, menurut Koenig (2003) kepercayaan, sikap dan praktek ibadah sebagai bentuk ketaatan dapat menekan emosi berlebihan yang disebabkan oleh kejadian hidup yang tidak menyenangkan dan menyebabkan penderitaan, sehingga efek kronisnya bisa ditahan atau dicegah.²⁶¹ Individu yang spiritualis bisa merubah interpretasi, reaksi diri terhadap stres, dan kepercayaan (*belief*) juga akan memfasilitasi sikap positif terhadap koping dan akan memperkuat dukungan sosial dalam merespon stres.²⁶²

Pada aspek personal, spiritualitas sebagai koping emosi dapat memberikan perasaan optimis, altruis, idealis, dan bertujuan hidup. Aspek intrapersonal pada dimensi spiritualitas yang dimanifestasikan dengan harmonisasi dengan alam dan sesama manusia sebagai koping emosi hal tersebut dapat memberikan sikap toleransi, dan rasa memiliki terhadap kelompok sehingga hal ini dapat menjadi sumber dukungan emosi sosial ketika dalam keadaan stres. Selanjutnya pada aspek transedensi, spiritualitas sebagai koping emosi akan memunculkan cinta tak bersyarat kepada Tuhan, dan keyakinan tidak sendirian dalam menghadapi permasalahan dan tuntutan hidup.²⁶³

Hal ini selaras dengan apa yang ditegaskan oleh Pargament (1997) spiritualitas pada beberapa tahun terakhir telah banyak dikaji oleh para ahli sebagai bentuk koping yang bisa dilakukan pada masa krisis dan stres. Dimana menurutnya koping spiritual ini bisa dimanifestasikan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan, kontemplasi, menghargai dan mencintai alam, ikut serta dalam bakti amal, yoga,

²⁶¹Harold G. Koenig, *Spirituality in Patient Care-Why, How, When and What*, (Pennsylvania: Templeton Foundation Press, 2003), 126.

²⁶²Terry Lynn Gall, and others, "Understanding the Nature and Role of Spirituality in Relation to Coping and Health: a Conceptual Framework", *Canadian Psychological Association*, (2005).

²⁶³Marcelo Saad dan Roberta de Medeiros, *Spiritual-Religious Coping-Health Services Empowering Patients' Resources*, (INTECH Open Science, 2012), 131.

dan sebagainya. Begitupula menurut Baldaccino dan Draper (2001) spiritualitas dapat dikatakan sebagai koping emosi karena meta-analisis menunjukkan bahwa individu yang menggunakan spiritualitas sebagai mekanisme koping akan memiliki kekuatan personal yang lebih baik, harapan, kekuatan menghadapi, dan makna dari situasi krisis yang dihadapi.²⁶⁴

Hal ini senada dengan ajaran Islam dimana spiritualitas diyakini menjadi sumber kekuatan dalam diri individu untuk menghadapi tekanan hidup. Beberapa pemikir muslim menyampaikan ide pemikirannya bahwa spiritualitas dapat menjadi koping yang bermanfaat baik kesehatan mental dan fisik. Muslim diharapkan menggunakan kepercayaan kepada Allah sebagai obat psikologis yang dengan kepercayaan tersebut bisa merubah persepsi diri terhadap keadaan yang dihadapi.²⁶⁵ Lamoshi (2015) menuliskan spiritualitas dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari keterhubungan individu dengan Allah, menurutnya spiritualitas sebagai koping dapat dijelaskan dengan tiga hal, *pertama*, spiritualitas sebagai koping emosi karena dapat meningkatkan persepsi positif terhadap kejadian hidup. *Kedua*, spiritualitas sebagai koping karena dapat memunculkan sifat optimistik, dimana sifat optimistik ini dapat membantu individu untuk mengatasi kejadian yang *stresful* dalam hidup. *Ketiga*, spiritualitas dapat memberikan perasaan tidak merasa gagal, Islam mengajarkan individu untuk memiliki pikiran yang jernih bahwa dengan menghubungkan diri dengan Allah dirinya tidak akan merasa takut untuk gagal karena yakin pertolongan Allah sangat dekat.²⁶⁶ Sebagaimana dituliskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 214:

... أَلَا إِنَّ فَضْلَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

²⁶⁴Donia R. Baldacchino dan Peter Draper, "Spiritual Coping Strategies: a Review of the Nursing Research Literature", *Journal of Advance Nursing*, Vol. 34, (2001); 833-941.

²⁶⁵Sumaya Laher dan Sumayyah Khan, "Exploring the Influence of Islam on the Perceptions of Mental Illness of Volunteers in a Johannesburg Community-based Organisation", *Psychology and Developing Societies*, Vol. 23, No. 1, (2011); 63-84.

²⁶⁶Abdulrouf Y. Lamoshi, "Religion as a Resilience Tool to Manage Stress in Adolescents: Islamic Approach", *Global Journal of Human-Social Science: Interdisciplinary*, Vol. 15, No. 3, (2015).

Artinya:

“...” *Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu Amat dekat*”. (QS. Al- Baqarah; 214)

Hal ini juga ditegaskan oleh Achour (2015) bahwa spiritualitas dalam Islam sejatinya tidak hanya berupa koping emosi namun juga dapat menjadi koping terfokus problem. Hal ini dapat ditegaskan karena dalam Islam spiritualitas tidak hanya terbatas pada bentuk keyakinan kepada Tuhan saja sehingga memberikan perasaan dan dorongan positif dalam menghadapi stres. Namun menurutnya ritualitas dalam Islam juga merupakan manifestasi koping terfokus masalah, karena dalam ritualitas seperti sholat menurutnya tidak hanya terbatas pada adanya kesadaran keterhubungan diri dengan Tuhan yang dapat memunculkan rasa tenang dan nyaman, namun yang terpenting dari sholat juga adanya gerakan-gerakan fisik. Serangkaian gerakan sholat dilakukan dengan pola gerakan yang sudah diatur dan ditetapkan dalam hukum fiqih, dengan demikian dalam sholat ada pola pengaturan perilaku sesuai syarat sahnya. Selanjutnya penulis menjelaskan diantara koping spiritualitas dalam Islam dapat dilakukan melalui kepercayaan kepada Allah, mendirikan sholat, zikir, sabar, memaafkan, berpikir positif, dan berhubungan sosial dengan baik.²⁶⁷

Selanjutnya jenis koping kedua yakni *problem-focused coping* (koping berfokus perilaku) pada penelitian dijelaskan dengan regulasi diri belajar. Koping berfokus perilaku secara umum dipahami sebagai bentuk koping adaptif yang dalam pelaksanaannya dilakukan perencanaan atau perilaku spesifik yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh stres.²⁶⁸ Sementara regulasi diri juga dipahami sebagai usaha untuk mengatur atau merubah respon

²⁶⁷ Meguellati Achour, Benaouda Bensaid, dan Mohd Roslan Bin Mohd Nor, “An Islamic Perspective on Coping with Life Stressors”, *Applied Reserach Quality Life*, (2015).

²⁶⁸ Susan Folkman dan Richard S. Lazarus, “If it Changes it Must be a Process: Study of Emotion and Coping during Three Stages of a College Examination”, *Journal of Personality and Social psychology*, Vol. 48, No.1, (1985); 150-170.

atau impuls terhadap sesuatu.²⁶⁹ Dengan demikian dari dua definisi koping dan regulasi diri terjadi persamaan dan tumpah tindih (*overlap*) konsep. Kedua-duanya sama dilakukan untuk mengatasi dan mengontrol suatu hal dan keadaan. Aldwin et al (2012) dalam tulisannya menjelaskan *overlap* dan perbedaan antara regulasi dan koping. Persamaannya baik coping maupun regulasi diri memiliki dua bentuk pengaturan dan pengelolaan yakni emosi dan perilaku yang dikenal dengan istilah “*emotional-focused coping* dan *problem-focused coping*” dan “*emotional self regulation* dan *behavior self regulation*”, keduanya dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Namun para penulis membedakan diantara keduanya bahwa koping bersifat terfokus pada pemecahan masalah stres namun regulasi diri lebih bersifat pada pemecahan masalah dan pencapaian tujuan yang tidak hanya terbatas pada stres. Regulasi diri merupakan orientasi berbasis aksi dan fokus pada pengaturan strategi, dan mengarahkan usaha, dengan demikian regulasi diri adalah bersifat aktif. Sementara koping sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak selamanya bersifat aktif, koping juga bisa bersifat pasif, membingungkan, pelarian dan menghindari bantuan dalam hal ini dimaknai negatif koping.²⁷⁰

Berdasarkan analisis penulis maka regulasi diri belajar yang dilakukan mahasiswa secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai koping perilaku positif secara implisit. Ketika individu melakukan sesuatu secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu dalam hal ini adalah mengatasi stres maka regulasi diri belajar menjadi salah satu strategi koping yang terfokus pada penyelesaian masalah dengan perilaku terencana (*effortfull* and *planfull*). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuente et al (2015) yang melakukan analisis review penelitian regulasi diri belajar, strategi koping dan stres pada mahasiswa. Hasil analisis review yang mereka lakukan menjelaskan bahwa hubungan antara regulasi diri belajar dan jenis

²⁶⁹Aleksandra Luszczynska and others, “Measuring One Component of Dispositional Self-Regulation: Attention Control in Goal Pursuit”, *Personality and Individual Differences*, Vol. 37, (2004); 555-566.

²⁷⁰Carolyn M. Aldwin and others, Coping and Self Regulation Across the Life Span dalam *Handbook of Life-Span Development*, (New York: Springer Publishing Company, 2011), 563-565.

koping yang dilakukan oleh mahasiswa adalah berhubungan positif dengan jenis koping terfokus masalah (*problem-focused coping*).²⁷¹

Dengan demikian menurut analisa penulis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa spiritualitas dan regulasi diri secara bersamaan menjadi koping positif yang dilakukan oleh mahasiswa dan secara positif pula dapat dipahami bahwa kedua aspek ini merupakan sistem pertahanan diri terhadap stres. Sehingga hasil penemuan riset ini menunjukkan bahwa model stres yang terjadi pada mahasiswa tidak lagi menjadi model stimulus-respon (S-R) tapi menjadi model stimulus-organism-respon (S-O-R). Sebagaimana Urbayatun dan Widhiarso (2012) menjelaskan pergeseran model stres dari S-R menjadi S-O-R jika proses koping melibatkan dalam analisis reaksi individu terhadap lingkungan yang penuh stres.²⁷²

Hasil analisis pada studi ini menunjukkan bahwa regulasi diri belajar memediasi hubungan antara spiritualitas dan stres. Dimana menurut Nelson (2009) spiritualitas atau religiusitas ketika dihubungkan dengan stres dan literatur koping, maka efeknya akan dijelaskan dalam model mediasi, yakni spiritualitas memiliki hubungan tidak langsung (*indirect effect*) terhadap stres. Spiritualitas atau religiusitas terlebih dahulu menghantar kepada perilaku koping yang lebih baik, baru kemudian spiritualitas dapat menekan stres yang dirasakan individu melalui peran variabel mediator koping tersebut.²⁷³ Adapun proses koping yang melibatkan dalam riset ini membuktikan bahwa regulasi diri belajar menjadi variabel mediator yang signifikan dalam menghubungkan spiritualitas dengan stres mahasiswa.

Hal ini selaras dengan Bosacki et al (2011), dimana hasil mereka menunjukkan bahwa regulasi diri memainkan peran penting dalam menghubungkan pengaruh positif spiritualitas terhadap kese-

²⁷¹Jesus De la Fuente and others, *Personal Self-Regulation, Self-Regulated learning and Coping Strategies in University Context with Stress*, (Switzerland: Springer International Publishing, 2014), 27.

²⁷²Siti Urbayatun dan Wahyu Widhiarso, "Variabel Mediator dan Moderator dalam Penelitian Psikologi Kesehatan Masyarakat:", *Jurnal Psikologi*, Vol. 39, No. 2, (2012); 180-188.

²⁷³James M. Nelson, *Psychology, Religion, and Spirituality*, (New York: Springer, (2009), 319.

hatan mental dan perilaku pro sosial pada anak-anak dan remaja.²⁷⁴ Begitupula regulasi diri pada beberapa studi terbukti menjadi variabel mediator pada beberapa domain riset yang berbeda-beda khususnya pada kajian-kajian akademik, seperti regulasi diri memediasi hubungan antara *parenting* dengan perilaku belajar dan *adjustment* di sekolah,²⁷⁵ regulasi diri memediasi hubungan antara religiusitas dan perilaku negatif remaja seperti minum-minuman dan merokok.²⁷⁶

Berdasarkan kedua bentuk koping “*emotion* dan *problem focused coping*” yang telah dijelaskan dan dianalisis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa spiritualitas menjadi bentuk koping emosi karena melalui spiritualitas mahasiswa memiliki persepsi-persepsi positif yang kemudian digunakan untuk mengatasi stres akademik. Adapun regulasi diri belajar menjadi bentuk koping terfokus masalah, karena dengan pola pengelolaan belajar yang baik mahasiswa ingin menekan atau menghilangkan ketegangan belajar dengan meningkatkan proses belajar yang adaptif, memilih waktu belajar yang tepat, dan memiliki strategi khusus ketika menghadapi kecemasan masa ujian. Selanjutnya spiritualitas terbukti berpengaruh positif terhadap regulasi, begitupula spiritualitas terbukti dapat menekan stres mahasiswa melalui regulasi diri belajar sebagai variabel mediatornya.

²⁷⁴Sandra Leanne Bosacki and others, “Preadolescents’ Gendered Spiritual Identities and Self-Regulation”, *Journal of Beliefs & Values*, Vol. 32, No. 3, (2011); 303-316.

²⁷⁵Hoi Kwang Ning dan Kevin Downing, “Influence of Student Learning Experience on Academic Performance; The Mediator and Moderator Effect of Self-Regulations and Motivation, *British Educational Research Journal*, Vol. 38, No. 2, (2012); 219-237.

²⁷⁶Scott A. Desmond, Jeffery T. Ulmer, dan Christopher D. Bader, “Religions, Self-Control, and Substance Use, *Deviant Behavior*, Vol. 34, No. 5, (2013); 384-406.

BAB V

PENUTUP

Fenomena stres yang seolah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia modern dan bisa menimpa siapa saja dalam bentuk, kadar, tingkatan serta jangka waktu lama atau pendek yang berbeda, memunculkan spiritualitas sebagai pendekatan masalah yang belakangan banyak digunakan oleh para ahli. Pemilihan spiritualitas sebagai dimensi positif manusia berawal dari asumsi dasar, bahwa stres disinyalir terjadi karena terlepasnya individu dari nilai penting dalam hidupnya. Sementara salah satu sumber signifikan atau *valued resources* yang dapat mempertahankan kesehatan psikologis adalah terpenuhinya kesejahteraan spiritualitas tersebut. Namun demikian penyelesaian masalah mental secara spiritualitas itu sendiri harus bersifat holistik yakni mendekati permasalahan kejiwaan dari berbagai cara sehingga tidak terbatas pada spiritualitas itu sendiri. Di antara kemungkinan tersebut adalah usaha untuk mengatur dan merubah respon diri terhadap berbagai sumber stres yang dikenal dengan istilah regulasi diri selanjutnya dalam konteks akademik dikenal dengan istilah regulasi diri belajar.

A. Kesimpulan

Berdasarkan konsep koping yang dijelaskan sebagai mekanisme pertahanan diri dari stres. Studi ini menyimpulkan, bahwa spiritualitas terbukti berhasil menjadi koping berfokus emosi (*emotion focused coping*), karena melalui spiritualitas mahasiswa memiliki persepsi-persepsi positif yang kemudian digunakan untuk mengatasi stres akademik. Secara bersamaan penelitian ini juga menyimpulkan bahwa regulasi diri belajar terbukti berhasil menjadi koping berfokus masalah/perilaku (*problem focused coping*), karena dengan pola pengelolaan belajar yang baik mahasiswa ingin menghilangkan atau menekan ketegangan akademik. Studi ini juga menyimpulkan bahwa, spiritualitas tidak memengaruhi penekanan stres secara langsung, namun harus melalui regulasi diri belajar yang baik. Begi-

tupula, regulasi diri belajar tidak dapat memengaruhi penekanan stres tanpa spiritualitas yang baik. Hal ini dibukti melalui:

1. Stresor terbukti memengaruhi stres secara signifikan. Prediksi nilai positif ($t=7.381.96$) mengindikasikan bahwa hubungan stresor terhadap stres adalah positif, artinya bahwa semakin tinggi stresor yang dirasakan akan semakin tinggi stres.
2. Spritualitas terbukti memengaruhi stres secara signifikan. Prediksi nilai negatif yang diperoleh ($t=-2.95-1.96$) mengindikasi hubungan terbalik antara spritualitas dan stres, artinya semakin tinggi spritualitas mahasiswa maka akan semakin rendah tingkat stres yang mereka rasakan.
3. Spritualitas terbukti memengaruhi regulasi diri belajar secara signifikan. Prediksi nilai positif yang diperoleh ($t=6.091.96$) mengindikasikan bahwa semakin tinggi spritualitas yang dimiliki oleh mahasiswa hal ini akan diikuti dengan semakin meningkatnya kemampuan regulasi diri belajar mereka.
4. Regulasi diri belajar terbukti signifikan memengaruhi tingkat stres. Prediksi nilai negatif yang diperoleh ($t=-3.13-1.96$) mengindikasikan hubungan terbalik antara regulasi diri belajar dan stres, artinya semakin tinggi kemampuan regulasi diri belajar pada mahasiswa maka tingkat stres yang dirasakan akan semakin rendah.
5. Regulasi diri belajar terbukti signifikan memediasi hubungan kausalitas antara spritualitas dan stres, prediksi nilai negatif ($t=-2.96-1.96$) mengindikasikan mediasi yang terjadi adalah sebab akibat yang linier, artinya spritualitas memengaruhi stres secara tidak langsung, karena harus melewati regulasi diri belajar sebagai mediator.
6. Implementasi spritualitas di kalangan mahasiswa tersebut secara singkat diwujudkan dalam dua bentuk. *Pertama*, keterhubungan dengan Tuhan melalui ibadah seperti sholat, do'a, membaca al-Qur'an, kepercayaan dan tawakal kepada Tuhan. *Kedua*, harmonisasi dengan alam dan manusia yang diwujudkan dengan menjaga alam dari segala kerusakan, meningkatkan kepedulian akan kebersihan sekitar, serta menikmati keindahan dan takjub kepada Alam. Sementara pada hubungan antar sesama manusia diwujudkan dengan perilaku yang

baik antar sesama dan keinginan untuk bisa menolong orang lain.

7. Keterhubungan antara spritualitas dan regulasi diri belajar dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, aspek spritualitas yang berhubungan dengan regulasi diri belajar adalah berada pada aspek emosi yakni efikasi diri. Keterhubungan dengan Tuhan memunculkan perpesktif diri bahwa Tuhan telah memberikan kemampuan atas masing-masing individu untuk melakukan tugas dan kewajibannya. *Kedua*, aspek spritualitas yang berhubungan dengan regulasi diri belajar adalah manajemen waktu. Ketaatan beribadah yang dimiliki individu secara tidak langsung memunculkan regulasi waktu dan disiplin diri.

B. Rekomendasi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pasti memiliki kelemahan yang ke depannya dapat menjadi rekomendasi bagi pengembangan penelitian lanjutan. Oleh karena itu dengan memperhatikan beberapa kelemahan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi.

Pertama, penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian pengembangan kajian keislaman melalui pendekatan psikologi Islam, namun secara teoritis penelitian ini belum banyak menggunakan landasan teori yang betul-betul berlandaskan sumber Islam (al-Qur'an, Sunnah). Pada penelitian selanjutnya hal ini dapat menjadi perhatian bagi para peneliti kajian keislaman yang tidak hanya menggunakan dua landasan al-Qur'an dan Sunnah saja namun juga bisa menggunakan teori-teori dasar yang bersumber dari berbagai pemikiran tokoh dan ulama muslim klasik dan modern yang telah memberikan kontribusinya dalam perkembangan kajian Psikologi Islam itu sendiri.

Kedua, fokus penelitian ini hanya terbatas pada mahasiswa kedokteran pra-praktikum sehingga untuk menemukan informasi secara keseluruhan dari mahasiswa kedokteran tidak tercapai. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa melibatkan mahasiswa pra-praktikum dan praktikum untuk melihat penyebaran signifikansi hubungan antar variabel secara lebih besar sebagai upaya generalisasi hasil penelitian.

Ketiga, memperhatikan stres sebagai kajian yang kompleks dimana indikasinya tidak terfokus pada dimensi psikologis, maka penelitian yang akan datang secara lebih komprehensif dapat menje-

laskan lebih detail terkait reaksi stres tersebut dari berbagai aspek seperti fisiologis, psikologis, sosial bahkan spritual itu sendiri.

Kecempat, selain dari variabel yang dibatasi dalam penelitian ini, para peneliti selanjutnya dapat melakukan pengembangan riset dengan variabel-variabel lainnya untuk membuktikan seberapa kuat variabel yang telah digunakan pada penelitian ini dapat menjelaskan variabel lain yang tidak menjadi fokus kajiannya.

Kelima, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi lembaga terkait. Dengan demikian penelitian ini memberikan rekomendasi pada lembaga-lembaga pelaksana pendidikan khususnya berfokus pada keilmuan kedokteran untuk memperhatikan dan mempertahankan kondisi psikologis yang baik bagi para mahasiswa, misalkan dengan menyediakan layanan konseling dan pengembangan kepribadian serta karir bagi mahasiswa, memberikan dan mengembangkan *life skill* yang berfokus pada keahlian melakukan coping stres, serta memberikan pengetahuan terkait pengelolaan emosi diri dengan relaksasi seperti yoga, meditasi dan sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal-Jurnal Internasional

- Abdelfattah, Hoda Mohammed. Abdelazeim, Fatch H. dan Elshen-nawy, Shroul. "Physical and Cognitive Consequence of Fatigue: a Review". *Journal of Advanced Research*. Vol. 6. (2015): 351-358.
- Abdullah, Ayat R. Dan Gabr, Hala M. "Depression. Anxiety. and Stress among First Year Medical Students in an Egyptian Public University". *International Research Journal of Medicine and Medical Sciences*. Vol. 2. No. 1. (2014): 11-19.
- Abdullah, Che Haslina and others. "General Anxiety Disorder (GAD) from Islamic Perspective and Western Perspectives". *World Journal of Islamic History and Civilization*. Vol. 2. No. 1. (2012): 44-52.
- Abdullah, Che Haslina and others. "The Effectiveness of Generalized Anxiety Disorder Intervention through Islamic Psychotherapy: the Preliminary Study". *Asian Social Science*. Vol. 9. No. 13. (2013): 157-162.
- Abdullah, Fatimah. "Virtues and Character Development in Islamic Ethics and Positive Psychology", *International Journal of Education and Social Science*. Vol.1. No. 2. (2014). 69-77.
- Abdulghani, Hamzah M and others. "Stress and Its Effects on Medical Students: A Cross Sectional Study at A College of Medicine in Saudi Arabia". *Journal Health Popul Nutr*. Vol 5 (2011): 516-522.
- Achour, Meguellati. Bensaid, Benaouda dan Mohd Nor, Mohd Roslan Bin. "An Islamic Perspective on Coping with Life Stressors". *Applied Research Quality Life*. (2015).
- Adnan, Mohamad Azrien Mohamed and others. "Self-Regulated Learning and Motivation of Islamic Studies and Non-Islamic Studies Stream Students". *GESJ: Education Science and Psychology*. Vol. 32. No. 6. (2014): 1-16.
- Ahmad, Mahjabeen dan Khan, Shamsul. "A Model of Spirituality for Ageing Muslims". *Journal Religion Health*. (2015): 1-14.

- Ahmadi, Jamshid. MD and others. "Mental Health of Dubai Medical College Students". *Iran Journal Psychiatry Behavir Sciences*. Vol. 6. No. 2. (2012): 79-83.
- Al-Dubai, Sami Abdo Radman and others. "Stress and Coping Strategies of Students in Medical Students. *Malaysian Journal Medical Science*. Vol. 18. No. 3 (2011): 57-64.
- Al-Haj, Malak Eisa Abdalla and others. "Eating Habits among Medical Students in a Sudanese Medical faculty". *International Research Journal of Medicine and Medical Sciences*. Vol. 3. No. 3. (2015): 64-69.
- Aldwin, Carolyn. Park, Crystal. Jeong, Yu-Jin dan Nath, Tiwik. "Differing Pathways Between Religiousness, Sprituality, and Health: a Self Regulation Perspective". *Psychology of Religion and Sprituality*. Vol. 6. No. 1 (2014): 9-21.
- Al- Haq, M Ashraf and others. "Islamic Prayer, Sprituality, and Priductivity: an Exploratory Conceptual Analysis". *Al-Iqtis-had: Journal of Islamic Economic*. Vol. 8. No. 2. (2016): 271-286.
- Al-Hashel, Jasem Y and others. "Migraine among Medical Students in Kuwait University". *The Journal of Headache and Pain*. Vol. 15. No. 26. (2014): 1-6.
- Alvaro, Celeste "Conservation of Resources Theory and Research Use in Health Systems". *Implementation Science*. Vol. 5. No. 79. (2010): 1-20.
- Anthony, Fabricatore. Paul J. Handal. Fenzel. L. Mickey. "Personal Sprituality as a Moderator between Stressors and Subjec-tive Well-Being". *Journal of Psychology and Theology*. Vol. 28 (2000): 221-228.
- Aslani, Usaf and others. "Sleep Disorders in Patients with Congestive Hearth Failure Hospitalized in Hajar Hospital. Shahrekord 2003. *Journal Shahrekord University Medical Sciences*. Vol. 9. No. 1. (2007): 44-49.
- Aspinwall, Lisa G. Taylor, Shelly E. "A Stich in Time: Self Regulation and Proactive Coping". *Psychological Bulletin*. Vol. 121. (1997): 417-436.
- Baharuddin, Elmi dan Ismail, Zainab. "Spritual Intelligent Relationship of Elderly People with the Religious Practice in the Welfare Home". *Islamiyyat*. Vol.35. No. 1. (2013): 19-28.

- Baldacchino, Donia R. dan Draper, Peter. "Spritual Coping Strategies: a Review of the Nursing Research Literature". *Journal of Advance Nursing*. Vol. 34. (2001): 833-941.
- Bates, Jeffrey M. Cooper, Diane L dan Wachs, Peter M. "Assessing Wellness in College Students: a Validation of the Salubrious Lifestyle Scale of the Student Developmental Task and Lifestyle Assessment". *Journal of College Student Development*. Vol. 42. No. 3. (2001): 193-203.
- Baqutayan, Shadiyah Mohamed S. "An Innovative Islamic Counseling". *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol. 1. No. 21 (2011): 178-183.
- Baron, Reuben M. dan Kenny, David A. "The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations". *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 51. No. 6. (1986): 1173-1182.
- Bashir, Hilal dan Bashir, Liyaqat. "Investigating the Relationship between Self-Regulation and Spritual Intelligence of Higher Secondary School Students". *Indian Journal of Health and Wellbeing*. Vol. 7. No. 3. (2016): 327-329.
- Basnet, Bibhusan. and others. "Depression among Undergraduate Medical Students". *Medical Education*. Vol. 10. No. 3. (2012): 56- 59.
- Beheshtifar, Malikeh dan Nazarian, Rahele "Role of Occupational Stress in Organization". *Interdiciplinary Journal of Contemporary Reserach In Business*. Vol. 4. N0. 9. (2013): 648-657.
- Benavente, Sonia Betzabeth Ticono dan Costa, Ana Lucia Siquire. "Physiological and Emotional Responses to Stress in Nursing Students: an Integrative Review of Scientific Literature". *Acta Paul Enferm*. Vol. 24. No. 4. (2011): 571-576.
- Bensaid, Benaouda. Machouche, Saleh ben Tahar dan Grine, Fadila. "A Qur'anic Framework for Spritual Intelligence". *Religioms*. Vol. 5. No. 1. (2014): 179-198.
- Berto, Rita. "The role of Nature in Coping with Psycho-Physiological Stress: a Literature Review on Restorativeness". *Behavioral Sciences*. Vol. 4. (2014): 394-409.
- Bhagat, Vidya and others. "Emotional Maturity among Medical Students and its Impact on their Academic performance". *Tran-*

- sactions on Science and Technology*. Vol. 4. No. 1. (2017): 48-54.
- Bjorklund, David F. dan Klipp, Katherine. "Parental Investment Theory and Gender Differences in the Evolution of Inhibition Mechanism". *Psychological Bulletin*. Vol. 120. No. 2. (1996): 163-188.
- Blair, Robert G. "Helping Older Adolescents Search for Meaning in Depression". *Journal of Mental Health Conseling*. Vol. 26. No. 4. (2004): 333-347.
- Bland, Earl D. "An Appraisal of Psychological and Religious Perspectives of Self Control". *J Relig Health*. Vol. 47. (2008): 4-16.
- Bonab, Bagher Gobar and others. "Attachment to God in Islamic Sprituality". *Journal of Muslim Mental Health*. Vol. 7. No. 2. (2013): 77-104.
- Borins, Mel. "Pronoia: Attitudinal Change. Love and Sprituality". *The International Journal of Healing and Caring*. Vol.11. No. 3. (2011).
- Bosacki, Sandra Leanne and others. "Preadolescents' Gendered Spritual Identities and Self-Regulation". *Journal of Beliefs & Values*. Vol. 32. No. 3. (2011): 303-316.
- Boswell, Gracie H. Kahana, Eva dan DA, Peggy. "Sprituality and Healthy Lifestyle Behaviors: Stress Counter – Balancing Effects on the Well-Being of Older Adults". *Journal of Religion and Health*. Vol. 45. No. 4 (2006): 587-602.
- Braskam, Larry A. "Fostering Religious and Spritual Development of Students during College (Electronic Version). diakses dari <http://religion.ssrc.org/reforum/Braskamp.pdf>.
- Bratman, Greogy N. Hamilton, J. Paul dan Daily, Gretchen C. "The Impact of Nature Experience oh Human Cognitive Function and Mental Health". *Annals of the New York Academy of Science*. (2012): 118-136.
- Bryant, Allyssa N. "Gender Differences in Spritual Development during the College Years". *Sex Roles*. Vol. 56. No. 11. (2007):835–846.
- Brown, David R dan Parrish, Mark S. "College Student Sprituality: Helping Explore Life's Existential Questions". *Vistas*. (2011).

- Brydges, Ryan. "A Reflective Analysis of Medical Education Research on Self-Regulation in Learning and Practice". *Med Educ.* Vol. 46. No. 1.(2012): 71-79.
- Buchko, Kathleen J. "Religious Beliefs and Practices of College Woman as Compared to College Men". *Journal of College Students Development.* Vol. 45. (20004): 89-98.
- Buckner, John C. Mezzacappa, Enrico dan Baerdslee, William R. "Self- Regulation and Its Relations to Adaptive Functioning in Low Income Youths". *American Journal of Orthopsychiatry.* Vol. 79. N0. 1 (2009): 19-30.
- Burkhardt, Margaret A. "Sprituality: an Analysis of the Concept". *Holistic Nursing Practice.* Vol. 3. No. 3. (1989): 69-77.
- Byrne, Bruce. "Relationship between Anxiety, Fear, Self-esteem, and Coping Strategies in Adolescence". *Journal of Adolescence.* Vol. 35. (2000): 201-215.
- Calaguas, Glenn M. "College Academic Stress: Differences along Gender Lines". *Journal of Social and Development Sciences.* Vol.1. No. 5. (2011): 194-201.
- Carleton, Russell A. and others. "Stress, Religious Coping Resources, And Deressive Symptoms in an Urban Adolescent Sample". *Journal for the Scientific Study of Religion.* Vol. 47 No. 1 (2008): 113-121.
- Carrol, Jhon B. "A Model of School Learning". *Teachers College Record.* No. 64. (1963): 723-733.
- Carter, Evan C. McCullough, Michael E. dan Carver, Charles S. "The Mediating Role of Monitoring in the Association of Religion with Self-Control". *Social and Psychological and Personality Science.* Vol. 3. No. 6. (2012): 691-697.
- Chilukuri, Harihar and others. "Perceived Stress amongst Medical and Dental Students". *Ap J Psychological Medicine.* Vol. 13. N0. 2 (2012): 104-107.
- Cho, Kenneth K. and others. "Medical Students Changes in Self-Regulated Learning during the Transition to the Clinical Environment". *Bio Med Central.* (2017).
- Clements, Andrea D dan Ermakova, Anna V. "Surrender to God and Stress: a Possible Link between Religiosity and Health". *Psychology of Religion and Sprituality.* Vol. 4. No. 2. (2012): 93-107.

- Cook, David A and others "The Motivated Strategies for Learning Questionnaire: Score Validity among Medicine Residents". *Med Educ.* Vol. 45. (2011): 230-240.
- Cour, Peter La dan Hvidt, Niels Christian. "Research on Meaning-Making and Health in Secular Society. Secular. Spiritual and Religious Existential Orientations". *Social Science & Medicine.* Vol. 71. No. 7. (2010): 1292-1299.
- Dagistani, Ahmad and others. "Stress in Medical Students in a Problem-Based Learning Curriculum". *International Journal of Higher Education.* Vol. 5. No. 3. (2016): 12-19.
- Damon, William. Menon, Jenni dan Bronk. Kendall Cotton. "The Development of Purpose During Adolescence". *Applied developmental Science.* Vol. 7. No. 3. (2003): 119-128.
- David R. Brown dan Mark S. Parrish. "College Student Sprituality: Helping Explore Life's Existential Questions". *VISTAS* . (2011).
- Davis, Teresa L. "Gender Differences in Masking Negative Emotions: Ability or Motivation?". *Developmental Psychology.* Vol. 31. No. 4. (1995): 660-667.
- Deci, Edward L dan Ryan, Richard M. "The "what" and "why" of Goal Pursuit: Human Needs and the Self-Determination of Behavior". *Psychological Inquiry.* Vol. 11. No. 4. (2000): 227-268.
- Desmond, Scott A. Ulmer, Jeffery T. dan Bader, Christopher D. "Religion. Self Control. and Substance Use". *Deviant Behavior.* Vol. 34. No. 5. (2013): 384-406.
- Dierendonck, Dirk Van dan Mohan, Krishna. "Some Thoughts on Sprituality and Eudaimonic Well-Being". *Mental Health. Religion and Culture.* Vol. 9. No. 3. (2006): 227-238
- Duckworth, Angela L. & Seligman, Martin. E.P. "Self-Discipline Outdoes IQ in Predicting Academic Performance of Adolescents. *Psychological Science.* Vol. 16.(2006): 939-944.
- Dumitru, Voichita M. Dan Cozman, Doina. "The Relationship between Stress and Personality Factors". *Human and veterinary Medicine International Journal of the Bioflux Society.* Vol. 4. No. 1. (2012): 34-39.
- Dusselier, Lauri and others. "Personal. Health. Academic. and Environmental Predictors of Stress for Residence Hall Students. *Canadian Journal of Counselling.* Vol. 54 (2005): 15-24.

- Backovic, Dusan V and others. "Gender Difference in Academic Stress and Burnout Among Medical Students in Final Years of Education". *Psychiatria Danubina*. Vo. 24. No. 2 (2012): 175-181.
- Dyrbye, Liselotte N. And others. "Medical Students Distress: Causes. Consequences. and Proposed Solutions". *Mayo Clin Proc*. Vol. 80. No. 12. (2005): 1613-1622.
- Dyrbye, Liselotte N. and others. "Systematic Review of Depression. Anxiety. and Others Indicators of psychological Distress among US and Canadian Medical Students". *Academic Medicine*. Vol. 81. No. 4. (2006): 354-373.
- Eikeland, Hanne-Lise and others. "The Pshysician's Role and Empathy- a Qualitative Study of Third Year Medical Students". *BMC Medical Education*. Vol. 14. (2014): 1-8.
- Eisenberg, Nancy dan Zhou, Qing. "Regulations from a Developmental Perspective". *Psychological Inquiry*. Vol. 11. No. 3. (2000): 166-171.
- Ekpenyong, Christopher. E and others. "Academic Stress and Menstrual Disorder among Female Undergraduate in Uyo. South eastern Nogeria- the Need for Health Education". *Niger J. Physiol Sci*. Vol. 26. (2011): 193-198.
- ElArab, Hanan Ez. Rabie, Menan A.M. dan Ali, Dalia H. "Sleep Behavior and Sleep Poblems among Medical Students Sample in Rekation to Academic Perfomance: a Cross-Sectional Questionnaire-Based Study". *Middle East Current Psychiatry*. Vol. 21. (2014): 72-80.
- Ellis, Albert. "Psychotherapy and Atheistic Values: A Reason to AE Bergin's Psychotherapy and Religious Values". *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. Vol. 48. (1980): 635-639.
- Ericsson, K. Anders. "Acquisition and Maintenance of Medical Expertise: a Perspective from the Expert Performance Approach which Deliberate Practice". *Academic Medicine*. Vol. 90. No. 11. (2015): 1471-1486.
- Eschenbeck, Heike. Kohlmann, Carl-Walter dan Lohaus, Arnold "Gender Differencess in Coping Strategies in Children and Adolescents". *Journal of Individual Differences*. Vol. 28. (2007): 18-26.

- Evans, Gary W dan McCoy, Janetta Mitchell. "When Buildings Don't Work: the Role of Architecture in Human Life". *Journal of Environmental Psychology*. Vol. 18. No. 1. (1998): 85-94.
- Fabruccatore, Anthony N. And others. "Personal Spirituality as a Moderator between Stressors and Subjective Well-Being". *Journal of Psychology and Theology*. Vol. 28. NO. 3. (2012): 221-228.
- Faisal, Alexander. Savonia, Mariangela Gentil dan Menezes, Paulo Rossi. "Coping Style and Depressive Symptomatology during Pregnancy in a private Setting Sample". *The Spanish Journal of Psychology*. Vol. 15. No. 1 (2012): 195-305.
- Faruqi and others. "Anger Arousal and Wellbeing as markers of Social Functioning and Quality of Life in the Aftermath of Exposure to Life Threatening Trauma". *European Psychiatry*. Vol. 26, No. 1. (2011).
- Fava and others. "Hostility Changes Following Antidepressant Treatment: Relationship to Stress and negative Thinking". *Journal of Psychiatric Research*. Vol. 30, No. 3. (1999): 349-362.
- Fisher, Jhon. "The Importance of Relating with God for Spritual Well-Being". *Journal of Beliefs & Values*. Vol. 31. No. 3. (2010): 323-332.
- Fisher, Jhon. "Development and Application of a Spritual Well-Being Questionnaire Called SHALOM". *Religions*. Vol.1. (2010): 105-121.
- Fisher, Jhon. "The Four Domains Model: Conncting Sprituality. health and Well-Being". *Religion*. Vol. 2. (2011): 17-28.
- Fisher, John W. dan Gomez. "Domains of Spritual Well-Being and Development and Validation of the Spritual Well-Being Questionnaire". *Personality and Individual Differences*. Vol. 35 (2003): 1975-1991.
- Fisher, Sebern. "Arousal and Identity: Thoughts on Neurofeedback in Treatment of Develomental Trauma". *Biofeedback*. Vol. 38, No. 1. (2010): 6-8
- Folkman, Susan dan Lazarus, Richard S. "If it Changes it Must be a Process: Study of Emotion and Coping during Three Stages of a College Examination". *Journal of Personality and Social psychology*. Vol. 48. No.1. (1985): 150-170.

- Foskett, Jhon. Marriott, James and Rudd, Fay Wilson. "Mental Health. religion. And sprituality: Attitudes. Experience. and Expertise among Mental Health Professionals and Relious Leadres in Somerset. *Mental Health. Religion. And Culture*. Vol. 7. No. 1 (2004): 55-22.
- Frazier, Royce E. dan Hansen, Nancy Downing. "Religious/Spritual Psychotherapy Behaviors: Do We Do What We Believe To Be Important?". *Profesional Psychology: Reserach and Practice*. Vol. 40. No. 1 (2009): 81-87.
- Gall, Terry Lynn and others. "Understanding the Nature and Role of Sprituality in Relation to Coping and Health: a Conceptual Framework". *Canadian Psychological Association*. (2005): 9-10.
- Gan, Yiqun. Hu, Yueqin dan Zhang, Yiwen. "Proactive and Preventive Coping in Adjustment to College". *The Psychology Record*. Vol. 60. (2010): 643-658.
- Gaultney, Jane F. "The Prevalence of Sleep Disorders in College Students: Impact on Academic Performance". *Journal of American College Health*. Vol. 59. No. 2. (2010): 91-97.
- Gelsthorpe, Jack. "Disconnect from Nature and its Effect on Health and Well-Being- A Public Engagement Literature Review". *Natural History Museum*. (2017).
- Ghodrati, Fatemah. "The Importance of Self-Esteem in islam and Its Impact on Physical and Mental Health". *Scholar Journal of Applied Medical Science*. Vol. 4. No. 5B. (2016): 1566-1569.
- Gibbons, Chris and others. "Stress and Eustress in Nursing Students". *Journal of Advanced Nursing*. Vol. 6. No. 3. (2008): 282-290.
- Gibbons, Chris and others. "Stress. Coping and Satisfaction in Nursing Students". *Journal of Advance Nursing*. Vol. 67. No. 3. (2011): 621-632.
- Gilbert dan Orlick, "Teaching Skills for Stress Control and Positive Thinking to Elementary School Children", *Journal of Excellence*, Vol. 7, No. 1, (2007); 1.
- Ginawi, Ibrahim and others. "Do Study of Medicine Leads to Increase Depression and Anxiety. Study from Ha'il University. Saudi Arabia". *Journal of Public Health*. Vol. 9. No. 1. (2014): 7-14.

- Golden, Jonathan and others. "Sprituality and Burnout: an Incremental Validity Study". *Journal of Psychology and Theology*. Vol. 32. No. 2 (2004): 115- 125.
- Gokdag, Ruchan. "Defense Mechanism Used by University Students to Cope with Stress. *International Journal on New Trends in Education and Their Implications*. Vol. 6. No. 2. (2015): 1-12.
- Good, Marie dan Willoughby, Teena. "Adolescence as a Sensitive Period for Spritual Development". *Child Developmnet Perspectives*. Vol. 2. No. 1. (2014): 32-37.
- Govaerts, Sophie dan Gregoire, Jacques. "Stressful Academic Situation: Study on Appraisal Variables in Adolescence". *Eoropean Review of Applied Psychology*. Vol. 54. No. 4. (2004): 261-271.
- Graham, Stephanie and others. "Religion and Sprituality in Coping with Stress". *Counselling and Values*. Vol. 46. No. 1. (2001): 2-13.
- Gulfo, Efreem dan Obsa, Oukula. "Students towards One-to-Five Peer Learning: a New Approach for Enhancing Education Quality in Wolaita Sodo University, Ethiopia". *Journal of Education and Practice*. Vol. 6. No. 19. (2015): 152-159.
- Guthrie, E. and others. "Embarking upon a Medical Career: Psychological Morbidity in First Year Medical Students". *Medical Education Journal*. (1995): 337-341
- Gutherie, E and others. "Pshological Stress and Burnout in Medical Students: a Five-Year Prospective Longitudinal Study". *J R Soc Med* (2002): 237-243.
- Hadavi, Sayedeh Hannaneh. Ahmadi. Masoud dan Hamedani. Saaid Saffarian. "Understanding the Relationship between ICT and Self-Regulated Learning Students of. Islamic Azad University of Sari". *International Journal of Economy. Management and Social Sciences*. Vol. 3. No. 12. (2014): 905-908.
- Hamdan, Aisha. "Gognitive Restructuring: an Islamic Perspective". *Journal of Muslim Mental Health*. Vol. 3. (2008): 99-116.
- Hamjah, Salasiah Binti Hanin. "Methods to Overcome Anxiety in Counseling: an Analysis from al-Ghazali Perspective". *Jurnal Hadhari*. Vol. 3. No. 1. (2010): 41-57.

- Hamzah, Rohana. Kamarudzaman dan Janor, Roziah Mohammad. "Spritual Education Development Model". *Journal of Islamic and Arabic Education*. Vol. 2. N0.2 (2010): 1-12.
- Hanefar, Shamsiah Banu. Sa'ari, Che Zarrina dan Siraj, Saedah. "A Synthesis of Spritual Intelligence Themes from Islamic and Western Philosophical Perspectives". *J Relig Health*. Vol. 55. No. 3. (2016).
- Hardiman, Piers dan Simmonds, Janette Graetz. "Spritual Well-Being. Burnout and Trauma in Counsellors and Psychotherapists". *Mental Health. Religion. & Culture*. Vol. 16. No.10 (2013): 1044-1055.
- Hardy, James. "Speaking Clearly: a Critical Review of the Self-Talk Literature". *Psychology of Sport and Exercise*. Vol. 7. (2006): 81-97.
- Hashempour, Sara dan Mehrad, Aida. "The Effect of Anxiety and Emotional Intelligence on Students' Learning Process". *Journal of Education and Social Policy*. Vol.1. No. 2. (2014): 115-122.
- Hassim, Noor Johari AB. "Stress And Coping Strategies Among Medical Students In National University Of Malaysia. Malaysia University Of Sabah And University Kuala Lumpur Royal College Of Medicine Perak". *J Community Health*. Vol 15. (2009): 106-115.
- Heiman dan Kariv. "Task Oriented Versus Emotion-Oriented Coping Strategies: The Case of College Students". *College Students Journal*. Vol. 39. No. 1. (2005): 72-89.
- Heidari, Mohammad Reza. Norouzadch. Reza dan Abbasi. Mohamad. "Sleep in the Qur'an and Health Sciences". *Health. Spritual Med Ethics*. Vol. 1. No. 1. (2014): 30- 36.
- Helminiak, Daniel A. "Treating Spritual Issues in Secular Psychotherapy". *Counselling and Values*. Vol. 45. No. 3. (2001): 163-189.
- Hendel, Darwin D. "The Relationship between Academic Life Conditions and Perceived Sources of Faculty Stress Over Time". *Journal of Human Behavior in the Social Environment*. Vol. 17. No. ½. (2008): 61-88.

- Henry, Hani M. "Spritual Energy of Islamic Prayers as a Catalyst for Psychotherapy". *Journal of Religion and Health*. (2013): 1-13.
- Hosseini, Maryam and others. "A Review Study on Spritual Intelligence. Adolescence and Spritual Intelligence. Factors that May Contribute to Individual Differences in Spritual Intelligence and the Related Theories". *International Journal of Psychological Studies*. Vol. 2. No. 2 (2010): 179-188.
- Ibrahim, Esam Eltigani Mohamed and others. "Interaction with the Qur'an and Self Regulated Learning Vis-a-Vis Academic Achievement of Undergraduate Students". *International Journal of Current Research and Academic Review*. Vol.3. No. 9. (2015): 189-197.
- Inam, Bazmi. "Anxiety and Depression among Students of a Medical College in Saudi Arabia". *International Journal Health Science* (Qassim). Vol. 1. No. 2. (2007): 214-219.
- Ivankova, Nataliya V. Creswell. Jhon dan Stick. Sheldon I. *Using Mixed- Mehods Sequential Explanatory Design from Theory to Practice*. http://www.sagepub.com/foundations/includes/Appendix%20A.Ivan_kova.%20et%20al.2006.pdf.
- Jafari, Forough. "Comparison of Relation between Critical Thinking and Spritual Intelligent in Iranian Male and Female". *The International Journal of Humanities & Social Studies*. Vol. 2. No. 11. (2014): 127-134.
- James, Abigail dan Wells. Adrian. "Religion and Mental health: towards a Cognitive-Behavioural Framework". *British Journal of Health Psychology*. Vol.8. (2003): 359-376.
- James, B.J. dan Samuels, C.A. "High Stress Life Events and Spritual Development". *Journal of Psychology and Theology*. Vol. 27. No. 3. (1999): 250-260.
- Javadpour, Ali Sahraian. "Sleep Disruption and its Correlation to Psychological Distress among Medical Students". *SEMJ*. Vol. 11. (2010): 12-17.
- Jawaid, Hena. "Impact of Religion/Spirituality on Health: What are the Evidences?". *African Journal of Psychiatry*. Vol. 17. No. 6. (2014): 1-5.
- Jhonson, Thomas J. Kristeller, Jean dan Sheets, Virgil L. "Religiousness and Spirituality in College Students: Separate

- Dimensions with Unique and Common Correlates". *Journal of College and Character*. Vol. 2. (2004): 1-36.
- Jouhari, Zahra. Haghani, Fariba dan Changiz, Tahereh. "Factors Affecting Self Regulated Learning in Medical Students: a Qualitative Study". *Med Edic Online*. (2015).
- Jouhari, Zahra. Haghani. Fariba dan Chagiz. Tahereh. "Assessment of Medical Students' Learning and Study Strategies in Self-Regulated Learning". *Journal of Advances in Medical Education & Professionalism*. Vol. 4. No. 2. (2016): 72-79.
- Leeuwen, Van and others. "Aspects of Sprituality Concerning Illness". *Scandinavian Journal of Caring Sciences*. Vol. 21. (2008): 482-489.
- Lin and others. "The Relationship between Optimism and Life Satisfaction for Patients Waiting or Not Waiting for Renal Transplantation". *Transplantation Proccedings*. Vol. 42, No. 3. (2010): 763-765.
- Lisa, Aspinwall dan Taylor, Shelly. E. "A Stich in Time: Self Regulation and Proactive Coping". *Psychological Bulletin*. Vol. 121 (1997): 417-436.
- Luszczynska, Aleksandra and others. "Measuring One Component of Dispositional Sel-Regulation: Attention Control in Goal Pursuit". *Personality and Individual Differences*. Vol. 37. (2004): 555-566.
- Kassab, Salah Eldin and others. "Relationship between the Quality of Blended Learning Expetience, Self Regulated Learning, and Academic Achievement of Medical Students: a Path Analysis". *Advances in Medical Education and Practice*. Vol. 6. (2015): 27-34.
- Kaufman, David. Mensink, David dan Day, Victor. "Stressors in Medical School: Relation to Curriculum Format and Year of Study". *Teaching and Learning in Medicine*. (1998).
- Keniger, Lucy E and others. "What are the Benefits of Interacting with Nature?". *Int. J. Environ Res Public Health*. Vol. 10. (2013): 913-935.
- Khadivi, Asodalah. Adib, Yusef dan Farhangphour, Farnaz. "Relationship between Spritual Intelligence and Self-Esteem with Students' Educational Improvement". *European Journal of Experimental Biology*. Vol. 2. No. 6. (2012): 2408-2414.

- Khan, Mussarat Jabeen. Altaf, Seema dan Kausar, Hafsa. "Effect of Perceived Stress on Students' Performance". *FWU Journal of Social Science*. Vol. 7. No. 2 (2013): 146-151.
- Khan, Zeenat. "Attitudes towards Counseling and Alternative Support among Muslim in Toledo, Ohio". *Journal of Muslim Mental Health*. Vol. 1. No. 1. (2006):21-42.
- Kim, Kyong-Jee dan Jang, Hye W. "Changes in Medical Students' Motivation and Self-Regulated Learning: a Preliminary Study". *International Journal of Medical Education*. Vol.6. (2015): 213-215.
- Koole, Sander L. and others. "Why Religion's Burdens Are Light: From Religiosity to Implicit Self Regulation. *Personality and Social psychology Review*. Vol 14. No. 1 (2010): 95-107
- Krok, Darius. "The Role of Sprituality in Coping: Examining the Relationship between Spritual Dimension and Coping Styles". *Mental Helath. Religion. and Culture*. Vol. 11. No. 7 (2008).
- Kross, Ethan and others. "Self-Talk as a Regulatory Mechanism: How You Do it Matters". *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 106. No. 2. (2014): 304-324.
- Kupriyanov, Roman dan Zhdanov, Renald "The Eustress Concept: Problems and Outlooks". *orld Journal of medical Sciences*. Vol. 11. No. 2. (2014): 179-185.
- Kushida, Clete A. and others. "Symptom-based Prevalence of Sleep Disorders in an Adult Primary Care Population". *Sleep and Breathing*. Vol. 4. No. 1. (2000): 11-15.
- Laher, Sumaya dan Khan, Sumayyah. " Exploring the Influence of Islam on the Perception of Mental Illness of Volunteers in Johannesburg Community-Based Organisation". *Psychology & Developing Societies*. Vol. 23. No. 1 (2011): 63-84.
- Lamoshi, Abdulraouf Y. "Religion as a Resilience Tool to Manage Stress in Adolescents: Islamic Approach". *Global Journal of Human Social Science*. Vol. 15. No. 3 (2015): 5-7
- Larsen, Douglas P. Butler, Andrew C. dan Roediger, Henry L. "Comparative Effects of Test-Enhanced Learning and Self-Explanation on Long-Term Retention. *Medical Education*. Vol. 47. No. 7. (2013): 674-682.
- Laurent, Baptiste and others. "Spritual and Religious Beliefs as Risk Factors for the Onset of Major Depression: An International

- Cohort Study". *Psychological Medicine*. Vol. 43 (2013): 2109-2120.
- Leeuwen, Van and others. "Aspects of Spirituality Concerning Illness". *Scandinavian Journal of Caring Sciences*. Vol 21. (2008): 482-489.
- Lindholm, Jennifer A. "Spirituality in the Academy: Reintegrating our Lives and the Lives of our Students". *About Campus*. Vol. 12. No. 4. (2007): 10-17.
- Lohitashwa, Renu and others. "Effect of Stress on Sleep in Quality in Young Adults Medical Students: a Cross Sectional Study". *International Journal of Research in Medical Sciences*. Vol. 3. No. 12. (2015): 3519-3523.
- Mamo, Jonathan. R and others. "Psychological Stress among Maltese Undergraduate Medical Students". *International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health*. Vol. 4. No. 5. (2012): 840-849.
- Mayer, F. Stephan and others. "Why is Nature Beneficial? The role of Connectedness to Nature". *Environment and Behavior*. Vol. 41. No. 5. (2009): 607-643.
- Mohd, Mostafa Amr and others. "Does Gender Predict Medical Students' Stress in Mansoura, Egypt?". *Medical Education Online*. Vol. 13. No. 1. (2008): 1-8.
- Marjani and others. "Stress among Medical Students of Gorgan (South East of Caspian Sea) Iran". *Kathamandu University Medical Journal*. Vol. 6. No. 3 (2008): 421-425.
- Marzband, Rahmatollah. Hamzeh, Seyed dan Hamzehgradeshi, Zeinab. "A Concept Analysis of Spiritual Care Based on Islamic Sources". *Religions*. Vol. 7. No. 61. (2016): 1-11.
- McCarthy, Christopher J and others. "Psychological Resources as Stress Buffers: Their Relationship to University Students's Anxiety and Depression". *Journal of College Counseling*. Vo. 9 (2006): 99-112.
- McDonald dan Friedman. "Measures of Spiritual and Transpersonal Constructs for Use in Yoga". *International Journal of Yoga*. Vol. 2. NO. 1. (2009): 2-12.
- McDonald. Ana Wong dan Gorsuch. Richard. "Surrender to God: an Additional Coping Styles?". *Journal of psychology and Theology*. Vol. 28. No. 2. (2012): 149-161.

- McClelland, Megan M and others. "Links between Behavioral Regulation and Preschoolers' Literacy, Vocabulary, and Math Skills". *Dev. Psychol.* Vol. 43. (2007): 947-959.
- McCullough, Michael E. "Prayer and Health: Conceptual Issues, Research Review, and Research Agenda". *Journal of psychology and Theology.* Vol. 23. (1995): 15-29.
- McCullough, Michael E. dan Carter, Evan C. "Religion, Self-Control and Self-Regulation: How and Why Are They Related". dalam *Handbook of Psychology. Religion, and Spirituality.* Vol 1. (2013). 130.
- McCullough, Michael E. and Willoughby, Brian L.B. "Religion, Self-Regulation, and Self Control, Associations, Explanations, and Implications". *Psychological Bulletin.* Vol. 135. No. 1 (2009): 69-93.
- McMahon, Brenden T dan Biggs, Herbert C. "Examining Spirituality and Intrinsic Religious Orientation as a Means of Coping with Exam Anxiety" (2012).
- McKean, Michelle. "College students' Academic Stress and Its Relation to their Anxiety, Time Management, and Leisure Satisfaction". *American Journal of Health Studies.* Vol. 16. No. 1 (2000): 41-52.
- Meezenbroek, Eltica de Jager and others. "Measuring Spirituality as a Universal Human Experience: Development of the Spiritual Attitude and Involvement List (SAIL)". *Journal of Psychology Oncology.* Vol. 30. (2012): 141-167.
- Mitroff dan Denton. "A Study of Spirituality in the Workplace". *Sloan Management Review.* Vol. 40. No. 4. (1999): 83-92.
- Monaghan, Cheryl L. and others. *Medical Students Stress and Burnout.* Committedd on Physician Health and Rehabilitation. (2013).
- Moodlet, Trevor. *The Relationship between Coping and Spritual Well-Being during Adolescence.* (Disertasi University of the Free State. Bloemfontein. 2008).
- Mosely, Thomas H and others. "Stress, Coping and Well-Being among Third Year Medical Students". *Academic Medicine.* Vol. 69. NO. 9. (1994): 765-767.
- Muzafer, Yumna and others. "Burnout and its Association Factors in Medical Students of Lahore, Pakistan". *Open Acces Original Article.* (2015): 1-12.

- Mytko, Johanna J. Dan Knight, Sara J. "Body. Mind and Sprit: towards the Integration of Religiousity and Sprituality in Cance Quality of Life Research". *Journal of the Psychological. Social and Behavioral Dimensions of Cancer*. Vol. 8. No. 5. (1999): 439-450.
- Nazeer, Mohd dan Sultana, Razia. "Stress and It's Coping Strategies in Medical Students". *Scholar Journal of Applied medical Sciences* (SJAMS). Vol. 2. No. 6D. (2014): 3111-3117.
- Niemi, Paivi M. dan Vainiomaki, Paula T. "Medical Students Distress – Qality. Continuity and Gender Difference during a Six-Year Medical Programme. *Med Teach*. Vol. 28. No. 2. (2006): 136-141.
- Ning, Hoin Kwang dan Downing, Kevin. "Influences of Students Learning Experience on Academic Performance: the Mediator and Moderator Effects of Self Regulation and Motivation". *British Educational Research Journal*. Vol. 38. No. 2. (2012): 219-237.
- Norcross, Jhon C. "Evidence-Based Therapy Relationship." Sponsored by the American Psychological Association's (APA) Division of Psychotherapy and Division of Clinical Psychology (2010):29-30.
- Nygaard, Mark. "The Muslim Concept of Surrender to God". *International Journal of Frontier Missions*. Vol. 13. No. 3. (1996): 125-130.
- Othman, Khatijah. "Researching Solution based on Islamic View and Practice in Managing Financial and Work Place Stress". *International Journal of Academic Research in Business and Social Science*. Vol. 2. No. 8 (2012): 239-252.
- Oman, Douh and others. "Meditation Lowers Stress and Supports Forgiveness among College Students: a Randomized Controlled Trial". *Journal of American College Health*. Vol. 56. No. 5. (2008).
- Osman, Hanisah and others. "Islamic View on the Muslim Ethich of Loving". *World Applied Sciences Journal*. Vol. 27. No. 10. (2013): 1380-1384.
- Overstreet, Dawn V. "Spritual vs Religious: Perspectives from Today's Undergraduate Catholics". *Catholic Education: a*

- Journal of Inquiry and Practices*. Vol. 14. No. 2. (2010): 238-263.
- Palmer, Laura. K. and others. "The Relationship between Stress. Fatigue. and Cognitive Functioning". *College Student Journal*. Vol. 47. No. 2. (2013): 312-325.
- Panayiotou, Georgia dan Kokkinos, Constantinos M. "Self-Consciousness and Psychological Distress: a Study Using the Greek SCS". *Personality and Individual Differences*. Vol. 41. (2006): 83-93.
- Panus, Peter C. and others. "A Subgroup Analysis of the Impact of Self-Testing Frequency on Examination Scores in a Pathophysiology Course". *American Journal of Pharmaceutical Education*. Vol. 78. No. 9. (2014): 1-8.
- Pargament, Kenneth. "Advances in the Conceptualization and Measurement of Religion and Spirituality: Implication for Physical and mental Health Research". *Am Psychol*. Vol. 58 (2003): 64-74.
- Pargament, Kenneth. "The Psychology of Religion and Spirituality? Yes and No". *The International Journal for the Psychology of Religion*. Vol. 9. No. 1. (1999): 3-16.
- Pargament, Kenneth I. Koenig, Harold G dan Perez, Lisa M. "The Many Methods of Religious Coping: Development and Initial Validation of the RCOPE". *Journal of Clinical Psychology*. Vol. 56. No. 4. (2000): 519-543.
- Pargament, Kenneth I. Koenig and others. "Patterns of Positive and Negative Religious Coping with Major Life Stressors". *Journal for the Scientific Study of Religion*. Vol. 37. No. 4. (1998): 710-724.
- Pariat, Lakyntiew. Rynjah, Angelyne dan Kharjana. Joplin MG. "Stress Level of College Students: Interrelationship between Stressors and Coping Strategies". *IOSR Journal of Humanities and Social Science*. (Vol. 19. No. 8. (2014): 40-46.
- Park, Crystal L. Adler, Nancy E. "Coping Styles as a Predictor of Health and Wellbeing across the First Year of Medical School". *Health Psychology*. Vol. 22. No. 6. (2003): 627-631.
- Park, Kyung Hye and others. "The Relationship between Empathy. Stress and Social Support among Medical Students". *International Journal of Medical Education*. Vol. 6. (2015): 103-108.

- Piedmont. "Spiritual Transcendence and the Scientific Study of Spirituality". *Journal of Rehabilitation*. Vol. 67. No. 1. (2001): 4-14.
- Pintrich, Paul R. "The Role of Motivation in Promoting and Sustaining Self-Regulated Learning". *International Journal of Educational Research*. Vol. 31. No. 6 (1999): 459-470.
- Pintrich, Paul R. dan De Groot, Elisabeth V. "Motivational and Self Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance". *Journal of Educational Psychology*. Vol. 82. No. 1.(1990): 33-40.
- Pintrich, Paul R. "A Conceptual Framework for Assessing Motivation and Self- Regulated Learning in College Students". *Educ Psychol Rev*. Vol. 16. (2004): 385-407.
- Plante, Thomas G. "What Do the Spritual and Religious Traditions Offer the Practicing Psychologists?". *Pastoral Psychol*. (2008).
- Plante, Thomas G. *Contemplative Practice in Action: Spirituality, Meditation, and Health*. (Santa Barbara: Praeger. 2010).
- Popa, Bogdan, Guillet, Laurent dan Mullet, Etienne. "Cultural Differences in the Apparaisal of Stress". *Psicologica*. Vol. 35. (2014): 745-760.
- Powers, David V. Cramer, Robert J dan Brubka, Joshua M. "Sprituality, Life Stress, and Affective Well-Being". *Journal of Psychology and Theology*. Vol. 35. No. 3. (2007): 235-243.
- Preacher, Kristopher J. Rucker, Derek. D. dan Hayes, Andrew F. "Adressing Moderated Mediation Hyphotheses: Theory, Methods, and Prescriptions". *Multivariate Behavioral Reseacrh*. Vol. 42. No. 1 (2007): 185-227.
- Radcliffe, Christina dan Lester, Helen. "Perceived Stress during Undergraduate Medical Training: a Qualitative Study". *Medical Education*. Vol. 37. No. 1. (2003): 32-38.
- Radzi,Husni Mohd and others. "Religious and Spritual Coping Used by Student in Dealing with Stress and Anxiety". *International Journal of Asian Social Science*. Vol. 4. No. 2. (2014): 314-319.
- Rahman, Nor Iza A and others. "Stress Among Preclinical Medical Students of University Sultan Zainal Abidin". *Journal of*

- Applied Pharmaceutical Science*. Vol. 3. No. 11. (2013): 076-081.
- Reddy, Sudhakara and others. "Burnout among Dental Faculty and Students in a Dental College". *Indian Journal of Public Health Research & Development*. Vol.5. No. 1 (2014): 64-68.
- Rehman, Rehana and others. "Health and Spirituality – Walk along- in Wellness Journey of medical Students". *Journal Pakistan Medical Association*. Vol 63. No. 4 (2013): 495-500.
- Ruffing, Janet. "To Have Been One with the Earth: Nature in Contemporary Christian Mystical Experience". *Presence: the Journal of Spritual Directors International*. Vol. 3. NO. 1. (1997): 40-54.
- Ryff, Carol. D dan Keyes, Corey Lee. M. "The Structure of Psychological Well-Being Revisited". *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 69. No. 4. (1995): 719-727.
- Sa'ari, Che Zarrina. "Penyakit Gelisah (anxiety/al-haluc a) dalam Masyarakat Islam dan Penyelesaiannya menurut Psiko-Spiritual Islam". *Jurnal Usuludin* Vol. 14 (2001).
- Yasin, Safree Aris dan Dzulkifli. Mariam Adawiah. "Difference in Depression, Anxiety, and Stress between Low-and High-Achievement Students". *Journal of Sustainability Science and Management*. Vol. 6. No. 1 (2011): 169-178.
- Saipanish. Ratana. "Stress among Medical Students in a Thai Medical School". *Journal Medical Teacher*. Vol. 2. No. 5. (2003): 502-506.
- Salam, Abdus and others. "Stress among Medical Students in Malaysia: a Systematic Review of Literatures". *International Medical Journal*. Vol. 20. No. 6. (2013): 649-655.
- Salami and others. "Impact of Work-Related Stress on Managers' Performance". *European Journal of Scientific Research*. Vol. 45. NO. 2. (2010)" 249- 252.
- Sandars, Jhon dan Cleary, Timothy J. "Self Regulation Theory: Application to Medical Education- AMEE Guide". *Med Teach*. Vol. 33. No. 58. (2011): 875-886.
- Schmitter, Marc and others. "Chronic Stress in Medical and Dental Education". *MED Teach*. no. 29. (2005): 1085-1088.
- Schunk, Dale H. "Self Regulated learning: the Educational Legacy of Paul R. Pintrich". *Educational Psychologist*. Vol. 40 (2005): 85-94.

- Schwabe, Lars dan Wolf, Oliver T. "Learning under Stress Impairs Memory Formation". *Neurobiology of Learning and Memory*. Vol. 93. (2010): 183-188.
- Shukor, Khairunnisa A. dan Noor, Ahmad Firdaus Mohd. "Self-Regulated Learning Strategies in Islamic Education". *World Journal of Islamic History and Civilization*. Vol. 4. No.1. (2014): 25-31.
- Sedgeman. "Health Realization/Innate Health: Can a Quite Mind and Positive Feeling State be Accessible Over the Lifespan without Strss-Relief Techniques?. *Medical Journal of Experimental and Clinical Research*. Vol. 11. No. 12 (2005): 32-47.
- Seligmen, Martin E.P. Steen, Tracy A. Park, Nansook dan Peterson, Christopher. "Positive Psychology Progress Empirical Validation of Interventions ". *Positive Psychology Progress*. Vol. 42. (2005): 874-884.
- Seyedfatemi, Naiemah. Tafreshi, Maryam dan Hagani, Hamid. "Experienced Stresors and Coping Strategies among Iranian Nursing Students". *Biomedical Central Nursing*. Vol. 6. No. 11. (2007).
- Shah, Mohsin and others. "Perceived Stress. Sources and Severity of Stress among Medical Undergraduates in a Pakistani Meical School". *BMC Med Educ*. Vol. 10. No. 2. (2010).
- Shapiro, Shauna L. And others. "Stress Management in Medical Education: A Review of the Literature". *Acad Med*. Vol. 75. No. 7. (2000): 748-759.
- Sharma, Bharti. "Adjustment and Emotional Maturity among First Year College Students". *Pakistan journal of Social and Clinical Psychology*. Vol. 10. NO. 2. 92012): 32-37.
- Shendarkar, Ajay T dan Patil, Vijay. "A Study of Stressors in Medical College Students (Hostelities) in Northern Maharashtra". *Journal India Acad Forensic Med*. Vol.35. No. 5 (2013): 227-229.
- Sherina, Mohd. Sidik Dan Nadarajan, Kaneson "The Prevalence of Depression Among Medical students". *Malaysian Journal of Psychiatry*. Vol. 11. No. 1. (2003): 12-17.

- Sherina, Mohd S. Rampal, L and Kaneson, N. "Psychological Stress Among Undergraduate Medical Students". *Med J Malaysia*. Vol. 59. No. 2 (2004): 207-211.
- Siddle, Ronald and others. "Religious Delusions in Patients Admitted to Hospital with Schizophrenia". *SocPsychiatry Epidemiol*. Vol. 37. (2002): 130-138.
- Silver, Henry K dan Glick, Anita Duhl. "Medical Students Abuse: Incidence. Severity. and Significance". *JAMA*. Vol. 263. No. 4. (1990): 950-952.
- Singh, Ajit. Lal, Amar dan Shekhkar. "Prevalence of Depression among Medical Students of a Private Medical College in India". *Online Journal of Health and Allied Sciences*. Vol. 9. No. 4 (2010): 1-3.
- Smith, Timothy B. McCullough, Michael E. dan Poll, Justin. "Religiousness and Depression: Evidence for a main Effect and the Moderating Influence of Stressful Life Events". *Psychological Bulletin*. Vol. 129. No. 4. (2003): 614-636.
- Sohail, Nudrat. "Stress and Academic Performance among Medical Students". *Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan*. Vol. 23. No. 1 (2013): 67-71.
- Spurgeon, A. Jackson, C.A. dan Beach, J.R. "The Life Events Inventory: re-Scaling based on an Occupational sample". *Occup Med*. Vol. 51. (2001): 287-293.
- Sreeramreddy, Chandrashekhar T and others. "Psychological Morbidity. Sources of Stress and Coping Strategies among Undergraduate Medical Students of Nepal". *BMC Med Educ*. Vol.2. No. 7. (2007): 6920-6926.
- Stewart, David and others. "Pharmacy Students Self-Testing as a Predictor of Examination Performance". *American Journal of Pharmaceutical Education*. Vol. 78. No. 2. (2014): 1-6.
- Stewart, Sunita M and others. "Predicting Stress in First Year Medical Students: a Longitudinal Study. *Medical Education*. Vyasol. 31. No.3 (1997): 163-168.
- Sulaiman. "Healing in Islam: a Psychological Perspective". *IFE Psychologia: Psychotherapy- Unity in Diversity*. Vol. 21. No.3. (2013).
- Sullivan, Gwynn dan Sullivan, Martin. "Promoting Wellness in Cardiac Rehabilitation: Exploring the Role of Altruism".

- Journal of Cardiovascular Nursing*. Vol. 11. No. 3. (1997): 43-52.
- Swaminathan, Anandhalakshmi and others. "Perceived Stress and Sources of Stress among First-year medical Undergraduate Students in a Private Medical College – Tamil Nadu". *National Journal of Physiology. Pharmacy and Pharmacology*. Vol. 6. No. 1. (2016): 9-14.
- Synder, Charles R. "Hope Theory: Rainbows of the Mind". *psychological Inquiry*. Vol. 13. (2002): 249-275.
- Tamaki, Tetsuo and others. "Prevalence of and Factors Associated with Smoking among Japanese Medical Students". *J. Epidemiol*. Vol. 20. No. 4. (2010): 339-345.
- Taylor, Daniel J. dan Mramoweth, Adam D. "Patterns and Consequences of Inadequate Sleep in College Students: Substance Use and Motor Vehicle Accidents". *Journal of Adolescent Health*. Vol. 46. No. 6. (2010): 610-612.
- Thompson, Carolyn J dan Dey, Eric L. "Pushed to the Margins: Sources of Stress for African American College and University Faculty". *The Journal of Higher Education*. Vol. 69. No. 3. (1998): 324-345.
- Trusty, Jerry and others. "Effects of Gender, Socioeconomic Status, and Early Academic Performance on Postsecondary Education Choice". *Journal of Counseling & Development*. Vol. 78. No. 4. 463-472.
- Turan, Sevgi, Demirel, Özcan dan Sayek, Iskender. "Metacognitive Awareness and Self-Regulated Learning Skills of Medical Students in Different Medical Curricula". *Medical Teacher*. Vol. 31. No. 10. (2009): e477-e483.
- Vaz, RF, Mbajiorgu, EF, Dan Acuda, SW. "A Preliminary Study of Stress Levels among First Year Medical Students at University of Zimbabwe". *Cent Afr J Med*. Vol. 44. No. 9. (1998): 214-219.
- Waaajman, Kees. "Spirituality – a Multifaceted Phenomenon". *Studies in Spirituality*. Vol. 17. (2007): 1-113.
- Wadge, Amit Dharmopal dan Ganaie, Showkat Ahmed. "Study on Emotional Maturity and Coping Strategies among the Students Pursuing Rehabilitation Studies". *International Journal of Science and Research*. Vol. 2. No. 8. (2013): 451-457.

- Weis, Mirjam. Heikamp, Tobias dan Trommsdorff, Gisela. "Gender Differences in School Achievement: The Role of Self Regulation". *Frontiers in Psychology*. Vol. 4. (2013): 1-10.
- Wenger, Jay L. "The Implicit Nature of Intrinsic Religious Pursuit". *International Journal for The Psychology of Religion*. Vol. 17. No. 1. (2007): 47-60.
- Wen-Yu and others. "Psychological Dysfunction in Southeast Asian Refugees as Mediated by Sense of Coherence". *American Journal of Community Psychology*. Vol. 25. No. 6. (1997): 839-859.
- West, Courtney dan Sadoski, Mark. "Do Study Strategies Predict Academic Performance in Medical School?". *Medical Education*. Vol. 45. No. 7. (2011): 696-703.
- Wills, Margaret. "Connection, Action and Hope: an Invitation to Reclaim the "Spiritual" in Health Care". *Journal Religion Health*. Vol. 46 (2007): 423- 436.
- Wilks, Scot E. "Resilience Amid Academic Stress: the Moderating Impact of Social Support among Social Work Students". *Advances in Social Work*. Vol. 9. No. 2. (2008): 106-125.
- Woods, Nicole N. Mylopoulos dan Brydges, Ryan. " Informal Self-Regulated Learning on a Surgical Rotation: Uncovering Students Experiences in Context". *Advances in Health Science Education*. Vol. 16. No. 5. (2011): 643-653.
- World Health Organization (WHO). *Promoting Mental Health*. (2005).
- Wolters, Christopher A. Pintrich, Paul R. dan Karabenick, Stuart A. "Assessing Academic Self-Regulated Learning". *Paper for the Conference on Indicator of Positive Development: Definition, Measures, and Perspective Validity*. Child Trends. National Institutes of Health. 2003.
- Yip. Michael. CW. "Differences between High and Low Academic Achieving University Students in Learning and Study Strategies: a Further Investigation". *Educational Research and Evaluation*. Vol. 16. No. 6. (2009): 561-570.
- Young, J. Scott. Cashwell, Graig S dan Shcherbakova, Julia. "The Moderating Relationship of Spirituality on Negative Life Events and Psychological Adjustment". *Counseling and Values*. Vol. 45. No. 1. (2000): 49-57.

- Yusoff, Muhamad Saiful Bahri and others. "A Study on Stress. Stressors. and Coping Strategies among Malaysian Medical Students". *International Journal of Students Research*. Vol. 1. No. 2 (2011): 45-50.
- Yusoff, Muhammad Saiful Bahri and others. "The Development and Validity of the Medical Student Stressor Questionnaire (MSSQ)". *ASEAN Journal of Psychiatry*. Vol. 11. No. 1 (2010): 1-12.
- Yusoff, Muhammad Saiful Bahri. "A Confirmatory Factor Analysis Study on the Medical Students Stressor Questionnaire among Malaysian Medical Students". *Medicine Journal*. Vol. 3. No. 1. (2011): e44-e53.
- Yusoff, Muhammad Saiful Bahri dan Rahim, Ahmad Fuad Abdul. *The Medical Students Stressors Questionnaire (MSSQ) Manual*. Diakses dari: <http://www.researchgate.net/publication/200640404>.
- ZA, Zaid. Chan, SC dan Ho, JJ. "Emotional Disorders among Medical Students in a Malaysian Private Medical School". *Singapore Med J*. Vol. 48. No. 10. (2007): 895-899.
- Zakerimoghadam, M. and others. "Comparison of Effective Factors on Sleeping the Nurses and Hospitalized Patients' View-points". *Journal of Hayat*. Vol.12. No. 2. (2006): 4-12.
- Zimmerman, Barry J. "A social Cognitive View of Self Regulated Academic Learning". *Jurnal of Educational Psychology*. Vol. 81 (1989): 329-339.
- Zimmerman, Barry J. dan Martinez-Pons, Manuel. "Students Differences in Self Regulated Learning: Relating Grades. Sex. and Giftedness to Self Efficacy and Strategy Use". *Journal of Educational Psychology*. Vol. 82. No. 1. (1990): 51-59.

Jurnal-Jurnal Nasional

- Abidin, Zaenal. "Ketika Stress Bereaksi Islam Punya Solusi". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 3. No. 1. (2009): 148-166.
- Agustina, Rahayu. *Studi Mengenai Derajat Stress dan Coping Strategy pada Koas Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran Angkatan 2009*. Diakses dari <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/Studi-Mengenai-Derajat-Stres-Dan-Coping-Strategy.pdf>.

- Christyanti, Dika. Mustami'ah, Dewi dan Sulistiani, Wiwik. "Hubungan antara Penyesuaian Diri terhadap Tuntutan Akademik dengan Kecenderungan Stress pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya". *Insan*. Vol. 12. No. 03. (2010): 153-159.
- Ediyanto, Mara. Muhlasah, Novitasari dan Satyahadewi, Neva. "Pengklasifikasian karakteristik Metode K-Means Cluster Analysis". *Buletin Ilmiah Mat. Stat dan Terapannya (Bimaster)*. Vol. 02. No. 2 (2013): 133-136.
- Gaol, Nasib Tua Lumban. "Teori Stres: Stimulus. Respons. dan Transaksional". *Buletin Psikologi*. Vol. 24. No. 1. (2016): 1-11.
- Hadjam, M. Noor Rochman dan Widhiarso, Wahyu. "Pengujian Model Peranan Kecakapan Hidup terhadap Kesehatan Mental". *Jurnal Psikologi*. Vol. 38. No. 1. (2011): 61-72.
- Hardjana, Agus M. *Religiositas, Agama dan Spritualitas*. (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
- Heryadi, Ammar Fauzi. "Logika Tindakan: Membangun Sistem Nilai Religius". *Al-Huda*. Vol. 2. N0. 8. (2003).
- Husna, Aftina Nurul. Hidayati, Frieda N.R. dan Ariati, Jati. "Regulasi Diri Mahasiswa Berprestasi". *Jurnal Psikologi Undip*. Vol. 13. No. 1 (2014): 50-63.
- Karuniawan, Abraham dan Cahyanti, Ika Yuniar. "Hubungan antara Academic Smartphone Addiction pada Mahasiswa Pengguna Smartphone". *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*. Vol. 2. No. 1. (2013): 16-21.
- Khalifah, Siti Nur dan Lutfiah, Nurul. "Religiopsikoneuroimunologi Al-Qur'an (Studi Klaborasi Terapi Al-Qur'an dan Fungsi Otak dalam Menghadapi Stres)". *Buletin Psikologi*. Vol. 18. No. 1. (2010): 19-28.
- Klerk, De. "Sprituality, Meaning in Life and Work Wellness: A Research Agenda". *The International Journal of Organizational Analysis*. Vol. 13. No.1. (2005): 64-88.
- Kurniawan, Yudi dan Sulityarini, Indahrian. "Komunitas SEHATI (Sehat Jiwa dan Hati) sebagai Intervensi Kesehatan Mental Berbasis Masyarakat". *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*. Vol. 1. No. 2. (2016): 112-124.
- Kusuma, Pergiawati Pristiana dan Gusniarti, Uly. "Gifted Review: Hubungan antara Penyesuai Didi Sosial dengan Stres pada

- Siswa Akselerasi". *Jurnal Keberbakatan & Kreativitas*. Vol. 02. No. 01. (2008): 31-43.
- Martono dan Hastjarjo, Dicky. "Pengaruh Emosi terhadap Memori". *Buletin Psikologi*. Vol. 16. No. 2. (tt): 98-102.
- Masdar, Hariatul and others. "Depresi. Ansietas. dan Stres serta Hubungannya dengan Obesitas pada Remaja". *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*. Vol. 12. No. 4. (2016):138-143.
- Mujib, Abdul. "Motivasi Berprestasi sebagai Mediator Kepuasan Kerja". *Jurnal Psikologi*. Vol. 39. No. 2. (2012): 143-155.
- Mujib, Abdul. "Implementasi Psiko-Spiritual dalam Pendidikan Islam". *Madania*. Vol. 19. No. 2. (2015): 195-204.
- Nurtjahjanti, Harlina. "Spiritualitas Kerja sebagai Ekspresi Keinginan Diri Karyawan untuk Mencari Makna dan Tujuan Hidup dalam Organisasi". *Jurnal Psikologi*. Vol. 7. No. 1. (2010): 27-30.
- Nuryaningtyas dan Martiana, Tri. "Analisis Tingkat Risiko *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) dengan *The Rapid Upper Limbs Assessment* (RULA) dan Karakteristik Individu terhadap Keluhan MSDs". *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*. Vol. 3. No. 2. (2014): 160-169.
- Nuzulia. "Peran Self-Efficay dan Strategi *Coping* terhadap Hubungan antara Stresor Kerja dan Stres Kerja". *Jurnal Psikologika*. No. 19 (2005): 32-40.
- Pathmanathan, Vilasseni V. dan Husada, M. Surya. "Gambaran Tingkat Stress pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara Semester ganjil Tahun Akademik 2012/ 2013". *E Journal FK USU*. Vol. 1. No. 1 (2013): 1- 4.
- Pramana, Nym. Doni. Agung, AA. Gede dan Antari, Ni N. Madri. "Pengaruh Model Pembelajaran *Self Regulated Learning* (SRL) terhadap Sikap Spritual dan Hasil Belajar PPKn". *E-Journal PGSD Universitas Pendidikan Gancsha*. Vol. 3. No.1. (2015).
- Rai, I Wayan. "Andragogi dan Belajar Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat". *Majalah Aplikasi Iptek Ngayah*. Vol. 4. No. 1. (2013): 1-7.
- Rahmandani, Amalia. "Pemaafan dan Aspek Kognitif daro Stres pada Mahasiswa Jurusan Kebidanan Tingkat Dua". *Jurnal Psikologi Undip*. Vol. 14. No. 2. (2015): 118-128.

- Suhaimi. "Gangguan Jiwa dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam". *Jurnal Risalah*. Vol. 26. No. 4. (2015): 197-205.
- Sutjiato, Margaret. Kandou, G.D. dan Tucuman, A.A. T. "Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Tingkat Stress pada Mahasiswa Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado. *JIKMU*. Vol. 5. No. 1 (2015): 30-42
- Sukadiyanto. "Stress dan Cara Mengurangnya". *Cakrawal Pendidikan*. Vol.29. No. 1 (2010): 55-67.
- Suwartika, Ira. Nurdin, Agus dan Ruhmadi, Edi. "Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Stress Akademik Mahasiswa Reguler Program Studi D III Keperawatan Cirebon Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya". *Jurnal Keperawatan Soedirman*. Vol. 9. No. 3. (2014): 173-189.
- Tandaju, Yafet. Runtuwene, Theresia. Kembun, Mieke A.H. N. "Gambaran Nyeri Kepala Primer pada Mahasiswa Angkatan 2013 Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado". *Jurnal e-Clinic (eCh)*. Vol. 4. No. 1. (2016):1-4.
- Umar, Jahja. "Peran Pengukuran dan Analisis Statistika dalam Penelitian Psikologi". *Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia*. Vol. 1. No. 1. (2012): 47-55.
- Urbayatun, Siti dan Widiarso, Wahyu. "Variabel Mediator dan Moderator dalam Penelitian Psikologi Kesehatan Masyarakat". *Jurnal Psikologi*. Vol. 39. No. 2. (2012): 180-188.
- Wibowo, Ugun Dwi Ario. "Peran Regulasi Diri Islami dan Karakteristik Pekerjaan terhadap Komitmen Oraganisasional pada Karyawan Organisasi Syariah". *Jurnal Psikologika*. Vol. 18. No. 1 (2013): 89-97.
- Wildan, Tesa. "Hubungan Resiliensi Diri terhadap Tingkat Stres pada Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Riau". *JOM FK*. Vol. 3. No. 1. (2016): 1-9.

Buku-buku

- Abdullah, Muhammad Husain. *Mafahim Islamiyah*, terj M. Romli, (Bangil: Al-Izzah, 2002).
- ‘Abd Allah, Ṣālih Ibn. *Naḍrah al- Na‘īm fī Makārim al- Akhlāq al- Rasul al- Karīm*. (tt).
- Abdul-Rahman, Khaled Ibn. *Time Mangement from Islamic and Administrative Perspective* (1st Edition). (al-Riyad, 2008).

- Adz-Dzaky, Hamdani Bakran. *Psikoterapi dan Konseling Islam*. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001).
- Ahmad, Alyson St. *Interest in Religion Rises among College Students*. Diakses dari <http://huntnewsnu.com/2004/01/interest-in-religion-rises-among-college-students/>.
- Alam, Syamsir dan Aripin. Jaenal. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006).
- Al- Āmir, ‘Uthmān. *Mas’uliyah al- Muthaqqaf al- Islami Tujāh Qaḍaya al- Irhāb*. (al- Maktabah al- Shamilah. V.3.28).
- Al-Atsari, Abu Abdillah Syahrul Fatwa. *Sifat Tidur Nabi SAW*. (Bogor: Media Tarbiyah, 2014).
- Al-Bara, Abū dan Yāsīn al-Ma’anī, Usāmah. “Manhaj Shar’ fi ‘Ilāj al-Mass wa al-Ṣar’.” al-Silsilah al-‘Ilmiyah. Naḥw Mausū’ah Shar’iyah fil ‘Ilm al-Ruqy. Dār al-Ma’āfi, 2000).
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Rauḍat al-Ṭalibīn wa ‘Umdat al-Sālikīn dalam Majmu‘at Rasail al-Imam Al-Ghazali*. (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1986).
- Al-Ghazali, Abu Ahmad. *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*. (Beirut: Dār al-Ma’rifah. tt).
- Al- Hurās, Abd al-Salām. *Al-Islam Dīn al- Wasaṭiyah wa al-Faḍāil wal al- Qayyim al-Khalidah* (al-Maktabah al-Shamilah V.3. 12. T.Th).
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *Healing with the Medicine of the Prophet*. (KSA: Darussalam, 2003).
- Al- Jauziyah, Ibn Qayyim. *Al-Dawa’: Macam-Macam Penyakit Hati yang Membahayakan dan Resep Pengobatannya*. (Jakarta: Pustaka Imam as-Shafi’i, 2009).
- Al- Marāghī, Ahmad Mustafa. *Tafsir al- Marāghī*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001).
- Al- Ma’rawī, Iḥsan. *Maqālat Mauqi ‘al-Alukah* (Maktabah al-Shamilah. V. 3.28).
- Al-Munajjid, Sheik Muhammad Salih. *Dealing With Worries and Stress*. (United Kingdom. Dar as-SunnahPublisher, 2013).
- Al- Quṣairi, Imam. *Ar-Risalah al- Quṣairiyah fi ‘Ilmi at- Taṣawuf*. (Mesir: Dār al- Khair, tt).
- Al- Ṭabari, Abū Ja’far. *Jami’ al- Bayān fi Ta’wil al- Qur’an Jilid 14*. (Mu’assasah al- Risalah, 2000).

- Aldwin, Carolyn M. and others. "Coping and Self-Regulation Across the Life Span". *Handbok of Life Span Development*. (John Wiley and Sons. Inc, 2014).
- Ali, Yunasril. *Manusia Citra Ilahi: Perkembangan Konsep Insan Kamil Ibn 'Arabi oleh al-Jili*. (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Aly, Howayda A. *Sprituality and psychological Well-Being in The Muslim Community: an Exploratory Study*. Disertasi pada Universitas La Verne. (2010).
- Amer, Hasan. *The Psycholgy of al-Ghazali*. (Ttp: Akadimiyah al-Qasimi, 2006).
- American College Health Association. *American College Health Association-National College Health Assessment II: Reference Group Executive Summary Spring 2015*. (Hanover. MD: American College Health Association, 2015).
- Anderson, Jhon R. *Learning and Memory: An integrated approach*. 4th Edition. (New York: John Wiley & Sons. Inc, 1995)
- Antoniou, Alexander Stamatis G. dan Cooper, Cary L. *Research Companion to Organizational Health Psychology*. (USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2005).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rhineka Cipta. 2010).
- Arora, Anjali. *5 Langkah Mencegah dan Mengatasi Stres*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2008).
- Azwar, Syaifuddin. *Penyusunan Skala Psikologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Bacon, Eric L. *Sprituality in Higher Education: Sprituality and Students Engagement in First Year College Students*. (Disertasi pada Universitas Northern Arizona, 2008).
- Baharuddin. *Paradigma Psikologi Islami*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Bandura, Albert. *Self Efficacy: The Exercise of Control*. (New York: Freeman, 1997).
- Barlow, David H. *Anxiety and Its Disorder: The Natureand the Treatment of Anxiety and Panic*, (New York: The Guildford Press, 2002).
- Bastaman, Hanna Djumhana *Integrasi Psikologi dengan Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

- Beauregard, Marion dan O'Leary Denyse. *The Spritual Brain A Neuroscientist's Case for the Existence of the Soul*. (London: HarperCollins Publishers Ltd, 2007).
- Benner, David. *Care of Souls*. (Grand Rapids. MI: Baker Books, 1998).
- Black, Joyce M. & Hawks. Jane Hokanson. *Medical Surgical Nursing: Medical Management for Positive Outcome* 7th ed. (Elsevier: Elsevier Saunders).
- Brannon, Linda & Feist. Jess. *The Nervous System and the Physiology of Stress*. In: *Health Psychology: An Introduction to Behaviour and Health* 6th edition. (USA: Thomson Wadsworth, 2007).
- Briki, Walid. "Involvement in Religion and Self-Regulations: Explanations of Muslims' Affects and Behaviors during Ramadan". (USA: OMICS Group e-Book, 2014).
- Burkhardt, Margaret A. dan Jacobson, Mary Gail Nagai. *Spirituality: Living our Connectedness (Healer)*. (Delmar: Thomson learning, 2005).
- Canda, Edward R. dan Furman, Leola Dyrud. *Spiritual Diversity in Social Work Practice: the Hearth of Healing* 2nd Edition. (New York: Free Press, 2009).
- Carlson, Neil R. *Stress Disorder in Foundation of Physiological Psychology* 6th Edition. US: Pearson, 2005.
- Carr, Deborah dan Umberson, Debra. *The Social Psychology of Stress, Health, and Coping* dalam DeLameter. J. & Ward. A. (Eds.). *Handbook of Social Psychology* (Netherlands: Springer, 2013).
- Cholil, Adam. *Meraih Kebahagiaan Hidup dengan Zikir dan Do'a*. (Jakarta: AMP Press, 2013).
- Cohen, Debie and others. *Factor that Impact on Medical Student Wellbeing Perspective of Risk*. (Cardiff University, 2013).
- Creswell, Jhon. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* 4th Edition. (Boston: Pearson, 2012).
- Daradjat, Zakiah. *Islam dan Kesehatan Mental*. (Jakarta: Gunung Agung. 1983).
- Daradjat, Zakiah. *Psikoterapi Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2002).

- DeLaune dan Ladner. *Fundamentals of Nursing: Standards and Practice*. (New York: Thompson Delmar Learning, 2006).
- Denros, Mukhlis. *Memanusiaikan Manusia: Menjadi Manusia yang Diridhoi Allah Sesuai Contoh Rasulullah*. (Jakarta: Qibla, 2011).
- Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Dossey. Barbara Montgomery. *Core Curriculum for Holistic Nursing*. (Gaithersburg. MD. Aspen, 1997).
- El-Qusy, Abdul 'Aziz. *Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa/Mental*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- Ellis, Albert. *Humanistic Psychotherapy: the Rational-Emotive Approach*. (New York: Mc-Gram-Hill, 1973).
- Eaton. Charles Le Gai. *Islam and the Destiny of Man*. (New York: State University of New York Press, 1985).
- Fausiah, Fitria dan Widury, Julianti. *Psikologi Abnormal*. (Jakarta: UI-Press, 2007).
- Feist dan Feist. *Teori Kepribadian*. Edisi 7. (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010).
- Fenzel, L. Mickey. *Spiritual Involment Scale*. (Unpublished Manuscript. Layola Collage Maryland. Balumore. MD).
- Ferdinand. *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*. Edisi 2. (Semarang: Fakultas Ekonomi UNDIP, 2002).
- Fernando, Suman. "Sprituality and Mental Health Across Culture" in Sprituality. Values. and Mental Health. ed Marry Ellen Coyte. Peter Gilbert. & Vicky Nicholls. (London: Jessica Kingsley Publisher, 2007).
- Friedli, Lynne. *Mental Health. Resilience and Inequalities*. (Belanda: WHO Europe, 2009).
- Fry, Prem S dan Keyes. Corey L.M. *New Frontiers in Resilient Aging. Life Strengths and Well-Being in Late Life*. (New York: Cambridge University Pres, 2010).
- Fuente, Jesus De la and others. *Personal Self-Regulation. Self-Regulated learning and Coping Strategies in University Context with Stress*. (Switzerland: Springer International Publishing, 2014).
- Gates, Gordon S. Wolverton, Mimi & Gmelch, Walter H. *Research on Stress and Coping in Education*. (Greenwich: Information Age, 2002).

- Gilbert, Peter. *The Sprituality Foundation: Awareness for Contex People's Live Today in Sprituality. Value. and Mental Health*. (London: Jessica Kingsley Publisher, 2007).
- Ghozali, Imam. *Model Persamaan Struktural: Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 19.0*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008).
- Golan, Moria. "Good-Enough Parenting, Self Regulation, and the Management of Weight-Related Problems". in Bagchi, Debasis. *Global Perspective on Childhood Obesity: Current Status, Consequence and Prevention*. (UK: Academic Press, 2011).
- Greenfield, Emily. Vaillant, George E. Dan Marks, Nadine F. "Formal Religious Participation and Daily Spritual ExperiencesL Separate. but Equal. Linkage with Psychological Well-Being?". *Center for Demography and Ecology University of Wisconsin- Madison*. (2007).
- Ghufron, M. Nur dan Risnawati, Rini. *Teori-Teori Psikologi*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010).
- Gulo, Dali. *Kamus Psikologi*. (Bandung: Tonis, 1982).
- Gunarya, Arlina. *Manajemen Stress*. (Makassar: Modul MD08 TOT Basic Study Skill Angkatan ke V dan VI, 2008).
- Habibi, Ahmad Azwar. Mufatuzahra, Aisyah, Siti dan al- Maududi, Abu Al'ala "Integrasi Modul Dokter Muslim pada KBK PSPD FKIK dalam Mencapai Lulusan Mencapai Standard Lulusan Dokter UIN". *Laporan Hibah Pengajaran HPEQ 2012- Program Develop*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2012).
- Hadi, Sutrisno. *Seri Program Statustik Versi 2000*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2000).
- Hair, Joseph F and others. *Multivariate Data Analysis 7th Edition*. (New York: Pearson Prentice Hall, 2010).
- Hamka, Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. *Tafsir al- Azhar*. (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1999).
- Hathout, Hassan. *Forgiveness in Islam* diakses dari <http://hhlf.org/Forgiveness%20in%20Islam.pdf>.
- Hawa, Said. *Mensucikan Jiwa Konsep Tazkiyatun an- Nafs Terpadu*, (Jakarta: Robbani Press, 2002).

- Hawari, Dadang. *Manajemen Stress. Cemas. dan Depresi*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001).
- Herlina. *Pengaruh Triterpen Total Pegagan terhadap Fungsi Kognitif Belajar dan Mengingat pada Mencit Jantan Albino*. (Palembang. FMIPA Universitas Sriwijaya, 2010).
- Hidayat, Komaruddin. *Psikologi Beragama: Menjadikan Hidup Lebih Nyaman dan Santun*. (Jakarta: Hikmah, 2006).
- Hidayat, Komaruddin. *Psikologi Kematian: Mengubah Ketakutan Menjadi Optimisme*. (Jakarta: Hikmah, 2006).
- Hidayat, Komaruddin. *Psikologi Ibadah*. (Jakarta: Serambi, 2008).
- Huit, William G. dan Robbins, Jennifer L. *An Introduction to Spiritual Development*. Paper Presented at the 11th Annual Conference: Applied Psychology in Education. mental Health. and Business. (2003).
- Ibnu Katsir, Abu Fada' Isma'il. *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*. Juz 6. (Jakarta: Sinat Baru al- Gensindo, 2004).
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. (Jakarta: Erlangga, 2009).
- Ilham, Muhammad Arifin. *Indonesia Berdzikir*. Cet 1. (Jakarta: Intuisi Press, 2004).
- Indra, Syarif dan Isran, Syarif. *Kepribadian dan Pola Hidup Adalah Sumber Penyakit Sekaligus Obat*. (Bekasi: Brain Health Service BHS, 2011).
- Isnaini. *Senam Vitalisasi Otak dapat Meningkatkan Fungsi Kognitif Usia Dewasa Muda*. (Jakarta: Fisioterapi Universitas Kristen Indonesia, 2012).
- Jaenudin, Ujam. *Psikologi Transpersonal*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir. *Kamis Ilmu Tasawuf*. (Jakarta: Amzah, 2005).
- Joreskog, Karl G. *Factor Analysis by MINRES*. diakses dari www.ssicentral.com/lisrel/techdocs.
- Kartono, Kartini dan Gulo, Dali. *Kamus Psikologi*. (Bandung: CV. Pionir jay, 2000).
- Kawuryan, Fajar. *Tinjauan Faktor-Faktor Psikologis dan Sosial dalam Mempengaruhi Stres*. (Kudus: Mawas, 2009).
- Keller, Stephan R. dan Wilson, Edward O. *The Biophilia Hypothesis*. (Washington. DC: Island Press, 1993).

- Keraf, A. Sony. *Etika Lingkungan Hidup*. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010).
- Kertawirian, Rajendra. *12 Langkah Membentuk Manusia Cerdas*. (Jakarta: Hikmah, 2004).
- Khalid, Fazlun. "Islam and the Environment Ethics and Practice". *The 15th General Conference of the Environment in Islam*. (Amman: The Hashemite Kingdom of Jordan, 2010).
- Koenig, Harold G. *Is Religion Good For Your Health?: The Effect of Religion on Physical and Mental Health*. (New York: The Haworth Pastoral Press, 1997).
- Koenig, Harold. G. *Handbook of Religion and Mental Health*. (United States of America: Elsevier Science, 1998).
- Koenig, Harold G. *Spirituality in Patient Care-Why. How. When and What*. (Pennsylvania: Templeton Foundation Press, 2003)
- Koenig, Harold G. Dan Al- Shohaib. S. *Health and Well-Being in Islamic Societies: Background. Research. and Applications*. (Switzerland: Springer International Publishing, 2014).
- Kung, Hans. *Freud and the Problem of God*. (Washington: The Wilson Quarterly, 1979).
- Kusnendi. *Model-Model Persamaan Struktural*. (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Lahey, Benjamin B. *Psychology: an Introduction. 8th edition*. (New York: McGraw Hill, 2007)
- Lam, Michael. *Adrenal Fatigue & Adrenal Support*. diakses melalui https://www.drlam.com/articles/adrenal_fatigue.asp.
- Levesque, Roger J.R. *Encyclopedia of Adolescence*. (New York: Springer, 2011).
- Lazarus, Richard S. Dan Folkman, Susan. *Stress, Appraisal and Coping*. (New York: Springer-Verlag, 1984).
- Lubis, Ridwan. Francisca dan Habibi, Ahmad Azwar. "Studi Analitik Standar Kompetensi Dokter Muslim". *Laporan Penelitian Institusional*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2012).
- Lumonga. *Depresi Tinjau Psikologis*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Lyon, Brenda L. *Stress. Coping and Health a Conceptual Overview*. (Detroit: Sage Publication, 2012).
- Mackinley, Elizabeth. *Spiritual Growth and Care in the Fourth Age of Life*. (London: Jessica Kingsley Publisher, 2006).

- Madjid, Nurcholish. *Islam Dokterin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan. Kemanusiaan dan Kemo-
dernan.* (Jakarta: Paramadina, 1992).
- Madjid, Nurcholish. *Kehampaan Spritual Masyarakat Modern: Res-
pon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat
Madani.* (Jakarta: Media Cita, 2002).
- Mansūr, Abd al- Majīd Sayyid Ahmad. Al- Shirbini, Zakariyya
Ahmad dan Al- Faqiy, Ismāil Muhammad. *Al- Suluk al-
Insani Bayna al- Tafsir wa Usus ‘Ilm- Nafsi al- Mu‘asir.*
(Kairo: Maktabat al- Anjilu al- Miṣriyyah, 2001).
- Millis, Harry. Reiss, Natalie dan Dombeck, Mark. *Environmental.
Social and Spritual Strategies for Stress Relief.* diakses dari
[https://www.mentalhelp.net/articles/environmental-social-
and-spiritual-strategies-for-stress-relief/](https://www.mentalhelp.net/articles/environmental-social-and-spiritual-strategies-for-stress-relief/).
- Miller, Judith Fitzgerald. *Coping with Chronic Illness: Overcoming
Powerlessness* 3rd ed. (Philadelphia: Davis, 2000).
- Miller, Vacher. “Purpose and Connection: Sprituality in a Learning
Society”. Center for International Education at the Univer-
sity of Massachussetts-Amherst. (2013)
- Mohan. “Analysis of Problems and Adjustmen of University Rese-
arch Scholars”. Paper at the National Conference of Indian
Academy of Applied Psychology.Tirupati.
- Mohd, Taib Dora dan Hamdan, Abd Kadir. *Mengurus Stress.*
Malaysia: (PTS Publication Distributor Sdn.Bhd, 2006).
- Molcong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Rosda
Karya, 2004).
- Ahmad Mubarak. *Psikologi Qurani.* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).
- Mujib, Abdul. *Kepribadian dalam Psikologi Islam.* (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2006).
- Mujib, Abdul dan Mudzakir, Jusuf. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam.*
(Jakarta: Rajawali Pres, 2002).
- Mustafa, Zainal dan Wijaya, Tony. *Panduan Teknik Statistik SEM
dan PLS dengan SPSS AMOS: Konsep Dasar SEM dan PLS.
Pengenaln AMOS dan Smart PLS. Contoh dan Penerapan
SPSS AMOS dan Smart PLS.* (Yogyakarta: Cahaya Atma
Pustaka, 2012).
- Najati, Muhammad Utsman. *Psikoterapi Menurut al-Qur’an.* (Sela-
ngor: Human Enterprise, 1992).

- Najati, Muhammad 'Uthmān. *Al-Qur'an wa 'Ilm al-Nafs*. (Cairo: Dār al-Syūrūk, 1993).
- Najati, Uthman. *Al-Qur'an dan Psikologi*. (Jakarta: Aras Pustaka, 2001).
- Najati, Muhammad Utsman. *The Ultimate Psychology – Psikologi Sempurna ala Nabi SAW*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008).
- Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Sprituality*. (London: Routledge & Kegan Paul, 2008).
- Nasr, Seyyed Hossein. *Tasawuf Dulu dan Sekarang*. terj: Abdul Hadi. Mengutip dari Syaikh al-'Arabi al- Darqawi, *Letter of a Sufi*.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Nata, Abuddin. *Perspektif Islam tentang Pendidikan Kedokteran*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2016).
- Nata, Abuddin. Gholib, Achmad dan Fauzan, *Fikih Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2017).
- Nelson, James M. *Psychology. Religion. and Sprituality*. (New York: Springer, 2009).
- Nevid, Jeffrey S. Rathus, Spencer A. & Greene, Beverly. *Abnormal Psychology in Changing World 7th editon*. (United State: Prentice Hall, 2000).
- Notosoedirdjo, Moeljono dan Latipun. *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*. (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2005).
- Ogden, Jane. *Health Psychology: A Textbook*. (UK: Mc Graw-Hill Education, 2007).
- Ormrod, Jeanne Ellis dan Kumara, Amitya. *Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang*. Jilid 2. (Jakarta: Erlangga, 2002).
- Paloutzian dan Ellison. "Loneliness, Spritual Well-Being and Quality of Life". in *Loneliness: A Soucebook of Current Theory: Research and Therapy*. Ed. Peplau L. Perlman D. (New York: Wiley Interscience, 1982).
- Perry, Potter. *Fundamental Keperawatan Edisi 7 Buku 2*. (Jakarta: Salemba Medika, 2005).
- Pheasant, Stephen. *Body Space 2nd Edition*. (Philadephia: Taylor & Francis, 2003).

- Poewadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Preston, David Lawrence. *365 Steps to Practical Spirituality: A Day-by-Day Guide to Finding Health, Contentment, and Inner Peace*. (Oxford: How to Content, 2007).
- Qardawi, Yusuf. *Al-Īman wal al-Hāyat*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998).
- Qutub, Sayyid. *Fī Zilāl al- Qur'an*. (al- Maktabah al- Syamilah V. 3.28)
- Rafknowledge. *Insomnia dan Gangguan Tidur Lainnya*. (Jakarta. Gramedia, 2004).
- Rajab, Khairunnas. *Psikologi Agama*. (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014).
- Ramayulis. *Psikologi Agama*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2013).
- Rasmun. *Stress. Koping dan Adaptasi Edisi ke-I*. (Jakarta: Sagung Seto, 2004).
- Rice, Philip L. *Stress and Health (2nd edition)*. (California: Brooks/ Cole Publishing Company, 1992).
- Rice, F. Philip. *The Adolscent: Development, Relationships and Culture*. (USA: Allyn & Bacon, 1993).
- Rice, Virginia H. *Handbook of Stress. Coping. and Health: Implications for Nursing Research. Theory. and Practice*. (USA: Sage Publication. Inc, 2012).
- Rogers, Carl R. *On Becoming a Person*. (Boston: Houghton Mifflin, 1961).
- Rosen, Jefry A and others. *Noncognitive Skill in the Classroom: New Perspectives on Educational Research*. (USA: RTI Press, 2010).
- Rusdi, Ahmad. *Kecemasan dan Psikoterapi Islam. Dari Spritual Disorder hingga Persoalan Eksistensial Menuju Kesehatan psiko-Spritual*. (Disertasi UIN Pasca Sarjana, 2014).
- Saad, Marcelo dan Medeiros, Roberta de. *Spritual-Religious Coping-Health Services Empowering Patients' Resources*. (INTECH Open Science, 2012).
- Ṣabḥī, Ghāzī. *Al-Qur'an Manhāj al- Hāyah*. (al Maktabah al-Shamilah. V. 3.28).
- Sajari, Dimyati. "Dzikir: Makanan Spritual Sang Sufi". *Dialog*. Vol. 37. No. 1. (2014).

- Sarafino, Edward P. *Health Psychology 2nd Edition*. (New York: John Willey and Sons, 1994).
- Sariati, Aat. *Tinjauan Tentang Stres*. (Jatinangor: Fakultas Keperawatan Universitas Padjajaran, 2002).
- Schmuck, Peter dan Schultz, Wesley P. *Psychology of Sustainable Development*. (Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002).
- Schultz, Duane P dan Schultz, Sydmei E. *Theories of Personality*. (Belmont: Wadsworth, 2005).
- Schunk, Dale H. dan Zimmerman, Barry. *Self Regulated Learning: from Teaching to Self-Reflective Practice*. (New York: Guilford Press, 1998).
- Setiadi. *Konsep dan Penulisan Riset Keperawatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Seaward. *Managing Stress: Principles and Strategies for Health and Well-Being*. (Sudbury: Jones and Bartlett, 2006).
- Shafwan, Muhammad. *Wacana Spritual Timur dan Barat*. (Yogyakarta: Qalam, 2000).
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al- Qur'an – Tafsir Maudu'ī atas Pelbagai Permasalahan Umat*. (Bandung: Mizan, 1993).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al- Miṣbah*. Vol. 14. (Jakarta: Lentera Hati, 2003).
- Simuh. *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 1996).
- Sīna, Ibn. *Al-Fann al-Sādīs min al- Ṭabī'iyāt min Kitāb al-Shifā'*. (Paris: Enterprise Universitaire, 1988).
- Sina, Ibn. *An-Najāt*. (Kairo: Mustafā al- Bābī al-Halabī, 1988).
- Siregar, Revay. *Tasawuf dari Sufi Klasik dan Neo-Sufisme*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Siswanto. *Kesehatan Mental: Konsep, Cakupan dan Perkembangannya*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2007).
- Slameto. *Belajar dan Fakotor-Faktor yang Mempengaruhinya*. (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010).
- Smeltzer & Bare. *Textbook of Medical Surgical Nursing Vol. 2*. (Philadelphia: Lippincott William & Wilkins, 2008).
- Solihin, M. dan Anwar, Rasihan. *Kamus Tasawuf*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Stoger, Heidrun and Ziegler, Albert. "Self Regulatory Training through Elementary-School Students' Homework Comple-

- tion. In Zimmerman, Barry dan Schunk, Dale H. *Educational Psychology Handbook Series. Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance*. (New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2011).
- Spangler. David. *Crafting Relationship: the Holding of Others*. (Everett. WA: Lorian Press, 2008)
- Sperry, Len & Shafranske, E.P. *Spirituality Oriented Psychotherapy*. (Washington. D.C.: American Psychological Association, 2005).
- Sukmono, Rizki Joko. *Psikologi Zikir*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sullivan. Colleen Janette. *Academic Self-Refulation. Academic Performance. and College Adjustment: What is the First Year Experience for Colloge Students?*. Disertasi Universitas Maryland. (2010).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suharsono. *Melejitkan IQ, IE, IS*. (Depok: Insiasi Press, 2005).
- Sumatri, Arif. *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Sumarmo, Suprapti. *Pengantar Psikologi Klinis*. (Jakarta: UI Press, 2003).
- Sumiati. dkk. *Penanganan Stres*. (Jakarta: Trans Info Media, 2010).
- Sunarto dan Hartono. Agung. *Perkembangan Peserta Didik*. (Jakarta: Rhineka Cipta, 2008)
- Suparto. *Sehat Menjelang Usia Senja*. (Bandung: Rosda, 2003).
- Suzuki, David dan McConnell, Amanda. *The Sacred Balance: Rediscovering our Place in Nature*. (Vancouver. BC: Greystone Books, 2002)
- Stuart, Gail W. *Principles and Practices of Psychiatric Nursing 10th Edition*. (St Louis: Mosby, 2006).
- Syarif, Adnan. *Psikologi Qur'ani*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002).
- Synder, Christopher R. dan Lopez, Shane J. *Handbook of Positive Psychology*. (New York: Oxford University Press, 2002).
- Tarwaka. *Ergonomi Industri*. (Surakarta: Harapan Press, 2010).
- Taufik, Muhammad Izudin. *Al- Ta'asil al-Islamiyah al- Dirasat al- Insaniyah*. (Cairo: Dar al- Salam).
- Taylor, Elizabeth Johnston. *Spiritual Care: Nursing Theory. Research. and Practice*. (New York: Prentice Hall, 2002).

- Taylor, Shelly E. *Health Psychology*. (New York: McGraw Hill Inc, 2006).
- Terry, Krista P. Smith. *The Effects of Online Time Management Practice on Self Regulated Learning and Academic Self Efficacy*. Disertasi Doktor Teknologi Pendidikan pada Virginia Polytechnic Institute and State University. (2002).
- Terzian, Mary and others. *Assessing Stress in Children and Youth: A Guide for Out-Of-School Time Program Prcticioners*. Brief Researh To Results Child Trends. (2010).
- The Provost's Committee on Student Mental Health. *The State of Student Mental Health on College and University Campuses with a Specific Assessment of the University of Minnesota. Twin Cities Campus*. (2016).
- Toha, Ahmad. *Kedokteran Islam*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992).
- Trevisani, Cassandra. *A Correlational Study of Self Regulated Learning. Stress and Mindfulness in Undergraduate Students*. (Honours Thesis, 2015).
- Tsabit, Muhammad Khalid. *Quantum Ridha*. (Jakarta: AMZAH, 2009).
- Tzen, Sy-Yi dan Nieh, Hwa-Ming. "How Self-Concept, Self-Efficacy and Self-Evaluation Relate to Relate to Achievement Outcomes". *Proceedings of International Conference on Interactive Collaborative Teaching*. (Italia: 2015).
- Pintrich, Paul R. "The Role of Goal Orientation in Self-Regulated Learning". *Handbook of self-regulation*. (San Diego CA: Academic Press, 2000).
- Plante, T. *Contemplative Practice in Action: Sprituality, Meditation, and Health*. (Santa Barbara: Praeger, 2010)
- Polzer, Rebecca. *Sprituality and Self-Management of Diabetes in African Americans*. Disertasi Universitas North Caroline. (2005).
- Potter & Perry. *Fundamental of Nursing: Concept. Process and Practice*. Asih Y. Et all. Penerjemah. (Jakarta: EGC, 2005).
- Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina Miftahul. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

- VandenBos. Gary R. *APA Dictionay of Psychology*. (Washinton: American Psychological Association, 2007).
- Yastion, Layla. *Handbook for A Spritual Revolution*. (Maryland: Hamilton Books, 2009).
- Yusoof, Muhammad Saiful Bahri and others. *Prevalence and Sources of Stress Among Medical Students in Universiti Sains Malaysia*. Medical Education. (Universiti Sains Malaysia (USM)). 2009.
- Yusuf, Syamsu dan Nurihasan, A. Juntika. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. (Bandung: Rosdakarya, 2009).
- Wahab, Ibn Muhammad Abdul. *Kitab Tauhid*. (TT: Darul ‘Arabiyah, 1969).
- Waitz, Grete. Strome. Sigmund . S.Railo. Willi. *Conquer Stress With Grete Waitz* terjemahan Sinta A.W. (Bandung: Angkas, 2003).
- Widhiarso, Wahyu *Estimasi Reliabilitas Pengukuran dalam Pendekatan Model Persamaan Struktural*. diakses dari <http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files/Widhiarso%20-%20Estimasi%20Reliabilitas%20Pengukuran%20Dalam%20Pendekatan%20SEM.pdf>.
- Watts, Fraser. *Perspective on Prayer*. (Chippenham: Rowe, 2001).
- Wijanto, Setyo Hari. *Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.8: Konsep dan Tutorial*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Willard, Dalls. *Hearing God: Developing a Conversational Realation-ship with God*. (Downers Groov. IL: InterVarsity Press, 1999).
- Wong’s & Hockenbery. *Wong’s Nursing Care of Infants and Children*. 8th edition. (Canada: Mosby Elsevier, 2007).
- Zohar, Danah dan Marshal, Ian. *Spritual Capital: Memberdayakan SQ di Dunia Bisnis*, terj. Helmi Mustafa. (Bandung: Mizan, 2005).

GLOSARIUM

A

Abnormalitas

Sesuatu yang menyimpang dari normal atau berbeda dari yang khas, adalah perilaku karakteristik yang ditentukan secara subyektif, diberikan untuk mereka yang memiliki kondisi langka atau disfungsional

Abstraksi

Usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian

Abuse

Suatu tindakan dimana ketika seseorang dengan sengaja menyalahgunakan, memanfaatkan, memperlakukan orang lain secara tidak pantas dan tidak wajar tanpa memikirkan perasaan dan diri orang tersebut.

Adaptasi

Cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup.

Adrenalin

Sebuah hormon yang memicu reaksi terhadap tekanan dan kecepatan gerak tubuh

Aktualisasi diri

Pencapaian diri ke tahap tertinggi hakekat manusia

Ansietas

Respons emosi tanpa objek yang spesifik yang secara subjektif dialami dan dikomunikasikan secara interpersonal

Antroposentrik

Kecenderungan untuk memandang alam sebagai suatu sumber yang bisa dimanfaatkan (*expendable*) untuk kepentingan manusia.

B

Biologis

Proses yang ada pada organisme hidup

Blue print

Rancangan alat ukur tes

Burnout

Istilah psikologi yang digunakan untuk menggambarkan perasaan kegalan dan kelesuan akibat tuntutan yang terlalu membebankan tenaga dan kemampuan seseorang

D

Depresi

Salah satu gangguan kesehatan mental dengan perasaan sedih yang intens.

Disqualibrium

Kehilangan keseimbangan atau stabilitas mental

Disfungsi

Kekurangan atau kehilangan fungsi norma

Disorder

Keadaan yang tidak sesuai dengan tatanan umum; keadaan dan perasaan badan yang kurang enak karena gangguan penyakit atau karena salah satu organ tidak berfungsi

Disregulasi

Kegagalan untuk mengatur sesuatu dengan benar

Distress

Keadaan subjektif yang dipersepsikan tidak menyenangkan

E

Efikasi diri

Keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk mengorganisir dan menggerakkan sumber-sumber tindakan yang dibutuhkan untuk mengelola situasi-situasi yang akan datang

Egoisme

Kecenderungan seseorang untuk berkelakuan menguntungkan diri sendiri

Ekstrinsik

Berasal dari luar; tidak termasuk bagian intinya

Empati	Proses kejiwaan seseorang individu yang larut dalam perasaan orang lain baik suka maupun duka, dan seolah-olah merasakan ataupun mengalami apa yang dirasakan atau dialami oleh orang tersebut
Ergonomi	Studi tentang aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau menurut anatomi, fisiologi, psikologi, mesin, manajemen dan desain.
<i>Eustress</i>	Stress yang baik yang menguntungkan kesehatan
<u>F</u>	
Fitrah	Asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal
Fisiologi	Mempelajari hal yang berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup walaupun dalam setiap bidang memiliki pengertian masing-masing
Frustrasi	Suatu harapan yang diinginkan dan kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan.
<u>G</u>	
Gender	Suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (<i>distinction</i>) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat
<i>General Anxiety Disorder</i>	Salah satu kecemasan yang dikarakteristikan dengan adanya kecemasan yang tidak terkontrol, irasional, terus-menerus, kuat mengenai hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, dimana hal-hal tersebut dicemaskan secara berlebihan

H

Homeostasis

Ketahanan atau mekanisme pengaturan lingkungan kesetimbangan dinamis dalam (badan organisme) yang konstan

Hipersomnia

Kantuk berlebihan, terlihat dari tidur malam yang berkepanjangan, sulit mempertahankan keadaan terjaga pada siang hari, atau episode tidur yang tidak diinginkan pada siang hari

Holistik

Sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya.

Hormon

Zat kimia yang terbentuk dalam satu organ atau bagian tubuh dan dibawa dalam darah ke organ atau bagian di mana mereka menghasilkan efek fungsional. Hormon membawa pesan dari kelenjar kepada sel-sel untuk mempertahankan tngkat bahan kimia dalam aliran darah yang mencapai homeostasis.

I

Insomnia

Gejala kelainan dalam tidur berupa kesulitan untuk tidur.

Insulin

Hormon alami yang diproduksi oleh pankreas

Irasionalistik

Tidak dapat diterima oleh pikiran sehat

Intrinsik

Terkandung di dalamnya; berasal dari dalam

Instrumen

Alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu

obyek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variable

K

Kardiovaskuler

Gangguan yang menyebabkan penyakit jantung (kardio) dan pembuluh darah (vaskular)

Kartisol

Hormon stres utama, diproduksi di korteks adrenal. Membantu dalam manajemen stres, sekresi berlebihan kortisol dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan.

Katastrofi

Kejadian besar yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi seperti bencana alam dan perang

Kepribadian

Keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang.

Koas

Periode pendidikan dokter yang didasarkan pada penerapan (aplikasi) teori-teori yang sebelumnya sudah didapat dari periode praklinik.

Kognitif

Kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional (akal)

Koherensi

Perasaan bermaknaan dan tujuan hidup

Konstruk

Konsep yang telah dibatasi pengertiannya

Koping

Sebuah proses strategis untuk mengatasi stres, baik internal maupun internal

Kosmos

Suatu sistem dalam alam semesta yang teratur atau harmonis

Kuesioner

Suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku

ku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada

M

Maladaptiv

Kegagalan individu mengintegrasikan aspek-aspek identitas masa kanak-kanak ke dalam kematangan aspek psikososial kepribadian pada masa dewasa yang harmonis

Mental

Kepribadian yang merupakan kebulsatan yang dinamik yang dimiliki seseorang dan tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotoriknya.

Metakognitif

Kemampuan untuk mengontrol ranah atau aspek kognitif.

Mindfulness

Kualitas kesadaran diri (*consciousness*), yang mencakup keadaan sadar terjaga (*awareness*) dan perhatian (*attention*)

Morbiditas

Keadaan sakit; terjadinya penyakit atau kondisi yang mengubah kesehatan dan kualitas hidup

Muskuloskeletal

Struktur yang mendukung anggota badan, leher dan punggung.

N

Narkolepsi

Gangguan tidur yang gejala awalnya ditandai dengan rasa kantuk yang tidak tertahankan di siang hari, lalu pada umumnya berlanjut dengan serangan tidur atau tidur secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat

O

Obstruksi

Penyumbatan yang terjadi di dalam usus

Overload

Kelebihan beban atau pekerjaan yang dialami oleh seseorang

P

Phobia

Rasa takut pada suatu hal atau fenomena berlebihan.

Prevalensi

Konsep statistik yang mengacu pada jumlah

Problem based learning

Metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berfikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan

Psikologis

Psikis; Keadaan jiwa atau mental

Psikopatologi

Studi tentang penyakit mental, tekanan mental dan abnormal/perilaku maladaptif

R

Random

Tidak teratur; acak

Regulasi diri

Upaya individu untuk mengatur diri dalam suatu aktivitas dengan mengikutsertakan kemampuan metakognisi, motivasi, dan perilaku aktif.

Religiusitas

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

Reliability

Kehandalan dan keajegan suatu alat ukur

Resistensi

Daya tahan tubuh/individu dalam mengatasi keadaan yang berbahaya atau tidak menyenangkan

Ruh

Unsur non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya kehidupan.

S

Silabus

Rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.

Simptom
Sindrom

Gejala yang terlihat di permukaan
Kumpulan dari beberapa ciri-ciri klinis, tanda-tanda, simtoma, fenomena, atau karakter yang sering muncul bersamaan.

Skala likert

Skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat.

Spiritual

Diartikan sebagai yang berhubungan dengan yang suci atau yang berhubungan dengan supernatural

Spiritualitas

Keyakinan dalam kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri; tujuan hidup; keyakinan; kepercayaan terhadap takdir; menemukan makna dalam penderitaan; rasa syukur atas kehidupan; dan ekspresi perilaku seperti doa, dan ibadah.

Stres

Istilah yang mengacu pada gabungan tekanan fisik, mental, dan emosional pada seseorang

Stresor

Stimulus atau penyebab yang menimbulkan respon stres

Survei

Salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak

T

Tasawuf

Ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlaq, membangun dhahir dan batin serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi.

Trasendensi

Sesuatu di luar kesanggupan sebagai manusia

U

Universe

Alam semesta; seluruh bidang

V

Validitas

Ketepatan suatu item dalam mengukur

Variabel manifest

Variabel yang besaran kuantitatifnya dapat diketahui secara langsung,

Variabel laten

Variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, melainkan hanya bisa diukur secara tidak langsung melalui beberapa variabel indikator dengan Analisis Faktor Konfirmatori

INDEKS

A

Abdul Mujib · 52, 65, 71, 85, 98, 99, 250, 274
Abū al-‘Abbas · 81
Abuddin Nata · 44, 82, 98, 138, 141
Abuse · 30, 148, 350, 371
Adjustment · 1, 55, 58, 238, 337, 349, 368
Akademik · 4, 6, 24, 54, 78, 145, 174, 176, 228, 229, 235, 238, 264, 354, 355, 356
Akhlaq · 107
Albert Ellis · 15, 135, 206
Al-Darini · 116
Al-Ghazali · 60, 84, 94, 357
Ali bin Abi Thalib · 85
Al-Qur’an · 13, 68, 84, 110, 175, 189, 210, 212, 276, 284, 354, 365, 366
Ansietas · 263, 355, 371
Antai-Otong · 7
Arif Sumantri · 106, 292
Asia · 4
Australia · 32, 186

B

Banten · 20
Baqtayan · 58, 60, 61, 64, 247, 248, 269, 331
Barat · 10, 20, 47, 81, 87, 89, 91, 92, 93, 97, 99, 100, 104, 107, 108, 113, 186, 367
Barry J. Zimmerman · 11, 123, 125, 132, 169, 199, 308
Bastaman · 52, 358

Behavior · 34, 43, 74, 80, 157, 195, 199, 222, 232, 259, 289, 324, 334, 335, 339, 343, 424, 428, 440
Biologis · 75, 372
Burnout · 1, 5, 6, 10, 111, 131, 243, 335, 338, 339, 344, 348, 372

C

Carl Rogers · 51
Carolyn Aldwin · 11, 15, 16, 18, 134, 135, 200, 214, 220
CFA · 32, 38, 423
Cohen · 6, 35, 110, 359
CRS · 6, 110, 136, 264

D

Dadang Hawari · 76
Depresi · 13, 76, 263, 355, 362, 363, 372
Disease · 55
Disfungsi · 2, 50, 372
Disorder · 2, 7, 15, 55, 70, 82, 87, 204, 208, 248, 277, 329, 335, 358, 359, 366, 372, 373
Distress · 12, 64, 81, 148, 176, 205, 304, 312, 335, 340, 345, 346, 372
DKI · 17, 18, 19, 20, 27, 28, 137, 139, 389
Dokter · 139, 140, 141, 152, 246, 356, 361, 363

E

Efikasi diri · 199, 219, 312, 372
Ego · 299

Egoisme · 299, 372
 Eksternal · 71, 148, 154, 157, 356
 Emosi · 57, 78, 229, 244, 246, 253,
 254, 317, 355, 419
 Empati · 303, 305, 373
 Ergonomi · 255, 373
Eustress · 13, 64, 65, 67, 81, 228, 304,
 337, 342, 373

F

Fakultas · 5, 6, 24, 41, 54, 71, 76, 78,
 79, 137, 138, 140, 141, 142, 145,
 148, 152, 154, 157, 172, 227, 228,
 230, 238, 246, 257, 353, 354, 356,
 360, 362, 367, 401, 447, 448
 Fisio · 74
 Folkman · 11, 23, 24, 56, 57, 126,
 129, 130, 231, 321, 336, 363

G

Gender · 5, 144, 148, 150, 151, 157,
 161, 162, 169, 170, 200, 241, 332,
 333, 334, 335, 343, 345, 351, 352,
 373, 400, 402, 405, 407, 410, 411,
 414, 416, 418, 422
General Anxiety · 70, 329, 373
General Anxiety Disorder · 70
 Gomez · 32, 90, 91, 92, 106, 107, 183,
 336
 Gracts · 6

H

Hans Selye · 56, 234
 Hardiman · 6, 339
 Harold G. Koenig · 117, 319
 Harun Nasution · 97

I

Ibadah · 93, 96, 101, 107, 301, 305,
 362
 Ibn al-Muẓaffar · 82
 Ibnu Sina · 16
 Iman · 60, 107, 300
 IMDB · 138
 Indonesia · 4, 38, 76, 81, 115, 137,
 139, 140, 152, 186, 252, 256, 263,
 355, 356, 362, 366, 447
 Inggris · 32, 55, 81, 232, 238, 265,
 407, 448
 Insomnia · 260, 366, 374
 Internal · 21, 71, 148, 154, 157, 199,
 343, 356
 Interpersonal · 30, 43, 178, 181, 410,
 423, 426, 437
 Intrapersonal · 30, 43, 178, 410, 423,
 426, 437
 Iran · 3, 5, 54, 186, 330, 343
 Irlandia · 32
 Islam · 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 27,
 44, 46, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59,
 61, 64, 65, 70, 71, 81, 82, 83, 84,
 87, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108,
 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120,
 121, 122, 123, 124, 130, 133, 137,
 138, 140, 141, 143, 144, 189, 191,
 208, 209, 210, 212, 215, 247, 248,
 249, 250, 267, 269, 271, 272, 274,
 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283,
 284, 286, 287, 288, 289, 292, 297,
 300, 302, 304, 306, 313, 315, 316,
 320, 321, 327, 342, 348, 350, 353,
 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361,
 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369,
 422, 447, 448
 Isti'ānah · 107

J

Jakarta · 4, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 25, 27, 28, 29, 36, 37, 41, 42,
44, 52, 53, 59, 61, 66, 68, 76, 77,
81, 82, 85, 86, 92, 93, 95, 96, 97,
98, 101, 102, 105, 106, 114, 115,
119, 120, 137, 138, 139, 141, 142,
143, 147, 152, 171, 206, 208, 210,
234, 239, 240, 241, 247, 248, 250,
251, 252, 258, 260, 263, 271, 273,
274, 276, 277, 292, 299, 301, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364,
365, 366, 367, 368, 369, 370, 389,
447, 448
Jibril · 82
Jiwa · 16, 51, 52, 53, 54, 55, 354, 356,
360, 361

K

Karachi · 24
Kartisol · 78, 375
KBK · 227, 238, 361
Kecemasan · 6, 7, 15, 59, 82, 87, 208,
247, 248, 366
Kedokteran · 4, 5, 24, 54, 71, 73, 76,
78, 82, 98, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 145, 148, 149, 151,
152, 153, 154, 156, 157, 158, 161,
163, 164, 167, 169, 182, 228, 238,
246, 257, 353, 354, 355, 356, 362,
365, 389, 391, 393, 448
Kesehatan · 1, 2, 3, 15, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 62, 69, 82, 87, 98, 106,
111, 138, 140, 141, 208, 220, 222,
248, 251, 256, 292, 297, 323, 354,
356, 359, 360, 365, 366, 367, 368
Klinik · 263, 355
Koas · 24, 143, 353, 375
Kognitif · 251, 252, 295, 355, 362,
375

Komaruddin Hidayat · 92, 96, 97,
101, 115, 274, 277, 301
Konstruk · 81, 107, 375
Koping · 4, 23, 68, 119, 129, 147,
239, 307, 317, 318, 321, 366, 375,
389

L

Lahore · 4, 22, 243, 344
Latipun · 2, 3, 365
Lazarus · 11, 12, 23, 24, 56, 57, 126,
129, 130, 153, 231, 318, 321, 336,
363
Levenson · 18
LISREL · 37, 42, 43, 174

M

Ma'rifah · 6, 11
Malaysia · 3, 4, 13, 22, 63, 153, 155,
156, 205, 316, 339, 350, 364, 370,
447
Maslow · 51
Mental · 2, 3, 6, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
62, 87, 91, 93, 111, 112, 113, 118,
131, 134, 182, 183, 187, 192, 207,
209, 216, 251, 275, 295, 297, 306,
313, 320, 330, 332, 334, 337, 338,
339, 340, 342, 352, 354, 356, 359,
360, 361, 363, 365, 367, 369, 376
Modern · 271, 364
MSSQ · 29, 31, 63, 73, 177, 181, 353
Muhammad Saiful Bahri Yusoff · 29,
63, 73, 148, 153, 154, 181
Muraqabah · 99, 106, 107, 304
Musa · 14, 83, 110, 283
Musa Asy'ari · 83
Mustafah Fahmi · 52

N

Nature · 7, 133, 211, 216, 270, 287,
288, 289, 290, 291, 294, 295, 319,
331, 332, 337, 341, 343, 348, 352,
368
Notosoedirjo · 2, 51

O

Optimis · 71, 304
Outcomes · 312

P

Pakistan · 4, 22, 23, 181, 238, 243,
344, 348, 349, 350
Perancis · 81, 109
Perguruan Tinggi · 139, 141, 152, 447
Prevalensi · 145, 147, 377, 426
Psiko · 2, 8, 15, 58, 74, 82, 98, 208,
220, 248, 250, 323, 348, 355
Psikologis · 13, 70, 78, 244, 362, 363,
377

R

Regulasi diri · 11, 12, 19, 119, 121,
122, 125, 128, 134, 165, 166, 167,
196, 198, 200, 213, 214, 217, 218,
307, 308, 322, 326, 377
Reliability · 38, 40
Ridha · 66, 98, 369
Rohana Hamzah · 16
Ronald Siddlc · 15
Ruh · 83, 84, 174, 291, 377
Rumah Sakit · 140

S

Şalih ibn ‘Abd Allah · 6
Sayyed Husain Nasr · 93
Sebern Fisher · 12
SEM · 37, 40, 41, 43, 170, 173, 364
Spritual · 6, 10, 16, 26, 29, 32, 33,
330, 331, 332, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 347,
348, 352, 355, 359, 361, 363, 364,
365, 366, 367, 368, 370, 378
Spritualitas · 19, 33, 39, 40, 42, 45,
326, 354, 355, 378, 389, 391, 423,
425, 427, 430, 433, 435, 439
Stres · 3, 4, 13, 18, 24, 32, 35, 39, 40,
42, 45, 50, 54, 55, 57, 61, 62, 64,
66, 67, 68, 70, 73, 74, 77, 78, 79,
80, 81, 108, 119, 126, 128, 145,
146, 147, 148, 149, 151, 153, 154,
157, 158, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 178, 200, 203, 204, 206, 207,
208, 217, 219, 227, 228, 229, 230,
231, 232, 234, 235, 238, 239, 244,
245, 246, 251, 258, 263, 264, 281,
353, 354, 355, 356, 358, 362, 367,
368, 378, 389, 391, 393, 425, 426,
429, 432, 435, 436, 437
Stresor · 4, 5, 18, 19, 26, 29, 38, 40,
42, 45, 68, 71, 73, 108, 125, 126,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 176,
177, 178, 179, 180, 203, 204, 219,
231, 326, 355, 378, 423, 425, 426,
429, 430, 432, 435, 436, 437
SWBQ · 29, 32, 33
Syarif Hidayatullah · 15, 17, 20, 25,
27, 40, 137, 138, 139, 143, 208,
248, 361, 363, 389, 447, 448

T

Tadabbur · 305
Tafakkur · 99, 103, 107, 124
Takhalluq · 107, 305

Tasawuf · 97, 98, 99, 101, 114, 362,
365, 367, 379
Tawakkal · 98, 107, 209
Tawassum · 107, 289, 305
Trisakti · 17, 20, 25, 27, 40, 137, 139,
140, 143

U

UCLA · 109, 159
UIN · 15, 17, 20, 25, 27, 40, 41, 82,
87, 137, 138, 139, 143, 152, 208,
248, 357, 361, 363, 366, 389, 422,
447, 448
UK · 118, 121, 186, 318, 361, 365
Usāmah bin Yāsīn al-Maʿani · 16
Utsman Najati · 70, 197, 241, 250,
276, 277

V

Validitas · 37, 38, 39, 379

Y

YARSI · 17, 20, 25, 27, 40, 137, 140,
141, 142, 143, 422
Yūnus · 96
Yunasril Ali · 95
Yusuf · 8, 9, 29, 59, 60, 71, 72, 85, 99,
210, 229
Yusuf Mudzakir · 71, 85
Yusuf Qardawi · 59, 60

Z

Zakiah Daradjat · 52, 53, 60, 61
Zikir · 8, 115, 359, 368
Zimbabwe · 149, 150, 351



LAMPIRAN - LAMPIRAN







LAMPIRAN A

INSTRUMEN PENELITIAN

- Lembar Persetujuan Subjek Penelitian
 - Kuesioner Penelitian
 - Hasil Wawancara



Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera

Dengan ini, saya mahasiswi Pascasarjana Strata Tiga (S3) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meminta waktu Saudara/i untuk berpartisipasi mengisi skala ini sebagai data kuantitatif penelitian disertasi saya yang berjudul **“Spritualitas dan Regulasi Diri Belajar: Studi Koping Stres pada Mahasiswa Kedokteran di DKI Jakarta”**. Sehingga demikian, sejumlah mahasiswa kedokteran tingkat pertama, kedua dan ketiga akan diikutsertakan dalam penelitian ini.

Adapun penjelasan dari isi lembar pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Anda merupakan jenis alat ukur penelitian guna mengetahui sumber stres dan tingkat stres yang dirasakan, serta meneliti sejauh mana spritualitas dan regulasi dapat menjadi *buffer* terjadinya stres. Dalam skala ini ini tidak ada jawaban benar atau salah, semua jawaban benar jika sesuai dengan apa yang Saudara/i alami atau rasakan selama ini. Alangkah bijaksananya apabila Saudara/i menjawab dengan **kejujuran** dan **kesungguhan hati**. Dalam penelitian ini, data Saudara/i dijamin kerahasiannya. Hal yang terbaik adalah anda tidak menghabiskan waktu terlalu lama pada tiap item pertanyaan sehingga setiap pertanyaan dijawab dengan secara spontan dan merupakan jawab yang Saudara **pikirkan pertama kali**.

Terima kasih

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Peneliti

Syahidah Rena
(13.3.00.1.16.01.0032)

PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN

Kami ingin meminta kesedian Saudara untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Dalam partisipasi selama penelitian ini dibutuhkan kesedian Saudara untuk meluangkan waktu sekitar 15-20 menit. Penelitian ini akan membutuhkan partisipasi Saudara untuk :

1. Membaca dan menandatangani surat persetujuan partisipasi dalam penelitian;
2. Mengisi skala yang sudah disediakan.

Apabila ada sesuatu yang membuat Saudara terganggu selama penelitian ini, Saudara dapat mengundurkan diri. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan serta referensi bagi penelitian selanjutnya maupun pihak Universitas. Penelitian ini tidak memiliki risiko apa pun atas diri Saudara secara fisik dan psikologis. Semua informasi yang saudara berikan akan terjaga kerahasiaannya, dan akhirnya hasil penelitian ini akan dipublikasikan sebagai laporan penelitian Disertasi.

Saya memahami semua informasi di atas dan dengan ini menyatakan kesedian untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.



Tandan Tangan Partisipan



Tanggal

IDENTITAS PRIBADI

Nama (boleh inisial) :
 Contact person (Hp) :
 Usia :
 Jenis Kelamin : L / P
 Agama :
 Universitas :
 Semester/ Angkatan :

PETUNJUK PENGISIAN SKALA

Terdapat empat skala dalam lembaran ini. Pertama, Skala Persepsi Stres terdiri dari 10 pernyataan. Kedua, Skala Sumber Stres (stresor) Mahasiswa Kedokteran terdiri dari 27 pernyataan. Ketiga Skala Spritualitas terdiri dari 20 pernyataan dan keempat, dan Skala Regulasi Diri Belajar terdiri dari 29 pernyataan. Pada kolom samping kanan terdapat pilihan jawaban. Bacalah petunjuk keterangan kode pilihan jawaban pada setiap skala!

SKALA 1 SKALA PERSEPSI STRES

Pernyataan pada skala ini mempertanyakan tentang perasaan saudara selama satu bulan terakhir. Pada setiap item, saudara ditanyakan seberapa **sesuai** merasakan hal-hal tersebut. Saudara dimohon memberikan tanda cek (X) pada opsi yang paling mencerminkan kondisi saudara.

No	Item pernyataan	Kode Pilihan Jawaban				
		STS	TS	AS	S	SS
1	Pada satu bulan terakhir, saya kecewa terhadap keadaan yang tiba-tiba muncul					
2	Pada satu bulan terakhir, saya sulit mengontrol perihai penting dalam hidup					
3	Pada satu bulan terakhir, saya gugup menghadapi sesuatu yang penting					
4	Pada satu bulan terakhir, saya merasa percaya diri dalam menangani masalah					
5	Pada satu bulan terakhir, saya merasa sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang					

	semestinya memang diharapkan					
6	Pada satu bulan terakhir, saya merasa gagal menyelesaikan masalah yang seharusnya bisa dilakukan					
7	Pada satu bulan terakhir, saya sulit mengontrol kejengkelan terhadap masalah dalam hidup					
8	Pada satu bulan terakhir, saya merasakan berada di puncak sesuatu yang sangat penting					
9	Pada satu bulan terakhir, saya marah terhadap keadaan yang tiba-tiba muncul					
10	Pada satu bulan terakhir, saya sulit memenuhi tuntutan yang semestinya harus diselesaikan					

SKALA 2

Skala Sumber Stres Mahasiswa Kedokteran

Skala ini akan mengidentifikasi sumber stres sekaligus mengukur tingkat intensitas stresor tersebut. Saudara dimohon memberikan tanda cek (X) pada opsi yang paling mencerminkan kondisi saudara.

No	Saya merasakan stres (SR/R/S/B/SB) ketika.....	Rating				
		SR	R	S	B	SB
1	Ujian					
2	Menghadapi konflik dengan mahasiswa lain					
3	Mendapatkan makian					

	verbal atau fisik dari mahasiswa lainnya					
4	Mendapatkan harapan yang tinggi dari orang tua					
5	Menetapkan harapan diri (melakukan hal terbaik)					
6	Melakukan tugas yang berat					
7	Berpartisipasi pada diskusi kelas					
8	Tidak mendapatkan cukup waktu membaca					
9	Kurangnya bimbingan dosen					
10	Merasa tidak mampu					
11	Memiliki sedikit waktu bersama keluarga dan teman					
12	Banyak persaingan dalam hasil belajar					
13	Dosen dirasakan kurang memiliki keahlian mengajar					
14	Mendapatkan tugas yang tidak sesuai					
15	Memiliki kesulitan memahami materi					
16	Mendapatkan nilai yang buruk					
17	Menjumpai motivasi belajar yang menurun					
18	Merasakan sedikit waktu untuk mengulang materi pelajaran					
19	Mendapatkan gangguan tugas studi dari teman					
20	Tidak mampu menjawab pertanyaan dosen					

21	Tidak memiliki keinginan untuk studi kedokteran					
22	Mendapatkan materi yang banyak untuk dipelajari					
23	Harus melakukan hal lebih karena paksaan orang lain					
24	Menghadapi proses penilaian yang tidak fair					
25	Kurang mendapatkan penghargaan atas tugas yang telah dikerjakan					
26	Berhadapan dengan komputer dalam waktu yang lama					

SKALA 3 SKALA SPIRITUALITAS

Pada skala ini, saudara diminta untuk memberi respon terhadap tiap pernyataan dengan memberikan tanda silang (X) pada opsi yang **saudara rasa paling benar** dapat merefleksikan pengalaman pribadi saudara selama ini.

No	Pernyataan	Respon				
		STS	TS	AS	S	SS
1	Saya mampu mengembangkan rasa kasing sayang antar sesama manusia dengan mudah					
2	Ketika beribadah saya merasa seperti berkomunikasi dan berhubungan dengan Tuhan					
3	Sulit bagi saya untuk memaafkan kesalahan orang lain					
4	Saya melakukan kegiatan mendekatkan diri dengan					

	alam seperti memanjat gunung,pergi ke pantai atau ke tempat wisata alam lainnya agar dapat merasakan energi positif alam					
5	Saya mengenal diri sendiri					
6	Saya beribadah kepada Tuhan sebagai wujud keterpaksaan kepada-Nya					
7	Saya merasa takjub akan kejadian di alam sekitar seperti pada luasnya langit dan dalamnya lautan					
8	Saya khawatir ketika meminjamkan sesuatu kepada orang lain					
9	Saya sulit memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri					
10	Saya merasa bahwa saya, tumbuhan, hewan dan alam memiliki hak yang berbeda untuk dipenuhi					
11	Saya merasakan bahwa Tuhan dekat dan selalu bersama					
12	Saya merasa asing ketika berinteraksi dengan alam					
13	Saya merasa tenang setiap saat mengingat Tuhan					
14	Saya merasakan kegembiraan hampir pada setiap hari-hari yang dijalani					
15	Saya berdoa setiap kali memulai setiap pekerjaan					

	dan belajar					
16	Saya sulit menangkan diri sendiri ketika menghadapi masalah					
17	Saya menghormati orang lain meskipun berbeda pendapat					
18	Saya suka merenungi makna dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup					
19	Saya segan untuk menolong orang lain					
20	Ketika mengamati proses dan kejadian alam saya merasakan keajaiban di dalamnya					

SKALA 4 SKALA REGULASI DIRI BELAJAR

Skala ini akan mengukur regulasi diri belajar anda yang meliputi regulasi emosi dan tingkah laku/strategi belajar. Saudara dimohon memberikan tanda silang (X) pada opsi yang paling mencerminkan kesesuaian dengan diri saudara.

No	Pernyataan	Respon				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya ingin melakukan hal terbaik untuk menunjukkan kemampuan diri pada keluarga, teman dan semua orang					
2	Belajar dengan cara yang tepat, akan membuat saya mampu mempelajari materi perkuliahan					
3	Hal yang paling menyenangkan adalah					

	mencoba memahami secara mendalam materi kuliah sebaik mungkin					
4	Saya percaya diri untuk mampu memahami konsep dasar yang diajarkan di perkuliahan ini					
5	Saya mengetahui konsekuensi akan kegagalan di saat ujian					
6	Ketika belajar, saya membuat ringkasan ide utama materi yang didapatkan dari dosen, buku dan hasil diskusi					
7	Pada waktu belajar, beberapa kali saya ketinggalan materi pembahasan karena memikirkan sesuatu di luar perkuliahan					
8	Meskipun beberapa materi perkuliahan membosankan dan kurang menarik, saya akan tetap berusaha keras menyelesaikan kuliah					
9	Saya belajar dengan mahasiswa lain untuk menyelesaikan tugas perkuliahan					
10	Ketika belajar, saya memberi tanda khusus untuk memudahkan penyusunan ide utama materi perkuliahan					
11	Saya lebih memilih materi perkuliahan yang menantang rasa ingin					

	banyak tau					
12	Saya kurang tertarik dengan materi perkuliahan kampus					
13	Saya ingin mendapatkan nilai terbaik diantara mahasiswa sekelas lainnya					
14	Meskipun memiliki kesulitan dalam beberapa materi perkuliahan, saya berusaha menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan dari siapapun					
15	Ketika mempelajari teori baru, saya mencoba mencari bukti lainnya yang mendukung ide tersebut					
16	Ketika kurang memahami materi perkuliahan saya bertanya pada mahasiswa lainnya					
17	Memahami subjek perkuliahan menjadi hal yang sangat penting bagi saya					
18	Ketika ujian, saya seringkali merasa kurang diantara teman sekelas lainnya					
19	Saya menghafal beberapa kata kunci untuk mengingat konsep dasar					
20	Bukan kesalahan sendiri, jika saya gagal mempelajari dengan baik materi perkuliahan					
21	Saya percaya diri untuk mampu memahami					

	sekompleks apapun materi yang disampaikan dosen					
22	Saya mulai mengembangkan ide pemikiran setiap kali mengulang materi perkuliahan					
23	Saya merasakan malas dan bosan pada beberapa kelas tertentu, sehingga terhenti dari rencana yang sudah dibuat sebelumnya					
24	Saya memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar					
25	Ketika membaca, saya membuat pertanyaan pribadi untuk meningkatkan fokus bacaan					
26	Ketika belajar, saya mengulang lagi dan lagi materi yang sudah diajarkan					
27	Saya membuat diagram, chart atau sejenisnya untuk merangkum ide utama materi perkuliahan					
28	Saya terbiasa berganti – ganti tempat belajar					
29	Ketika belajar, saya mencoba menjelaskan materi kepada teman lainnya					

TERIMA KASIH

WAWANCARA TERHADAP MAHASISWA

A. TUJUAN WAWANCARA

Tujuan wawancara untuk menemukan permasalahan yang lebih khusus seperti memperoleh data pengalaman, persepsi, dan tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengatasi stres akademik yang dialami.

B. WAWANCARA SUBJEK A

1. Keterangan Umum

Interviewer : Syahidah Rena
Interviewee : Inisial A-T-1
Gender : Laki-laki
Tempat wawancara : Kampus Responden A
Hari/Tanggal/Pukul : Senin/6 Februari 2017/ 09.30 WIB

2. Gambaran Subjek A

Subjek A merupakan mahasiswa dari tahun pertama yakni semester 2. Pada pengisian angket subjek A merupakan responden dengan no urut 41. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif subjek terindikasi memiliki tingkat stres tinggi dengan hasil skor stres 3432, sementara skor ≥ 32 termasuk kategori stres tinggi (lihat tabel prevalensi stres). Subjek A juga terindikasi memiliki tingkat spiritualitas rendah dengan hasil skor 6271, sementara skor ≤ 71 termasuk kategorisasi spiritualitas rendah (lihat tabel kategorisasi spiritualitas). Selanjutnya subjek A juga terindikasi memiliki regulasi diri belajar yang rendah dengan skor 8494, sementara skor ≤ 94 termasuk kategorisasi regulasi diri belajar rendah (lihat tabel kategorisasi regulasi diri belajar).

3. Deskripsi Hasil Wawancara

Penilaian terhadap pembelajaran

Subjek A menjelaskan ada perbedaan pola dan metode belajar pada perguruan tinggi dan sekolah. Dirinya menjelaskan pola pembelajaran di perguruan tinggi khususnya pada pendidikan dokter ini sangat berbeda dengan kebiasaan belajar di masa SMU di mana biasanya guru yang banyak menyampaikan informasi, namun pada pembe-

lajaran sistem PBL yang diterapkan di Fakultas kedokteran menuntut subjek A untuk banyak belajar secara mandiri dan harus menyelesaikan beberapa tugas tepat waktu. Namun seiring dengan tuntutan tersebut seringkali subjek A merasakan ketakutan setiap mendapatkan tugas baru dikarenakan di waktu yang bersamaan tugas pada materi perkuliahan lain juga harus diselesaikan.

Subjek A juga seringkali merasa bingung memilih prioritas materi apa saja yang harus dipelajari terlebih dahulu. Bahkan terkadang menghadapi tugas yang berturut-turut subjek merasakan sedikit penyesalan mengapa harus mengambil bidang keilmuan ini.

Indikasi stres-Uncontrolled

Menurut subjek A menjalani proses pendidikan kedokteran cukup mengurus emosi, perlu adaptasi terkait proses belajar. Subjek menjelaskan dirinya sedikit kaget (*shock*) dengan pembelajaran dimana dirinya harus banyak membaca untuk memecahkan beberapa permasalahan yang harus dipecahkan dalam bentuk tugas yang diberikan oleh dosen. Termasuk pula subjek menjelaskan seringkali dirinya kehilangan kontrol diri berkejar-kejar dengan waktu untuk menyelesaikan beberapa tugas dalam waktu yang singkat dan hampir bersamaan.

Indikasi stres-Kesal dan kecewa

Subjek A menjelaskan bahwa tugas yang diberikan sebenarnya kebanyakan merupakan tugas kelompok, tidak jarang muncul rasa kesal karena beberapa tingkah laku teman yang menurutnya baru ia kenal dan perlu waktu untuk merasa nyaman bersama teman baru. Seringkali kejengkelan itu tidak bisa dilampiaskan langsung kepada yang bersangkutan, sehingga memunculkan rasa kecewa pada diri sendiri, buruknya lagi subjek A mengakui rasa kesal dan kecewa seringkali harus ia lampiaskan kepada orang lain, seperti teman dan keluarga.

C. WAWANCARA SUBJEK B

1. Keterangan Umum

Interviewer : Syahidah Rena
Interviewee : Inisial B-R-1
Gender : Perempuan
Tempat wawancara : Kampus Responden B-1
Hari/Tanggal/Pukul : Senin/ 6 Februari 2017/ 12.30 WIB

2. Gambaran Subjek B

Subjek B merupakan mahasiswi dari tahun pertama yakni semester 2. Pada pengisian angket subjek merupakan responden dengan no urut 17. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif subjek B terindikasi memiliki tingkat stres rendah dengan hasil skor stres 1620, sementara skor ≤ 20 termasuk kategori rendah (lihat tabel prevalensi stres). Subjek B juga terindikasi memiliki tingkat spiritualitas tinggi dengan hasil skor 9775, sementara skor ≥ 75 termasuk kategorisasi tinggi (lihat tabel kategorisasi spiritualitas). Selanjutnya subjek B juga terindikasi memiliki regulasi diri belajar yang tinggi dengan skor 118113, sementara skor ≥ 113 termasuk kategorisasi tinggi (lihat tabel kategorisasi regulasi diri belajar).

3. Deskripsi Hasil Wawancara

Penilaian terhadap pembelajaran

Menurut subjek B ada perbedaan cara dan corak belajar antara perguruan tinggi dan sekolah, namun demikian tidak memberi pengaruh yang cukup besar bagi subjek, karena dirinya merasa mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan dan tuntutan akademik yang harus ia jalani. Menurut subjek B dirinya tidak merasa kesulitan untuk mengikuti pola pembelajaran PBL di perguruan tinggi karena subjek tidak merasa bahwa materi perkuliahan cukup berat, karena dirinya masih menjalni tahun pertama pendidikan materi yang sedang dipelajari sedikit banyak masih terkait dengan beberapa topik bahasan ketika di SMU misalnya mempelajari anatomi manusia yang sedikit banyak dipelajari pada pelajaran biologi, termasuk pula beberapa materi perkuliahan menurutnya masih terkait dengan beberapa konsep dasar fisika, kimia dan matematika yang dulu di masa SMU seingat subjek pernah sedikit mempelajarinya, maka di perguruan

tinggi mungkin sifatnya pengayaan bacaan dan pemahaman lebih dalam terkait materi-materi di atas.

Kesempatan untuk belajar lebih

Subjek B menjelaskan bahwa sistem pembelajaran dengan PBL tidak memberi kesan menyulitkan meskipun dirinya baru beradaptasi dengan dunia kampus karena masih sebagai mahasiswa tahun pertama. Pembelajaran dengan sistem PBL menurutnya memberikan kesempatan yang cukup banyak baginya untuk lebih intens berinteraksi dengan teman-teman. Subjek sampai dengan saat ini merasa nyaman menjalani proses pendidikan tersebut.

Menghormati orang lain sebagai manifestasi tingkat spiritualitas yang tinggi

Sebenarnya dalam proses pembelajaran yang dijalani, subjek B merasakan beberapa konflik dengan beberapa teman-teman khususnya terkait penyelesaian tugas-tugas perkuliahan, namun demikian dirinya menyikapi hal tersebut dengan sedikit santai. Menurut subjek, tidak mengapa kalau diantara mahasiswa terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, khusus nya terkait dengan keputusan mendiagnosis dan memberikan pelayanan yang tepat kepada pasien terkait dengan isu-isu pembelajaran yang ditugaskan secara berkelompok. Menurut subjek meskipun perbedaan itu ada, tapi biasanya melalui proses diskusi, berbagi ide dan analisis bacaan biasanya pada akhirnya dirinya bersama teman-teman bisa sedikit banyak memiliki kesepakatan bersama terhadap ide-ide yang dikembangkan dalam pemecahan masalah.

Memaafkan orang lain

Menurut subjek B mengapa dirinya tetap bisa merasakan nyaman ketika menjalani proses perkuliahan dan menghadapi konflik dengan teman, baginya tidak menjadi tekanan yang berarti, karena menurutnya kalau terjadi konflik, kemudian muncul rasa kesal dan kecewa dengan teman, subjek B akan berusaha semaksimal mungkin mudah memaafkan kesalahan teman. Menurut subjek B mudah memaafkan orang lain akan sedikit banyak mengurangi beban pikiran. Saya belajar maksima; berusaha keras untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan, adapun teman saya tidak selalu banyak memikir-

kan hal tersebut. Kalau bisa membantu dan menyelesaikan akan saya kerjakan, kalau tidak ya saya tinggalkan.

Self-testing sebagai bentuk regulasi diri belajar

Subjek B memiliki tingkat regulasi diri belajar yang baik. Dari tiga dimensi regulasi diri belajar (motivasi, kognisi dan behavior) subjek B cenderung memiliki keahlian regulasi diri belajar dengan *self-testing* yakni menguji kemampuan diri sendiri sebagai evaluasi penguasaan pada materi. Menurut subjek B untuk mengurangi kecemasan dalam menghadapi test atau ujian dalam perkuliahan dirinya ketika mempersiapkan diri dalam belajar untuk ujian, subjek melakukan *self-testing* dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan *multiple choice* yang biasanya ada di buku-buku atau modul perkuliahan. Atau sekiranya subjek tidak menemukan latihan menjawab soal-soal, dirinya akan membuat beberapa pertanyaan yang dirinya formulasi dari bahan bacaan yang dipelajari kemudian mencoba untuk menjawabnya sendiri juga.

Kemudian menurut subjek B melalui *self testing* tersebut ia mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri terkait penguasaan, pemahaman, dan hafalan terkait materi-materi yang sudah diajarkan dan dipelajari. Dari regulasi diri "*self testing*", subjek B berharap dirinya bisa menilai kemampuan sendiri sebelum orang lain melakukan test atas dirinya.

D. WAWANCARA SUBJEK C

1. Keterangan Umum

Interviewer	: Syahidah Rena
Interviewee	: Inisial C-T-3
Gender	: Perempuan
Tempat wawancara	: Kampus Responden C
Hari/Tanggal/Pukul	: Jum'at/ 17 Februari 2017/ 09.30 WIB

2. Gambaran Subjek C

Subjek C merupakan mahasiswi dari tahun pertama yakni semester 2. Pada pengisian angket subjek C merupakan responden dengan no urut 282. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif subjek C terindikasi memiliki tingkat stres tinggi dengan hasil skor stres 4832, sementara skor ≥ 32 termasuk kategori tinggi (lihat tabel prevalensi stres). Subjek C juga terindikasi memiliki tingkat spiritualitas rendah

dengan hasil skor $71 \leq 71$, sementara skor ≤ 71 termasuk kategorisasi rendah (lihat tabel kategorisasi spritualitas). Selanjutnya subjek C juga terindikasi memiliki regulasi diri belajar yang rendah dengan skor $94 \leq 94$, sementara skor ≤ 94 termasuk kategorisasi rendah (lihat tabel kategorisasi regulasi diri belajar).

3. Deskripsi Hasil Wawancara

Indikasi stres-Kelelahan yang berlebihan

Subjek C menjelaskan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara pembelajaran ketika dirinya duduk di bangku sekolah dengan pendidikan di bangku perkuliahan, terlebih lagi menurut subjek C ketika dirinya memperhatikan teman-teman sekolah lainnya yang kebetulan ada di beberapa fakultas berbeda seperti menurut subjek C untuk mahasiswa kedokteran sangat melelahkan. Subjek C menjelaskan pembelajaran sistem PBL menuntut energi yang cukup banyak karena secara garis besar dia harus melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas memahami dan menguasai materi secara mandiri.

Adapun jadwal kuliah yang padat, seperti dengan sistem perkuliahan per modul, seolah-olah kita dalam waktu singkat dipaksakan untuk memahami, menguasai modul-modul yang diberikan, dalam waktu yang ditentukan biasanya kurang dari tiga minggu kita harus ujian, setelah ujian tanpa istirahat pada pekan selanjutnya kita akan diberikan modul perkuliahan yang baru, dan ini berlaku terus-menerus sampai masa-masa perkuliahan satu semester berakhir. Menurut subjek C hal ini cukup memberi tekanan mental yang terkadang sepulang perkuliahan dirinya merasakan lelah yang cukup berlebihan, sehingga terkadang hari libur Sabtu-minggu hanya ingin dihabiskan untuk hanya beristirahat di rumah.

Indikasi stres-uncontrolled

Menurut subjek C, secara sadar sebenarnya dirinya menyadari seringkali ketika pulang ke rumah dengan keadaan lelah, dirinya melampiaskan emosi yang tidak baik dengan anggota keluarga lainnya. Menurut subjek C terkadang memang dalam keadaan lelah dirinya jadi gampang marah, semisal ketika pulang subjek C yang hanya memiliki satu saudara kandung laki-laki (kakak) seringkali menurutnya marah yang tidak jelas terhadap sang kakak, padahal disadari subjek

C kakaknya terkadang hanya menggoda, bermain dan bergurau namun dirinya menyikapi guyonan tersebut dengan sinis, marah-marah yang tidak jelas. Subjek C mengakui bahwa untuk itu mungkin karena kelelahan menjalani kehidupan kampus dirinya kurang menguasai kontrol emosi dalam diri. Dirinya merasa lebih mudah tersinggung sehingga secara tidak disadari subjek C mengakui bahwa karena itu ia memiliki intensitas berbicara dan berkomunikasi yang lebih sedikit dengan anggota keluarga lainnya.

Indikasi stres-Gugup yang berlebihan

Subjek C mengungkapkan seringkali dirinya merasa gugup yang berlebihan ketika harus berbicara ditengah-tengah teman saat diskusi atau presentasi kelas, atau pun pada kelas-kelas kecil praktek lainnya. Dalam keadaan gugup dan sedikit tidak tenang subjek C mengakui rada sulit baginya untuk berkonsentrasi di dalam kelas.

Sulit berkonsentrasi

Menurut subjek C terkadang rasa gugup yang berlebihan itu memberikan perasaan yang tidak nyaman sehingga terbawa ketika harus mengulangi pelajaran di rumah. Ketika membaca buku menurut subjek C dirinya perlu waktu lebih lama untuk benar-benar memahami dan menghafal materi, karena dirinya merasa perasaan tidak nyaman tersebut sedikit banyak mengganggu proses konsentrasi belajar. Terkadang menurutnya untuk satu atau dua paragraph dirinya harus membaca tiga sampai empat kali untuk benar-benar memahami bahan bacaannya. Menurut subjek C, terlebih lagi karena beberapa referensi bacaan berbahasa Inggris menambah tingkat kesulitan memahami materi. Seringkali dirina merasa lelah juga untuk itu. Subjek C menyadari bahwa dirinya perlu berusaha lebih keras untuk bertahan sebagai mahasiswa pada keilmuan kedokteran ini.

E. WAWANCARA SUBJEK D

1. Keterangan Umum

Interviewer	: Syahidah Rena
Interviewee	: Inisial D-R-3
Gender	: Laki-laki
Tempat wawancara	: Kampus Responden D
Hari/Tanggal/Pukul	: Jum'at/ 17 Februari 2017/ 10.00 WIB

2. Gambaran Subjek D

Subjek D merupakan mahasiswa dari tahun pertama yakni semester 2. Pada pengisian angket subjek D merupakan responden dengan no urut 286. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif subjek D terindikasi memiliki tingkat stres rendah dengan hasil skor stres 1820, sementara skor ≤ 20 termasuk kategori rendah (lihat tabel prevalensi stres). Subjek D juga terindikasi memiliki tingkat spiritualitas tinggi dengan hasil skor $75 \geq 75$, sementara skor ≥ 75 termasuk kategorisasi tinggi (lihat tabel kategorisasi spiritualitas). Selanjutnya subjek D juga terindikasi memiliki regulasi diri belajar yang tinggi dengan skor 115113, sementara skor ≥ 113 termasuk kategorisasi tinggi (lihat tabel kategorisasi regulasi diri belajar).

3. Deskripsi Hasil Wawancara

Lebih matang karena faktor usia

Subjek D mengatakan bahwa memang secara usia dirinya lebih tua atau usianya diatas rekan sekelas lainnya, karena tahun ini menjadi tahun kedua dirinya mengikuti test masuk perguruan tinggi setelah tahun sebelumnya gagal dalam beberapa test masuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan pada akhirnya dinyatakan lulus pendidikan dokter pada perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutnya tahun pertama pendidikan dokter memang cukup melelahkan karena banyak sekali kegiatan yang harus diikuti mulai dari sesi fasil, masa bimbingan sampai dengan perkuliahannya itu sendiri. Namun dirinya tetap senang dan nyaman saja. Terlebih lagi pengalaman kuliah satu tahun sebelumnya PTS lainnya pada fakultas tehnik Kimia menjadikan dirinya tidak terlalu kaget dengar aktivitas perkuliahan namun diakui memang lebih padat dan sibuk dibandingkan perkuliahan sebelumnya.

Tidak Berputus Asa

Subjek D yang gagal pada test tahun pertama di pendidikan dokter tidak berputus asa untuk mencoba kembali pada tahun berikutnya, dirinya masih mempunyai keyakinan sebagaimana yang diungkapkannya bahwa ia yakin dapat menyelesaikan studi pendidikan kedokteran ini dengan baik. Ketika gagal mengikuti ujian masuk perguruan tinggi di tahun pertama saya selesai SMU saya sempet kecewa akan hasil nya, meskipun di SMU saya duduk di kelas ungu-

lan yang notabene semua siswa adalah jenius namun ternyata hasil akhir UN tidak memuaskan, test SNMPTN gagal, SBMPTN gagal bahkan test di swata pun gagal.

Implementasi spritualitas dengan prasangka baik dan percayaan dan pasrah pada Tuhan

Subjek D mengungkapkan bahwa dirinya ketika mengalami kegagalan ketika mengikuti ujian masuk perguruan tinggi pada tahun pertama sempat merasakan kesedihan dan sedikit kecewa, namun dirinya mengakui tidak berlarut lama pada keadaan tersebut. Dirinya yakin bahwa Allah punya rencana khusus untuk itu, dirinya hanya harus berusaha lebih keras, gagal akan sesuatu yang kita inginkan bukan berarti Tuhan tidak sayang, usaha maksimal yakin pasti akan sampai.

Subjek juga menjelaskan bahwa terkait spritualitas menurutnya dalam menjalin hubungan dengan Tuhan diekspresikan dengan pasrah kepada Tuhan. Ketika sudah melaksanakan tugas atau mengikuti ujian dirinya tidak terlalu memikirkan hasil akhir atau bisa dikatakan tidak terlalu stres dengan hasil nanti yang akan didapatkan, Menurutnya berharap baik dan sempurna iya pastinya. Namun lagi-lagi setelah usaha maksimal dirinya menyerahkan kepada Allah hasil usaha yang akan diterima nanti.

Yakin dan optimis

Subjek D menjelaskan meskipun dirinya menyadari bahwa ke depannya nanti proses pendidikan kedokteran ini akan sangat sulit dijalanin mulai dari penguasaan materi pada masa preklinik sampai nanti memasuki masa klinik, dimana semua proses belajar yang akan dihadapi pasti akan sangat membutuhkan ketahanan mental. Namun demikian subjek tidak terlalu banyak mengkhawatirkan hal tersebut. Sebagaimana dirinya yakin bahwa Allah yang membukakan jalan dirinya untuk bisa duduk di fakultas ini, maka ia juga meyakini bahwa Tuhan pula akan memberinya kemampuan luar biasa nantinya untuk bisa menyelesaikan studi ini.

Menjalin hubungan dengan Tuhan melalui gemar mengaji

Subjek D menceritakan bahwa seberapa sibuk dirinya dengan perkuliahan dan segala aktifitas dan kegiatan di dalamnya dirinya selalu berusaha sebisa mungkin menyempatkan diri untuk minimal satu kali setiap hari membaca al-Qur'an. Menurutnya meskipun

sebentar setidaknya dirinya bisa beristirahat juga sejenak dari berbagai macam beban tugas dan pikiran terkait tuntutan kampus. Setelah membaca al-Qur'an saya merasa siap kembali untuk melanjutkan proses belajar lainnya.

Manajemen dan regulasi diri dengan waktu melalui ibadah

Menurut subjek D dengan senantiasa menjaga ibadah, dirinya merasa secara tidak langsung bisa meregulasi aktifitas hariannya, dirinya tau kapan harus bangun tidur dan kapan harus bisa tertidur kembali. Secara lebih detail subjek D mengungkapkan dirinya terbiasa dengan pengelolaan waktu dan disiplin diri sendiri untuk setidaknya bisa membaca al-qur'an minimal 1 halaman selesai magrib. Pada waktu-waktu tertentu, biasa karena lelah setelah mengikuti perkuliahan seharian dirinya seringkali tidur di awal waktu malam, kemudian akan bangun sekitar pukul 22.00 atau 23.00 malam untuk mengerjakan sholat Isya' yang dilanjutkan dengan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Subjek juga menjelaskan dirinya terbiasa bangun pagi juga karena harus mengerjakan sholat shubuh.

F. WAWANCARA SUBJEK E

1. Keterangan Umum

Interviewer	: Syahidah Rena
Interviewee	: Inisial E-T-2
Gender	: Perempuan
Tempat wawancara	: Kampus Responden E
Hari/Tanggal/Pukul	: Selasa/ 14 Februari 2017/ 12.00 WIB

2. Gambaran Subjek E

Subjek E merupakan mahasiswa dari tahun pertama yakni semester 2. Pada pengisian angket subjek E merupakan responden dengan no urut 143. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif subjek E terindikasi memiliki tingkat stres tinggi dengan hasil skor stres 3832, sementara skor ≥ 32 termasuk kategori tinggi (lihat tabel prevalensi stres). Subjek E juga terindikasi memiliki tingkat spiritualitas rendah dengan hasil skor $69 \leq 71$, sementara skor ≤ 71 termasuk kategorisasi rendah (lihat tabel kategorisasi spiritualitas). Selanjutnya subjek C juga terindikasi memiliki regulasi diri belajar sedang dengan skor

105, sementara skor (95-112) termasuk kategorisasi sedang (lihat tabel kategorisasi regulasi diri belajar).

Aktifitas berkelompok dan persaingan antara teman

Subjek E menjelaskan dirinya memang terbantu dengan sistem pembelajaran secara berkelompok namun sebagai mahasiswa tahun pertama dirinya mengakui belum terlalu akrab dengan teman-teman barunya di perguruan tinggi. Menurutnya seringkali dirinya merasakan bahwa dalam diskusi dan presentasi kelompok hampir setiap teman pada kesempatan yang ada justru sama-sama ingin menunjukkan penguasaan diri terkait bahasan materi dan tugas bersama, dengan demikian dirinya merasa bahwa setiap teman saling bersaing secara maksimal untuk menjadi yang terbaik. . Begitupula pembagian porsi tugas yang tidak seimbang seperti pembuatan laporan, makalah dan presentasi seringkali menimbulkan konflik dan memicu permasalahan interpersonal.

Interpersonal dan Intrapersonal Stressor

Sebagaimana stresor terkait aktifitas berkelompok yang dideskripsikan subjek E menimbulkan persaingan diantara teman sebaya dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung subjek E juga menegaskan bahwa dirinya juga mengalami permasalahan dengan dirinya sendiri (*intrapersonal*) karena tidak mampu menjalin hubungan yang baik dengan teman dan untuk itu subjek E merasa kecewa. Begitupula subjek E juga mengakui dengan demikian dirinya juga mungkin memiliki tekanan atau sumber stres yang berasal dari permasalahan dan hubungan dengan orang lain (*interpersonal*).

Merasa kesendirian

Subjek E secara terus terang menceritakan bahwa dirinya mungkin perlu waktu untuk benar-benar merasa nyaman ketika berhubungan dan belajar bersama teman-teman kampusnya. Seringkali ketika mendapatkan sedikit konflik dengan teman karena mungkin kita berbeda pendapat, ide dan gagasan seringkali hal tersebut membuat dirinya tidak merasa nyaman meskipun berada di dekat teman lainnya sehingga membuat dirinya merasa kesendirian . Subjek E juga terindikasi mengalami stres yang ditandai dengan kekecewaan yang cukup besar ketika dirinya tidak bisa menyelesaikan tugas dengan sempurna dikarenakan ada beberapa teman yang tidak bisa

menyelesaikan tugas yang sebenarnya sudah secara sepakat dibagi secara bersama. Dalam wawancara Subjek E merasakan bahwa ketika menghadapi konflik dengan teman sebayanya di perguruan tinggi, karena dirinya tinggal berjauhan dengan orang tua, sesekali ia kehilangan tempat curhat dengan keluarga, terlebih lagi teman-teman akrab semasa SMU sudah tidak intens lagi berkomunikasi.

G. WAWANCARA SUBJEK F

1. Keterangan Umum

Interviewer : Syahidah Rena
 Interviewee : Inisial F-R-1
 Gender : Perempuan
 Tempat wawancara : Kampus Responden F
 Hari/Tanggal/Pukul : Rabu/ 8 Februari 2017/ 09.30 WIB

2. Gambaran Subjek F

Subjek F merupakan mahasiswi dari tahun ketiga yakni semester 6. Pada pengisian angket subjek F merupakan responden dengan no urut 115. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif subjek terindikasi memiliki tingkat stres rendah dengan hasil skor stres 2020, sementara skor ≤ 20 termasuk kategori rendah (lihat tabel prevalensi stres). Subjek F juga terindikasi memiliki tingkat spiritualitas tinggi dengan hasil skor 9375, sementara skor ≥ 75 termasuk kategorisasi tinggi (lihat tabel kategorisasi spiritualitas). Selanjutnya subjek F juga terindikasi memiliki regulasi diri belajar yang tinggi dengan skor 120113, sementara skor ≥ 113 termasuk kategorisasi tinggi (lihat tabel kategorisasi regulasi diri belajar).

Pemaknaan terhadap tujuan hidup melalui pilihan pendidikan

Subjek F menyadari bahwa pilihan dirinya untuk menjadi dokter pasti tidak akan mudah, menurutnya menjadi dokter adalah salah satu bentuk rasa cinta, peduli dan kasih sayang antar sesama. Terkait dengan tuntutan akademik subjek F mengungkapkan bahwa dirinya menyadari untuk menjadi dokter merupakan pilihan profesi yang tidak sama seperti profesi lainnya, karena dalam pelayanan kesehatan selain penguasaan keilmuan, kecepatan dan ketepatan tindakan praktis medis, dirinya menyadari perihal yang terpenting di

atas semua itu adalah memberikan pertolongan dan kasih sayang kepada orang lemah khususnya orang sakit. Dirinya berekspektasi pada saatnya nanti akan sangat menyenangkan kalau dirinya bisa menolong orang banyak pada suatu saat nanti.

Kemampuan beradaptasi

Subjek F menceritakan bahwa dirinya masih mengingat betul ketika masuk kuliah kedokteran di tahun pertama dirinya mengalami *shock* dengan sistem pembelajaran PBL yang diterapkan oleh kampus, namun semakin naik ke semester atas meskipun secara materi dirasakan bertambah sulit namun dirinya merasakan sudah terbiasa dengan situasi dan tuntunan akademik jadi semua dapat dijalanin dan dirasakan tanpa beban yang berarti.

Percaya pada Tuhan

Menurut subjek F dalam masa-masa kritis dan tertekan dirinya mengungkapkan bahwa apa yang ia miliki terhadap Allah adalah keyakinan padaNya. Misalkan ketika dirinya menginginkan sesuatu namun kemudia sesuatu itu tidak dia dapatkan atau sesuatu tersebut terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, meskipun ada terlintas rasa kecewa namun subjek F menegaskan dirinya tidak suka berlarut-larut pada perasaan itu. Dirinya meyakini mungkin Allah akan memberi dirinya sesuatu yang lebih baik pada waktunya nanti. Sehingga untuk itu dirinya termotivasi untuk semakin giat berdoa dan beribadah. Subjek F yakin bahwa keberhasilan yang akan ia dapat pasti karena pertolongan Tuhan.

Lebih lanjut subjek F menceritakan dirinya pernah merasakan gagal dalam satu modul kuliah, nilai yang ia dapatkan sangat kecil saat itu. Namun kemudian dia merasakan seolah mukjizat Allah itu benar-benar datang, dirinya berdo'a semoga dia mendapat kesempatan. Setelah beberapa hari menerima nilai tersebut dirinya mencoba menghubungi dosen sekiranya dia bisa diberi kesempatan untuk remedial. Sambungnya, pada awalnya dosen tersebut menolak untuk memberikan saya ujian remedial dan memberi kesempatan kedua, meskipun nilai remedial tidak mencapai hasil akhir A, setidaknya subjek F menurut pengakuannya, dirinya mendapatkan nilai yang lebih baik. Saat itu dia sangat yakin bahwa ini semua karena pertolongan Allah pada dirinya.

Merasakan kedamaian dengan berdoa

Subjek F mengungkapkan bahwa meskipun dirinya menyadari tidak semua yang dia inginkan lalu didapatkan, namun dirinya tetap yakin bahwa Allah suatu saat akan memberikan sesuatu yang lebih, sehingga dirinya termotivasi untuk kembali dekat pada-Nya dan meningkatkan ibadah dan doa, karena yakin Allah mendengar semua do'a-do'a yang dipanjatkannya. Ketika subjek ditanya terkait kesulitan yang dihadapi selama masa pendidikan dokter, individu menyebutkan seringkali dirinya dalam do'a mengeluhkan semua itu. Setiap kali selesai berdo'a dirinya merasa sedikit ringan dan merasa nyaman dari beban pikiran dan perasaan dari berbagai tekan-tekanan akademik.

Speak aloud and self talking

Terkait dengan regulasi diri dalam belajar subjek F mengungkapkan bahwa ketika belajar dirinya seringkali mengeraskan suara ketika membaca beberapa teks dari buku yang sedang dipelajari, seolah-olah ia menjelaskan kepada dirinya sendiri bagian tersebut. Ketika belajar ia juga seringkali berbicara dengan diri sendiri. Dirinya menentukan bagian-bagian mana saja yang penting dan harus betul-betul dipahami, dipelajari, serta diingat. Termasuk pula kalau sedang belajar untuk ujian, biasanya subjek membuat pertanyaan-pertanyaan kecil dari materi yang ia pelajari yang terkadang ia tuliskan dan terkadang hanya muncul dalam pikirannya saja. Apa yang subjek lakukan menurutnya akan mengurangi rasa tegang dan cemas ketika keesokan harinya memasuki ruangan ujian. Subjek juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa lebih tenang dan lebih siap untuk ujian dengan regulasi diri belajarnya tersebut.

H. WAWANCARA SUBJEK G

1. Keterangan Umum

Interviewer	: Syahidah Rena
Interviewee	: Inisial G-R-2
Gender	: Perempuan
Tempat wawancara	: Kampus Responden G
Hari/Tanggal/Pukul	: Selasa/ 14 Februari 2017/ 12.30 WIB

2. Gambaran Subjek G

Subjek G merupakan mahasiswi dari tahun ketiga yakni semester 6. Pada pengisian angket subjek merupakan responden dengan no urut 232. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif subjek G terindikasi memiliki tingkat stres rendah dengan hasil skor stres 1420, sementara skor ≤ 20 termasuk kategori rendah (lihat tabel prevalensi stres). Subjek G juga terindikasi memiliki tingkat spiritualitas tinggi dengan hasil skor 9375, sementara skor ≥ 75 termasuk kategorisasi tinggi (lihat tabel kategorisasi spiritualitas). Selanjutnya subjek G juga terindikasi memiliki regulasi diri belajar yang tinggi dengan skor 137113, sementara skor ≥ 113 termasuk kategorisasi tinggi (lihat tabel kategorisasi regulasi diri belajar).

3. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdiskusi dan Berbagi pengalaman dengan Teman

Subjek G menjelaskan meskipun materi perkuliahan pada semester atas semakin sulit ditambah lagi persiapan mengikuti program praklinik dan klinik. Namun demikian dirinya merasa tidak terlalu dibebani dengan hal tersebut karena ketika dihadapi kesulitan materi perkuliahan dirinya banyak melakukan diskusi dengan teman. Subjek G mengungkapkan untuk persiapan memasuki perkuliahan klinik dirinya sering berbagi pengalaman dengan para senior sehingga ketegangan dan kecemasan yang berlebihan kadang sedikit mereda.

Percaya kepada Tuhan

Subjek G dalam sesi wawancara menjelaskan bahwa, ketika dirinya menghadapi kesulitan terkait akademik atau masalah pribadi, dia yakin bahwa Tuhan Yesus akan datang membebaskan dirinya dari semua itu, menurutnya dia tidak perlu berpegangan pada yang lain. Subjek G menyadari meskipun seringkali dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada dirinya. Begitupula menurutnya pada kenyataan sebenarnya dirinya juga tidak mengerti mengapa kejadian tersebut terjadi padanya sehingga dia tidak menemui jawaban untuk itu. Tapi subjek G pada satu sisi lain menyadari bahwa meskipun hal tersebut tidak dipahami dia tetap yakin pasti ada rahasia Tuhan Yesus untuk segala hal tersebut.

Lebih lanjut subjek G menjelaskan sampai di tahun ke tiga ini, dirinya merasakan bahwa kehidupan akademik semakin membuat ia

stres, dimana orang tua, teman dia rasakan tidak terlalu banyak membantu, tapi karena keyakinan subjek G kepada Tuhan Yesus yang kemudian membuat dia bertahan. Keyakinan dirinya pada Tuhan membantu dia mampu melewati masa-masa penuh stres selama kuliah di keilmuan kedokteran ini. Dia yakin ketika dia bersabar untuk tetap bertahan pasti dia akan mendapatkan balasan untuk itu.

Merasakan kedamaian melalui harmonisasi dengan Alam

Subjek G mengakui bahwa padatnya waktu kuliah, tugas dan kewajiban lainnya dirinya memiliki waktu yang tidak banyak untuk secara leluasa bisa menikmati liburan akhir pekan. Dirinya baru bisa betul-betul menikmati masa libur ketika libur panjang akhir semester perkuliahan. Adapun liburan pendek berkala setiap pekan atau setiap bulan subjek G menjelaskan dia tidak punya waktu cukup banyak untuk itu, karena menurutnya sabtu minggu dia akan sibuk dengan tugas-tugas kuliah dan berbagai bentuk test dan ujian di kampus.

Namun demikian ketika subjek G diminta untuk mendeskripsikan sekiranya mereka dapat berada di alam bebas, perasaan apa yang akan muncul serta implementasi seperti apa yang bisa dilakukan sebagai wujud keterhubungan diri dengan alam? Subjek G mengungkapkan bahwa dirinya akan sangat senang untuk dapat melakukan hal tersebut agar bisa bersistirahat sejenak dari segala kesibukan kampus. Subjek G bisa membayangkan pasti akan sangat merasa nyaman, penuh damai ketika bisa secara langsung merasakan hembusan angin dan udara yang bersih. Membayangkan keindahan alam. Menurut subjek G dirinya bertanggung jawab untuk keindahan tersebut dengan cara menjaga lingkungan atau setidaknya tidak merusak anugrah Tuhan tersebut.

Ditengah keterbatasan waktu untuk berhubungan langsung dengan alam, subjek G menjelaskan pada beberapa waktu khususnya di malam hari biasanya ditengah-tengah waktu belajar di malam hari, sesekali ia melepaskan pandangan ke langit luas, melihat bintang-bintang kecil terkadang bulan setengah dan purnama baginya sudah memberi sedikit rasa ketenangan dan rasa nyaman.

I. WAWANCARA SUBJEK H

1. Keterangan Umum

Interviewer : Syahidah Rena
 Interviewee : Inisial H-T-3
 Gender : Perempuan
 Tempat wawancara : Kampus Responden H
 Hari/Tanggal/Pukul : Senin/ 20 Februari 2017/ 09.30 WIB

2. Gambaran Subjek H

Subjek H merupakan mahasiswi dari tahun ketiga yakni semester 6. Pada pengisian angket subjek H merupakan responden dengan no urut 337. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif subjek H terindikasi memiliki tingkat stres tinggi dengan hasil skor stres 3632, sementara skor ≥ 32 termasuk kategori tinggi (lihat tabel prevalensi stres). Subjek H juga terindikasi memiliki tingkat spritualitas rendah dengan hasil skor 6771, sementara skor ≤ 71 termasuk kategorisasi rendah (lihat tabel kategorisasi spritualitas). Selanjutnya subjek H juga terindikasi memiliki regulasi diri belajar yang rendah dengan skor 89 94, sementara skor ≤ 94 termasuk kategorisasi rendah (lihat tabel kategorisasi regulasi diri belajar).

3. Deskripsi Hasil Wawancara

Indikasi stres-sering sakit kepala

Subjek H merupakan salah satu mahasisi dengan indikasi stres yang cukup tinggi, dalam hal ini subjek H menjelaskan seringkali merasakan sakit kepala di bagian tengah kepala sebelah kiri dan kepala bagian belakang, sakit pada bagian-bagian tersebut meskipun tidak dirasakan secara permanen namun dirinya menjelaskan seringkali merasakan sakit secara berulang. Khususnya rasa sakit sangat intens dirasakan justru ketika dirinya dalam keadaan relaks misalkan berbaring dan hendak istirahat malam, atau sedang duduk bersama teman. Sese kali serangan sakit kepala sangat terasa ketika dalam posisi duduk, belajar menghadap laptop.

Kurang istirahat dan berlibur

Subjek H mengungkapkan dirinya tidak memiliki waktu cukup untuk berlibur jangan kan untuk liburan menikmati keindahan alam

seperti pantai, gunung dan danau. Untuk berlibur sejenak saja di tempat rekreasi sederhana kadangkala ia tidak bisa lakukan dikarenakan tugas yang cukup banyak. Pernah sesekali saja ia memaksakan diri untuk pergi ke mall saja bersama keluarga atau teman-teman. Tapi itu tidak bisa dikatakan intens karena untuk pergi ke mall saja subjek H menjelaskan hanya bisa dalam 3-4 bulan sekali saja ketika masa kuliah aktif seperti ini.

Kurang menyempatkan waktu untuk menjaga ibadah

Secara terus terang dengan sedikit malu-malu subjek H menjelaskan untuk masalah ibadah, diakui bahwa dirinya masih belajar untuk itu, seringkali mungkin karena terlalu sibuk atau lelah subjek H seringkali abai akan perintah ibadah wajib seperti Sholat. Misalkan ketika sangat lelah kuliah di pagi hari sesampai di rumah istirahat dan bisa langsung tidur usai magrib, subjek menjelaskan dipastikaan saat itu dirinya kehilangan sholat Isya. Subjek juga menjelaskan tidak sedit juga dirinya absen melakukan sholat shubuh karena bangun kesiangan, dan hanya bisa terburu-buru mengejar waktu kuliah. Karena kebetulan juga jarak antara rumah dan kampus cukup jauh jadi semua terasa tidak hanya lelah mengikuti perkuliahan tapi juga dalam perjalanan pulang dan pergi ke kampus itu sendiri.

J. WAWANCARA SUBJEK I

1. Keterangan Umum

Interviewer	: Syahidah Rena
Interviewee	: Inisial I-T-1
Gender	: Perempuan
Tempat wawancara	: Kampus Responden I
Hari/Tanggal/Pukul	: Selasa/ 8 Februari 2017/ 12.30 WIB

2. Gambaran Subjek I

Subjek I merupakan mahasiswi dari tahun ketiga yakni semester 6. Pada pengisian angket subjek merupakan responden dengan no urut 127. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif subjek terindikasi memiliki tingkat stres tinggi dengan hasil skor stres 32, sementara skor ≥ 32 termasuk kategori tinggi (lihat tabel prevalensi stres). Subjek I juga terindikasi memiliki tingkat spritualitas rendah

dengan hasil skor $\bar{63}$ 71, sementara skor ≤ 71 termasuk kategorisasi rendah (lihat tabel kategorisasi spritualitas). Selanjutnya subjek I juga terindikasi memiliki regulasi diri belajar yang rendah dengan skor 84 94, sementara skor ≤ 94 termasuk kategorisasi rendah (lihat tabel kategorisasi regulasi diri belajar).

3. Deskripsi Hasil Wawancara

Indikasi stres-Sulit Tidur

subjek I mengungkapkan pada tahun ketiga dari masa pendidikannya saat ini, dirinya merasa materi-materi perkuliahan semakin banyak, tugas semakin sulit, aktifitas semakin padat. Dirinya menyebutkan karena semakin sibuk dengan segala hal terkait dengan perkuliahan di pagi dan siang hari, pola tidurnya bergeser biasanya ia tidur lebih awal namun ia memutuskan untuk tidur lebih awal sekitar jam 7 malam sepulang dari kampus. Kemudian bangun pada jam 21.00 WIB dan baru akan tertidur lagi sekitar jam 02.00 WIB. Namun terkadang meskipun ia sudah berusaha keras memejamkan mata nampaknya ia perlu waktu lebih panjang untuk lebih rileks dan baru tertidur pulas dibawah jam 03.30 dan harus terbangun lagi pagi di jam 06.00 pagi. Seringkali justru ketika ia terlalu padat melakukan aktifitas di siang hari, dirinya juga mengalami kesulitan untuk tidur di malam hari.

Emosi yang sering tidak terbendung

Subjek I menyadari seringkali kalau keadaan sudah memuncak seperti tugas banyak, kelas yang semakin padat kemudian ditambah lagi ujian-ujian lainnya dirinya merasa mungkin karena kurang tidur jadi mempengaruhi suasana hati. Seringkali mood yang tidak baik itu terbawa ke kampus atau dilampiaskan pada keluarga terdekat. Dirinya mengakui menjadi lebih sensitif.

LAMPIRAN B
DATA DAN ANALISIS



DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN**1. Universitas Partisipan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	UIN	135	35.7	35.7	35.7
	TRISAKTI	115	30.4	30.4	66.1
	YARSI	128	33.9	33.9	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

2. Tahun Pendidikan Partisipan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tahun Ke-1	126	33.3	33.3	33.3
	Tahun ke-2	130	34.4	34.4	67.7
	Tahun Ke-3	122	32.3	32.3	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

3. Gender Partisipan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	113	29.9	29.9	29.9
	Perempuan	265	70.1	70.1	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

4. Agama Partisipan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Islam	361	95.5	95.5	95.5
	Katolik	6	1.6	1.6	97.1
	Protestan	9	2.4	2.4	99.5
	Hindu	1	.3	.3	99.7
	Budha	1	.3	.3	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

**DESKRIPSI VALIDITAS DAN RELIABILITAS
(FIRST ORDER ANALYSIS/CFA)**

1. Stresor (X1)

Indikator	Item	SLF (>0.40)	Nilai Error	CR (>0.70)	Keterangan
				0.92	Reliabilitas sangat baik
Academic Related Stressors (ARS)	X1	0.58	0.67		Valid
	X5	0.53	0.72		Valid
	X6	0.55	0.70		Valid
	X8	0.57	0.67		Valid
	X12	0.52	0.73		Valid
	X15	0.76	0.43		Valid
	X16	0.65	0.58		Valid
	X18	0.72	0.48		Valid
	X20	0.62	0.61		Valid
	X22	0.67	0.55		Valid
	X24	0.47	0.78		Valid
Interpersonal and Intrapersonal Related Stressors (IRS)	X2	0.42	0.82		Valid
	X3	0.35	0.88		Tidak valid
	X17	0.80	0.36		Valid
Teaching and learning Related Stressors (TLRS)	X9	0.57	0.68		Valid
	X13	0.68	0.54		Valid
	X14	0.68	0.54		Valid
	X25	0.49	0.76		Valid
Social Related Stressors (SRS)	X11	0.33	0.89		Tidak valid
	X19	0.53	0.73		Valid
	X26	0.22	0.95		Tidak valid
Desire Related Stressors (DRS)	X4	0.21	0.96		Tidak valid
	X21	0.51	0.74		Valid
	X27	0.61	0.63		Valid
Group Activities Relates Stressors (GARS)	X7	0.41	0.83		Valid
	X10	0.55	0.69		Valid
	X23	0.47	0.77		Valid

2. Spritualitas (X2)

Indikator	Item	SLF (>0.40)	Nilai Error	CR (>0.70)	Keterangan
				0.81	Reliabilitas sangat baik
Personal (PS)	X5	0.20	0.96		Tidak valid
	X9	0.45	0.80		Valid
	X14	0.41	0.83		Valid
	X16	0.38	0.86		Tidak valid
	X18	0.27	0.93		Tidak valid

Communal (CM)	X1	0.35	0.88		Tidak valid
	X3	0.48	0.77		Valid
	X8	0.37	0.86		Tidak valid
	X17	0.49	0.76		Valid
	X19	0.34	0.88		Tidak valid
Environmental (EV)	X4	0.29	0.92		Tidak valid
	X7	0.50	0.75		Valid
	X10	0.37	0.86		Tidak valid
	X12	0.46	0.79		Valid
	X20	0.55	0.70		Valid
Trancendental (TC)	X2	0.54	0.71		Valid
	X6	0.75	0.44		Valid
	X11	0.47	0.77		Valid
	X13	0.62	0.62		Valid
	X15	0.49	0.76		Valid

3. Regulasi Diri Belajar (M)

Indikator	Item	SLF (>0.40)	Nilai Error	CR (>0.70)	Keterangan
				0.86	Reliabilitas sangat baik
Motivation (MV)	M1	0.79	0.38		Valid
	M2	0.73	0.47		Valid
	M3	0.51	0.74		Valid
	M11	-0.01	1.00		Tidak valid
	M13	0.56	0.68		Valid
	M20	0.19	0.96		Tidak Valid
Emotion (EM)	M4	0.49	0.76		Valid
	M5	0.33	0.89		Tidak valid
	M12	0.16	0.97		Tidak valid
	M17	0.47	0.78		Valid
	M18	0.08	0.99		Tidak Valid
	M21	0.52	0.73		Valid
Cognition (CG)	M6	0.55	0.69		Valid
	M7	0.10	0.99		Tidak valid
	M10	0.56	0.69		Valid
	M15	0.49	0.76		Valid
	M19	0.36	0.87		Tidak valid
	M22	0.57	0.67		Valid
	M25	0.44	0.81		Valid
	M26	0.59	0.65		Valid
	M27	0.43	0.82		Valid
Behavior (BV)	M8	0.54	0.73		Valid
	M9	0.03	0.55		Tidak valid
	M14	-0.35	0.86		Tidak valid

	M16	0.08	0.48		Tidak valid
	M23	-0.88	0.39		Tidak valid
	M24	-0.12	0.70		Tidak valid
	M28	-0.22	0.89		Tidak valid
	M29	-0.17	0.60		Tidak valid

4. Stres (Y)

Indikator	Item	SLF (>0.40)	Nilai Error	CR (>0.70)	Keterangan
				0.84	Reliabilitas sangat baik
Unpredicted (UP)	Y1	0.50	0.75		Valid
	Y4	0.10	0.99		Tidak valid
	Y6	0.68	0.54		Valid
	Y8	-0.30	0.91		Tidak valid
	Y10	0.75	0.44		Valid
Uncontrolled (UC)	Y2	0.79	0.37		Valid
	Y5	0.15	0.98		Tidak valid
	Y7	0.65	0.58		Valid
Nervous (NV)	Y3	0.62	0.62		Valid
	Y9	0.62	0.62		Valid

5. *Construct Reliability Variabel-Variabel Manifest*

Variabel Manifest	Construct Reliability	Keterangan
Stresor	0.92	Reliabilitas sangat baik
Spiritualitas	0.81	Reliabilitas sangat baik
Regulasi Diri Belajar	0.86	Reliabilitas sangat baik
Stres	0.84	Reliabilitas sangat baik

ANALISIS TEMATIK

1. Kategorisasi Prevalensi Stres

N	Valid	378
	Missing	0
Mean		26.13
Median		26.00
Std. Deviation		5.928

No	SKOR	KATEORI	FREKUENSI	PERSENTASE
1	11-20	Rendah	65	17.2 %
	21 - 32	Sedang	256	67.7 %
	≥ 32	Tinggi	57	15.1 %
Jumlah			378	100 %

2. Kategorisasi Stresor

N	Valid	378
	Missing	0
Mean		156.92
Median		157.00
Std. Deviation		28.062

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	57	15.1	15.1	15.1
	Sedang	265	70.1	70.1	85.2
	Rendah	56	14.8	14.8	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

No	ASPEK	SKOR	KATE GORI	FREKU ENSI	PERSEN TASE
1	Academic Related Stressors (ARS)	16-29	Rendah	59	15.6 %
		30-43	Sedang	269	71.2,4 %
		≥ 44	Tinggi	50	13.2 %
		Jumlah		378	100 %
2	Intrapersonal and Interpersonal Related Stressors (IRS)	3-6	Rendah	75	19.8 %
		7-11	Sedang	253	66.9 %
		≥ 12	Tinggi	50	13.2 %
		Jumlah		378	100 %
3	Teaching and Learning Related Stressors (TLRS)	4-8	Rendah	58	15.3 %
		9-14	Sedang	270	71.4 %
		≥ 15	Tinggi	50	13.2 %
		Jumlah		378	100 %
4	Social Related Stressors (SRS)	3-6	Rendah	54	14.3 %
		7-10	Sedang	255	67.5 %

		≥ 11	Tinggi	69	18.3 %
Jumlah				378	100 %
5	Drive and Desire Related Stressors (DRS)	2-5	Rendah	36	9.5 %
		6-11	Sedang	314	83.1 %
		≥ 12	Tinggi	28	7.4 %
Jumlah				378	100 %
6	Group Activities Related Stressors (GARS)	2-5	Rendah	36	9.5 %
		6-11	Sedang	314	83.1 %
		≥ 12	Tinggi	28	7.4 %
Jumlah				378	100 %

3. Kategorisasi Spritualitas

N	Valid	378
	Missing	0
Mean		74.16
Std. Deviation		2.187

SKOR	KATEORI	FREKUENSI	PERSENTASE
52-71`	Rendah	131	34.7
72-74	Sedang	70	18.5
≥ 75	Tinggi	177	46.8
Jumlah		378	100 %

No	ASPEK	SKOR	KATE GORI	FREKU ENSI	PERSEN TASE
1	Personal (PS)	11-14	Rendah	43	11.4%
		15-19	Sedang	260	68.8%
		≥ 20	Tinggi	75	19.8%
Jumlah				378	100%
2	Communal (CM)	11-15	Rendah	70	18.5%
		16-20	Sedang	250	66.1%
		≥21	Tinggi	58	15.3%
Jumlah				378	100%
3	Environmental (EV)	9-15	Rendah	58	15.3%
		16-20	Sedang	257	68.0%
		≥ 21	Tinggi	63	16.7%
Jumlah				378	100%
4	Transcendental (TC)	12-17	Rendah	50	13.2%
		18-21	Sedang	268	70.9%
		≥ 22	Tinggi	60	15.9%
Jumlah				378	100%

4. Kategorisasi Regulasi Diri Belajar

N	Valid	378
	Missing	0
Mean		103.47
Median		103.00
Std. Deviation		8.984

SKOR	KATEORI	FREKUENSI	PERSENTASE
73-94	Rendah	55	14.6%
95-112	Sedang	265	70.1%
≥ 113	Tinggi	58	15.3 %
Jumlah		378	100 %

No	ASPEK	SKOR	KATEORI	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Motivation	26 – 37	Rendah	65	17.2 %
		38 – 46	Sedang	263	69.6 %
		≥ 47	Tinggi	50	13.2 %
		Jumlah		378	100 %
2	Cognition	18 – 25	Rendah	64	16.9 %
		26 – 32	Sedang	254	67.2 %
		≥ 33	Tinggi	60	15.9
		Jumlah		378	100 %
3	Behavior	8 – 12	Rendah	44	11.6 %
		13 – 16	Sedang	277	73.3 %
		≥ 17	Tinggi	57	15.1 %
		Jumlah		378	100 %

ANALISIS KOMPARASI GENDER (*Independet Sample t-Test*)

1. Stres

Group Statistics					
	GENDER	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Stres	Laki-Laki	113	26.47	5.936	.558
	Perempuan	265	25.98	5.930	.364

Independent Samples Test										
			Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means					
			F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference
Stres	Equal variances assumed		.086	.769	.732	376	.465	.488	.666	Lower Upper
	Equal variances not assumed				.732	211.389	.465	.488	.667	-.823 1.798

2. Stresor

Group Statistics					
	GENDER	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
STRESOR	Laki-Laki	113	70,97	13,670	1,286
	Perempuan	265	71,10	12,826	,788

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Stresor	Equal variances assumed	,443	,506	-,085	376	,932	-,125	1,470	-3,015	2,766
	Equal variances not assumed			-,083	199.91	,934	-,125	1,508	-3.099	2,849

3. Spritualitas

Group Statistics					
	GENDER	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
SPRITUAL	laki-laki	113	45,65	5,182	,488
	Perempuan	265	48,86	4,989	,306

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Stresor	Equal variances assumed	,502	,479	-2.154	376	,032	-3.203	1,487	-6.126	-,279
	Equal variances not assumed			-2.125	205.219	,035	-3.203	1.507	-6.174	-,231

4. Regulasi Diri Belajar

Group Statistics					
	GENDER	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
RG_DIRI	Laki-Laki	113	50,78	5,860	,551
	Perempuan	265	54.65	6,006	,369

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
SRL	Equal variances assumed	.001	.977	-2.056	376	.040	-3.570	1.736	-6.984	-.156
	Equal variances not assumed			-2.051	210.412	.041	-3.570	1.740	-7.001	-.139

ANALISIS KOMPARASI TAHUN PENDIDIKAN (One Way ANOVA)

1. Stres

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Tahun_1	126	152.67	27.732	.543	25.53	27.68	14	44
Tahun_2	130	161.62	26.805	.473	24.54	26.41	13	38
Tahun_3	122	156.30	29.157	.568	25.20	27.45	11	48
Total	378	156.92	28.062	.305	25.53	26.73	11	48

ANOVA Stres					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	88.430	2	44.215	1.260	.285
Within Groups	13161.475	375	35.097		
Total	13249.905	377			

2. Stresor

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Tahun_1	126	152.67	27.732	2.471	147.79	147.79	88	226
Tahun_2	130	161.62	26.805	2.351	156.97	156.97	71	238
Tahun_3	122	156.30	29.157	2.640	151.08	151.08	63	225
Total	378	156.92	28.062	1.443	154.09	154.09	63	238

ANOVA					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5192.807	2	2596.403	3.338	.037
Within Groups	291687.968	375	777.835		
Total	296880.775	377	2596.403		

3. Spritualitas

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Tahun_1	126	46,87	5,231	,466	45,94	47,79	32	60
Tahun_2	130	46,76	4,999	,438	45,89	47,63	31	58
Tahun_3	122	45,83	4,954	,448	44,94	46,72	35	59
Total	378	46,49	5,071	,261	45,98	47,01	31	60

ANOVA					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	80,790	2	40,395	1,576	,208
Within Groups	9613,699	375	25,637		
Total	9694,489	377			

4. Regulasi Diri Belajar

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Tahun_1	126	51,54	6,732	,600	50,35	52,73	32	70
Tahun_2	130	50,75	5,340	,468	50,92	52,77	42	66
Tahun_3	122	51,85	5,754	,521	49,72	51,79	29	70
Total	378	51,39	5,969	,307	50,79	52,00	29	70

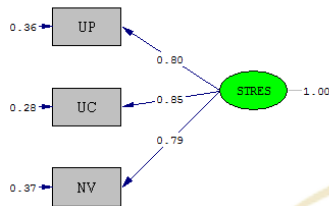
ANOVA					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	79,205	2	39,603	1,112	,330
Within Groups	13350,848	375	35,602		
Total	13430,053	377			

HASIL UJI UNIVARIAT NORMALITAS

Variabel Laten	Variabel Teramati	Skewnes		Kurtosis		Skewness and Kurtosis	
		Z-Score	P-Value	Z-Score	P-Value	Chi-Square	P-Values
Stres	UP	0.115	0.909	-0.092	0.927	0.022	0.989
	UC	0.318	0.750	-0.595	0.552	0.455	0.797
	NV	0.218	0.828	-0.421	0.674	0.225	0.894
Stresor	ARS	-0.020	0.984	0.048	0.962	0.003	0.999
	IRS	-0.043	0.965	-0.368	0.713	0.137	0.934
	TLRS	0.030	0.976	-0.048	0.962	0.003	0.998
	SRS	0.274	0.784	-0.590	0.555	0.423	0.809
	DRS	0.356	0.722	-1.327	0.184	1.888	0.389
	GARS	0.045	0.964	-0.002	0.998	0.002	0.999
Spritualitas	PS	-0.102	0.919	-0.086	0.931	0.018	0.991
	CM	-0.524	0.601	-0.388	0.698	0.425	0.809
	EV	-0.250	0.803	-0.441	0.659	0.257	0.879
	TC	-0.441	0.659	-0.744	0.457	0.748	0.688
Regulasi Diri Belajar	MV	-0.662	0.508	-1.211	0.226	1.905	0.386
	CG	-0.042	0.966	-0.036	0.971	0.003	0.998
	BV	0.009	0.993	-0.028	0.978	0.001	1.000

ANALISIS HASIL UJI MODEL PENGUKURAN

1. Stresor



Chi-Square=0.00, df=0, P-value=1.00000, RMSEA=0.000

Variabel Laten	Nilai SFL (> 0.40)	Nilai Error	Nilai CR (≥ 0.70)	Nilai AVE (≥0.50)	Kesimpulan Perhitungan
Stres			0.85	0.64	Reliabilitas Baik
<i>Upset</i> (UP)	0.80	0.36			
<i>Uncontrolled</i> (UC)	0.85	0.85			
<i>Nervous</i> (NV)	0.79	0.37			

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 11

Minimum Fit Function Chi-Square = 44.88 (P = 0.00)

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 48.15 (P = 0.00)

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 37.15

90 Percent Confidence Interval for NCP = (19.32 ; 62.53)

Minimum Fit Function Value = 0.12

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.099

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.051 ; 0.17)

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.095

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.068 ; 0.12)

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.0036

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.22

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.17 ; 0.29)

ECVI for Saturated Model = 0.15

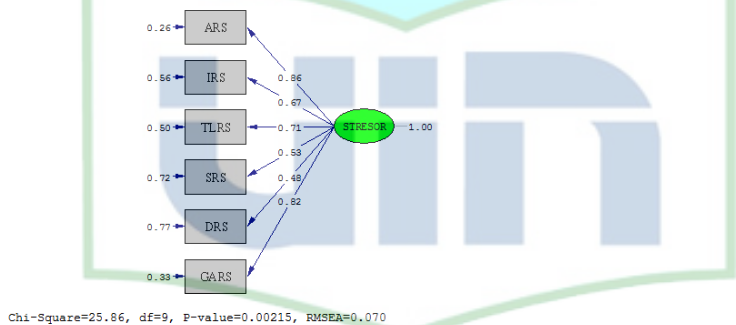
ECVI for Independence Model = 4.33

Chi-Square for Independence Model with 21 Degrees of Freedom = 1618.34

Independence AIC = 1632.34

Model AIC = 82.15
Saturated AIC = 56.00
Independence CAIC = 1666.88
Model CAIC = 166.05
Saturated CAIC = 194.18
Normed Fit Index (NFI) = 0.97
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.96
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.51
Comparative Fit Index (CFI) = 0.98
Incremental Fit Index (IFI) = 0.98
Relative Fit Index (RFI) = 0.95
Critical N (CN) = 208.71
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.047
Standardized RMR = 0.039
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.96
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.91
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.38

2. Stresor



Variabel Laten	Nilai SFL (> 0.40)	Nilai Error	Nilai CR (≥ 0.70)	Nilai AVE (≥ 0.50)	Kesimpulan Perhitungan
Stresor			0.84	0.60	Reliabilitas Baik
Academic Related Stres (ARS)	0.86	0.26			
Intrapersonal and Interpersonal Related Stressors (IRS)	0.67	0.56			
Teaching and	0.71	0.50			

Leraning Related Stressors (TLRS)					
Social Related Stressors (SRS)	0.53	0.72			
Desire Related Stressors (DRS)	0.48	0.72			
Group Activities Related Stressors (GARS)	0.82	0.77			

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 9

Minimum Fit Function Chi-Square = 25.41 (P = 0.0026)

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 25.86 (P = 0.0022)

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 16.86

90 Percent Confidence Interval for NCP = (5.31 ; 36.04)

Minimum Fit Function Value = 0.067

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.045

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.014 ; 0.096)

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.070

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.040 ; 0.10)

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.13

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.13

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.10 ; 0.18)

ECVI for Saturated Model = 0.11

ECVI for Independence Model = 3.41

Chi-Square for Independence Model with 15 Degrees of Freedom = 1274.91

Independence AIC = 1286.91

Model AIC = 49.86

Saturated AIC = 42.00

Independence CAIC = 1316.52

Model CAIC = 109.08

Saturated CAIC = 145.63

Normed Fit Index (NFI) = 0.98

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.98

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.59

Comparative Fit Index (CFI) = 0.99

Incremental Fit Index (IFI) = 0.99

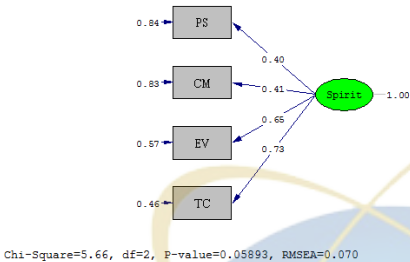
Relative Fit Index (RFI) = 0.97

Critical N (CN) = 322.50

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.21

Standardized RMR = 0.031
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.95
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.42

3. Spritualitas



Variabel Laten	Nilai SFL (> 0.40)	Nilai Error	Nilai CR (≥ 0.70)	Nilai AVE (≥ 0.50)	Kesimpulan Perhitungan
Spiritualitas			0.72	0.53	Reliabilitas Cukup
Personal (PS)	0.40	0.84			
Communal (CM)	0.41	0.83			
Environmental (EV)	0.65	0.57			
Transcendental (TC)	0.73	0.46			

Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 2
Minimum Fit Function Chi-Square = 5.81 (P = 0.055)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 5.66 (P = 0.059)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 3.66
90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 14.88)
Minimum Fit Function Value = 0.015
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0097
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.039)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.070
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.14)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.24
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.057
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.048 ; 0.087)
ECVI for Saturated Model = 0.053
ECVI for Independence Model = 0.61

Chi-Square for Independence Model with 6 Degrees of Freedom = 222.05

Independence AIC = 230.05

Model AIC = 21.66

Saturated AIC = 20.00

Independence CAIC = 249.79

Model CAIC = 61.14

Saturated CAIC = 69.35

Normed Fit Index (NFI) = 0.97

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.95

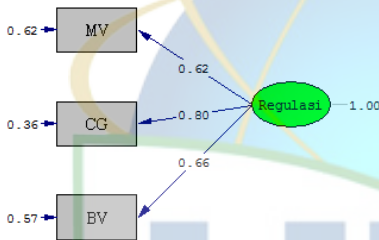
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.32

Comparative Fit Index (CFI) = 0.98

Incremental Fit Index (IFI) = 0.98

Relative Fit Index (RFI) = 0.92

4. Regulasi Diri Belajar



Variabel Laten	Nilai SFL (> 0.40)	Nilai Error	Nilai CR (≥ 0.70)	Nilai AVE (≥ 0.50)	Kesimpulan Perhitungan
Regulasi Diri Belajar					Reliabilitas Cukup
Motivation(MV)	0.62	0.76			
Cognition (CG)	0.80	0.36			
Behavior (BV)	0.66	0.57			

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 2

Minimum Fit Function Chi-Square = 7.67 (P = 0.022)

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 7.24 (P = 0.027)

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 5.24

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.44 ; 17.52)

Minimum Fit Function Value = 0.020

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.014

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0012 ; 0.046)

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.083
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.024 ; 0.15)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.15

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.062
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.049 ; 0.094)
ECVI for Saturated Model = 0.053
ECVI for Independence Model = 0.80

Chi-Square for Independence Model with 6 Degrees of Freedom = 294.58

Independence AIC = 302.58

Model AIC = 23.24

Saturated AIC = 20.00

Independence CAIC = 322.32

Model CAIC = 62.72

Saturated CAIC = 69.35

Normed Fit Index (NFI) = 0.97

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.94

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.32

Comparative Fit Index (CFI) = 0.98

Incremental Fit Index (IFI) = 0.98

Relative Fit Index (RFI) = 0.92

Critical N (CN) = 453.58

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.15

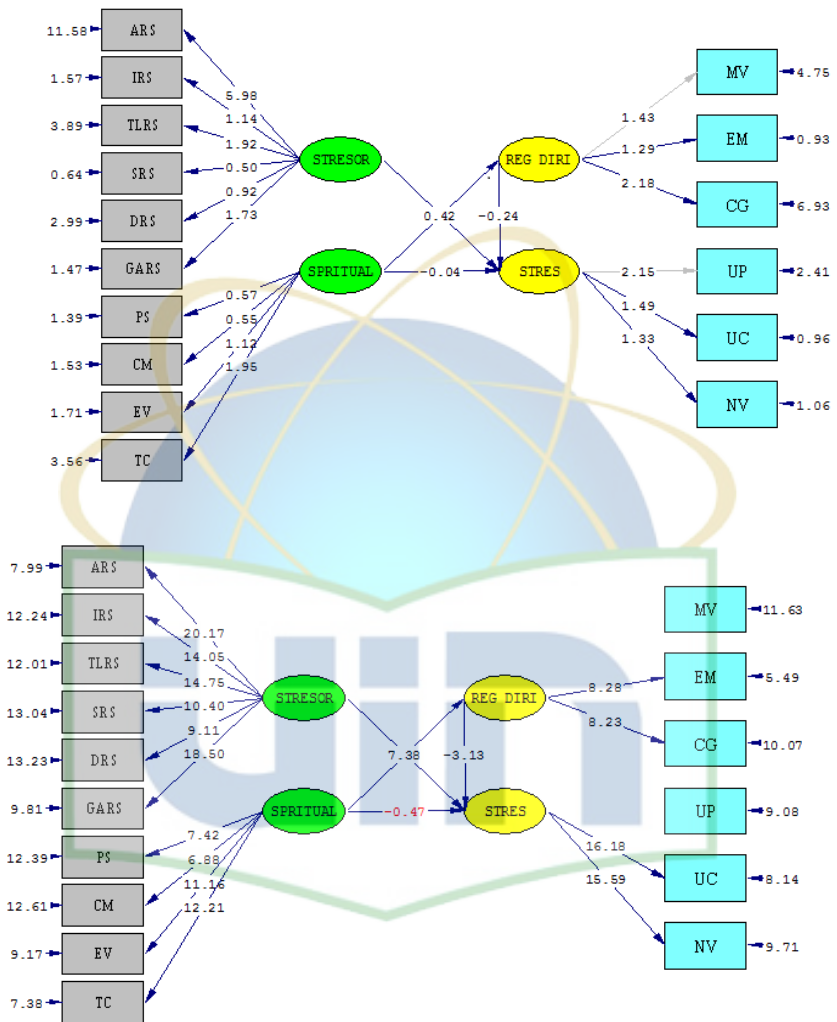
Standardized RMR = 0.031

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.95

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.20

ANALISIS HASIL UJI MODEL STRUKTURAL



Structural Equations

REG DIRI = 0.51*SPRITUAL, Errorvar.= 0.75 , $R^2_y = 0.25$

(0.083) (0.16)

6.09 4.73

STRES = - 0.24*REG DIRI + 0.42*STRESOR - 0.036*SPRITUAL, Errorvar.= 0.74 , $R^2_y = 0.26$

(0.077) (0.057) (0.077) (0.088)

-3.13 7.38 -0.47 8.35

Total and Indirect Effects

Total Effects of KSI on ETA

STRESOR SPRITUAL

REG DIRI -- 0.51
(0.08)

6.09

STRES 0.42 -0.16
(0.06) (0.06)

7.38 -2.56

Indirect Effects of KSI on ETA

STRESOR SPRITUAL

REG DIRI -- --
STRES -- -0.12
(0.04)
-2.96

Total Effects of ETA on ETA

REG DIRI STRES

REG DIRI -- --
STRES -0.24 --
(0.08)
-3.13

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 99

Minimum Fit Function Chi-Square = 198.06 (P = 0.00)

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 199.11 (P = 0.00)

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 100.11

90 Percent Confidence Interval for NCP = (63.70 ; 144.29)

Minimum Fit Function Value = 0.53

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.27

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.17 ; 0.38)

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.052

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.041 ; 0.062)

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.38

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.72

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.63 ; 0.84)

ECVI for Saturated Model = 0.72

ECVI for Independence Model = 8.29

Chi-Square for Independence Model with 120 Degrees of Freedom = 3095.13

Independence AIC = 3127.13

Model AIC = 273.11

Saturated AIC = 272.00

Independence CAIC = 3206.09

Model CAIC = 455.70

Saturated CAIC = 943.15

Normed Fit Index (NFI) = 0.94

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.96

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.77

Comparative Fit Index (CFI) = 0.97

Incremental Fit Index (IFI) = 0.97

Relative Fit Index (RFI) = 0.92

Critical N (CN) = 257.30

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.34

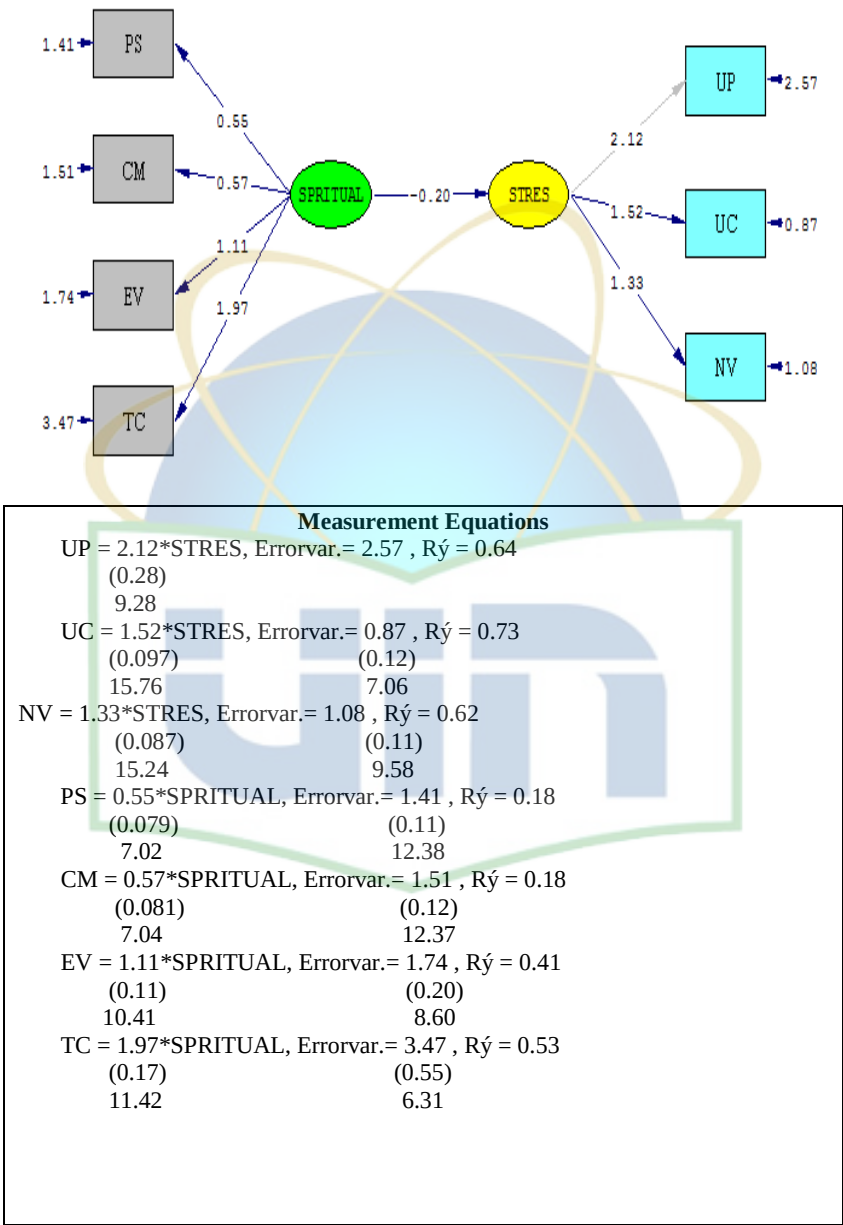
Standardized RMR = 0.060

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.94

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.91

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.68

ANALISIS PARSIAL UJI HIPOTESA PENGARUH SPIRITUALITAS
TERHADAP STRES
(Tanpa Mediator)



Structural Equations

STRES = - 0.20*SPRITUAL, Errorvar.= 0.96 , R_y = 0.039
 (0.067) (0.11)
 -2.95 8.52

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 13

Minimum Fit Function Chi-Square = 26.06 (P = 0.017)

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 26.78 (P = 0.013)

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 13.78

90 Percent Confidence Interval for NCP = (2.68 ; 32.61)

Minimum Fit Function Value = 0.069

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.037

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0071 ; 0.087)

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.053

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.023 ; 0.082)

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.39

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.15

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.12 ; 0.20)

ECVI for Saturated Model = 0.15

ECVI for Independence Model = 2.13

Chi-Square for Independence Model with 21 Degrees of Freedom = 789.57

Independence AIC = 803.57

Model AIC = 56.78

Saturated AIC = 56.00

Independence CAIC = 838.11

Model CAIC = 130.80

Saturated CAIC = 194.18

Normed Fit Index (NFI) = 0.97

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.97

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.60

Comparative Fit Index (CFI) = 0.98

Incremental Fit Index (IFI) = 0.98

Relative Fit Index (RFI) = 0.95

Critical N (CN) = 401.60

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.17

Standardized RMR = 0.055

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.96

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.46

BIOGRAFI PENULIS



Syahidah Rena yang biasa akrab dipanggil dengan Rena lahir di Kota Palembang pada 10 Maret 1984. Anak ke 9 dari 12 bersaudara dari pasangan H. Muhammad Abdul Kadir dan Hj. Rukiah. Mengawali pendidikan formal di MI Adabiyah II Palembang, melanjutkan tingkat MTs dan MA di Pondok Pesantren Ummul Quro al-Islami Bogor. Penulis menikah dengan Abdurrahman S.Hum pada tanggal 18 Agustus 2013 dan dikaruniakan seorang putri bernama Raufah Adibah.

Penulis melanjutkan pendidikan jenjang Perguruan Tinggi Strata 1 di IAIN (sekarang UIN) Raden Fatah Palembang-Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Islam. Pada waktu yang bersamaan penulis juga menempuh jenjang Pendidikan Tinggi Diploma (D3) Dirasah Islamiyah di Perguruan Tinggi Sa'ad Bin Abi Waqash kerjasama AMCF (Asean Monetary Charity Foundation) dan Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis kemudian melanjutkan studi Strata 2 (Magister) di University of Malaya-Malaysia dengan konsentrasi Psikologi Pendidikan. Pada pendidikan lanjutan jenjang strata 3 (Doktoral) penulis memantapkan pilihan pada program studi Pengkajian Islam dengan konsentrasi Psikologi Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam Psikologi Pendidikan dengan perspektif Keilmuan Keislaman dan Psikologi.

Dalam perjalanan hidupnya, penulis memiliki pengalaman organisasi yang diawali dengan menjadi pengurus Badan Eksekutif Fakultas Tarbiyah (BEMF) IAIN Raden Fatah Palembang (2006-2007) dan dilanjutkan menjadi Ketua Departemen Pendidikan dan Penelitian di Badan Eksekutif Mahasiswa Institut (BEMI) IAIN Raden Fatah Palembang (2007-2008). Selanjutnya ketika menempuh pendidikan S2, penulis menjadi Ketua Departemen Pendidikan dan Penelitian pada Kepengurusan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia tahun 2011-2012. Pada masa bhakti tersebut, penulis menjadi ketua pelaksana Program Pendidikan Non Formal (PNF) bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kerjasama PPI Malaysia, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIK) dan Komjen Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia.

Disamping itu, penulis juga memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan yang dimulai tahun 2008 dengan menjadi salah satu tim tutor Bahasa Arab-Inggris bagi guru-guru MTS Model 1 Palembang, dilanjutkan dengan pengabdian pada IAIN Raden Fatah Palembang dengan menjadi salah satu dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin dan Psikologi Islam (2011-2013), serta sempat menjadi salah satu anggota Tim Program Kerja (POKJA) Wakil Rektor IAIN Raden Fatah pada tahun 2012. Penulis juga aktif menjadi pengajar (dosen) di Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Pendidikan Islam. Pada tahun yang sama, penulis juga menjadi salah satu pengurus editor bahasa Inggris jurnal “Scriptoria dan Concencia” Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang. Selain berkiprah di dunia akademik, pada tahun 2011-2014 penulis aktif menjadi penulis pada beberapa koran lokal dan majalah di Palembang dan sempat menjadi pengasuh forum konsultasi Psikologi Pendidikan dan Keluarga di koran “Surat Kabar Sumatera”. Mulai tahun 2014-sekarang penulis aktif mengabdikan diri sebagai Dosen Luar Biasa (DLB) di Fakultas Psikologi dan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Akhirnya, untuk menjalin silaturahmi dan memberikan kritik dan saran penulis dapat dihubungi di email: syakra84@gmail.com atau hand phone: 08217908611.

